学校代码：10286
分类号：TU246
密　级：公开
U D C：725
学　号：150099

東南大學

SOUTHEAST UNIVERSITY

建筑学硕士学位论文

综合医院门诊科室与医技部门位置关系研究
——基于诊疗中心化的视点

（学位论文形式：应用研究）

研究生姓名：刘曦文
导师姓名：周　颖　教授
万小梅　高级工程师

申请学位类别 建筑学硕士　学位授予单位 东南大学
工程领域名称 建筑学（专业学位）　论文答辩日期 2018 年 5 月 23 日
研究方向 建筑设计及理论　学位授予日期 20 年 月 日
答辩委员会主席 陈小坚　评　阅　人 陈小坚、陈宇

2018 年　月　日

中国知网 https://www.cnki.net

東南大學

硕士学位论文

综合医院门诊科室与医技部门位置关系研究
——基于诊疗中心化的视点

专 业 名 称：建筑设计及理论

研究生姓名：刘曦文

导 师 姓 名：周颖　教授

万小梅　高级工程师

中国知网　https://www.cnki.net

RESEARCH ON THE POSITION RELATIONSHIP BETWEEN OUTPATIENT DEPARTMENTS AND MEDICAL LABORATORY IN GENERAL HOSPITAL ——BASED ON CENTRALIZED DIAGNOSIS AND TREATMENT

A Thesis Submitted to

Southeast University

For the Professional Degree of Master of Architecture

BY

LIU Xi-wen

Supervised by

Prof. ZHOU Ying

and

Senior Architect WAN Xiao-mei

School of Architecture

Southeast University

May 2018

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

摘要

题　　名：综合医院门诊科室与医技部门位置关系研究——基于诊疗中心化的视点
硕士研究生：刘 曦 文
导　　师：周　　颖
学 校 名 称：东南大学

随着人类生活水平的提高，兼患有多个疾病的患者屡见不鲜，而多疾病患者多科反复就诊与传统医院科室精细化分科诊疗、医院内外科分开布局的矛盾；医院科室整合和多学科合作诊疗与传统医院相关科室分离布局的矛盾；以及建筑届缺乏对医院相关科室和医技间关系的研究，迫使建筑师急需探求一套满足新时代患者就诊特点、医院科室整合和多学科合作诊疗需求的新型医院设计方法。

通过归纳整理、统计分析和对比研究等方法，从医院门诊诊疗中心建设实例出发，探讨医院科室间的关系、科室与医技间关系、以及新型诊疗中心式医院的设计方法。

从日本建成较完善的医院门诊诊疗中心出发，得出诊疗中心主要分为脏器中心、系统中心和疾病中心，且每类中心科室配置、涉及医技和平面布局各有特点；研究日本不同规模和不同类型医院门诊诊疗中心配置数量、种类和布局特点，得出医院门诊诊疗中心设置数量跟医院规模和等级成正相关，诊疗中心的种类与医院的规模和类型相关，以及配有不同数量种类诊疗中心医院的布局特点；对比日本相同规模、类型而配置不同数量、种类诊疗中心的医院，得出医院门诊诊疗中心的建设主要受限于医院的诊疗体制和科室组成、且相关科室和医技邻近布局更有利于医院后期诊疗中心的开设；对比科室实行各类诊疗体制对患者就诊的影响，得出双轨制更利于患者诊疗；通过重新演绎上述研究成果，提出满足新时代患者诊疗需求的相关科室、医技邻近布局的诊疗中心式医院设计方法、展望以疾病特征出发的诊疗中心模式构建国家甚至全球医疗健康体系网的可能。

关键词：科室整合，多学科合作诊疗，科室间关系，诊疗中心，诊疗中心式医院设计

中国知网　https://www.cnki.net

ABSTRACT

Title: Research on the Position Relationship between Outpatient Departments and Medical Laboratory in General Hospital——Based on Centralized Diagnosis and Treatment
Graduate student: LIU Xi-wen
Supervisor: Prof.ZHOU Ying
University: Southeast University

With the improvement of human living standards, paitents with multiple diseases are common. The contradictions among repeated visits to multi-disease patients, traditional hospital departments finesse branch diagnosis and treatment, and the separation planning of interal medicine department and surgery department; The contradiction between the integration of hospital departments and multidisciplinary treatment, and the separation layouts of related medical departments in traditional hospital; And the lack of research on the relationship between hospital medical departments and exam rooms in architecture, which forced architects to urgently explore a new type of hospital design method that meets the characteristics of new-age patient attendance, hospital medical departments integration, and multidisciplinary treatment needs.

Through the methods of inductive collation, statistical analysis and comparative research, starting from the construction practice of hospital outpatient medical center, the relationship between medical departments and exam rooms, and the design method of a new type of medical-centralized hospital are discussed.

Starting from the establishment of a relatively complete hospital outpatient medical center in Japan, it is concluded that the medical center is mainly divided into an organ center, a system center and a disease center, and each type of hospital outpatient medical center have their own characteristics on medical departments, exam rooms and plane layout; Based on the number ,type and layout characteristics of hospital outpatient medical center deployed in different sizes and types of hopitals in Japan, it is concluded that the number of hospital outpatient medical center is positively related to the size and the rank of the hopitals, the types of hospital outpatient medical center are related to the size and types of hospitals, and the layout characteristics of hospitals with different types of medical centers; Compared with the same size or the same type of hospitals with different numbers of hospital outpatient medical centers, it is concluded that the establishment of hospital outpatient medical center is mainly constrained by the hospital's diagnosis and treatment system and the composition of medical departments, and the related layout of medical departments and exam rooms is more conducive to the establishment of the hospital's late-stage medical center; Comparing the effects of different types of diagnosis ant treatment system on patient visits, the dual-track system is more conducive to the patient's diagnosis and treatment;Through the re-interpretation of the above research results, it proposes the design method for the relevant medical departments and exam rooms that meets the needs of patients in the new era, and the prospects for building a national or even global health care system network based on the model of medical centers centered on disease characteristics.

Keywords: Deparment integration, multidisciplinary treatment, the relationships between medical departments, medical center, medical-centralized hospital design

中国知网 https://www.cnki.net

目录

摘要.....I
ABSTRACT.....III
目录.....V
上篇 工程图纸.....1
0.1 设计表现.....2
0.2 项目介绍.....4
0.3 总体规划.....7
0.4 平面设计.....10
0.5 立面剖面设计.....13
下篇 工程研究报告.....15
第 1 章 绪论.....16
1.1 研究背景及意义.....16
1.2 定义及研究范围.....18
1.2.1 定义.....18
1.2.2 研究范围.....19
1.3 国内外研究现状及发展动向.....19
1.3.1 欧美.....19
1.3.2 日本.....22
1.3.3 中国.....25
1.3.4 小结.....28
1.4 研究对象、研究内容和研究方法.....29
1.4.1 研究对象.....29
1.4.2 研究内容.....29
1.4.3 研究方法.....29
1.5 研究框架.....30
第 2 章 不同类型诊疗中心建设研究.....31
2.1 诊疗中心的分类.....31
2.2 脏器中心.....37
2.2.1 心脏（心血管）中心.....38
2.2.2 肾脏中心.....42
2.2.3 脑神经中心.....47
2.2.4 眼科中心.....50
2.2.5 耳鼻喉科相关中心.....53
2.2.6 口腔中心.....56
2.2.7 乳腺中心.....61
2.3 系统中心.....64
2.3.1 消化系统中心.....64
2.3.2 呼吸系统中心.....66
2.3.3 睡眠中心.....69
2.3.4 内分泌中心.....73

中国知网 https://www.cnki.net

2.3.5 心·脑血管中心 75
2.3.6 慢性创伤中心 77
2.3.7 脊椎脊髓中心 80
2.3.8 骨科中心 82
2.3.9 整形中心 86
2.3.10 女性骨盆底中心 87
2.3.11 生殖医疗中心 89
2.3.12 周产期母子医疗中心 91
2.3.13 女性诊疗中心 94
2.3.14 儿童医疗中心 96
2.4 疾病中心 99
2.4.1 糖尿病中心 99
2.4.2 过敏中心 103
2.4.3 风湿·胶原病中心 105
2.4.4 皮肤病中心 108
2.4.5 血液病中心 110
2.4.6 精神卫生中心 112
2.4.7 疼痛中心 115
2.4.8 肿瘤中心 117
2.4.9 认知症医疗中心 123
2.4.10 高血压中心 126
2.4.11 唇腭裂中心 128
2.4.12 脑卒中中心 130
2.4.13 癫痫中心 133
2.5 小结 134
第 3 章 不同医院诊疗中心配置研究 136
3.1 总述 136
3.2 不同规模医院诊疗中心配置研究 136
3.2.1 分类 136
3.2.2 20-199 床 138
3.2.3 200-399 床 141
3.2.4 400-599 床 146
3.2.5 600-799 床 152
3.2.6 800 床以上 156
3.2.7 对比研究 163
3.3 不同类型医院诊疗中心配置研究 167
3.3.1 分类 167
3.3.2 特定机能医院 169
3.3.3 地域支援医院 176
3.3.4 一般医院 182
3.3.5 高度综合医疗设施 186
3.3.6 国立高度专门医疗研究中心 190
3.3.7 对比研究 193
3.4 小结 198
第 4 章 考察 199
4.1 总述 199

中国知网 https://www.cnki.net

4.2 医院诊疗中心设置与否及配置不同比较研究.....199
4.2.1 同规模医院诊疗中心设置与否及配置不同比较研究.....199
4.2.2 同类型医院诊疗中心设置与否及配置不同比较研究.....212
4.2.3 小结.....224
4.3 医院科室实行中心化诊疗模式与否比较研究.....224
4.3.1 分科诊疗制.....224
4.3.2 中心制.....226
4.3.3 双轨制.....228
4.3.4 对比研究.....229
4.4 诊疗中心式医院平面设计方法研究.....230
4.4.1 功能配置及相互关系.....230
4.4.2 平面布局.....242
4.4.3 诊疗中心式医院平面设计思路.....250
4.5 小结.....251
第 5 章 结论.....253
5.1 结论.....253
5.1.1 诊疗中心层面.....253
5.1.2 医院层面.....253
5.1.3 医疗体系层面.....256
5.1.4 理论层面.....257
5.2 提案.....257
5.3 今后研究课题.....258
参考文献.....259
作者简介.....263
致谢.....265
附录.....267
附录 A 文献研究动向.....269
附录 B 日本研究案例基本情况.....277
附录 C 日本研究案例各类诊疗中心配置情况.....283

中国知网 https://www.cnki.net

上篇 工程图纸

项目名称：西藏自治区墨竹工卡县甲玛乡卫生院暨墨竹工卡县甲玛分院建筑方案
建设用地：7654 ㎡
建设规模：甲玛乡中心卫生院 2500 ㎡，宿舍 700 ㎡
建设单位：西藏自治区墨竹工卡县党委
设计单位：东南大学建筑学院周颖工作室
南京市建筑设计研究院有限责任公司

中国知网 https://www.cnki.net

0.1 设计表现

整体鸟瞰图

人视效果图

中国知网 https://www.cnki.net

人视效果图

室内效果图

中国知网 https://www.cnki.net

0.2 项目介绍

1.基本信息：

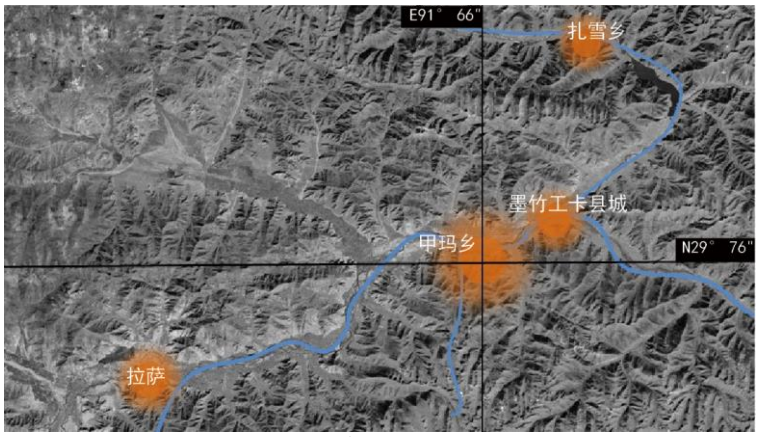
项目名称：西藏自治区墨竹工卡县甲玛乡中心卫生院暨墨竹工卡县医院的甲玛分院
建设用地：7654 ㎡
建设规模：甲玛乡中心卫生院 2500 ㎡，宿舍 700 ㎡
机动停车位 3 辆，救护车停车位 2 辆
容 积 率：41.80%
建筑密度：34.20%
绿 地 率：42.69%

2.甲玛乡地理位置：

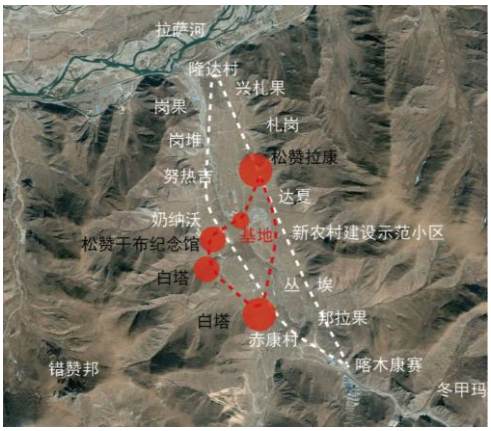
甲玛乡距离拉萨约 70 公里，据墨竹工卡县城约 10 公里，海拔 3900m。

3.周边地区分析：

甲玛乡卫生院基地位于松赞干布出生地纪念馆的东面，西面正对 3 座古老的白塔以及博物馆，东南角建有霍尔康庄园的白塔。东面紧邻新农村建设示范小区，北面有松赞拉康以及忱果泉，附近有许多传统的藏族聚落。



甲玛乡地理位置

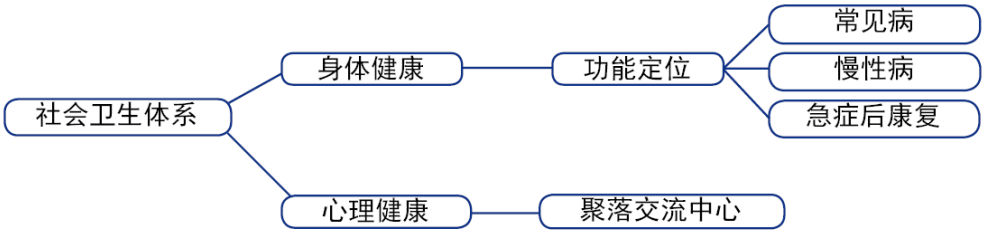


基地周边地区分析

4.项目定位：

甲玛乡中心卫生院是西藏农村卫生体系的重要组成部分，是江苏省重要的援藏项目。本设计力求使之成为藏区聚落的新型交流中心，本地健康生活的样板区，绿色节能样板区。

功能定位：1）开展常见病及多发病的诊治，以及对确诊为慢性病的患者进行居家治疗；2）承担急症患者的初步处理和转诊护送；3）康复训练与理疗；4）为在上级医院结束急性期医疗的患者提供慢性疗养环境，设 20 床的住院部；5）为甲玛乡内 2 个矿厂的工人提供体检与医疗服务。



甲玛乡功能定位

中国知网 https://www.cnki.net

5.设计理念：

1）身·心·灵——渡

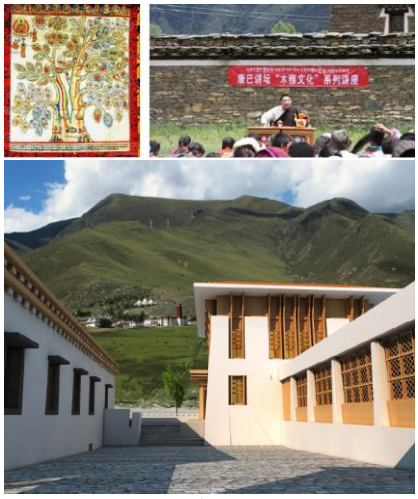
在设计中注重藏民精神空间与健康空间的结合，引入与西藏人民信仰密切相关的元素，力求打造符合藏民需求的身心养护空间。

2）台·院·堂

通过药师台、庭院、与室外的学堂实现所有重要的公共空间与室外的健身步道的联系。

台

院



堂

3）现代化西藏建筑语言

采用西藏当地特色的建筑形态语言，进行现代化演绎，打造现代化新型西藏建筑。

建筑空间、形态与构件

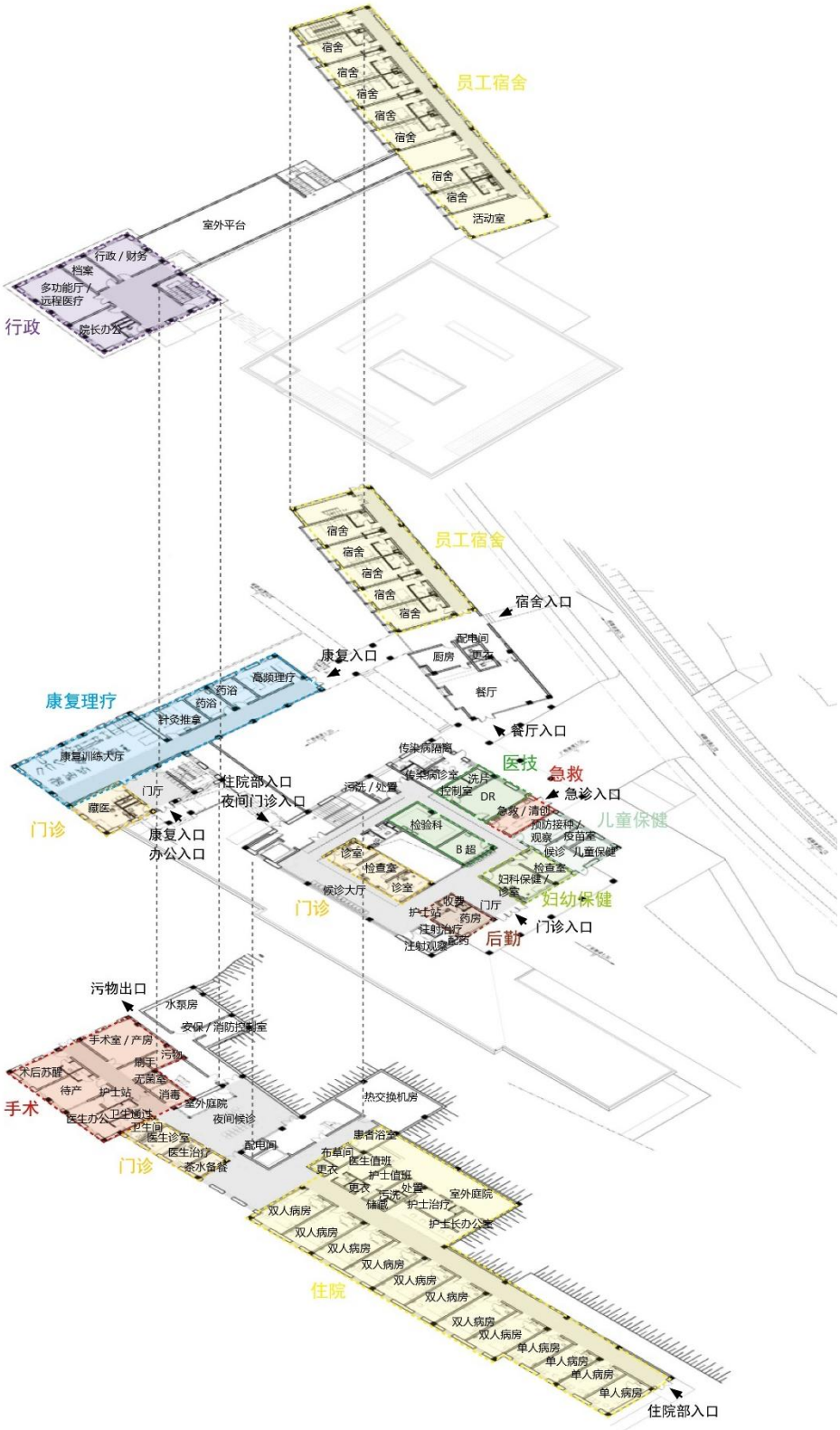
建筑细部与构造——墙体收分

建筑细部与构造——女儿墙处理

中国知网 https://www.cnki.net

6.功能规划：

合理规划卫生院功能流线，以区分卫生院不同使用人群的独特需求，如妇幼保健与门诊分开，住院与手术同层等。考虑到藏区卫生院医护人员较少，一个医护人员往往兼顾多种职能的情况，以医护人员工作范畴为功能规划原点，邻近该工作人员进行功能区规划，以方便患者诊疗，提高医护人员工作效率。



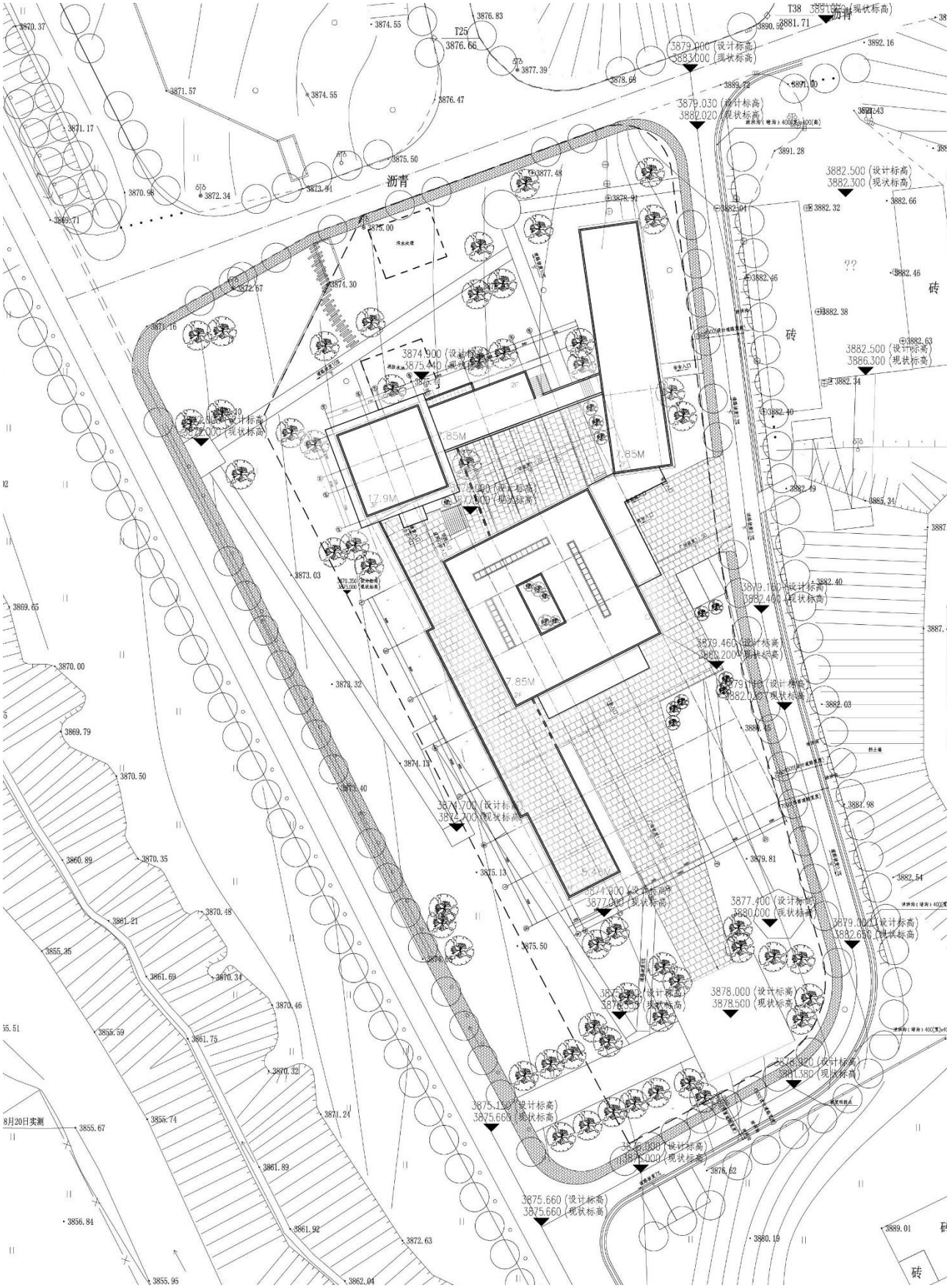
功能布局图

中国知网 https://www.cnki.net

0.3 总体规划

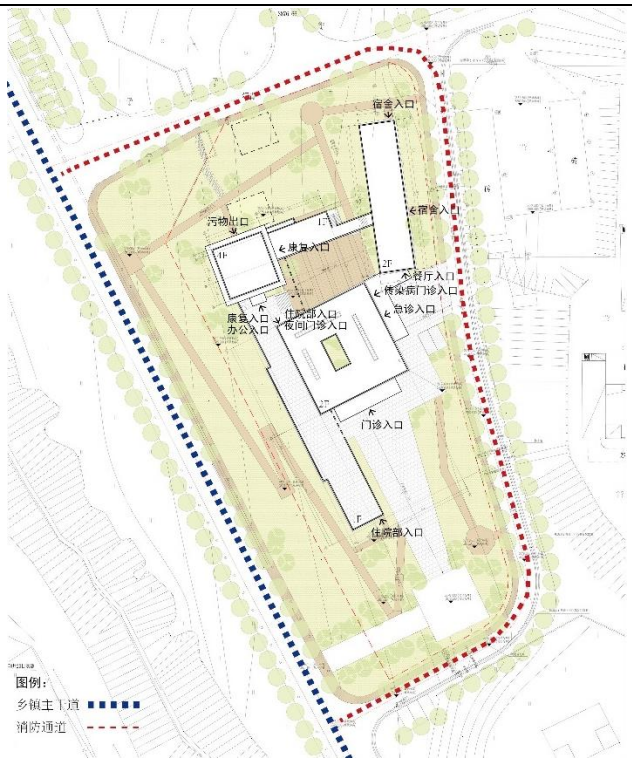
总平面图

中国知网 https://www.cnki.net

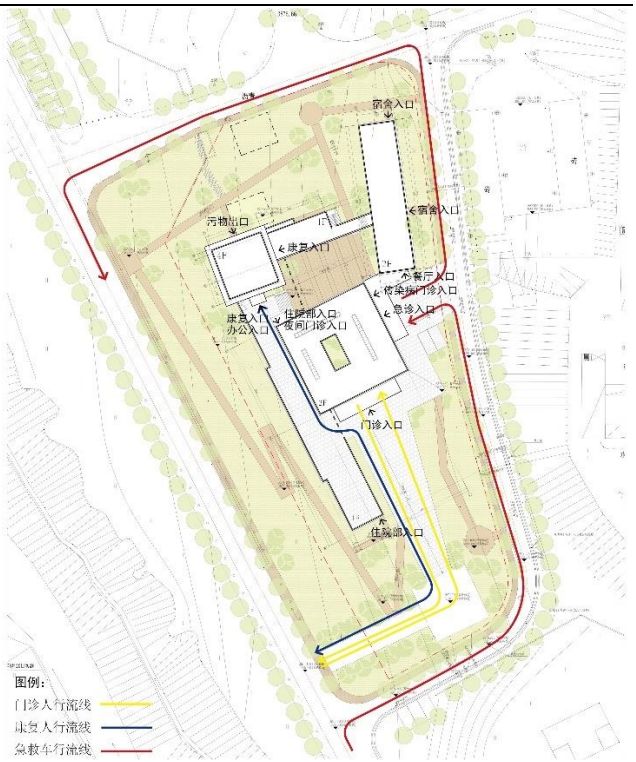


基地道路中心线标高设计

中国知网 https://www.cnki.net

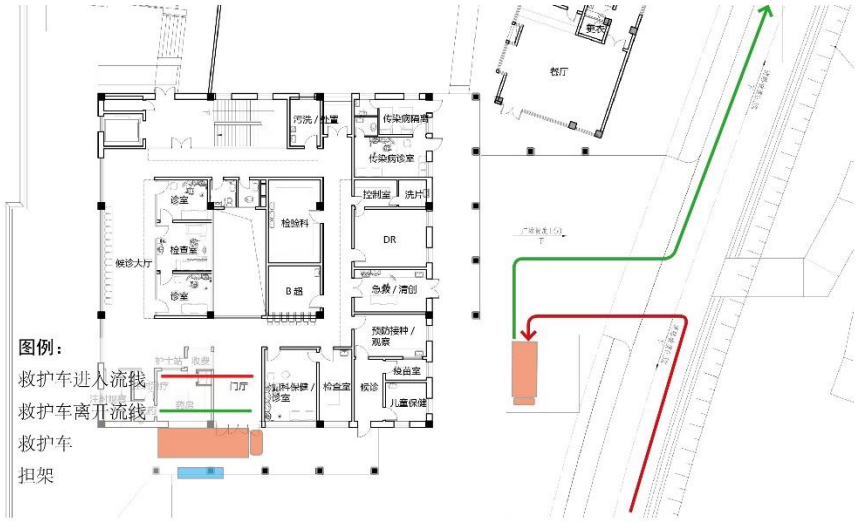


消防通道示意图



门急诊及康复流线分析

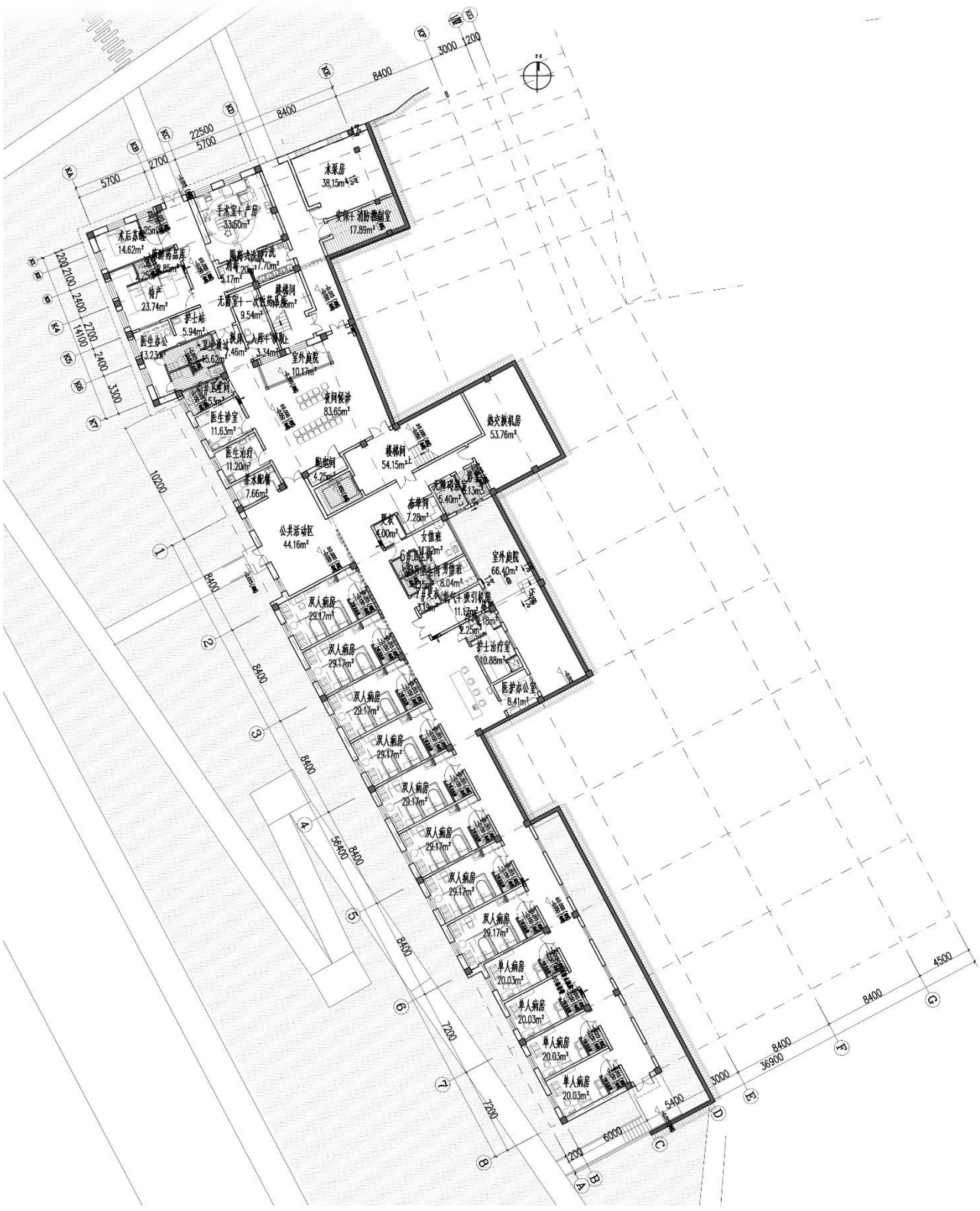
救护车搬运流线



救护车离开流线

中国知网 https://www.cnki.net

0.4 平面设计

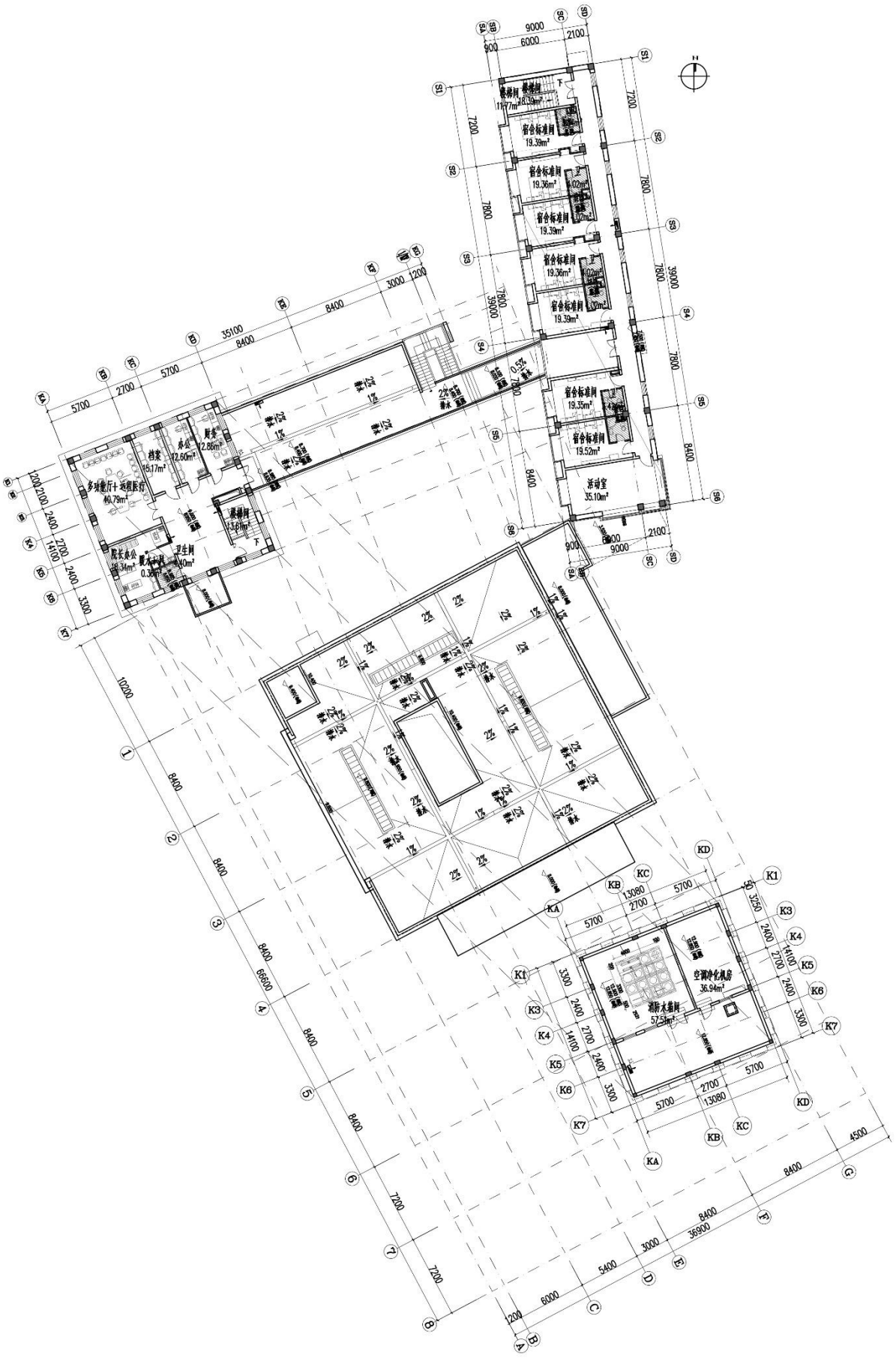


一层平面图（标高±0.000m）

中国知网 https://www.cnki.net

二层平面图（标高+4.500m）

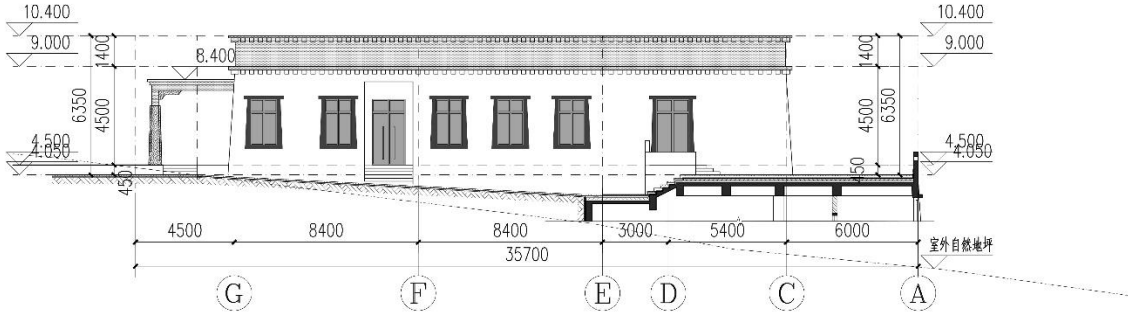
中国知网 https://www.cnki.net



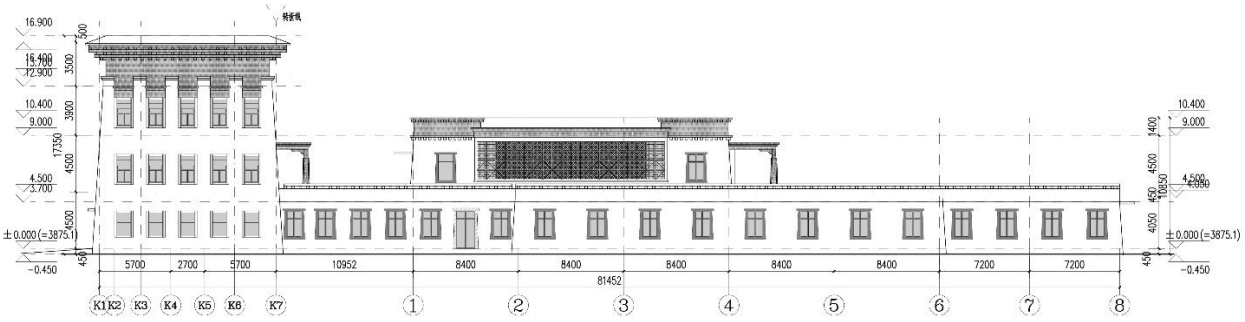
三层平面图（标高+9.000m）

中国知网 https://www.cnki.net

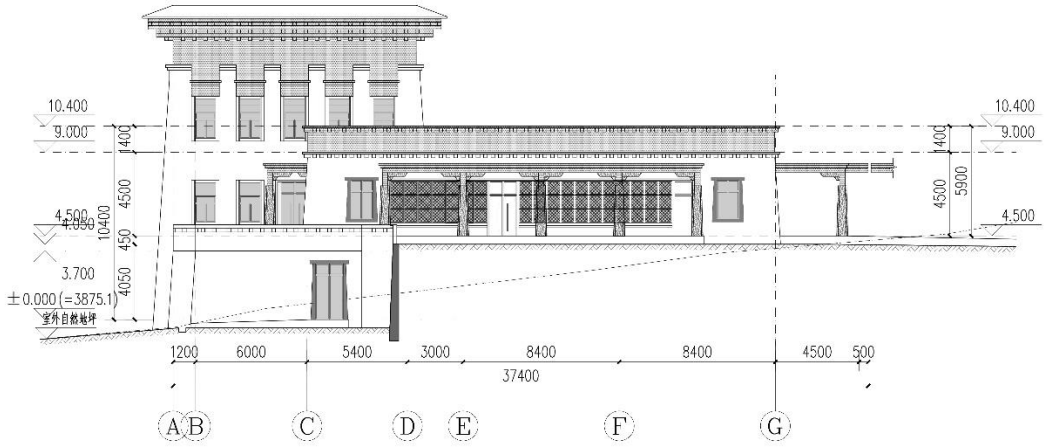
0.5 立面剖面设计



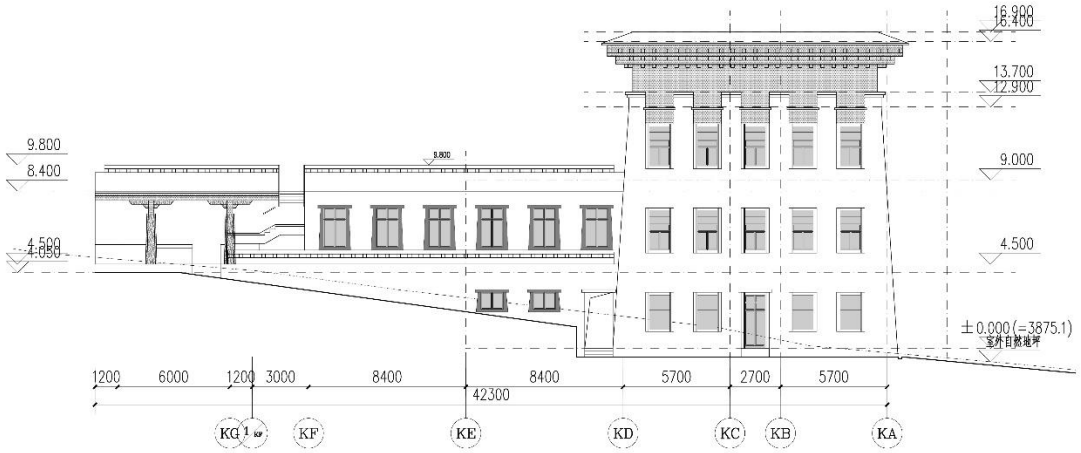
东立面图



西立面图

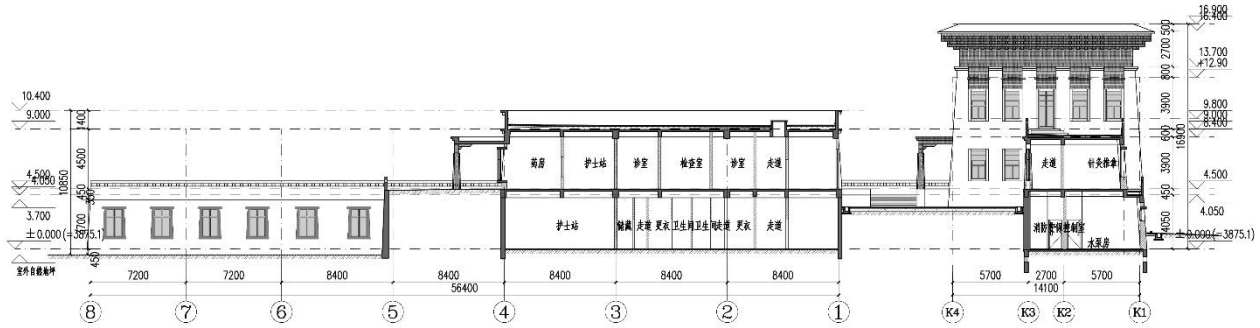


南立面图

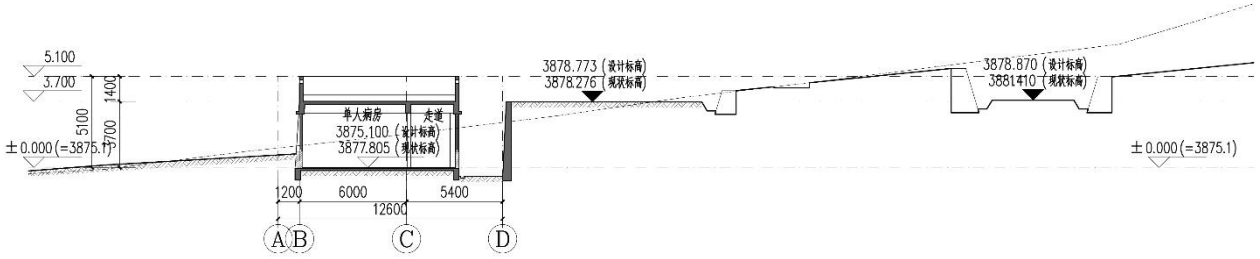


北立面图

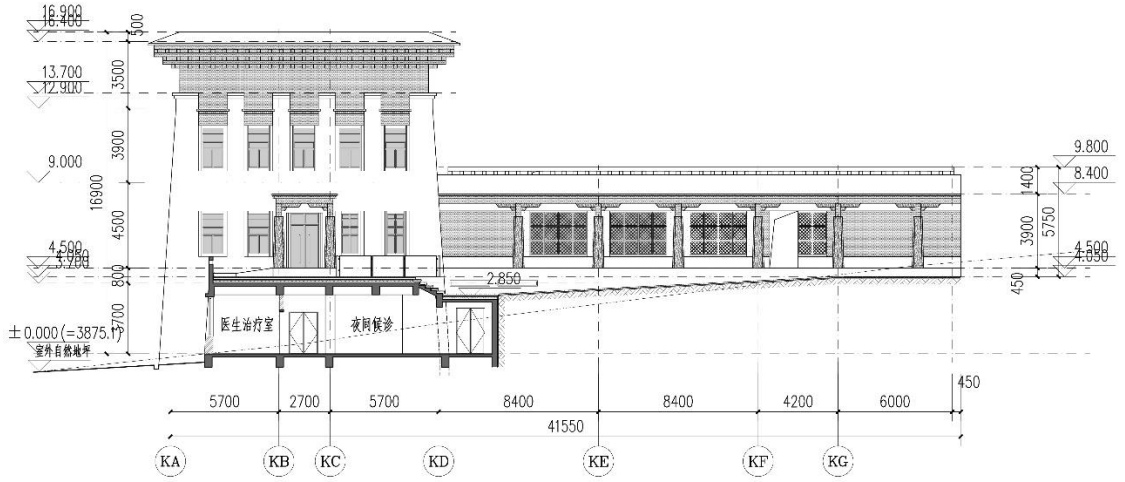
中国知网 https://www.cnki.net



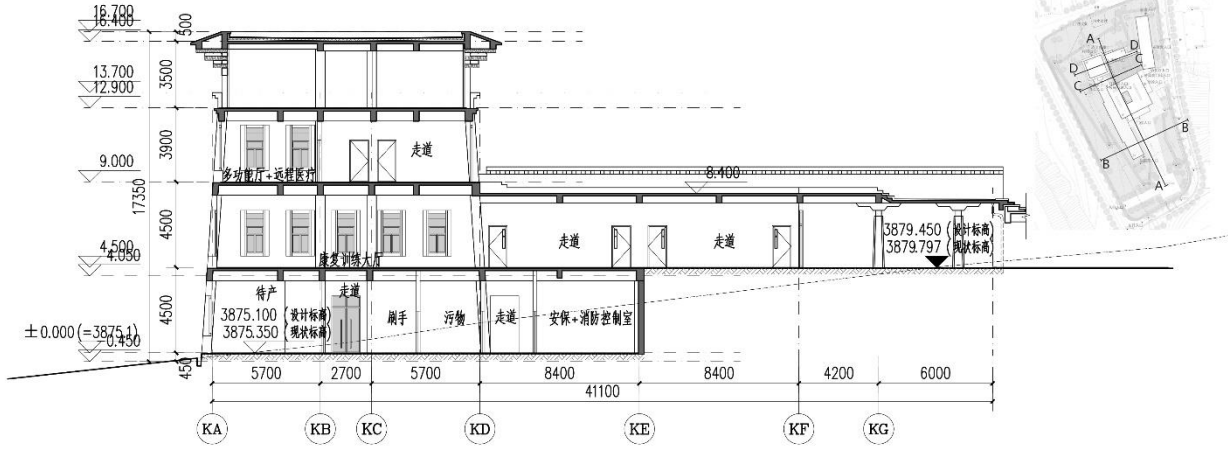
剖面 A-A



剖面 B-B



剖面 C-C



剖面 D-D

中国知网 https://www.cnki.net

下篇 工程研究报告

中国知网 https://www.cnki.net

第 1 章 绪论

1.1 研究背景及意义

21 世纪以后，人类疾病谱（见图 1-1）发生巨大改变，以肿瘤、心血管疾病为代表的多因素复杂性疾病积聚增加，据统计，80%的冠心病患者同时患有糖尿病，50%以上的心力衰竭患者合并肾功能不全，60%的肾功能不全患者合并冠心病和心力衰竭[1]。而当今大多数医院却仍以治疗方法或器官进行传统的内外科、精细化分科诊疗，需要多疾病患者挂多个号来回诊疗（见图 1-2），患者大部分时间浪费在重复挂号、排队、缴费等非医疗行为上，甚至可能得到完全不同的治疗方针，增加患者的身心和财力负担；也易造成医生以不属于我的医疗范畴为由，进行医疗责任的推诿[2]……

当然，院方也意识到过细的科室划分，会导致一定程度上对患者整体性和疾病对多器官多系统影响的忽视，不利于患者的“真正”治愈[3]，也不利于医院人才的培养和专科医生对全面病情的整体把握[4]，使得“医生各有专长，但患者知之甚少，很难找到合适的科室和合适的医生看病”[5]。

因此，考虑到新世纪多疾病患者的积增和传统医院科室划分过细等导致患者诊疗不便、诊疗不全等因素，院方开始积极的开展学科整合、开设诊疗中心，进行多学科合作诊疗（MDT）[1]，以简化患者就诊流程、缩短患者等候时间、降低患者诊疗成本、提高医疗服务质量和促进医院学科发展和人才培养。

但医院学科整合、诊疗中心的建设和实行多学科诊疗并非易事，既会遇到传统医疗体制的阻碍，如传统医院各科室单独考核和医生职称评定的问题，科室合作诊疗后内外科沟通和收入分配，多学科诊疗医疗学术权威的问题等，又会遇到建筑领域对医院多学科诊疗不敏感，多数医院仍按照传统内外科分开、相关科室和医技分离布局的硬件阻碍，使得医院科室整合和多学科诊疗发展缓慢或停留在简单的会诊上的情况[6]，诊疗中心的建设流于名称化，很难大范围的服务积增的多疾病患者，患者仍需奔波于医院各处，往返就诊。

因此，综合考虑诊疗中心在方便新时代患者诊疗、提高医疗效率和水平的巨大优势和传统医疗体制及相关科室、医技分开布局导致多疾病患者诊疗不便的现实问题，本文有必要从医院建设较完善的诊疗中心入手、解明新时代医院门诊科室、医技间的关系、探求新时代医院门诊部的设计方法，帮助建筑师紧跟医疗前沿邻近布局医学相关科室和医技部门，帮助促进医院学科整合和诊疗中心建设，为方便当今时代甚至未来很长一段时间的患者提供诊疗的便利。

[1] MDT（Multi-Disciplinary Team）：多学科合作诊疗，英国官方定义为：多个医学学科合作诊疗各自常规领域外的复杂问题，并根据对复杂问题的新理解达成解决方案。其工作范围包括，从多个学科出发，打破各科领域界限，共同利用知识、技能以提供最佳的实践，如重新定义医疗、社会关怀、志愿或私人护理的提供者，重新界定和构建医疗与社会护理的提供问题，并在对复杂疾病患者多学科集思广益的基础上提出解决方案。参见：https://www.england.nhs.uk/wp-content/uploads/2015/01/mdt-dev-guid-flat-fin.pdf

中国知网 https://www.cnki.net

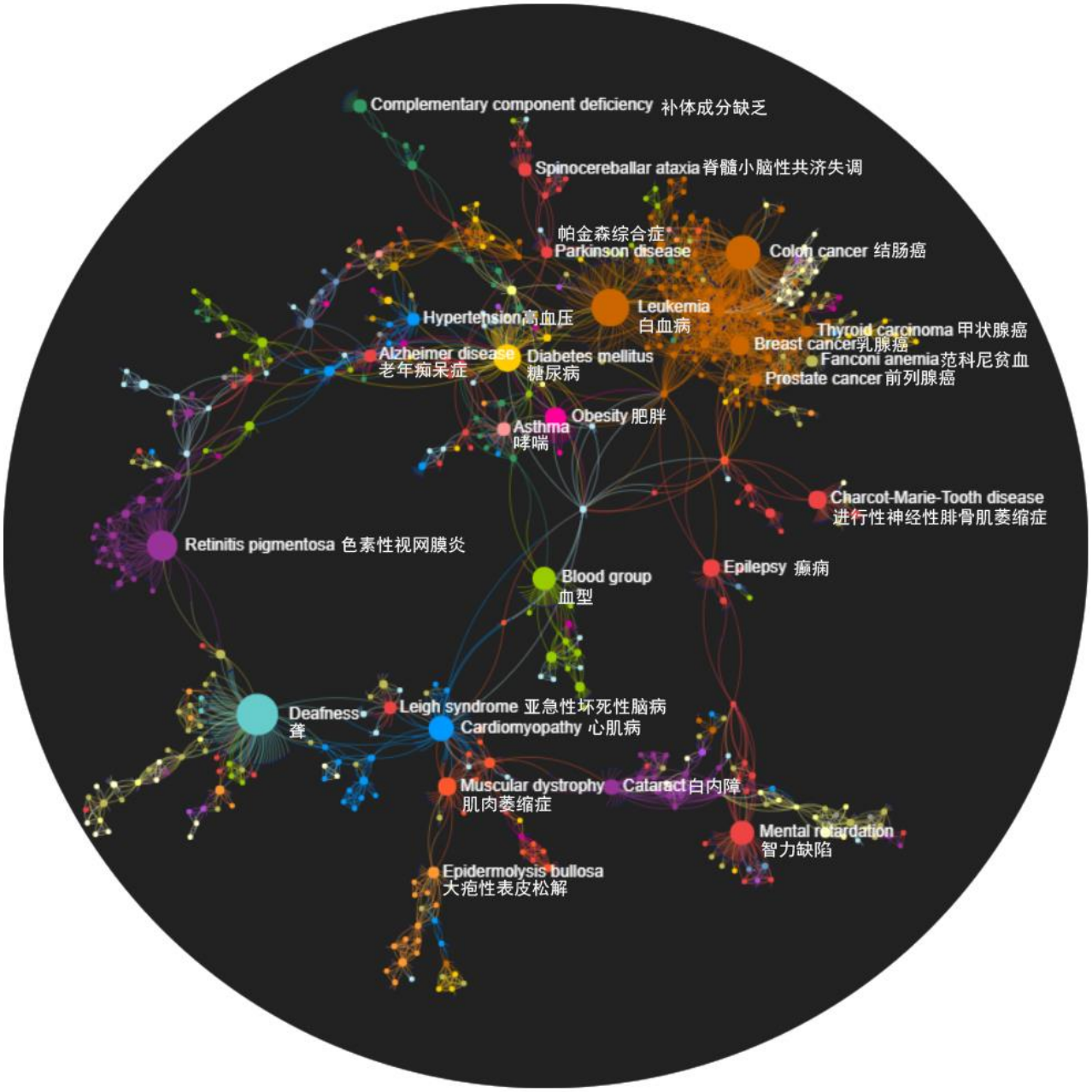


图 1-1 人类疾病谱网络结构

图片来源：http://exploring-data.com/vis/human-disease-network/，并由作者翻译

中国知网 https://www.cnki.net

图 1-2 糖尿病并发心脏疾病患者在鼓楼医院就诊动线模拟图
图片来源：作者自绘

1.2 定义及研究范围

1.2.1 定义

综合医院：根据《综合医院建筑设计规范》GB 51039 上定义，综合医院指有一定数量的病床，分设内科、外科、妇科、儿科、眼科、耳鼻喉科等各种科室及药剂、检验、放射等医技部门，拥有相应人员、设备的医院。

门诊部：是一所集医疗、预防、检测、康复为一体的综合性医疗机构。内设外科、妇科、内科、耳鼻喉科、中医科、医学检测等特色科室，是一所医院的重要职能部门，为不住

中国知网 https://www.cnki.net

院的病人进行医疗、咨询。[1]

医技科室：指运用专门的诊疗技术和设备，协同临床科诊断和治疗疾病的医疗技术科室。[2]

中心化诊疗：主要指医院的服务模式。相关医学专科间或不同医学学科间由于诊疗某些疾病的需要，进行以多学科合作诊疗的模式（MDT）服务患者。

诊疗中心：对邻近布置提供中心化诊疗的科室的总称。根据诊疗疾病的不同，会有不同类型的诊疗中心。如心脏中心，其主要由心内科和心外科邻近布局，以合作诊疗心脏器官类疾病。

诊疗中心式医院设计：以诊疗中心的建设思想但不限于诊疗中心的建设，针对各医院科室、医师、设备和空间等的资源条件，整体深入把握科室间、科室与医技间和“诊疗中心”的关联性，基于相互关联科室、医技和“诊疗中心”邻近原则的医院设计方法。

1.2.2 研究范围

国内外诊疗中心建设热潮，对新时代医院建设提出了新的要求，本文从诊疗中心角度入手，研究新时代医院科室、医技间关系，以指导国内外新时代医院的建设。目前国内外诊疗中心朝着自身科室完善和科室自身诊断、治疗空间的完善方向发展，除设置在门诊医技楼外，部分诊疗中心也会独栋建设，更有可能独立成为专科医院。本文则主要以研究综合医院门诊医技楼设置的诊疗中心为主，探讨新时代医院科室与医技间关系，见图 1-3。

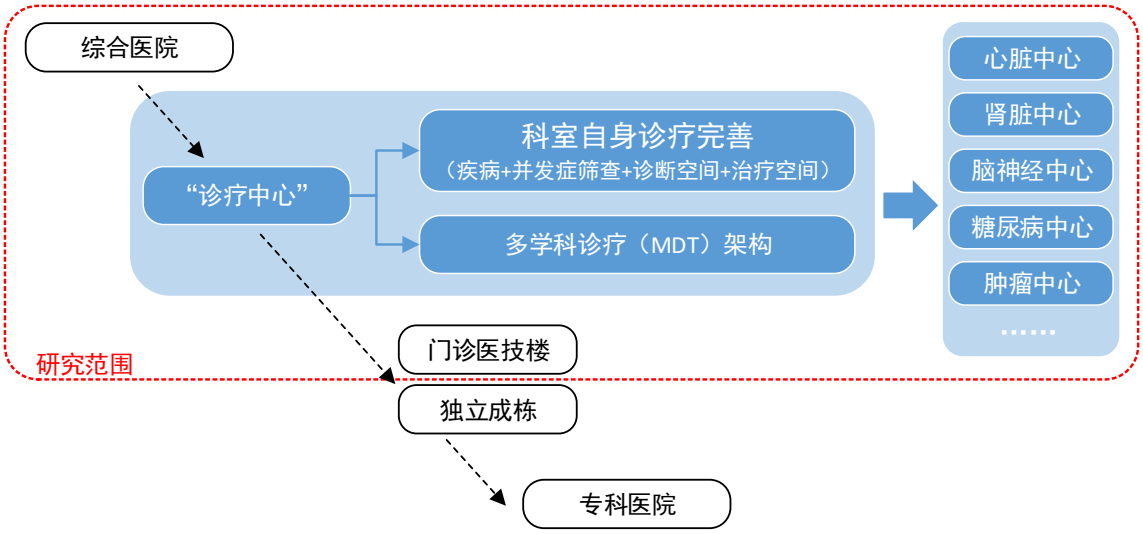


图 1-3 研究范围
图片来源：作者自绘

1.3 国内外研究现状及发展动向

1.3.1 欧美

若直接以“general hospital outpatient department design”和“hospital medical center design”等为关键词进行欧美国家综合医院诊疗中心建设的相关文献搜索，多搜索到医学类文献，很少有关于门诊部诊疗中心建设的文献，其主要跟欧美国家医疗体制有关。在欧美，人们生病了一般先到相关家庭医生的诊所中诊疗，如有问题需要专科医生解决，家庭医生才会指点患者到专家处诊疗，而家庭医生会时时与专家保持联系，以全权负责病人的治疗工作。[7]而医院则主要是服务住院病人和急诊病人的场所，主要包括急诊部、住院部和医技部，几乎没有像

[1] 定义来源：百度百科，（https://baike.baidu.com/item/%E9%97%A8%E8%AF%8A%E9%83%A8/9468801?fr=aladdin）
[2] 定义来源：百度百科，（https://baike.baidu.com/item/%E5%8C%BB%E6%8A%80%E7%A7%91%E5%AE%A4/3112035?fr=aladdin）

中国知网 https://www.cnki.net

国内这样的门诊部。由此可见，欧美国家不需要住院的患者一般去门诊诊所诊疗而不是去医院诊疗，因此转为对欧美国家门诊诊所“outpatient clinic”建设趋势进行研究。相关文献，见附录 A-1 和附录 A-2。

通过整理欧美国家门诊诊所建设相关文献，可将对欧美国家门诊诊所建设的研究文献归纳为如下几个部分：总体设计角度、使用者角度、转诊角度、通用设计、功能配置、计算机模拟和专科诊所设计，见图 1-4。可见欧美国家各年代对门诊诊所的研究文献主要集中在对专科诊所的研究上， 2011 年以后，从使用者角度、诊所功能配置和专科诊所设计研究的文献激增。

其中，从使用者角度对门诊诊所的相关研究，最早开始于 1990 年汤姆森等人从患者活动进行医疗中心的研究，《Planning the move of patient activities at a large medical center》[8]；2008 年，A Radley 等人开始从医生的角度进行诊所空间的考察《Time, space and opportunity in the outpatient consultation: ‘The doctor's story’》[9]；2011 年后，除从患者角度和工作人员角度对门诊诊所研究外，也出现了一定的从患者和工作人员整体角度出发对门诊诊所设计考察的文献，如《Effect of Clinic Design on Patient Care: Perceptions of Medical Staff and Patients》[10]，而从患者角度出发研究的文章，会更关注特殊患者如何使用诊所，如从轮椅使用者角度的研究《Healthcare utilization and associated barriers experienced by wheelchair users: A pilot study》[11]，从工作人员角度出发的研究文献，则主要在设计新的团队医疗空间上，《The Impact of Environmental Design on Teamwork and Communication in Healthcare Facilities: A Systematic Literature Review》[12]，见图 1-5。

对门诊诊所功能空间的相关的研究，起于对门诊候诊区的研究；90 年代，开始研究门诊诊所护理区；2001 年后，增加对内视镜检查室和一般检查室的研究；2006 年后，增加对哺乳区、多学科诊所、姑息医疗、诊室和康复功能空间的研究；2011 年后，又增加了对远程医疗和工作人员空间等功能空间的研究，见图 1-6。其中，近年来增加较多的是对门诊诊所工作人员使用空间的研究，并主要集中在对团队工作人员使用空间的研究上，如 2015 年詹妮弗等人对美国时兴的团队护理模式，开展相应的门诊诊所空间的研究，《Designing Team Rooms for Collaboration in the Outpatient Clinics》[13]。由此可见，欧美国家门诊诊所功能空间随着使用者需求、护理模式及医生工作模式的变化在不断增加和完善。

对专科诊所的研究，在各年代均为欧美国家的研究重点。90 年代之前，对专科诊所设计研究的类型包含性病诊所、城乡结合诊所、学前儿童发展诊所、泌尿科诊所等等；1991 年到 2000 年，除了对精神病诊所、疼痛诊所、糖尿病中心等继续研究外，又增加了对影像中心、更年期诊所、门诊透析中心、初级保健诊所等的研究；2001 年到 2005 年，新增诊所研究类型包含风湿病诊所，血液、肿瘤、骨髓移植诊所、认知症诊所等，且在此期间，杰恩·马尔金（Jain Malkin）出版了涉及多类门诊诊所建设的书籍，《Medical and dental space planning: A comprehensive guide to design, equipment, and clinical procedures》[14]，详尽地讲解了包括家庭医生诊所、内科、儿科、外科、妇产科等在内的各类诊所的设计要点、功能需求和面积配置，及便于患者快速找到其他专家的合伙开业的诊所建设模式；2006 年到 2010 年，多学科诊所、肿瘤诊所、骨科诊所、姑息医疗诊所等相关研究出现；2011 年之后，心脏诊所、骨质疏松诊所、哺育诊所、多学科消化病诊所等相继相关研究出现，见图 1-7。通过对比各年代专科诊所的研究类型，可以发现欧美国家对专科诊所研究类型一方面朝着精准的专科化发展，另一方面朝着多学科合作方向发展。

对比各年代均出现的对专科诊所建设研究的文献，可见，2010 年前相关研究主要专注于如何建设某类专科诊所，2011 年后相关研究则着重考察新时代的诊所需求。如 2011 年后，疼痛诊所的研究关注点转为如何架构团队合作诊疗空间，《Medical Group Visits: A Feasibility Study to Manage Patients with Chronic Pain in an Underserved Urban Clinic》[15]；糖尿病中心的关注点转为诊所如何适应电子诊疗、多学科护理的需求等，《Impact of Diabetes E-Consults on Outpatient Clinic Workflow》[16]和《Transformation of the Multidisciplinary Diabetic Foot Clinic

中国知网 https://www.cnki.net

Into a Multidisciplinary Diabetic Foot Day Unit》[17]；初级保健诊所的关注点在于如何整合特定疾病人群的治疗，如《Integrating HIV treatment with primary care outpatient services: opportunities and challenges from a scaled-up model in Zambia》[18]；骨科诊所的专注点在虚拟骨科诊所的设立，《Virtual stone clinic – the future of stone management?》[19]等等。由此可见， 2011 年后，再次出现的对同类型专科诊所的研究，无不涵盖了对新科技、患者需求和诊疗护理模式考虑。

综上所述，欧美国家对门诊诊所的研究，在专科诊所的研究领域朝着更细分的专科诊所领域和多学科联合诊所领域发展；对一般门诊诊所功能空间的研究，紧跟新时代患者需求和新医疗模式的改变，不断加入新的功能需求，尤其是对团队合作空间的需求；以使用者角度研究门诊诊所的文献，除了关注患者 需求外，也加入了对工作人员需求的考虑，尤其对团队工作人员使用空间的考虑。由此可见，欧美各类诊疗研究文献均不约而同的朝着多学科合作诊疗方向发展。

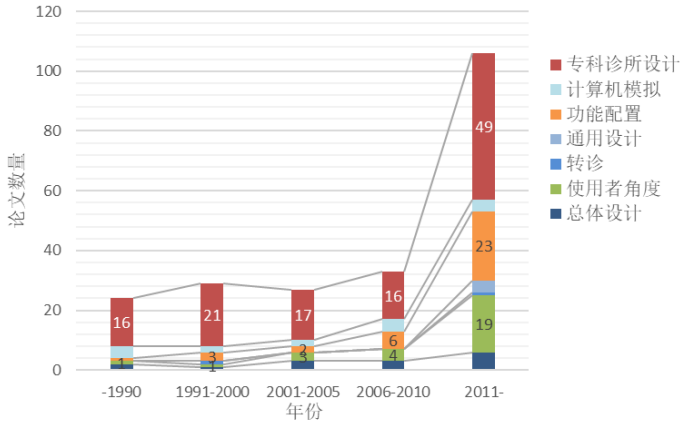


图 1-4 欧美门诊诊所设计相关论文研究关系图
图片来源：作者自绘

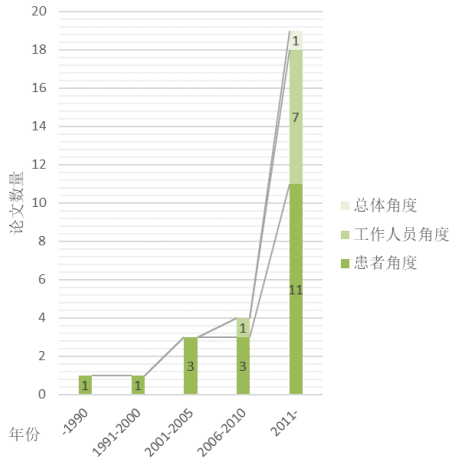


图 1-5 欧美国家以使用者角度出发研究门诊诊所相关文献统计图
图片来源：作者自绘

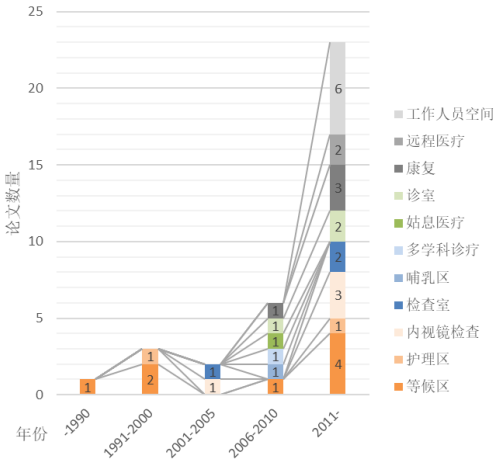


图 1-6 欧美国家各年代门诊诊所功能配置相关文献统计图
图片来源：作者自绘

中国知网 https://www.cnki.net

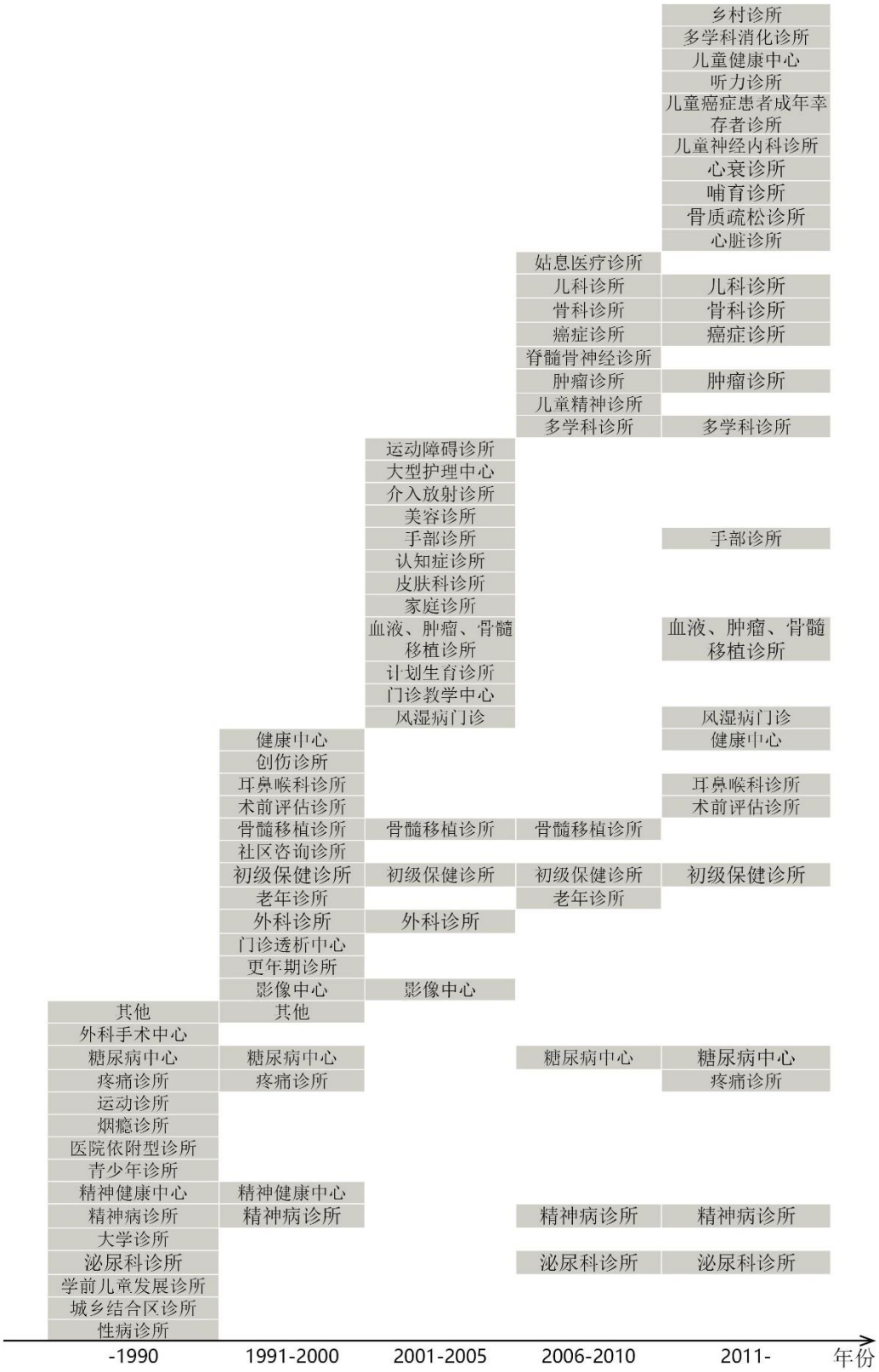


图 1-7 欧美国家各年代专科诊所类型研究文献统计图

图片来源：作者自绘

1.3.2 日本

以“病院外来部、診療センター、設計”等为关键词对日本医院门诊部诊疗中心相关设计研究文献进行检索，可得到日本一些对综合医院门诊部诊疗中心的研究文献，但为更全面把握日本诊疗中心相关研究在综合医院门诊部相关研究中的位置和趋向，分别对日本综合医

中国知网 https://www.cnki.net

院门诊部文献研究和诊疗中心文献研究进行整理分析，见附表 A-3。

按照文献的研究内容，除总体设计外，大体可将日本综合医院门诊部的相关研究归纳为功能规划、交通流线、和空间营造三个部分，且呈一定的时间脉络，见图 1-8。早在 1954 年，日本就开展对医院门诊部功能规划的相关研究，吉武・泰水等人发现医院在集中布置医技空间带来高效的同时，导致患者滞留建筑空间拥塞的状况，进行对医院门诊规模的研究《病院外来部の規模》[20]，和医院科室候诊空间的研究《331 待合室の規模 : 病院外来各科》[21]。从 1967 年小栗・英男等人对门诊物品动线的研究《23 病院内に於ける物の動きについて : 外来診療に伴なう伝票の動き(第 4 部 設計計画)》[22]，到 1975 年中野・明等人对患者动线《525 外来患者の動きと中央診療施設の利用実態 : 病院の建築計画に関する研究(建築計画)》[23]和患者停留时间的相关研究《外来患者の院内滞在に関する考察(その 1) : A 病院でのケーススタディ : 建築計画》[24]，表明日本全面展开对医院门诊部交通流线的研究；直到 1997 年，伊藤・克洋等人进行对医院门诊候诊空间评价研究《24 外来患者による病院外来待合い環境の評価構造 : ニューラルネットワーク利用による主観的評価の解析手法に関する研究(建築計画)》[25]，日本建立了较为完善的医院门诊部的研究体系。

通过对日本各时期医院门诊部相关研究论文进行数量统计，见图 1-9。可见 90 年代前，日本大量研究文献专注对医院门诊部的研究，并主要集中在医院的功能规划方面。90 年代初，日本医院门诊部功能规划研究论文数量减少，出现从使用者角度出发对医院寻路系统《患者の行動と認知を通してみた病院外来の考察 : Hospital Geography に関する研究 1》[26]和空间营造的研究《24 外来患者による病院外来待合い環境の評価構造 : ニューラルネットワーク利用による主観的評価の解析手法に関する研究(建築計画)》[27]，这暗示着日本医院门诊部的研究开始从对传统医院功能效率的研究转变为从患者和工作人员等医院使用者舒适性角度的研究。21 世纪之后，功能规划的相关研究整体研究数量又开始占据主要地位，其中变化较为明显的是对医院诊疗中心的相关研究。

日本医院诊疗中心的建设研究起于 1960 年，开始于对医技中心的研究《病院ラジオアイソトープセンター》[28]，之后又出现对母子医疗中心、康复中心、癌症中心、脑卒中中心、心脏中心等不同类型诊疗中心的建设研究，见图 1-10。2011 年后，诊疗中心相关建设研究迎来了高峰，各类诊疗中心大量涌现。虽然其中大部分文章为对诊疗中心相关建设项目的介绍，但已经足以说明在日本，医院诊疗中心的建设已成为趋势。

其中母子医疗中心、脑卒中中心和癌症诊疗中心的建设研究在多个年代均有讨论，但各年代研究的侧重点不同。

母子医疗中心：早在 1963 年，日本就有关于医院母子医疗中心的建设研究 ，但主要以产科建设，成立母子医疗中心为侧重点，《17. 産科診療施設の地域的計画 : 地域における母子健康センターの使われ方(1)(第 4 部(基本計画・設計々画・設備関係))》[29]；2000 年之后，母子医疗中心建设强调周产期母子安全的建设，《作品 大分県立病院総合周産期母子医療センター--設計 伊藤喜三郎建築研究所》[30]；2010 年之后，母子医疗中心的建设开始转为产妇周产期与儿科合作诊疗的相关建设，《IWAHORI'S EYE 病院建築最前線(第 50 回) 周産期および小児医療を 80 年にわたって展開。培ったノウハウを建物設計に生かして新築移転し、生命の誕生と成育のさらなる効率的支援を目指す 社会福祉法人恩賜財団 母子愛育会 総合母子保健センター 愛育病院》[31]。

脑卒中中心：2005 年，日本开始出现脑卒中中心的相关建设研究，《弘前脳卒中センター--日建設計（特集 ニュー・ホスピタル・スタンダード--これからの病院建築に求められるもの)》[32]；2010 年，转为对急性期医院脑卒中中心的建设研究，《急性期中核病院の機能としての脳卒中センター（特集+医療建築 トータルケア・ホスピタル)》[33]；到 2013 年，脑卒中中心的建设研究转为与康复中心合作建设研究的倾向，《14021 弘前脳卒中・リハビリ

中国知网 https://www.cnki.net

テーションセンター 東棟(縮退する社会の中で,あるいは震災後の今考える,医療・療養空間の未来(1),建築デザイン,2013 年度日本建築学会大会(北海道)学術講演会・建築デザイン発表会)》[34]。

癌症中心：2002 年，门诊点滴中心的研究开始，即化疗中心的原型，《外来点滴センターの運営概要と物的環境 -通院治療部門の建築計画に関する研究（その 1)-》[35]；2004 年，姑息・化疗中心成立《作品 名古屋掖済会病院 緩和・化学療法センター--設計 日本設計》[36]；2008 年，全面涵盖化疗、放疗和姑息治疗等癌症治疗方法的癌症中心的建设研究开始，标志着癌症诊疗中心自身诊疗设施的完善，《済生会熊本病院外来がん治療センター--東畑建築事務所（特集 3e-ホスピタル)》[37]。

由此可见，日本各类诊疗中心的建设研究，在不断完善自身诊疗技术的同时，也朝着与其他科合作诊疗的方向发展。

除此之外，2010 年，永坂・祐贵等人提出通过科室适当配置，解决患者复科就诊而造成在医院滞留问题《病院の改装に向けた診療科適正配置に関する研究－外来診療科の適正配置の検討－》[38]。2015 年，中村・茂树、今井・沙耶、金子・真央等人意识到医院科室中心化的趋势，并开始以患者复科就诊视点研究科室邻近的倾向和科室中心化的形成倾向《5066 診療科特性から読み解くセンター化の有効性と課題 ：外来部門の診療科再編・連携に向けた患者空間構築に関する研究 その 1(病院の全体計画,建築計画,学術講演会・建築デザイン発表会)》[39],表明日本开始注意到综合医院整体门诊科室调整和科室中心化倾向。

综上所述，近年来日本综合医院诊疗中心建设研究，一方面扩充着不同诊疗中心的建设研究类型，另一方面不断完善诊疗中心自身的诊疗技术和探讨与其他科室的合作诊疗的可能；并出现以复科就诊患者相关科室邻近诊疗视点出发的对综合医院科室中心化研究的文献。

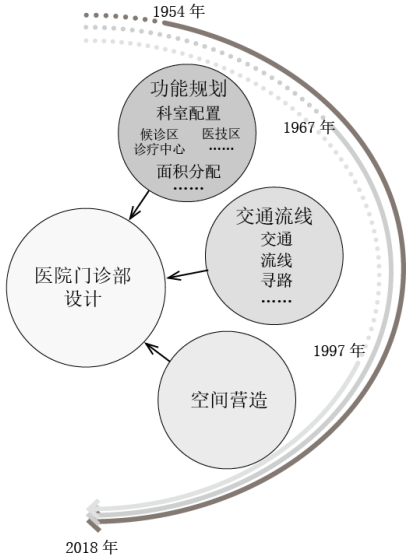


图 1-8 日本综合医院门诊部设计研究脉络图
图片来源：作者自绘

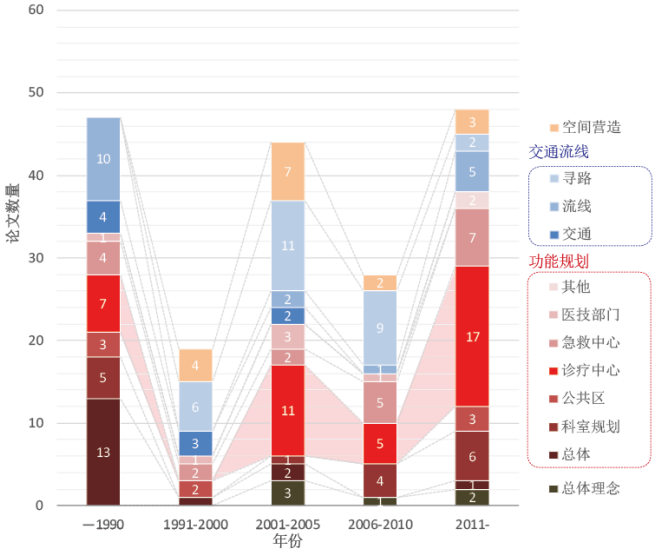


图 1-9 日本综合医院门诊部历年研究统计条形图
图片来源：作者自绘

中国知网 https://www.cnki.net

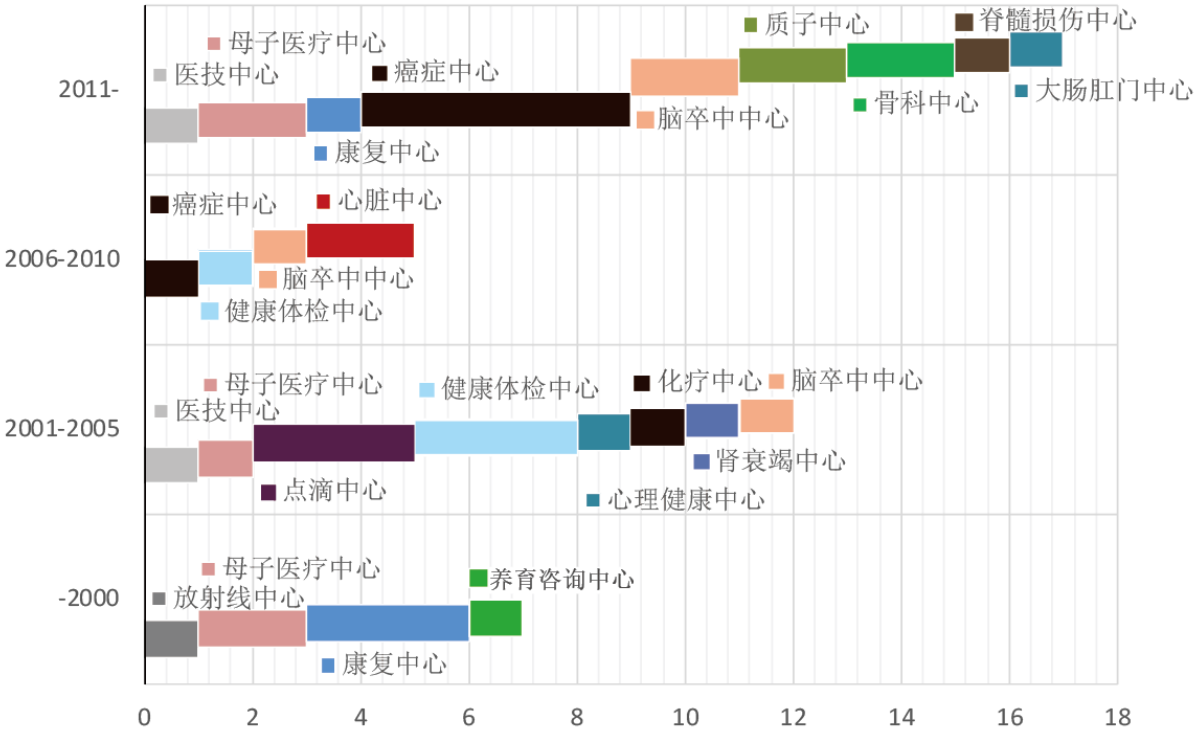


图 1-10 日本综合医院门诊部诊疗中心各年代研究百分比堆积条形图
图片来源：作者自绘

1.3.3 中国

1）建筑领域

以“综合医院诊疗中心建设”和“诊疗中心建设”等为关键词在中国知网上搜索，可以得到大量医学类关于诊疗中心成立的文献和少部分建筑类医技中心相关研究文章，扩大搜索范围至“综合医院门诊部设计”，才得到建筑类相关研究文献，见附录 A-4。

通过对各研究文献研究领域划分，可以得到我国综合医院门诊部相关研究架构图，如图 1-11。无论从前期策划、医疗工艺，还是设计理念、功能布局和交通流线，虽然各类研究文章都涉及对综合医院门诊部的设计研究讨论，但往往点到为止，关注门诊部整体视角的讨论，很少涉及门诊内部科室讨论和以诊室为基础的诊疗中心的研究。

通过统计各年代国内综合医院门诊部设计相关研究文献（图 1-12），可见，2000 年之后，我国建筑领域才出现少部分关于综合医院门诊部相关研究文献，且多为设计理念类文献，如 2002 年郭晖以“以病人为中心”为题，从“总体设计”、“内部功能分区及流线组织”、“人性化的室内环境”和“现代化的建筑造型”四个方面以项目介绍的方式讲解湖北省人民医院综合门诊楼的设计等[40]；2006 年之后，各方面研究综合医院门诊部的文章开始涌现，并出现了部分关于医技中心和诊疗中心设计的相关文献，其中对诊疗中心的相关研究，出现在 2010 年，高枫首次以设计理念的方式提出超大型医院“网格型+医疗中心”型的设计模式，指出超大型医院可以以专病模式代替门诊模式，每个医疗中心都设有各自对应的门诊医技和住院单元，形成院中院，解决病人来往于门诊和医技检查线路过长的问题，《超大型综合医院医疗体系设计研究》[41]；2011 年之后，综合医院门诊部设计研究的文献大量出现，其中多为医技中心的相关文章，包括超声影像中心、介入治疗中心、血液透析中心、检验中心、内视镜中心等的相关研究，这些文章大部分从医技部门入手，谈及医技中心涉及科室和具体的医技中心布局流程。如 2014 年西安建筑科技大学发表了一系列关于医技中心相关研究的硕士论文。如杨冰洁的《现代综合医院检验中心空间设计研究》[42]、王炜的《现代综合医院内镜中心建

中国知网 https://www.cnki.net

筑空间设计研究》[43]和张名良的《现代综合医院血液透析中心的建筑空间设计研究》[44]等。

总的来开国内对诊疗中心的相关研究，可分为以科室和医技关系为基础的诊疗单元的相关研究和诊疗中心相关设计理念的研究。2011 年，张雷从传统的候诊室、外科诊室、内科诊室的出发笼统的分析研究各科室平面布局和室内环境，《大型综合医院门诊部诊疗单元及空间环境设计研究》[45]；2016 年，徐更从科室与医技关系出发，以减少患者就诊距离为出发点进行相关研究，《精细创造高效 “新医疗体制”下三级综合医院交通组织的探索》[46]；2016 年，曹胜昔等人在高枫基础上，继续以理念的方式提出超大型综合医院“医疗主街+组团分中心”的设计模式[47]；2017 年，张远平等人对多学科诊疗模式下肿瘤中心的建设进行探讨，《基于 MDT 模式的肿瘤医院设计——四川省肿瘤诊疗中心新建工程》[48]，但这些文章仍点到为止，以设计理念的方式大而笼统的进行项目介绍。

以此可见，国内建筑领域对医院门诊楼的研究无论是从前期策划、医疗工艺，还是设计理念、功能布局、交通流线，虽然均涉及对综合医院门诊部的设计研究讨论，但却点到为止，以整体视角讨论医院门诊设计的注意点，很少涉及对医院门诊科室的讨论和以科室为基础的诊疗中心的研究。而诊疗中心的研究却仅以超大型综合医院的设计理念方式，和传统内外科室划分下，简单的单个科室加相关医技构成的布局方式提出。

2）医疗领域

医院建设跟各医院诊疗模式与诊疗理念的发展有很大关系，诊疗中心的建设也不例外。通过归纳整理我国医学领域关于设立诊疗中心的相关研究文献（见附录 A-5）、并与建筑领域对诊疗中心相关研究文献进行对比，以明确我国综合医院诊疗中心建设发展趋势，如图 1-13。

医学领域对诊疗中心的相关研究，除了成立相关诊疗中心和医技中心外，还涉及对学科建设及多学科合作诊疗模式的研究。早在 1995 年，北京医院就成立了帕金森病及锥体外系疾病诊疗中心[49]，随后全国各地相继建立了睡眠呼吸障碍诊疗中心、肺癌诊疗中心、肿瘤诊疗中心等不同类型疾病诊疗中心。2010 年后，诊疗中心的建设飞速发展，各医院均在打造本医院特色的诊疗中心，如 2013 年安徽省立医院创建安徽省首家“脑胶质瘤诊疗中心” [50]。

但诊疗中心的建设离不开医院科室的整合和诊疗模式的发展。2002 年，郑成中等人开始意识到现代医学对“病人作为一个整体”系统诊疗的忽视，探讨以病人为中心的多学科诊疗模式，以解决综合医院“全”与“专”的矛盾，《综合性医院多学科整体诊疗模式的构想》[51]；2006 年后，有关医院学科建设、多学科诊疗和中心化诊疗的相关研究广泛开展，各界医生开始探讨现代医学发展过细的问题。其中，《现代医学发展探寻多学科整合之路》[52]一文中提及现代学科发展过细导致专科医生仅局限于某一领域，而忽视了对患者的整体治疗的问题，并积极探讨将过细的专科整合起来的方法，以便于为患者提供个性化的诊疗方案；2011 年之后，医院方面对学科整合、多学科诊疗和中心化诊疗探讨更加深入，部分医院以自身的实践，探讨各自在学科整合和多学科诊疗过程中遇到机遇和挑战。如 2012 年，《中国医院院长》杂志当期对当时热议的医院学科整合问题，邀请著名医院院长，就各自医院进行学科整合和多学科诊疗过程中遇到的困难进行分享。在《学科整合突围》一文中，张贵民记录了如同济大学附属东方医院副院长李钦传等著名院长，就为解决目前患者由于科室划分过细，患者很难找到合适的科室和合适的医生看病等问题，而通过科室整合和多学科诊疗组建相关诊疗中心，以方便患者就诊的方法提出意见，并表示了对其他医疗届领军人物在各领域试图展开中心化诊疗，仅停留在吆喝上或简单的会诊阶段的叹息，也对现行人事制度对中心化发展阻碍表示无奈。其中提及各医院在科室整合过程中遇到的主要问题：1.外科和内科如何沟通的问题 2.患者收入住院后，收入分配的问题 3.内外科整合后评职称和医师执照的问题 4.医院现行单独科室考核体系与多学科交叉合作，工作量计算问题 5.学术权威的问题，多学科诊疗若都为教授诊疗，各自技术均有专长，很难相互信服的问题，等等。当然，各院院长也就各自医院遇到的问题提出了各自相关的解决措施，包括整改医院的考核体制、公开聘请专家等方

中国知网 https://www.cnki.net

式，以为学科整合扫除制度障碍；通过取消传统内外科大楼分开布局的情况，进行相关科室相邻的布局策略，以为学科整合提供物质基础；等等。[53]同年，王静成就苏北人民医院多学科诊治中心建设及学科整合状况发表了看法，《大型公立医院学科整合的初步探索》，其中提到学科整合对提高医疗质量，避免学科间专业局限性，提高医疗水平，简化诊疗流程，缩短就诊时间，降低医疗成本的重要作用，也说明了医院学科整合过程中遇到的一些问题，包括学科发展不平衡导致的学科整合的速度过慢，人才队伍结构不合理导致的学科长远发展规划不足，管理方式滞后导致的资源内耗和科研项目及高水平科研成果不够引起的学科发展瓶颈。[54]2013 年，王魁英等人就学科整合的类型、意义和方法进行了研究，《综合医院学科整合刍议》，其中提到学科整合有利于提高医疗服务治疗；有利于促进创新人才的培养；有利于提升医疗设备利用率；有利于提高医院管理效能，并提出遵循疾病谱变化进行学科整合、指定政策规章进行学科整合、依托高层次学科带头人进行学科整合和调整医疗用房，打破内外科界限进行学科整合等多种学科整合的方法。[55]同年，诸玲等人就无锡市第二人民医院门诊实行中心化诊疗的益处进行了分享，《创新实践路径 加快“中心化诊疗”门诊服务建设》，“中心化诊疗”可以提高诊疗效率，避免病人多次往返，减轻病人经济负担，缩短学科间具体，减少学科间隔阂，加强优势学科间优势互补[56]；2014 年，黄柳就瑞金医院 MDT[1]门诊运行模式遇到的问题和发展前景进行了报道，《细致演绎 MDT 门诊》，提到通过与职称挂钩和科室奖金挂钩等方面来消除高年资医生对 MDT 门诊能否找过挑战性的病例，是否消耗他们宝贵的时间的顾虑，也提到 MDT 门诊低收费与汇集医院 80%以上专家合作诊疗的不协调现象表示担忧，但即便如此，MDT 门诊“惠及患者和医院学科发展”的作用，让瑞金医院更加努力发展 MDT 门诊[57]。等等。

由此可见，虽然我国医疗领域早已认可学科整合和多学科诊疗（即中心化诊疗）为未来医院的发展趋势，并能“惠及患者和医院的学科发展”，但由于传统医院学科制度、医师资源、职称评定和奖金制度等原因，医院科室整合和中心化诊疗发展缓慢或停留在简单的会诊上。虽然各医院在科室整合和中心化诊疗中遇到不同的问题，但多数医院仍积极的进行医院科室整合和多学科诊疗，并指出：医院制度改革是解决医院科室整合和利于中心化诊疗的重要举措，相关科室邻近配置则会为技术融合奠定基础。

但在医疗领域对科室整合和中心化诊疗讨论开展的如火如荼时，建筑领域关于诊疗中心的研究却仍停留在对超大型综合医院的相关设计理念上。大多数医疗建筑师对医疗领域科室整合和中心化诊疗的趋势视而不见，不主动去了解新的医院科室间的关系，仍按传统的内外科方式进行医院的设计，从硬件上使得部分医院诊疗中心的建设停留在制度上或会诊上，使患者在医院各处寻求相关诊疗，极其不便。

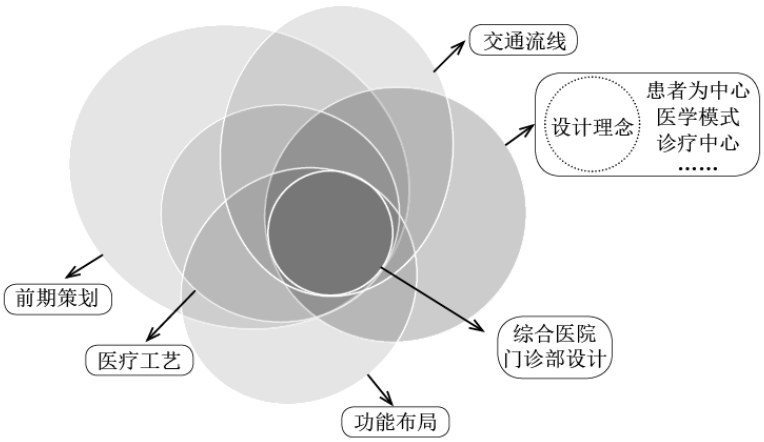


图 1-11 中国综合医院门诊部设计相关论文研究脉络图
图片来源：作者自绘

[1] MDT：Multi-Disciplinary Team 多学科诊疗

中国知网 https://www.cnki.net

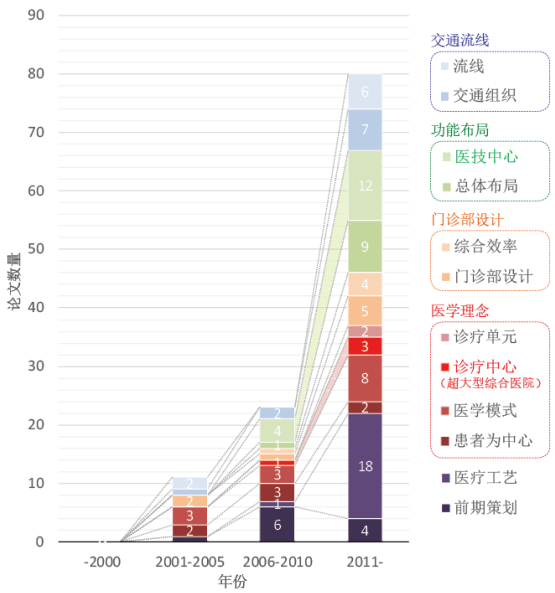


图 1-12 我国综合医院门诊部各方面设计研究论文统计条形图
图片来源：作者自绘

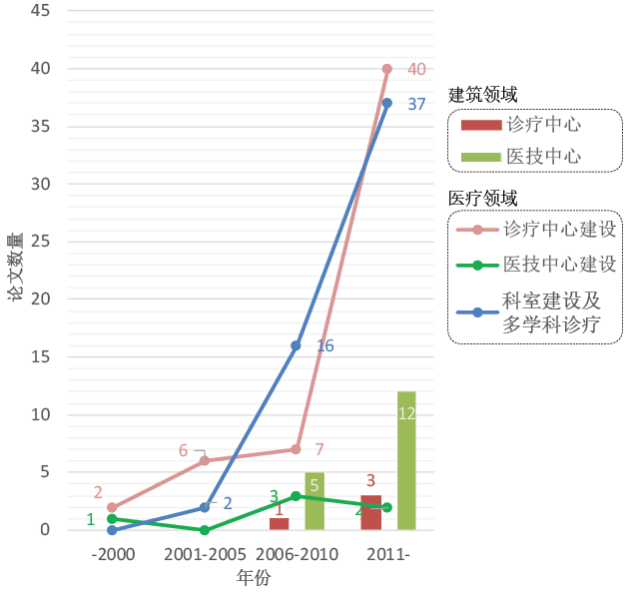


图 1-13 我国综合医院诊疗中心相关研究医疗领域研究与建筑领域对比图
图片来源：作者自绘

1.3.4 小结

总的来说，虽然世界各国医疗体制存在差异，诊疗中心相关建设研究的落脚点不同，但基于多学科合作诊疗的诊疗中心的相关建设研究却是世界各国医疗建设领域的研究热点：

1.欧美国家：与国内大小病均去综合医院门诊诊疗的情况不同，欧美国家医院主要为住院患者和急诊患者服务，一般患者需去诊所诊疗。且近年来，欧美国家门诊诊所的相关研究有以下几个特点：专科诊所相关研究朝着专业更加细化的专科诊所和多学科合作的联合诊所发展；一般门诊诊所功能研究，侧重从新时代患者需求和新医疗模式改变出发，在门诊诊所加入新的功能，尤其是加入团队医疗空间的需求；从使用者角度出发对门诊诊所的相关研究，除包括对特殊患者的考虑外，还着重对医护人员工作空间的考虑，尤其是对团队工作人员使用空间的考虑。欧美国家对门诊诊所建设研究的各角度均表明团队医疗（多学科诊疗）已成为一般诊所和专科诊所的设计趋势，并有相当部分文献对团队医疗使用空间进行研究。

2.日本：与国内医院建设类似，日本医院门诊部与住院部并设，但与国内无论患什么病均去综合医院诊疗不同，日本医疗往往有一定的层级划分，一般等级较高的医院多接受由下级医院转诊的患者或疑难杂症的患者，需要介绍信预约就诊，普通疾病仍在一般在诊所或中小型医院诊疗。相对国内诊疗中心建设停留在会诊上和建筑领域对医院诊疗中心研究停留在超大型综合医院建设的设计理念而言，近年来，日本医院诊疗中心的相关建设研究一方面不断扩充着对新类型诊疗中心建设研究，探究诊疗中心合并新技术以及与其他科室合作诊疗的可能，另一方面也有研究者以患者多科就诊的视点研究医院部分科室相邻布局的趋势进行医院科室中心化的研究，但没有文章从医院诊疗中心建设出发展开对医院相关科室邻近布局的研究。

3.国内：虽然国内综合医院的建设与国外不同，国内建筑领域也鲜有对医院诊疗中心和医院科室、医技间关系研究，但多学科合作诊疗和患者多科就诊的需求却在国内外类同。而医疗领域广泛开展的对科室整合和多学科中心化诊疗模式体制的探讨，以及提出的相关科室邻近布置对促进多学科诊疗、建设诊疗中心、方便患者诊疗的重要意义，均使得建筑领域应紧跟新时代患者的需求和医院科室建设及多学科合作诊疗的趋势，进行医院科室间和科室与相关医技间关系研究，以便于医疗领域进行科室整合、多学科合作诊疗、诊疗中心的建设，以方便多疾病患者的就诊。

中国知网 https://www.cnki.net

因此，鉴于欧美国家与国内医院建设模式不同，日本没有从医院诊疗中心角度出发对医院科室、医技间关系研究，国内医疗领域对科室整合和中心化诊疗的热议，以及建筑领域仍停留在对传统医院内外科分开布局和诊疗中心建设仅为包含相关医技的传统理解上，有必要以日本建设较完善诊疗中心的医院为研究对象，从诊疗中心的角度，研究综合医院科室、医技间的相互关系、综合医院诊疗中心配置方法和新时代医院的建设方法和诊疗中心的医疗发展潜力。

1.4 研究对象、研究内容和研究方法

1.4.1 研究对象

科室和医技是医院门诊部运营的基础，是医院诊疗中心建设的前提。本文从时兴的诊疗中心入手，展开对医院科室和医技部门位置关系的基础性研究，以探求新时代医院建设的方向和设计方法。

综合考虑：1.欧美国家诊所诊疗与国内综合医院门诊诊疗有很大不同，相关参考性较低；2.国内建筑领域对诊疗中心相关建设研究停留在设计理念层面，且与医疗领域对诊疗中心相关研究有很大脱节；3.国内医疗领域关于学科整合和多学科中心化诊疗的处于探索阶段，诊疗中心的建设停留在会诊方面；4.日本医院各类诊疗中心建设案例较多，医院建设情况与国内类似，且已有少部分出于对患者多科就诊而进行相关科室邻近的研究文献，可供参考；等因素，本文选择与国内综合医院建设较为类似的设有诊疗中心的日本医院为研究对象，探求医院门诊科室、医技间关系，为国内外诊疗中心化下新型医院的建设提供设计方法和思路，为国家和国际社会建设诊疗中心医疗体系埋下伏笔。其中具体日本医院的选取情况，见附录 B。

1.4.2 研究内容

从诊疗中心层面，解明目前日本医院建设有哪些诊疗中心，各类诊疗中心由哪些科室构成、涉及哪些相关科室和医技，其布局特征是什么，为理清新时代医院科室、医技间关系打下基础；从医院层面，解明不同医院应该配置多少诊疗中心、配置哪些诊疗中心，相关科室和医技如何布局，为新时代医院综合考虑科室、医技间关系，如何布局提供依据；并通过相同医院间比较，探求各医院诊疗中心配置不同的原因，诊疗中心建设的优势和局限，以窥探新时代医院建设方向和设计方法，为国内外诊疗中心式相关科室、医技邻近布局的医院建设提供理论依据和实践指导；并以总体视角，挖掘以诊疗中心模式架构国家和国际社会医疗、疾病网络的可能。

1.4.3 研究方法

本文涉及到的研究方法主要为既往研究、实地调研、医护访谈、案例归纳、统计分析、电脑模拟、对比分析和演绎归纳等方法。通过既往研究，了解国内外学者对医院门诊部诊疗中心下科室与医技关系的研究现状和研究深度，为本文研究明确方向。通过实地调研和医护访谈，了解国内外医院和诊疗中心建设现状和建设趋势，为本文提供现实依据；通过案例归纳、统计分析和对比分析，研究日本医院各类诊疗中心科室组成、关联科室和涉及医技，和各类医院诊疗中心配置数量、种类和布局情况，为国内外医院建设诊疗中心打下物质基础；通过对比分析，了解日本各医院诊疗中心配置数量和种类不同的原因和医院中心化诊疗的优势和困境，以帮助国内外医院综合考虑自身情况，合理布局相关科室和医技，成立诊疗中心；通过演绎归纳，全面模拟诊疗中心式医院科室、医技间相互关系，和诊疗中心式医院平面布局类型，为国内外新型医院建设提供依据。

中国知网 https://www.cnki.net

1.5 研究框架

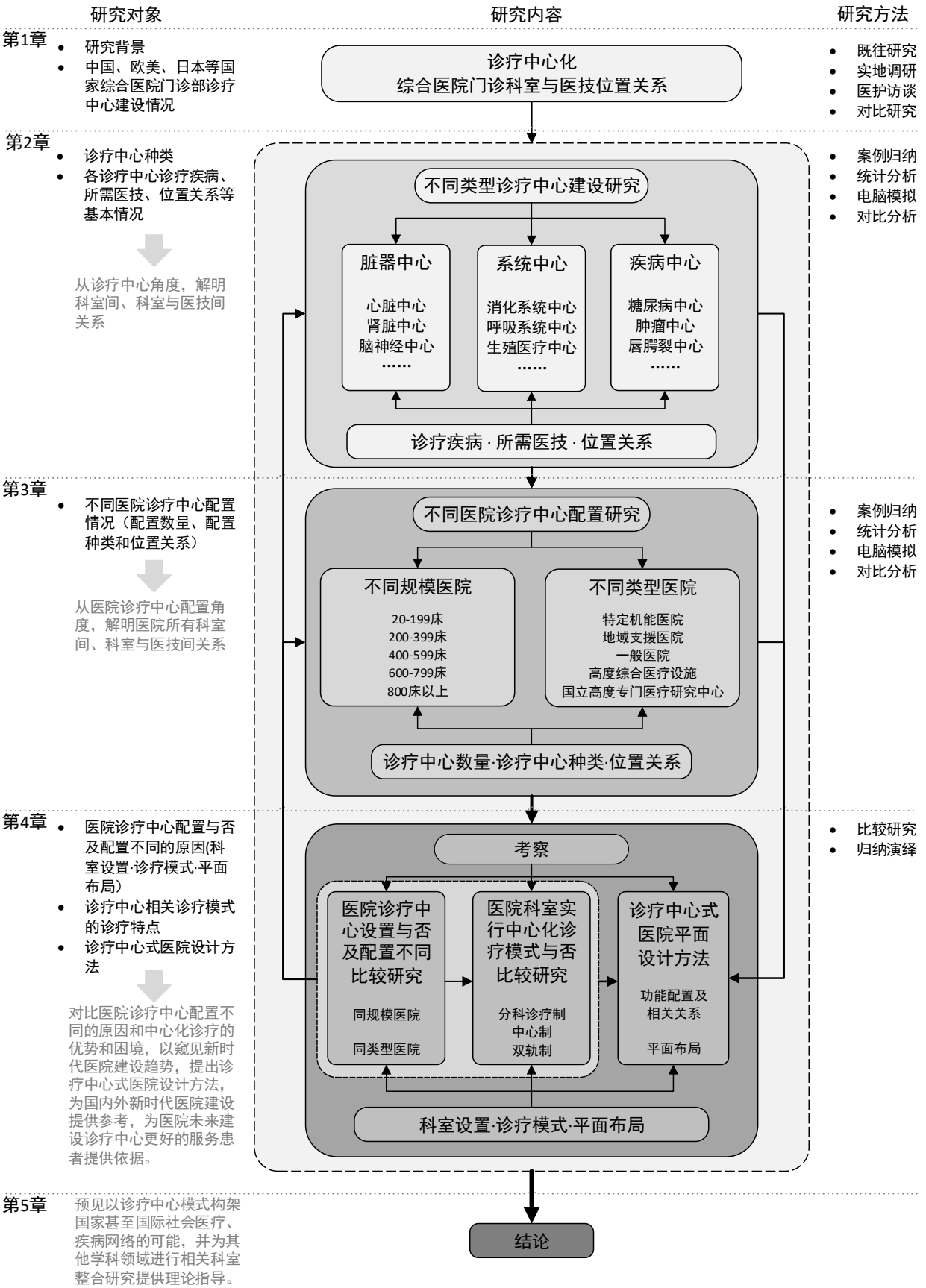


图 1-13 论文研究框架
图片来源：作者自绘

中国知网 https://www.cnki.net

第 2 章 不同类型诊疗中心建设研究

2.1 诊疗中心的分类

鉴于各国诊疗中心建设仍处于探索期，欧美国家“诊疗中心”与我国现阶段综合医院的建设模式不同，本章主要针对日本综合医院设置的诊疗中心进行相关研究，包括对各诊疗中心的基本情况、诊疗中心的构成科室和相关科室及医技情况，以及诊疗中心的平面位置布局情况进行相关分析，以解明各医院在建设相关诊疗中心时应考虑的科室及医技的相关关系，从而方便患者就医，提高医疗效率。

以日语“病院”、“センター”和“診療センター”等关键词，在 Google 上进行搜索，检索出相关日本配置有诊疗中心的医院 294 所，相关案例基本情况，详见附录 B。

但在分别对这 294 所设有诊疗中心的医院的官网上列出的诊疗中心的种类和数量进行统计时，发现各医院对诊疗中心的检索类别的分类存在差异，如有的医院将诊疗中心与科室放在一起检索；有的医院将诊疗中心与科室分开检索等等，见表 2.1。而相较于较为方便患者检索的传统的内外科检索方式和便于患者找寻科室的按身体发病部分区分的科室分类方式（见表 2.2），诊疗中心的检索方式显得较为混乱。

表 2.1 日本医院诊疗中心检索分类方式表

检索分类	案例
1：诊疗中心与诊疗科一起检索	医疗诊疗部 心脏病中心 心内科 心血管外科 周产期母子中心 新生儿病区 儿科 妇产科 呼吸系统中心 呼吸外科 肿瘤内科・呼吸内科 综合急救中心 急救部 中央放射线中心 放射线诊断科 放射线治疗科 内分泌・代谢科 脑神经内科・认知症中心 消化内科 精神科 外科 乳腺中心 骨科 整形外科 脑卒中中心 脑神外科 皮肤科 泌尿科 眼科 耳鼻喉・头颈部外科 康复科 麻醉科 病理诊断科 姑息治疗科 ベルランド総合病院

中国知网 https://www.cnki.net

2:诊疗科与诊疗中心检索分开

诊疗科 中心

部门	担任表	部门 HP	部门	担任表	部门 HP
血液内科	○	○	精神科	○	○
心理科	○	○	儿科	○	○
乳腺・内分泌外科	○	○	小儿外科	○	○
骨科	○	○	整形外科	○	○
皮肤科	○	○	妇产科	○	○
眼科	○	○	耳鼻喉科	○	○
放射线肿瘤科	○	○	影像诊断・核医学科	○	○
麻醉科・疼痛门诊	○	○	口腔科	○	○
综合诊疗科	○	○	康复科	○	○
病理诊断科		○	化疗・姑息治疗科	○	○
风湿科		○	睡眠科	○	○
黄斑疾病综合护理单元					

诊疗科 中心

部门	担任表	部门 HP	部门	担任表	部门 HP
心脏病中心					
心内科	○	○	心血管外科	○	○
小儿心脏科	○	○			
消化系统中心					
消化内科	○	○	消化・一般外科	○	○
消化内视镜科		○			
脑神经中心					
神经内科	○	○	脑神经外科	○	○
肾脏病综合诊疗中心					
肾内科	○	○	肾外科	○	○
泌尿科	○	○	血液净化疗法科	○	○
小儿肾脏科	○	○			
糖尿病中心					
糖尿病・代谢内科	○	○	糖尿病眼科	○	○
内分泌疾病综合医疗中心					
高血压・内分泌内科	○	○	乳腺・内分泌外科	○	○
母子综合医疗中心					
产科・母子中心	○	○	新生儿科		○
呼吸中心					
呼吸内科	○	○	呼吸外科	○	○
儿童综合医疗中心			急救中心	○	○
前列腺肿瘤中心		○	女性排尿障碍中心		○
炎症性肠疾病中心			遗传医疗门诊	○	○

東京女子医科大学病院

3:既与诊疗科合并检索，又有单独诊疗中心检索

内科系诊疗科

- 普内科
- 血液内科
- 内分泌代谢科(糖尿病・代谢部门)
- 内分泌代谢科（内分泌部门）
- 呼吸系统中心内科
- 睡眠呼吸科
- 消化内科（胃肠）
- 消化内科（肝・胆・胰腺）
- 肝脏内科
- 神经内科
- 心脏中心内科
- 肾中心内科
- 风湿胶原病科
- 临床肿瘤科
- 姑息医疗科
- 临床感染科
- 精神科
- 认知症科
- 高龄者综合诊疗部

外科系诊疗科

- 心脏中心外科
- 肾中心外科
- 呼吸系统中心外科
- 消化外科（上消化道）
- 消化外科（肝・胆・胰腺）
- 消化外科（下消化道）
- 乳腺・内分泌外科
- 脑神经外科
- 脑神经血管内治疗科
- 间脑下垂体外科
- 急救科

其他诊疗科

- 儿科
- 皮肤科
- 放射科
- 骨科
- 整形外科
- 妇产科
- 泌尿科
- 眼科
- 耳鼻喉科
- 麻醉科
- 口腔科
- 重症监护科
- 放射科
- 病理诊断科

中心

- 内分泌中心（内分泌代谢科・儿科・乳腺・内分泌外科・间脑下垂体外科）
- 听觉中心（耳鼻喉科）
- 脑卒中中心（神经内科・脑神经血管内治疗科・脑神经外科）
- 健康管理中心、影像诊断中心

虎の門病院

中国知网 https://www.cnki.net

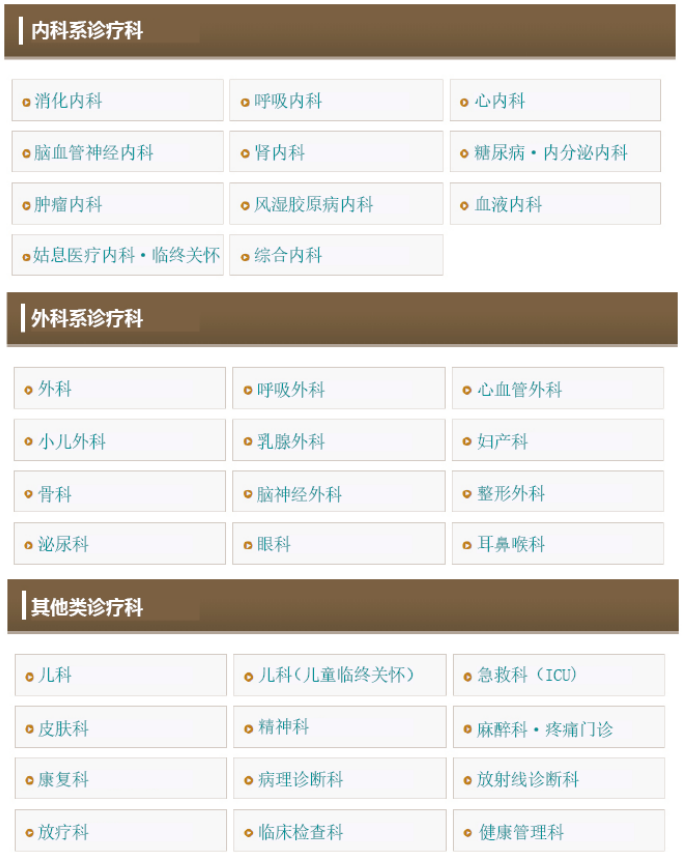
科室分类检索方式	案例
4：诊疗中心列为中央诊疗设施或其他	 慶應義塾大学病院
1：全部罗列检索	 熊本赤十字病院

注：表格图片来源于各医院官网，并由作者翻译

表 2.2 日本医院科室分类检索方式表

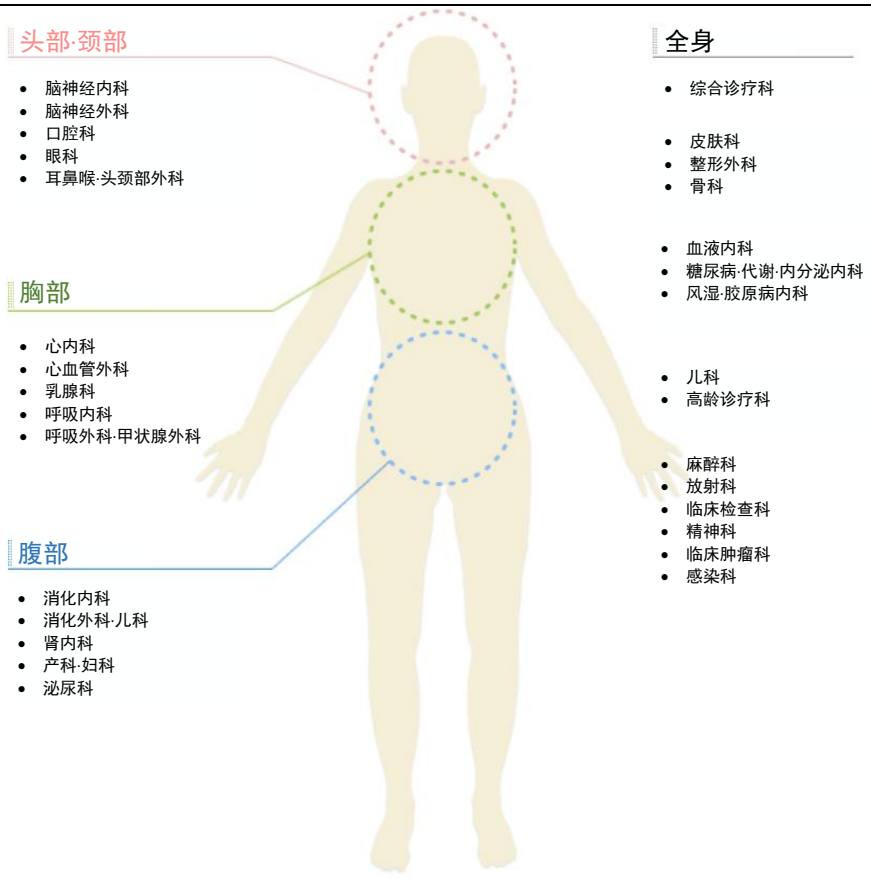
中国知网 https://www.cnki.net

2. 内外科分类检索



淀川キリスト教病院

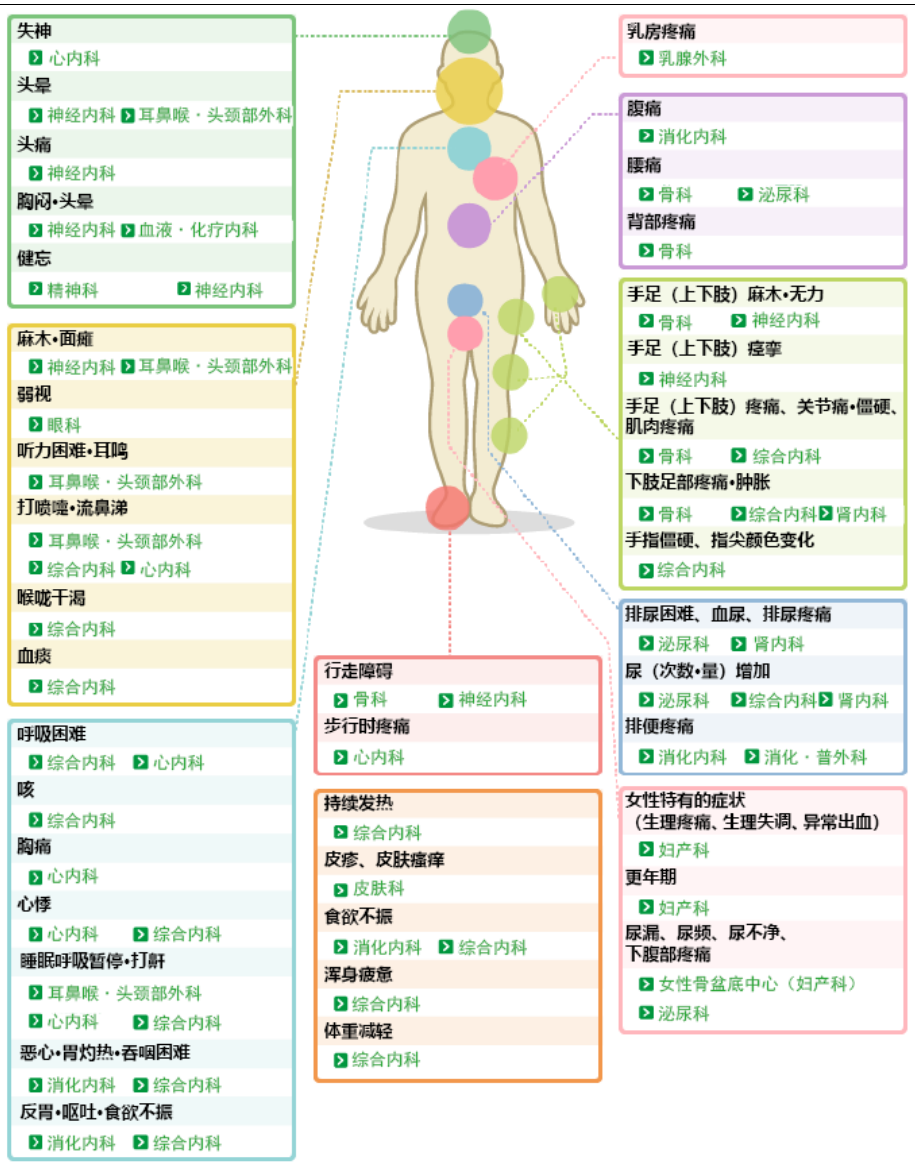
3. 身体发病部位分类检索



東京医科大学病院

中国知网 https://www.cnki.net

東京医科大学八王子医療センター



日生病院

注：表格图片来源于各医院官网，并由作者翻译

因此，鉴于日本各医院诊疗中心检索分类不成熟和诊疗中心以诊疗某类疾病为特征的诊

中国知网 https://www.cnki.net

疗方式，为便于文章的研究分析，本文以按身体发病部位区分科室的分类方式，对研究案例的诊疗中心进行种类和数量进行统计归纳，见图 2-1。其中不同类型诊疗中心用不同颜色字体表示；不同数量诊疗中心用不同字体大小表示，字体越大，表示该类诊疗中心的设置数量越多。

图 2-1 日本医院诊疗中心数量与种类分布图

图片来源：作者自绘

并根据不同类型诊疗中心与身体发病部位的相关关系以及诊疗中心的诊疗特点，选取数量较多或有代表性的诊疗中心[1]进行初步分类，分为脏器中心、系统中心和疾病中心，分类依据和代表中心类型，见表 2.3。

其中脏器中心主要诊疗某类脏器器官疾病，如心脏中心、肾脏中心和脑神经中心等；系统中心主要诊疗系统性疾病，如消化系统中心、呼吸系统中心和运动系统中心等；疾病中心主要诊疗某类特定疾病，如糖尿病中心、肿瘤中心和高血压中心等。

[1] 本文研究的诊疗中心主要为门诊诊疗中心，不包含以下几类医院设置的“诊疗中心”：1.以检查为主的医技中心 2.较为独立完善的急救中心 3.健康体检相关中心 3.以研究为主的临床研究类中心 4.少于两个设置的疑难杂症中心 5.一些以咨询为主的中心。具体研究中心类别见附表 C。

中国知网 https://www.cnki.net

值得注意的是，世界范围内并没有公认的诊疗中心的分类方式，各医院诊疗中心的建设也根据各自医院的特色处于探索阶段，本文诊疗中心的分类也仅为笔者根据各诊疗中心的诊疗特征和科室特征，为便于展开研究而进行的初步分类，尚不成熟，随着世界范围内各界对诊疗中心研究的深入，此种分类方式仍会有所改进和优化。

表 2.3 诊疗中心分类依据表

诊疗中心分类	分类依据	代表中心	主要构成科室
脏器中心	主要诊疗特定脏器器官类疾病	心脏（心血管）中心	心内科、心血管外科
		肾脏中心	肾内科、泌尿科
		脑神经中心	神经内科、脑神经外科
		眼科中心	眼科
		耳鼻喉科相关中心	耳鼻喉科
		口腔中心	口腔科
		乳腺中心	乳腺·内分泌外科
系统中心	主要诊疗特定身体系统类疾病	消化系统中心	消化内科、消化外科
		呼吸系统中心	呼吸内科、呼吸外科
		内分泌中心	内分泌内科、乳腺·内分泌外科
		睡眠中心	耳鼻喉科、呼吸内科、精神科等
		心·脑血管中心	心内科、心血管外科、神经内科、脑神经外科等
		慢性创伤中心	整形外科、心内科、骨科等
		脊椎脊髓中心	骨科、脑神经外科等
		骨科中心	骨科
		整形中心	整形外科
		女性骨盆底中心	妇科、泌尿科、消化外科等
		生殖医疗中心	妇科、泌尿科等
		周产期母子医疗中心	产科、新生儿科
		女性诊疗中心	妇科、产科、乳腺·内分泌外科
		儿童医疗中心	儿科、小儿外科
疾病中心	主要诊疗特定疾病	糖尿病中心	糖尿病·代谢内科
		过敏中心	儿科、皮肤科、耳鼻喉科等
		风湿·胶原病中心	风湿·胶原病内科
		皮肤病中心	皮肤科
		血液病中心	血液内科
		精神卫生中心	精神科、心理科
		疼痛中心	麻醉科
		肿瘤中心	肿瘤内科、发病部位科室、放射科等
		认知症医疗中心	神经内科、精神科、老年科等
		高血压中心	呼吸内科、心内科、泌尿科等
		唇腭裂中心	整形外科、儿科、口腔科等
		脑卒中中心	神经内科、脑神经外科
		癫痫中心	神经内科、脑神经外科、精神科、儿科等

注：表格自制

2.2 脏器中心

通过对研究医院所设置的各类诊疗中心进行统计归纳和对各诊疗中心诊疗内容和特性的区分，将心脏中心、肾脏中心、脑神经中心、眼科中心、耳鼻喉科中心、口腔中心、和乳腺中心归为一类，统称为脏器中心，这类中心主要诊疗特定脏器器官类疾病。本节将主要解明各类脏器中心主要诊疗内容、科室组成、关联科室、涉及医技部门和布局特征，以为国内建设相关诊疗中心，邻近布局相关科室和医技提供参考。

中国知网 https://www.cnki.net

2.2.1 心脏（心血管）中心

1）基本情况

心脏疾病相关中心主要诊疗包括心脏病、心律失常和血管病等在内的心脏相关疾病。在所研究医院中，诊疗心脏疾病相关中心共 176 个，包括心脏（心血管）中心、主动脉中心和心血管·主动脉中心等，如图 2-2，其中大致以心脏（心血管）中心命名的中心 125 个，占研究心脏疾病相关中心的一半以上。为便于研究分析，将与诊疗心脏疾病相关中心，统称为心脏（心血管）中心。

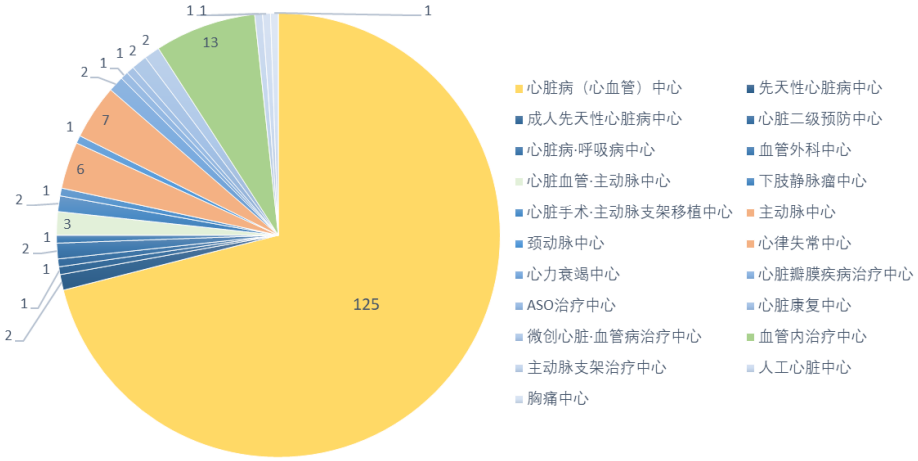


图 2-2 心脏疾病相关中心名称数量统计图
图片来源：作者自绘

综合考虑各医院心脏（心血管）中心的科室配置、诊疗特点和平面布局特征，选取东京女子医科大学医院、久留米大学医院和关西医科大学附属医院等在内的 10 所医院心脏（心血管）中心进行诊疗基本疾病、科室配置、关联科室、诊疗涉及医技等分析，基本情况统计如表 2.4。

表 2.4 各医院心脏（心血管）中心基本情况一览

医院名称	诊疗中心名称	包含科室	关联科室或诊疗中心	诊疗疾病	诊断	治疗
東京女子医科大学病院	心脏病中心	心内科 心外科 儿童心脏科	麻醉科（母子医疗中心、精神科、放射科、儿科）[1)]	· 缺血性心脏病 · 心律失常 · 心力衰竭 · 瓣膜症等大血管疾病 · 先天性心脏病 · 高血压等	心导管检查、心脏超声、心电图、心脏 CT、MRI 等	手术等
仙台厚生病院	心脏血管中心	心内科 心血管外科（主动脉治疗中心、闭塞性动脉硬化治疗中心）		· 缺血性心脏病 · 急性心肌梗塞 · 瓣膜症 · 主动脉、末梢血管、静脉疾病	血管造影、冠动脉 CT、超声检查、ABI 检查	手术等
総合病院回生病院	心脏·血管中心	心内科	急救中心	· 心肌梗塞 · 瓣膜症 · 主动脉瘤 · 闭塞性动脉硬化 · 肾血管性高血压 · 心肌病 · 心里失常 · 心脏康复	血管造影、心脏 CT、超声、心电图	手术等

中国知网 https://www.cnki.net

久留米大学病院	心脏病中心	心内科 心外科 血管外科 环境医学科 儿童心脏科		· 心脏、大血管疾病 · 生活习惯病 · 缺血性心脏病 · 心力衰竭 · 心律失常 · 心脏瓣膜症 · 高血压、高血脂、糖尿病、肺高血压等	CT、运动负荷检查、心肌显像、心电图、血压、心脏超声等	手术等
大濱第一病院	心脏血管中心	心内科 心律失常诊疗科 心血管外科	急救中心	· 急性心肌梗塞 · 心律失常 · 血管疾病 · 瓣膜症 · 先天性心脏病 · 下肢静脉瘤等	血管造影、心脏超声、心电图等	急救医疗
関西医科大学附属病院	心脏中心	心内科 心血管外科	康复科 内分泌代谢科 肾内科 儿科	· 急性心肌梗塞 · 急性心力衰竭 · 心脏病 · 血管病 · 心律失常	心电图、心脏超声、血管超声、血管造影、冠动脉 CT	手术等
立川総合病院	心脏・脑血管中心	心内科 心血管外科 脑神经外科 神经内科 心血管放射科 内分泌内科 肾内科		· 心脏、脑疾病，全身血管疾病及糖尿病血管并发症	心电图、心脏超声、检验科、急救科、放射科等	手术等
湘南藤沢徳洲会病院	心脏病中心	心内科 心血管外科	麻醉科 急救部 手术室 ICU	· 心肌梗塞 · 缺血性心脏病 · 心律失常 · 瓣膜症 · 主动脉疾病 · 高血压等	心电图、心脏超声	手术等
岩手医科大学附属病院	心脏医疗中心	心内科 心血管外科 儿童心脏科 心脏放射科 心脏麻醉科		· 心脏病 · 血管病 · 心律失常 · 心肌病 · 肺高血压等	心电图、超声、核磁共振、CT、心导管检查等	手术等
倉敷中央病院	心脏病中心	心内科 心血管外科	（糖尿病内科、皮肤科、整形外科）[2)]	· 缺血性心脏病 · 心律失常 · 心力衰竭 · 心肌症 · 先天性心脏病等	心电图、超声、心脏 CT、ABI、血管造影、MRI、血液检查等	手术等

注：1）小儿心脏科，主要诊疗胎儿心律失常等疾病，需要配合母子医疗中心诊疗，较常与心血管外科、儿科、精神科和放射科合作诊疗。
2）闭塞性动脉硬化往往需要心内科、心血管外科、糖尿病内科、皮肤科、整形外科合作诊疗。
表格自制

2）涉及科室和医技

心脏（心血管）中心主要由心内科和心血管外科构成，主要涉及医技检查为心电图检查、心脏超声检查，部分疾病涉及放射科检查和检验检查。当诊疗某些特殊疾病时，心脏（心血管）中心需要与其他科室合作诊疗，如与儿科合作诊疗儿童心脏疾病；与糖尿病内科合作诊疗糖尿病合并心血管疾病；与脑神经外科和神经内科等联合成立心・脑血管中心，诊疗全身血管疾病；等等，见图 2-3。

中国知网 https://www.cnki.net

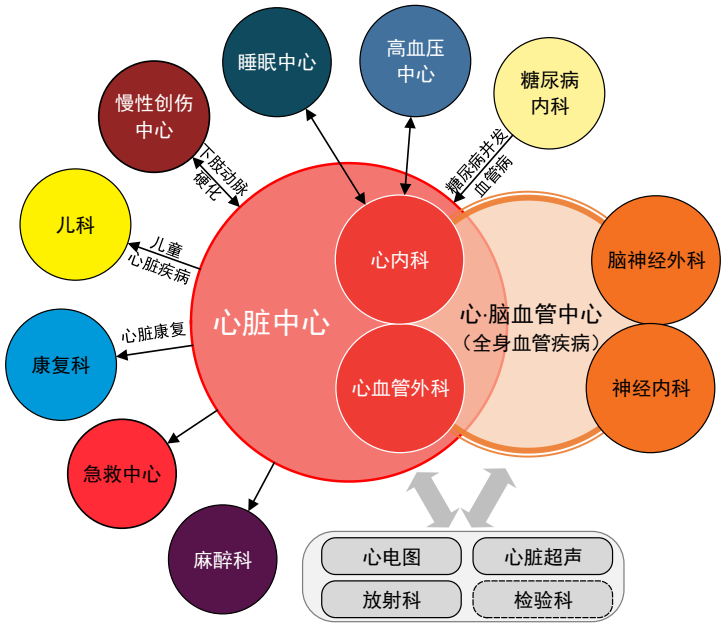
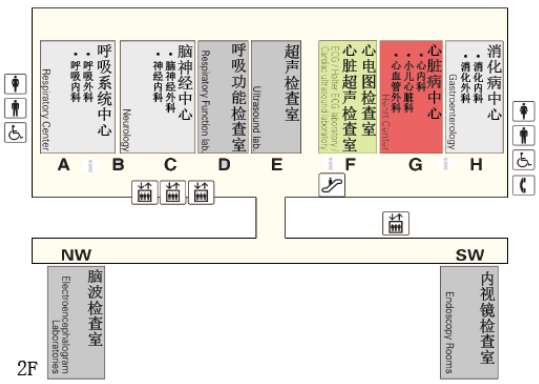
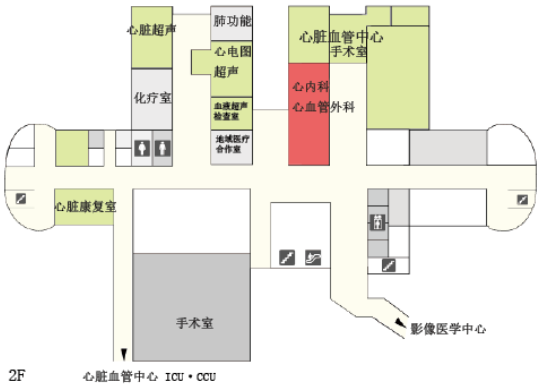


图 2-3 心脏（心血管）中心主要组成科室、关联科室和涉及医技部门关系图
图片来源：作者自绘

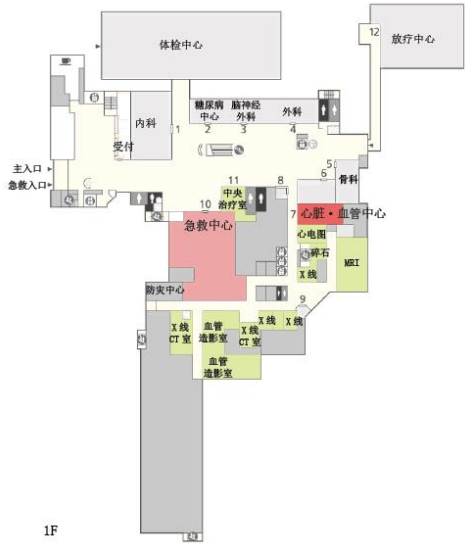
3）位置关系研究

心脏（心血管）中心较常邻近相关医技检查室布局，或将主要检查设置在中心内，如久留米大学医院心脏（心血管）中心的布局。为便于多疾病患者的诊疗和紧急心梗塞等患者的救助，部分医院会考虑将心脏（心血管）中心与其他相关科室或中心邻近布局，如大滨第一医院心脏血管中心邻近急救中心设置。为便于门诊住院一体化管理，可将心脏（心血管）中心与住院区邻近设置，如湘南藤沢德洲会医院心脏（心血管）中心布局。除此之外，部分医院考虑到本医院心脏疾病患者较多，采用独栋布局方式，以更方便患者诊疗。选取案例各医院具体平面布局见表 2.5。

表 2. 5 心脏（心血管）中心平面布局特征

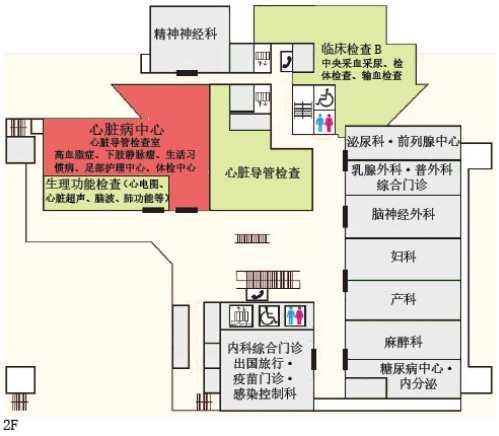
布局	案例	
1. 与相关检查室相邻		
	東京女子医科大学病院	仙台厚生病院

中国知网 https://www.cnki.net



総合病院 回生病院

2. 内设相关检查室



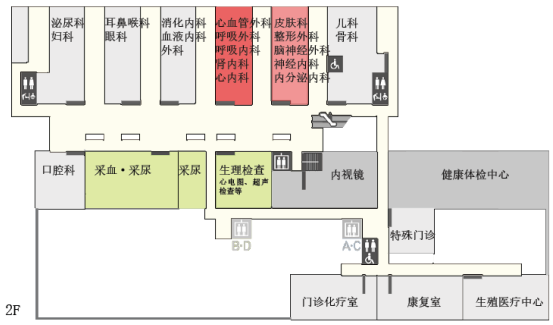
久留米大学病院

3. 邻近相关科室或诊疗中心

大濱第一病院

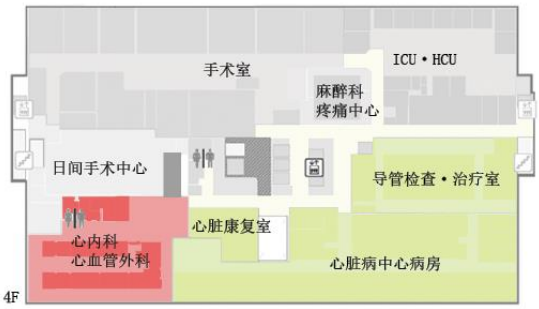
関西医科大学附属病院

中国知网 https://www.cnki.net



立川総合病院

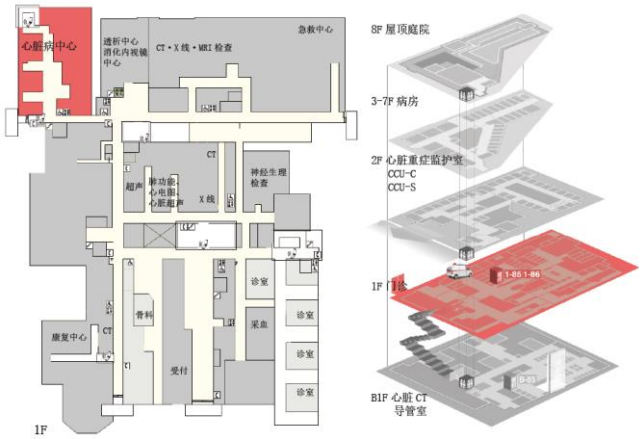
4. 与病房邻近布置



湘南藤沢德洲会病院

5. 独栋布置

岩手医科大学附属病院



倉敷中央病院

注：图表自制

2.2.2 肾脏中心

1）基本情况

肾脏疾病相关中心主要诊疗肾脏相关疾病，如慢性肾病等。在所研究医院中，设置诊疗肾脏疾病相关的诊疗中心共 157 个，包括肾脏中心、肾泌尿科中心和人工透析中心等，如图 2-4，其中以肾脏中心命名的中心数量较多，为便于研究分析，将与诊疗肾脏疾病相关中心，统称为肾脏中心。

中国知网 https://www.cnki.net

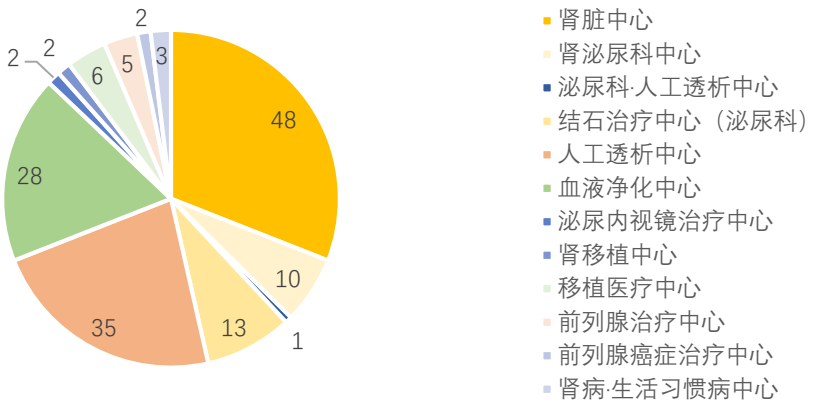


图 2-4 肾脏疾病相关中心名称数量统计图
图片来源：作者自绘

综合考虑各医院设置肾脏中心的科室配置、诊疗特点和平面布局特征，选取户田中央综合医院、爱知医科大学医院和熊本赤十字医院等在内的 8 所医院肾脏中心进行相关分析，基本情况见表 2.6。

表 2.6 各医院肾脏中心基本情况一览

医院名称	诊疗中心名称	包含科室	关联科室或诊疗中心	诊疗疾病	诊断	治疗
户田中央総合病院	肾脏中心	肾内科 泌尿科 移植外科		・ 肾内科（慢性肾脏病、急性肾障碍、慢性肾炎、肾病综合征、生活习惯病引起的肾病） ・ 泌尿科・移植外科（尿路结石、泌尿系统肿瘤、前列腺疾病等）	肾活检、检体检查、超声检查	透析等
愛知医科大学病院	综合肾病中心	肾・胶原病内科 透析中心 肾移植外科（儿童肾脏医生、泌尿医生）		・ 慢性肾病（CKD） ・ 肾炎 ・ 肾病综合征 ・ 糖尿病肾病 ・ 肾功能衰竭 ・ 风湿・胶原病（系统性红斑狼疮、类风湿性关节炎等）	尿检、肾活检	血液透析、腹膜透析、血浆交换、活体肾移植
熊本赤十字病院	肾脏中心	中毒中心	急救部 外科 儿科	・ 肾炎 ・ 肾衰竭透析治疗	尿液、肾活检、肾病教室	血液透析、腹膜透析、肾移植
東京女子医科大学病院	肾病综合医疗中心	肾内科 肾外科 泌尿科 血液净化疗法科 儿童肾脏科	前列腺肿瘤中心 女性排尿障碍中心	・ 肾内科（肾炎、肾病综合征、肾功能不全、胶原病和高血压等） ・ 肾外科（肾脏・肝脏・胰腺移植、外科手术等） ・ 泌尿科（尿路感染、尿路结石、前列腺肥大、泌尿系统肿瘤、性功能障碍等） ・ 儿童肾脏科（先天性肾病、尿路疾病等）	血液、尿液检查、肾活检、（超声・CT・MRI）	透析等
関西医科大学附属病院	肾脏中心	肾内科 肾泌尿外科	糖尿病内科 生殖医疗中心	・ 慢性肾病（CKD） ・ 预防肾衰竭患者透析 ・ 肾移植	尿检	透析、肾移植

中国知网 https://www.cnki.net

			癌症中心	· 保护泌尿系统癌症患者肾功能 · 糖尿病肾病预防和管理 · 肾泌尿外科（泌尿系统·生殖系统肿瘤、性功能障碍、尿频、肾移植、尿路结石等）		
日立総合病院	肾脏病·生活习惯病中心	内科·生活习惯病 肾内科 代谢内分泌内科 透析门诊		· 高血压 · 糖尿病、内分泌疾病 · 肾病综合征 · 糖尿病肾病、胶原病肾病、生活习惯病肾病 · 慢性肾衰竭、急性肾栓接、急性肾炎	肾活检等	透析
NTT 東日本関東病院	前列腺中心	泌尿科		· 前列腺疾病（前列腺增生、前列腺癌）	血液检查、尿检 影像检查：超声检查、CT、MRI、骨成像（RI） 前列腺活检	药物治疗、手术治疗和放疗
千葉西総合病院	结石治疗中心	泌尿科		· 肾·尿管结石 · 膀胱尿路结石	尿检、血液检查、腹部 X 线、CT、腹部超声	破碎治疗

注：表格自制

2）涉及科室和医技

肾脏中心主要构成科室为肾内科和泌尿科，主要涉及医技检查为尿液检查和病理相关检查，少部分疾病诊断还会涉及超声检查和放射线检查。主要涉及治疗部门为血液净化部即透析部。由于肾内科和泌尿科各自诊疗疾病范围有所不同，所以当诊疗某类特定疾病时，需要其分别与相对应科室合作，如在诊疗生活习惯病时，需肾内科与糖尿病内科合作诊疗；诊疗不孕不育时，则需泌尿科与妇产科合作诊疗。除此之外，泌尿科可下设相关治疗中心，如前列腺中心和结石中心等。见图 2-5。

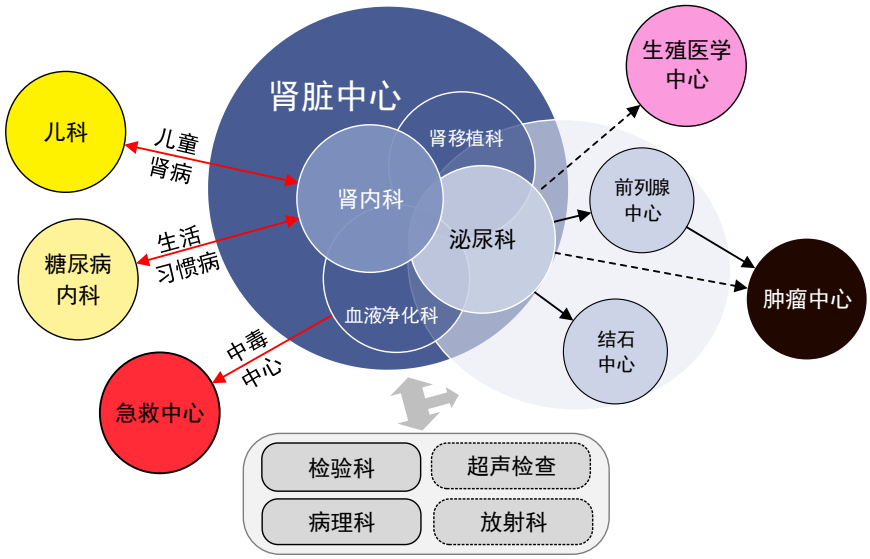


图 2-5 肾脏中心主要组成科室、关联科室和涉及医技部门关系图
图片来源：作者自绘

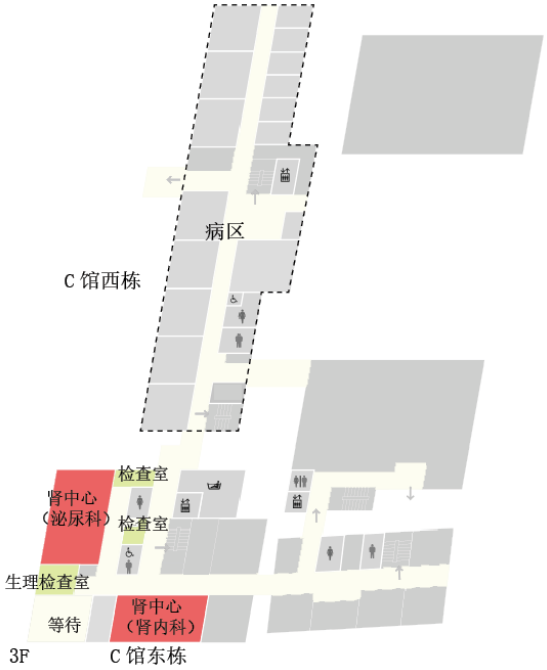
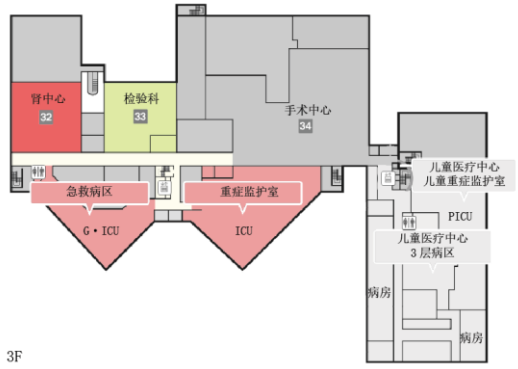
3）位置关系研究

除了整合肾内科和泌尿科外，一般肾脏中心常与透析中心合并设置，如爱知医科大学医院肾脏中心的布局；为方便多疾病患者诊疗，可采用将肾脏中心邻近相关科室或中心的布局

中国知网 https://www.cnki.net

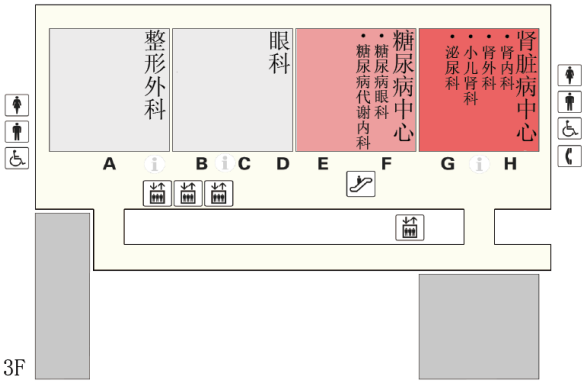
方式，如东京女子医科大学将肾病中心邻近糖尿病中心布局；为便于患者门诊——住院一体化诊疗，也可将肾病中心与住院区邻近布局，详见户田中央综合病院肾脏中心布局；就泌尿科而言，其则可在科室内设置相应治疗中心。肾脏中心具体平面布局特征见表 2.7。

表 2.7 肾脏中心平面布局特征

布局	案例
1. 内设相关检查室	 户田中央総合病院
2. 邻近透析中心	 爱知医科大学病院（综合肾病中心）
3. 与相关检查室邻近	 熊本赤十字病院

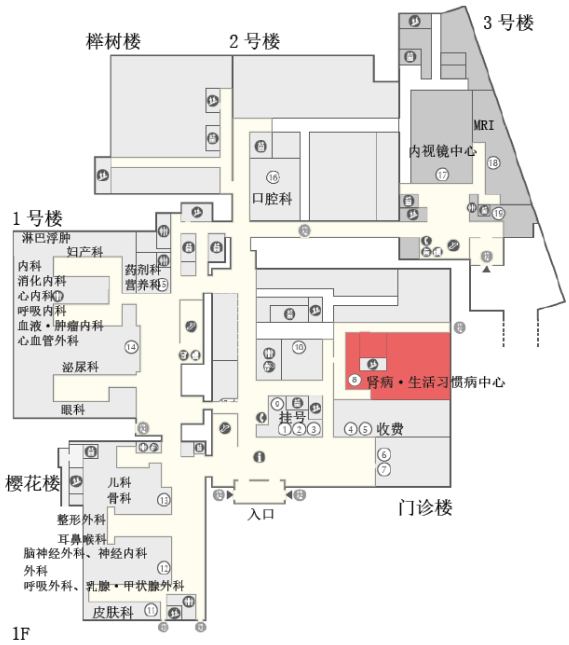
中国知网 https://www.cnki.net

4. 邻近相关科室或诊疗中心



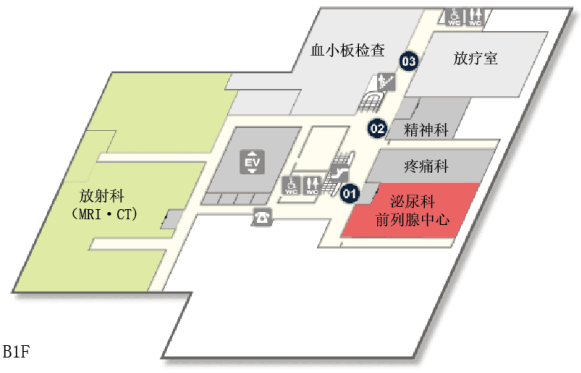
東京女子医科大学病院

関西医科大学附属病院

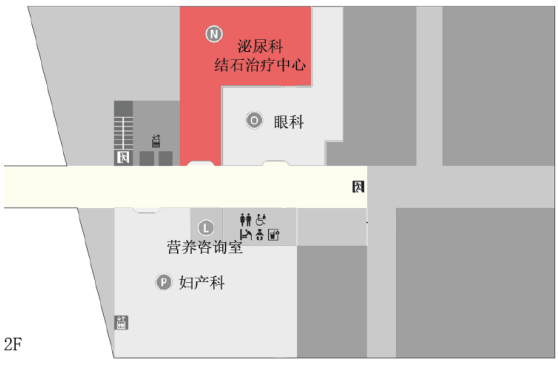


日立総合病院

5. 内设治疗中心



NTT 東日本関東病院



千葉西総合病院

注：图表自制

中国知网 https://www.cnki.net

2.2.3 脑神经中心

1）基本情况

脑神经疾病相关中心主要诊疗脑神经相关疾病，如脑卒中、头痛等。在所研究医院中，设置诊疗脑神经疾病相关中心共 68 个，包括脑神经中心、脑血管内治疗中心、头颈部肿瘤中心等，如图 2-6。其中以脑神经中心命名的中心 32 个，占所研究脑神经相关中心的一半左右。为便于研究分析，现将与诊疗脑神经疾病相关中心，统称为脑神经中心。

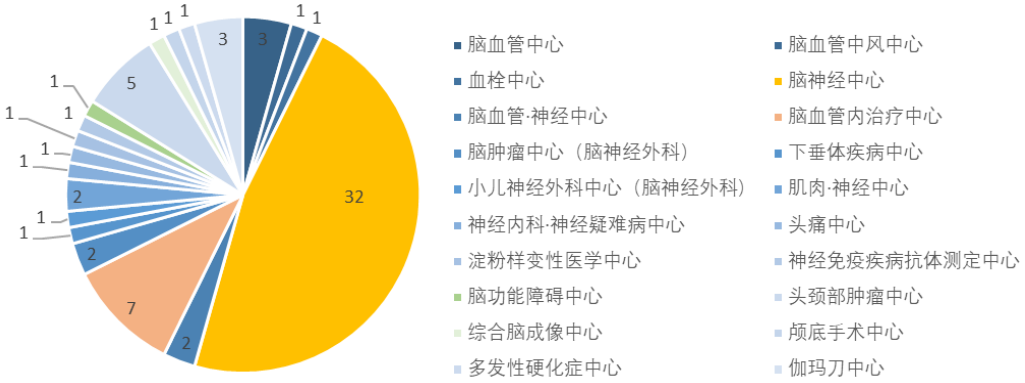


图 2-6 脑神经疾病相关中心名称数量统计图
图片来源：作者自绘

综合考虑各医院设置脑神经中心的科室配置、诊疗特点和平面布局特征，选取润和会纪念医院、竹田综合医院和川崎医科大学附属医院等在内的 6 所医院脑神经疾病相关中心进行相关研究分析，基本情况统计见表 2.8。

表 2.8 各医院脑神经中心基本情况一览

医院名称	诊疗中心名称	包含科室	关联科室或诊疗中心	诊疗疾病	诊断	治疗
潤和会記念病院	脑神经中心	脑神经外科 神经内科 康复科		· 脑神经外科：脑血管障碍、脊髓脊椎疾病、头部外伤、脊髓肿瘤等 · 神经内科：髓膜炎、脑炎、脊髓炎等炎症性疾病、脑梗塞、脑出血等脑血管疾病、睡眠呼吸暂停等	脑磁气计 MEG、经头颌磁刺激、影像诊断 MRI、CT、肌电图、脑波等	手术等
竹田綜合病院	脑神经疾病中心	脑神经外科 神经内科	骨科 放射科 康复科	· 脑神经疾病、脑·脊髓·末梢神经相关疾病 · 头痛、面部疼痛、颈部疼痛、头晕、头昏、运动障碍等 · 脑卒中	放射科（CT、MRI 等）、血液检查、胸部 X 线、心电图、超声、电生理检查、遗传检查、病理检查	药物治疗、手术治疗
大崎市民病院	脑神经中心	神经内科 脑神经外科	急救科 康复科	· 神经内科：脑膜炎、癫痫、帕金森等退行性疾病 · 脑神经外科：脑部外伤、脑出血、蛛网膜下腔出血、脑肿瘤等 · 脑卒中	MRI、CT、PET-CT、SPECT、脑波、肌电图、脑血管造影等	脑血管内治疗等
高槻病院	脑神经中心	脑神经外科 神经内科 眼科 [1)] 耳鼻喉科 [2)]	骨科 [3)]	· 脑神经外科：肿瘤性脑疾病、出血性脑疾病、闭塞性脑血管疾病、机能性脑外科疾病、外伤性脑血管	CT、MRI、脑血管造影、颈动脉超声、脑波、	手术等

中国知网 https://www.cnki.net

		精神科		疾病 · 神经内科：中枢神经、末梢升级、骨骼肌肉、脑血管疾病等	肌电图、心脏超声、血液检查等	
川崎医科大学附属病院	脑神经中心	神经内科 脑卒中科 脑神经外科	康复科 眼科 耳鼻喉科 骨科 心理科 心内科	· 神经内科：脑、脊髓、末梢神经相关疾病、认知症、帕金森、头痛、癫痫、脑炎等 · 脑卒中科：脑卒中、脑梗塞、脑内出血等 · 脑神经外科：脑肿瘤、脑血管障碍、脊髓疾病治疗等	CT、MRI、肌电图等神经电生理检查、超声、血管造影、脑波、遗传检查等	脑血管内治疗等
九州大学病院	脑中心	神经内科 精神科 心理科 耳鼻喉科 肾·高血压·脑血管内科		· 认知症、运动障碍、感觉障碍等疾病 · 脑卒中 · 神经性疑难杂症 · 神经退行性疾病（帕金森病、阿兹海默症等） · 免疫性神经疾病（多发性硬化症、重症肌无力等）	脑波、肌电图、脑电图检查、颈部血管超声、神经心理学检查等	药物等

注：1）由于视力障碍与眼科领域重叠，所以脑神经中心会选择与眼科合作诊疗眼睑下垂、眼球后神经炎等由脑神经和眼球运动相关疾病。
2）脑干、前庭·听神经障碍需到耳鼻喉科复查，吞咽障碍可能由神经系统引起的，也可能由于食管、咽喉异常引起。
3）腰痛、四肢麻木、瘫痪等疾病需要骨科和神经内科合作诊疗。
表格自制

2）涉及科室和医技

脑神经中心基本构成科室为神经内科和脑神经外科，主要涉及医技检查包括脑波检查、脑电图检查、脑磁图检查、肌电图检查和神经心理学检查等在内的脑部检查、放射科检查、检验科检查和遗传检查等。由于脑部疾病的诊疗往往是一场与时间的“游戏”，所以脑神经中心常与急救中心合作诊疗。当诊疗某些特殊疾病，脑神经中心需要与其他科室联合诊疗，如与骨科合作诊疗脊髓相关疾病；与眼科合作治疗眼神经疾病；与精神科合作治疗癫痫疾病……见图 2-7。

除此之外，构成脑神经中心的神经内科和脑神经外科也可以构成脑卒中中心，详见 2.2.4 节内容。

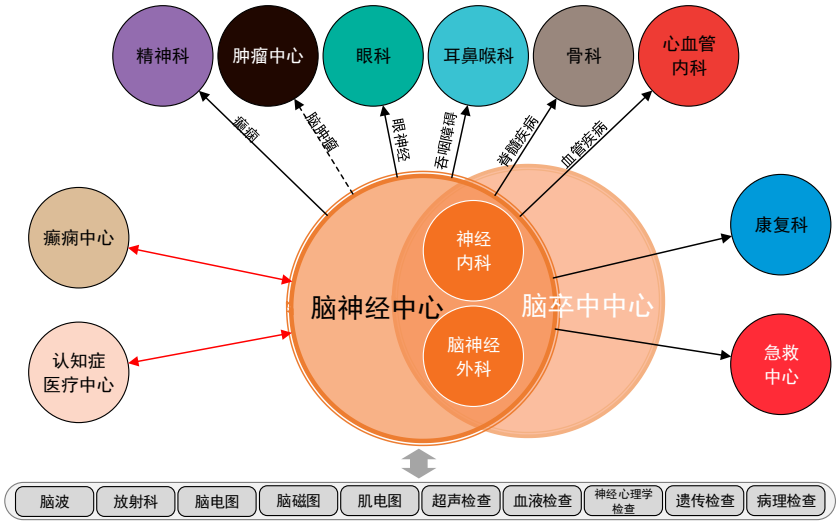


图 2-7 脑神经中心主要组成科室、关联科室和涉及医技部门关系图
图片来源：作者自绘

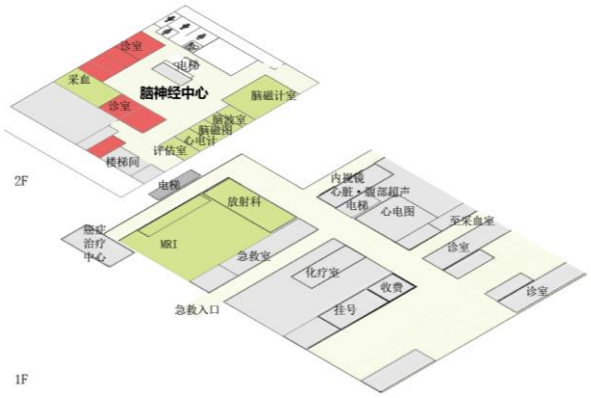
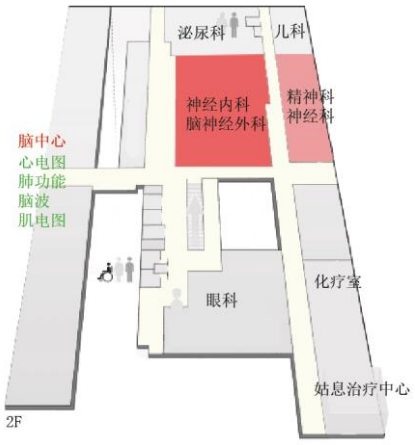
3）位置关系研究

由于脑神经疾病的诊断主要靠放射诊断，所以脑神经中心常邻近放射科布局，如竹田综合医院将脑神经中心邻近放射科布局；此外，为方便多疾病患者诊疗，脑神经中心还会与相关

中国知网 https://www.cnki.net

科室或中心邻近设置。见表 2.9。

表 2. 9 脑神经中心平面布局特征

布局	案例
1. 内设相关检查室	 潤和会記念病院
2. 与相关检查室相邻	 竹田綜合病院 大崎市民病院
3. 邻近相关科室或诊疗中心	 高槻病院 川崎医科大学附属病院  九州大学病院

注：图表自制

中国知网 https://www.cnki.net

2.2.4 眼科中心

1）基本情况

眼科疾病相关中心主要诊疗眼部疾病，如青光眼、白内障等。在所研究医院中，设置诊疗眼部疾病相关中心共 16 个，包括眼科中心、视网膜玻璃体中心和角膜中心等，如图 2-8。其中以眼科疾病命名的中心数量较多，为便于研究分析，现将与诊疗眼部疾病相关中心，统称为眼科中心。

图 2-8 眼科疾病相关中心名称数量统计图
图片来源：作者自绘

综合考虑各医院眼科中心的科室配置、诊疗特点和平面布局特征，选取杏林大学医学部附属医院和日本大学医院等在内的 5 所医院眼科中心进行相关研究分析，基本情况统计见表 2.10。

表 2.10 各医院眼科中心基本情况一览

医院名称	诊疗中心名称	包含科室	关联科室或诊疗中心	诊疗疾病	诊断	治疗
杏林大学医学部付属病院	眼科中心	眼科	糖尿病内科（糖尿病视网膜病）	· 白内障 · 青光眼 · 角膜移植 · 视网膜剥落 · 糖尿病视网膜病 · 黄斑疾病 · 斜视、弱视、近视等	眼底层析摄影（OCT）、眼底照相、荧光眼底摄影、视力检查、超声检查等	手术治疗等
日本大学病院	眼科中心	眼科		· 视网膜、玻璃体疾病 · 高龄黄斑病 · 糖尿病视网膜病变	视力检查、视野检查、眼底检查、	手术视力等
真生会富山病院	眼科中心	眼科	糖尿病内科（糖尿病视网膜病）	· 白内障 · 青光眼 · 泪道 · 角膜 · 视网膜晶状体 · 弱视、近视 · 糖尿病视网膜病变 · 干眼症、老花眼、睡眠障碍等	视野检查、角膜形状测定、超声诊断、眼底摄影等	手术治疗等
堺市立総合医療センター	眼科中心	眼科	整形外科（眼睑下垂）	· 一般眼科疾病（白内障、青光眼、结膜炎、眼睑疾病等） · 角膜疾病（角膜感染、水疱性角膜症等） · 视网膜疾病（糖尿病视网膜疾病、高龄黄斑病等）	主观视力检查：视力检查、眼压检查、视力敏感度等 客观视觉检查：视网膜电图（ERG）、多局部视网膜电图（VERIS）、视觉诱发电位检查（VEP）眼底 OCT、角膜形状分析、眼底造影、超声检查等	手术治疗等
洛和会音羽病院	眼科中心	眼科		· 白内障 · 青光眼	视力检查、视敏感度测试、OCT、角膜形状分析	手术治疗等

中国知网 https://www.cnki.net

				· 视网膜剥落 · 晶状体出血 · 高龄黄斑病 · 糖尿病视网膜病 · 视网膜静脉闭塞	测试、眼压检查、眼底检查、超声检查、视网膜电图（ERG）、荧光眼底造影等	

注：表格自制

2）涉及科室和医技

眼科中心的主要构成科室为眼科，主要涉及检查为眼科内检查，包括视力检查、视野检查、眼底摄影等等。其往往会与糖尿病内科合作诊疗糖尿病视网膜病变等眼部疾病，与整形外科合作诊疗眼睑下垂等疾病，见图 2-9。

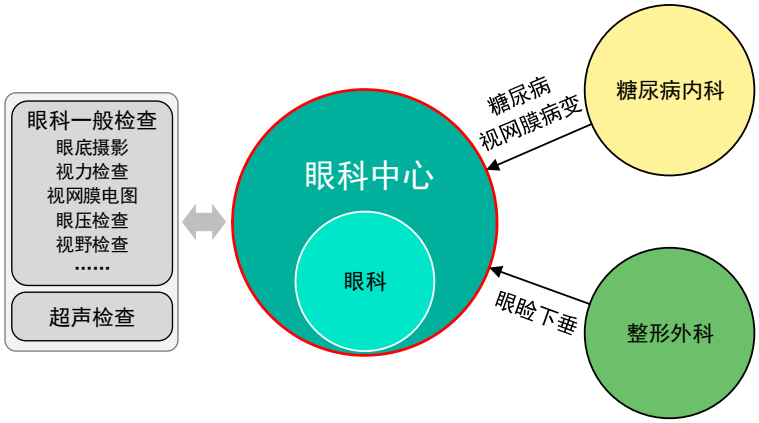
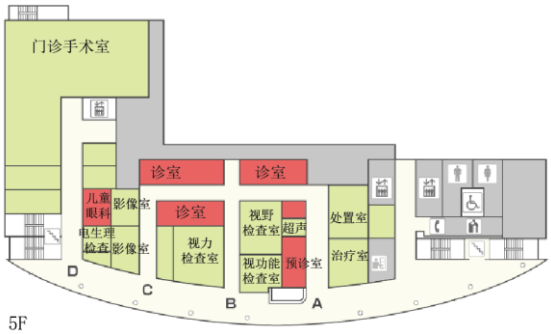


图 2-9 眼科中心主要组成科室、关联科室和涉及医技部门关系图
图片来源：作者自绘

3）位置关系研究

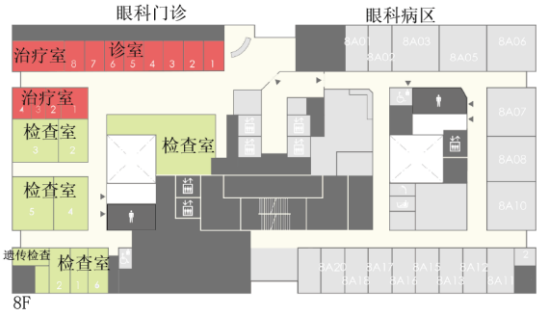
由于眼科中心与其他科室的关联度较弱，往往可独立成区布局、或独栋布局、或与住院区邻近布局。具体平面布局案例见表 2.11。

表 2. 11 眼科中心平面布局特征

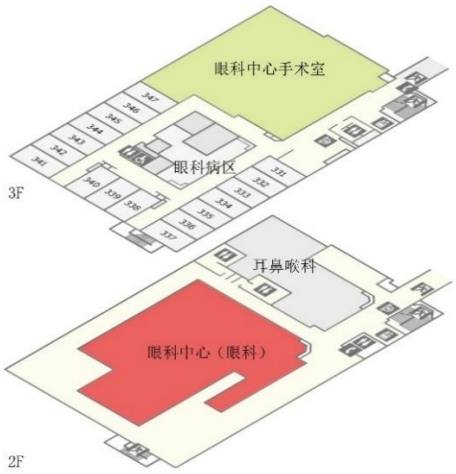
布局	案例
1. 内设主要检查室	 杏林大学医学部付属病院

中国知网 https://www.cnki.net

2. 与住院区邻近

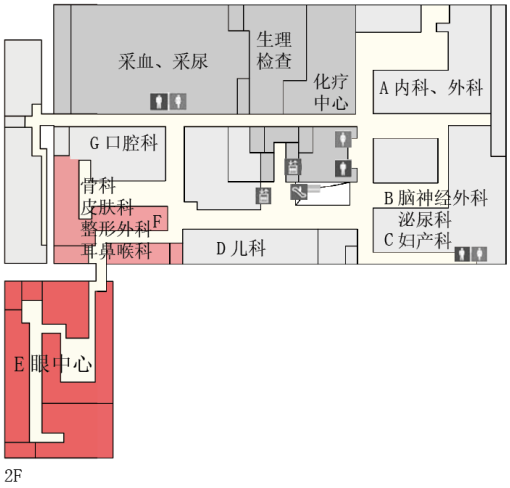


日本大学病院



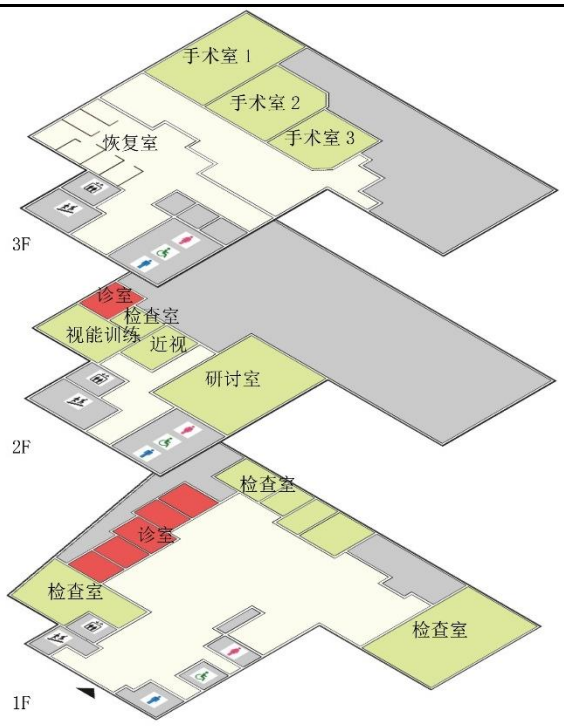
真生会富山病院

3. 邻近相关科室或诊疗中心



堺市立総合医療センター

4. 独栋布置



洛和会音羽病院

注：图表自制

中国知网 https://www.cnki.net

2.2.5 耳鼻喉科相关中心

1）基本情况

耳鼻喉科相关中心主要诊疗耳、鼻、咽喉和头颈部区域相关疾病。在所研究医院中，设置诊疗耳鼻喉相关疾病的中心共 17 个，包括听觉中心、人工内耳·人工听觉器中心和头晕中心等等，如图 2-10。由于这些中心主要是由耳鼻喉科构成，为方便分析统称为耳鼻喉科相关中心。

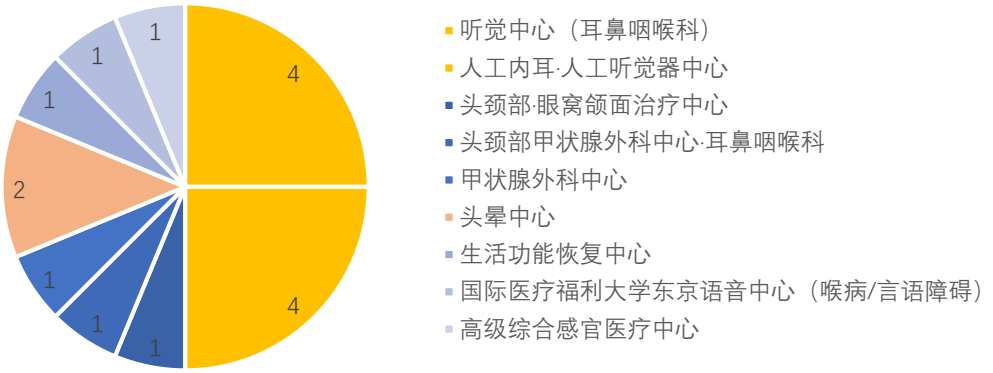


图 2-10 耳鼻喉科相关中心名称数量统计图
图片来源：作者自绘

综合考虑各医院设置耳鼻喉科相关中心的科室配置、诊疗特点和平面布局特征，选取虎的门医院、关西医科大学综合医疗中心和熊本大学医学部附属医院等在内的 8 所医院耳鼻喉科相关中心进行相关研究分析，基本情况统计见表 2.12。

表 2.12 各医院耳鼻喉科相关中心基本情况一览

医院名称	诊疗中心名称	包含科室	关联科室或诊疗中心	诊疗疾病	诊断	治疗
虎の門病院	听力中心遗传诊疗中心	耳鼻喉科		· 听力损失疾病（中耳炎、耳硬化症、突发性听力损失、感觉性听力损失） · 头晕（内耳、中枢性等） · 遗传性听力损失诊断 · 鼻窦炎（过敏性鼻炎、慢性鼻窦炎、鼻息肉、鼻中隔弯曲） · 咽、喉、舌（扁桃体炎、声带息肉、睡眠呼吸暂停综合征） · 唾液腺（腮腺、唾液、下颌腺肿瘤） · 面瘫 · 咽喉、甲状腺、舌、鼻、颅底肿瘤		手术、言语听觉治疗等
东京大学医学部附属病院	人工内耳·人工听觉中心	耳鼻喉科		· 先天性听力下降、后天性耳聋、遗传性听力丧失 · 中耳炎 · 鼻炎、过敏性鼻炎 · 下咽癌、舌癌、咽癌等 · 面部神经 · 气管食道 · 头晕 · 语言障碍 · 吞咽障碍	听力测试、遗传因子测试、头戴式内视镜检查、组织活检、超声检查、影像检查（CT、MRI）	手术等
総合病院聖隷浜松	头颈部中心	耳鼻喉科眼窝形成	康复科、整形外科、肿	· 头颈部肿瘤 · 面部伤痕		头颈部肿瘤治疗：与眼科、口

中国知网 https://www.cnki.net

病院		外科 口腔科[1)]	瘤放射科、姑息治疗科合作	· 眼窝 · 上下颚、面部领域疾病 · 口腔癌（舌癌、鼻腔癌、口腔癌、下咽癌、眼窝肿瘤、泪道疾病、面部骨折等）		腔科合作 面部骨折：与眼科、口腔科合作 头颈部肿瘤：耳鼻喉科负责肿瘤手术治疗 眼窝外科：面部创伤手术，涉及眼眶肿瘤。
関西医科大学総合医療センター	甲状腺外科中心	耳鼻喉科	甲状腺医疗团队（耳鼻喉科、内科（内分泌内科、肿瘤内科）、儿科、放射科、整形外科、心血管外科）	· 耳、鼻、咽喉以及头颈部（包括面神经和口腔、腮腺、甲状腺、甲状旁腺） · 耳：听力障碍、助听器 · 鼻：鼻涕、打喷嚏、花粉过敏等 · 头颈部：颈部疼痛、下巴、耳肿胀	PET-CT 诊断甲状腺癌转移和复发	手术等 头颈部肿瘤着重放疗和化疗 耳鼻喉科、内科（内分泌内科、肿瘤内科）、儿科、放射科、整形外科、心血管外科合作治疗甲状腺疾病
奈良県立医科大学附属病院	头晕中心	耳鼻喉科		· 头晕	神经耳科检查	
熊本大学医学部附属病院	吞咽中心	耳鼻喉科 口腔科 呼吸内科 神经内科 精神科 营养部 康复科 护理部		· 吞咽障碍 · 误咽性肺炎	咽下造影、咽喉频闪等	言语听觉士康复训练等
山口大学医学部附属病院		耳鼻喉科	生活功能恢复中心[2)] 高级综合感官医疗中心[3)]	·		
川崎医科大学附属病院	感官中心	眼科 耳鼻喉科 口腔科		· 眼科疾病 · 耳鼻喉科疾病 · 口腔科疾病		

注：1）该医院口腔科支持治疗头颈部疾病治疗。头颈部与呼吸、说话、吃饭、吞咽等有关，口腔治疗可以帮助疾病的恢复，常与康复科合作。

2）生活功能恢复中心包含小组治疗室、隔音室和医生办公室。耳鼻喉科患者进行食道声带康复治疗，妇产科进行助产指导，精神科医生进行精神指导，神经内科在隔音室进行听觉电生理检查。

3）高级综合感官医疗中心为眼科、皮肤科、耳鼻喉科医生诊疗地方，旨在通过患有感觉器官障碍疾病患者进行整体训练和评估，以改善残余感觉功能和改善生活质量。眼科·小儿眼科进行斜视、弱视训练、视觉电生理检查，皮肤科进行皮肤紫外线敏感度检查，耳鼻喉科进行助听器、听觉言语训练、人工内耳康复、空间识别测验、平衡训练等。

表格自制

2）涉及科室和医技

耳鼻喉科相关中心主要构成科室为耳鼻喉科，涉及相关检查主要为科室内检查，如听觉检查、吞咽功能测试和语言功能测试等，部分检查涉及到遗传检查和超声检查，放射科检查则主要用于头颈部肿瘤病变的评估。

由于耳鼻喉科涉及整个头颈部区域病症，往往会与其他科室合作，成立更加复合的中心以诊疗某些特殊疾病。如与眼科和口腔科合作成立头颈部中心或感官中心，诊疗头颈部肿瘤和面部骨折等疾病；与口腔科、呼吸内科和康复科等合作成立吞咽障碍中心，诊疗患者吞咽障碍；与肿瘤中心、整形外科等合作诊疗甲状腺疾病；等等。见图 2-11。

中国知网 https://www.cnki.net

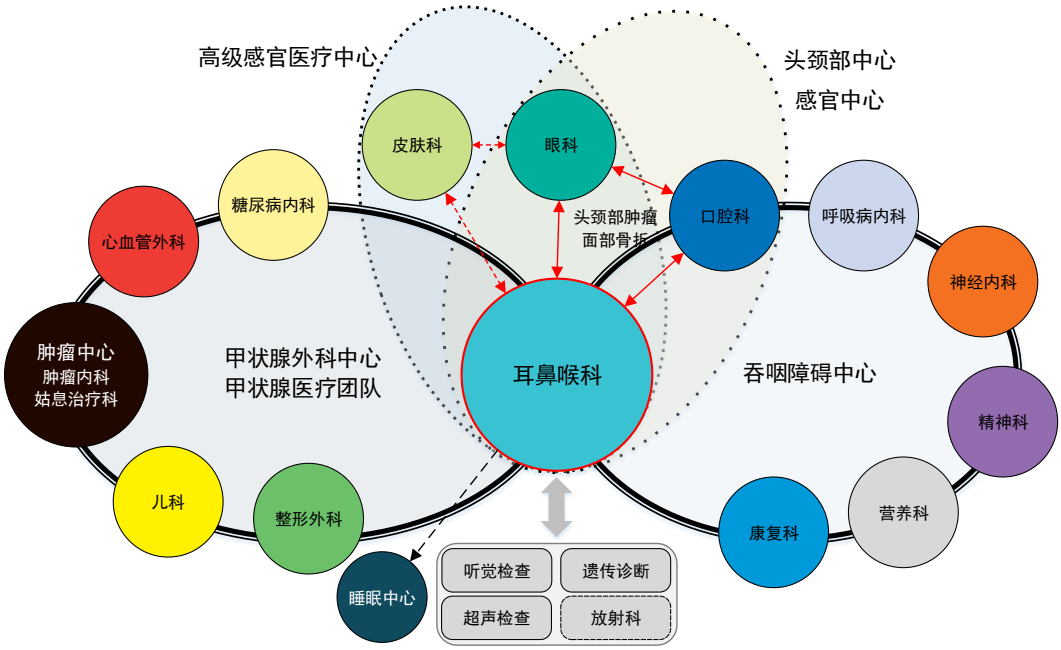
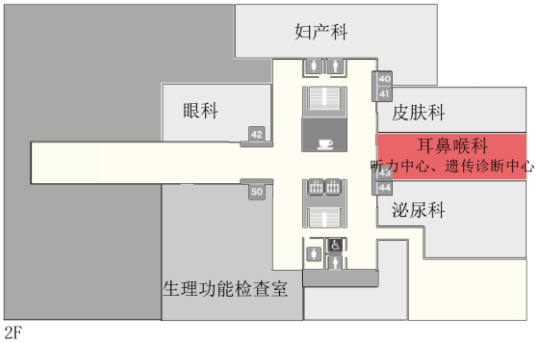
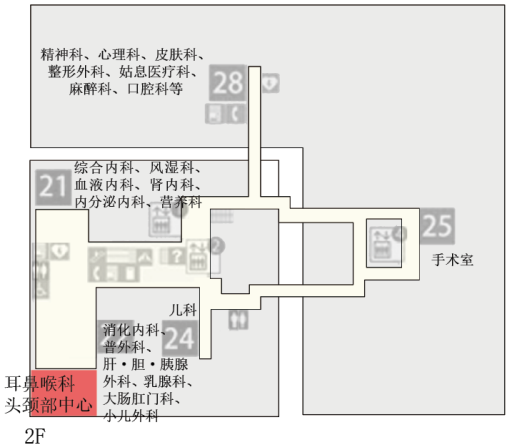
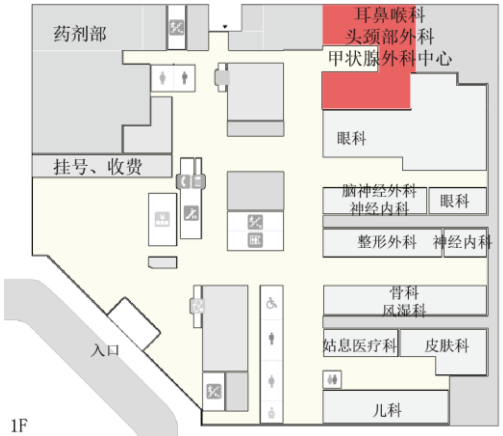


图 2-11 耳鼻喉科相关中心主要组成科室、关联科室和涉及医技部门关系图
图片来源：作者自绘

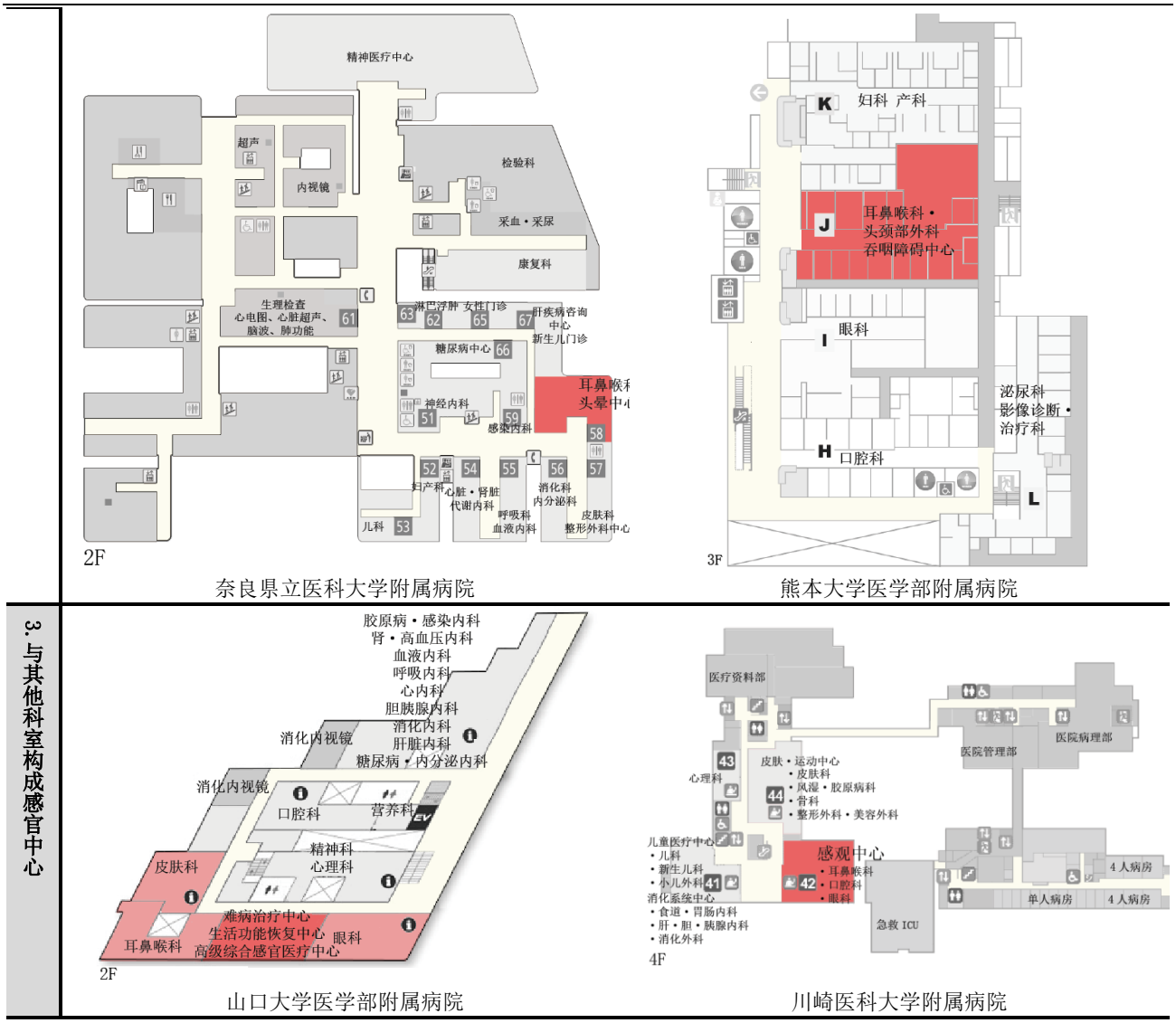
3）位置关系研究

由于耳鼻喉科相关中心涉及整个头部器官诊疗，常需要与其他科室合作，宜将耳鼻喉科中心与相关合作科室邻近设置，以方便患者诊疗。具体平面布局见表 2.13。

表 2.13 耳鼻喉科相关中心平面布局特征

布局	案例
1. 内设相关检查室	 虎の門病院
2. 内设相关诊疗中心	 総合病院聖隷浜松病院  関西医科大学総合医療センター

中国知网 https://www.cnki.net



注：图表自制

2.2.6 口腔中心

1）基本情况

口腔相关疾病中心主要诊疗口腔、牙齿相关疾病。在所研究医院中，设置诊疗口腔疾病相关中心共 26 个，包括口腔中心、口腔癌症中心和牙种植中心等，如图 2-12。其中以口腔中心命名的中心 12 个，占所有口腔相关中心的一半以上。为便于研究，现将与诊疗口腔疾病相关中心统称为口腔中心。

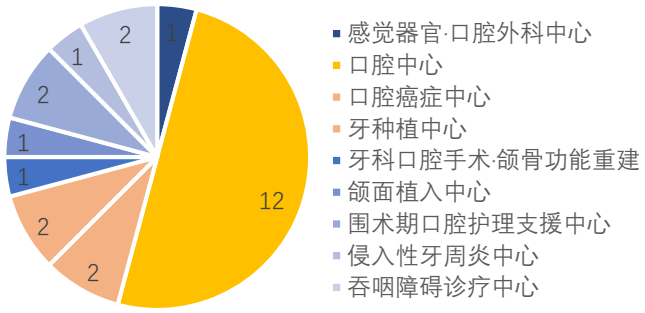


图 2-12 口腔疾病相关中心名称数量统计图
图片来源：作者自绘

中国知网 https://www.cnki.net

综合考虑各医院设置口腔中心的科室配置、诊疗特点和平面布局特征，选取东北大学医院、宇治德洲会医院和长野松代综合医院等在内的 8 所医院口腔中心进行相关研究分析，基本情况统计见表 2.14。

表 2.14 各医院口腔中心基本情况一览

医院名称	诊疗中心名称	包含科室	关联科室或诊疗中心	诊疗疾病	诊断	治疗
东北大学病院	牙种植中心	口腔诊断科 口腔外科 牙周病科 龋齿科等	牙科下颌口腔外科 牙科麻醉科	· 牙种植治疗牙缺损 · 牙种植植入手术	CT 影像诊断、CAD/CAM 系统等	手术等
	围术期口腔管理中心[1)]	牙科医生 牙齿保健师 牙科技师	术前口腔管理 癌症治疗支持	· 口腔癌症、移植治疗 · 改善癌症治疗和心血管疾病治疗、器官移植治疗	X 线检查、牙周组织检查、细菌检查	手术前进行口腔检查和紧急处理口腔问题，清洁口腔等
宇治德洲会病院	口腔中心	口腔科	（吞咽障碍团队）	· 一般牙齿疾病 · 口腔外科疾病 · 口腔黏膜疾病 · 牙种植 · 紧急治疗（创伤、炎症、出血）等		全身麻醉或局部麻醉手术等
長野松代総合病院	口腔・下颚功能重建中心	口腔科	心理科（口腔心理病）	· 头颈部肿瘤 · 下颌畸形 · 颌面部创伤 · 牙种植 · 口腔内科疾病 · 口腔黏膜病 · 口腔感染等	CT 检查等、（血液检查、细菌检查）[2)]	手术治疗等
住友病院	口腔・颚中心	口腔科	整形外科	· 与整形外科合作诊疗颌面畸形 · 围术期口腔功能管理 · 颚关节病治疗	MRI、X 线	手术等
洛和会音羽病院	京都口腔健康中心	口腔外科 京都颚变形中心 口腔麻醉科	糖尿病・内分泌・生活习惯病中心（牙周病）	· 口腔外科疾病：智齿、拔牙、种植牙、口腔感染、口腔癌等 · 口腔内科疾病：口腔炎、舌痛、口腔干燥、面部神经痛、睡眠呼吸暂停综合征 · 全身麻醉・静脉镇定口腔治疗 · 围术期口腔管理 · 糖尿病患者牙周病治疗 · 口腔癌检查	视诊・初诊、口腔 CT、口腔全景、口腔内荧光检查	手术等
岡山大学病院	侵袭性牙周病中心	牙周科 儿童口腔科 儿科 综合内科	口腔放射科・口腔诊断科 精神神经科 小儿神经科 矫正口腔科 义齿科 预防口腔科 护理部 口腔护理师	· 牙周炎、牙周病	牙科影像诊断	
岩手医科大学附属病院	口腔科医疗中心	口腔综合诊疗科		· 牙周病、口腔护理、口臭、牙龈、牙齿美容、假牙、口	X 线摄影、唾液腺造	手术等

中国知网 https://www.cnki.net

		口腔科 口腔护理科 义齿科 口腔种植科 口腔外科 正畸牙科 小儿牙科 牙齿放射科 口腔麻醉科		腔种植、颌面疼痛、唇裂、磨牙	影 成 像 、CT、MRI、超声检查	
鹿児島大学病院	口腔科	口腔保健科 正畸牙科 小儿口腔科 牙周病科 口腔外科 口腔颌面外科 颌面放射科 口腔麻醉科	唇裂门诊 口干门诊 睡眠呼吸暂停门诊	· 口腔保健、正畸、唇裂、颌骨变形、儿童口腔保健、牙周病治疗、口臭检查诊疗、义齿、智齿、口腔肿瘤等	影像诊断	手术等

注：1）围术期口腔管理中心：a.预防手术并发症（预防全身麻醉下活动牙齿的脱落；预防口腔、上消化道全身麻醉手术易引发手术部位感染；预防手术过程中口腔细菌吸入肺部引发肺炎）b.心血管疾病和器官移植手术前口腔治疗（上述手术需要去除慢性细菌感染，而严重的牙周炎和龋齿是典型的细菌感染病变。）c.口腔科参与癌症治疗（化疗和放疗易导致口腔炎、口腔干燥症、口腔念珠菌病、味觉障碍等；一些口服药物易导致颌骨坏死，进行用药前的咨询和口腔内部清洁）。

2）舌痛症需进行血液检查、细菌检查

表格自制

2）涉及科室和医技

口腔中心主要构成科室为口腔科，主要涉及医技检查为科室内检查，如口腔 CT、牙片等。口腔中心常与其他科室或中心合作诊疗某些特殊疾病，如与整形外科合作诊疗颌面畸形；与唇腭裂中心合作诊疗唇腭裂疾病；与睡眠中心合作诊疗睡眠呼吸暂停综合症等等；除此之外，在一些医院口腔中心会与日间手术中心合作进行一些口腔手术或与手术中心邻近进行围术期的口腔管理工作。见图 2-13。

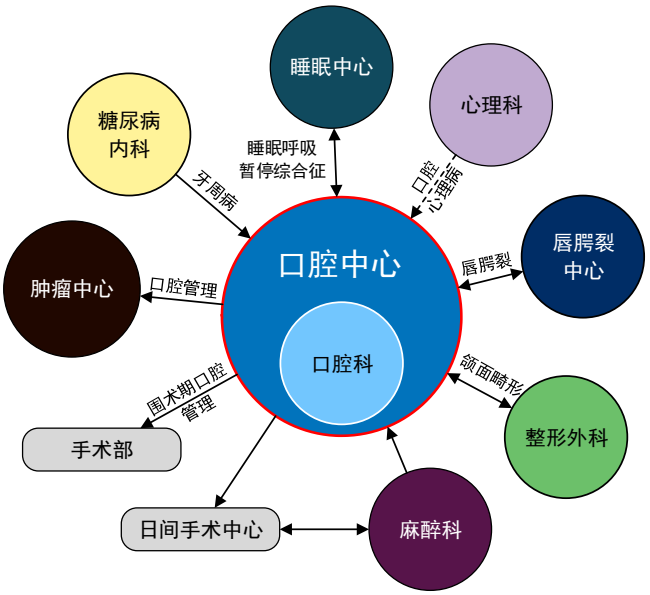


图 2-13 口腔中心主要组成科室、关联科室和涉及医技部门关系图

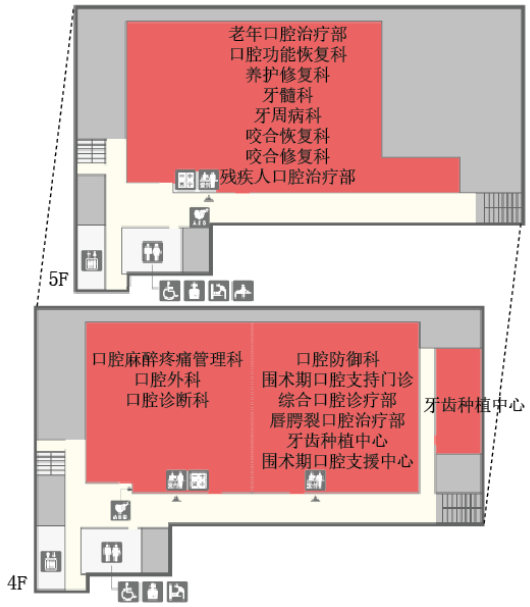
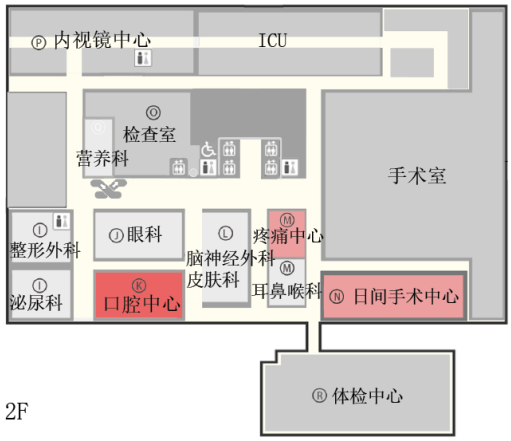
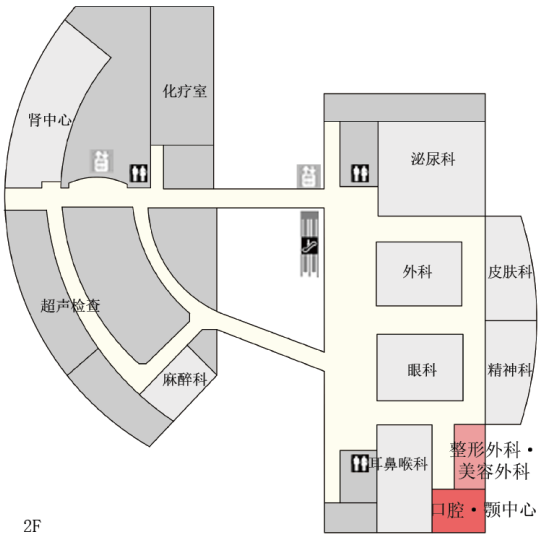
图片来源：作者自绘

3）位置关系研究

除了常见的将口腔中心独立布局外，考虑到口腔进食引起手术或其他患者伤口感染的可能，口腔中心还常与手术部或其他科室中心邻近布局，具体平面布局形式见表 2.15。

中国知网 https://www.cnki.net

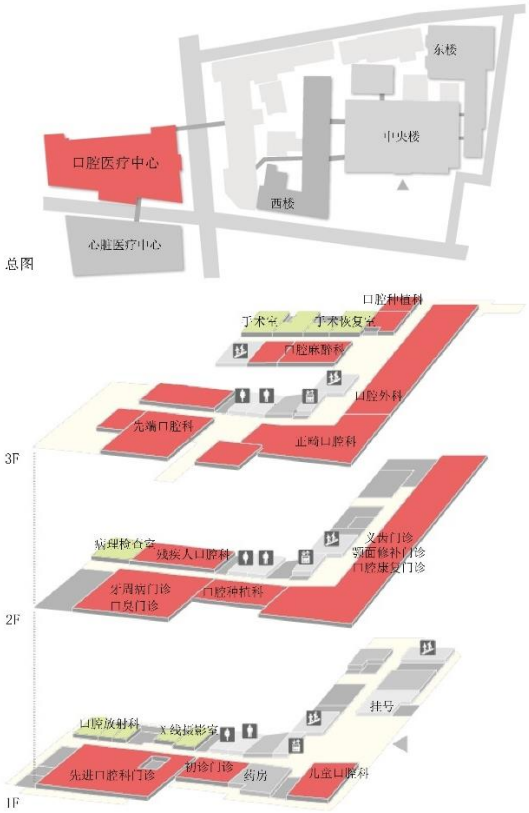
表 2.15 口腔中心平面布局特征

布局	案例
1. 内设相关检查室	 东北大学病院
2. 与日间手术中心或手术中心相邻	 宇治德洲会病院 長野松代総合病院
3. 与相关科室相邻	 住友病院 洛和会音羽病院

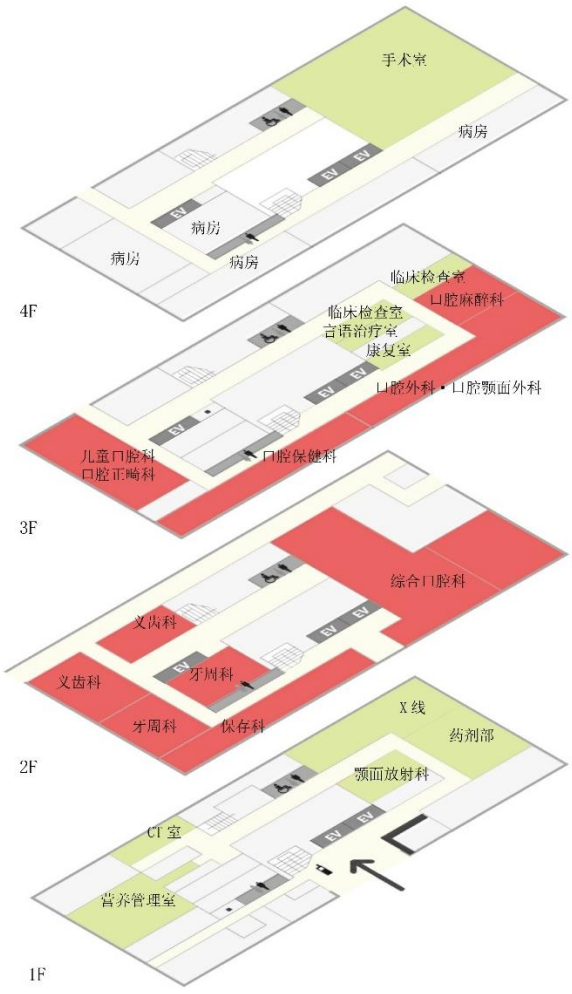
中国知网 https://www.cnki.net

4.独栋布置

岡山大学病院



岩手医科大学附属病院



鹿児島大学病院

注：图表自制

中国知网 https://www.cnki.net

2.2.7 乳腺中心

1）基本情况

在日本的女性恶性疾病中，乳腺癌的发病率最高，乳腺中心的成立，力在对乳腺癌进行早发现、早诊断和早治疗。在所研究医院中，设置乳腺疾病相关中心共 41 个，包括乳腺中心、乳腺癌治疗・乳房重建中心和乳腺・甲状腺中心，见图 2-14。其中以乳腺中心命名的中心数量较多，为方便研究，将与诊疗乳腺相关疾病中心，统称为乳腺中心。

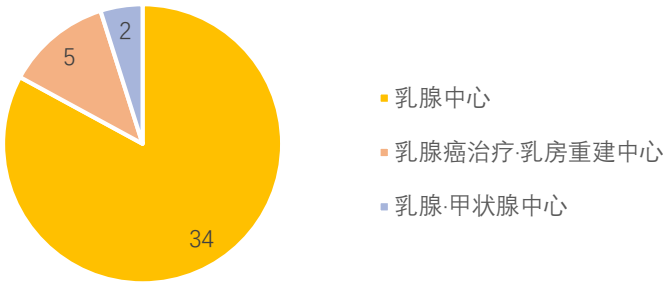


图 2-14 乳腺疾病相关中心名称数量统计图
图片来源：作者自绘

综合考虑各医院设置乳腺中心的科室配置、诊疗特点和平面布局特征，选取北斗医院和昭和大学医院等在内的 7 所医院乳腺中心进行研究分析，基本情况见表 2.16。

表 2.16 各医院乳腺中心基本情况一览

医院名称	诊疗中心名称	包含科室	关联科室或诊疗中心	诊疗疾病	诊断	治疗
ベルランド総合病院	乳腺中心		整形外科 放射科 病理部 姑息治疗科	・ 乳腺癌	视触诊、超声检查、乳房 X 线检查、细胞活检、CT、MRI 等	手术治疗、化疗、放疗、内分泌治疗
北斗病院	乳腺・乳腺癌中心	乳腺外科		・ 乳腺癌	超声、乳房 X 线、MRI、病理诊断等	保乳手术等
昭和大学病院	乳房中心	乳腺外科	肿瘤中心 姑息治疗中心 整形外科	・ 乳腺癌 ・ 遗传性乳腺癌 ・ 卵巢癌 ・ 乳腺症 ・ 心理咨询	乳房 X 线、超声、MRI、CT、病理检查、遗传诊断	乳房再建、手术治疗等
昭和大学藤が丘病院	乳房中心		整形外科	・ 乳腺癌 ・ 遗传咨询	乳房 X 线、乳房超声、组织活检、遗传检测	手术、化疗、放疗
市立貝塚病院	乳腺癌诊断・治疗中心		整形外科	・ 乳腺癌 ・ 淋巴浮肿	乳腺造影、卧式乳房切片活检、病理诊断	微创手术、乳房重建
国際医療福祉大学三田病院	乳腺中心		（乳腺癌医生、化疗药剂师、癌症护士、放射线技师）	・ 乳腺癌	遗产诊断、乳房 X 线、超声、乳房 MRI、细胞活检	手术治疗、放疗、化疗 乳房再建

中国知网 https://www.cnki.net

東京西徳洲会病院	乳腺肿瘤中心		放射科	· 乳腺癌 · 淋巴结清洁	乳房 X 线、乳房超声、乳房 MRI、PET-CT	手术、化疗、放疗

注：表格自制

2）涉及科室和医技

乳腺中心主要构成科室为乳腺·内分泌外科，主要涉及检查为乳房 X 线、超声检查、病理检查等，其常与整形外科合作进行女性保乳手术的治疗，与肿瘤中心合作进行乳腺癌的诊疗，见图 2-15。

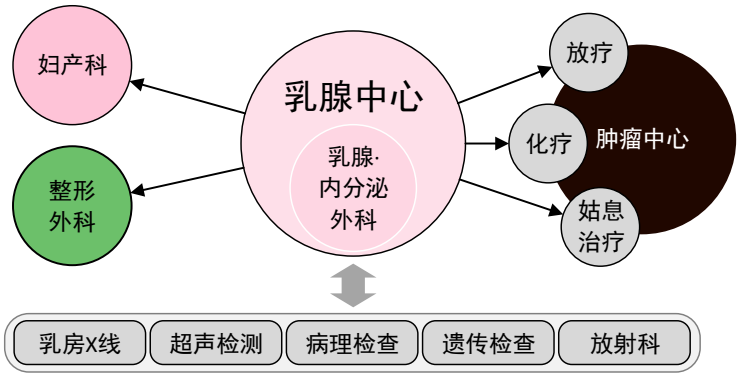


图 2-15 乳腺中心主要组成科室、关联科室和涉及医技部门关系图
图片来源：作者自绘

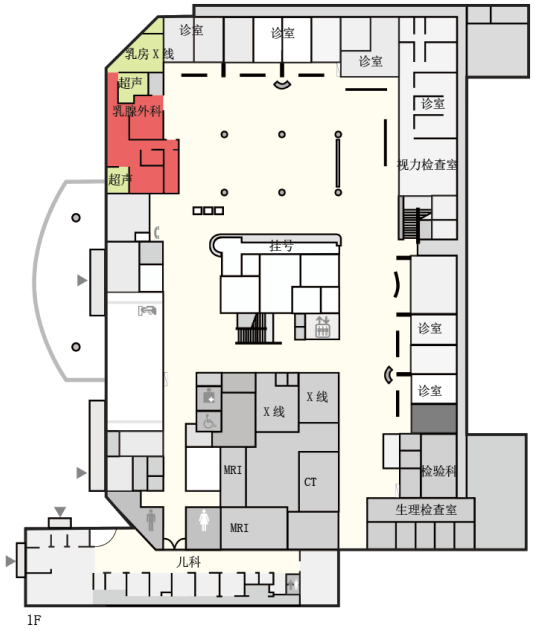
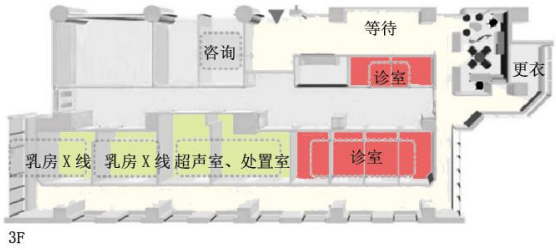
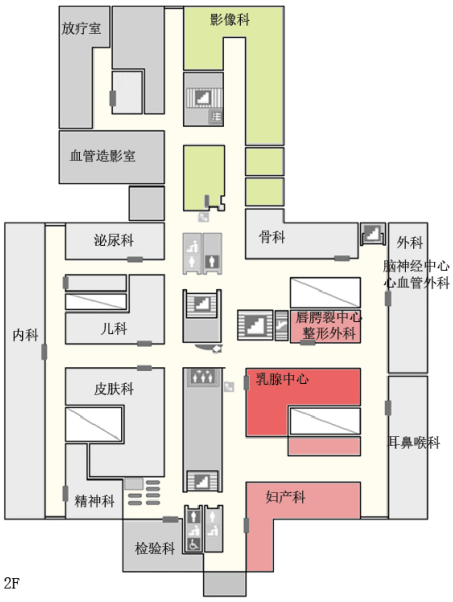
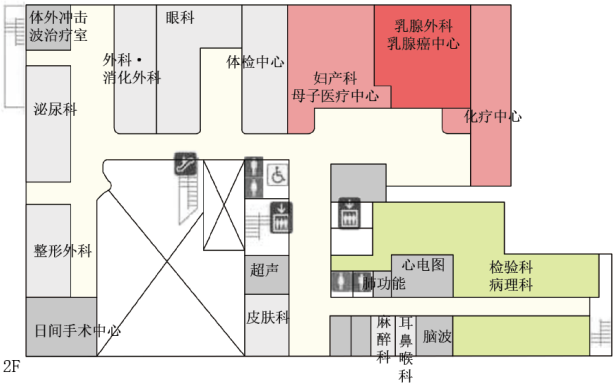
3）位置关系研究

乳腺中心常设在妇产科内，也可单独布置，中心往往配有相应的检查设施，以便于患者诊疗。除此之外，乳腺中心还会邻近整形外科或肿瘤中心布局，以方便乳腺癌患者一站式诊疗，见表 2.17。

表 2.17 乳腺中心平面布局特征

布局	案例
1. 设置在妇产科内	ベルランド総合病院

中国知网 https://www.cnki.net

2. 内设相关检查室	 北斗病院	 昭和大学病院
3. 与相关科室或中心相邻	 昭和大学藤が丘病院	 市立貝塚病院
	 国際医療福祉大学三田病院	 東京西徳洲会病院

注：图表自制

中国知网 https://www.cnki.net

2.3 系统中心

通过对研究医院设置的各种诊疗中心进行统计归纳和对各诊疗中心诊疗内容和特性区分，将消化系统中心、呼吸系统中心、睡眠中心、内分泌中心、心·脑血管中心、慢性创伤中心、脊椎脊髓中心、骨科中心、整形中心、女性骨盆底中心、生殖医疗中心、周产期母子医疗中心、女性诊疗中心和儿童医疗中心归为一类，统称为系统中心。这类中心主要诊疗特定身体系统疾病。本节将主要解明此类诊疗中心诊疗疾病、科室构成和相关医技等基本情况，以及各类系统中心的布局特征。

2.3.1 消化系统中心

1）基本情况

消化系统疾病相关中心主要诊疗食道、胃、大肠、小肠等在内消化系统疾病。在所研究医院中，设置消化系统疾病相关中心共 157 个，包含消化系统中心、肝脏病医疗中心、炎症性肠疾病中心等，如图 2-16。其中以消化系统中心命名的中心 105 个，占一般以上。为方便研究分析，现将与消化系统疾病相关的中心，统称为消化系统中心。

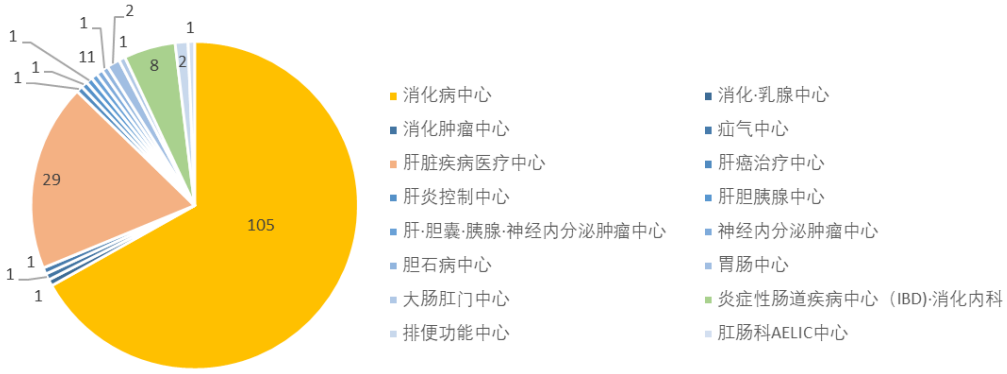


图 2-16 消化系统疾病相关中心名称数量统计图
图片来源：作者自绘

综合考虑各医院设置消化系统中心的科室配置、诊疗特点和平面布局特征，选取久留米大学医院、大森医院和自治医科大学附属医院等在内的 4 所医院消化系统中心进行相关研究分析，基本情况统计见表 2.18。

表 2.18 各医院消化系统中心基本情况一览

医院名称	诊疗中心名称	包含科室	关联科室或诊疗中心	诊疗疾病	诊断	治疗
久留米大学病院	消化病中心 肝癌中心 炎症性肠疾病中心	消化内科 消化外科 放射科	口腔科、营养师	· 食道、胃、大肠癌、炎症性肠病、胆胰腺肿瘤、肝炎等	内视镜检查 超声检查	食道癌：手术、化疗、放疗 下咽部食道癌：与耳鼻喉科·整形外科合作 肝胆胰腺癌：与放射科、病理科合作 炎症性肠疾病：与儿科、放射科、免疫科、药剂科、病理科合作
東邦大学医療センター 大森病院	消化系统中心	消化内科 消化外科	放射科	· 胆道·胰腺疾病 · 肝疾病（慢性肝炎、急性肝功能衰竭、肝硬	内视镜、超声、CT、MRI、血管造影	消化系统癌症化疗、放疗等。

中国知网 https://www.cnki.net

				化） · 胃癌、食道癌、大肠癌、肝癌	等	
自治医科大学附属病院	消化系统中心	消化・肝脏内科 消化外科	临床肿瘤科、放射科、急救中心	· 消化道（食道、胃、十二指肠、小肠、大肠）、肝脏、胆道（胆囊、胆管）、胰腺等消化系统疾病	内视镜、腹部超声、CT、MRI	与消化内科合作治疗消化系统疾病 与移植外科合作进行儿童活体肝移植 与临床肿瘤科、放射科合作，治疗消化系统癌症 与急救中心合作，开展急救手术。
湘南鎌倉総合病院	消化病中心	消化内科 消化外科 肝胆胰腺内科	血管内治疗中心、放射科、肿瘤内科、综合内科	· 胃肠道、肝脏、胆囊、胰腺疾病	内视镜检查	与急救部合作：紧急下内视镜检查和治疗 消化系统癌症诊疗：内视镜、IVR（血管内治疗）、放射科、肿瘤中心 与一般内科合作：腹痛，可能不是胃肠疾病

注：表格自制

2）涉及科室和医技

消化系统中心主要由消化内科和消化外科（普外科）构成，主要涉及医技检查为内视镜检查和腹部超声检查，当诊断消化系统癌症时需相关放射科和病理科的检查。消化系统作为癌症多发部位，致使消化系统中心与肿瘤中心的联系密切。见图 2-17。

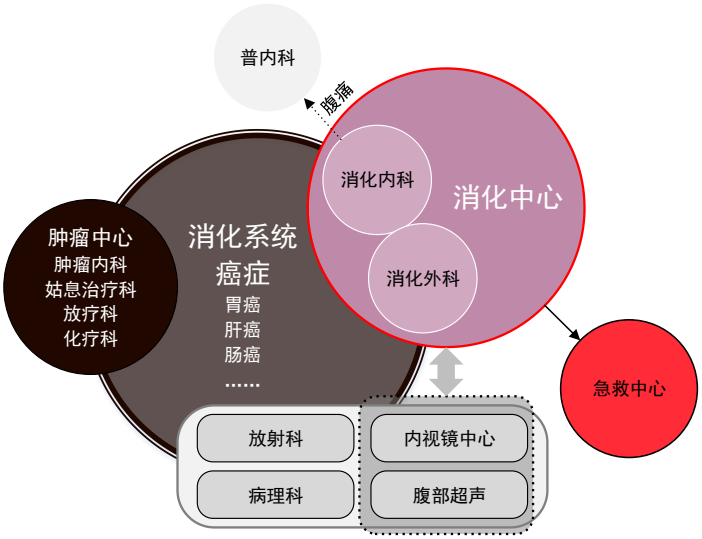


图 2-17 消化系统中心主要组成科室、关联科室和涉及医技部门关系图
图片来源：作者自绘

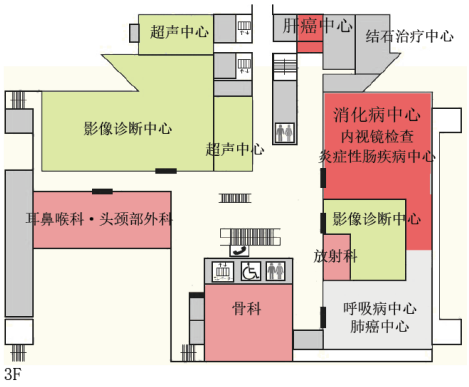
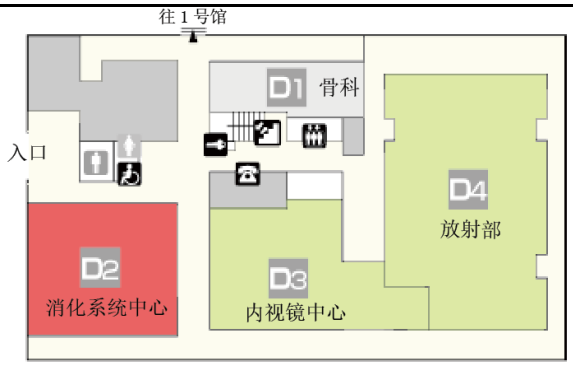
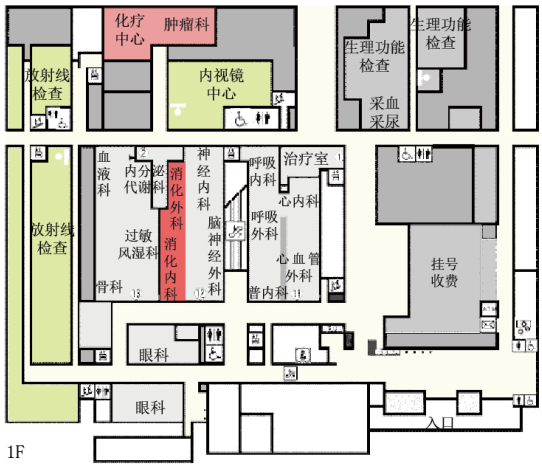
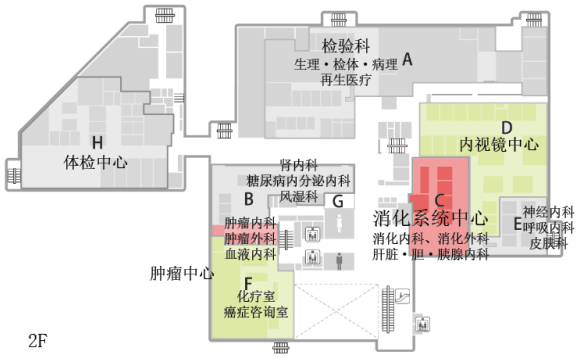
3）位置关系研究

由于消化系统中心常涉及内视镜检查，所以在医院布局中，往往将消化系统中心与内视镜中心邻近布置；除此之外，消化系统作为癌症多发部位，日本各医院在布置消化系统中心时，往往考虑与放射科和肿瘤中心邻近布置。具体情况见表 2.19。

表 2. 19 消化系统中心平面布局特征

布局	案例

中国知网 https://www.cnki.net

1. 内设内视镜中心	 久留米大学病院
2. 与相关检查室相邻	 東邦大学医療センター　大森病院
3. 邻近相关科室或诊疗中心	 自治医科大学附属病院
	 湘南鎌倉総合病院

注：图表自制

2.3.2　呼吸系统中心

1）基本情况

呼吸系统疾病相关中心以诊疗呼吸道及肺部疾病为主。在所研究医院中，设置诊疗呼吸系统疾病相关中心共 72 个，包括呼吸系统中心、肺癌中心、石棉病中心等，如图 2-18。其中以呼吸系统疾病命名的中心 63 个，占所有呼吸系统疾病相关中心一半以上，为便于研究分析，现将与诊疗呼吸系统疾病相关中心，统称为呼吸系统中心。

中国知网　https://www.cnki.net

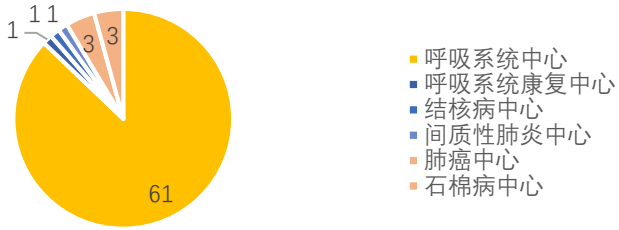


图 2-18 呼吸系统疾病相关中心名称数量统计图
图片来源：作者自绘

综合考虑各医院呼吸系统中心的科室配置、诊疗特点和平面布局特征，选取久留米大学医院、複十字医院、自治医科大学附属医院和大森医院呼吸系统中心进行相关研究分析，基本情况统计见表 2.20。

表 2.20 各医院呼吸系统中心基本情况一览

医院名称	诊疗中心名称	包含科室	关联科室或诊疗中心	诊疗疾病	诊断	治疗
久留米大学病院	呼吸系统中心 肺癌中心	呼吸内科 呼吸外科 放射科		・ 慢性呼吸系统疾病 ・ 呼吸道感染 ・ 肺癌 ・ 呼吸衰竭	胸部 X 线，CT，PET，MRI，肺功能测试，气道反应测试，痰检，支气管镜、胸腔镜、纵膈镜等	手术、（ 化疗、放疗）等
複十字病院	呼吸系统中心 呼吸系统康复中心（结核病中心）	呼吸内科 呼吸外科 过敏科（结核科）	癌症中心	・ 感冒 ・ 支气管炎 ・ 肺气肿 ・ 慢性支气管炎 ・ 支气管哮喘 ・ 间质性肺炎 ・ 呼吸感染 ・ 睡眠呼吸暂停综合征	支气管镜，胸部 X 线 CT，遗传因子检查，细菌检查，CT 下经皮活检，支气管动脉造影，痰检	手 术等
自治医科大学附属病院	呼吸系统中心	呼吸内科 呼吸外科	放射科（肺癌）	・ 肺癌 ・ 过敏性肺病 ・ 间质性肺炎 ・ 肺炎感染 ・ 气胸 ・ 睡眠呼吸暂停 ・ 呼吸衰竭等	气道过敏性试验呼吸功能检查，支气管镜洗肺・肺活检・超声引导下淋巴活检，CT、MRI、PET，超声诊断、超声下活检，多导睡眠图，胸腔镜下胸膜活检，检体检查，传染病微生物检查	胸 腔镜 手术，放疗、化疗（针对 肺癌）等
東邦大学医療センター 大森病院	呼吸系统中心 间质性肺炎中心 [1)]	呼吸内科 呼吸外科	癌症中心 睡眠中心 康复科 病理科	・ 肺癌 ・ 间质性肺炎 ・ 肺部感染 ・ 睡眠呼吸暂停综合征 ・ 支气管哮喘 ・ 气胸等	影像检查、CT、MRI、PET-CT，支气管镜检查，EBUS（支气管内超声检查），CT 下肺活检	手术、（ 化疗）等

注：1）间质性肺炎中心，需要多学科诊断（MDD：multidisciplinary），与临床检验科合作进行血液检查，与康复科合作康复诊疗，与呼吸外科合作进行肺活检和间质性肺炎手术，与麻醉科合作进行相关手术，与胶原病科合作诊疗胶原病合并性肺炎，与心血管内科・小儿心血管科合作诊疗合并高血压，与病理科（MDD 诊断）和放射科(MDD)合作诊断。
表格自制

2）涉及科室和医技

呼吸系统中心主要由呼吸内科和呼吸外科构成，主要涉及医技检查为支气管镜检查和肺功能检查。当诊疗某些特殊疾病时，呼吸系统中心往往需要与其他科室合作诊疗，如与放射科和肿瘤中心合作诊疗肺癌；与风湿胶原病科和心内科等合作诊疗间质性肺炎；与睡眠中心合作诊疗睡眠呼吸暂停综合征；等等，见图 2-19。

中国知网 https://www.cnki.net

由于呼吸系统中心涉及诊疗科室和诊疗中心较多，所以日本部分医院在设置呼吸系统中心时，会考虑与医院相关医疗团队合作诊疗，如图 2-20 县立广岛病院呼吸病中心的构成。

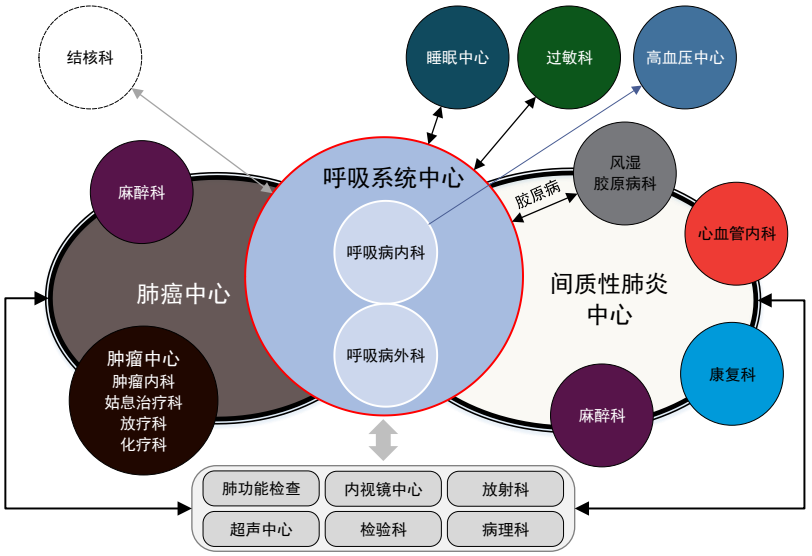


图 2-19 呼吸系统中心主要组成科室、关联科室和涉及医技部门关系图
图片来源：作者自绘

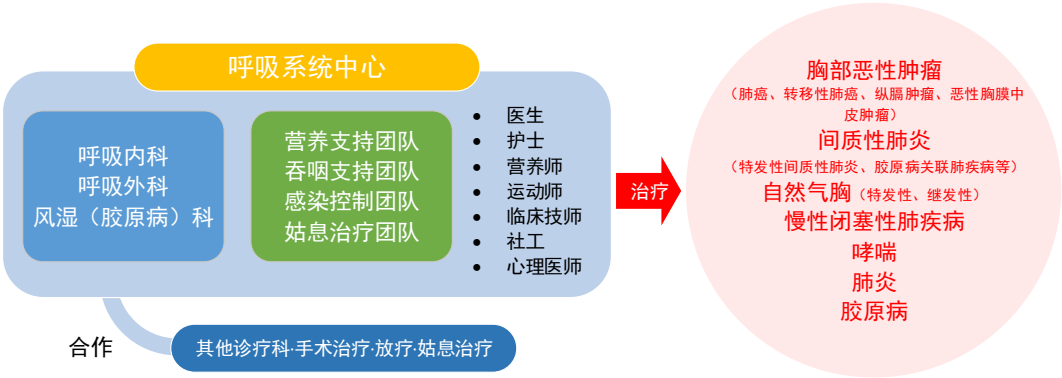


图 2-20 县立广岛病院呼吸系统中心构成
图片来源：作者根据该医院官网翻译重绘

3）位置关系研究

为便于患者检查，呼吸系统中心常内设相关检查或邻近相关检查室布局，往往会与消化系统中心共用内视镜中心。除此之外，呼吸系统中心还会与肿瘤中心等相关科室邻近，以方便多疾病患者的诊疗。见表 2.21。

表 2. 21 呼吸系统中心平面布局特征

布局	案例
1. 内设主要检查室	 久留米大学病院

中国知网 https://www.cnki.net

2. 与相关检查室相邻	 複十字病院
3. 邻近相关科室或诊疗中心	 自治医科大学附属病院 東邦大学医療センター　大森病院

注：图表自制

2.3.3 睡眠中心

1）基本情况

睡眠中心主要以诊疗睡眠呼吸暂停综合症为主。长期睡眠不足，易引发高血压、脑血管障碍、心绞痛和糖尿病等生活习惯病，需要早诊断、早治疗。综合考虑各医院设置睡眠中心的科室配置、诊疗特点和平面布局特征，选取名古屋市立大学医院和大阪大学医学院附属医院等在内 8 所医院进行相关研究分析，基本情况见表 2.22。

中国知网 https://www.cnki.net

表 2.22 各医院睡眠中心基本情况一览

医院名称	诊疗中心名称	包含科室	关联科室或诊疗中心	诊疗疾病	诊断	治疗
名古屋市立大学病院	睡眠医疗中心	耳鼻喉科		· 睡眠呼吸暂停综合征 · 嗜睡等	PSG MSLT	CPAP、耳鼻喉科、口腔科手术治疗
大阪大学医学部附属病院	睡眠医疗中心	精神科 耳鼻喉科 糖尿病・内分泌科 儿科 老年・高血压内科	各科单独受诊	· 睡眠呼吸障碍综合征 · 嗜睡 · REM 睡眠行为障碍	采血、内视镜检查（上呼吸道状态评估）、头部 MRI 检查、夜晚睡眠检查	药物治疗、CPAP 治疗、口腔治疗、手术治疗、营养指导
東邦大学医療センター　大森病院	睡眠呼吸障碍中心	呼吸内科 心内科	呼吸系统中心 口腔外科、耳鼻喉科	· 睡眠呼吸暂停综合征 · 嗜睡	头部 X 线、血氧饱和度检查、PSG 检查、放射线 住院睡眠监测	口腔科治疗、耳鼻喉科手术治疗
九州大学病院	睡眠呼吸障碍中心	（心内科医生 2 名，呼吸内科医生 1 名）	呼吸科、口腔科、耳鼻喉科、心内科、神经内科、心理内科、精神科、放射科、综合诊疗科	· 睡眠呼吸障碍 · 精神心理异常（睡眠障碍） · 内科疾病（代谢综合征、心力衰竭、肾功能衰竭、内分泌异常等） · 呼吸道异常	血氧饱和度、多导睡眠图（PSG）、MSLT、头部 MRI、心脏超声等	CPAP、人工呼吸治疗（SAV）、口腔矫治器（OA）（口腔科）、手术口腔颚关节手术（耳鼻喉科）
滋賀医科大学医学部附属病院	睡眠中心			· 睡眠障碍 · 睡眠呼吸暂停综合征 · 嗜睡 · REM 睡眠行为障碍	多导睡眠图（PSG） 反复浅睡眠测试（MSLT）	药物治疗
日本大学医学部附属板橋病院	睡眠中心	呼吸内科 精神科		· 睡眠呼吸暂停综合征 · 失眠 · 周期性肢体运动障碍	问诊、体格检查、鼻通气检查（必要时采血、心电图、肺功能检查）、便携式检查设备、入院 PSG 检查、MSLT 检查	CPAP、口腔科、手术治疗
愛知医科大学病院	睡眠中心	睡眠科		· 睡眠呼吸暂停综合征 · 嗜睡 · REM 睡眠行为障碍 · 不宁腿综合征	PSG MSLT 携带式无呼吸检查	认知行为疗法（CBTI）[1)] 正压呼吸疗法（CPAP）、人工呼吸机（ASV）
大阪回生病院	睡眠医疗中心			· 睡眠呼吸障碍 · 嗜睡 · 睡眠中行为异常（REM 睡眠障碍，梦游） · 睡眠中运动异常（抖腿）	MSLT 检查等	耳鼻喉科、口腔科治疗

注：1）与心理医生共同为失眠症患者进行认知行为疗法。

表格自制

中国知网 https://www.cnki.net

2）涉及科室和医技

睡眠中心往往需要多学科联合诊疗，如耳鼻喉科、呼吸内科和精神科等，主要涉及医技检查为多导睡眠图检查（PSG）、重复浅睡眠监测检查（MSLT），以及心电图检查等。如图 2-21。

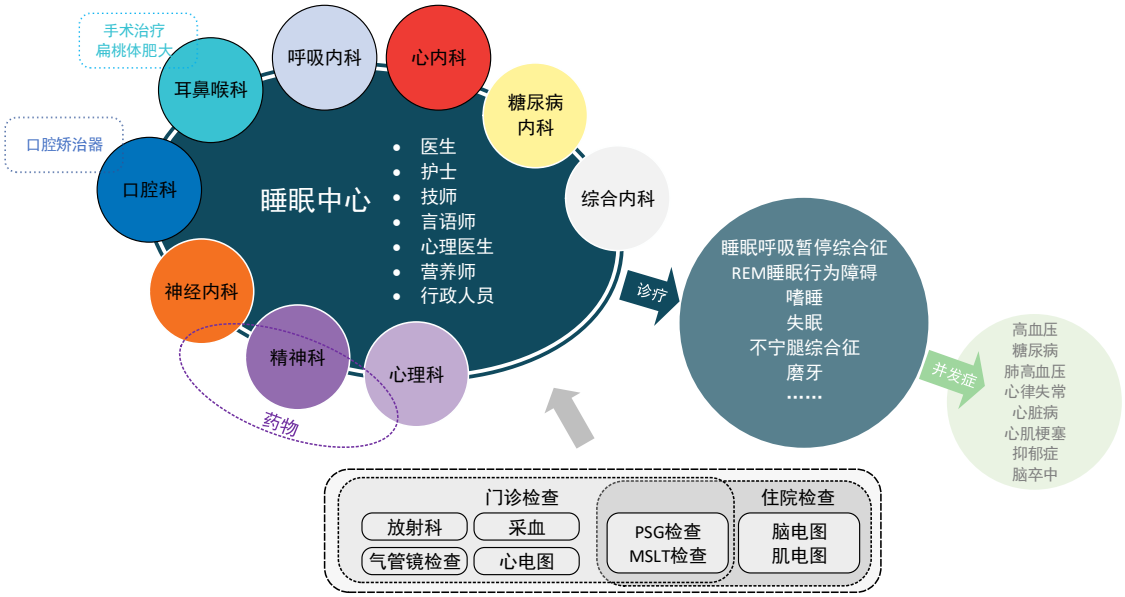


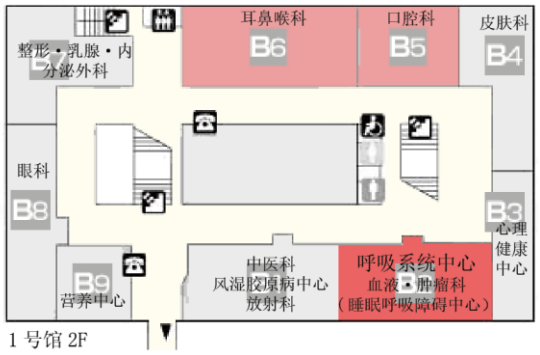
图 2-21 睡眠中心主要组成科室、关联科室和涉及医技部门关系图

图片来源：作者自绘

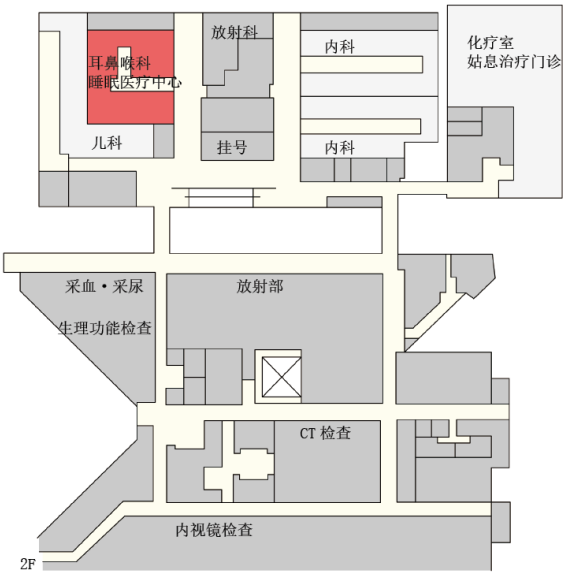
3）位置关系研究

由于睡眠中心往往需要对患者进行睡眠检测，所以一般医院会安排患者进行 1-2 日住院检测，因此部分医院会将睡眠中心设置在住院区，以方便患者诊疗；除了设置单独的睡眠中心外，部分医院会将睡眠中心分散在各优势学科中，或与相关科室邻近布置，见表 2.23。

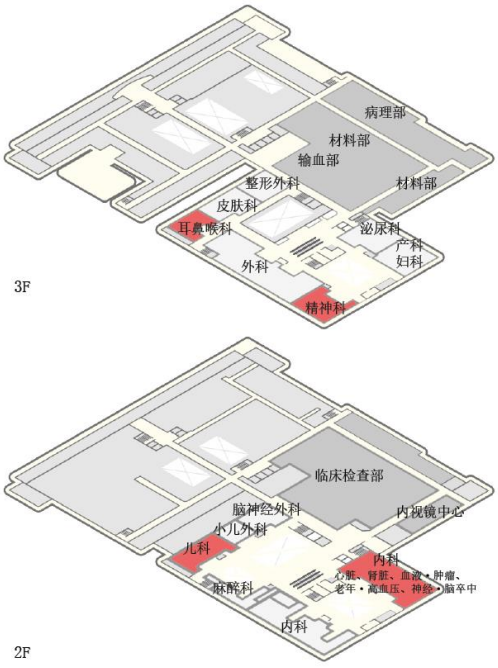
表 2.23 睡眠中心平面布局特征

布局	案例
1. 开设在不同科室	 東邦大学医療センター　大森病院 九州大学病院

中国知网 https://www.cnki.net



名古屋市立大学病院

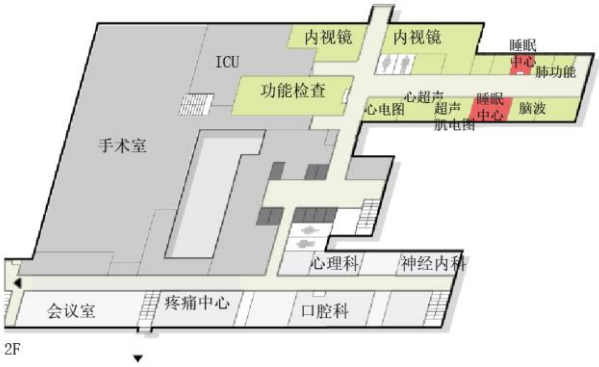


大阪大学医学部附属病院

2. 独立睡眠中心

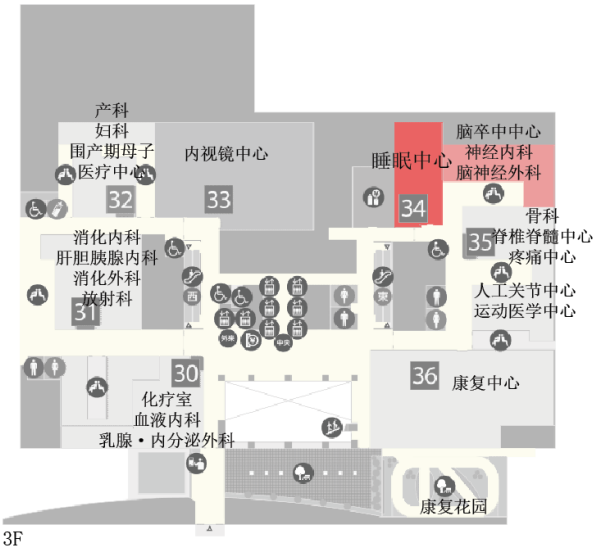
滋賀医科大学医学部附属病院

3. 与相关检查室邻近



日本大学医学部附属板橋病院

中国知网 https://www.cnki.net

4. 与相关科室邻近	 爱知医科大学病院
5. 设置在住院区	13F 餐厅 12F 外科・脑神经外科・口腔科・糖尿病内分泌内科（46 床） 11F 呼吸内科・眼科（46 床） 10F 泌尿科・耳鼻喉科・头颈部外科・妇科（46 床） 9F 骨科・整形外科・皮肤科（46 床） 8F 地域综合护理病区（46 床） 7F 心内科・消化内科病区（45 床） 6F 睡眠医疗中心（15 床） 5F 精神科、康复中心、营养管理室、医疗安全控制室、感染管理室 4F 门诊手术室、ICU・CCU（10 床）、人工透析中心、ME 中心等 3F 门诊诊室（内科、外科、耳鼻喉科、头颈部外科、妇科、眼科、整形外科）、消化中心、点滴室、采血室、生理功能检查室、药剂部、营养指导室、地域医疗合作部、医疗福祉咨询室、门诊化疗室 2F 挂号、收费、门诊诊室（骨科、脑神经外科、神经内科、皮肤科、泌尿科、口腔科、放射科）、医务科等 1F 体检中心、急救室、灾害中心、会议室、停车场、商店等 B1F PET 中心、病理检查室 大阪回生病院

注：图表自制

2.3.4 内分泌中心

1）基本情况

内分泌中心主要诊疗如甲状腺、肾上腺等内分泌疾病。选取冈山大学医院、东京女子医科大学医院和虎的门医院内分泌中心进行相关研究，具体情况见表 2.24。

表 2.24 各医院内分泌中心基本情况一览

医院名称	诊疗中心名称	包含科室	关联科室或诊疗中心	诊疗疾病	诊断	治疗
岡山大学病院	内分泌中心	内分泌内科 乳腺・内分泌外科	脑神经外科、泌尿科、妇产科、儿科、放射科	・ 甲状腺、甲状旁腺、乳腺、肾上腺、下垂体等内分泌器官分泌失调问题	内分泌功能检查 影像检查（CT、MRI、PET-CT 检查）	药物疗法、手术疗法
東京女子医科大学病院	内分泌疾病综合医疗中	高血压・内分泌内科		・ 高血压・内分泌内科（高血压、心血管内分泌代	超声检查、血液检查、	药物疗法、手

中国知网 https://www.cnki.net

	心	乳腺·内分泌外科		谢、甲状腺疾病、甲状旁腺疾病、下垂体疾病、性腺疾病、甲状旁腺疾病等） · 乳腺·内分泌外科（甲状腺、甲状旁腺肾上腺、乳腺疾病）	甲状腺功能检查	术疗法
虎の門病院	内分泌中心	内分泌内科 儿童内分泌科 乳腺·内分泌外科 间脑下垂体外科	妇产科、泌尿科、消化外科	· 青春期疾病 · 间脑下垂体疾病 · 甲状腺疾病 · 肾上腺疾病 · 性腺功能异常 · 甲状旁腺疾病 · 代谢性骨疾病 · 内分泌性高血压等	超声等	药物疗法、手术疗法

注：表格自制

2）涉及科室和医技

内分泌中心主要由内分泌内科和乳腺·内分泌外科构成，涉及检查主要为检验科检查、影像检查和超声检查，可与儿科合作诊疗儿童生长发育问题，与泌尿科合作诊疗肾上腺分泌问题等，见图 2-22。

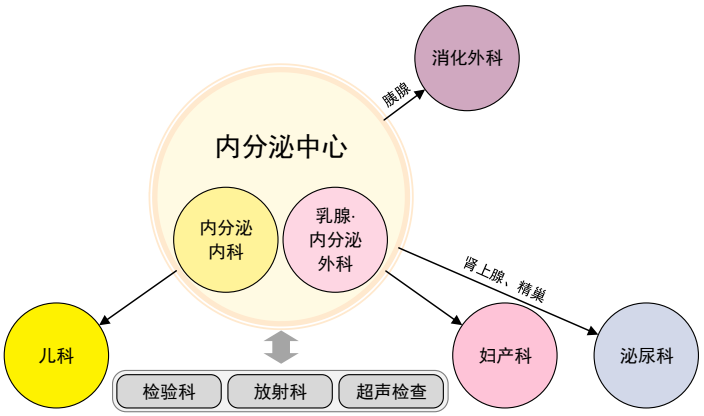


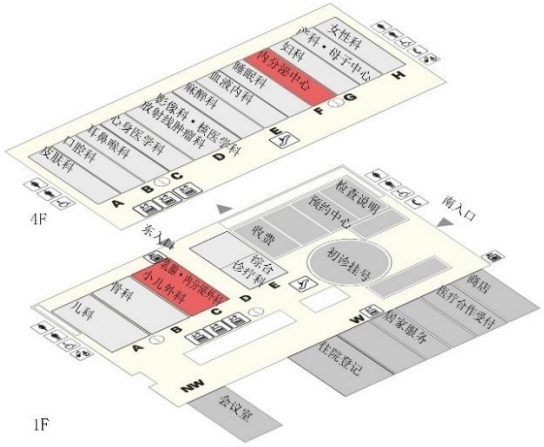
图 2-22 内分泌中心主要组成科室、关联科室和涉及医技部门关系图

图片来源：作者自绘

3）位置关系研究

内分泌中心主要布局方式包括内分泌内外科分开布局和合并布局两种，见表 2.25。

表 2.25 内分泌中心平面布局特征

布局	案例
1. 内分泌内科、外科分开布置	

東京女子医科大学病院

中国知网 https://www.cnki.net

2. 内分泌内科、外科合并布置	 岡山大学病院

注：图表自制

2.3.5 心・脑血管中心

1）基本情况

心・脑血管中心主要治疗全身血管疾病，包括脑血管、心血管、腹部血管和四肢血管疾病，血管疾病易引发脑卒中、心绞痛、心肌梗塞和心律失常。在日本，心脏病与心血管疾病死亡人数之和已相当于恶性肿瘤死亡人数。高龄社会生活习惯病和糖尿病患者增多，导致动脉粥样硬化患者增多，使患者可能同时患有数个疾病。目前心脏・血管疾病已经是欧美国家死亡的主要原因，日本也可以毫不夸张的说进入了心、脑血管疾病时代。在所研究医院中，有 10 所医院设置心・脑血管中心，如图 2-23，为方便分析统称为心・脑血管中心。

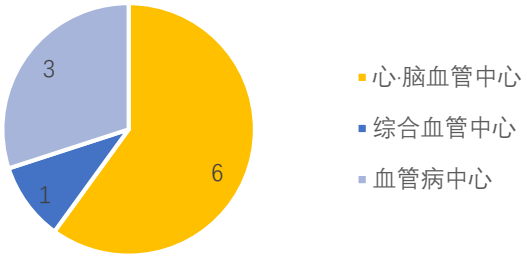


图 2-23 心・脑血管中心名称数量统计图
图片来源：作者自绘

综合考虑各医院心・脑血管中心的科室配置、诊疗特点和平面布局特征，选取福井县立医院和立川综合医院等在内的 5 所医院进行相关分析研究，基本情况见表 2.26。

表 2.26 各医院心・脑血管中心基本情况一览

医院名称	诊疗中心名称	包含科室	关联科室或诊疗中心	诊疗疾病	诊断	治疗
福井県立病院	脑心脏血管中心	心脏科 心血管外科 脑神经外科		・ 全身血管疾病（主要是动脉硬化）	CT、MRI 等	手术等
立川総合病院	心脏・脑血管中心	心内科 心血管外科 脑神经外科	急救科 放射科	・ 心脏、脑疾病，全身血管疾病及糖尿病血管并发症	心电图、心脏超声、检验科、放射	手术等

中国知网 https://www.cnki.net

		神经内科 心血管放射科 内分泌内科 肾内科			科等	
福冈和白病院	心脏·脑·血管中心 HNVC	心内科 心血管外科 脑血管外科 血管放射科		· 糖尿病·高血压·高血脂·肥胖引起的血管病 · 心绞痛·心肌梗塞·脑梗塞·闭塞性动脉硬化引起的血管病	心电图、超声等	手术等
熊本赤十字病院	综合血管中心	心血管外科 放射科	心内科 脑神经外科 神经内科 骨科	· 生活习惯病硬气的全身血管病（闭塞性动脉硬化症、动脉瘤、静脉瘤、动脉畸形等）	超声等	血管内治疗等
県立広島病院	脑·心血管中心	脑神经内科 心内科 脑神经外科 心脏外科	肾内科 糖尿病·内分泌内科 麻醉科 急救科 放射科 康复科 营养管理科	· 高血压、高血糖、高胆固醇等导致的动脉硬化，进而导致脑血管、心脏血管、腹部血管、四肢血管疾病产生，导致脑卒中、心绞痛、心肌梗塞、心律失常等。	头部 MRI、颈部 MRA、颈动脉超声、冠动脉 CT、ABI、血管 CT 等	手术等

注：表格自制

2）涉及科室和医技

心·脑血管中心主要由心内科、心血管外科、脑神经外科和神经内科合作诊疗，涉及相关医技检查为头部 MRI、颈动脉超声、CT 等检查，常与肾内科、糖尿病内科和放射科合作诊疗，见图 2-24。

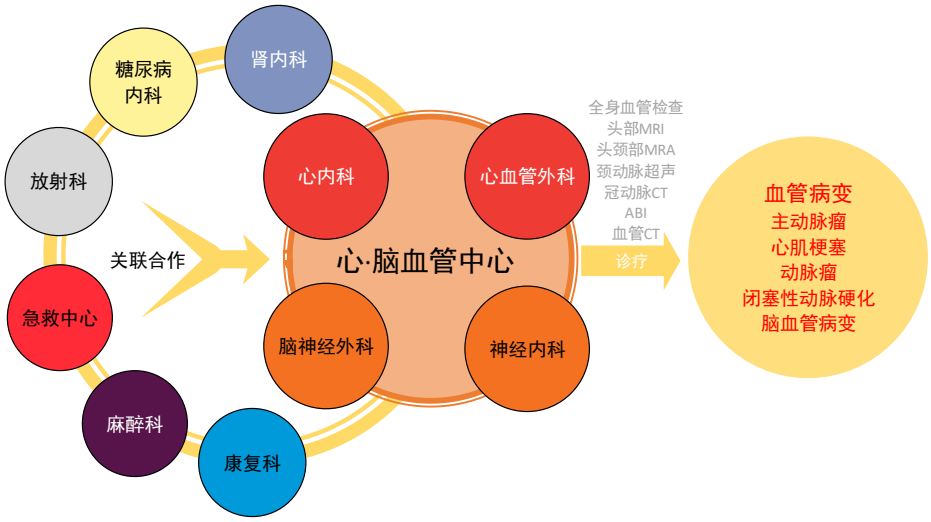


图 2-24 心·脑血管中心主要组成科室、关联科室和涉及医技部门关系图
图片来源：作者自绘

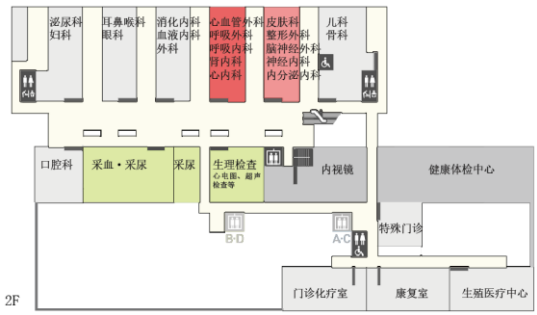
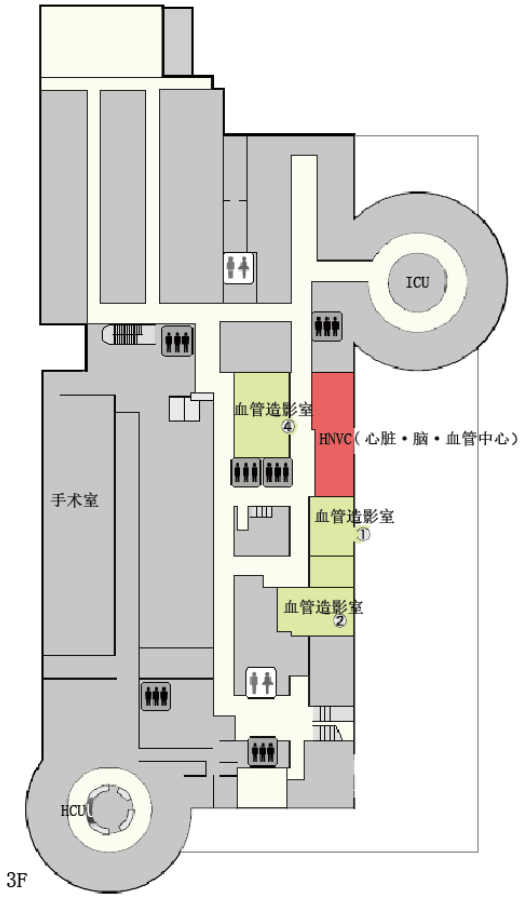
3）位置关系研究

心·脑血管中心布局呈现两种方向，一是门诊心、脑相关科室邻近布置，二是成立专门的心·脑血管诊疗中心，由多科专家会诊，见表 2.27。

表 2.27 心·脑血管中心平面布局特征

布局	案例

中国知网 https://www.cnki.net

1. 邻近相关科室	 福井県立病院	 立川総合病院
2. 独立区域布置	 福岡和白病院	

注：图表自制

2.3.6 慢性创伤中心

1）基本情况

慢性创伤中心主要治疗包括糖尿病足病、静脉或动脉闭塞引起的静脉曲张等慢性创伤疾病。在所研究医院中共 19 所医院设置诊疗慢性创伤类疾病中心，其中以慢性创伤中心命名的中心数较多，为便于研究，现将与诊疗慢性创伤相关中心，统称为慢性创伤中心，如图 2-25。

中国知网 https://www.cnki.net

图 2-25 慢性创伤相关中心名称数量统计图

图片来源：作者自绘

综合考虑各医院设置慢性创伤中心的科室配置、诊疗特点和平面布局特征，选取河内综合医院和新东京医院等在内的 5 所医院进行相关研究分析，基本情况见表 2.28。

表 2.28 各医院慢性创伤中心基本情况一览

医院名称	诊疗中心名称	包含科室	关联科室或诊疗中心	诊疗疾病	诊断	治疗
河内総合病院	创伤中心	整形外科足病门诊	心血管中心（心内科、心血管外科）、透析中心、肾糖尿病内科、脑卒中中心（脑神经外科）、临床检查部、放射科	· 糖尿病引起的皮肤溃疡 · 闭塞性动脉硬化 · 脑血管障碍 · 感染症、胶原病 · 褥疮	血管超声非造影 MRA、MRI 检查 造影 CT 检查 机能评估：ABI 检查、SPP 检查	局部治疗、血行再建治疗、内科治疗、基础疾病治疗、并发症治疗
新东京病院	创伤治疗中心	整形外科	心内科、心血管外科、糖尿病内科、放射科、康复科	· 慢性创伤（难治性皮肤溃疡） · 糖尿病性溃疡 · 闭塞性动脉硬化导致缺血性溃疡 · 静脉曲张引起的小腿溃疡等	采血（糖尿病确认）、四肢血流评估（ABI、SPP 测量、超声或 CT、通过 MRI 血管通畅确认），怀疑伤口感染（细菌培养、MRI 骨髓炎评估）	心内科与心外科合作血管重建治疗，康复科康复，有需要进行透析治疗
大雄会第一病院	创伤・血管中心	血管外科	整形外科、皮肤科、泌尿科、内分泌・糖尿病内科、心内科、心血管外科、骨科、康复科、临床检查部	· 急性闭塞性动脉疾病 · 慢性闭塞性动脉疾病 · 静脉疾病 · 先天性血管形成异常 · 糖尿病性坏疽、透析患者足病变	见听：血压脉波检查触	外科治疗、血管内治疗
関西電力病院	足部护理中心	糖尿病・代谢・内分泌中心	糖尿病・代谢・内分泌中心、整形外科、皮肤科、心内科、肾内科	· 糖尿病足预防治疗 · 创伤治疗	ABI、SPP 检查等	团队医疗
荻窪病院	足诊断・治疗中心	骨科	骨科、整形外科、皮肤科、心内科、心外科、糖尿病内科	· 拇指外翻、足关节损伤、脚踝部位畸形 · 足部溃疡、坏疽	MRI、CT 检查 血流量评估	足外科：关节镜和内视镜手术治疗 足部护

中国知网 https://www.cnki.net

						理门诊：多部门合作治疗

注：表格自制

2）涉及科室和医技

由于不同患者慢性创伤的病因不同，慢性创伤中心往往以团队医疗的形式对患者进行护理和治疗，不同科室在慢性创伤的治疗中承担不同的工作，如心内科和心血管外科主要对慢性创伤患者进行血行再建治疗；对患有糖尿病的患者，糖尿病内科医生帮助患者进行血糖控制和全身管理……。慢性创伤中心涉及主要医技检查为血液检查、ABI 检查等，见图 2-26。

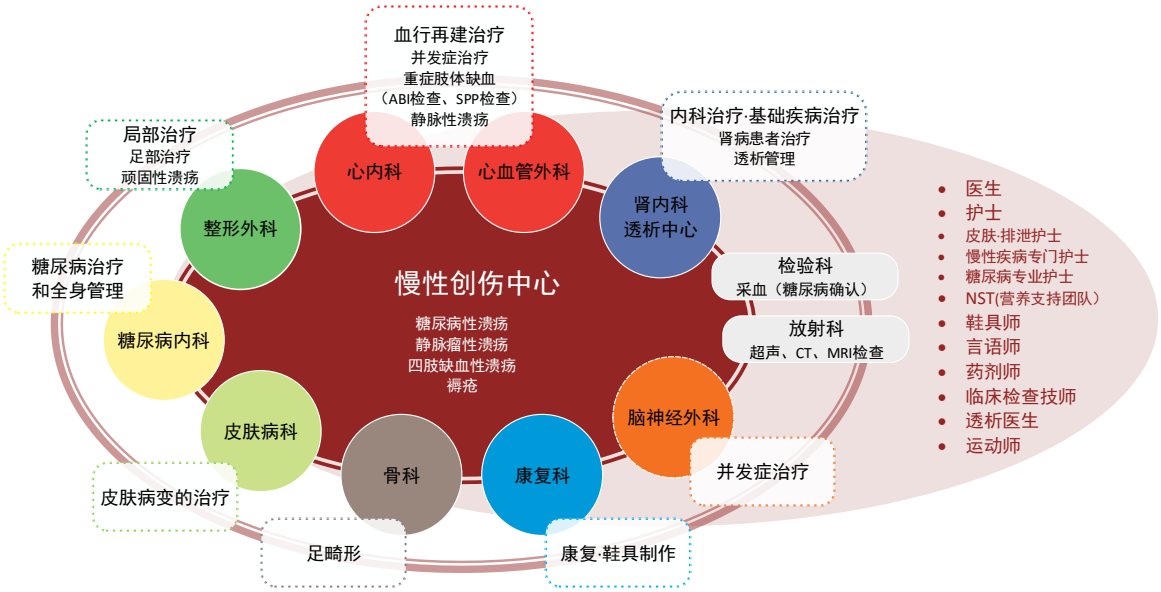
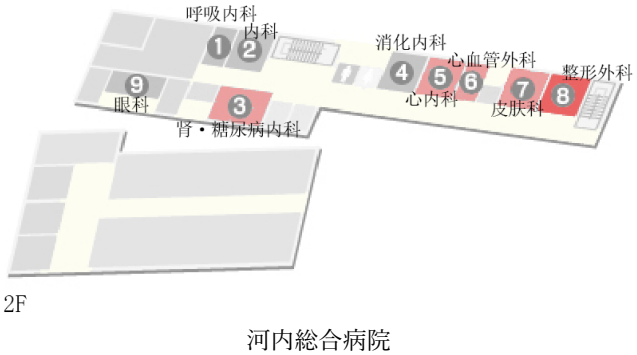


图 2-26 慢性创伤中心主要组成科室、关联科室和涉及医技部门关系图
图片来源：作者自绘

3）位置关系研究

慢性创伤中心倾向于设置在一个科室内，并与相关科室邻近布置，见表 2.29。

表 2.29 慢性创伤中心平面布局特征

布局	案例
1. 邻近相关科室	 河内総合病院

注：图表自制

中国知网 https://www.cnki.net

2.3.7 脊椎脊髓中心

1）基本情况

脊椎脊髓相关中心的设立主要诊疗脊椎脊髓疾病。由于脊椎脊髓类疾病既涉及运动器官又涉及运动神经，一般来讲骨科医生可以稍微处理一点涉及神经的疾病，神经科医生也可以处理一点涉及运动器官的疾病。脊椎脊髓中心的设立，则是通过骨科与脑神经外科合作，对患者进行全面诊疗。其中骨科负责脊椎，脑神经外科负责脊髓。

在所研究医院中共 40 所医院设置脊椎脊髓相关中心，包括脊椎脊髓中心、脑・脊髓外科中心等，其中以脊椎脊髓中心命名的医院占一半以上，见图 2-27。为方便研究，现将与诊疗脊椎脊髓相关疾病的中心，统称为脊椎脊髓中心。

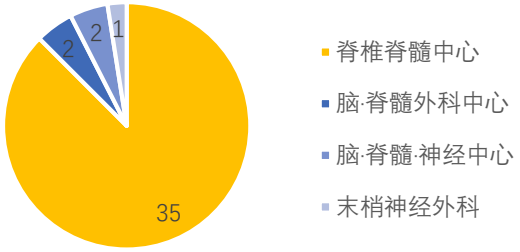


图 2-27 脊椎脊髓相关中心名称数量统计图
图片来源：作者自绘

综合考虑各医院脊椎脊髓中心科室配置、诊疗特点和平面布局特征，选取国际医疗福祉大学三田医院、爱知医科大学医院和东京新宿医疗中心的脊椎脊髓中心进行相关分析研究，基本情况统计见表 2.30。

表 2.30 各医院脊椎脊髓中心基本情况一览

医院名称	诊疗中心名称	包含科室	关联科室或诊疗中心	诊疗疾病	诊断	治疗
国際医療福祉大学三田病院	脊椎脊髓中心	骨科 脑神经外科		・ 脊柱侧弯 ・ 颈椎病 ・ 韧带骨化 ・ 类风湿性脊椎炎 ・ 感染性疾病 ・ 脊椎・脊髓肿瘤等		微创手术治疗
愛知医科大学病院	脊椎脊髓中心	脑外科 骨科	神经内科 放射科 疼痛中心 康复科・运动疗愈中心	・ 腰部脊柱管狭窄症、腰椎间盘突出、颈椎间盘突出、脊椎脊髓肿瘤等		手术治疗等
東京新宿メディカルセンター	脊椎脊髓中心	脊椎脊髓外科	骨科 脑神经外科	・ 腰痛、颈部痛、脊椎压迫骨折、脊髓内外肿瘤、颈髓症、韧带骨化症、脊柱管狭窄症、椎间盘突出、侧弯症等	X 线、MRI、脊髓造影	微创手术

注：表格自制

2）涉及科室和医技

脊椎脊髓中心主要由骨科和脑神经外科合作诊疗，主要涉及医技检查为 X 线、CT 等放射科检查，其主要与康复科和疼痛中心合作进行患者的治疗康复和疼痛管理。见图 2-28。

中国知网 https://www.cnki.net

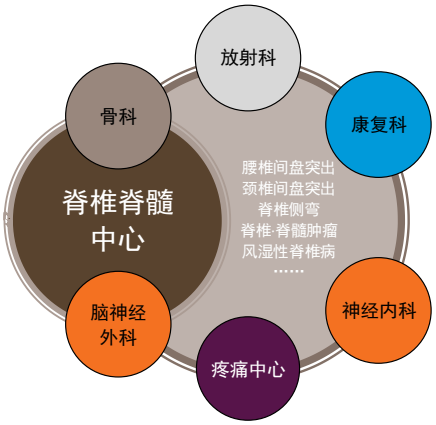
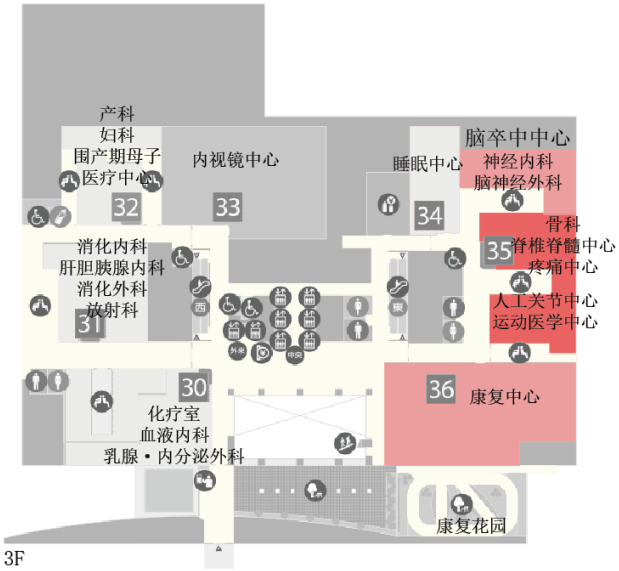


图 2-28 脊椎脊髓中心主要组成科室、关联科室和涉及医技部门关系图
图片来源：作者自绘

3）位置关系研究

脊椎脊髓中心往往邻近骨科和脑神经外科布置，以方便医生合作诊疗，根据各医院患者多少和科室优势，也可单设脊椎脊髓中心，见表 2.31。

表 2.31 脊椎脊髓中心平面布局特征

布局	案例	
1. 邻近相关科室	国際医療福祉大学三田病院	 愛知医科大学病院

中国知网 https://www.cnki.net

注：图表自制

2.3.8 骨科中心

1）基本情况

人体主要是由骨骼支撑，骨科疾病相关中心成立主要是诊疗骨骼相关疾病。在所研究医院中，设置诊疗骨科疾病相关中心 85 个，包括人工关节中心、关节外科中心和骨科中心等，如图 2-29。由于涉及骨科疾病中心种类繁多，为便于研究分析，现将与诊疗骨科疾病相关中心统称为骨科中心。

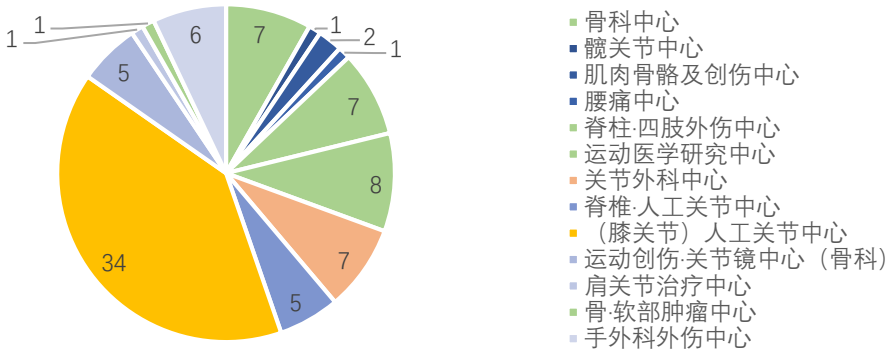


图 2-29 骨科相关中心名称数量统计图
图片来源：作者自绘

综合考虑各医院骨科中心的科室配置、诊疗特点和平面布局特征，选取名铁医院、仙台西多贺医院和松波综合医院等在内的 8 所医院进行相关研究，基本情况见表 2.32。

中国知网 https://www.cnki.net

表 2.32 各医院骨科中心基本情况一览

医院名称	诊疗中心名称	包含科室	关联科室或诊疗中心	诊疗疾病	诊断	治疗
名鉄病院	关节镜・运动骨科中心	骨科		・ 肩（肩腱板断裂、反复性肩关节脱臼、肩关节损伤） ・ 肘：变形性关节症 ・ 膝：膝前十字韧带断裂、膝半月板损伤等 ・ 其他：足关节损伤	MRI、CT、超声等	关节镜手术等
仙台西多賀病院	股关节中心 脊椎脊髓疾病研究中心 风湿病研究中心	骨科 风湿科		・ 脊椎疾病(腰椎管狭窄症、腰椎间盘突出、腰椎变形侧弯等腰椎疾病，颈椎性脊髓症、颈椎间盘突出等颈椎疾病 ・ 关节疾病（类风湿性关节炎、风湿病、关节炎）		手术等
松波総合病院	脊椎外科中心 关节外科中心 风湿病中心	骨科	康复科	・ 骨折 ・ 运动障碍 ・ 关节外科(肩关节、肘关节、手关节、股关节、膝关节、足关节疾) ・ 脊椎外科 ・ 风湿病 ・ 骨质疏松	CT 等	关节镜手术等
岡山ろうさい病院	脊椎脊髓中心 腰痛中心 人工关节中心	骨科	康复科 急救科	・ 关节外科（慢性风湿性关节病等） ・ 脊椎外科（腰椎间盘突出、骨质疏松等） ・ 外伤（骨折、脱臼等） ・ 手外科（腱断裂、腱鞘炎等）	关节镜检查、MRI 等	微创手术
大阪急性期・総合医療センター	人工关节中心	骨科（关节外科、脊椎外科、上下肢外伤、手外科）	康复科 免疫风湿科 麻醉科 影像诊断科	・ 变形性股关节症、变形性膝关节症、风湿关节病、股骨头快四等 ・ 高龄患者手术前并发症筛查	X 线检查、CT 检查、MRI 检查、骨显像检查	微创手术、日间手术
北里大学北里研究所病院	脊椎中心 人工关节・软骨移植中心 综合运动医学中心	骨科	康复科	・ 变形性关节病（脊椎、膝关节、股关节、足关节、肩关节等各关节）、慢性风湿性关节炎、骨质疏松、各部位骨折、关节脱臼、腱断裂、脊椎、膝关节韧带损伤、半月板损伤、足关节韧带损伤等。	X 线检查、X 线断层摄影、超声检查、CT、MRI、肌电图、脊髓造影、椎间盘造影、MRI、骨密度检查、血液检查	手术等
倉敷中央病院	人工关节中心	骨科	康复科	・ 股关节、膝关节疾病 ・ 变形性关节病 ・ 外伤性关节病 ・ 关节风湿病 ・ 股骨头坏死等 ・ 骨折 ・ 手外科	造影检查	手术等
愛知医科大学病院	脊椎脊髓中心 人工关节中心	骨科	（脑神经外科 神经内科 放射科 疼痛中心	・ 腰部脊柱管狭窄症、腰椎间盘突出等颈椎・腰椎疾病 ・ 关节炎、类风湿性关节炎、股骨头坏死等等		手术等

中国知网 https://www.cnki.net

			康复科 运动疗愈中心 急救中心）[1]			

注：1）在爱知医科大学病院，脊椎脊髓中心关联科室主要为骨科、脑神经外科、神经内科、放射科、疼痛中心、康复科、运动疗愈中心；人工关节中心关联科室为骨科、康复科、运动疗愈中心；骨科关联科室为急救中心。

表格自制

2）涉及科室和医技

骨科中心主要由骨科构成，主要涉及医技检查为 X 线、CT 和 MRI 等放射线检查、超声检查和骨密度检查等，可与脑神经外科合作成立脊椎脊髓中心，与急救中心合作诊疗急性手等部位骨折的患者与康复科合作进行患者康复等，见图 2-30。

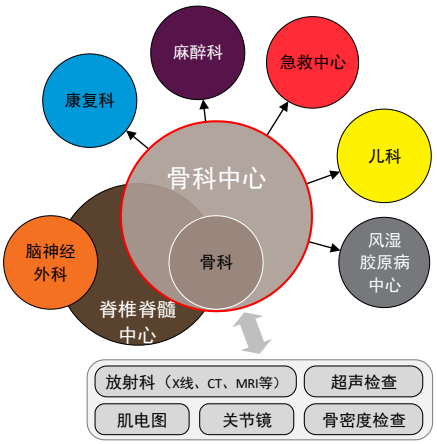


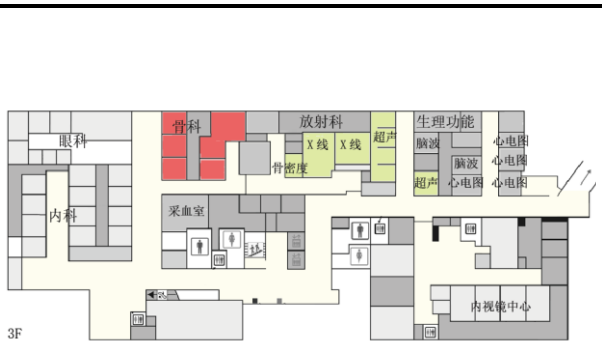
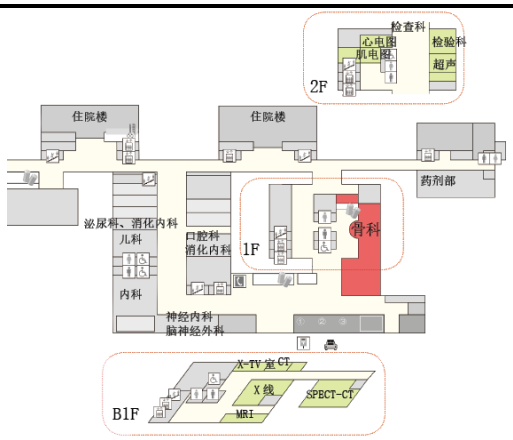
图 2-30 骨科中心主要组成科室、关联科室和涉及医技部门关系图

图片来源：作者自绘

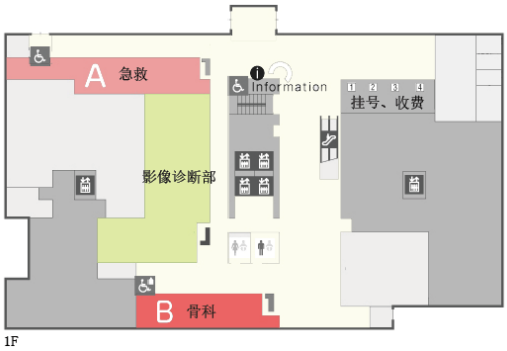
3）位置关系研究

骨科中心的布局一般以邻近相关诊断科室为宜，如邻近放射科；有医院为方便急性骨折患者，与急救中心邻近布置；若为方便患者康复，则可考虑与康复中心邻近布置，见表 2.33。

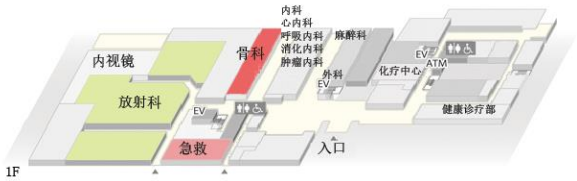
表 2.33 骨科中心平面布局特征

布局	案例
1. 邻近相关检查室	 名鉄病院  仙台西多賀病院

中国知网 https://www.cnki.net

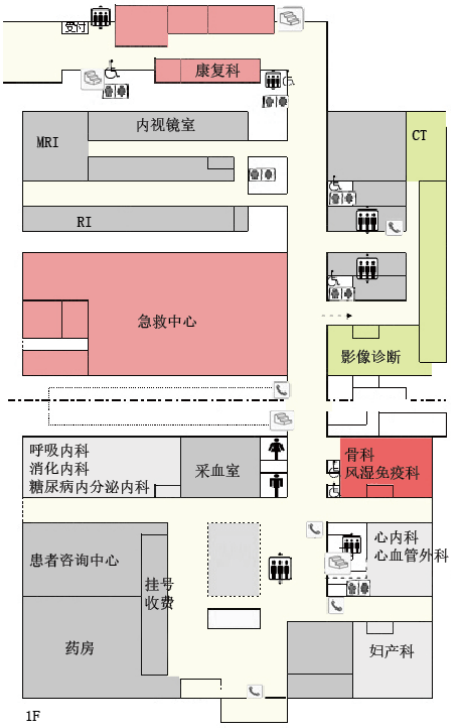


松波総合病院



岡山ろうさい病院

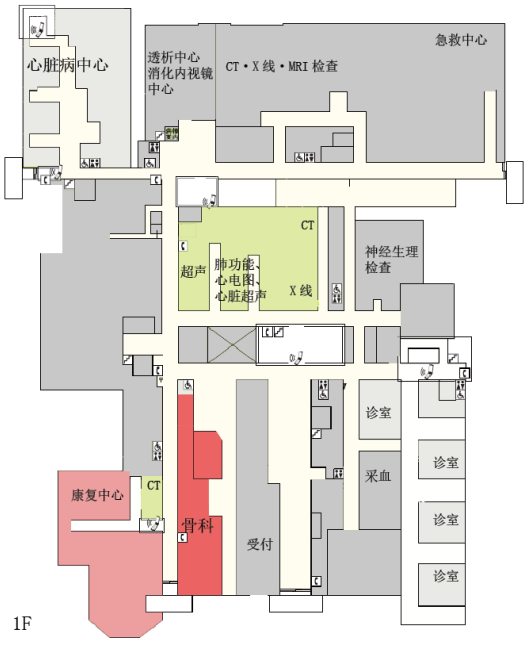
2. 邻近急救中心



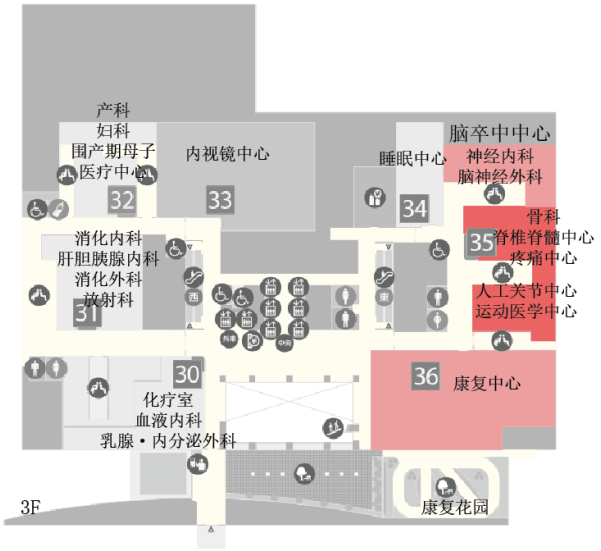
大阪急性期・総合医療センター

北里大学北里研究所病院

3. 邻近康复中心或其他科室



倉敷中央病院



愛知医科大学病院

注：图表自制

中国知网 https://www.cnki.net

2.3.9 整形中心

1）基本情况

整形中心主要是对患者伤口处进行整形修复。对所研究医院整形中心进行研究分析，基本情况见表 2.34。

表 2.34 各医院整形中心基本情况一览

医院名称	诊疗中心名称	包含科室	关联科室或诊疗中心	诊疗疾病	诊断	治疗
総合東京病院	整形・美容外科中心	整形外科・美容外科	口唇腭裂中心	・ 烧伤 ・ 面部骨折・外伤 ・ 口唇腭裂 ・ 先天手足异常 ・ 母斑・血管瘤・良性肿瘤 ・ 瘢痕 ・ 褥疮 ・ 整容手术 ・ 皮肤美容等		显微手术、激光治疗、局部麻醉等
時計台記念病院	整形外科・创伤治疗中心	整形外科	心脏病中心[1)]	・ 口唇腭裂 ・ 皮肤良性・恶性肿瘤重建 ・ 整形外科所有疾病，如瘢痕修正 ・ 急性期创伤治疗（如急救中心烧伤、面部骨折） ・ 慢性期创伤、褥疮治疗（如糖尿病足坏疽）	皮肤灌流压测量（PAD3000）（进行血流评估）	手术治疗
東大和病院	整形中心	整形外科		・ 黑色瘀伤（老年斑） ・ 血管瘤 ・ 皱纹 ・ 面部骨折和损伤 ・ 眼睑下垂 ・ 双眼皮 ・ 瘢痕		手术治疗、激光治疗

注：1）对足趾坏疽，该医院整形外科・创伤治疗中心与心脏中心合作通过重建血液循环，尽可能保留下肢治疗，整形外科通过植皮等手术科进行治疗。

表格自制

2）涉及科室、中心和医技

整形中心主要包含科室为整形外科和美容外科，主要医技检查基本在科室内进行，当诊疗某类特殊疾病时，需要与其他科室合作诊疗，如与口腔科合作诊疗口唇腭裂；与慢性创伤中心合作诊疗慢性创伤；与急救中心合作诊疗急性创伤和烧伤；与皮肤科合作诊疗皮肤病等，见图 2-31。

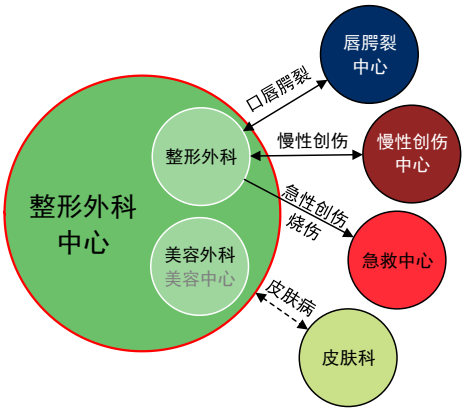


图 2-31 整形中心主要组成科室、关联科室和涉及医技部门关系图

图片来源：作者自绘

中国知网 https://www.cnki.net

3）位置关系研究

整形中心的平面布局相对较为灵活，若考虑与其他科室或中心合作诊疗，宜将其与相关科室或中心邻近布置。

2.3.10 女性骨盆底中心

1）基本情况

女性骨盆中有膀胱、尿道、子宫、阴道、直肠和肛门等，由骨盆底支撑，骨盆底容易受分娩、老化影响而受伤或松动，支撑不起骨盆内器官重量，而突出体外，造成骨盆器官脱垂，引起排尿困难，进而使得生活质量下降。女性骨盆底中心的建立力在整合妇产科和泌尿科等科室，为女性骨盆底患者提供一站式诊疗服务。

综合考虑各医院女性骨盆底中心科室配置、诊疗特点和平面布局特征，选取市立砺波综合医院等在内的 3 所医院进行研究分析，基本情况见表 2.35。

表 2.35 各医院女性骨盆底中心基本情况一览

医院名称	诊疗中心名称	包含科室	关联科室或诊疗中心	诊疗疾病	诊断	治疗
市立砺波総合病院	女性骨盆底再建中心	泌尿科	妇科 大肠・肛门外科	・ 盆骨器官脱垂 ・ 盆骨器官脱垂伴随膀胱、直肠功能障碍		手术治疗等
北アルプス医療センターあづみ病院	女性骨盆底医学中心	泌尿科 妇产科		・ 盆腔器官脱垂 ・ 尿失禁	超声检查	微创手术等
日生病院	女性骨盆底中心	妇产科 泌尿科 消化外科	康复科 营养科	・ 盆骨器官脱垂 ・ 腹压性尿失禁		手术治疗、保守治疗（康复指导、营养指导）

注：表格自制

2）涉及科室和医技

女性骨盆底中心主要由妇产科、泌尿科和消化外科合作诊疗，主要涉及医技检查为超声健康，往往与营养科和康复科合作，对骨盆底患者进行饮食指导和康复训练，见图 2-32。

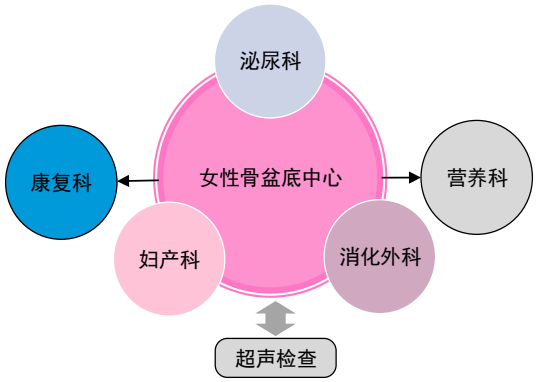


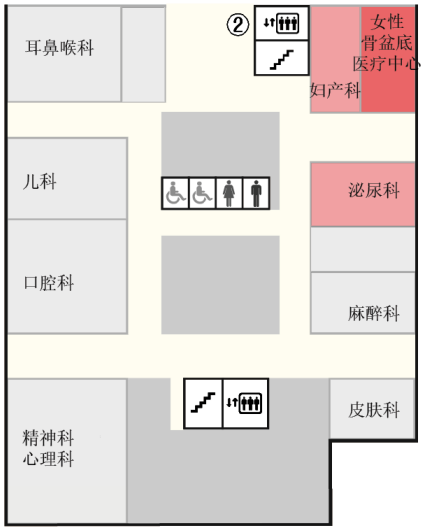
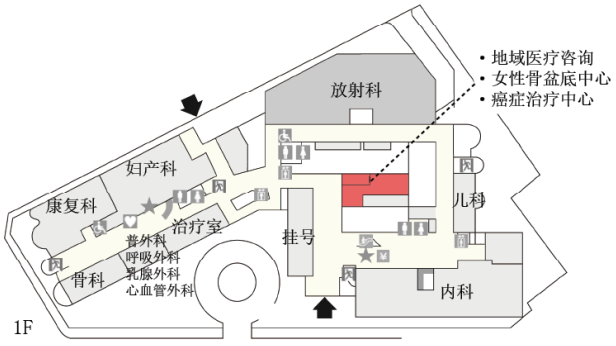
图 2-32 女性骨盆底中心主要组成科室、关联科室和涉及医技部门关系图
图片来源：作者自绘

3）位置关系研究

女性骨盆底中心平面布局可分为三类：1.设置于不同科室内；2.与相关科室相邻；3.独立设置，见表 2.36。

中国知网 https://www.cnki.net

表 2.36 女性骨盆底中心平面布局特征

布局	案例
1.设置于不同科室内	 市立砺波総合病院
2.邻近相关科室	 北アルプス医療センター　あづみ病院
3.独立设置	 日生病院

注：图表自制

中国知网 https://www.cnki.net

2.3.11 生殖医疗中心

1）基本情况

生殖医疗中心主要解决夫妻双方不孕不育的问题。传统上不孕不育分开在相关科室检查，男性方面在泌尿科受诊，女性在妇产科检查，使得信息不能同步共享，给患者带来诸多不便。成立生殖医疗中心，既可以方便夫妇双方诊疗，又便于妊娠后续的服务工作，如咨询如何抚养孩子等问题。

综合考虑各医院设置生殖医疗中心的科室配置、诊疗特点和平面布局特征，选取圣路加国际医院等 4 所医院生殖医疗中心进行研究分析，基本情况见表 2.37。

表 2.37 各医院生殖医疗中心基本情况一览

医院名称	诊疗中心名称	包含科室	关联科室或诊疗中心	诊疗疾病	诊断	治疗
聖路加国際病院	生殖医疗中心	妇产科	女性综合诊疗部	· 不孕不育 · 癌症患者生殖医疗	腹腔镜、宫腔镜检查等	人工授精、排卵诱导、手术等
千葉メディカルセンター	不孕不育治疗中心	妇产科	泌尿科	· 不孕不育	宫颈癌检查、超声检查、采血检查、腹腔镜、宫腔镜检查、泌尿科检查	排卵诱导、人工授精等
関西医科大学附属病院	生殖医疗中心	妇产科 泌尿科		· 不孕不育	妇产科：女性不孕检查 泌尿科：男性不育检查	生殖辅助医疗、人工授精、体外受精等
大阪大学医学部附属病院	生殖医疗中心	泌尿科 妇产科	围产期母子医疗中心 儿科 遗传诊疗部	· 不孕不育	妇产科：女性不孕检查 泌尿科：男性不育检查	体外受精、显微授精等
東邦大学医療センター 大森病院	生殖医学中心		妇产科 泌尿科	· 不孕不育 · 男性不育、性功能障碍	超声检查、内分泌检查、宫腔镜、腹腔镜检查等	人工授精、体外受精、显微授精、胚胎移植等

注：表格自制

2）涉及科室和医技

生殖医疗中心主要由妇产科和泌尿科合作诊疗，主要涉及医技检查为超声检查、血液检查、遗传检查等。在怀孕后，通过与周产期母子医疗中心合作，确保母子的安全，产后与儿科合作，商讨抚育儿童的问题。见图 2-33。

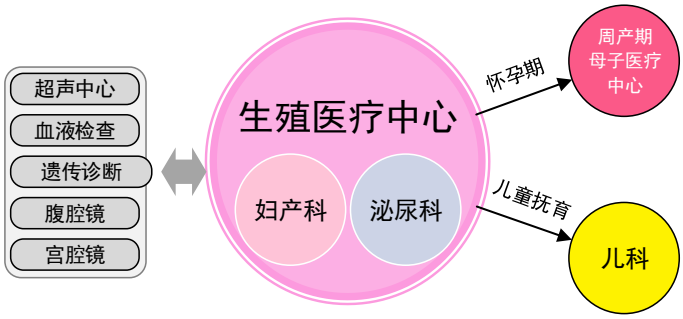


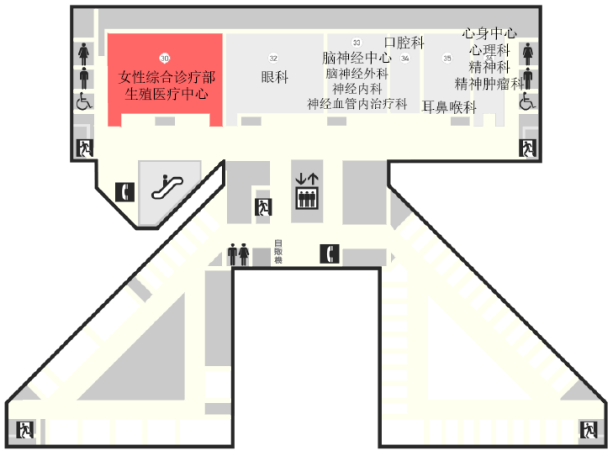
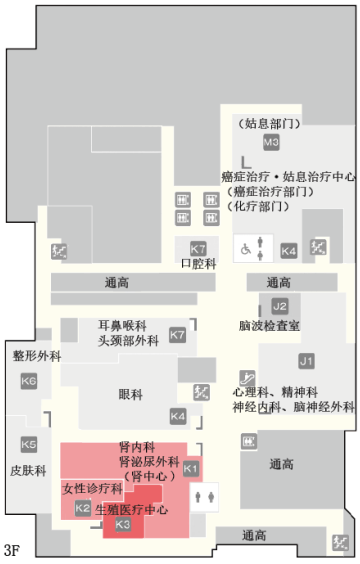
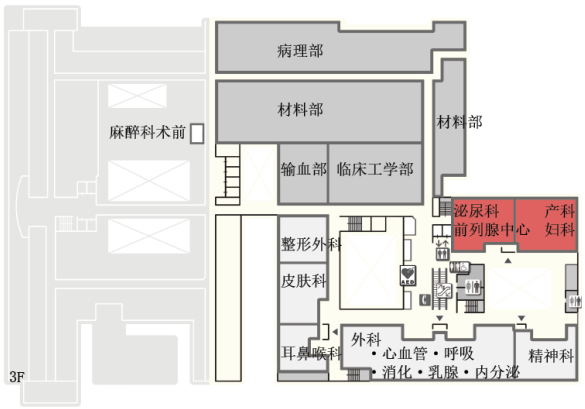
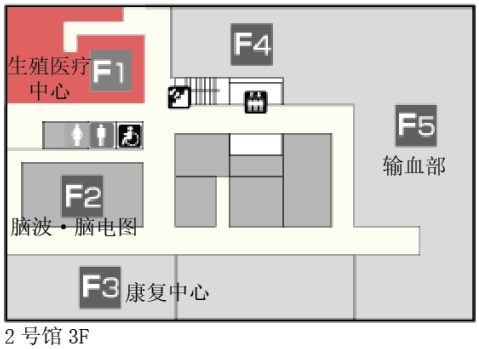
图 2-33 生殖医疗中心主要组成科室、关联科室和涉及医技部门关系图
图片来源：作者自绘

中国知网 https://www.cnki.net

3）位置关系研究

出于对患者隐私的考虑，生殖医疗中心往往单独布置，或邻近妇产科和泌尿科布局，或于妇产科内设置，见表 2.38。

表 2.38 生殖医疗中心平面布局特征

布局	案例
1.邻近妇产科	 聖路加国際病院 千葉メディカルセンター
2.邻近妇产科和泌尿科	 関西医科大学附属病院  大阪大学医学部附属病院
3.独立设置	 2 号馆 3F 東邦大学医療センター　大森病院

注：图表自制

中国知网 https://www.cnki.net

2.3.12 周产期母子医疗中心

1）基本情况

周产期母子医疗相关中心的设立主要是为了保证孕妇的正常分娩和孕妇与新生儿的安全。在所研究医院中，设置周产期母子医疗相关中心共 91 个，包括周产期母子医疗中心、妇产科·助产中心和新生儿中心等，见图 2-34。其中以周产期母子医疗中心命名的中心 79 个，占所有中心的大多数，为便于分析研究，现将周产期母子医疗相关中心统称为周产期母子医疗中心。

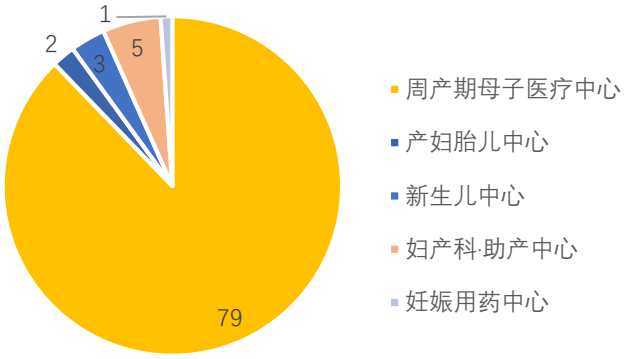


图 2-34 周产期母子医疗中心相关中心名称数量统计图
图片来源：作者自绘

综合考虑各医院周产期母子医疗中心的科室配置、诊疗特点和平面布局特征，选取爱知医科大学医院、东京大学附属医院和宇治德洲会医院等在内的 6 所医院进行相关研究，基本情况见表 2.39。

表 2.39 各医院周产期母子医疗中心基本情况一览

医院名称	诊疗中心名称	包含科室	关联科室或诊疗中心	诊疗疾病	诊断	治疗
愛知医科大学病院	周产期母子医疗中心	围产期医疗部门 新生儿集中治疗部门		· 并发症患者妊娠 · 妊娠管理 · 胎儿异常诊断	超声、妊娠血管内皮机能检查（FMD）	
東京大学医学部附属病院	综合周产期母子医疗中心	产科		· 妊娠并发症 · 不育症 · 胎儿异常 · 高龄妊娠·遗传性疾病合并妊娠	遗传检查、超声检查	不育症治疗、胎儿治疗
宇治徳洲会病院	地域周产期母子医疗中心	妇产科	儿科	· 顺产 · 剖腹产		
高知医療センター	综合周产期母子医疗中心	产科部 新生儿部	儿科 小儿外科 麻醉科	· 早产 · 并发症产妇进行妊娠和分娩管理 · 正常妊娠·分娩 · 孕妇管理 · 孕妇·胎儿管理 · 胎儿疾病	血液检查、超声检查	手术等
名古屋市立西部医療センター	周产期医疗中心	孕妇·婴儿诊疗部门 NICU	产科 儿科 小儿外科 急救科	· 孕妇分娩异常 · 胎儿·新生儿异常		
東京慈恵医科大学附属病院	综合母子健康医疗中心	产科 生殖内分泌		· 不孕不育 · 助产门诊	超声、遗产检查	

中国知网 https://www.cnki.net

		科 儿科		· 婴儿健诊、儿童康复、遗传咨询、青春期门诊、早产儿		

注：表格自制

2）涉及科室和医技

周产期母子医疗中心的主要构成科室为产科和新生儿科，主要涉及医技检查为超声检查和遗传检查，当涉及某些紧急情况时，可能需要与急救中心和手术部合作，见图 2-35。

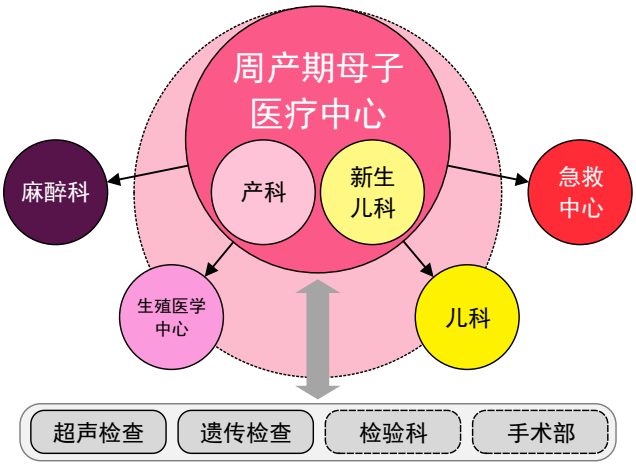


图 2-35 周产期母子医疗中心主要组成科室、关联科室和涉及医技部门关系图
图片来源：作者自绘

3）位置关系研究

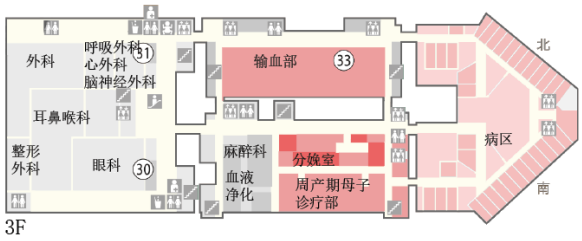
周产期母子医疗中心由于孕妇分娩的需求，往往与病房区邻近设置。见表 2.40。

表 2.40 周产期母子医疗中心平面布局特征

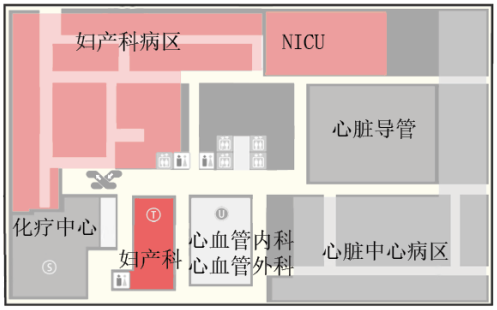
布局	案例
1. 门诊设置	 愛知医科大学病院

中国知网 https://www.cnki.net

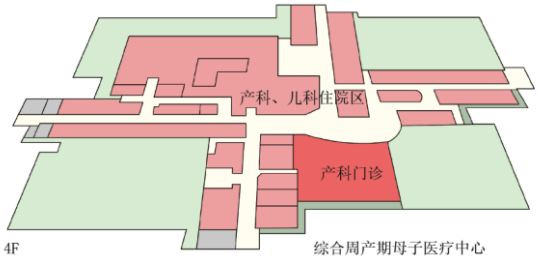
2. 与住院部邻近



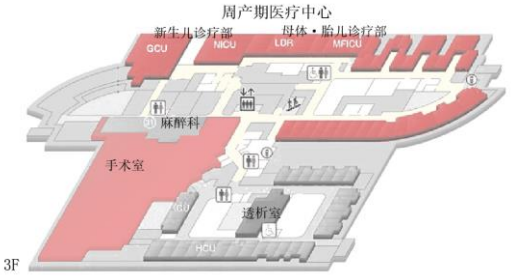
東京大学医学部附属病院



宇治徳洲会病院



高知医療センター

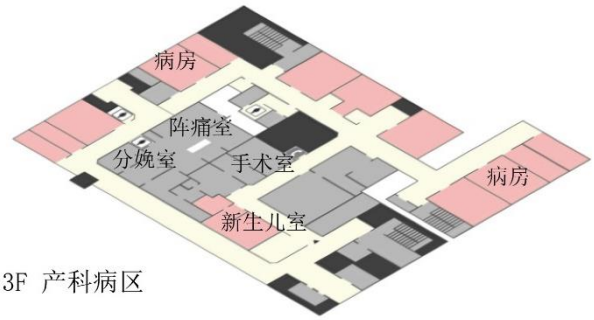


名古屋市立西部医療センター

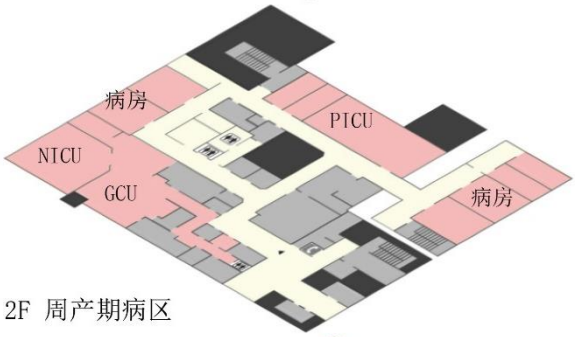
3. 独栋布置

5F 妇科・生殖医疗病区

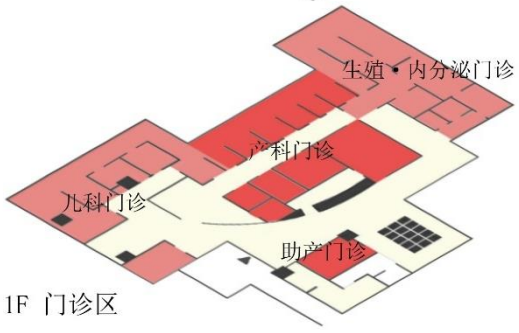
4F 儿科病区



3F 产科病区



2F 周产期病区



1F 门诊区

東京慈恵医科大学附属病院

注：图表自制

中国知网 https://www.cnki.net

2.3.13 女性诊疗中心

1）基本情况

女性诊疗相关中心主要是诊疗女性特有的器官疾病，如子宫肌瘤等。女性诊疗相关中心的成立，除了强调女性医疗的整体性，而不仅是诊疗一个个专门的器官外，还考虑到女性患者对隐私等独特的需求，强调医生应能更了解女性心理。在所研究医院中，设置诊疗女性疾病相关中心共 23 个，包括女性诊疗中心、女性肿瘤中心和子宫肌瘤治疗中心等，如图 2-36。其中以女性诊疗中心命名的中心数量 15 个，占一半以上，为方便研究分析，现将与诊疗女性疾病相关中心，统称为女性诊疗中心。

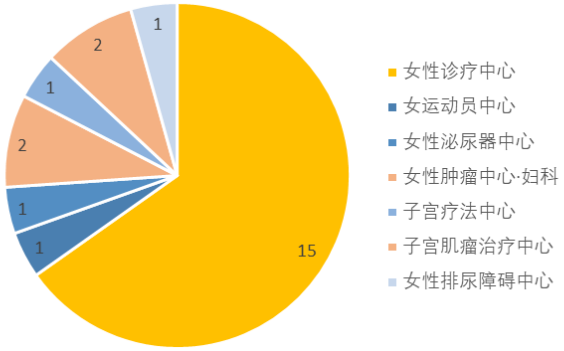


图 2-36 女性疾病相关中心名称数量统计图
图片来源：作者自绘

综合考虑各医院女性诊疗中心科室配置、诊疗特点和平面布局特征，选取 JR 东京综合医院、福井县济生会医院和福山医疗中心等在内的 5 所医院女性诊疗中心进行基本情况分析，见表 2.41。

表 2.41 各医院女性诊疗中心基本情况一览

医院名称	诊疗中心名称	包含科室	关联科室或诊疗中心	诊疗疾病	诊断	治疗
JR 東京総合病院	女性诊疗中心	妇产科 乳腺外科・内分泌外科	整形外科（乳房重建）	・ 产科：自然分娩 ・ 妇科：妇科肿瘤（宫颈癌、卵巢癌）、不孕不育和生殖内分泌疾病、生殖器脱垂 ・ 乳腺外科：乳腺癌	超声、CT、MRI 检查、病理检查、骨密度检查、阴道镜检查、血液检查、乳房 X 线	手术、化疗、放疗等
福井県済生会病院	女性诊疗中心	妇科 乳腺外科 泌尿科 精神保健		・ 女性更年期障碍 ・ 泌尿科、肛门科疾病 ・ 一般女性疾病	超声检查	药物、手术等
福山医療センター	女性医疗中心	产科 妇科 乳腺・内分泌外科	围产期母子中心 泌尿科	・ 产科：妊娠・分娩 ・ 妇科：妇科恶性肿瘤（宫颈癌、卵巢癌）、子宫肌瘤等 ・ 乳腺・内分泌外科（乳腺癌）	乳腺 X 线检查、超声、乳房活检	放疗，化疗、手术等
名鉄病院	女性泌尿科・泌尿中心	泌尿科 妇产科	康复科	・ 女性特殊尿路疾病（盆腔器官脱垂和腹压性尿失禁等）		手术等
耳原総合病院	妇幼保健中心（妇产科）	产科 妇科	儿科（产科相关） 麻醉科	・ 产科并发症 ・ 恶性肿瘤（宫颈癌、卵巢癌、子宫癌等） ・ 子宫肌瘤 ・ 不孕不育	超声检查、采血	腹腔镜、宫腔镜手术等

中国知网 https://www.cnki.net

				· 传染病（衣原体感染 • 淋菌感染症） · 卵巢功能不全 · 内分泌失常 · 妇女保健（更年期、月经失常等）		

注：表格自制

2）涉及科室和医技

主要构成女性诊疗中心科室为妇科、产科和乳腺 • 内分泌外科，主要涉及医技检查为超声检查、血液检查、乳房 X 线和病理检查等，一般内设于女性诊疗中心。除了一般的女性疾病，女性诊疗中心还跟其他科室或中心合作诊疗某些特殊疾病，如与泌尿科合作诊疗女性骨盆底疾病；与生殖医疗中心合作诊疗不孕不育；与肿瘤中心合作诊疗女性肿瘤等等。见图 2-37。

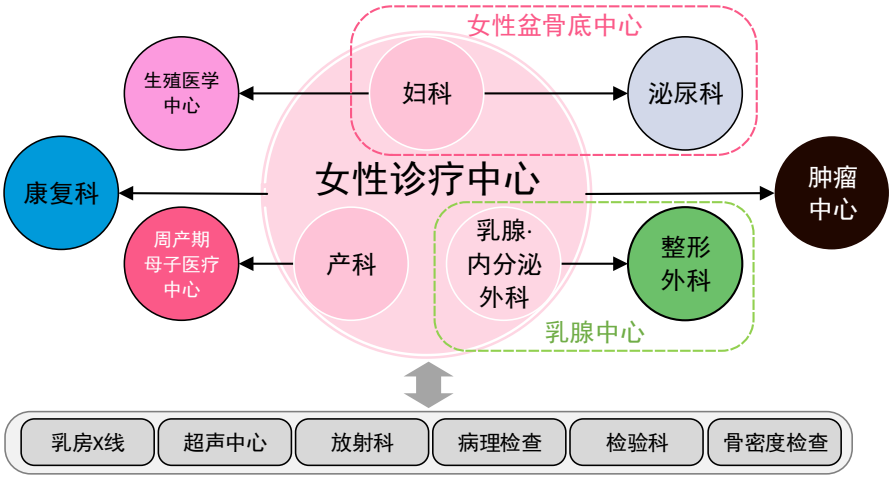
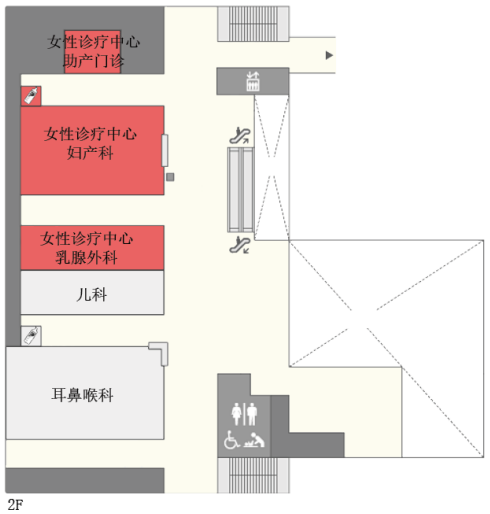
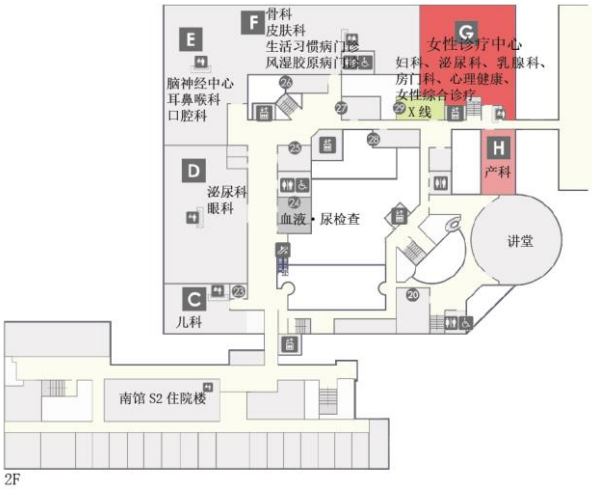


图 2-37 女性诊疗中心主要组成科室、关联科室和涉及医技部门关系图
图片来源：作者自绘

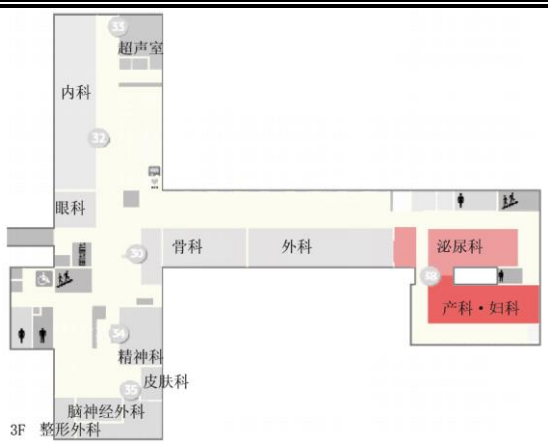
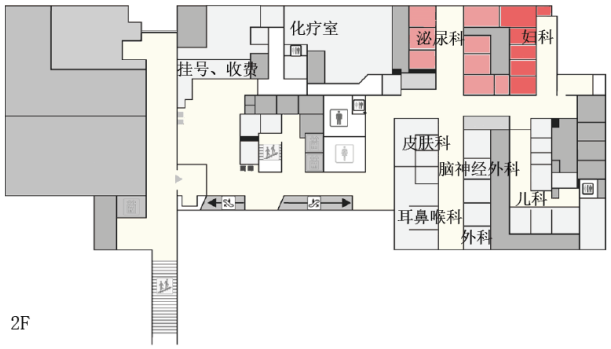
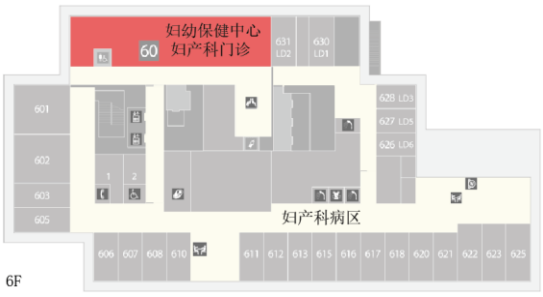
3）位置关系研究

女性诊疗中心的布置常涉及到女性隐私的问题，往往独立区域布置、或邻近住院部、或邻近泌尿科布局，见表 2.42。

表 2.42 女性诊疗中心平面布局特征

布局	案例
1. 内设相关检查室	 JR 東京総合病院  福井県済生会病院

中国知网 https://www.cnki.net

2. 与泌尿科相邻	 福山医療センター	 名鉄病院
3. 与住院部邻近	 耳原総合病院	

注：图表自制

2.3.14 儿童医疗中心

1）基本情况

儿童医疗相关中心主要诊疗对象为儿童患者。在所研究医院中，设置针对儿童患者诊疗中心共 42 个，包括儿童医疗中心、儿童健康中心和小儿心脏病・川崎病中心等，如图 2-38。其中以儿童医疗中心命名的中心 34 个，占大多数，为方便研究分析，现将与诊疗儿童患者相关中心统称为儿童医疗中心。

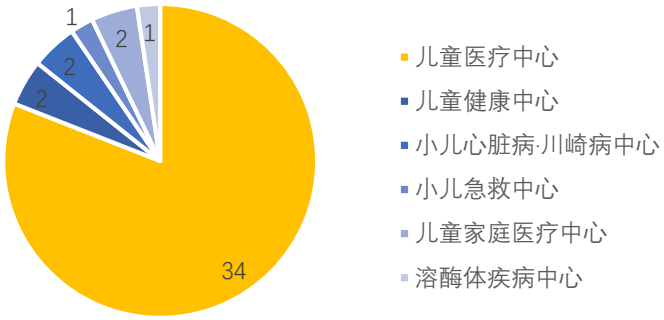


图 2-38 儿童医疗相关中心名称数量统计图
图片来源：作者自绘

综合考虑各医院设置儿童医疗中心的科室配置、诊疗特点和平面布局特征，选取大阪市立综合医疗中心等在内的 4 所医院进行研究分析，基本情况见表 2.43。

表 2.43 各医院儿童医疗中心基本情况一览

医院名称	诊疗中心名称	包含科室	关联科室或诊疗中心	诊疗疾病	诊断	治疗
大阪市立総合	儿童医疗中	小儿内科系（小儿综合	急救中心	・ 儿科所有疾病		药物、

中国知网 https://www.cnki.net

医療センター	心	诊疗科、小儿血液肿瘤科、小儿代谢·内分泌内科、小儿神经内科、小儿心内科、小儿心律失常科、小儿急救科） 小儿外科系（小儿外科、小儿脑神经外科、小儿心血管外科、小儿泌尿科、小儿骨科、小儿整形外科、小儿眼科、小儿耳鼻喉科） 其他（小儿青年精神科、小儿语言科）	ICU	（中枢神经系统、呼吸感染、肠道感染、肾·高血压、胶原病、儿童肿瘤等）		手术等
高槻病院	儿童中心·PICU	儿科 小儿外科 小儿脑神经外科	急救中心 围产期母子医疗中心	· 儿童一般疾病（过敏症、儿童神经系统疾病、肾脏疾病、心血管疾病、代谢·内分泌疾病、发育障碍等） · 先天性疾病（脑积水、脊椎裂等）、脑肿瘤、脑血管疾病		药物、手术等
東京西徳洲会病院	儿童医疗中心	儿科		· 中枢神经系统病 · 脊髓相关疾病 · 末梢神经疾病 · 肌肉经 · 发育障碍等		药物、手术等
大阪急性期·総合医療センター	儿童医疗中心	儿科 小儿外科	急救科 周产期母子医疗中心	· 感染症（脑膜炎、脑炎、败血症） · 川崎病 · 过敏症（食物过敏、支气管哮喘、皮炎） · 神经系统疾病		药物、手术等

注：表格自制

2）涉及科室和医技

儿童医疗中心主要由儿科和小儿外科构成，涉及几乎所有医技部门，常与急救中心和周产期母子医疗中心合作诊疗，见图 2-39。

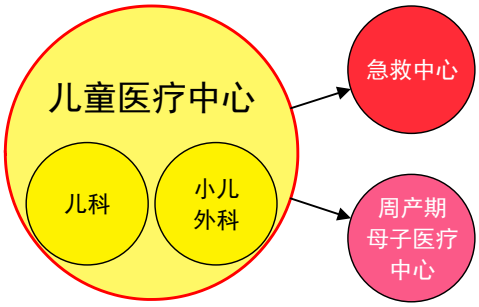


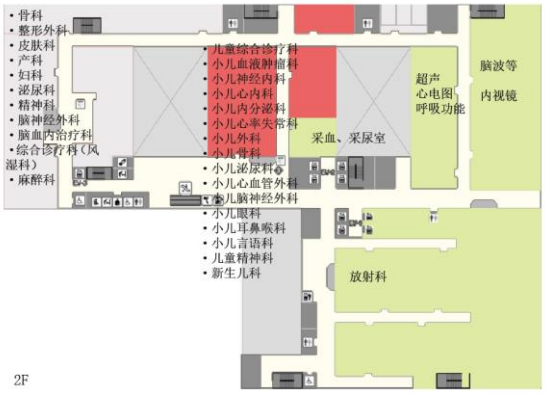
图 2-39 儿童医疗中心主要组成科室、关联科室和涉及医技部门关系图
图片来源：作者自绘

中国知网 https://www.cnki.net

3）位置关系研究

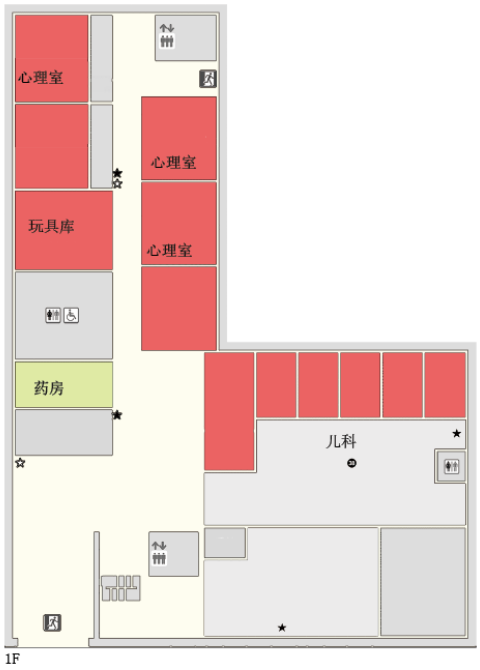
由于儿童医疗中心诊疗对象主要是儿童，所以其位置布局可较为独立或独栋布置，也可邻近医院医技部门或急救中心设置。见表 2.44。

表 2.44 儿童医疗中心平面布局特征

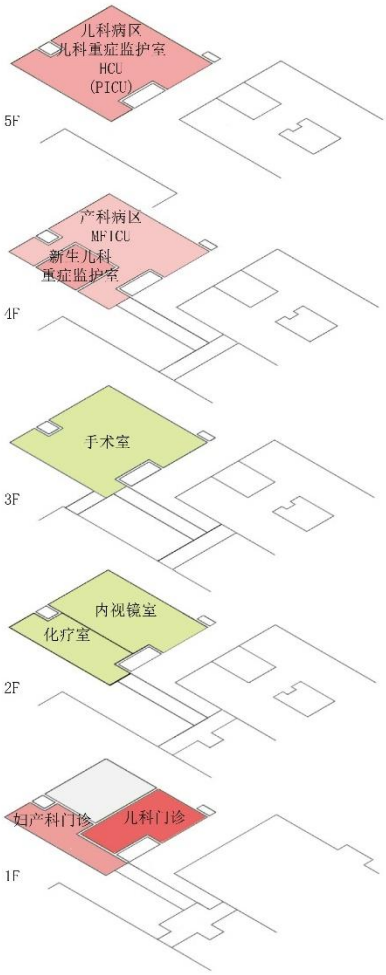
布局	案例
1.邻近相关检查室	 大阪市立総合医療センター
2.邻近急救中心	 高槻病院

中国知网 https://www.cnki.net

3. 独栋布置



東京西徳洲会病院



大阪急性期・総合医療センター

注：图表自制

2.4 疾病中心

通过对研究医院设置的各种诊疗中心进行统计归纳和分析，将糖尿病中心、过敏中心、风湿・胶原病中心、皮肤病中心、血液病中心、精神卫生中心、疼痛中心、 肿瘤中心、认知症医疗中心、高血压中心、唇腭裂中心、脑卒中中心和癫痫中心归为一类，统称为疾病中心。其主要以诊疗某类特定疾病为主。本节将主要解明此类诊疗中心基本情况和布局特征。

2.4.1 糖尿病中心

1）基本情况

糖尿病相关中心主要以诊疗糖尿病等代谢类疾病为主。糖尿病属于慢性病，往往无法根治，且患病时间越长越有几率出现其他并发症，进而引发死亡。因此各医院成立糖尿病中心以便及早的预防糖尿病及并发症产生。在所研究医院中，设置糖尿病诊疗相关中心共 73 个，包括糖尿病中心、糖尿病・内分泌中心和糖尿病・生活习惯病中心等，如图 2-40。其中以糖尿病中心命名的中心 44 个，占所研究中心的一半以上。因此，为方便分析研究，现将与诊疗糖尿病疾病相关的中心统称为糖尿病中心。

中国知网 https://www.cnki.net

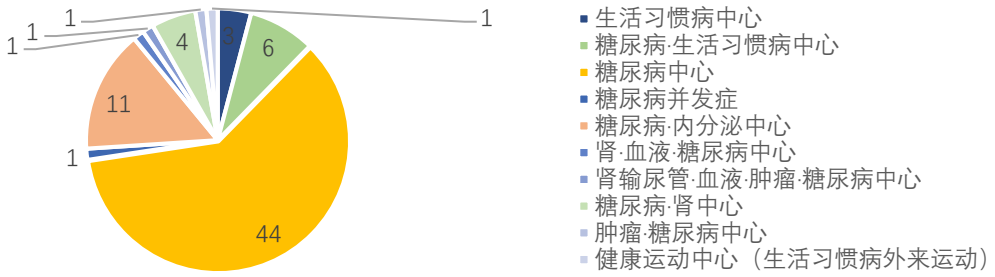


图 2-40 糖尿病相关中心名称数量统计图

图片来源：作者自绘

综合考虑各医院设置糖尿病中心的科室配置、诊疗特点和平面布局特征，选取爱知医科大学医院、日生医院和府中医院等在内的 8 所医院糖尿病中心进行分析研究，见表 2.45。

表 2.45 各医院糖尿病中心基本情况一览

医院名称	诊疗中心名称	包含科室	关联科室或诊疗中心	诊疗疾病	诊断	治疗
愛知医科大学病院	糖尿病中心	糖尿病内科		· 糖尿病(1 型糖尿病，2 型糖尿病，妊娠糖尿病，其他糖尿病) · 肥胖 · 糖尿病并发症筛查	血糖监测、末梢神经检查、眼底检查、神经传导检查等	营养指导等
日生病院	糖尿病・内分泌中心			· 糖尿病 · 糖尿病并发症（糖尿病视网膜病变、脑血管障碍、糖尿病肾病、冠动脉疾病、糖尿病神经障碍、糖尿病足病，糖尿病末梢动脉疾病） · 下垂体、甲状腺、甲状旁腺、肾上腺等经	身体机能评估、血糖测定、神经障碍评估	生活习惯指导、营养指导、运动指导等
府中病院	糖尿病中心		糖尿病教室	· 糖尿病为主的生活习惯病（糖尿病、高血压、脂质异常、肥胖症等） · 并发症预防	血糖等	教育等
千葉中央メディカルセンター	糖尿病中心	糖尿病内科	健康运动中心	· 糖尿病 · 动脉硬化疾病（与心脏科、脑外科、骨科共同诊疗） · 糖尿病视网膜病变、肾病（与眼科、肾内科、透析科合作）	血糖测定等	营养相谈、运动疗法等
関西電力病院	糖尿病・代谢・内分泌中心		营养治疗中心 足部护理中心 内分泌肿瘤中心	· 生活习惯病（糖尿病、高血压、血脂异常、肥胖症等） · 甲状腺、甲状旁腺、脑垂体等内分泌疾病	运动负荷心电图、冠动脉造影 CT、血管内皮功能测试等	需与心内科、脑神经外科、整形外科、眼科、肾内科合作诊疗。饮食疗法、运动疗法、药物疗法
東京女子医科大学病院	糖尿病中心	糖尿病・代谢内科 糖尿病眼科		· 糖尿病代谢内科（糖尿病、儿童・青少年糖尿病、糖尿病肾病、糖尿病神经障碍、妊娠糖尿病、肥胖、足部护理门诊等） · 糖尿病眼科（糖尿病眼部并发症诊疗。）	血糖测定 眼底检查（糖尿病视网膜病变） 尿蛋白检查（糖尿病肾病） 腱反射、知觉检查（糖尿病神经障碍）	饮食疗法、运动疗法、药物疗法、糖尿病教育等

中国知网 https://www.cnki.net

					心电图、冠动脉造影、脑 CT・MRI（冠动脉、脑血管障碍） 皮肤 AGE 测定 足溃疡检测	
千葉大学医学部附属病院	糖尿病并发症中心	糖尿病・代谢・内分泌科 眼科 肾内科 神经内科 营养部、护理部	心内科、皮肤科、骨科、整形外科、药剂部、检查部、康复部、高龄医疗中心	・ 糖尿病并发症	血糖等	与皮肤科、心血管内科、骨科、整形・美容外科组成“糖尿病足护理门诊”；运动疗法等
川崎医科大学附属病院	肾尿路・血液・糖尿病中心	肾内科 泌尿科 血液内科 糖尿病・代谢・内分泌科		・ 肾内科相关疾病 ・ 泌尿科相关疾病 ・ 血液内科相关疾病 ・ 糖尿病 •代谢 •内分泌科：糖尿病、脂质异常、肥胖症、高血压、高尿酸症、甲状腺、肾上腺等疾病	脉波传播速度、颈动脉超声、腹部 X 线、CT 检查内脏脂肪堆积，遗传诊疗	饮食指导、运动指导、药物治疗、并发症筛查、教育

注：表格自制

2）涉及科室和医技

糖尿病中心主要由糖尿病・代谢内科构成，主要诊疗糖尿病等相关疾病，其主要涉及医技检查为血液检查，由于糖尿病易引发各种并发症，所以各医院糖尿病中心还进行糖尿病并发症的相关筛查，包括眼底检查、心电图检查、超声检查和肌电图检查等。除了相关并发症筛查外，糖尿病中心还会与各科室合作诊疗糖尿病相关并发症，如与眼科合作诊疗糖尿病视网膜病变，与肾内科合作诊疗糖尿病肾病，与口腔科合作诊疗糖尿病牙周病等，见图 2-41。

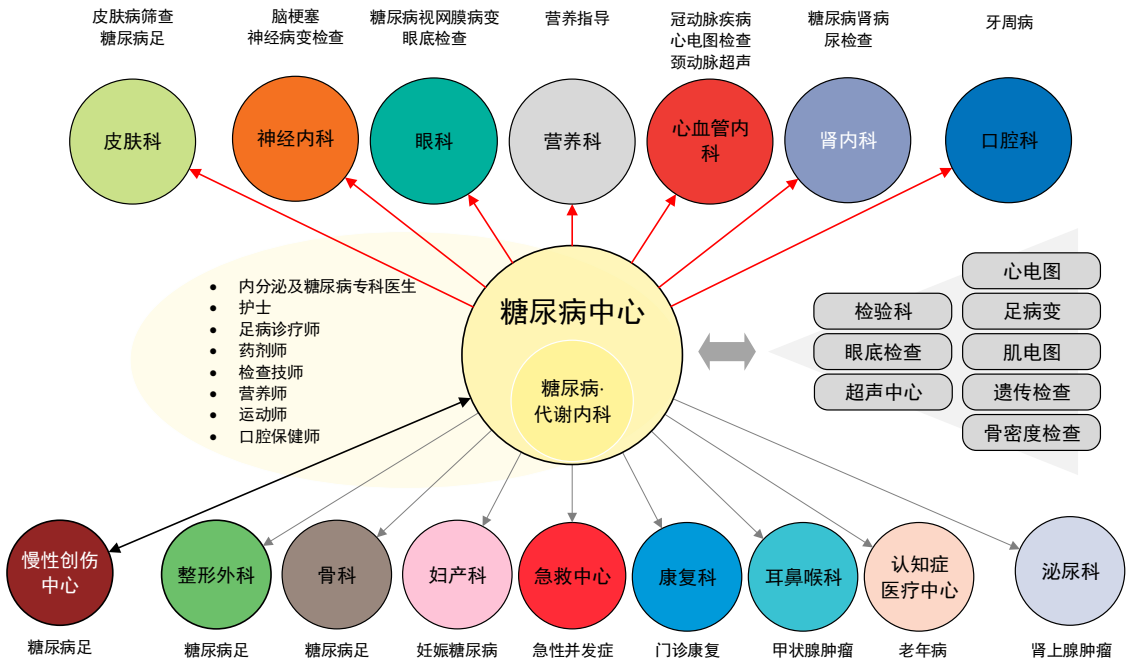


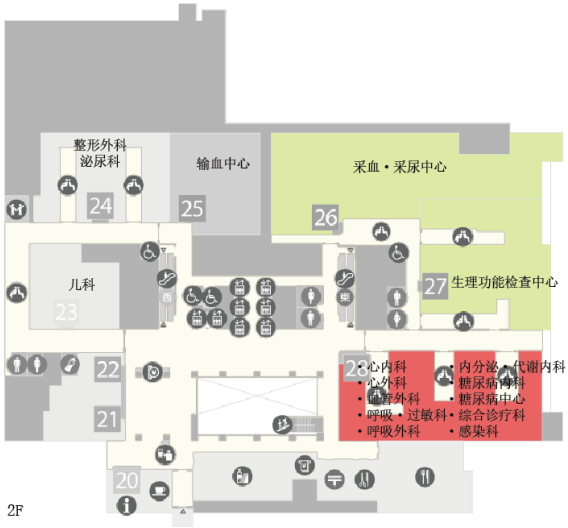
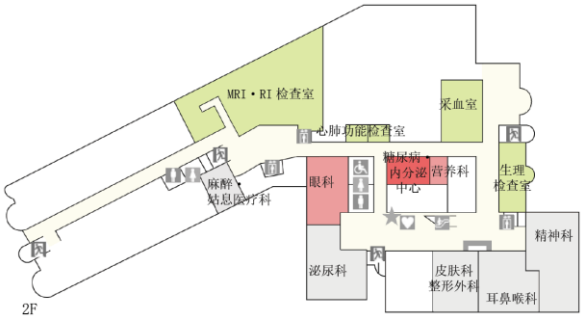
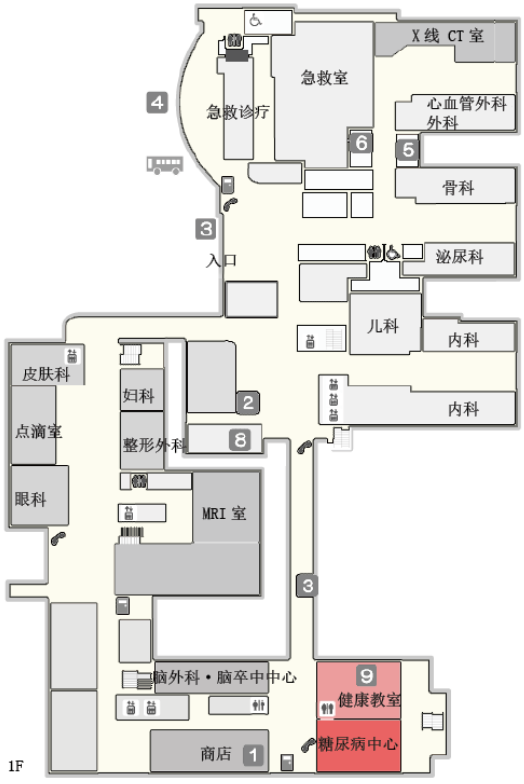
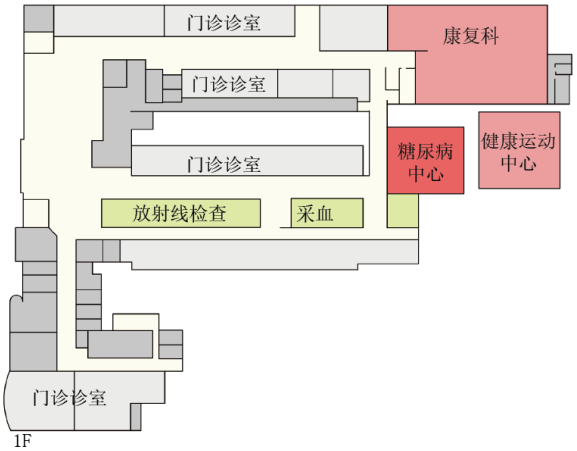
图 2-41 糖尿病中心主要组成科室、关联科室和涉及医技部门关系图
图片来源：作者自绘

中国知网 https://www.cnki.net

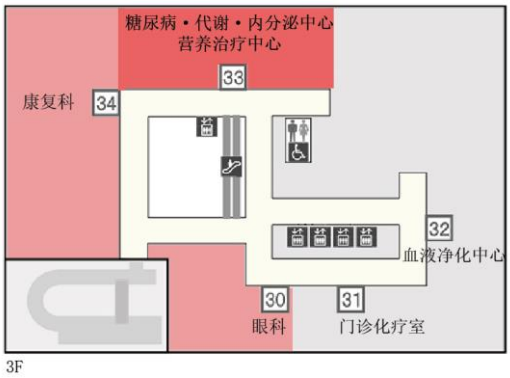
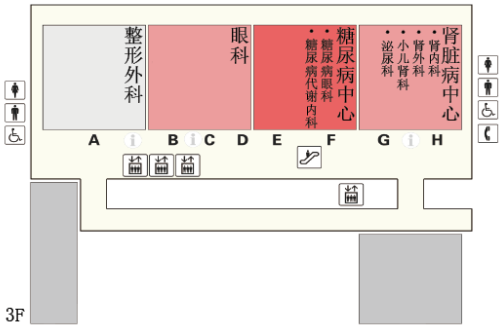
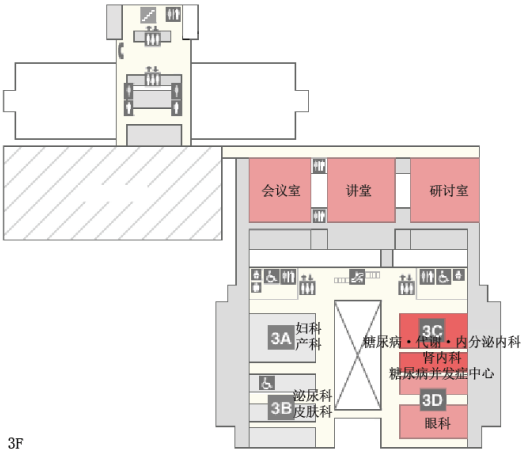
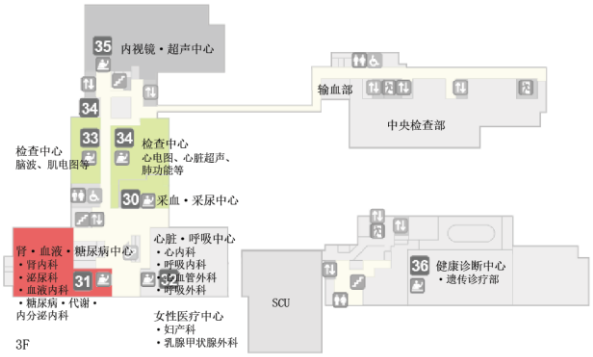
3）位置关系研究

由于糖尿病涉及医技检查较多，所以糖尿病中心往往邻近相关医技设置；有些医院强调糖尿病的预防和运动疗法，往往选择邻近健康运动中心布置；还有医院会更注重糖尿病并发症的治疗，平面布局时则考虑其与相关科室或中心邻近联合布置，见表 2.46。

表 2.46 糖尿病中心平面布局特征

布局	案例	
1.与相关检查室邻近	 愛知医科大学病院	 日生病院
2.与健康运动中心相邻	 府中病院	 千葉中央メディカルセンター

中国知网 https://www.cnki.net

3. 与相关科室或中心相邻	 関西電力病院  東京女子医科大学病院  千葉大学医学部附属病院  川崎医科大学附属病院

注：图表自制

2.4.2 过敏中心

1）基本情况

过敏中心主要诊疗过敏性疾病，包括食物过敏、皮肤过敏等，其往往伴有全身性疾病，需要多学科合作诊疗。不同医院会设置过敏中心或专门应对儿童的小儿过敏中心，见图 2-42。

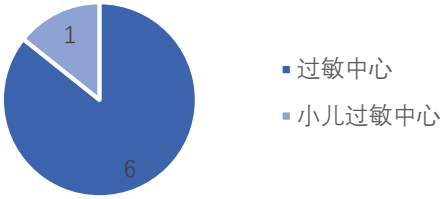


图 2-42 过敏中心名称数量统计图
图片来源：作者自绘

中国知网 https://www.cnki.net

综合考虑各医院过敏中心科室配置、诊疗特点和平面布局特征，选取千叶大学医学部附属医院、关系医科大学医院等在内的 4 所医院进行相关研究分析，基本情况见表 2.47。

表 2.47 各医院过敏中心基本情况一览

医院名称	诊疗中心名称	包含科室	关联科室或诊疗中心	诊疗疾病	诊断	治疗
千葉大学医学部附属病院	过敏中心	过敏・胶原病内科 儿科 耳鼻喉科 皮肤科		・ 支气管哮喘 ・ 过敏性鼻炎 ・ 皮肤炎 ・ 食物过敏	过敏测试	免疫治疗
関西医科大学附属病院	过敏中心	儿科 呼吸感染内科 皮肤科 眼科 耳鼻喉科 血液肿瘤内科	急救科 综合诊疗科	・ 食物过敏 ・ 过敏性皮炎 ・ 过敏性哮喘 ・ 过敏性鼻炎	过敏测试	药物治疗等
埼玉医科大学病院	过敏中心	呼吸内科 儿科 皮肤科 耳鼻喉科		・ 哮喘 ・ 慢性咳嗽 ・ 食物过敏 ・ 花粉过敏 ・ 小儿过敏性皮炎	过敏测试	免疫治疗
坂文種報德會病院	综合过敏中心	呼吸・过敏内科 儿科 耳鼻喉科 皮肤科 眼科		・ 支气管哮喘 ・ 运动诱发性哮喘 ・ 食物过敏 ・ 过敏性肺炎 ・ 过敏性鼻炎 ・ 皮炎 ・ 过敏性结膜炎	呼吸功能测试、咳嗽敏感性测试等	免疫治疗

注：表格自制

2）涉及科室和医技

由于过敏部位不同，过敏中心往往需要与各科合作进行综合诊疗，如过敏性结膜炎需要眼科相关合作诊疗、哮喘需要呼吸内科相关合作诊疗等。过敏中心的主要检查为过敏测试，一般在中心内进行，如图 2-43。

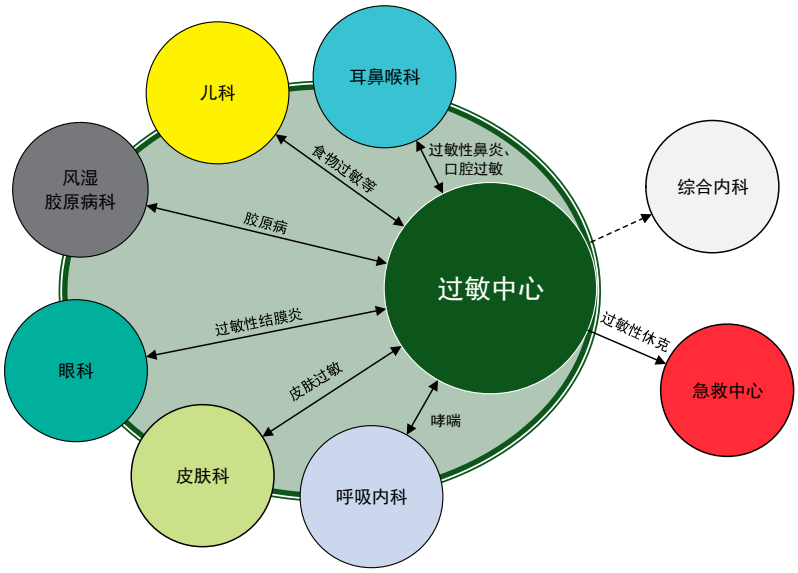


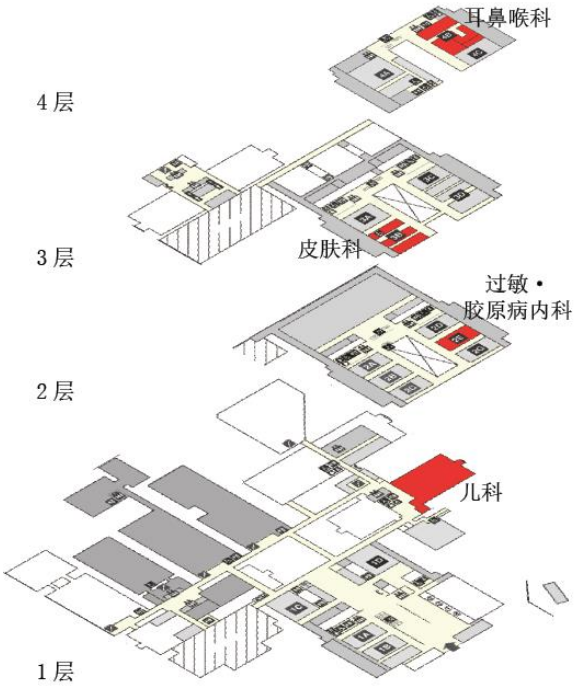
图 2-43 过敏中心主要组成科室、关联科室和涉及医技部门关系图
图片来源：作者自绘

中国知网 https://www.cnki.net

3）位置关系研究

目前日本综合医院过敏中心呈各科独立受诊的布局状况，有条件的医院可以成立单独的过敏中心以方便多疾病患者的诊疗，见表 2.48。

表 2.48 过敏中心平面布局特征

布局	案例
1：多个科室分别设立	 千葉大学医学部附属病院

注：图表自制

2.4.3 风湿・胶原病中心

1）基本情况

高龄化社会使得运动器官疾病患者不断增加，类风湿关节炎从青壮年时期就开始产生，风湿・胶原病中心的设立，指在建立跨部门的医疗体系，以应对激增的患者。在所研究的医院中，设置诊疗风湿・胶原病相关疾病的诊疗中心共 31 个，包括风湿・胶原病中心、免疫疾病治疗中心和类风湿性关节炎・生物支援中心，如图 2-44。为便于研究，现将与诊疗风湿・胶原病相关中心统称为风湿・胶原病中心。

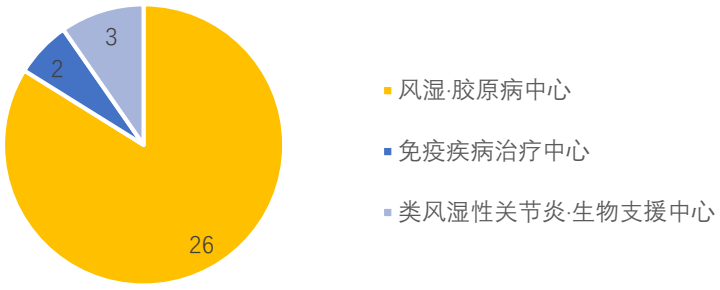


图 2-44 风湿・胶原病相关中心名称数量统计图
图片来源：作者自绘

中国知网 https://www.cnki.net

综合考虑各医院风湿·胶原病中心科室配置、诊疗特点和平面布局特征，选取自治医科大学医院、圣路加国家医院和大阪市立综合医疗中心等在内的 5 所医院风湿·胶原病中心进行分析研究，基本情况见表 2.49。

表 2.49 各医院风湿·胶原病中心基本情况一览

医院名称	诊疗中心名称	包含科室	关联科室或诊疗中心	诊疗疾病	诊断	治疗
自治医科大学附属病院	风湿病中心	风湿科 骨科		· 骨关节病 · 系统性红斑狼疮 · 类风湿性关节病 · 血管炎 · 过敏性疾病等	活检	药物等
聖路加国際病院	风湿·胶原病中心	风湿胶原病内科 儿童风湿科	中医（骨科 皮肤科 心内科 呼吸内科）[1]	· 全身性红斑狼疮（SLE） · 胶原病 · 类风湿性关节炎 · 脊椎关节炎 · 儿童胶原病 · 过敏反应 · 血管炎	关节超声、MRI	关节手术
大阪市立総合医療センター	风湿病	综合诊疗科（风湿内科） 骨科（风湿外科） 皮肤科		· 类风湿性关节炎 · 与皮肤病相关的关节炎	关节超声	药物治疗
東邦大学医療センター　大森病院	风湿胶原病中心	胶原病科		· 风湿关节炎 · 全身性红斑狼疮 · 全身性硬化横 · 皮肤肌炎 · 混合性结缔组织病 · 干燥综合征 · 血管炎综合征 · 其他类风湿关节炎	超声检查、血液检查	药物疗法
大阪急性期·総合医療センター	风湿性关节炎·生物支持中心	免疫风湿科 骨科 呼吸内科 急救中心 康复科		· 类风湿性关节炎 · 类风湿性关节炎的并发症	免疫机能检查、抗体检查、感染症检查、X线、关节和腹部超声、关节穿刺、CT、MRI、支气管镜检查、呼吸功能检查等	药物等

注：1）在圣路加国际医院，风湿胶原病内科与骨科和皮肤科合作诊疗脊椎关节炎，与心内科、呼吸内科合作诊疗全身性硬化症和肺高血压症，与骨科合作治疗类风湿性关节炎。

表格自制

2）涉及科室和医技

风湿·胶原病中心往往由风湿科和骨科合作诊疗，主要检查为超声检查和血液检查，当诊疗某些特殊疾病时，需要与其他科室合作诊疗，如与心内科和呼吸内科合作诊疗全身性硬化症，与皮肤科合作诊疗皮肤性关节炎等，见图 2-45。

中国知网 https://www.cnki.net

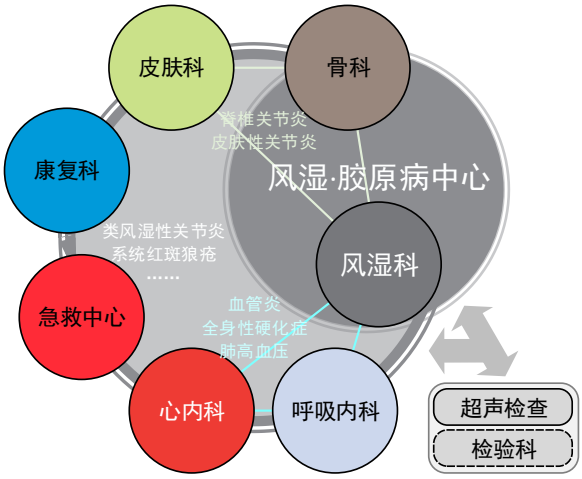
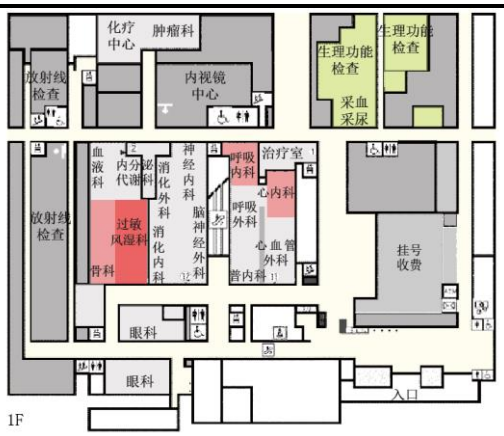
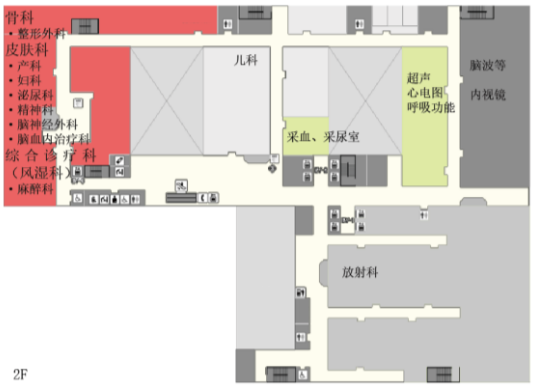


图 2-45 风湿・胶原病中心主要组成科室、关联科室和涉及医技部门关系图
图片来源：作者自绘

3）位置关系研究

由于风湿・胶原病中心涉及医技较少，可设置在诊疗中心内，所以风湿・胶原病中心的布局重点往往在与其他科室邻近布置上。见表 2.50。

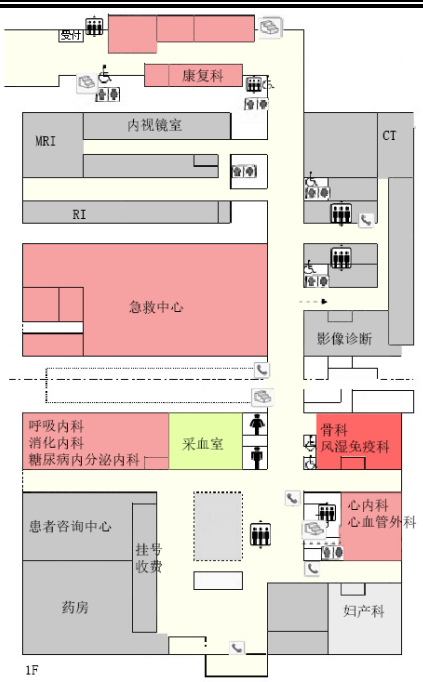
表 2.50 风湿・胶原病中心平面布局特征

布局	案例
1. 邻近相关科室或中心	 自治医科大学附属病院 聖路加国際病院  大阪市立総合医療センター

中国知网 https://www.cnki.net

2. 邻近相关医技、科室或中心

東邦大学医療センター　大森病院



大阪急性期・総合医療センター

注：图表自制

2.4.4　皮肤病中心

1）基本情况

皮肤病相关中心主要诊疗皮肤疾病，如皮炎等。在所研究医院中，有 5 所医院设置皮肤病相关中心，包括皮肤病中心、皮肤保健中心、皮肤癌中心和油症研究与医疗中心，为方便研究现统称诊疗皮肤相关疾病中心为皮肤病中心，见图 2-46。

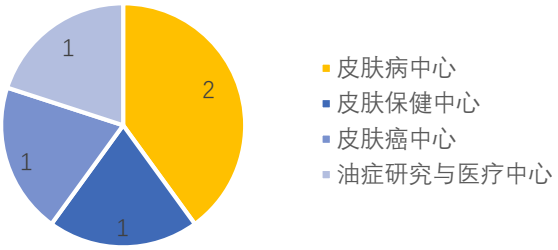


图 2-46　皮肤病相关中心名称数量统计图
图片来源：作者自绘

综合考虑各医院设置皮肤病中心的科室配置、诊疗特点和平面布局特征，选取川崎医科大学附属医院、堺市立综合医疗中心、大森病院和木沢纪念医院进行相关分析研究，见表 2.51。

表 2.51　各医院皮肤病中心基本情况一览

医院名称	诊疗中心名称	包含科室	关联科室或诊疗中心	诊疗疾病	诊断	治疗
川崎医科大学附属病院	皮肤・运动中心	皮肤科 风湿・胶原病科 骨科 整形・美容外科	放射科	・　一般皮肤科疾病（湿疹・皮肤炎、带状疱疹、细菌感染、干癣、细菌感染、疣、鸡眼、水疱、胶原病、皮肤肿瘤、下肢溃疡、药疹等） ・　一般风湿・胶原病、骨科	皮肤活检、视诊等	手术治疗、化疗、放疗等

中国知网　https://www.cnki.net

				疾病、整形・美容外科疾病		
堺市立総合医療センター	皮肤病中心	皮肤科 整形外科	皮肤科 整形外科	・皮炎、湿疹、红斑、肉芽肿、角质化等皮肤疾病 ・皮肤肿瘤 ・免疫性疾病、下肢静脉曲张引起的皮肤溃疡等 ・皮肤科・整形外科一般疾病等	过敏测试、皮肤镜检查、皮肤活检等	手术治疗等
東邦大学医療センター　大森病院	皮肤保健中心	皮肤科 （皮肤科附属中心）		・抗衰老 ・美容 ・水疱 ・接触性过敏 ・皮肤外科 ・牛皮癣 ・痤疮 ・指甲等	皮肤病理检查（活检）、过敏测试、基因分析	激光治疗、化学剥离等
木沢記念病院	皮肤癌中心	皮肤科	放射科	・接触性皮炎 ・荨麻疹 ・银屑病 ・皮肤细菌感染 ・带状疱疹 ・肝斑 ・老年斑 ・皮肤肿瘤等	皮肤镜检查、组织检查、影像检查（PET-CT）	手术治疗、化疗以及多学科治疗[1)]

注：1）皮肤肿瘤治疗涉及影像科 PET-CT 诊断，以用来检测皮肤癌是否转移，并用肿瘤治疗的一般方法进行治疗，详见 2.4.1 节肿瘤中心相关内容。

表格自制

2）涉及科室、中心和医技

皮肤病中心主要由皮肤科构成，部分医院会将皮肤科与整形外科整合成为皮肤病中心，其主要涉及医技检查为皮肤病理检查，主要在中心内进行。皮肤病中心还会与肿瘤中心合作诊疗皮肤恶性肿瘤，与风湿・胶原病科合作诊疗胶原病等，见图 2-47。

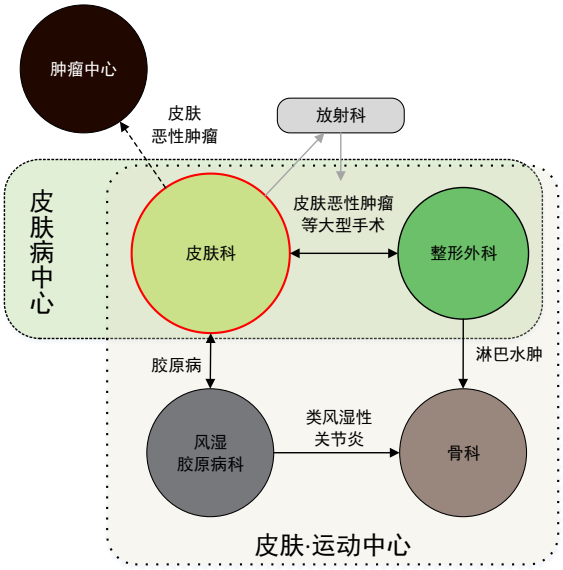


图 2-47 皮肤病中心主要组成科室、关联科室和涉及医技部门关系图

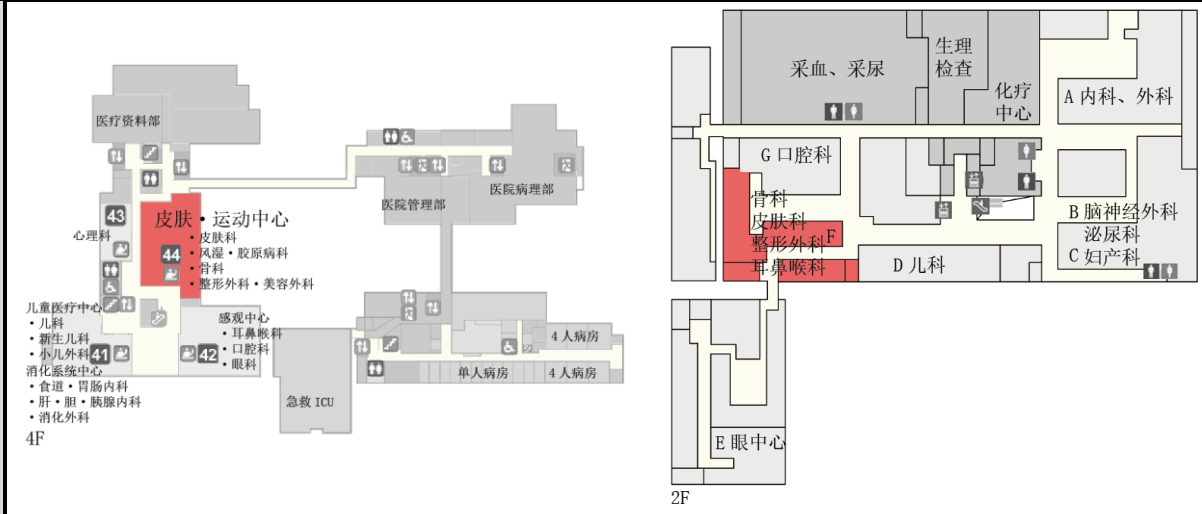
图片来源：作者自绘

3）位置关系研究

由于皮肤病中心相关检查基本在中心内进行，所以皮肤病中心的平面布局应主要需考虑与相关科室邻近布局。见表 2.52。

中国知网 https://www.cnki.net

表 2.52 皮肤病中心平面布局特征

布局	案例
1：与相关科室邻近	

川崎医科大学附属病院　　堺市立総合医療センター

注：图表自制

2.4.5　血液病中心

1）基本情况

血液病相关中心主要诊疗血液类疾病，如白血病等。在所研究医院中，设置诊疗血液疾病相关中心共 21 个，包括血液病中心、血友病中心和造血细胞移植（治疗） 中心等，见图 2-48。

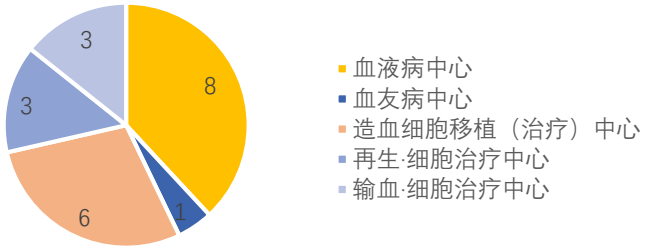


图 2-48 血液病相关中心名称数量统计图

图片来源：作者自绘

综合考虑各医院血液病中心的科室配置、诊疗特点和平面布局特征，选取福岛县立医科大学会津医疗中心、爱媛大学医学部附属医院、PL 医院和东京慈惠医科大学附属医院进行相关分析研究，见表 2.53。

表 2.53 各医院血液病中心基本情况一览

医院名称	诊疗中心名称	包含科室	关联科室或诊疗中心	诊疗疾病	诊断	治疗
福島県立医科大学 会津医療センター	血液疾病治疗中心	血液内科・中医科	姑息治疗中心	・ 白血病 ・ 恶性淋巴瘤 ・ 原发性骨髓瘤	骨髓造影、临床检查部、病理检查（淋巴活检、骨髓活检）、CT 摄影	化疗、门诊输血治疗、干细胞检查
愛媛大学医学部附属病院	造血细胞移植中心	儿科 血液内科 输血部	药剂部 营养部	・ 贫血 ・ 白血病 ・ 骨髓形成异常症 ・ 骨髓瘤		化疗、姑息治疗等

中国知网 https://www.cnki.net

				· 淋巴瘤 · 血友病等		
PL 病院	血液病中心	血液内科		· 急性白血病 · 恶性淋巴瘤 · 再生障碍性贫血 · 骨髓增生异常综合征 · 血友病	血液检查	化疗等
東京慈恵医科大学附属病院	造血细胞治疗中心	肿瘤・血液内科 儿科 输血部		· 白血病 · 造血干细胞移植 · 恶性淋巴瘤 · 原发性骨髓瘤 · 骨髓形成异常症 · 贫血		姑息治疗等

注：表格自制

2）涉及科室和医技

血液病中心主要由血液内科构成，主要涉及医技检查包括血液检查、病理检查和放射科检查等，主要与儿科合作诊疗白血病，与肿瘤中心合作诊疗血液肿瘤，见图 2-49。

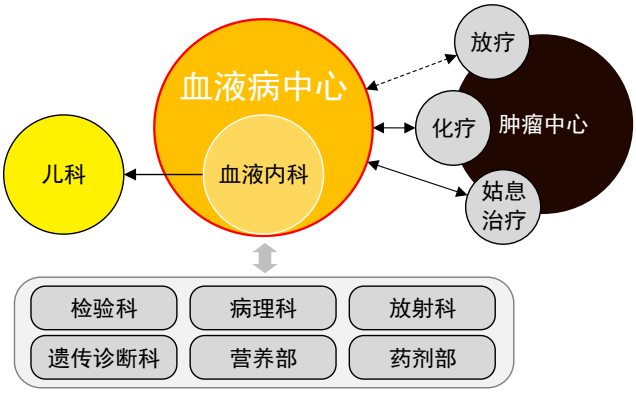
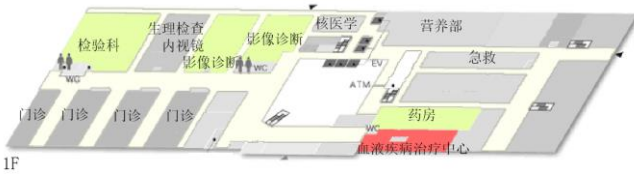
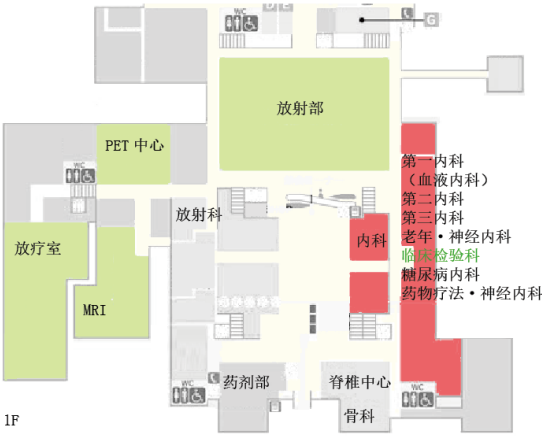


图 2-49 血液病中心主要组成科室、关联科室和涉及医技部门关系图
图片来源：作者自绘

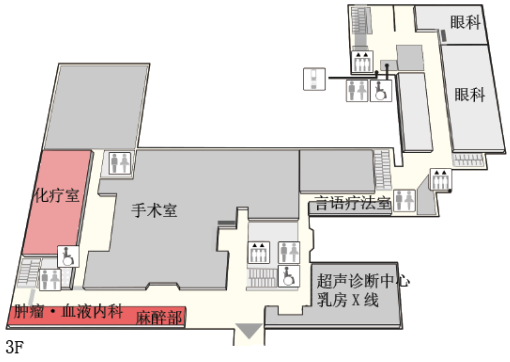
3）位置关系研究

在所研究医院中，血液中心常见布局包括邻近相关检查室和邻近化疗室布局，见表 2.54。

表 2.54 血液病中心平面布局特征

布局	案例	
1. 邻近相关检查室		
	福島県立医科大学 会津医療センター	愛媛大学医学部附属病院

中国知网 https://www.cnki.net

2. 邻近化疗室		
		
	PL 病院	東京慈恵医科大学附属病院

注：图表自制

2.4.6 精神卫生中心

1）基本情况

现代社会压力的增加，使得许多人患有或多或少的精神性或心理性疾病，成立精神或神经疾病相关中心，以为相关患者提供综合的诊疗服务，帮助患者适应社会。在所研究医院中，设置诊疗精神性或心理性疾病相关中心共 29 个，包括精神卫生中心、心理科・精神中心和精神分裂症中心等，如图 2-50。其中以精神卫生中心命名的中心 16 个，占一半以上，为便于研究分析，现将与诊疗精神或神经疾病相关中心，统称为精神卫生中心。

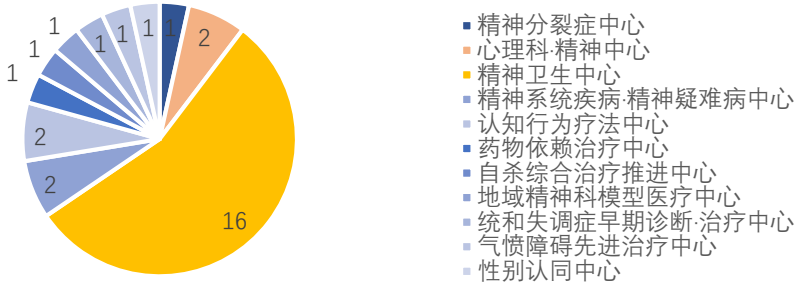


图 2-50 精神或神经疾病相关中心名称数量统计图

图片来源：作者自绘

综合考虑各医院设置精神卫生中心的科室配置、诊疗特点和平面布局特征，选取圣路加国际医院、东邦大学医疗中心大森医院和国立国际医疗研究中心医院等在内的 8 所医院精神卫生中心进行相关分析研究，基本情况见表 2.55。

表 2.55 各医院精神卫生中心基本情况一览

医院名称	诊疗中心名称	包含科室	关联科室或诊疗中心	诊疗疾病	诊断	治疗
聖路加国際病院	心身中心	心理科、精神科		・ 心理科疾病（恐慌症、慢性头痛、饮食失调、心身障碍、惆怅等） ・ 精神科（精神分裂症、狂躁症、抑郁症、强迫症、失眠、神经质、精神紧张性障碍、人格障碍、认知症、睡眠障碍等）		
東邦大学医療センター 大森病院	精神卫生中心	精神科		・ 抑郁症 ・ 认知症	心理检查（认知功能检查、性	综合区域精神治疗计划（OTP）

中国知网 https://www.cnki.net

					格检查、脑机能检查）	
国立国際医療研究センター病院	精神卫生中心	精神科、心理科、精神联络小组、认知症护理团队	姑息治疗科	· 精神科（抑郁症、心身障碍、精神分裂症、认知症） · 心理科（心身障碍、饮食失调、癌症患者心理支持、生活习惯病心理支持）	精神科（CT、MRI、SPECT、PET、脑波、心理检查）	改良电疗（mECT）、高照度光刺激、住院精神治疗
高知医療センター	精神卫生中心	儿童精神科、成人精神科	儿童精神疾病与儿科、周产期母子中心合作	· 身体并发症精神病患者（脑外科、骨科、消化外科、肾疾病）	SPECT	并发症手术治疗、住院治疗
奈良県立医科大学附属病院	精神医疗中心	精神科	认知症医疗中心	· 精神障碍 · 人格障碍 · 生理障碍 · 精神病 · 心理障碍 · 情感障碍 · 精神分裂		药物治疗、心理治疗、mECT 治疗等
愛知医科大学病院	精神卫生中心	精神联络部、临床心理部	精神科	· 手术后精神康复 · 住院患者抑郁和精神状况 · 身体疾病引起的焦虑•抑郁症状	心理评估	
福井県立病院	精神卫生中心	精神科、心身医疗科、日间护理部、作业医疗科		· 急救医疗（自杀、抑郁症） · 嗜酒症 · 精神科疾病 · 心理科疾病		
济生会横浜市東部病院	精神卫生中心	精神科	急救中心	· 精神科急救 · 精神科身体并发症 · 情绪障碍（抑郁症、躁郁症） · 精神障碍 · 强迫性障碍 · 精神分裂症 · 睡眠障碍 · 认知症等		集体治疗，mECT(改良电疗)

注：表格自制

2）涉及科室和医技

精神卫生中心主要由精神科和心理科构成，涉及检查主要为心理检查、知能检查、神经心理学检查以及脑波检查和放射科相关检查等。精神卫生中心常与各诊疗科合作诊疗身心并发症，与认知症医疗中心合作诊疗认知症，与急救中心合作诊疗抑郁自杀，与周产期母子中心合作诊疗产后抑郁等，见图 2-51。

中国知网 https://www.cnki.net

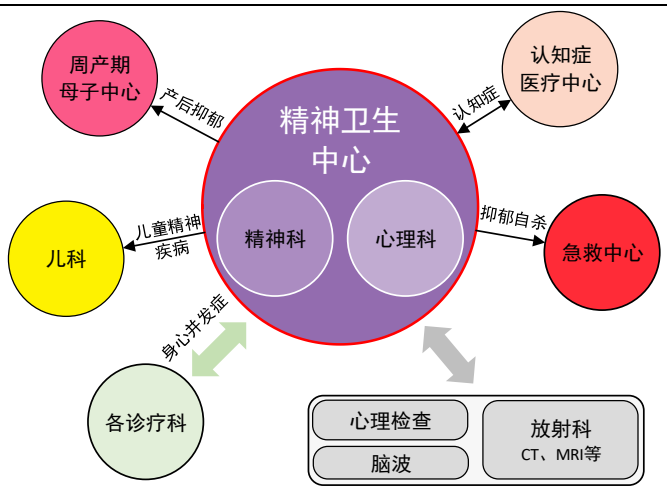
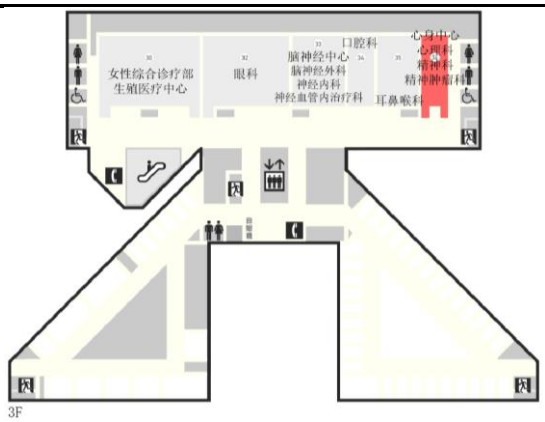
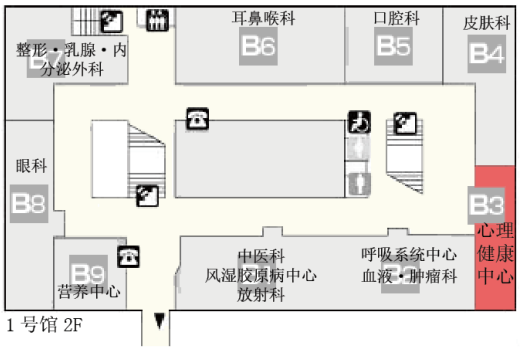
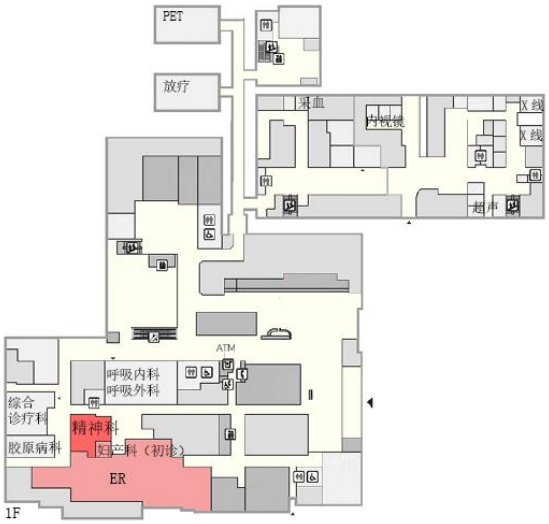


图 2-51 精神卫生中心主要组成科室、关联科室和涉及医技部门关系图
图片来源：作者自绘

3）位置关系研究

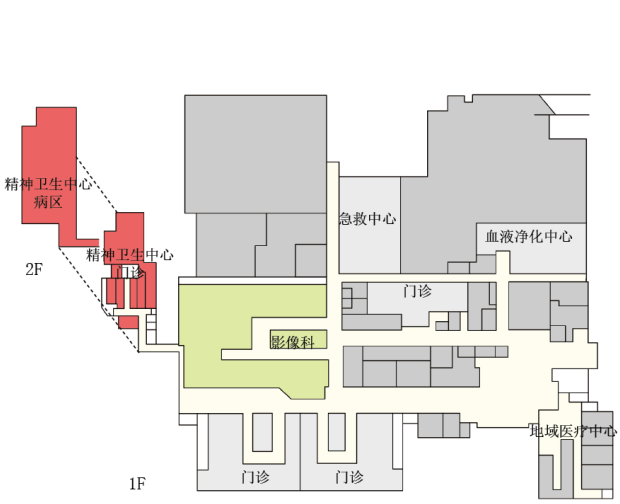
出于对患者隐私和安全性的考虑，精神卫生中心常独栋或独立区域设置，也可根据医院精神卫生中心诊疗特色邻近相关科室或中心布局，具体平面布局见表 2.56。

表 2.56 精神卫生中心平面布局特征

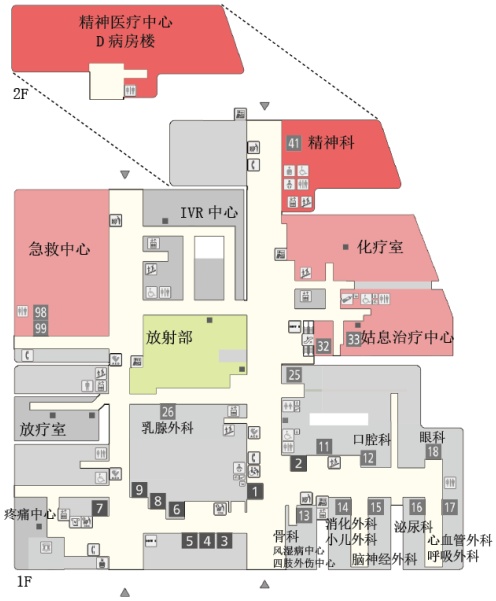
布局	案例
1. 邻近其他科室或中心	 聖路加国際病院  東邦大学医療センター　大森病院
2. 邻近急救中心	 国立国際医療研究センター病院

中国知网 https://www.cnki.net

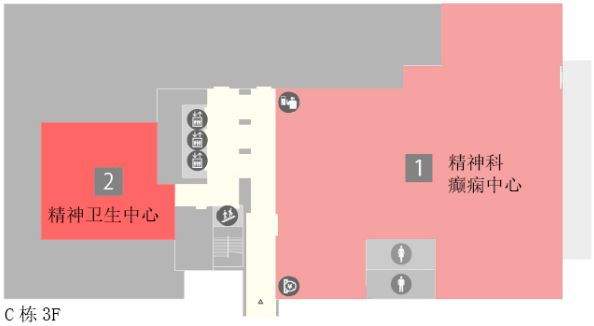
3. 独栋或独立布置



高知医療センター



奈良県立医科大学附属病院



愛知医科大学病院

注：图表自制

2.4.7 疼痛中心

1）基本情况

疼痛中心设立主要诊疗慢性疼痛患者，包括身体、心理和社会上的“疼痛”。随着社会老龄化，疼痛治疗的作用将越来越重要。综合考虑各医院疼痛中心科室配置、诊疗特点和平面布局特征，选取宇治德洲会医院等在内的 5 所医院疼痛中心研究分析，基本情况见表 2.57。

表 2.57 各医院疼痛中心基本情况一览

医院名称	诊疗中心名称	包含科室	关联科室或诊疗中心	诊疗疾病	诊断	治疗
宇治德洲会病院	疼痛中心	麻醉科		· 疼痛治疗（伤害性疼痛、神经性疼痛、心理疼痛） · 头·面部疼痛、颈椎·腰背疼痛、腹痛、带状疱疹、癌症疼痛、术后疼痛等		药物等
日本大学医学部附属板橋病院	疼痛中心		骨科 康复科 心理内科 精神科	· 癌症性疼痛和非癌症性慢性疼痛	血液、MRI、CT	药物等
愛知医科大学病院	疼痛中心		精神科 心理科 运动疗愈中心	· 颈椎·腰椎痛 · 肩·肘·膝·股关节变形疾病 · 癌症疼痛 · 神经性疼痛		运动疗法、精神疗法、药物疗法

中国知网 https://www.cnki.net

				· 头痛、面部疼痛、三叉神经痛 · 脊髓损伤疼痛		
东京大学医学部附属病院	麻醉科·疼痛中心	麻醉科		· 手术室麻醉 · 门诊疼痛治疗（姑息治疗、癌症疼痛、带状疱疹神经痛、颈椎症、头痛、三叉神经痛、肩周炎等）	X 线	脊髓刺激疗法、神经康复治疗、肉毒杆菌治疗、运动疗法、神经心理治疗等
奈良県立医科大学附属病院	疼痛中心			· 带状疱疹疼痛 · 颈椎·腰椎·关节痛（与骨科合作） · 三叉神经痛、头痛、末梢神经障碍等	X 线、超声；心理检查、MRI 检查；血液检查（阻断治疗时）	阻断治疗[1]、药物、重要治疗等

注：1）由于阻断治疗后往往需要休息 10 分钟到 1 小时，所以该医院疼痛中心设有 10 张休息床位。
表格自制

2）涉及科室和医技

疼痛中心主要构成科室为麻醉科，由医生、护士、药剂师、物理疗法师、作业疗法师和临床心理师组成医疗团队对患者诊疗。主要涉及医技检查包括血液检查和放射科相关检查。精神科、心理科、骨科、神经内科等科室常需要与疼痛中心合作诊疗患者出现的疼痛问题，见图 2-52。

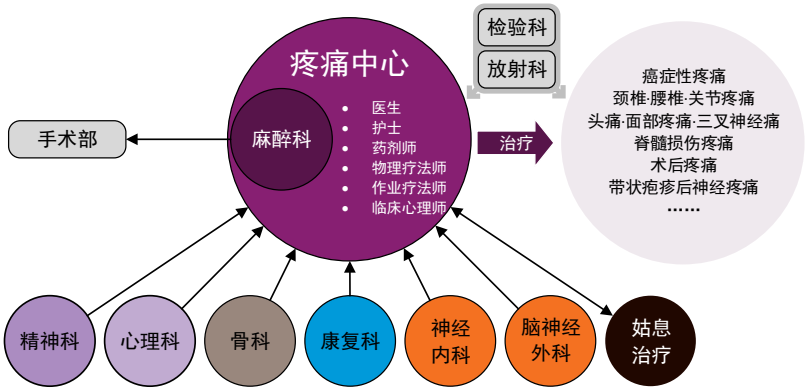


图 2-52 疼痛中心主要组成科室、关联科室和涉及医技部门关系图
图片来源：作者自绘

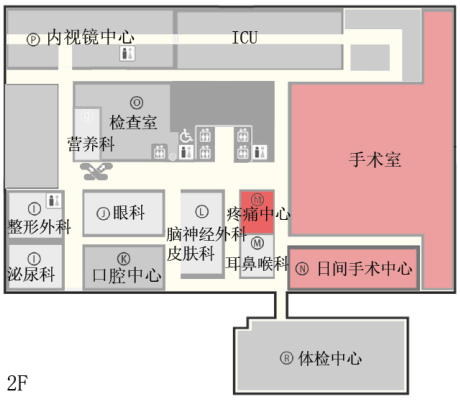
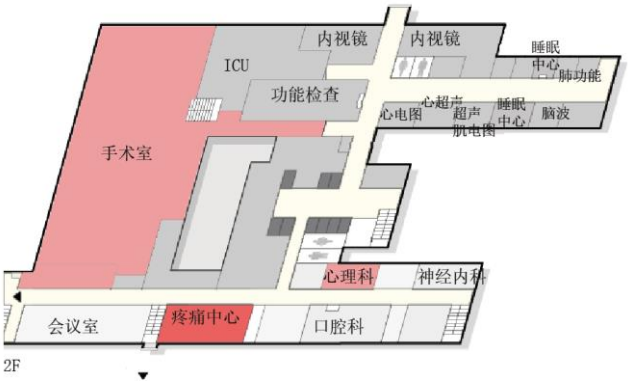
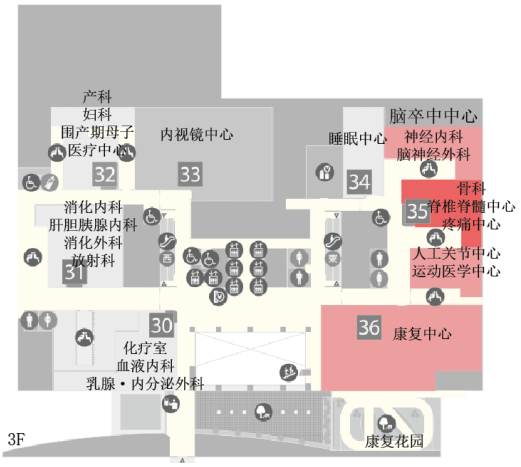
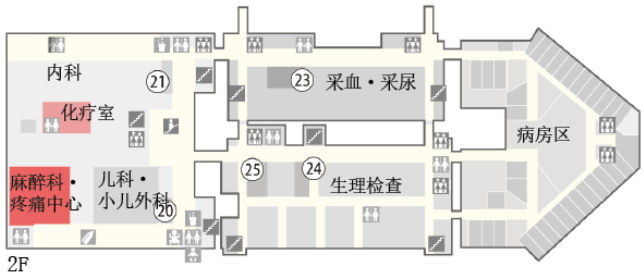
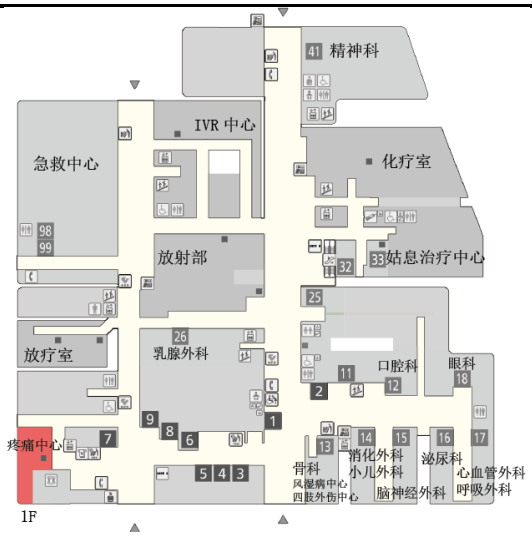
3）位置关系研究

由于疼痛中心主要由麻醉科构成，所以疼痛中心常邻近手术室设置，或与其他科室邻近设置以解决诊疗时带来的疼痛，也有医院独立设置疼痛中心以应对越来越多的慢性疼痛患者。见表 2.58。

表 2.58 疼痛中心平面布局特征

布局	案例

中国知网 https://www.cnki.net

1. 邻近手术室	 宇治德洲会病院	 日本大学医学部附属板橋病院
2. 邻近相关科室或中心	 愛知医科大学病院	 东京大学医学部附属病院
3. 独立布置	 奈良県立医科大学附属病院	

注：图表自制

2.4.8 肿瘤中心

1）基本情况

随着社会老龄化，癌症已经成为日本最严重的疾病。由于癌症发生在人体各个部位，各有不同的特点，往往需要多学科合作诊疗。为更好的为患者服务，各医院纷纷成立癌症诊疗相关中心。在所研究医院中，设置诊疗癌症相关疾病中心共 225 个，包括肿瘤（癌症治疗中心）、化疗中心、放射线治疗中心、癌症咨询中心等，如图 2-53。其中以肿瘤（癌症治疗）

中国知网 https://www.cnki.net

中心命名的中心 88 个，占大多数，为便于研究分析，现将诊疗癌症疾病相关中心，统称为肿瘤中心。

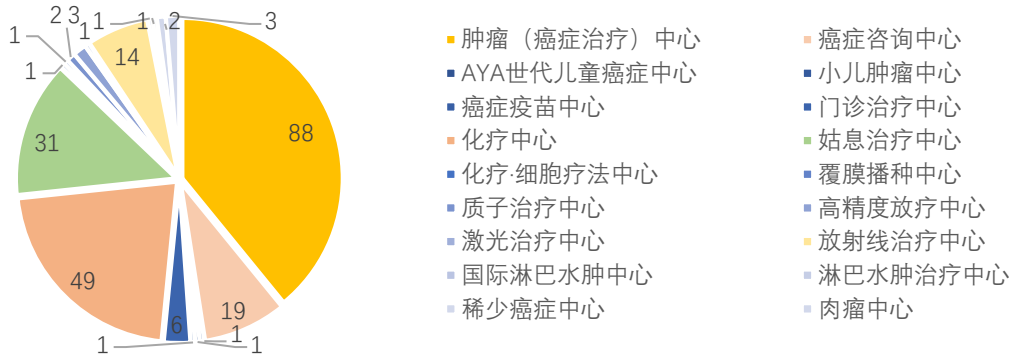


图 2-53 肿瘤疾病相关中心名称数量统计图

图片来源：作者自绘

综合考虑各医院设置肿瘤中心的科室配置、诊疗特点和平面布局特征，选取湘南镰仓综合医院、东邦大学医疗中心大森医院和山形大学医学部附属医院等在内的 12 所医院进行相关研究分析，基本情况统计见表 2.59。

表 2.59 各医院肿瘤中心基本情况一览

医院名称	诊疗中心名称	包含科室	关联科室或诊疗中心	诊疗疾病	诊断	治疗
湘南鎌倉総合病院	肿瘤中心	肿瘤内科 肿瘤外科 血液内科 姑息治疗门诊 化疗室	乳腺外科 呼吸内科 消化中心 外科 妇产科 泌尿科 风湿科	· 消化系统癌症 · 肺癌 · 乳腺癌 · 妇科癌 · 泌尿科癌症 · 血液肿瘤等	影像诊断	化疗、放疗、手术治疗、姑息治疗
東邦大学医療センター 大森病院	癌症中心	诊疗联合部 化疗部 放疗部 姑息治疗部 癌症咨询中心 信息管理部 教育部 癌症康复部 癌症口腔管理部	口腔科	· 各种癌症	血液检查、影像检查（超声、CT、MRI）、病理诊断	手术、化疗、放疗、姑息治疗、营养指导、社会支援
山形大学医学部附属病院	癌症中心	癌症患者登记中心 化疗室 癌症诊疗合作中心 癌症患者咨询室		· 各种癌症（食道癌、胃癌、大肠癌、肺癌、肝癌、乳腺癌、血液癌等）		手术治疗、化疗、放疗、质子治疗
彩の国東大宮メディカルセンター	癌症治疗中心	各诊疗科 癌症咨询中心 化疗室 癌症沙龙		· 消化系统癌症等	内视镜、影像诊断	手术治疗、放疗、化疗
日高病院	肿瘤中心	诊断部门（影像诊断、病理诊断） 治疗部门（手术、放疗、化疗、温热治疗、免疫细胞	（各诊疗科医生、放射科医生、影像诊断科医生、病理科医生、放射线技师等）	· 乳腺癌 · 肺癌 · 胃癌，大肠癌等消化系统癌症 · 肾癌，前列腺癌等泌尿系统癌症	影像诊断（PET/CT）、病理诊断	

中国知网 https://www.cnki.net

		疗法） 诊疗部门（一般诊疗、姑息门诊、第二意见门诊） 诊疗支持部门（姑息治疗・癌症咨询中心、癌症登记）				
淀川キリスト教病院	癌症诊疗中心	肿瘤内科	（肿瘤科医生、外科医生、放射科医生、姑息科医生、病理科医生、护士、药剂师合作）	・ 乳腺癌、卵巢癌、宫颈癌、食道癌、胃癌、大肠癌、胰腺癌、肾细胞癌、前列腺癌、肺癌、头颈部肿瘤、甲状腺癌、肝癌等	检查血液（化疗）	手术治疗、内视镜治疗、放疗、化疗、姑息医疗、癌症康复、营养治疗等
富山大学附属病院	多学科癌症诊疗中心	癌症诊疗医师教育部 化疗部 癌症姑息治疗部 癌症咨询・地域合作部 癌症遗传咨询部 癌症委员会 癌症登记	精神科	・ 各种癌症	CT、MRI 等	化疗、姑息治疗
順天堂医院	癌症治疗中心		（医生、护士、药剂师、临床心理师、社会工作者、治疗师、营养师、医学物理师等合作） 消化内、外科 血液内科 泌尿科 妇科 耳鼻喉科 呼吸内、外科 放射科	・ 各种癌症	影像诊断:CT、MRI	手术治疗、化疗、放疗、姑息治疗
関西医科大学附属病院	癌症中心	化疗部 姑息治疗部	消化外科 呼吸内科 血液肿瘤内科	・ 各种癌症		化疗、姑息治疗
慶應義塾大学病院	肿瘤中心	化疗部 放疗部 姑息治疗部 微创治疗开发部 康复部	（癌症医生、护士、药剂师、理学疗法师、口腔保健师、社工）	・ 恶性肿瘤 ・ 纵膈肿瘤 ・ 大肠癌 ・ 食道癌 ・ 胃癌 ・ 胰腺癌 ・ 胆道癌 ・ 肝脏癌 ・ 乳腺癌 ・ 肺癌等		放疗、化疗、姑息医疗、微创治疗、康复治疗等
大阪大学医学	肿瘤中心	化疗部	姑息治疗（麻	・ 恶性黑色肿瘤		化疗、

中国知网 https://www.cnki.net

部附属病院		放疗部 姑息治疗团队	醉科医生、精神科医生、内科医生、护士、药剂师）	· 肺癌 · 消化器癌		放疗、姑息治疗
熊本大学医学部附属病院	癌症中心	化疗中心 癌症咨询中心 癌症登记中心 姑息治疗中心	姑息治疗团队（医生、护士、口腔保健师、口腔科医生、临床心理师、营养师、药剂师、社工）	· 各种癌症	各诊疗科、遗传诊断	手术治疗、化疗、放疗、姑息治疗、内视镜治疗、分子治疗等

注：表格自制

2）涉及科室和医技

癌症的诊断和治疗往往与初诊科室有很大关联，如岐阜大学医学部附属医院癌症委员会组成情况（表 2.60），所以一般肿瘤中心仅作为癌症咨询和癌症治疗的功能，包括一般的诊室、化疗室、放疗室、姑息治疗室等。癌诊的诊断则需要各学科独立或合作完成，其中主要涉及医技检查为放射科诊断（如 PET、CT 诊断等）、血液诊断、超声诊断和病理诊断等。见图 2-54。

表 2.60 岐阜大学医学部附属病院癌症委员会召开状况（院内）

脏器	诊疗科	时间	跨学科
脑肿瘤	脑神经外科	每天早上 8:00～	
齿科・口腔肿瘤	齿科・口腔外科	每天早上 8:30～	
	齿科・口腔外科	星期二 17:00～	
耳鼻咽喉肿瘤	耳鼻咽喉科	星期二 17:30～	
		星期四 18:00～	麻醉科疼痛治疗科（疼痛管理）
	耳鼻咽喉科	每隔一个周二 18:00～	
呼吸系统肿瘤	呼吸内科・呼吸外科	星期四 13:00～	
	呼吸外科・消化外科（Ⅰ）	周一、周四 8:00～	
消化系统肿瘤	消化外科（Ⅰ）・呼吸外科	周一、周四 8:00～	精神科（姑息医疗）
	消化内科	第 2、第 4 个周一 19：00～	
	综合内科		
	消化外科、消化外科（Ⅰ）		病理部（确定诊断）
妇科领域肿瘤	成育医疗科・女性科	星期二 13:30～	
		星期五 8:00～	
泌尿科肿瘤	泌尿科	星期四 17:00～	
乳腺肿瘤	乳腺外科	星期二 17:00～	放射科（诊断・治疗）
	乳腺外科・放射科	星期二 16:30～	
骨格・运动领域肿瘤	骨科	星期三 7:30～	
皮肤肿瘤	皮肤科	星期四 16:30～	
血液疾病	血液・感染症内科	星期一 17:00～	
	儿科	星期三 17:00～	

注：表格来源与该医院官网，由作者翻译而成

中国知网 https://www.cnki.net

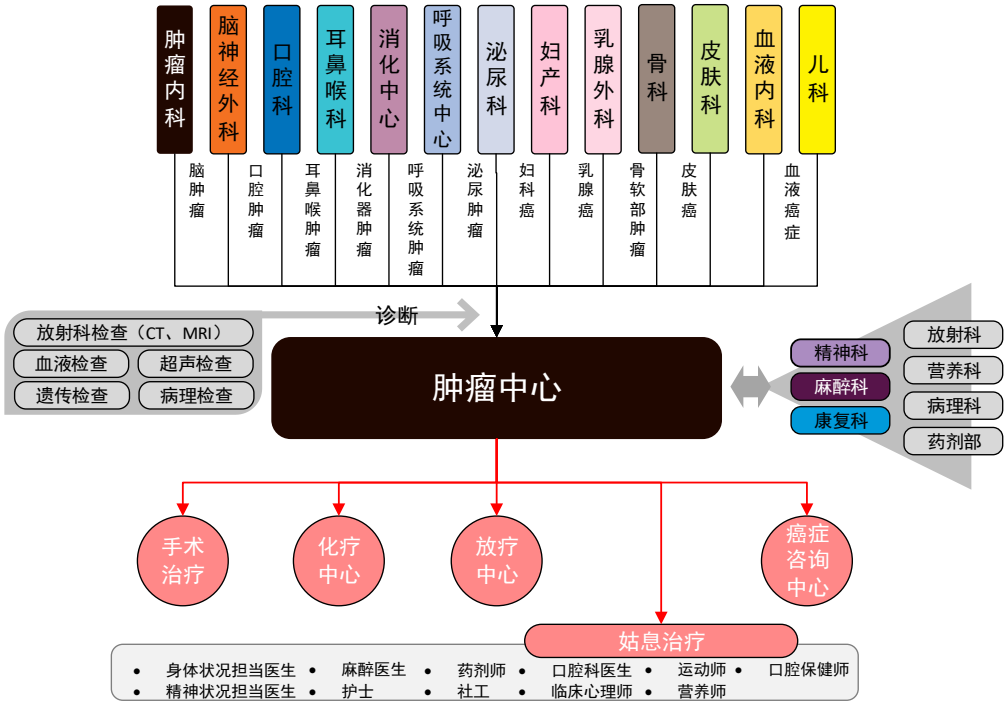


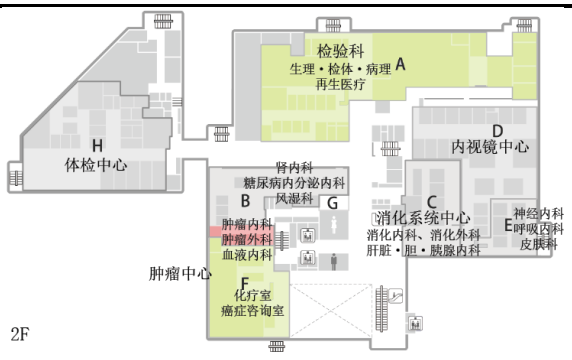
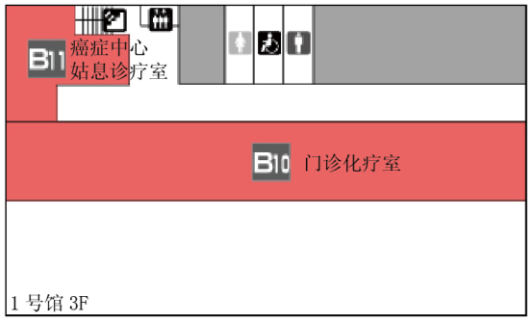
图 2-54 肿瘤中心主要组成科室、关联科室和涉及医技部门关系图

图片来源：作者自绘

3）位置关系研究

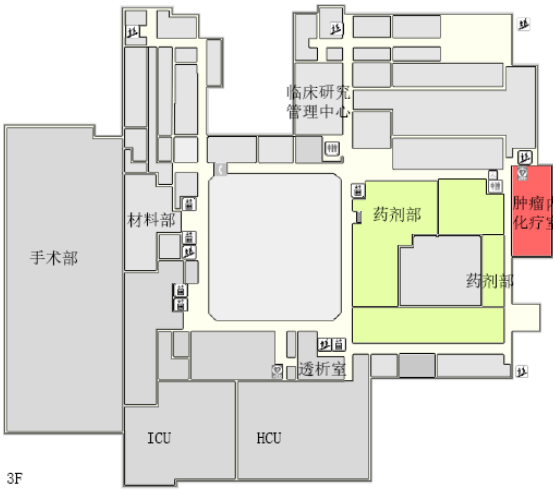
肿瘤中心的布局往往倾向于独立区域布局，常邻近化疗室、放疗室和姑息治疗室布局，大多数医院会选择将姑息治疗室与化疗室邻近布局，以便于患者化疗的同时进行姑息治疗，如东邦大学医疗中心大森医院癌症中心的设置。见表 2.61。

表 2.61 肿瘤中心平面布局特征

布局	案例	
1. 邻近化疗室	 湘南鎌倉総合病院	 東邦大学医療センター　大森病院

中国知网 https://www.cnki.net

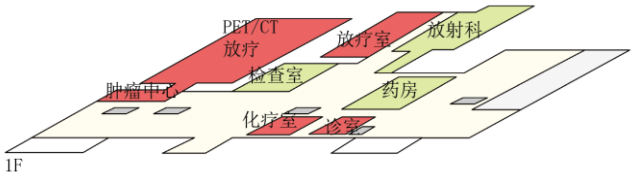
2. 邻近化疗室、药剂部



山形大学医学部附属病院

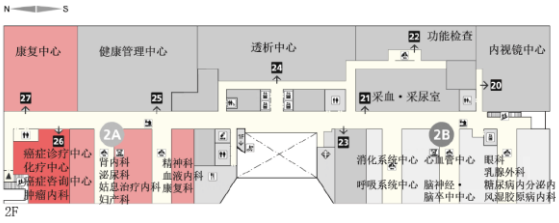
3. 邻近放疗室、化疗室

彩の国東大宮メディカルセンター



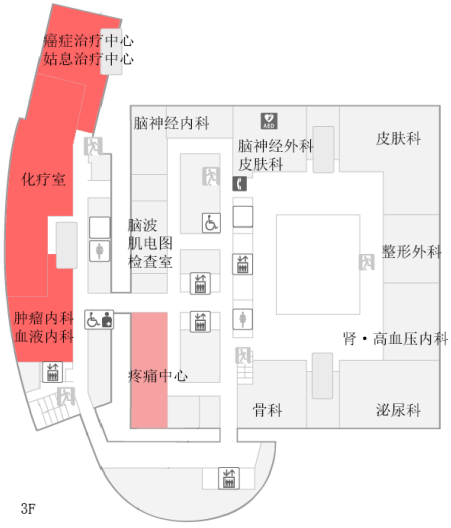
日高病院

4. 邻近相关科室或中心

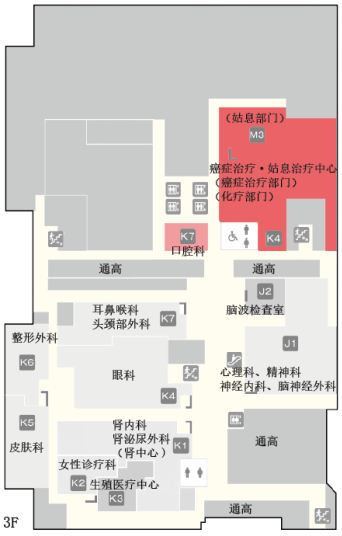


淀川キリスト教病院

富山大学附属病院



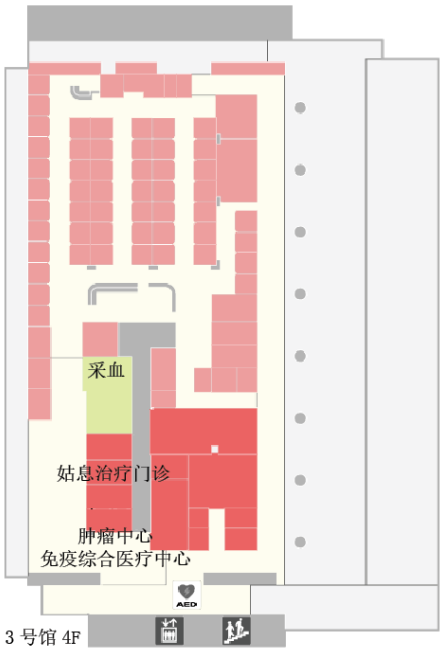
順天堂医院



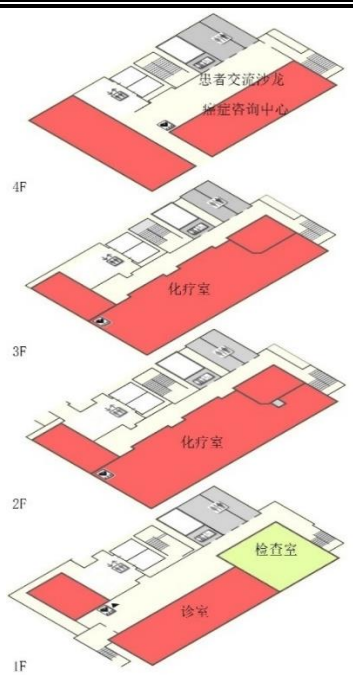
関西医科大学附属病院

中国知网 https://www.cnki.net

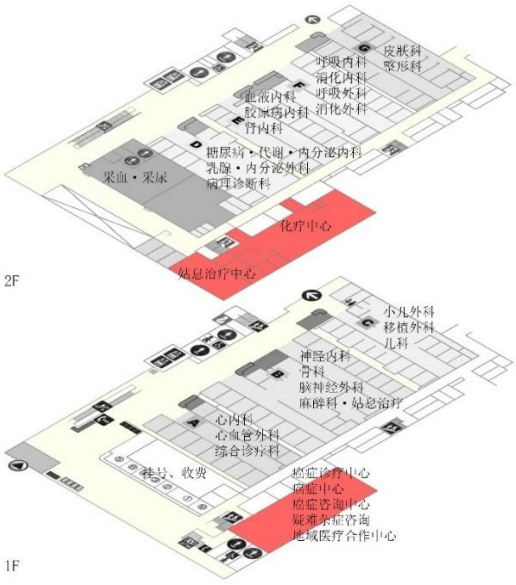
5. 独栋或独立区域设置



庆應義塾大学病院



大阪大学医学部附属病院



熊本大学医学部附属病院

注：图表自制

2.4.9 认知症医疗中心

1）基本情况

认知症相关中心主要诊疗以认知症为代表的老年性疾病，随着社会老龄化的加剧，认知症患者数量逐渐增加，认知症作为一种记忆障碍，影响着老年人和子女的生活。在所研究医院中设置诊疗认知症相关疾病中心 45 个，如图 2-55，其中以认知症医疗中心命名的中心数较多，为便于研究分析，现将诊疗认知症等相关疾病的中心，统称为认知症医疗中心。

中国知网 https://www.cnki.net

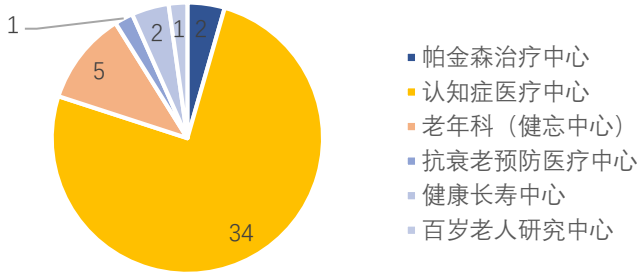


图 2-55 认知症相关中心名称数量统计图
图片来源：作者自绘

综合考虑各医院设置认知症医疗中心的科室配置、诊疗特点和平面布局特征，选取京都中部综合医疗中心和东京医科大学医院等在内的 4 所医院认知症医疗中心进行相关分析研究，基本情况统计见表 2.62。

表 2.62 各医院认知症医疗中心基本情况一览

医院名称	诊疗中心名称	包含科室	关联科室或诊疗中心	诊疗疾病	诊断	治疗
京都中部総合医療センター	认知症疾病医疗中心	精神科		· 认知症	认知功能检查、影像检查、血液检查	
東京医科大学病院	认知症医疗中心	高龄诊疗科 神经内科 精神卫生科		· 认知症	血液检查、头部CT、影像检查、神经心理检查	
千葉大学医学部附属病院	认知症疾病医疗中心	神经内科 精神科		· 阿兹海默症 · 脑血管性认知症 · 混合型认知症 · 前额叶退化 · 路易体认知症等	神经心理检查、血液检查、影像检查、脑波检查、髓液检查	
近畿大学医学部附属病院	早期认知症中心	放射科 精神科 神经内科 康复科		· 阿兹海默症 · 路易体认知症 · 脑血管性认知症等	神经心理检查、影像检查（MRI、SPECT、CT）	

注：表格自制

2）涉及科室和医技

认知症医疗中心主要由神经内科、精神科和老年科合作诊疗，主要涉及医技检查为脑波检查、神经心理学检查等，其往往与康复科合作帮助认知症患者康复，见图 2-56。

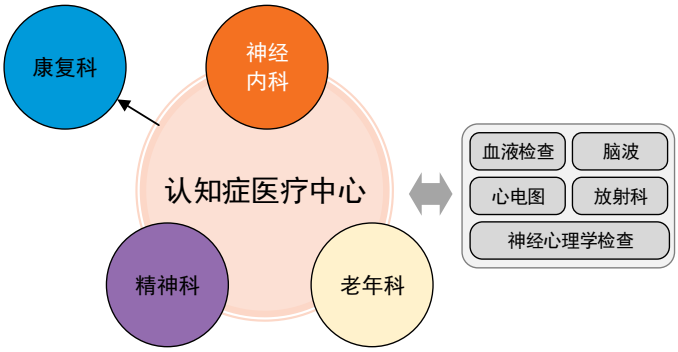


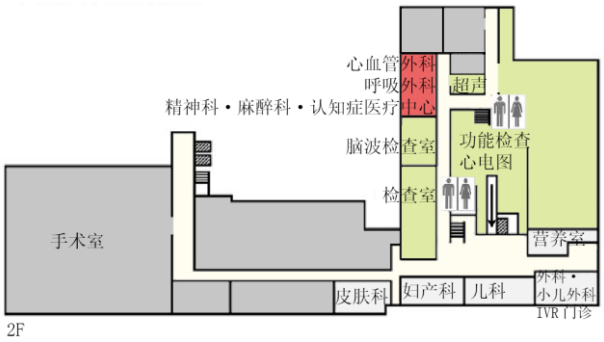
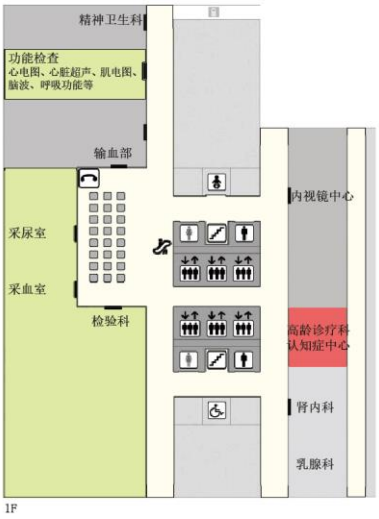
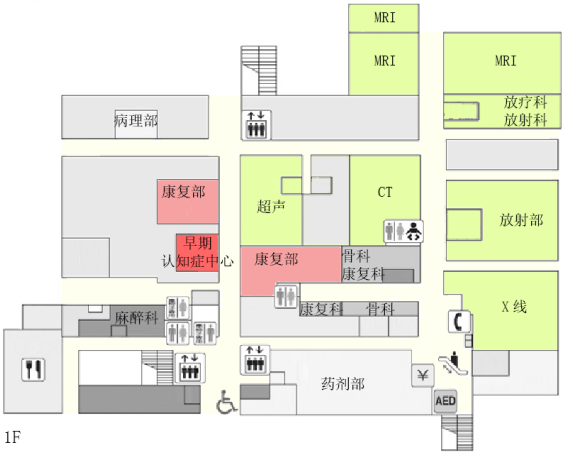
图 2-56 认知症医疗中心主要组成科室、关联科室和涉及医技部门关系图
图片来源：作者自绘

中国知网 https://www.cnki.net

3）位置关系研究

由于不同医院诊疗认知症的主要科室不同，往往各医院会将认知症医疗中心设置在不同的诊疗科内，如京都中部医疗中心将认知症医疗中心设置在精神科；也有医院将认知症医疗中心单独布置，或与相关科室邻近布置，如表 2.63。

表 2.63 认知症医疗中心平面布局特征

布局	案例
1.设置于不同科室内	 京都中部総合医療センター  東京医科大学病院
2.邻近相关科室	千葉大学医学部附属病院
3.单独设置	 近畿大学医学部附属病院

注：图表自制

中国知网 https://www.cnki.net

2.4.10 高血压中心

1）基本情况

高血压可以引起多种疾病，是脑卒中和心脏病的主要原因。高血压发病原因很多，往往需要多学科诊疗，在所研究医院中，诊疗高血压的相关中心包括心脏·高血压中心、高血压中心和肺高血压中心，为便于分析，统称为高血压中心，如图 2-57。

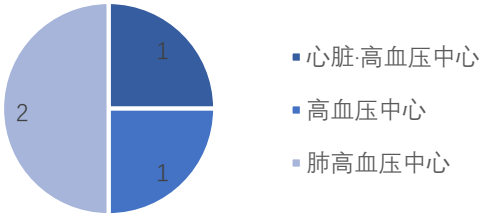


图 2-57 高血压相关中心名称数量统计图
图片来源：作者自绘

综合考虑各医院高血压中心的科室配置、诊疗特点和平面布局特征，选取千叶大学医学部附属医院、神钢纪念医院和国际医疗福祉大学三田医院进行相关研究，基本情况见表 2.64。

表 2.64 各医院高血压中心基本情况一览

医院名称	诊疗中心名称	包含科室	关联科室或诊疗中心	诊疗疾病	诊断	治疗
千葉大学医学部附属病院	肺高血压中心	呼吸内科	呼吸外科 心脏血管外科 心内科 风湿·胶原病内科 儿科 精神科 皮肤科 消化内科 放射科	· 慢性血栓性肺高血压 · 胶原病相关高血压 · 呼吸疾病相关高血压		手术等
神鋼記念病院	高血压中心	心内科 糖尿病·代谢内科 呼吸内科 泌尿科		· 继发性高血压 · 原发性醛固酮增多	采血、造影 CT、负荷检查	药物、手术等
国際医療福祉大学三田病院	肺高血压中心	心脏血管中心		· 肺动脉性高血压 · 胶原病引起的肺高血压 · 肺血栓塞性肺高血压 · 呼吸疾病引起的肺高血压		静脉注射

注：表格自制

2）涉及科室和医技

高血压诊疗往往涉及呼吸内科、心内科和风湿·胶原病科等，由于发病原因不同，一般需要多学科合作诊疗，主要涉及检查为血液检查和放射科检查。见图 2-58。

中国知网 https://www.cnki.net

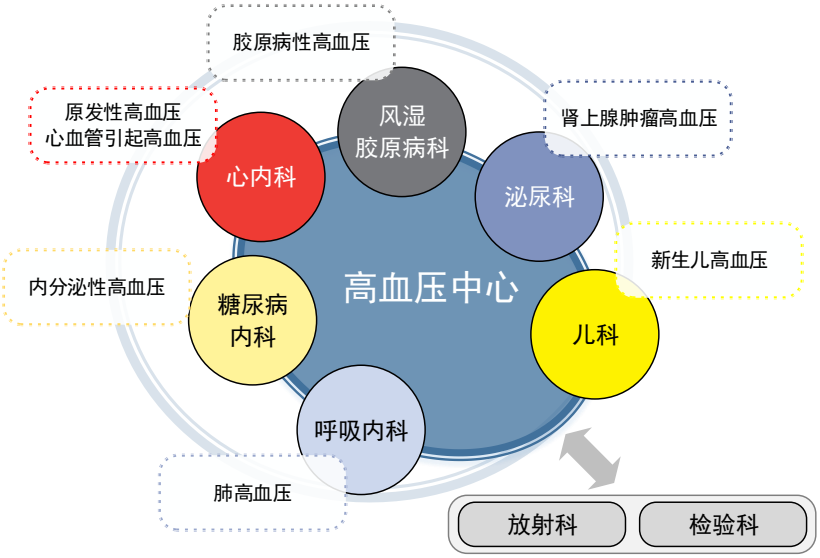


图 2-58 高血压中心主要组成科室、关联科室和涉及医技部门关系图
图片来源：作者自绘

3）位置关系研究

高血压中心一般开设在某一科室内，或将高血压中心与相关科室和医技部邻近设置，以方便患者诊疗，见表 2.65。

表 2.65 高血压中心平面布局特征

布局	案例
1. 开设于某一科室	 千葉大学医学部附属病院
2. 邻近相关科室	 神鋼記念病院

中国知网 https://www.cnki.net

3. 邻近相关科室和检查室

国際医療福祉大学三田病院

注：图表自制

2.4.11 唇腭裂中心

1）基本情况

唇腭裂中心主要诊疗唇腭裂患者，其中以儿童患者为主。通过跟进患儿出生到治疗完成的全过程，以完成对唇腭裂患儿高效的诊疗服务。综合考虑各医院唇腭裂中心科室配置、诊疗特点和平面布局特征，选取东北大学医院和久留米大学医院等在内的 4 所医院进行相关研究分析，基本情况见表 2.66。

表 2.66 各医院唇腭裂中心基本情况一览

医院名称	诊疗中心名称	包含科室	关联科室或诊疗中心	诊疗疾病	诊断	治疗
東北大学病院	唇腭裂中心	整形外科	耳鼻喉科 儿科 口腔科 产科 （心理指导师、言语治疗师）	・ 口唇腭裂等在内的先天性颌面疾病	产科在儿童出生前进行超声诊断	手术治疗、心理治疗、言语治疗
久留米大学病院	唇腭裂・小耳症中心	整形外科・颚颌面外科	耳鼻喉科 儿科 口腔科 麻醉科	・ 唇裂和小耳症（唇耳异形）		手术治疗
東京医科大学病院	唇腭裂中心	儿科	妇产科 儿科 耳鼻喉科 整形外科 口腔科	・ 口唇腭裂	胎儿超声诊断	手术治疗、口腔矫正治疗
東京大学医学部附属病院	唇腭裂中心	口腔科	儿科 耳鼻喉科 麻醉科 产科 儿童外科 康复科	・ 口唇腭裂及面部异常	X 线摄影、CT 摄影、MRI 检查、牙齿印象模型、鼻咽腔纤维检查 [1)]	手术治疗、言语治疗

注：1）该医院口唇腭裂中心属于口腔科，其检查主要为口腔科检查。
表格自制

中国知网 https://www.cnki.net

2）涉及科室和医技

出于对患儿提供全程诊疗的考虑，唇腭裂中心往往由从患儿出生到治愈完成的一些科室合作诊疗，包括妇产科、儿科、口腔科、整形外科、耳鼻喉科、麻醉科和康复科等，主要涉及医技为超声检查，具体科室配置和诊疗流程见图 2-59。

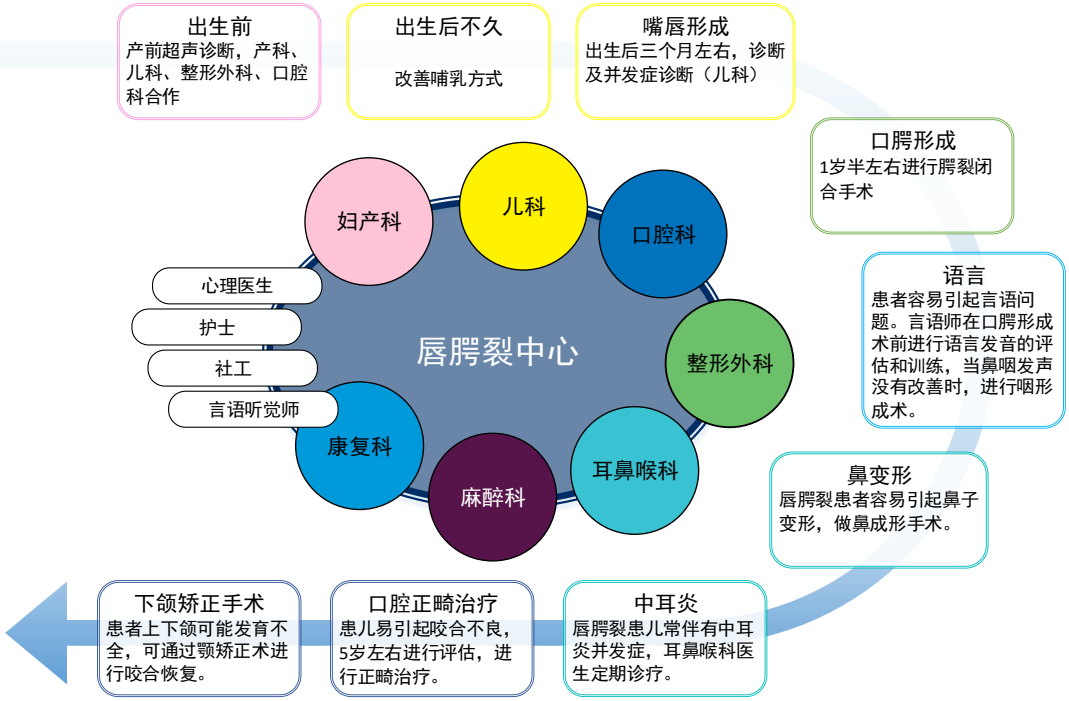


图 2-59 唇腭裂中心主要组成科室、关联科室和涉及医技部门关系图

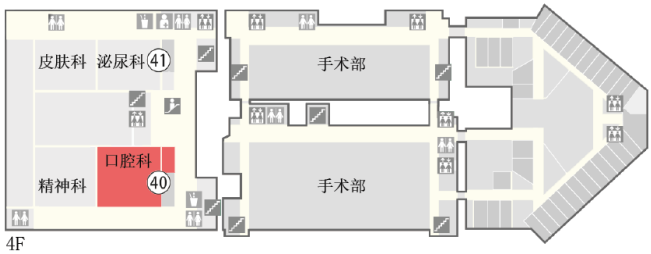
图片来源：作者自绘

注：涉及手术治疗的，往往需要多学科会诊，如口腭形成术，需要口腔科、整形外科、耳鼻喉科、麻醉科合作会诊。唇腭裂治疗往往设有一个主要科室，进行手术整体把控。

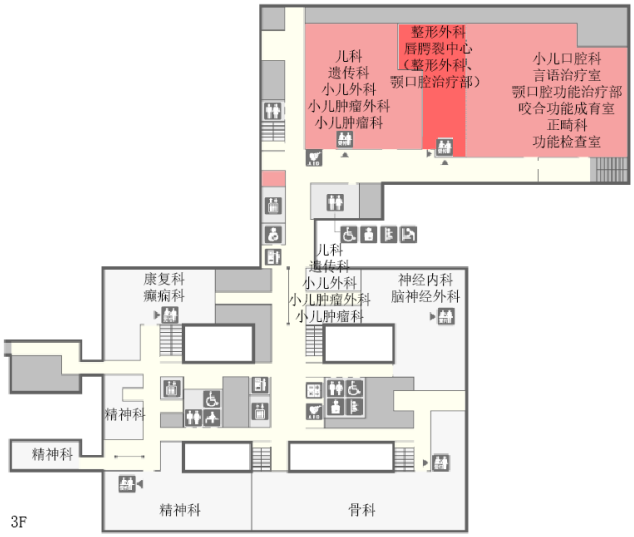
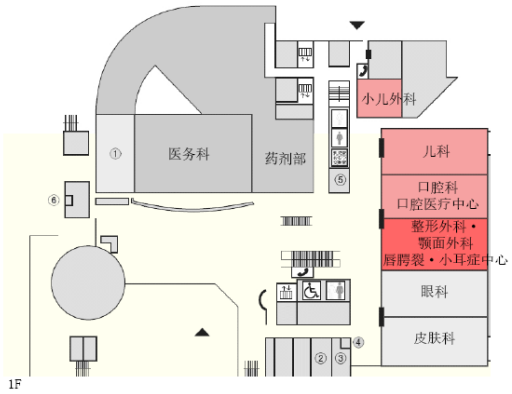
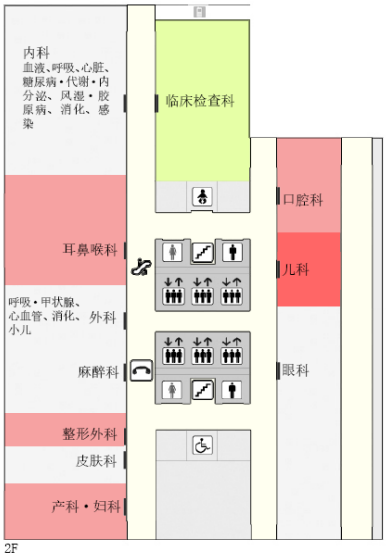
3）位置关系研究

唇颚裂中心的布局差异，主要是设置在不同科室的差异，部分医院会将唇颚裂中心设置在整形外科，并与口腔科和儿科邻近，由整形外科作为主要负责医生，如东北大学医院唇颚裂中心布局；也有医院选择将唇颚裂中心设置在口腔科或儿科，这主要与各医院对唇腭裂诊疗方针有关，见表 2.67。因此，各医院在配置唇腭裂中心时，应根据各自诊疗特点，合理配置。

表 2.67 唇腭裂中心平面布局特征

布局	案例
1. 设于口腔科	 東京大学医学部附属病院

中国知网 https://www.cnki.net

2. 设于整形外科，与口腔科、儿科邻近	 東北大学病院  久留米大学病院
3. 设于儿科	 東京医科大学病院

注：图表自制

2.4.12 脑卒中中心

1）基本情况

脑卒中中心主要是各医院为诊疗脑卒中疾病而设立的。脑卒中是指脑梗塞、脑内出血、蛛网膜下腔出血的总称，强调急性期、慢性期的合作诊疗。在所研究医院中，共 60 所医院设置脑卒中疾病相关中心，包括脑卒中中心和急性脑卒中中心，如图 2-60。

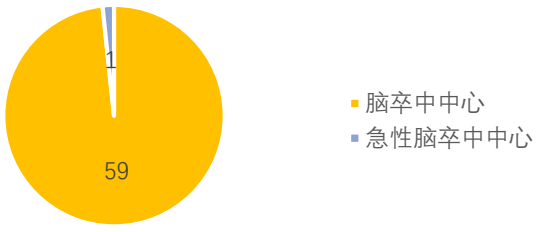


图 2-60 脑卒中相关中心名称数量统计图
图片来源：作者自绘

中国知网 https://www.cnki.net

综合考虑各医院设置脑卒中中心的科室配置、诊疗特点和平面布局特征，选取爱知医科大学医院和关西医科大学附属医院等在内的 4 所医院脑卒中中心进行相关研究分析，基本情况统计见表 2.68。

表 2.68 各医院脑卒中中心基本情况一览

医院名称	诊疗中心名称	包含科室	关联科室或诊疗中心	诊疗疾病	诊断	治疗
関西医科大学附属病院	脑卒中中心	脑神经外科 神经内科 急救科 康复科		· 脑梗塞、脑出血、虹膜下出血	MRI、脑电图、肌电图等	脑血管内治疗等
大分三愛メディカルセンター	脑卒中中心	脑神经外科		· 脑血管障碍 · 脑肿瘤 · 神经机能疾病 · 头部外伤		手术治疗等
京都中部総合医療センター	脑卒中中心	脑神经内科 脑神经外科		· 脑卒中、癫痫、帕金森、阿兹海默症、偏头痛等	血压、检验检查、头部 CT、MRI 等	手术等
愛知医科大学病院	脑卒中中心 脑血管内治疗中心	神经内科 脑神经外科	ICU 急救科 放射科 康复科	· 急性期脑卒中治疗 · 恢复期患者康复 · 慢性期护理	经头颌超声（TCD）、颈动脉超声	药物治疗、IVR 手术治疗等

注：表格自制

2）涉及科室和医技

脑卒中中心主要由脑神经外科、神经内科和脑血管内治疗科构成，主要涉及医技检查为检验科检查、放射科检查、脑电图和心电图检查等。与脑卒中联系较为紧密的科室为急救科和康复科。脑卒中中心强调团队合作，以满足患者从急性期到恢复期到居家的体系化诊疗。见图 2-61。

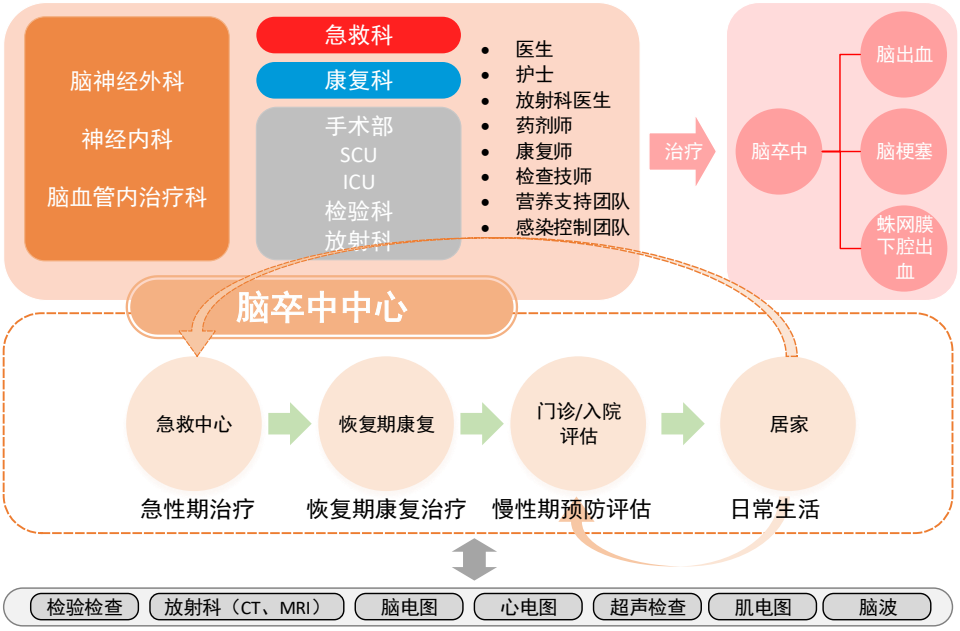


图 2-61 脑卒中中心主要组成科室、关联科室和涉及医技部门关系图

图片来源：作者自绘

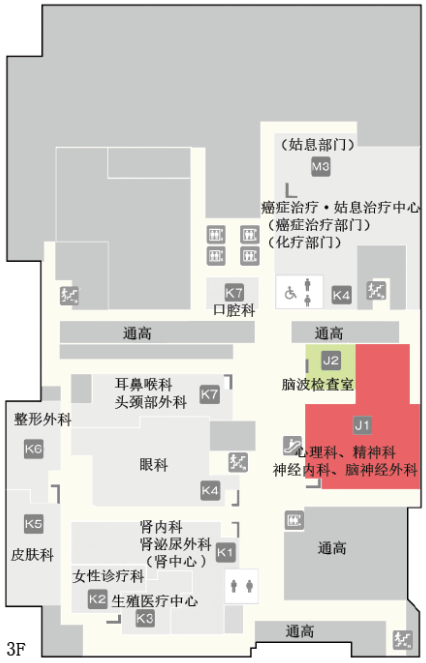
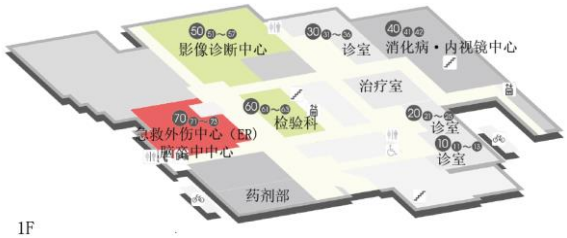
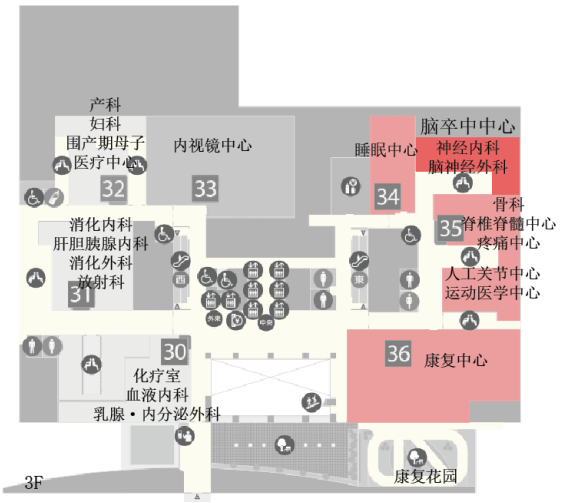
3）位置关系研究

脑卒中作为一种急发性疾病，往往需要及时抢救和治疗，所以脑卒中中心往往邻近急救中心布局。除此之外，在患者居家时，需定时到门诊进行相关预防评估，这时脑卒中中心往

中国知网 https://www.cnki.net

往邻近康复中心或相关医技检查布局。具体情况布局见表 2.69。

表 2.69 脑卒中中心平面布局特征

布局	案例
1.与相关检查室相邻	 関西医科大学附属病院
2.与急救中心相邻	 大分三愛メディカルセンター 京都中部総合医療センター
3.与康复中心相邻	 愛知医科大学病院

注：图表自制

中国知网 https://www.cnki.net

2.4.13 癫痫中心

1）基本情况

癫痫作为一种脑神经疾病中较为常见的慢性疾病，患者人群即包括儿童又包含老人，且会重复性发作。癫痫中心的成立为患者提供跨部门的合作和护理，帮助患者康复以及适应社会生活。综合考虑各医院癫痫中心的科室配置、诊疗特点和平面布局特征，选取包括爱知医科大学医院等在内的 4 所医院进行研究分析，具体情况见表 2.70。

表 2.70 各医院癫痫中心基本情况一览

医院名称	诊疗中心名称	包含科室	关联科室或诊疗中心	诊疗疾病	诊断	治疗
愛知医科大学病院	癫痫中心	精神神经科（成人癫痫中心） 儿科（儿童癫痫中心）	脑神经外科 康复中心	· 癫痫	脑波、PET、SPECT、MRI、遗传诊疗	药物、手术治疗等
順天堂医院	癫痫中心	脑神经外科 脑神经内科 儿科 精神科 放射科		· 癫痫	脑波、脑电图、MRI、神经心理检查、SPECT 检查、脑磁图（MEG）等	药物治疗、手术治疗等
东北大学病院	癫痫中心	癫痫科 神经内科 儿科 脑神经外科 脑功能障碍可 放射科 生理检查中心 护理部 地域合作室		· 癫痫	脑波、MRI、神经心理学检查、脑磁图、脑电图等	药物治疗、手术治疗等
総合病院聖隷浜松病院	癫痫中心	儿科 神经内科 脑神经外科 精神科		· 儿童、成人癫痫	脑波检查、影像检查（MRI、SPECT、PET）等	药物、手术治疗、带刺激治疗等

注：表格自制

2）涉及科室和医技

癫痫中心主要由脑神经外科、神经内科、精神科和儿科进行合作诊疗，涉及医技检查包括脑电图、脑磁图、神经心理学检查和放射科相关检查等，常与康复科合作，进行康复训练，见图 2-62。

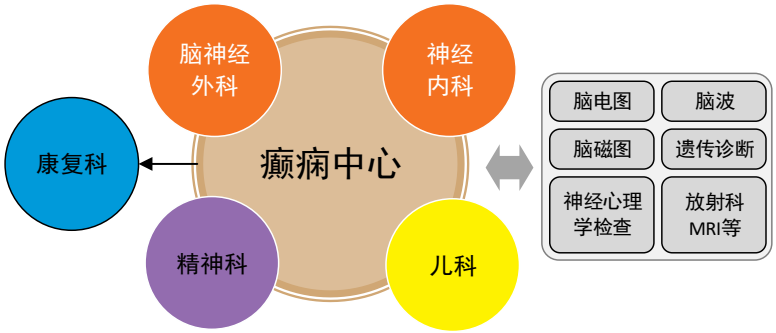


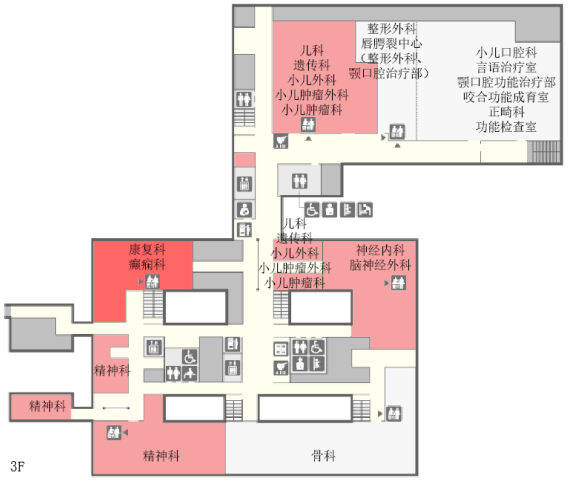
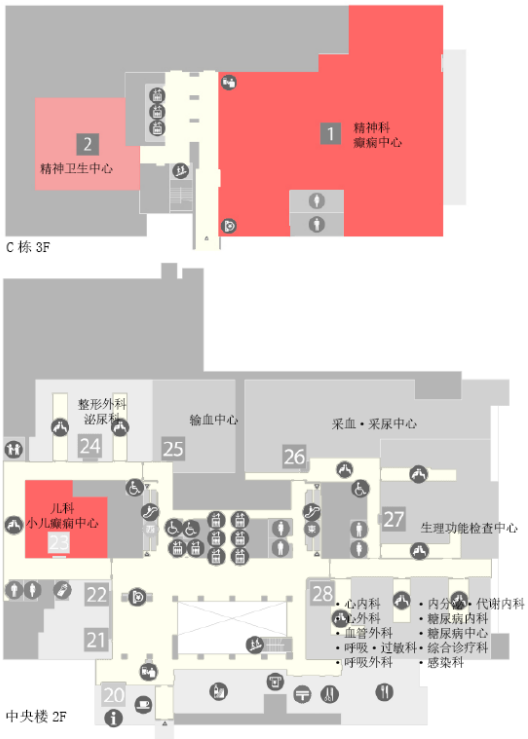
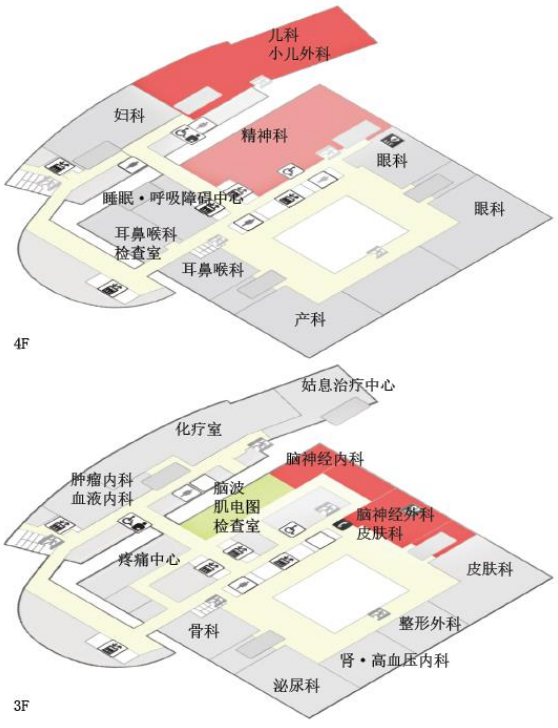
图 2-62 癫痫中心主要组成科室、关联科室和涉及医技部门关系图
图片来源：作者自绘

中国知网 https://www.cnki.net

3）位置关系研究

癫痫中心的布局除了一般分科诊疗外，还可设置独立的癫痫中心，邻近相关科室布局，见表 2.71。

表 2.71 癫痫中心平面布局特征

布局	案例
1.邻近相关科室	 东北大学病院 総合病院聖隷浜松病院
2.设置于不同科室内	 愛知医科大学病院  順天堂医院

注：图表自制

2.5 小结

显然，不同医院不同种类的诊疗中心诊疗特点、科室构成、涉及医技和平面布局等方面都各有特点，它们往往根据各医院诊疗理念、各中心门诊量和医护资源等条件进行针对性的计划设计。通过总结各类型诊疗中心的科室配置、诊疗特点和平面布局类型，为医院集中优

中国知网 https://www.cnki.net

势资源邻近就相关科室和医技部门，方便患者诊疗、提高医疗效率打下理论基础，并可得出各大类诊疗中心平面布局特点：

1.脏器中心：主要诊疗特定脏器类疾病，科室构成以合作诊疗脏器器官的外科为主，该类中心内往往可内设主要检查设施或邻近相关医技部门布置。通过完整构建相关科室和医技，脏器中心可独立布局或邻近住院部布局，以方便患者门诊——住院一体化诊疗。

2.系统中心：主要诊疗身体特定系统类疾病，科室构成以合作诊疗该系统相关科室为主，该类系统中心往往内设相关检查设备或邻近相关医技部门布局，同样科室构成较完善的系统中心可独立区域布局。

3.疾病中心：主要诊疗某类特定疾病，科室构成以诊疗该疾病的科室为主，关联诊疗该疾病引起的并发症的科室，常需要跨部门，多科室合作诊疗。常常呈诊疗中心邻近相关并发症科室布局的态势。

除此之外，还有某些诊疗中心由于患者隐私和安全性考虑，倾向于单独布置，如精神卫生中心、生殖医疗中心和儿童中心等。

综上，从诊疗中心层面研究可以窥探各科室间合作、相关医技邻近科室布局的可能，为医院统筹邻近相关科室、医技布局、方便患者诊疗和医院成立诊疗中心打下物质基础。

中国知网 https://www.cnki.net

第 3 章 不同医院诊疗中心配置研究

3.1 总述

在日本，医疗设施的种类主要分为医院、一般诊所、口腔科诊所三类，如图 3-1。本文研究对象主要为除却精神病院的医院类建筑。通过分析日本不同规模和不同类型医院诊疗中心配置数量、配置种类和平面布局特征，探讨医院如何配置诊疗中心、配置多少诊疗中心和医院层面下科室与医技位置关系。

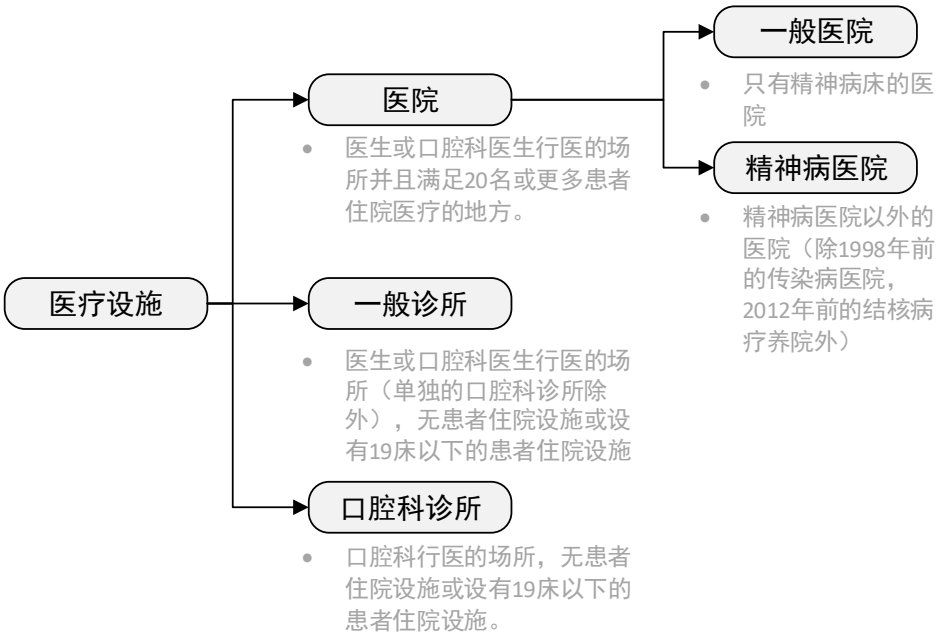


图 3-1 日本医疗设施的分类

图片来源：根据日本官方厚生劳动省对医疗设置种类的分类（http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/iryosd/16/dl/gaikyo.pdf），整理绘制而成

3.2 不同规模医院诊疗中心配置研究

3.2.1 分类

1）规模选择

日本官方在统计医院数量时，常按 20-49 床,50-99 床等进行分类统计，见表 3.1。通过借鉴此种分类方式，对本文所选 294 所医院案例按照此种方法进行归纳，得到不同规模医院诊疗中心数量配置箱式图，如图 3-2。可以看出 200-299 床和 300-399 床,400-499 床和 500-599 床医院诊疗中心数量配置类似，因此，根据图 3-2 不同规模医院诊疗中心配置数量的类似性和规模间隔统一性，选择以 200 床为分界原则，即 20-199 床，200-399 床，400-599 床，600-799 床和 800 床以上 5 类，对所研究案例进行重新归纳分析。

中国知网 https://www.cnki.net

表 3.1 病床规模分类与施设个数

截止至每年 10 月 1 日

	设施数		与去年相比		构成比（1%）	
	平成 28 年（2016）	平成 27 年（2015）	增减数	增减率（%）	平成 28 年（2016）	平成 27 年（2015）
医院	8442	8480	△ 38	△ 0.4	100	100
20 ~ 49 床	919	942	△ 23	△ 2.4	10.9	11.1
50 ~ 99	2120	2127	△ 7	△ 0.3	25.1	25.1
100 ~ 149	1423	1429	△ 6	△ 0.4	16.9	16.9
150 ~ 199	1331	1338	△ 7	△ 0.5	15.8	15.8
200 ~ 299	1136	1121	15	1.3	13.5	13.2
300 ~ 399	706	711	△ 5	△ 0.7	8.4	8.4
400 ~ 499	389	387	2	0.5	4.6	4.6
500 ~ 599	174	179	△ 5	△ 2.8	2.1	2.1
600 ~ 699	106	106	－	－	1.3	1.3
700 ~ 799	54	54	－	－	0.6	0.6
800 ~ 899	31	31	－	－	0.4	0.4
900 床以上	53	55	△ 2	△ 3.6	0.6	0.6
一般诊所（有床）	7629	7961	△ 332	△ 4.2	100	100
1 ~ 9 床	2234	2358	△ 124	△ 5.3	29.3	29.6
10 ~ 19	5395	5603	△ 208	△ 3.7	70.7	70.4

注：表格来源于日本官方厚生劳动省 2017 年对医疗设施调查统计（http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/79-1.html）

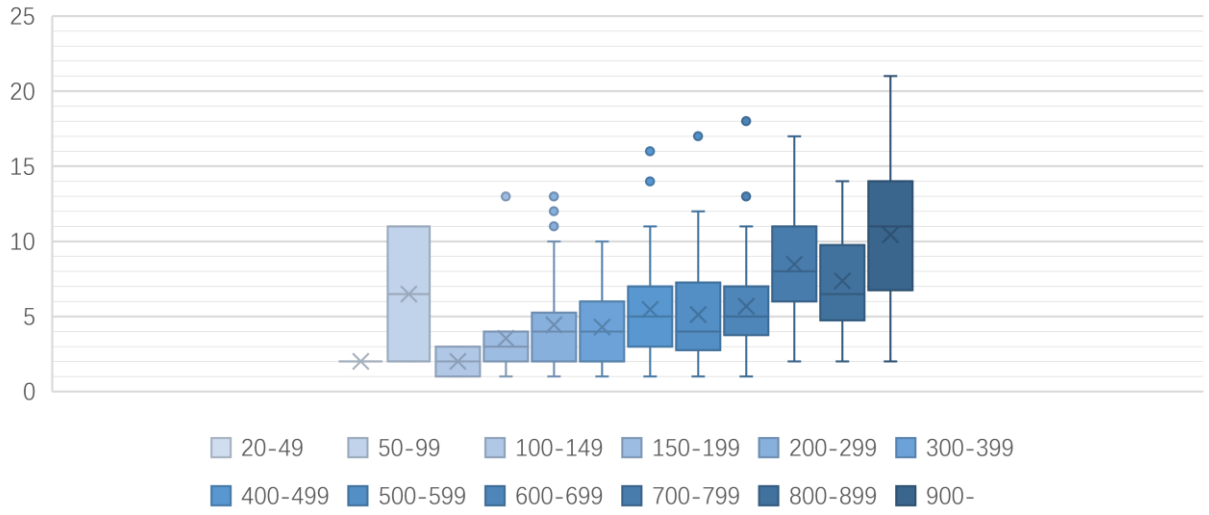


图 3-2 不同规模医院诊疗中心数量配置箱式图
图片来源：作者自绘

2）对象统计

对本文研究所选 294 家医院，按 200 床规模分类进行划分统计，得到表 3.2 和图 3-3。其中研究所选 20-199 床规模医院 16 所，200-399 床规模医院 93 所，400-599 床规模医院 86 所，600-799 床规模医院 55 所，800 床以上规模医院 44 所。

表 3.2 选取案例医院规模数量与总医院规模数量统计表

医院规模（床）	20-199	200-399	400-599	600-799	800-
研究医院个数	16	93	86	55	44
总医院数 [1)]	5793	1842	563	160	84
研究医院数量占总医院数量比率	0.28%	5.05%	15.28%	34.38%	52.38%

注：1）数据重新统计借鉴于日本官方厚生劳动省 2017 年对医疗设施调查统计（http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/79-1.html）
表格自制

中国知网 https://www.cnki.net

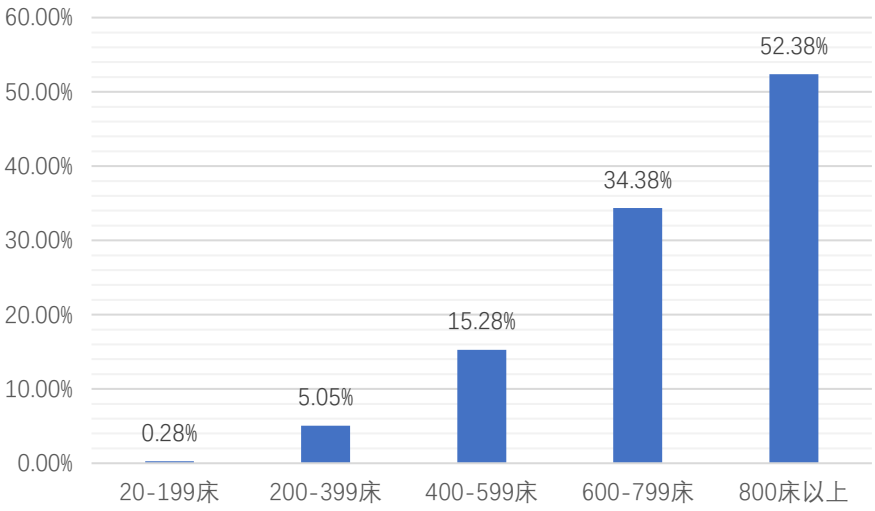


图 3-3 不同规模医院占各规模医院总数比率图
图片来源：作者自绘

3.2.2 20-199 床

1）配置数量

按诊疗中心数量对所选 20-199 床规模医院进行分类统计，得到表 3.3。并绘制出相关的诊疗中心数量与医院数量关系图，见图 3-4。综合表 3.3 和图 3-4，得出 20-199 床规模医院大多数配置诊疗中心的数量在 2-3 个之间。其中仅有 2 所医院诊疗中心的数量配置超过 5 个。配置诊疗中心数最多的医院为福冈山王医院，诊疗中心数量为 13 个。

表 3.3 20-199 床规模医院诊疗中心数量配置基本信息表

诊疗中心数量	医院名称	病床数	日门诊人次	日住院人数
1	泰玄会病院	133	242	93
	小松病院	190	600	
	土庫病院	199	313	179
2	井上病院	46		
	真生会富山病院	99	914	95
	洛和会丸太町病院	150	343	122
	福西会病院	198	316	172
3	佐野病院	131		
	札幌共立五輪橋病院	188	180	130
	長津田厚生総合病院	190		
	鹿島労災病院	199	269	37
	神戸百年記念病院	199	506	112
4	大分三愛メディカルセンター	179	258	162
	西宮渡辺病院	192	181	110
11	山王病院	79	795	61
13	福岡山王病院	199	663	148

注：以上数据来源于各医院官网、病院情报局等相关资料

中国知网 https://www.cnki.net

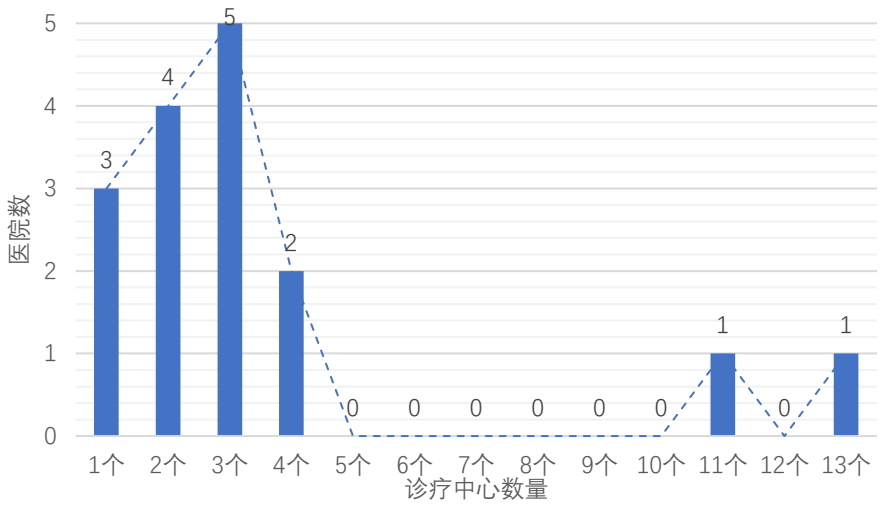


图 3-4　20-199 床规模医院诊疗中心数量与医院数量关系图
图片来源：作者自绘

2）配置种类

20-199 床规模医院，诊疗中心数量配置最多的是消化系统中心，其次为心脏（心血管）中心、肾脏中心。见图 3-5。总的来看，20-199 床规模医院，多设置脏器中心和系统中心、疾病中心设置量较少。见图 3-6。

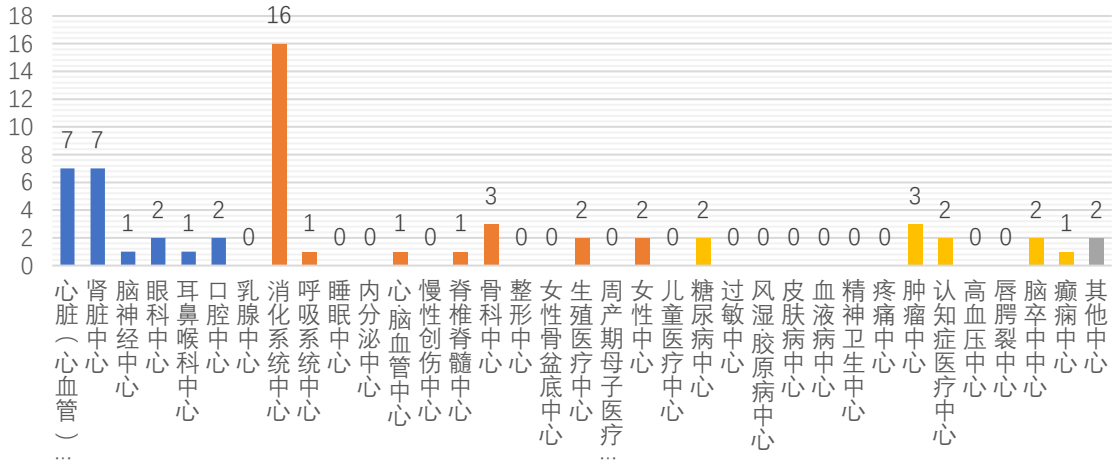


图 3-5　20-199 床规模医院诊疗中心配置种类统计图
图片来源：作者自绘

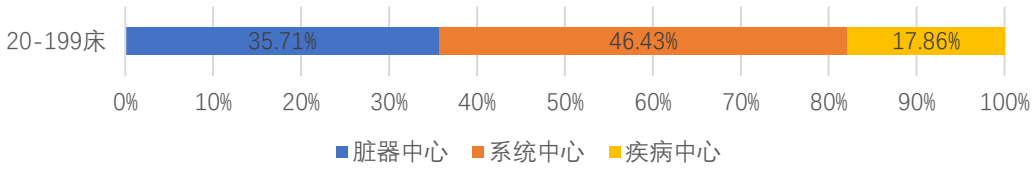


图 3-6　20-199 床规模医院各类中心配置数量相对比率图
图片来源：作者自绘

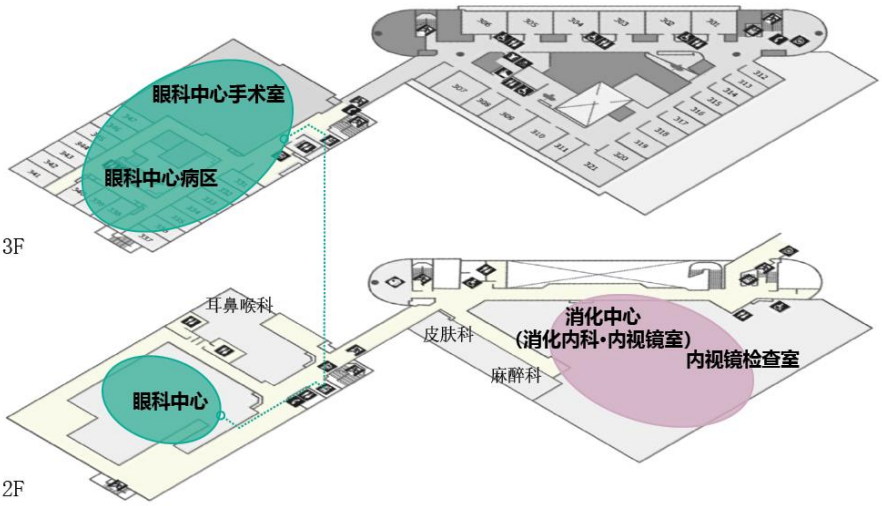
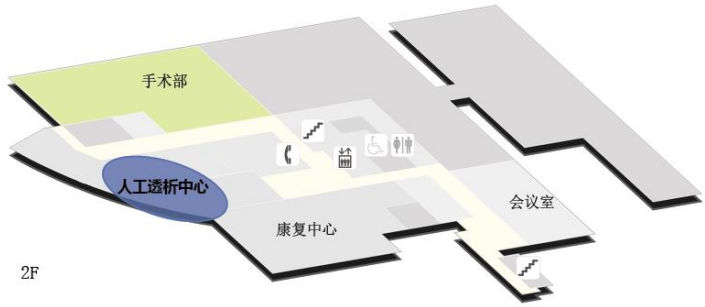
3）位置关系

由于 20-199 床规模医院诊疗中心设置数量相对较少（2 个左右），中心多以脏器中心和系统中心为主，中心间联系较弱，所以诊疗中心的布局往往呈中心间独立的趋势。各医院诊疗中心布局区别在于诊疗中心与医技间的位置关系，相关医技检查可于中心内布置，也可邻

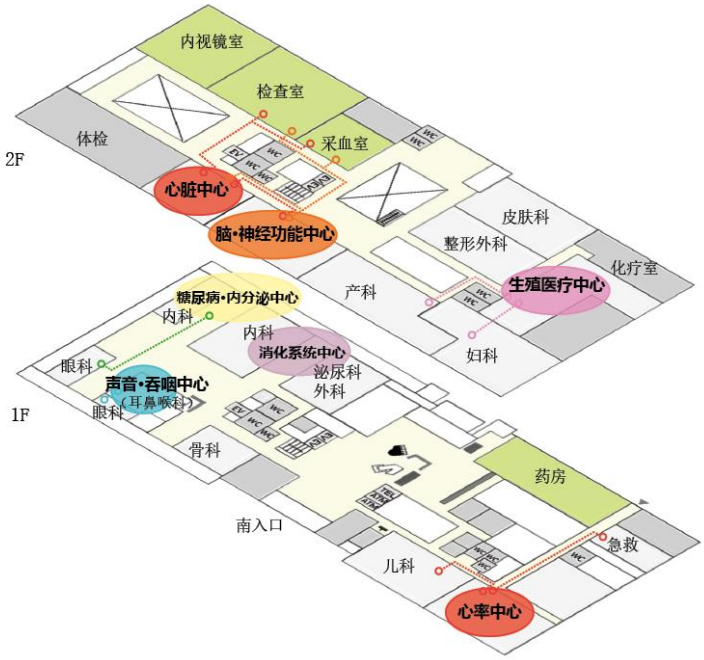
中国知网 https://www.cnki.net

近中心或混合布置，见表 3.4。

表 3.4　20-199 床规模医院诊疗中心平面布局特征

位置关系	医院名称	主要诊疗中心数量及种类	布局分析
1.中心间独立，中心内设相关医技	真生会富山病院	2 消化系统中心 眼科中心	
2.中心间独立，医技邻近	鹿島労災病院	3 心理健康和中医诊疗科 消化系统中心 脊髓·腰痛中心	
3.中心间独立，医技内设或相邻	大分三愛メディカルセンター	4 脑卒中中心（脑神经外科） 消化病·内视镜中心（消化外科·消化内科） 运动器官中心（骨科） 人工透析中心（泌尿科）	

中国知网　https://www.cnki.net

4:相关中心关联，部分医技邻近	福岡山王病院	13 糖尿病・内分泌中心 消化系统中心 肝脏・胆・胰腺・神经内分泌肿瘤中心 心率中心 心脏中心 排便功能中心 关节外科中心 脑・神经功能中心 癫痫・睡眠中心 声音・吞咽中心 生殖医疗中心 血液透析中心 胆石症中心	

注：图表自制

3.2.3 200-399 床

1）配置数量

通过对所选案例 200-399 床规模医院按诊疗中心数量分类统计，得到表 3.5，并绘出图 3-7 所示诊疗中心数量和医院数量关系图。可以看出，200-399 床规模医院诊疗中心的设置数量多在 2-4 个之间，有少部分医院诊疗中心的配置数量超过 10 个。

表 3.5 200-399 床规模医院诊疗中心配置基本信息表

诊疗中心数量	医院名称	病床数	日门诊人次	日住院人数
1	高萩協同病院病院	220	393	91
	出水郡医師会広域医療センター	222	183	
	土浦協同病院なめがた地域医療センター	230	484	115
	函館協会病院	286	298	
	つくばセントラル病院	313	719	237
	下関医療センター	315	586	183
	興生総合病院	323	545	195
	筑波学園病院	331	945	238
	坂総合病院	357	830	330
	伊那中央病院	394	860	325
2	柏市立柏病院	200	529	143
	宇城総合病院	204	252	190
	西の京病院	248	445	143
	常滑市民病院	267	579	209
	国際親善総合病院	287	720	240
	新小山市民病院	300	624	210
	藤沢湘南台病院	322	545	187
	名城病院	326	530	260
	松阪市民病院	328	628	278

中国知网 https://www.cnki.net

	石切生喜病院	331	931	
	新松户中央総合病院	333	869	278
	彩の国東大宮メディカルセンター	337	644	287
	大分赤十字病院	340	507	292
	NTT 西日本大阪病院	341	774	219
	上都賀総合病院	352	803	293
	福岡県済生会福岡総合病院	380	547	320
3	大濱第一病院	214	567	212
	横浜新緑総合病院	236		
	葛城病院	243	396	213
	高の原中央病院	249	419	158
	金沢赤十字病院	262	522	172
	城山病院	299	511	272
	朝倉医師会病院	300		230
	大阪回生病院	300	930	192
	北アルプス医療センター　あづみ病院	320	691	206
	札幌東徳洲会病院	325	532	284
	神鋼記念病院	333	1098	309
	岸和田徳洲会病院	341	877	328
	兵庫県立 姫路循環器病センター	350	362	222
	PL 病院	370	930	274
	名鉄病院	373	619	290
	池上総合病院	384	850	305
	武田病院	394	715	253
4	練馬総合病院	224	500	180
	福島県立医科大学 会津医療センター	226	503	157
	市立貝塚病院	249	613	168
	荻窪病院	252	617	234
	HITO 病院	257	282	150
	千葉中央メディカルセンター	272	661	231
	牧田総合病院	284	700	
	大船中央病院	285	735	192
	小林病院	300		
	鎌ケ谷総合病院	306	800	290
	行徳総合病院	307	421	152
	千葉メディカルセンター	315	937	224
	日本大学病院	320	1032	276
	藤元総合病院	343	627	233
	河内総合病院・森本記念クリニック	350	475	258
	JA 尾道総合病院	393	746	335
5	久留米大学医療センター	250	518	
	吉田病院	263	187	228
	倉敷成人病センター	269	120	243
	緑成会横浜総合病院	300	780	247
	昭和大学江東豊洲病院	303	478	284
	河北総合病院	331	1190	354
	湘南東部総合病院	348		
	日生病院	350	883	281
	府中病院	380	880	364
	川崎市立 井田病院	383	702	279

中国知网 https://www.cnki.net

	新東京病院	396	28	321
6	イムス三芳総合病院	273	555	209
	日高病院	287	274	231
	福岡和白病院	369	495	
	坂文種報德會病院	370	665	296
	国立長寿医療研究センター	383	601	255
	耳原総合病院	386	403	326
7	南奈良総合医療センター	232	442	138
	福岡市立こども病院	239	289	184
	川崎幸病院	326	308	136
8	神户赤十字病院	310	511	285
	市立奈良病院	350	765	283
	市立池田病院	364	891	327
	福山医療センター	374	703	303
9	複十字病院	339	530	
	長野松代総合病院	365	900	320
10	時計台記念病院	250	49	197
	医誠会病院	327	334	283
	北里大学北里研究所病院	329	907	157
	岡山ろうさい病院	358	835	289
	りんくう総合医療センター	388	824	345
11	東大和病院	284	447	247
12	北斗病院	267	203	194
13	国際医療福祉大学三田病院	291	827	213

注：以上数据来源于各医院官网、病院情报局等相关资料

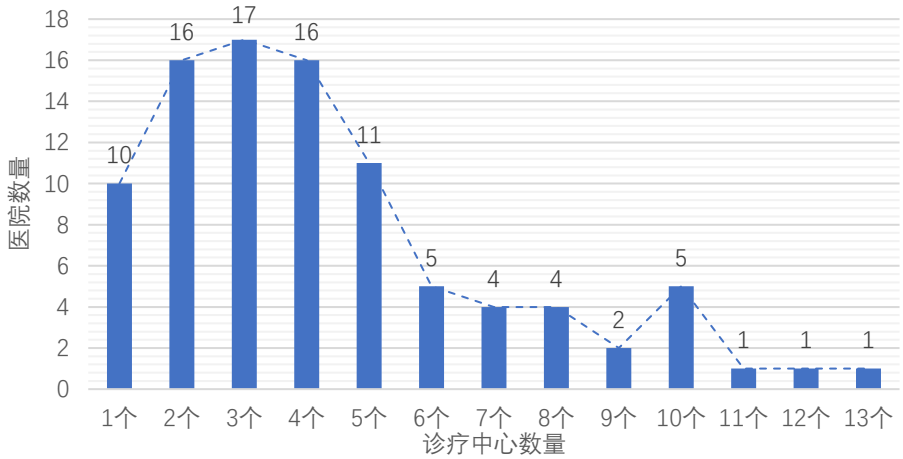


图 3-7 200-399 床规模医院诊疗中心数量与医院数量关系图
图片来源：作者自绘

2）配置种类

对研究案例各类中心进行统计，结果如图 3-8 所示。可见，200-399 床医院诊疗中心设置消化系统中心数量最多，其次为肾脏中心、心脏（心血管）中心和肿瘤中心。在脏器中心中，肾脏中心、心脏（心血管）中心和脑神经中心设置量较多；系统中心中，消化系统中心、骨科中心和呼吸系统中心设置量较多；疾病中心中，肿瘤中心、糖尿病中心和脑卒中中心设置量较多。总的来看，脏器中心、系统中心和疾病中心设置数量均衡，约各占 30%，见图 3-9。

中国知网 https://www.cnki.net

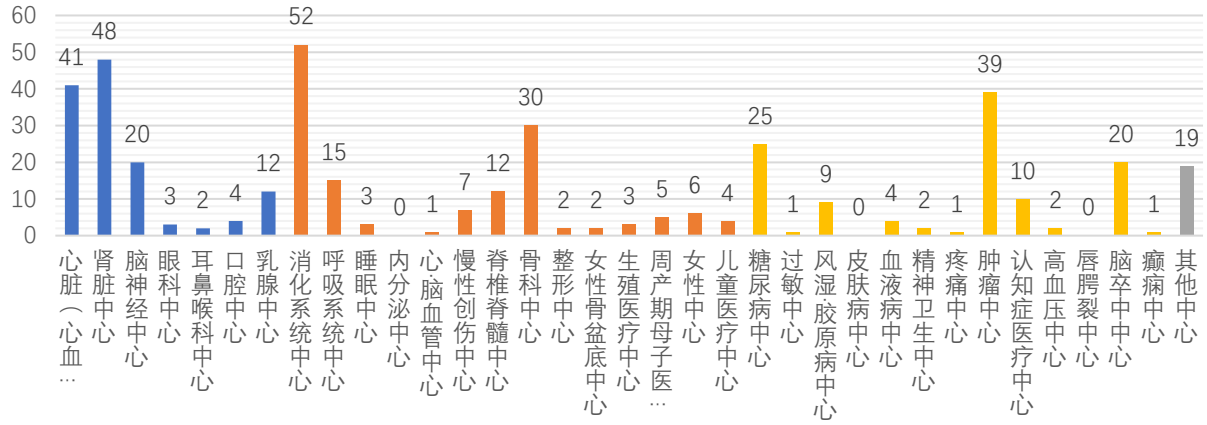


图 3-8　200-399 床规模医院诊疗中心配置种类统计图
图片来源：作者自绘

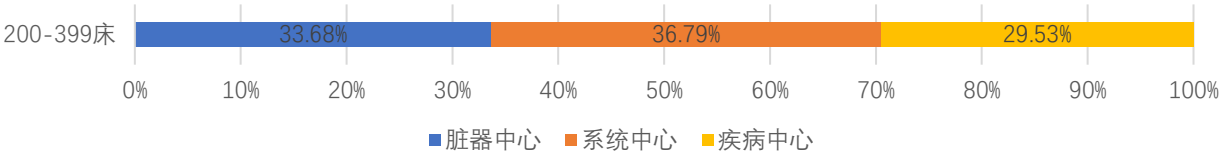
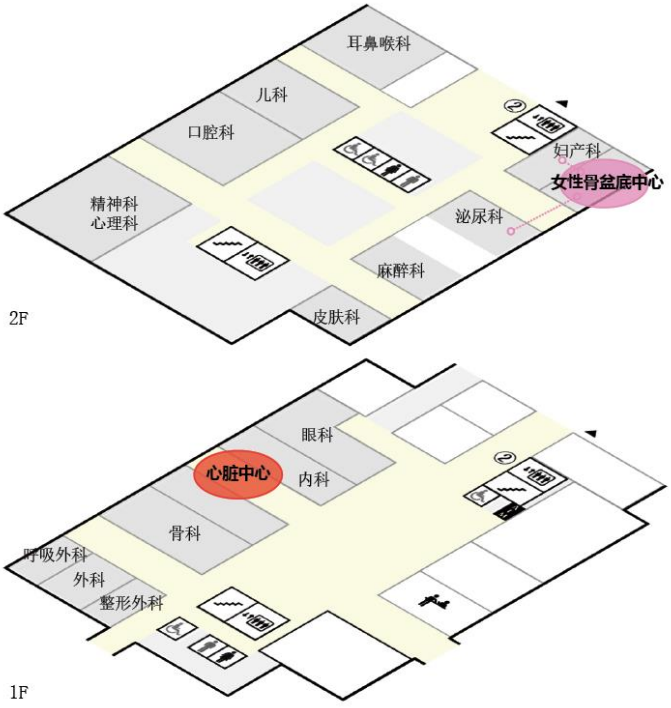


图 3-9　200-399 床规模医院各类中心配置数量相对比率图
图片来源：作者自绘

3）位置关系

由于 200-399 床规模医院诊疗中心设置数量多在 3 个左右，脏器中心、系统中心和疾病中心设置数量均衡（约各占 30% ），所以相关科室呈现邻近诊疗中心布局的趋势，诊疗中心与诊疗中心间呈现一定关联性，相关医技则呈现集中布置或与诊疗中心关联分散布局的形态，见表 3.6。

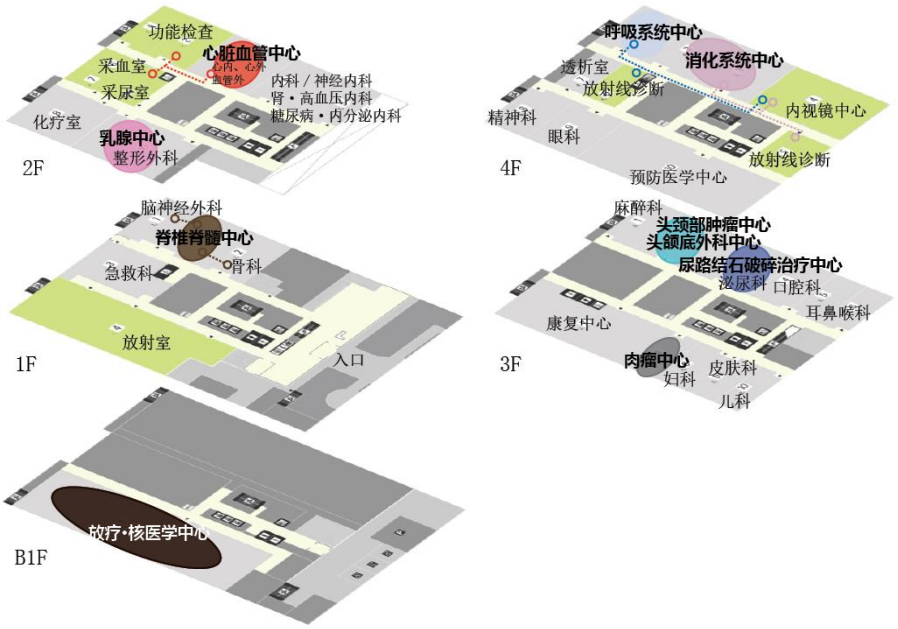
表 3.6　200-399 床规模医院诊疗中心平面布局特征

位置关系	医院名称	主要中心数量及种类	布局分析
1.中心间独立，相关科室相邻	北アルプス医療センター　あづみ病院	3 女性骨盆底中心 肩关节治疗中心 心脏病中心	

中国知网　https://www.cnki.net

2. 中心间独立，中心内设或邻近相关医技	高の原中央病院	3 消化内视镜中心 心脏中心 人工透析中心	
	千葉メディカルセンター	4 运动医学中心 消化系统中心 心脏血管中心 不孕不育治疗中心	
3. 相关中心关联，医技集中设置	市立奈良病院	8 脑·神经中心 消化肝脏病中心 头颈部·甲状腺癌症中心 乳腺中心 四肢外伤中心 视网膜晶状体中心 人工关节中心 脑卒中中心	

中国知网 https://www.cnki.net

4:相关中心关联，中心邻近相关科室，相关医技分散相邻	国际医疗福祉大学三田病院	13 心脏血管中心 尿路结石破碎治疗中心 肺高血压中心 女性肿瘤中心·妇科 脊椎脊髓中心 耳鼻喉科（听觉·人工内耳中心） 头颈部肿瘤中心 头颌底外科中心 消化中心 肉瘤中心 乳腺中心 呼吸中心 放疗·核医学中心	

注：图表自制

3.2.4　400-599 床

1）配置数量

通过对 400-599 床规模医院案例按诊疗中心数量分类归纳，得到表 3.7，并绘出如图 3-10 所示的诊疗中心数量与医院数量关系图。可以看出，400-599 床规模医院，设置 4 个诊疗中心医院数量最多，而设置超过 10 个诊疗中心的医院屈指可数，诊疗中心数量设置最多的医院为济生会横滨市东部医院，设有 17 个诊疗中心。

表 3.7　400-599 床规模医院诊疗中心配置基本信息表

诊疗中心数量	医院名称	病床数	日门诊人次	日住院人数
1	市立岸和田市民病院	400	1019	322
	日本医科大学多摩永山病院	401	841	305
	飯田市立病院	423	926	307
	潤和会記念病院	446	263	386
	德山中央病院	507	1384	454
	広島赤十字・原爆病院	565	1467	482
2	近江八幡市立総合医療センター	407	896	362
	松阪中央総合病院	440	747	338
	船橋市立医療センター	449	908	384
	三豊総合病院	478	1037	412
	三井記念病院	482	1110	410
	筑波記念病院	487	197	394
	近森病院	512	524	395
	東京新宿メディカルセンター	520	1141	406
	青梅市立総合病院	562	1302	393
	福岡東医療センター	591	423	

中国知网　https://www.cnki.net

3	春日部中央総合病院	404	680	340
	仙台厚生病院	409	401	412
	けいゆう病院	410	1270	334
	公立甲賀病院	413	987	320
	国立がん研究センター（東病院）	425		
	静岡市立清水病院	475	706	326
	熊本赤十字病院	490	1221	447
	医仁会武田総合病院	500	1456	411
	岩国医療センター	530	699	434
	香川県立中央病院	533	949	421
	東京都健康長寿医療センター	550	802	475
	金沢医療センター	554	707	427
4	長野市民病院	400	997	320
	京都岡本記念病院	419	599	312
	平塚共済病院	441	913	364
	佐久医療センター	450	751	428
	高崎総合医療センター	451	793	380
	京都中部総合医療センター	464	578	296
	市立旭川病院	478	982	334
	立川綜合病院	481	1100	420
	戸田中央総合病院	492	1222	401
	住友病院	499	1281	408
	名古屋市立西部医療センター	500	1015	420
	松波総合病院	501	395	413
	公立昭和病院	518	1030	387
	津山中央病院	535	911	433
	京都市立病院	548	1303	460
	板橋中央総合病院	579	1001	430
5	東京労災病院	400	913	318
	関西電力病院	400	908	320
	東京警察病院	415	1172	327
	相模原協同病院	437	1243	370
	JR 東京総合病院	448	1464	292
	大雄会について	454	424	370
	大崎市民病院	500	1030	327
	市川総合病院	570	1373	443
6	湘南藤沢徳洲会病院	419	987	362
	北播磨総合医療センター	450	927	391
	製鉄記念八幡病院	453	502	359
	ベルランド総合病院	477	866	456
	市立砺波総合病院	514	951	359
	北海道がんセンター	520	613	372
7	済生会熊本病院	400	503	381
	総合病院 回生病院	402	594	283
	北里大学東病院	413	864	151
	釧路ろうさい病院	450	969	379
	木沢記念病院	452	860	446
	仙台西多賀病院	480	123	403
	国立成育医療研究センター	490	977	385
	茨城県立中央病院・茨城県地域がんセンター	500	1031	401

中国知网 https://www.cnki.net

8	立川病院	450	950	400
	宇治徳洲会病院	473	1375	339
	岡山済生会総合病院	553	967	513
9	篠ノ井総合病院	433	821	404
	勤医協中央病院	450	500	430
	総合東京病院	451	501	264
	福井県済生会病院	460	1295	428
	東京西徳洲会病院	486	700	400
	中東遠綜合醫療センター	500	1262	384
	洛和会音羽病院	548	1403	361
	昭和大学藤が丘病院	584	1105	505
10	高槻病院	477	1143	421
11	江戸川病院	418	277	346
	熊本医療センター	550	640	454
12	聖路加国際病院	520	2700	490
14	国立精神・神経医療研究センター	474	478	231
	堺市立総合医療センター	487	767	392
16	関西医科大学総合医療センター	477	1296	469
17	済生会横浜市東部病院	560	1075	490

注：以上数据来源于各医院官网、病院情报局等相关资料

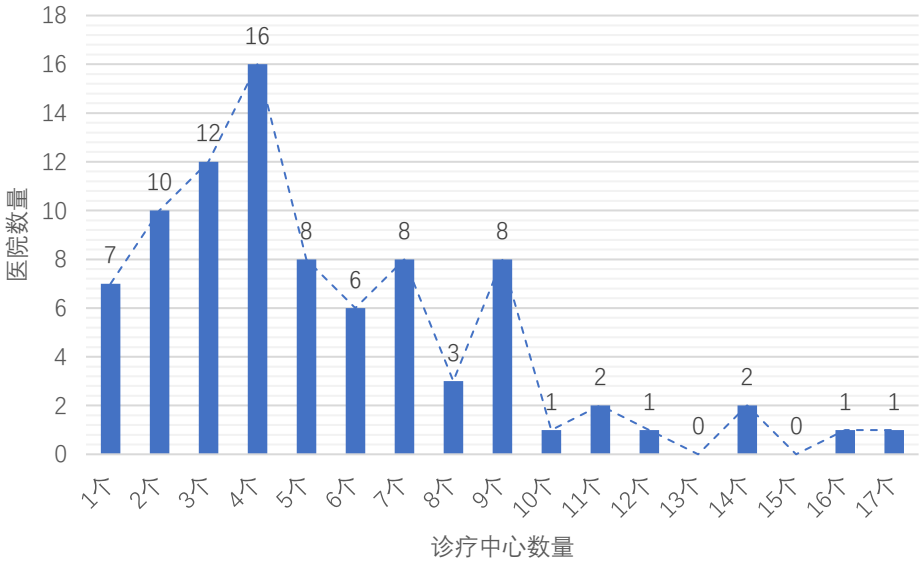


图 3-10　400-599 床规模医院诊疗中心数量与医院数量关系图
图片来源：作者自绘

2）配置种类

400-599 床规模医院肿瘤中心的配置数量最多，其次为心脏（心血管）中心和肾脏中心。在脏器中心中，心脏（心血管）中心、肾脏中心和脑神经中心设置量较多；系统中心中，消化系统中心、骨科中心和呼吸系统中心设置量较多；疾病中心中，肿瘤中心、糖尿病中和脑卒中中心设置量较多。见图 3-11。总的来看，脏器中心、系统中心和疾病中心设置比率均衡（约各占 30%），见图 3-12。

中国知网　https://www.cnki.net

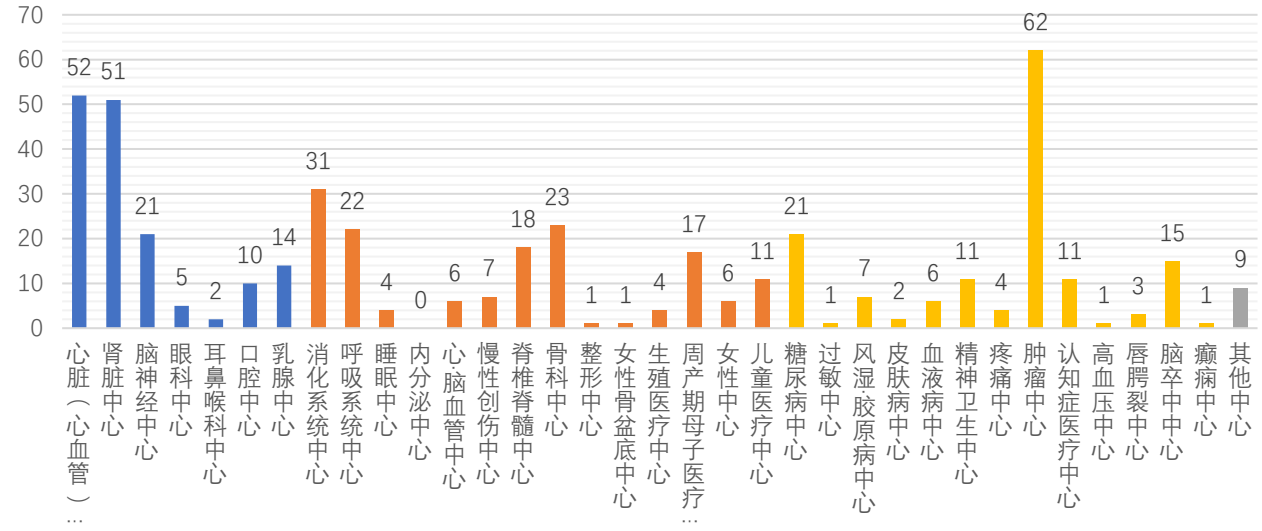


图 3-11　400-599 床规模医院诊疗中心配置种类统计图
图片来源：作者自绘

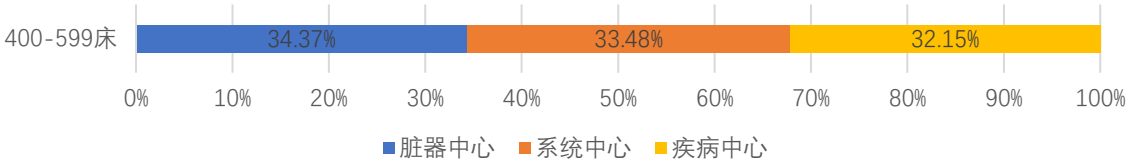


图 3-12　400-599 床规模医院各类中心配置数量相对比率图
图片来源：作者自绘

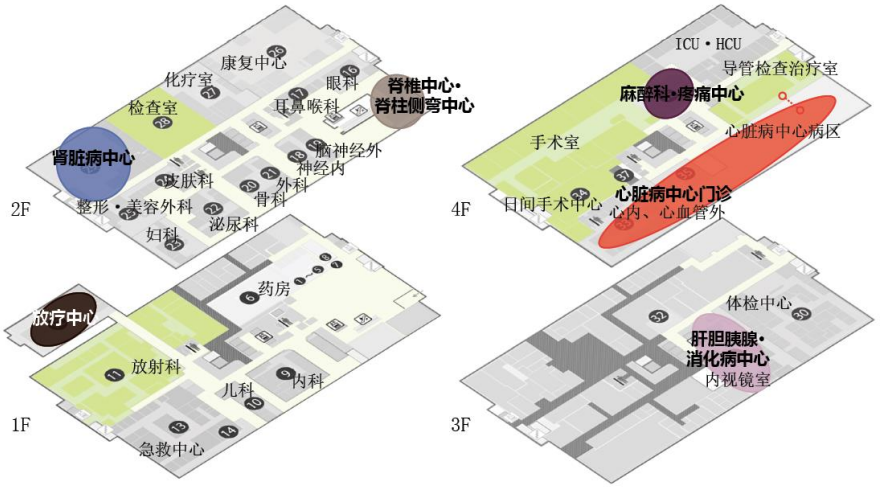
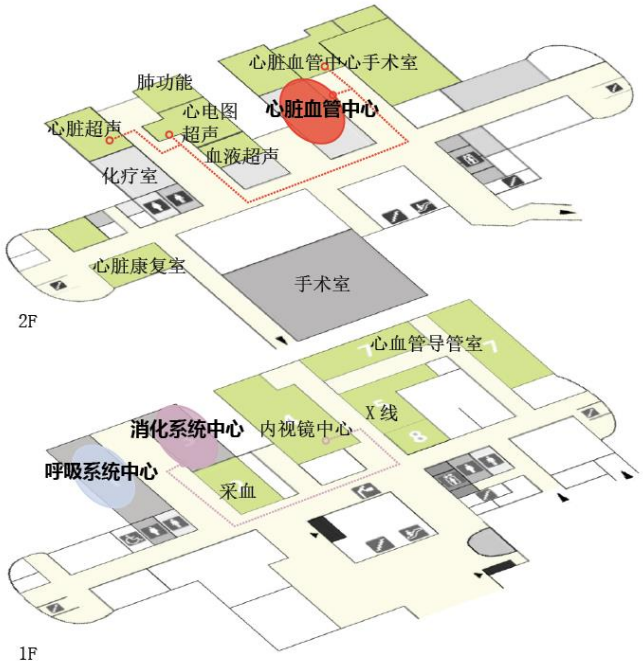
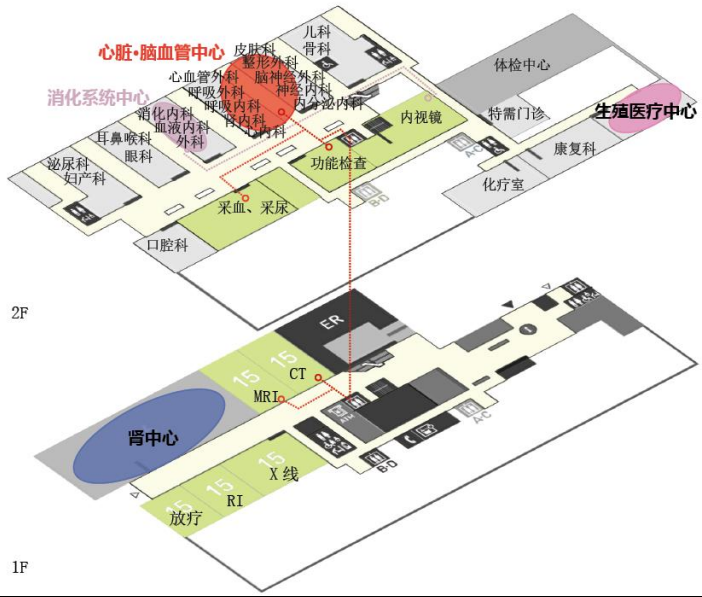
3）位置关系

该类型医院由于设置诊疗中心数量较多（4 个左右），脏器中心、系统中心和疾病中心设置均衡（约各占 30%），所以 400-599 床规模医院出现诊疗中心间关联的布局趋势，相关医技则出现内设、集中邻近和分散邻近诊疗中心的情况，见表 3.8。

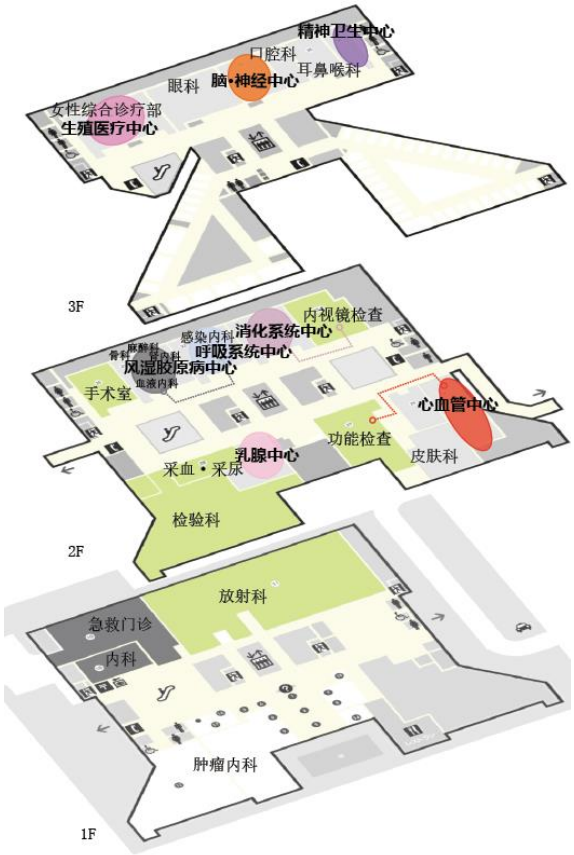
表 3.8　400-599 床规模医院诊疗中心平面布局特征

位置关系	医院名称	主要中心数量及种类	布局分析
1.中心独立，内设主要医技检查	潤和会記念病院	1 脑神经中心	

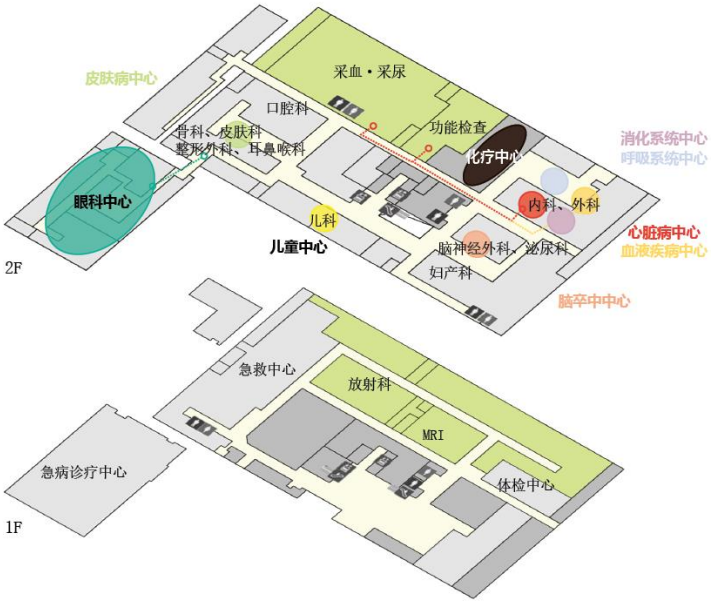
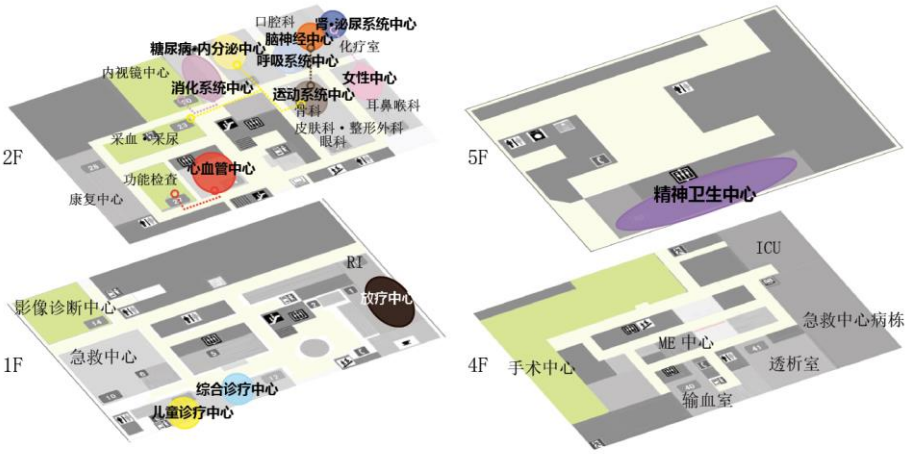
中国知网 https://www.cnki.net

	湘南藤沢德洲会病院	6 心脏病中心 肾病中心 肝胆胰腺·消化病中心 脊椎中心·脊柱侧弯中心 放疗中心 麻醉科·疼痛中心	
2.中心间独立，医技分散相邻	仙台厚生病院	3 心脏血管中心 呼吸系统中心 消化系统中心	
3.中心间独立，相关科室相邻，医技集中相邻	立川綜合病院	4 心脏·脑血管中心 消化系统中心 生殖医疗中心 肾中心	

中国知网 https://www.cnki.net

4. 相关中心间关联，医技集中邻近	篠ノ井総合病院	9 人工肾中心 风湿胶原病中心 心脏血管中心 关节疾病运动障碍治疗中心 地域周产期母子医疗中心 结石治疗中心 睡眠呼吸中心 糖尿病中心 不孕不育治疗中心	
5. 相关中心关联，相关医技分散邻近	聖路加国際病院	12 呼吸系统中心 消化系统中心 儿童综合医疗中心 心血管中心 肾中心 运动医疗中心 脑・神经中心 乳房中心 风湿胶原病中心 精神卫生中心 生殖医疗中心 认知症疾病医疗中心	

中国知网 https://www.cnki.net

6.相关中心关联，相关医技集中邻近	堺市立総合医療センター	14 综合诊疗中心 癌症中心 消化系统中心 呼吸系统中心 心脏病中心 肾・透析中心 脑卒中中心 糖尿病中心 血液疾病中心 风湿胶原病中心 儿童中心 皮肤病中心 乳腺中心 眼科中心	
	済生会横浜市東部病院	17 综合诊疗中心 消化系统中心 呼吸系统中心 心脏血管中心 糖尿病・内分泌中心 肾泌尿系统中心 脑神经中心 女性中心 儿童中心 精神卫生中心 运动系统中心 感觉・口腔中心 放疗中心 主动脉治疗中心 前列腺治疗中心 瓣膜治疗中心 癌症中心	

注：图表自制

3.2.5　600-799 床

1）配置数量

对 600-799 床规模研究医院按诊疗中心数量分类统计，见表 3.9，并绘出诊疗中心数量与医院数量关系图，见图 3-13。其中，较多 600-799 床规模医院配置 7 个诊疗中心。其中爱媛大学医学部附属医院配置诊疗中心数量最多，高达 18 个。

表 3.9　600-799 床规模医院诊疗中心配置基本信息表

诊疗中心数量	名称	病床数	日门诊人次	日住院人数
1	東京医科大学八王子医療センター	610	1162	485
	国立循環器病研究センター	612	623	480
	新潟市民病院	676	839	612

中国知网　https://www.cnki.net

	三重大学医学部附属病院	685	1288	600
	大阪医療センター	692	1138	518
2	国立国際医療研究センター（国府台病院）	622		
	山梨県立中央病院	647	1117	483
	仙台医療センター	689	963	540
	名古屋医療センター	740	1377	558
3	宮崎大学医学部附属病院	632	1058	547
	草津総合病院	719	705	304
4	国立がん研究センター（中央病院）	600	1301	524
	岐阜県総合医療センター	604	1349	532
	市立豊中病院	613	1199	520
	山形大学医学部附属病院	637	1245	545
	日立総合病院	651	1001	419
	高知医療センター	660	873	494
	刈谷豊田総合病院	710	1898	658
5	加古川中央市民病院	600	1300	500
	滋賀医科大学医学部附属病院	612	1315	542
	富山大学附属病院	612	1245	470
	香川大学医学部附属病院	613	932	427
	岐阜大学医学部附属病院	614	1325	491
	昭和大学横浜市北部病院	689	1138	603
6	長崎医療センター	643	750	503
	横浜市立大学附属病院	674	1874	561
	青森県立中央病院	684	1306	583
	がん研有明病院	700	1569	606
	県立広島病院	712	1253	601
	東京医療センター	760	1607	560
	いわき市立総合磐城共立病院	761	902	547
7	松戸市立病院	600	929	416
	京都医療センター	600	1362	507
	旭川医科大学病院	602	1553	503
	佐賀大学医学部附属病院	604	933	503
	浜松医療センター	606	940	522
	NTT 東日本関東病院	627	1914	428
	横浜市立市民病院	650	1373	550
	鹿児島大学病院	716	1279	565
8	関西医科大学附属病院	751	1920	701
9	京都第一赤十字病院	666	1404	537
	北野病院	699	1779	609
	呉医療センター	700	1014	486
	総合病院聖隷浜松病院	750	1615	695
10	淀川キリスト教病院	630	1156	564
	市民総合医療センター	726	2053	651
	山口大学医学部附属病院	736	1271	619
11	千葉西総合病院	608	1419	541
	横浜労災病院	650	1898	572
12	九州医療センター	702	889	561
	信州大学医学部附属病院	707	1509	599
13	湘南鎌倉総合病院	648	1427	570

中国知网 https://www.cnki.net

17	安城更生病院	749	1873	710
	大阪急性期・総合医療センター	768	1249	686
18	愛媛大学医学部附属病院	644	1237	519

注：以上数据来源于各医院官网、病院情报局等相关资料

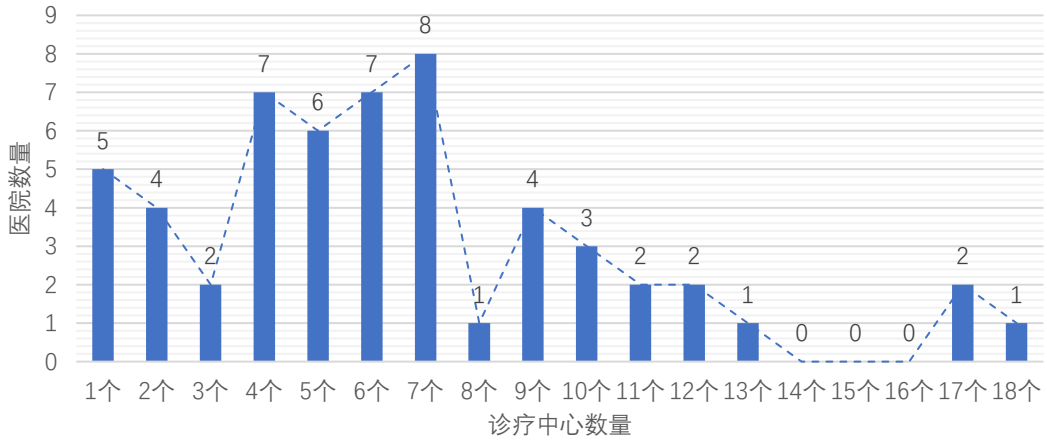


图 3-13　600-799 床规模医院诊疗中心数量与医院数量关系图
图片来源：作者自绘

2）配置种类

600-799 床规模医院肿瘤中心的配置数量最多，其次为心脏（心血管）中心、消化系统中心和周产期母子医疗中心。在脏器中心中，心脏（心血管）中心、肾脏中心和脑神经中心设置量较多；系统中心中，消化系统中心、周产期母子医疗中心和呼吸系统中心设置量较多；疾病中心中，肿瘤中心、糖尿病中心和脑卒中中心设置量较多，见图 3-14。总的来看，脏器中心、系统中心和疾病中心设置均衡（约各占 30%），见图 3-15。

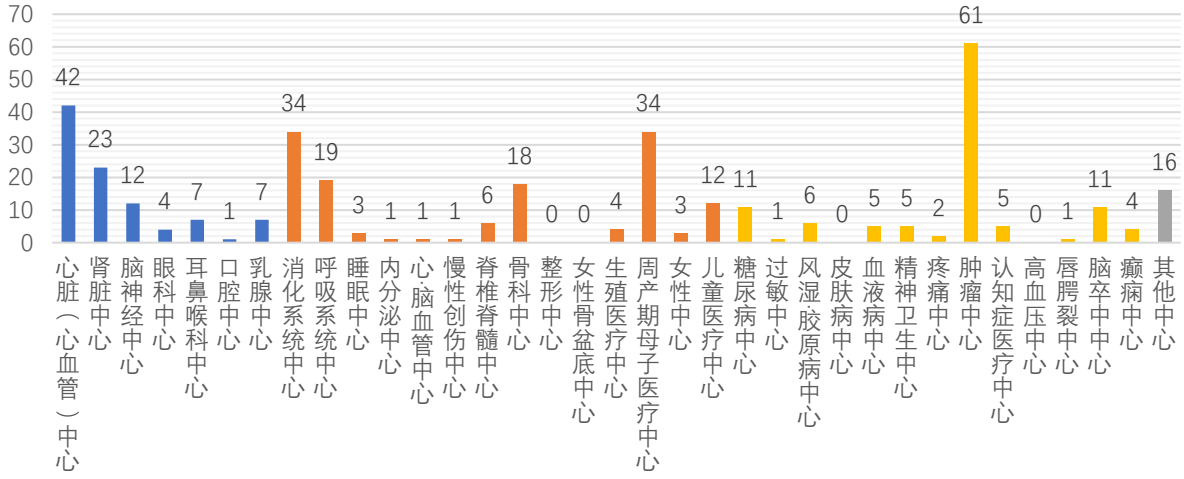


图 3-14　600-799 床规模医院诊疗中心配置种类统计图
图片来源：作者自绘

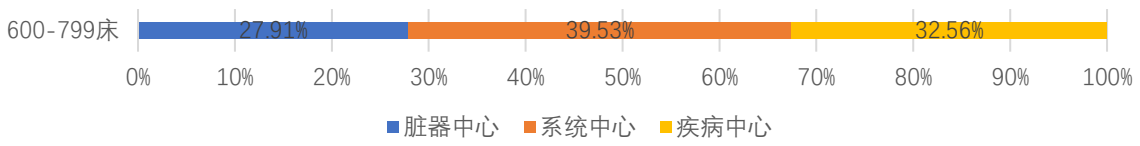


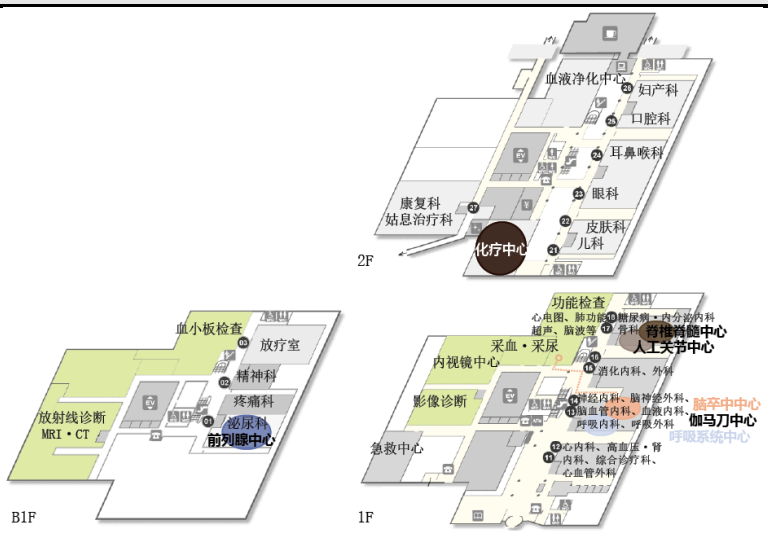
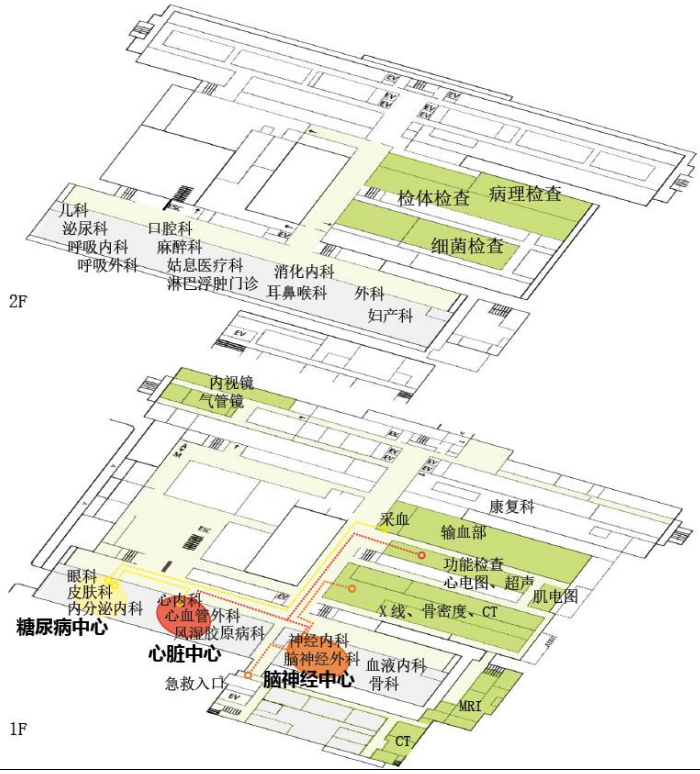
图 3-15　600-799 床规模医院各类中心配置数量相对比率图
图片来源：作者自绘

中国知网 https://www.cnki.net

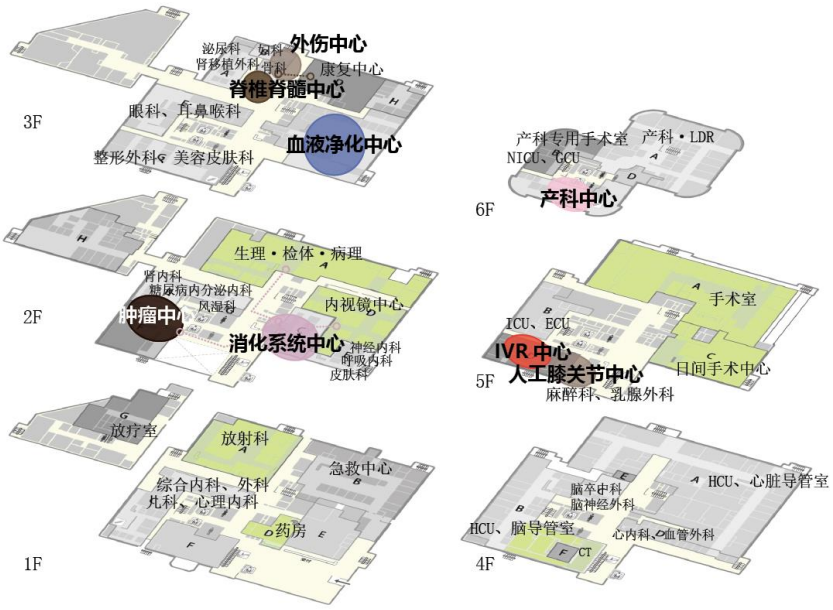
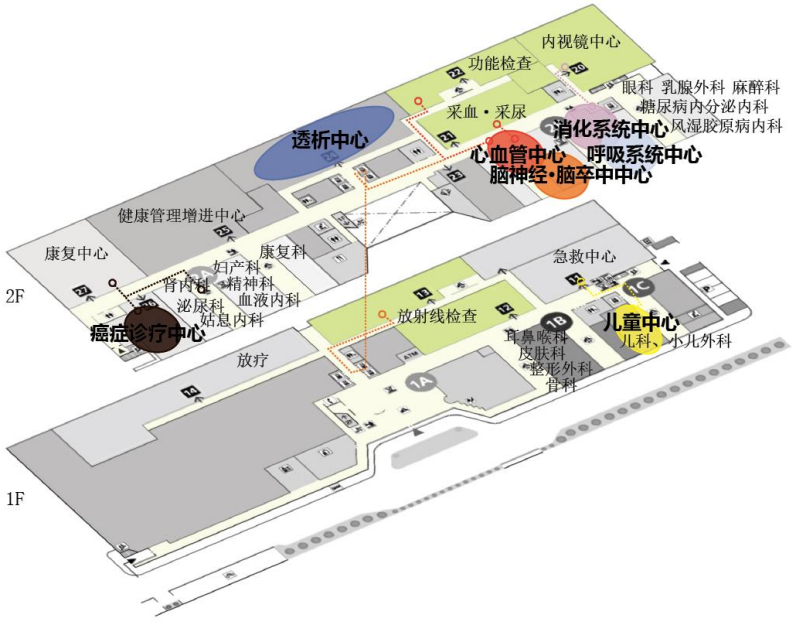
3）位置关系

由于 600-799 床规模医院诊疗中心的相对设置数量在 7 个左右，脏器中心、系统中心和疾病中心设置均衡（约各占 30%），因此诊疗中心间呈关联布局状，相关医技也呈集中邻近和分散邻近的布局特征，见表 3.10。

表 3.10　600-799 床规模医院诊疗中心平面布局特征

位置关系	医院名称	主要中心数量及种类	布局分析
1. 中心间独立，医技相邻	NTT 東日本関東病院	7 呼吸系统中心 人工关节中心 脊椎·脊髓中心 前列腺中心 脑卒中中心 化疗中心 伽马刀中心	
2. 相关中心间关联，相关医技集中相邻	青森県立中央病院	6 癌症诊疗中心 姑息治疗中心 心脏中心 脑神经中心 糖尿病中心 综合周产期母子医疗中心	

中国知网 https://www.cnki.net

3.相关中心关联，相关科室邻近，相关医技分散邻近	湘南鎌倉総合病院	13 肾脏病综合医疗中心 血液净化中心 SAS 中心 消化系统中心 主动脉中心 脊椎脊髓中心 外伤中心 产科中心 人工膝关节中心 肿瘤中心 未来医疗研究中心 日间护理中心 IVR 中心	
4.相关中心关联，相关科室邻近，相关医技集中邻近	淀川キリスト教病院	10 癌症诊疗中心 母子中心 脑神经・脑卒中中心 消化系统中心 呼吸系统中心 心脏血管中心 助产中心 化疗中心 儿童医疗中心 人工透析中心	

注：图表自制

3.2.6 800 床以上

1）配置数量

对 800 床以上规模医院按诊疗中心数量进行分类统计，见表 3.11，并绘出相应的诊疗中心数量与医院数量关系图，见图 3-16。可以得出，多数 800 床以上规模医院诊疗中心设置数量在 13 个，而东邦大学医疗中心-大森医院则设置多达 21 个诊疗中心。

表 3.11 800 床以上规模医院诊疗中心配置基本信息表

诊疗中心数量	医院名称	病床数	日门诊人次	日住院人数
2	竹田綜合病院	837	1176	641
	大阪赤十字病院	999	2076	728
	飯塚病院	1048	1896	894
3	日本大学医学部附属板橋病院	1025	2211	783

中国知网 https://www.cnki.net

	藤田保健衛生大学病院	1435	2236	1261
4	天理よろづ相談所病院	815	2038	571
	大阪医科大学附属病院	882	1979	709
5	和歌山県立医科大学附属病院	800	1509	658
	福井県立病院	880	1115	655
	東京慈恵医科大学附属病院	1075	2769	867
	岩手医科大学附属病院	1166	1470	766
6	名古屋市立大学病院	808	1750	683
	虎の門病院	868	2794	752
	北海道大学病院	944	3073	828
7	東海大学医学部付属病院	804	2528	773
	帝京大学医学部附属病院	1078	1643	800
	倉敷中央病院	1166	2708	1073
8	国立国際医療研究センター（病院）	801	1912	670
	岡山大学病院	855	2561	667
	順天堂医院	1026	3900	945
	杏林大学医学部付属病院	1153	2205	809
9	愛媛県立中央病院	827	1664	643
	近畿大学医学部附属病院	929	2044	766
	埼玉医科大学病院	972	1836	643
	東京大学医学部附属病院	1217	2926	1043
10	慶應義塾大学病院	1044	3064	785
12	千葉大学医学部附属病院	850	2139	706
	京都府立医科大学附属病院	1065	2113	624
	九州大学病院	1275	2943	1124
13	昭和大学病院	815	1442	666
	奈良県立医科大学附属病院	992	1995	685
	東京医科大学病院	1015	2621	813
	久留米大学病院	1025	1761	775
	大阪市立総合医療センター	1063	1818	833
	東京女子医科大学病院	1379	3552	990
14	熊本大学医学部附属病院	848	1487	753
	獨協医科大学病院	1167	2118	1007
	聖マリアンナ医科大学病院	1208	2316	843
15	東北大学病院	1225	2244	1021
16	川崎医科大学附属病院	1182	1750	646
17	愛知医科大学病院	900	2541	741
	大阪大学医学部附属病院	1086	2393	907
18	自治医科大学附属病院	1132	2631	873
21	東邦大学医療センター　大森病院	948	2353	822

注：以上数据来源于各医院官网、病院情报局等相关资料

中国知网 https://www.cnki.net

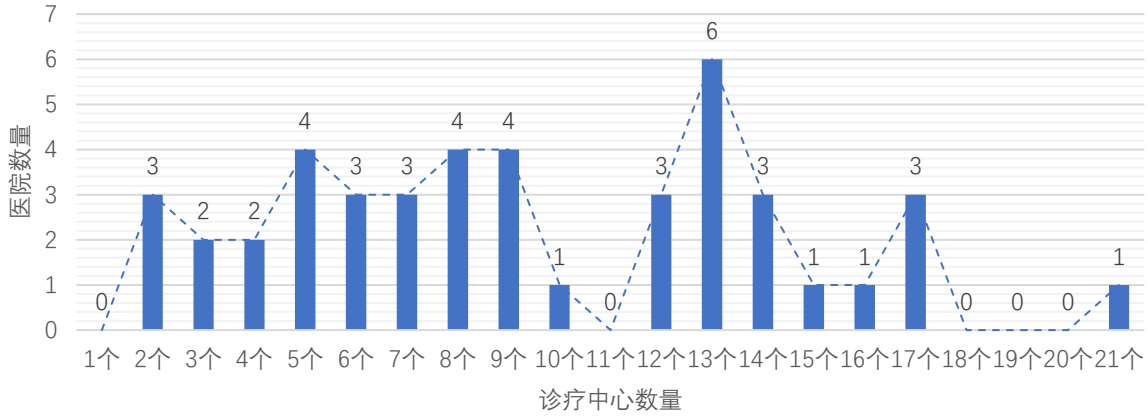


图 3-16　800 床以上规模医院诊疗中心数量与医院数量关系图
图片来源：作者自绘

2）配置种类

800 床以上规模医院肿瘤中心的配置数量最多，其次为周产期母子医疗中心、心脏（心血管）中心和肾脏中心。脏器中心中，心脏（心血管）中心、肾脏中心和脑神经中心设置数量较多；系统中心中，周产期母子医疗中心、消化系统中心和儿童医疗中心设置量较多；疾病中心中，肿瘤中心、认知症医疗中心和糖尿病中心设置量较多，见图 3-17。总的来说，疾病中心设置量较多，见图 3-18。

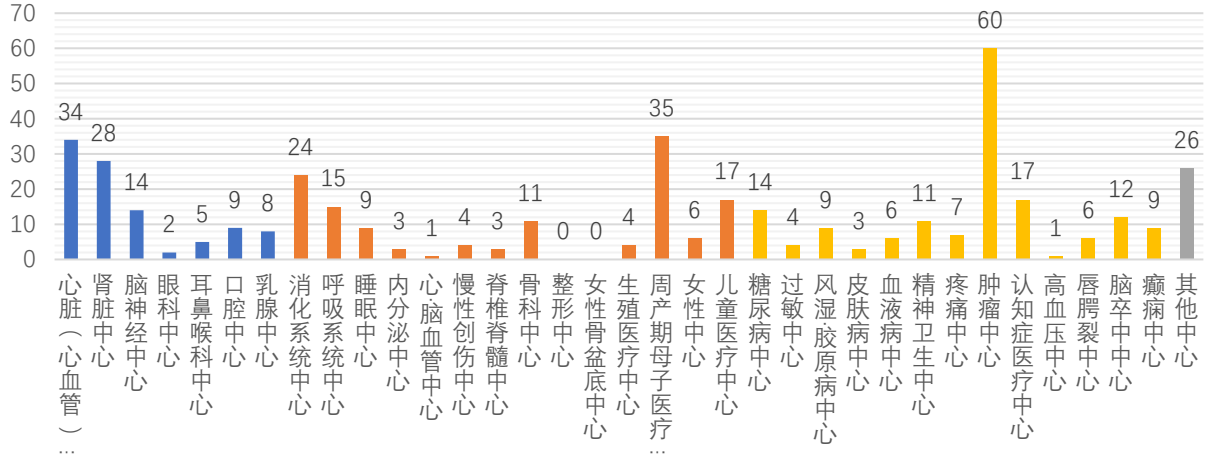


图 3-17　800 床以上规模医院诊疗中心配置种类统计图
图片来源：作者自绘

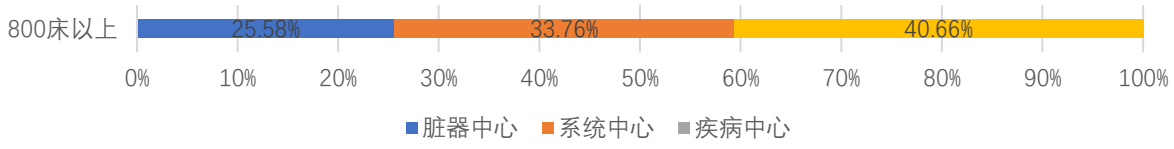


图 3-18　800 床以上规模医院各类中心配置数量相对比率图
图片来源：作者自绘

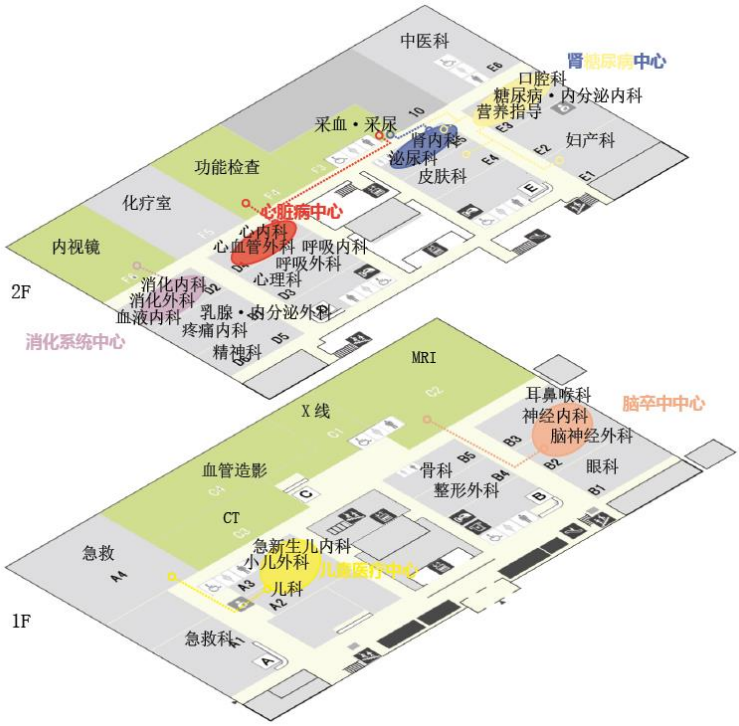
3）位置关系

800 床以上规模医院由于诊疗中心设置数量较多（9 个左右），且疾病中心设置量较多，诊疗中心布置多呈诊疗中心间邻近布局，诊疗中心相关医技邻近诊疗中心布局的趋势。少部分 800 床以上规模医院出现部分诊疗中心独栋布局的模式，且出现多个诊疗中心关联合并为一个大诊疗中心的命名及布局可能，科室呈邻近主要诊疗中心布局，医技则呈多成分散邻近

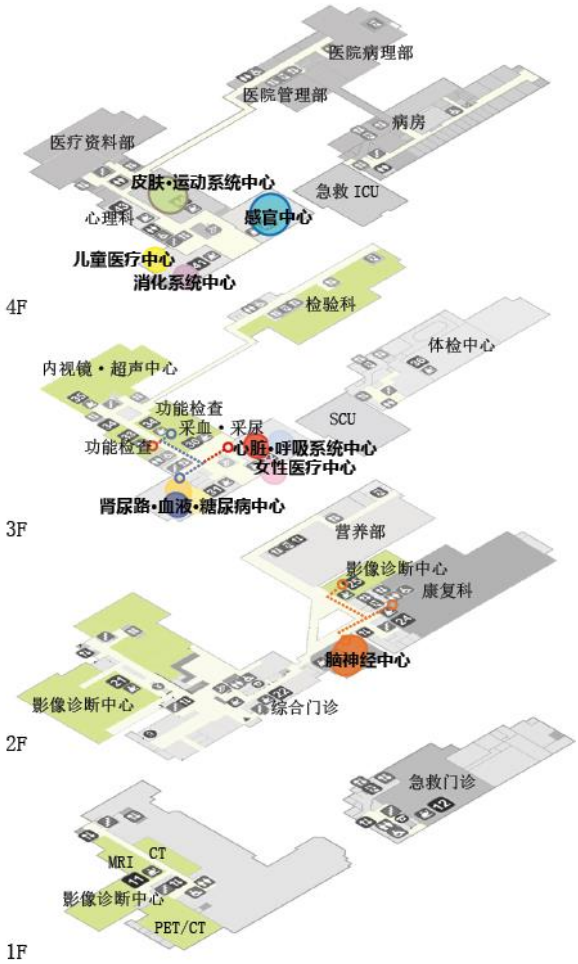
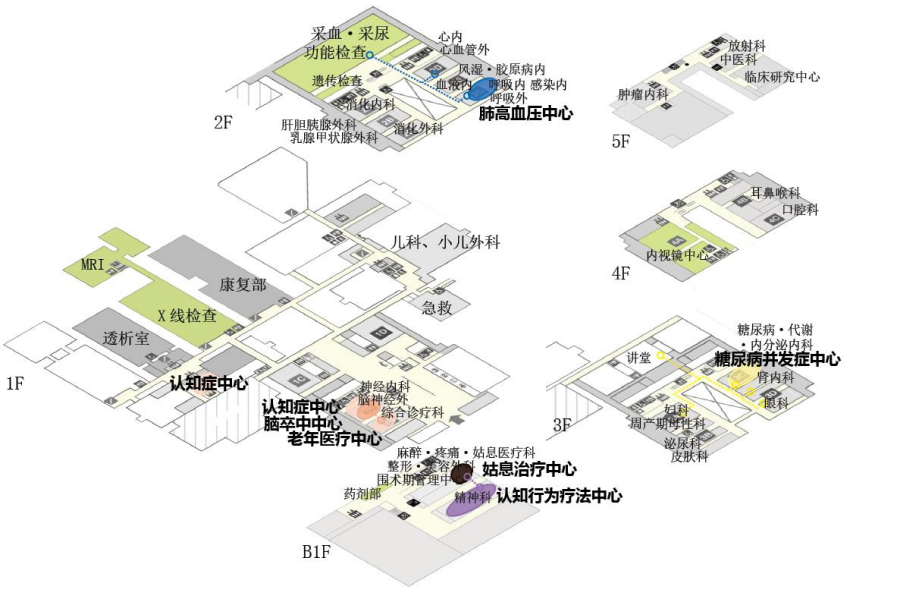
中国知网　https://www.cnki.net

的特征，见表 3.12。

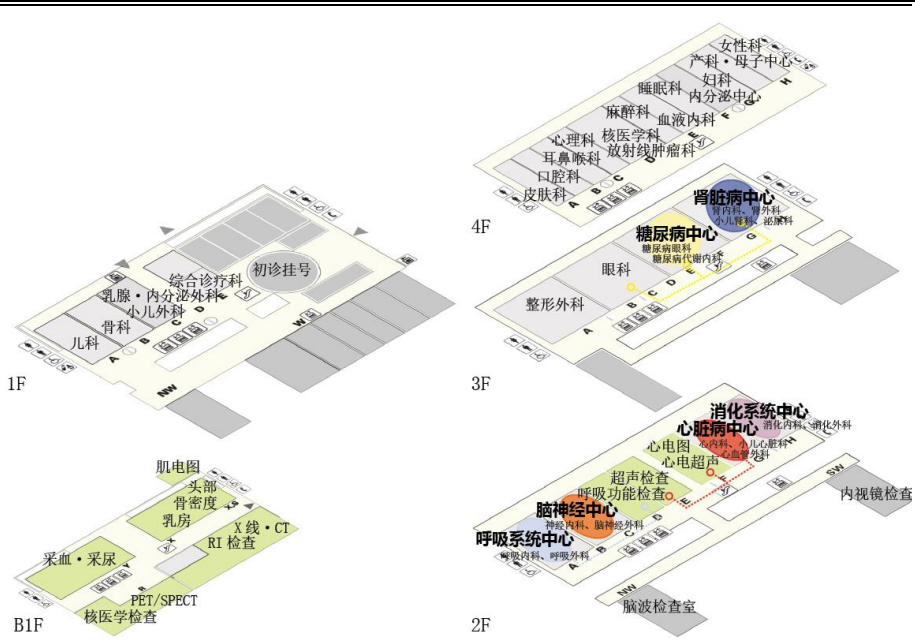
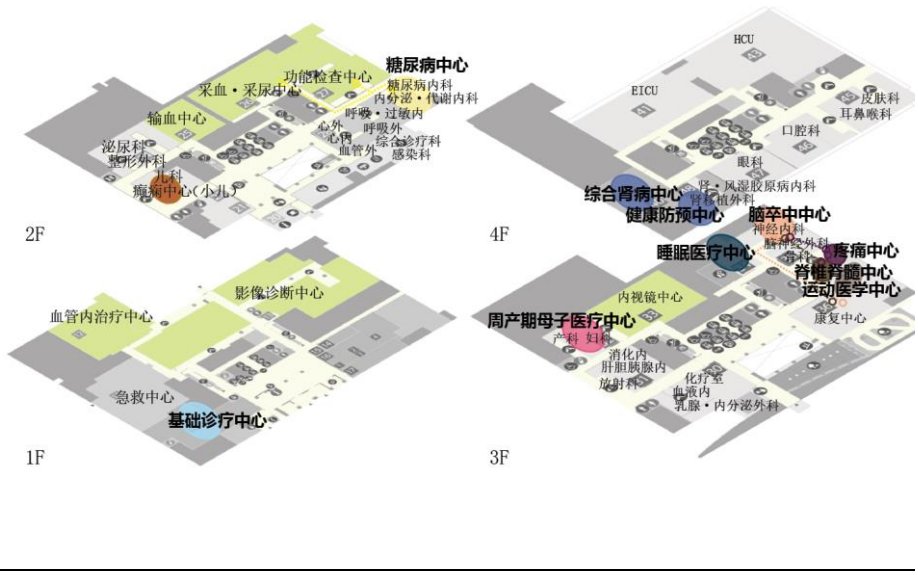
表 3.12 800 床以上规模医院诊疗中心数量与医院数量关系图

位置关系	医院名称	主要中心数量及种类	布局分析
1. 中心独栋	岩手医科大学附属病院	5 口腔医疗中心 心脏医疗中心 肿瘤中心 认知症疾病医疗中心 肝疾病咨询中心	
2. 中心间独立，医技集中邻近	大阪赤十字病院	2 心脏血管中心 癌症诊疗中心	
3. 诊疗中心合并，相关科室邻近，相关医技分散邻近	爱媛県立中央病院	9 周产期母子医疗中心 儿童医疗中心 肾糖尿病中心 消化系统中心 癌症治疗中心 脑卒中中心 心脏病中心 综合诊疗中心 灾害中心	

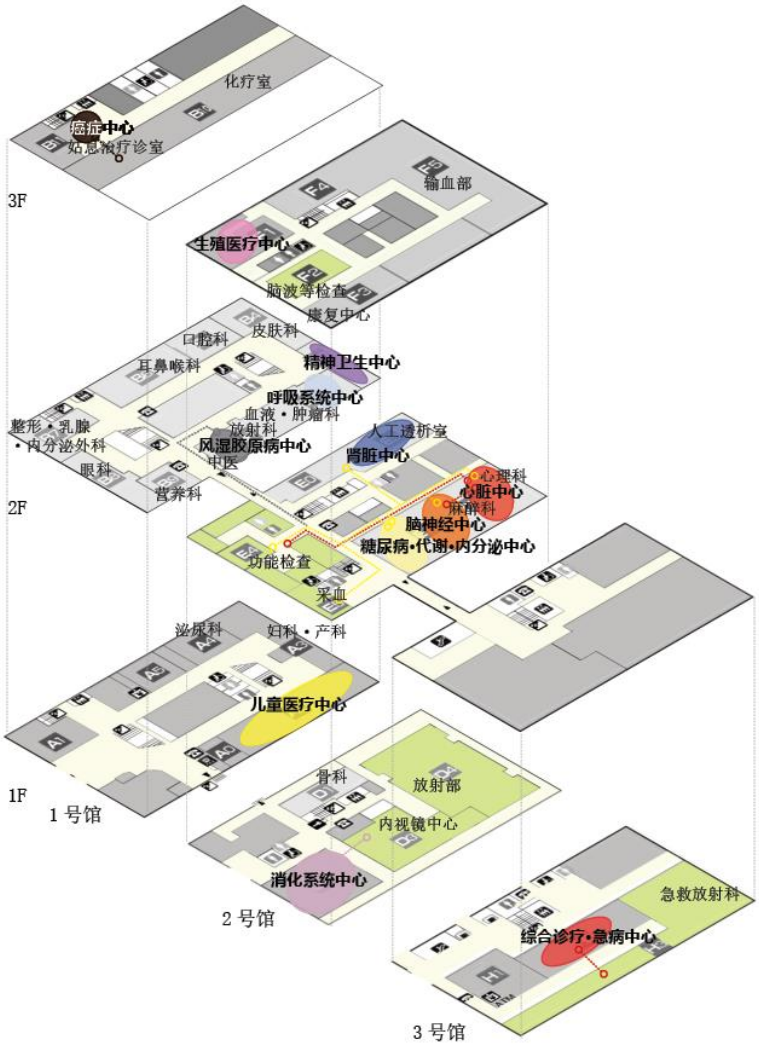
中国知网 https://www.cnki.net

	川崎医科大学附属病院	16 心脏・呼吸系统中心 肾尿路・血液・糖尿病中心 脑神经中心 儿童医疗中心 女性医疗中心 皮肤・运动系统中心 消化系统中心 感官中心 肾中心 新生儿中心 脑卒中中心 癌症中心 姑息治疗中心 造血细胞移植中心 认知症疾病中心 临床心理中心	
注：相关中心关联，相关科室邻近，相关医技分散邻近	千葉大学医学部附属病院	12 老年医疗中心 糖尿病并发症中心 姑息治疗中心 脑卒中中心 过敏中心 周产期母子中心 肺高血压中心 认知症医疗中心 肺癌治疗中心 国家医疗中心 未来研究中心 认知行为疗法中心	

中国知网 https://www.cnki.net

東京女子医科大学病院	13 心脏病中心 消化系统中心 脑神经中心 肾病综合医疗中心 糖尿病中心 内分泌疾病综合医疗中心 母子综合医疗中心 呼吸系统中心 儿童综合医疗中心 前列腺肿瘤中心 女性排尿障碍中心 炎症性肠疾病中心 癌症中心	
愛知医科大学病院	17 综合肾病中心 疼痛中心 周产期母子医疗中心 临床肿瘤中心 糖尿病中心 脊椎脊髓中心 健康防预中心 运动医学中心 脑血管内治疗中心 睡眠医疗中心 脑卒中中心 姑息医疗中心 精神卫生中心 基本诊疗中心 人工关节中心 癫痫中心 造血细胞移植中心	

中国知网 https://www.cnki.net

	東邦大学医療センター　大森病院	21 综合诊疗・急病中心 消化系统中心 心脏中心 呼吸系统中心 糖尿病・代谢・内分泌中心 肾中心 脑神经中心 风湿胶原病中心 儿童医疗中心 精神卫生中心 癌症中心 姑息治疗中心 化疗中心 综合周产期母子医疗中心 生殖医疗中心 主动脉中心 外伤・运动医学中心 睡眠呼吸障碍中心 心率失常中心 皮肤健康中心 间质性肺炎中心	
5. 相关中心关联，相关科室邻近，相关医技集中邻近	自治医科大学附属病院	18 心脏中心 消化系统中心 呼吸系统中心 脑神经中心 肾脏中心 儿童医疗中心 综合围产期母子医疗中心 成人先天性心脏病中心 脑卒中中心 糖尿病中心 风湿病中心 癫痫中心 血管内治疗中心 生殖医学中心 移植・再生医疗中心 肿瘤中心 临床感染中心 透析中心	

注：图表自制

中国知网　https://www.cnki.net

3.2.7 对比研究

1）不同规模医院诊疗中心配置数量

通过统计各规模医院诊疗中心设置数量和设有不同数量诊疗中心的规模医院构成情况，见图 3-19 和 3-20，可以得出，在研究案例中，大多数医院诊疗中心的设置数量在 4 个左右；其中 200-399 床规模医院诊疗中心数量多设置在 5 个以内；12 个以上数量诊疗中心的设置，多见设置于 800 床以上规模的医院。

通过研究各规模医院与设置诊疗中心数量关系，分别绘制出各规模医院与诊疗中心设置数量分布趋势图（图 3-21）、各规模医院诊疗中心相对设置数量分布趋势图（图 3-22）和各规模医院诊疗中心设置个数箱式图（图 3-23），综合对比以上统计图，可以得出 20-199 床规模医院诊疗中心数量一般设置在 3 个，200-399 床规模医院诊疗中心数量一般设置在 4 个左右，400-599 床规模医院诊疗中心数量一般设置在 5 个左右，600-799 床规模医院诊疗中心数量一般设置在 7 个左右，800 床以上规模医院诊疗数量多设置 9 个左右，诊疗中心设置数量与医院规模呈现一定的正相关性，即医院规模越大，诊疗中心的设置数量越多。

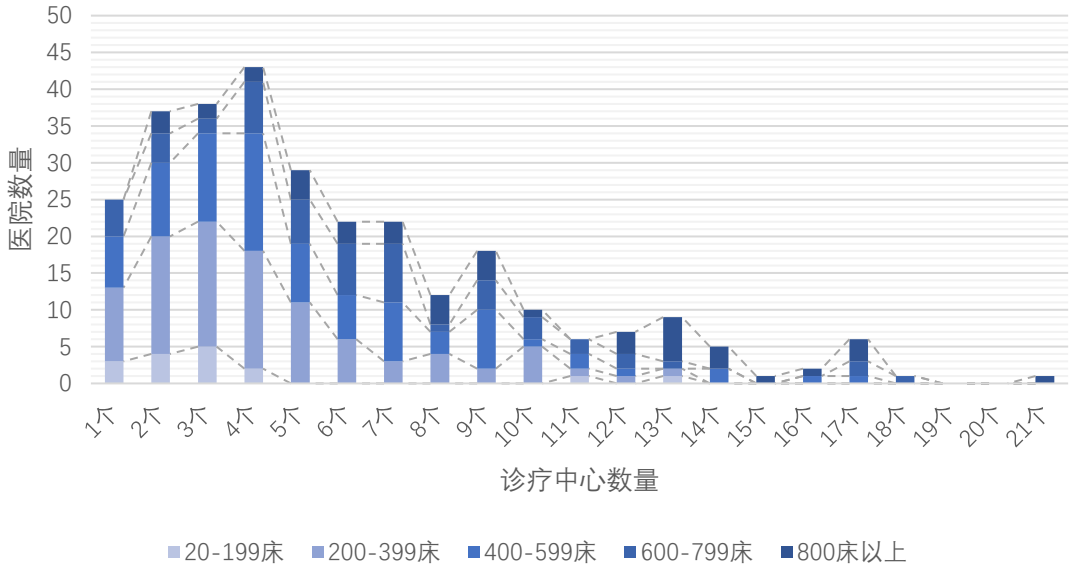


图 3-19 不同规模医院诊疗中心设置数量统计图
图片来源：作者自绘

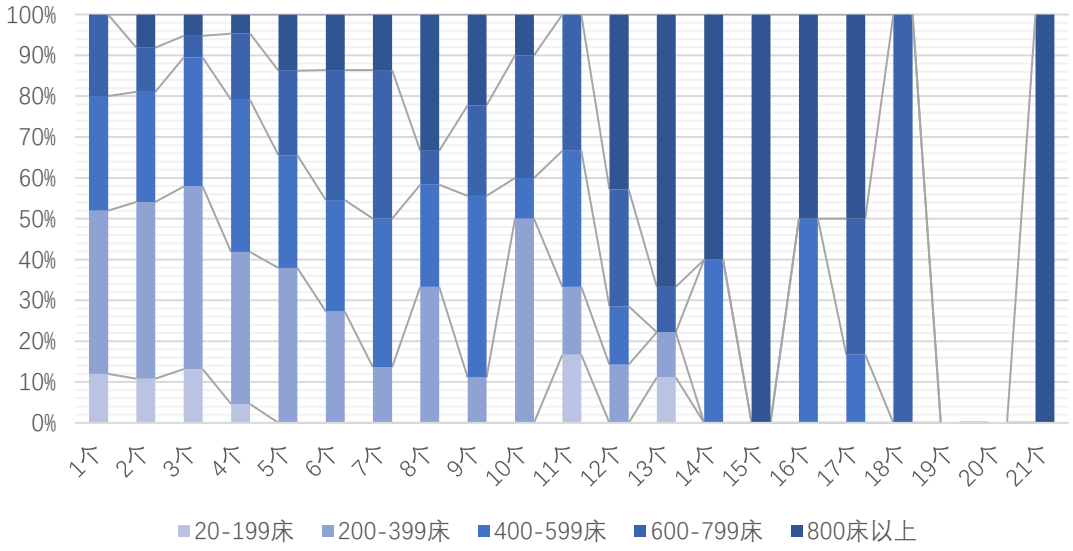


图 3-20 诊疗中心设置数量与医院规模构成百分比图
图片来源：作者自绘

中国知网 https://www.cnki.net

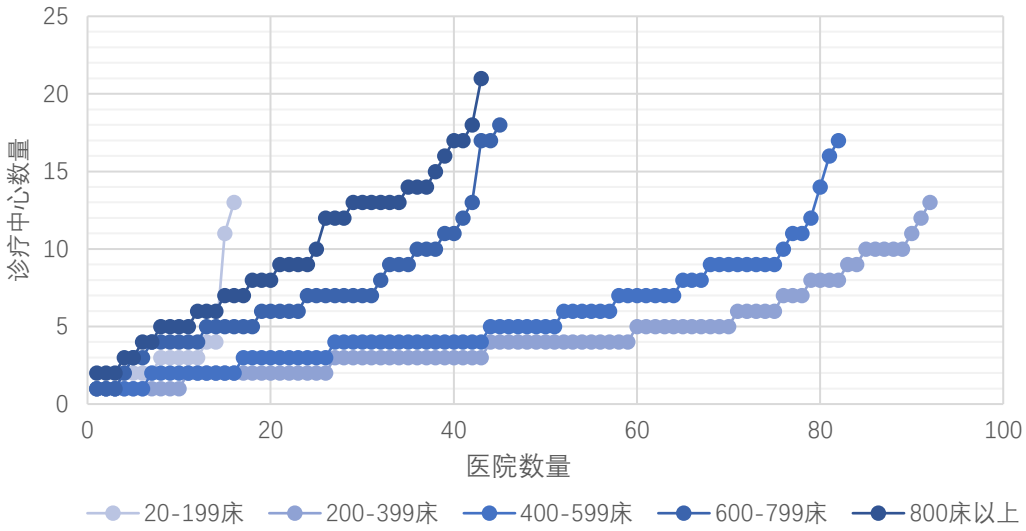


图 3-21 不同规模医院与诊疗中心数量分布趋势图
图片来源：作者自绘

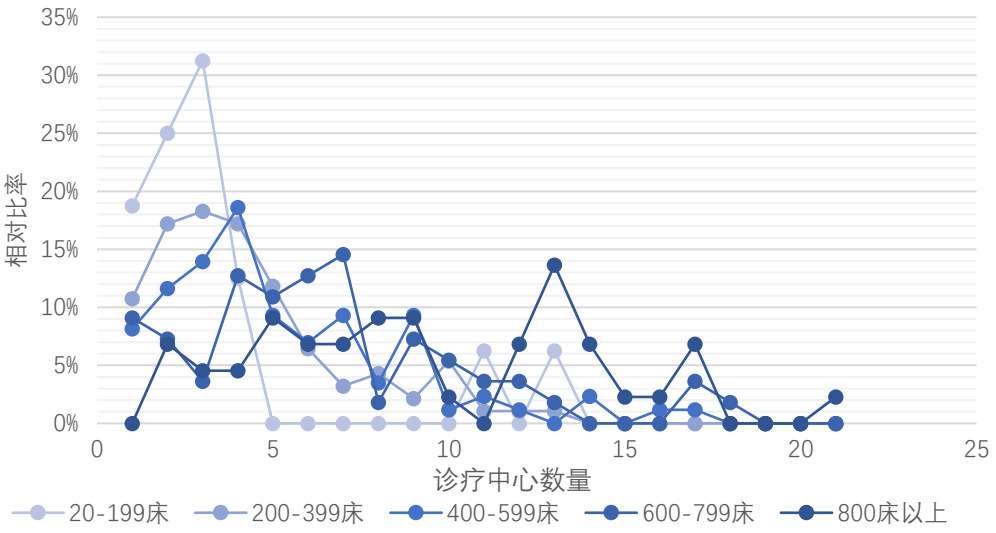


图 3-22 不同规模医院诊疗中心设置相对数量折线图
图片来源：作者自绘

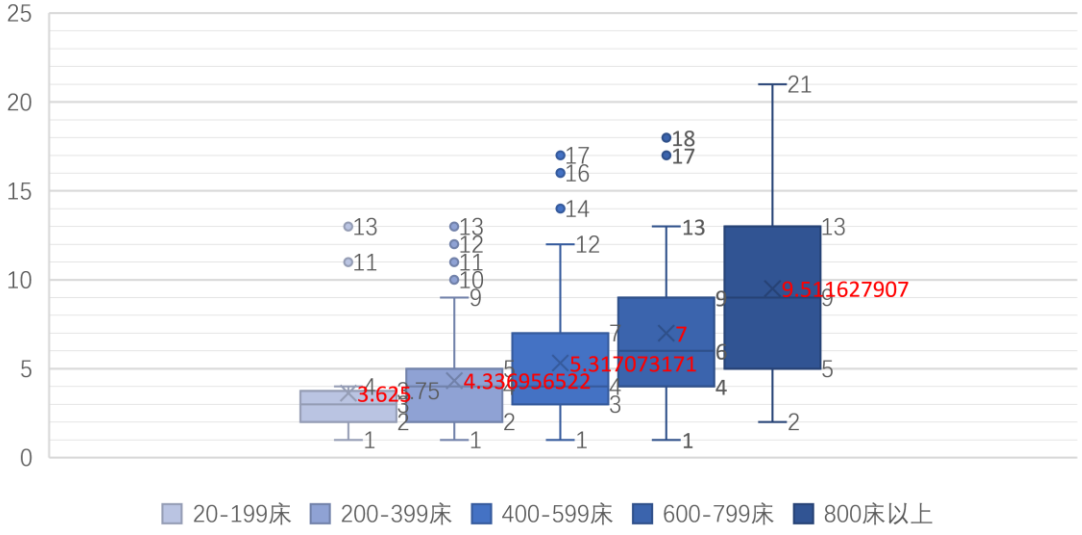


图 3-23 不同规模医院诊疗中心设置个数分布箱式图
图片来源：作者自绘

中国知网 https://www.cnki.net

2）不同规模医院诊疗中心设置种类

通过对比不同规模医院诊疗中心设置种类，分别绘出不同规模医院各类诊疗中心统计图（图 3-24）、不同规模医院各类诊疗中心所占比率图（图 3-25）、不同规模医院各类诊疗中心相对比率图（图 3-26）和不同规模医院各类诊疗中心相对数量比率图（图 3-27）。可以分别得到如下结论：

在所有类别诊疗中心中，肿瘤中心设置数量最多，其次为心脏（心血管）中心、肾脏中心和消化系统中心，如图 3-24。其中脏器中心设置前三的诊疗中心为心脏（心血管）中心、肾脏中心和脑神经中心；系统中心设置前三的诊疗中心为消化系统中心、周产期母子医疗中心和骨科中心；疾病中心设置前三的诊疗中心为肿瘤中心、糖尿病中心和脑卒中中心。

20-199 床规模医院各类诊疗中心的设置比率均低于其他规模医院；200-399 床规模医院高血压中心、女性骨盆底中心和整形中心设置率较高；400-599 床规模医院皮肤病中心、心 •脑血管中心的设置率较高；600-799 床规模医院耳鼻喉科中心、周产期母子医疗中心设置率较高；800 床以上规模医院内分泌中心、皮肤病中心、精神卫生中心、疼痛中心、唇腭裂中心、癫痫中心、睡眠中心和过敏中心等诊疗中心设置率较高，如图 3-25。

对比各医院各类诊疗中心相对设置率（图 3-26），20-199 床规模医院消化系统中心设置率较高，600 床以上医院肿瘤中心和周产期母子医疗中心设置率较高。

总的来说，20-199 床规模医院系统中心设置比率较高，疾病中心设置率较少；200-399 床规模，400-599 床规模医院和 600-799 床规模医院脏器中心、系统中心和疾病中心设置率相当；800 床以上规模医院疾病中心设置率较高，见图 3-27。

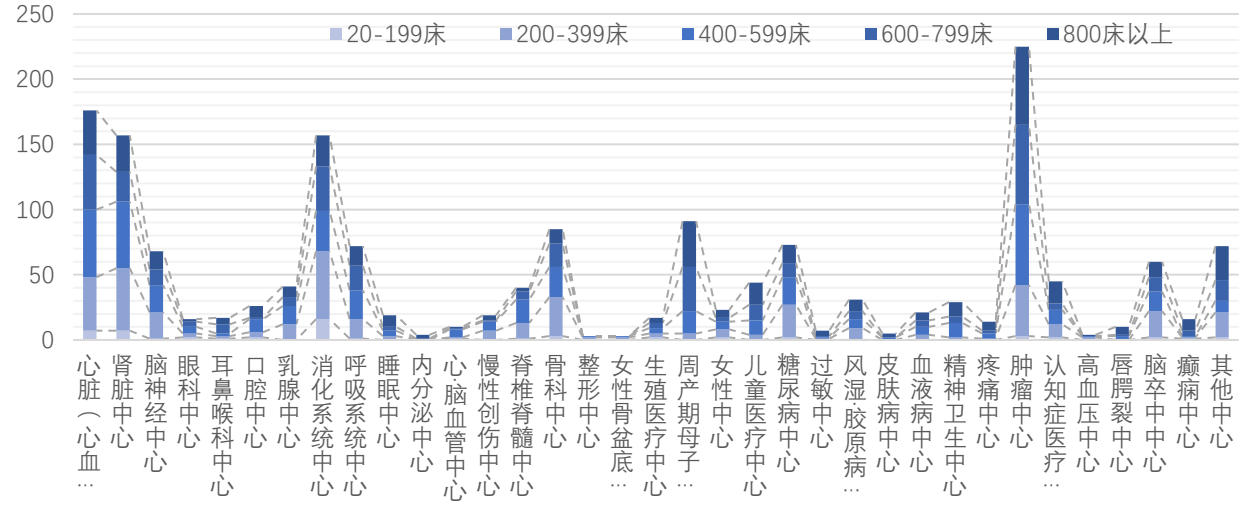


图 3-24 不同规模医院各类诊疗中心设置数量统计图

图片来源：作者自绘

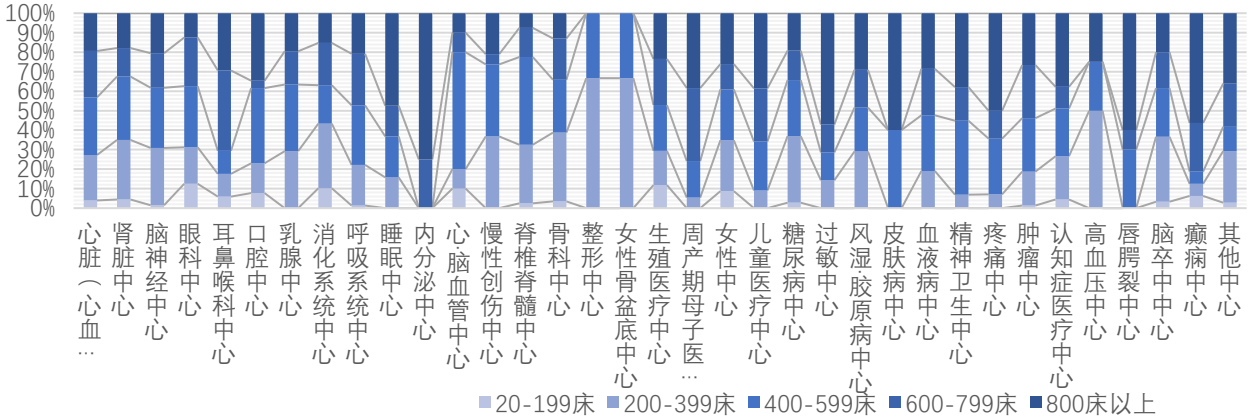


图 3-25 不同规模医院各类诊疗中心设置所占比率图

图片来源：作者自绘

中国知网 https://www.cnki.net

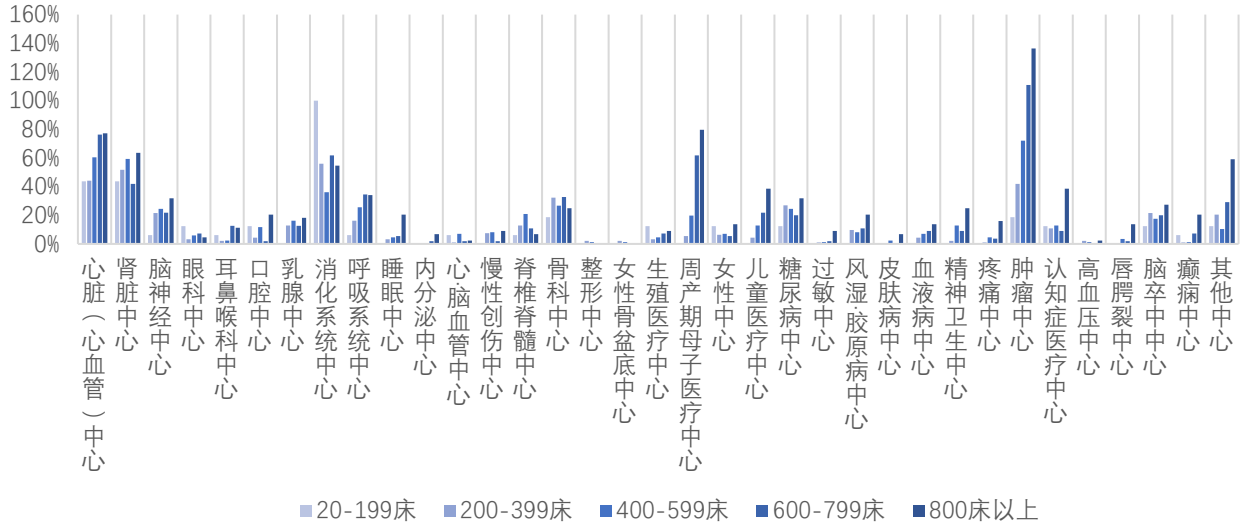


图 3-26 不同规模医院各类诊疗中心设置相对比率图
图片来源：作者自绘

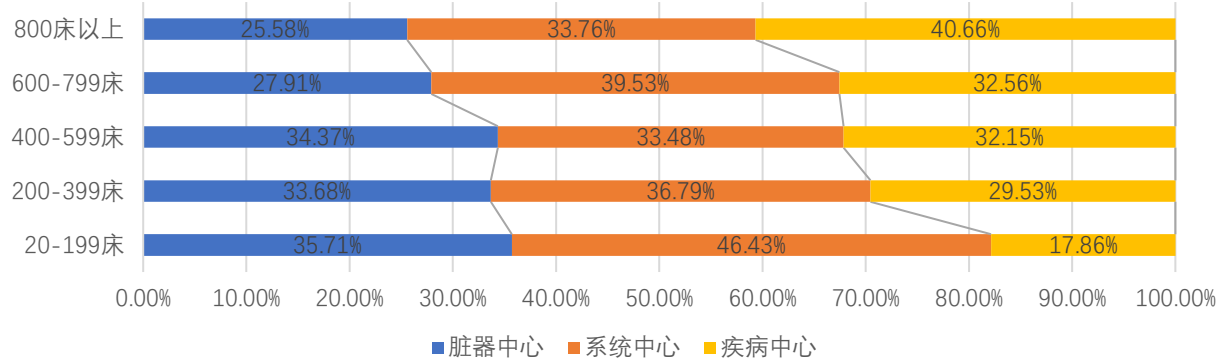


图 3-27 不同规模医院各类诊疗中心设置相对数量比率图
图片来源：作者自绘

3）不同规模医院诊疗中心平面布局特征

由于不同规模医院诊疗中心设置种类和数量不同，诊疗中心布局也呈现不同的特点：

20-199 床规模医院诊疗中心设置数量多在 2-3 个之间，诊疗中心设置多以脏器中心和系统中心为主，诊疗中心间关联较弱，所以诊疗中心的布局多成独立布局趋势，主要医技检查往往于诊疗中心内设置或邻近诊疗中心设置，见表 3.4。

200-399 床规模医院诊疗中心设置数量多在 2-4 个之间，脏器中心、系统中心和疾病中心设置量相当（30%左右），诊疗中心的布局呈相关科室邻近中心布局的趋势，相关医技检查集中邻近诊疗中心布局，见表 3.6。

400-599 床规模医院诊疗中心设置数量多在 5 个左右，脏器中心、系统中心和疾病中心设立量相当（30%左右），诊疗中心布局呈相关科室相邻，相关医技检查呈集中邻近和分散邻近布局特征，见表 3.8。

600-799 床规模医院多设置 7 个左右的诊疗中心，脏器中心、系统中心和疾病中心设置量相当（30%左右），除上述几类规模医院诊疗中心的布局特征外，此类规模医院相关诊疗中心间呈关联布局的趋势，相关医技呈集中或分散邻近趋势，见表 3.10。

800 床以上规模医院诊疗中心设置数量一般多为 9 个，诊疗中心多以疾病中心为主，诊疗中心的布局除呈现相关诊疗中心邻近布局，还呈现多个诊疗中心合并成一个大诊疗中心的布局的可能，相关医技检查也呈分散邻近布置趋势，见表 3.12。

中国知网 https://www.cnki.net

3.3 不同类型医院诊疗中心配置研究

3.3.1 分类

日本医疗法将成人的医疗场所限于医院和诊所，医院和诊所的区分在于床位数的多少，其中 20 床以上的为医院，19 床以下的为诊所。医疗法将日本的医院类型分为具有一定机能的医院（特定机能医院和地域支援医院）和一般医院，如图 3-28。其中有一定机能医院和一般医院的不同之处在于病院认定条件的不同，包括人员配置标准、结构设备标准、管理人员的职责等，见表 3.13。为保证整个医疗体系完整，各类医疗设施间保持紧密联系，见图 3-29。

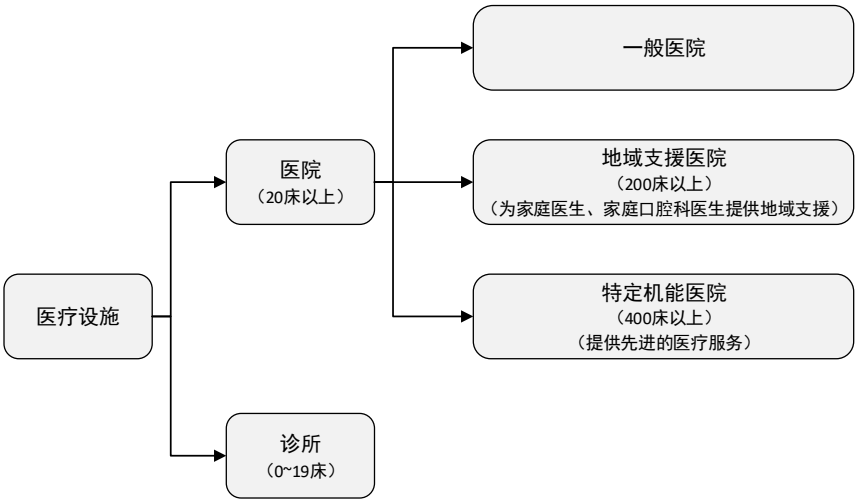


图 3-28 日本医疗设施类型

图片来源：根据日本官方厚生劳动白皮书（http://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/10-2/kousei-data/PDF/22010206.pdf），整理绘制而成

表 3.13 地域支援医院、特定机能医院和一般医院的比较

项目	地域支援医院	特定机能医院	一般医院
主要功能	为转诊患者提供医疗服务 病床及昂贵医疗设备共用 提供 24 小时紧急医疗服务 培训当地医务人员	先进的医疗服务（心脏手术、器官移植等） 先进医疗技术的研发与评估 先进的医疗培训	大多数人就医的地方，为患者提供方便、科学、适当的医疗服务
科室	无规定	内科、外科、口腔科等基础医学科的全部科室（特定研究领域的特定机能医院，10 科室以上）	无规定
病床数	原则上 200 床以上	400 床以上	20 床以上
转诊率	满足下述条件中的一条 ・地域支援医院转诊率 80%以上 ・地域支援医院转诊率 65%以上且地域支援医院下转率 40%以上 ・地域支援医院转诊率 50%以上且地域支援医院下转率 70%以上	转诊率 50%以上且下转率 40%以上（特定研究领域的特定机能医院转诊率 80%以上且下转率 60%以上）	无规定
设施设备	除一般医院设施设备外，增加重症监护室、救护车、医疗设备信息管理室、化学・细菌的检查设施、病理解剖室等	除一般医院设施设备外，增加重症监护室、医药用品信息管理室、化学・细菌的检查设施、病理解剖室、无菌室等	手术室、临床检查设施、诊室、处置室等

注：表格来源 https://www.shaho.co.jp/shaho/shop/usr_data/sample/16500-sample.pdf，并由作者翻译而成。

中国知网 https://www.cnki.net

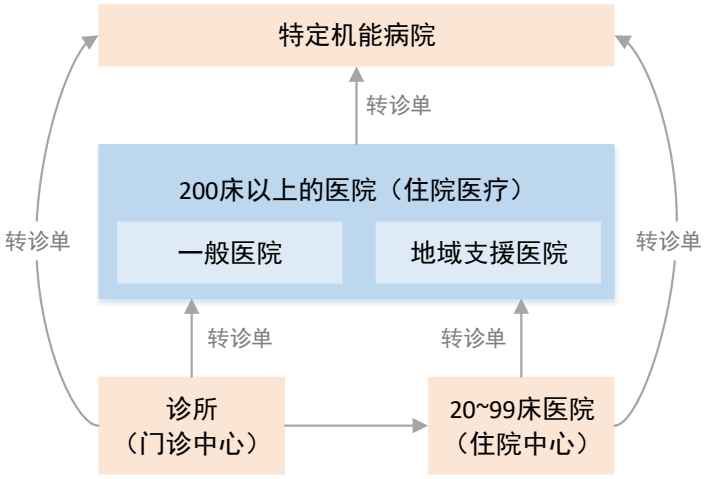


图 3-29 厚生劳动省 医疗功能分化图

图片来源：http://mdo.co.jp/tokuho/topics/topics0013.html，并由作者翻译整理

除了医疗法规定的特定机能医院和地域支援医院外，日本医院还会接受各县县长、医疗财团等各种指定，肩负多种职能，如被指定为地域癌症诊疗医院、急救中心、灾害医院等等，详见附录 B。

此外，对于对日本国民公共卫生有严重影响的疾病，日本通过国立高度专门医疗研究中心及独立行政法人国立医疗机构实行“政策医疗”，以弥补私立医院医疗条件不足的情况。[1] 往往这些国立医疗机构在诊疗某些疾病方面，代表着日本最高的医疗水平，并提供高度先进的医疗设施、临床研究、教育研修等等。见图 3-30。相较特定机能医院、地域支援医院和一般医院的分类而言，此类医院对某些疾病的医疗专业度更高。

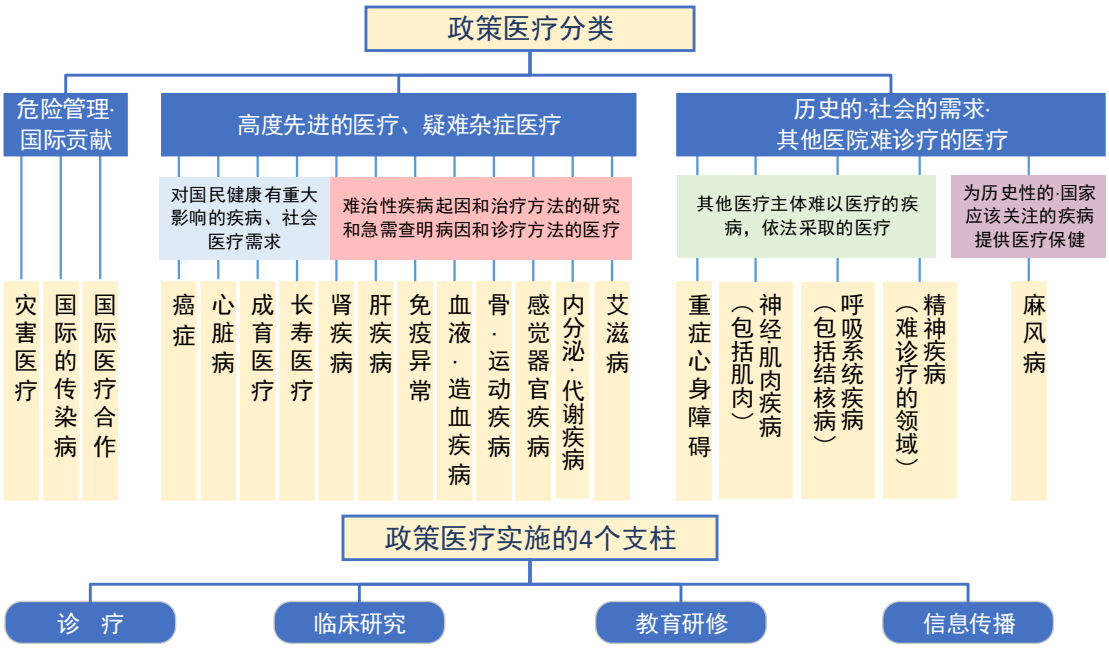


图 3-30 日本政策医疗构成图

图片来源：https://www.nho-kinki.jp/aboutus/policy.html，并由作者翻译

本文主要以日本医疗法规定的特定机能医院、地域支援医院和一般医院，以及实行政策医疗的高度综合医疗设施和国立高度专门医疗研究中心，进行已选医院案例的诊疗中心配置

[1] 政策医疗：https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%94%BF%E7%AD%96%E5%8C%BB%E7%99%82

中国知网 https://www.cnki.net

数量、配置种类和平面布局研究。其中，研究所选特定机能医院 54 所，占日本官方承认特定机能医院的 63.53%；地域支援医院 130 所，占日本官方承认地域支援医院的 23.94%；一般病院 110 所，占所有一般医院的 1.63%；全部 10 所高度综合医疗设施和 8 所国立高度专门医疗研究中心病院，见表 3.14。

表 3.14 所选案例医院类型统计表

医院种类	特定机能医院	地域支援医院	一般医院	高度综合医疗设施	国立高度专门医疗研究中心
研究医院个数	54	130	110	10	8
总数	85[1)]	543[1)]	6750[1)]	10[2)]	8[3)]
比率	63.53%	23.94%	1.63%	100%	100%

注：1）数据来源：日本官方厚生劳动省（http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/79-1.html），后经笔者整理
2）数据来源：独立行政法人国立医疗机构（http://www.hosp.go.jp/about/cnt1-0_000003.html）
3）数据来源：日本官方厚生劳动省（http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002esyb-att/2r9852000002et42.pdf）

3.3.2 特定机能医院

1）基本情况

特定机能医院为日本医疗设施机能系统化的一部分，由日本官方批准认可，主要提供先进的医疗服务、先进的医疗技术的研发和医疗培训。见图 3-31。

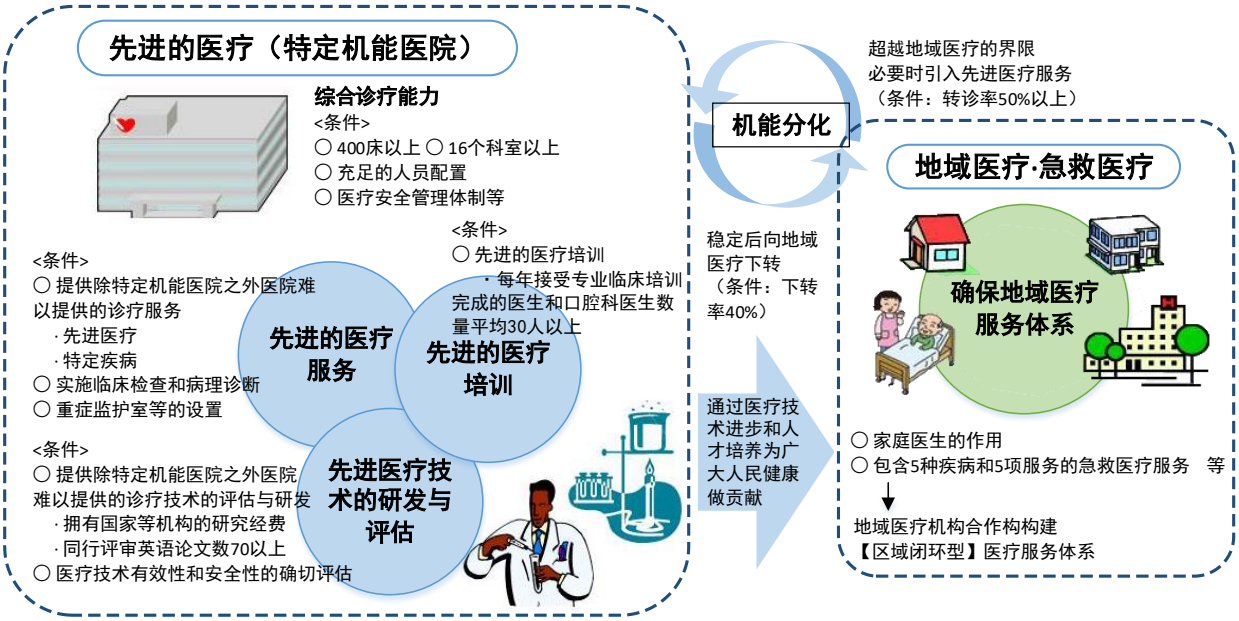


图 3-31 特定机能医院的作用

图片来源：http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000137801.html，并由作者翻译重绘

2）诊疗中心配置数量

日本官方认可的特定机能医院共 85 所[1]，选取研究医院 54 所，超过总数的一半，见图 3-32。

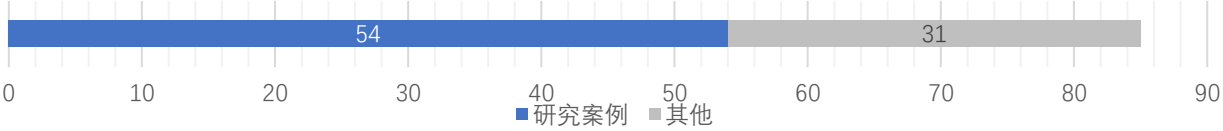


图 3-32 特定机能医院选取研究案例

图片来源：作者自绘

[1] 数据来源：http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000137801.html

中国知网 https://www.cnki.net

通过对所研究的特定机能医院进行诊疗中心数量的统计，见图 3-33。可以得出，有 7 家特定机能医院设置 5 个诊疗中心，6 家医院设置 7 个诊疗中心，大部分医院诊疗中心数量设置超过 11 个，最多可设置到 21 个诊疗中心。

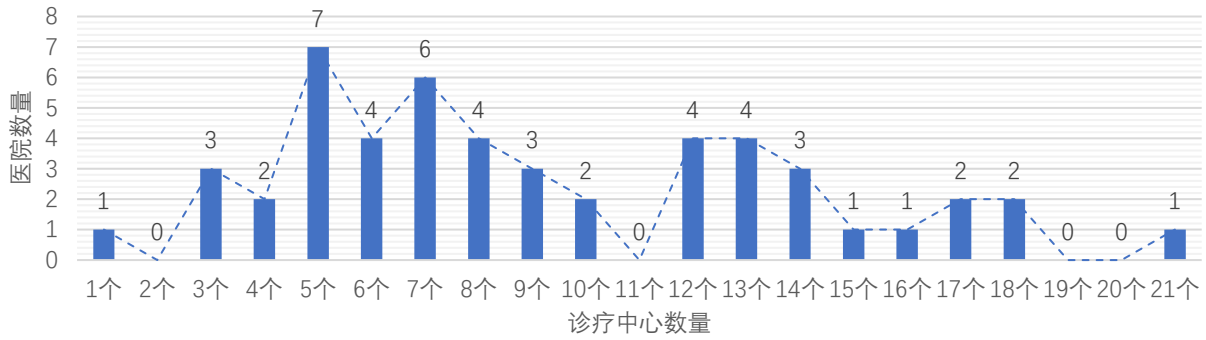


图 3-33 特定机能医院设置诊疗中心数量统计图
图片来源：作者自绘

3）诊疗中心种类

通过统计特定机能医院不同类型诊疗中心的设置数量，见图 3-34。可以得出，特定机能医院肿瘤中心设置数量最多，其次为周产期母子医疗中心和心脏（心血管中心）。在脏器中心中，心脏（心血管）中心、肾脏中心和脑神经中心设置数量较多；在系统中心中，周产期母子医疗中心、消化系统中心和儿童医疗中心的设置率较高；在疾病中心中，肿瘤中心、认知症医疗中心和脑卒中中心设置数量较多。总的来说，特定机能医院疾病中心设置率较高，见图 3-35。

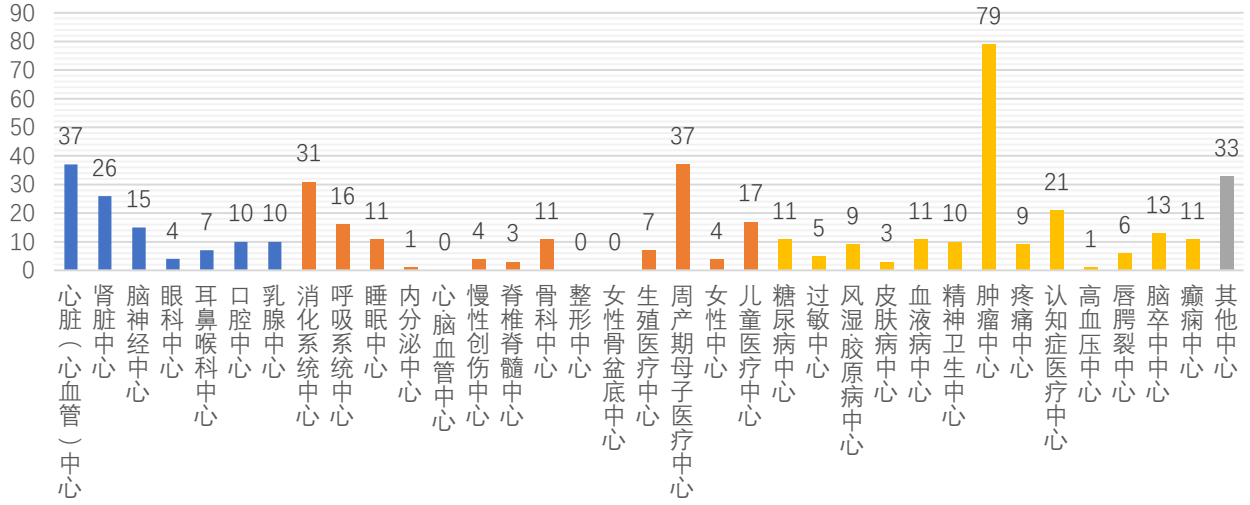


图 3-34 特定机能医院诊疗中心设置种类统计图
图片来源：作者自绘

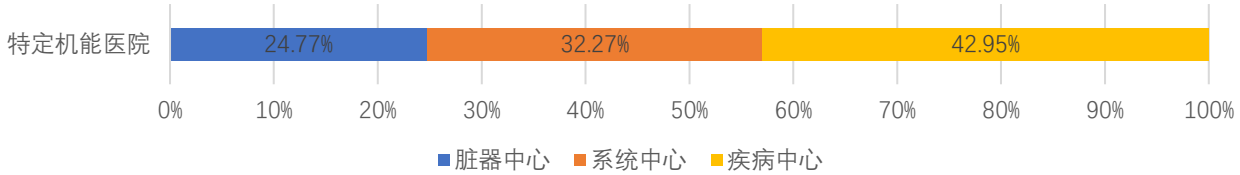


图 3-35 特定机能医院各类中心配置数量相对比率图
图片来源：作者自绘

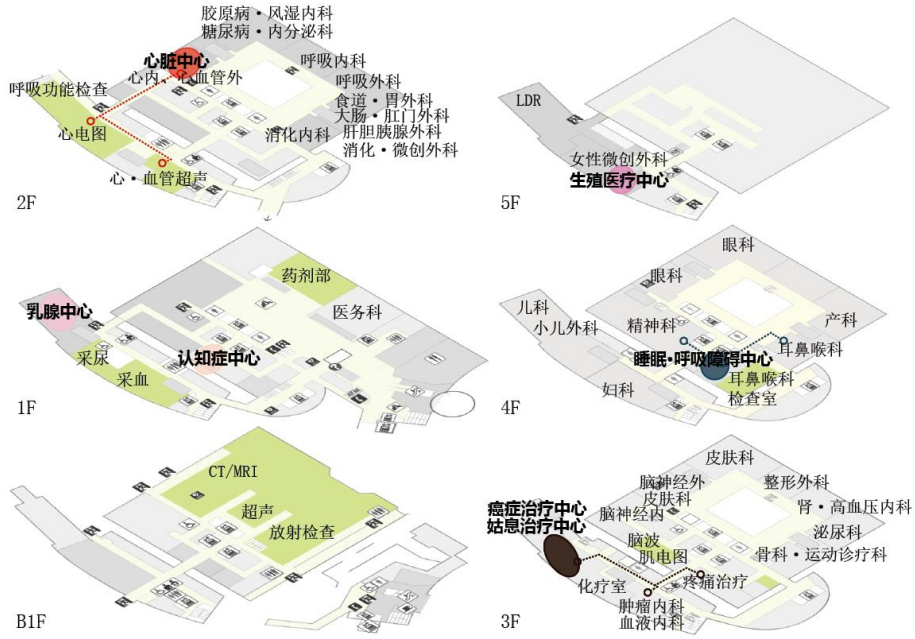
4）平面位置关系

由于特定机能医院诊疗中心多设置 9 个以上，诊疗中心以疾病中心为主，所以相关诊疗

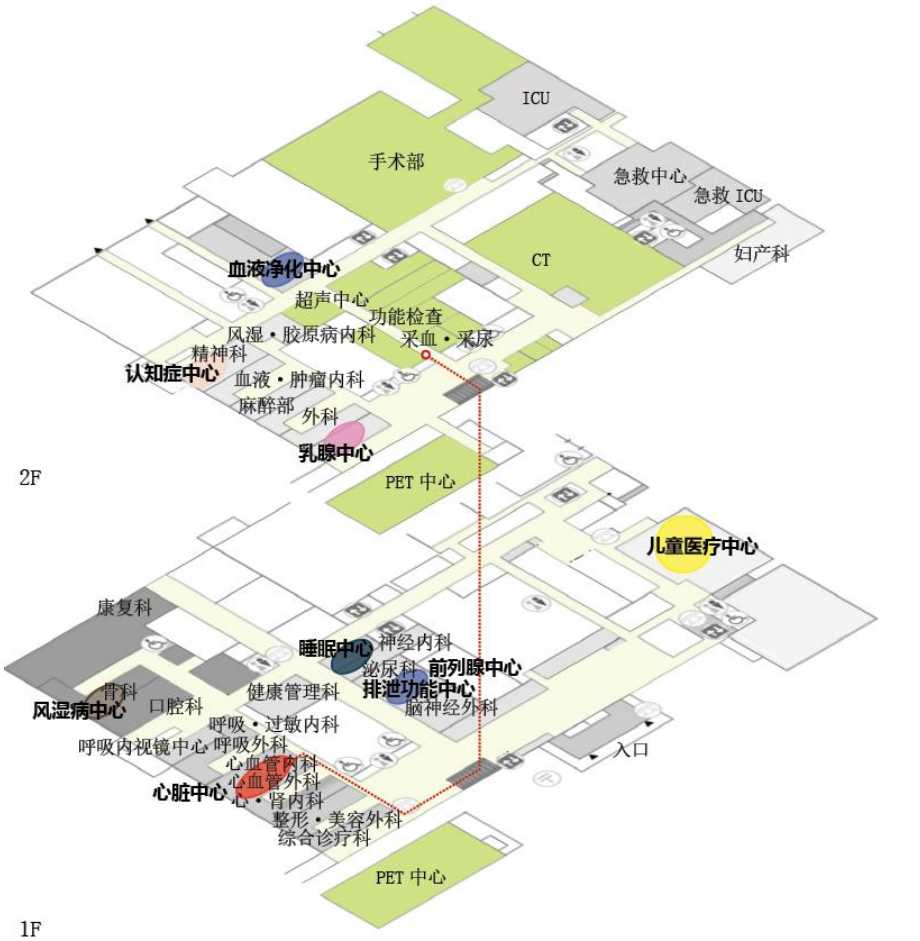
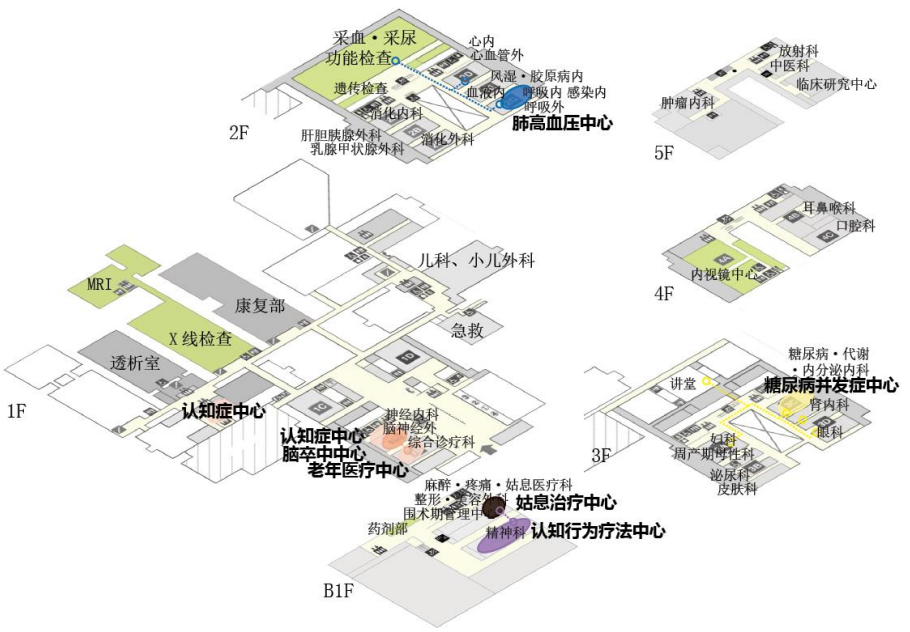
中国知网 https://www.cnki.net

中心往往邻近布局，诊疗中心相关医技也呈分散式邻近相关诊疗中心布局，并出现部分医院将多个诊疗中心合并布局的方式（如川崎医科大学附属医院）和独栋布局（岩手医科大学附属医院）的方式。除此之外，多数特定机能医院会设置较多疾病中心，以解决一般医院难以合作诊疗的疾病，且这些中心往往呈集中布局的模式（熊本大学医学部附属医院）。见表 3.15。

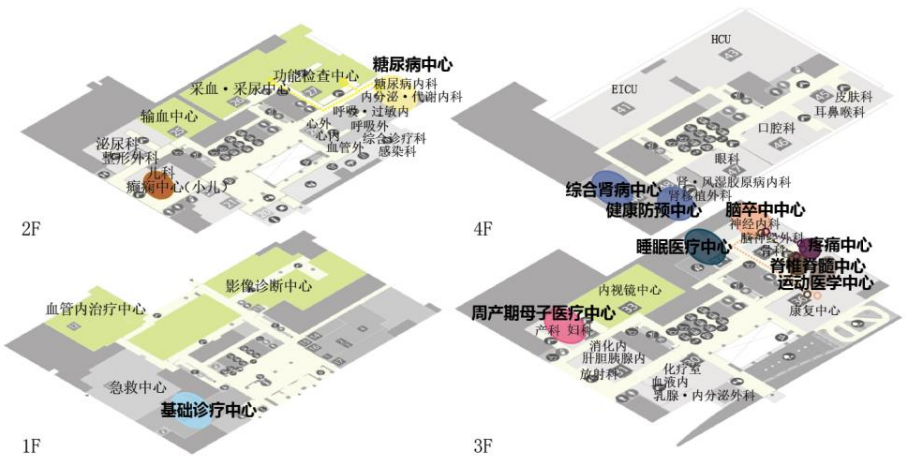
表 3.15 特定机能医院诊疗中心布局特征

位置关系	医院名称	主要中心数量及种类	布局分析
1.中心独栋	岩手医科大学附属病院	5 口腔医疗中心 心脏医疗中心 肿瘤中心 认知症疾病医疗中心 肝疾病咨询中心	
2.中心间独立，相关科室邻近，相关医技分散邻近	顺天堂医院	8 乳腺中心 心脏中心 儿科・小儿外科・围产期母子医疗中心 癌症治疗中心 姑息治疗中心 认知症疾病医疗中心 癫痫中心 女性微创外科・生殖中心	

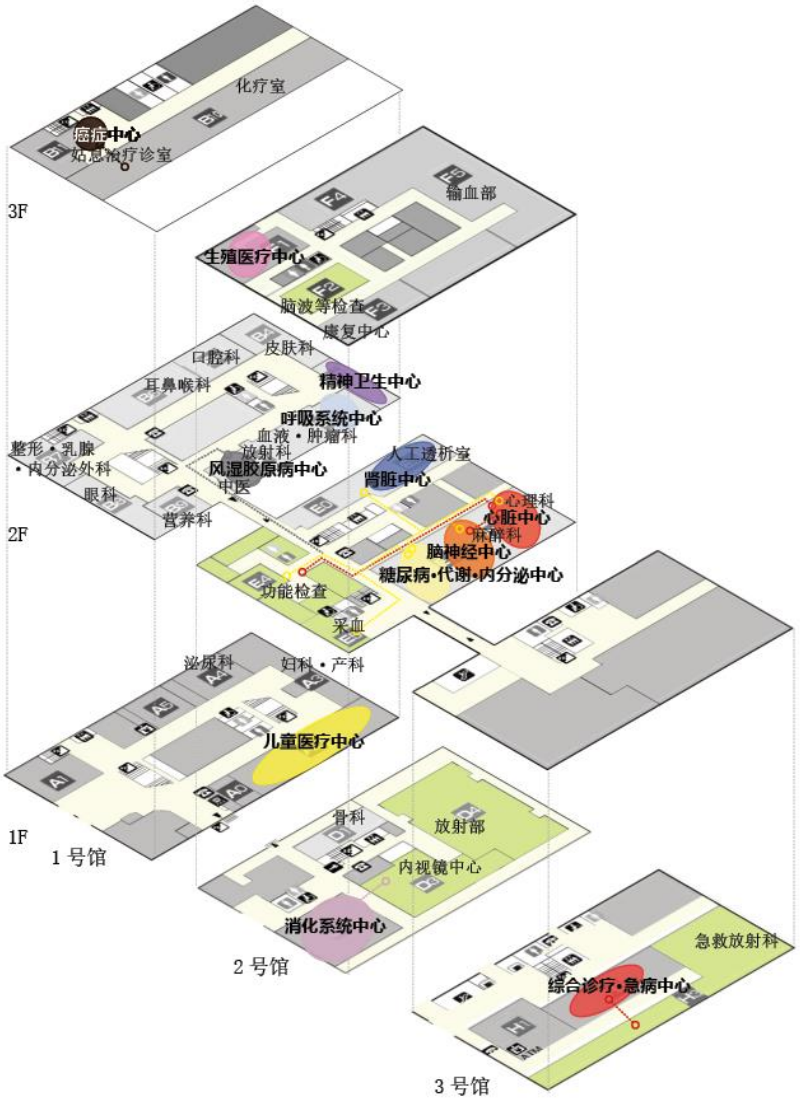
中国知网 https://www.cnki.net

3. 中心间独立，相关科室邻近，相关医技集中邻近	獨協医科大学病院	14 排泄功能中心 认知症医疗中心 综合周产期母子医疗中心 血液净化中心 肿瘤中心 睡眠医疗中心 儿童医疗中心 风湿中心 心脏中心 乳腺中心 前列腺中心 再生医疗中心 放疗中心 感染控制中心	
4. 相关中心间关联，相关科室邻近，相关医技分散关联	千葉大学医学部附属病院	12 老年医疗中心 糖尿病并发症中心 姑息治疗中心 脑卒中中心 过敏中心 周产期母子中心 肺高血压中心 认知症医疗中心 肺癌治疗中心 国家医疗中心 未来研究中心 认知行为疗法中心	

中国知网 https://www.cnki.net

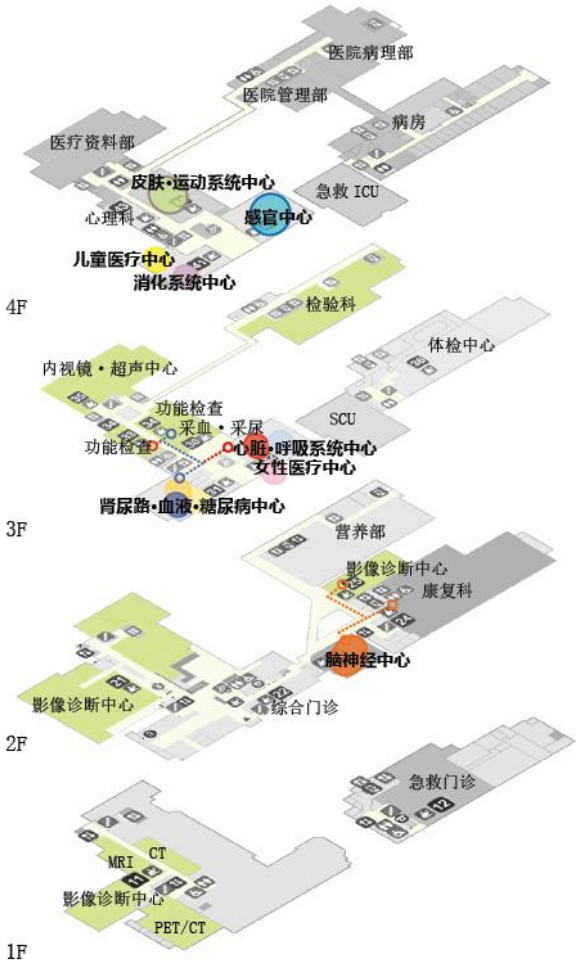
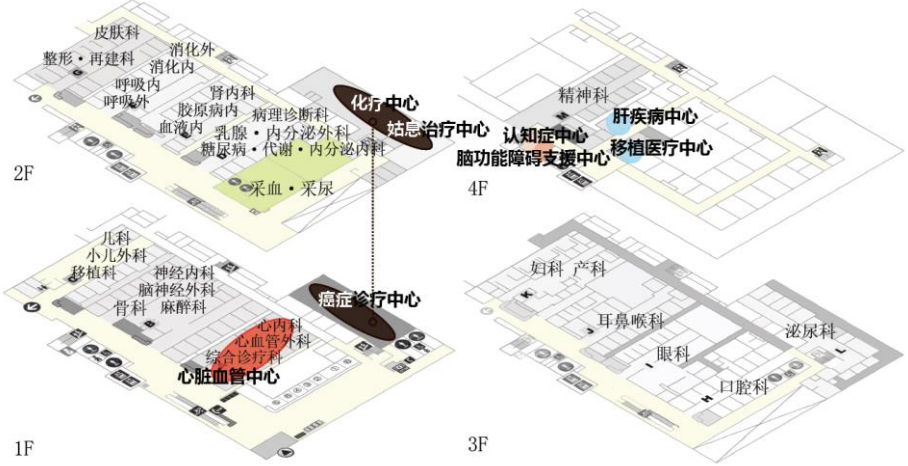
久留米大学病院	13 消化系统中心 肝癌中心 炎症性肠疾病中心 心脏病中心 呼吸系统中心 肺癌中心 糖尿病中心 口腔医疗中心 姑息治疗中心 癌症治疗中心 周产期母子医疗中心 认知症医疗中心 唇腭裂中心	
愛知医科大学病院	17 综合肾病中心 疼痛中心 周产期母子医疗中心 临床肿瘤中心 糖尿病中心 脊椎脊髓中心 健康防预中心 运动医学中心 脑血管内治疗中心 睡眠医疗中心 脑卒中中心 姑息医疗中心 精神卫生中心 基本诊疗中心 人工关节中心 癫痫中心 造血细胞移植中心	

中国知网 https://www.cnki.net

	東邦大学医療センター　大森病院	21 综合诊疗・急病中心 消化系统中心 心脏中心 呼吸系统中心 糖尿病・代谢・内分泌中心 肾中心 脑神经中心 风湿胶原病中心 儿童医疗中心 精神卫生中心 癌症中心 姑息治疗中心 化疗中心 综合周产期母子医疗中心 生殖医疗中心 主动脉中心 外伤・运动医学中心 睡眠呼吸障碍中心 心率失常中心 皮肤健康中心 间质性肺炎中心	
	自治医科大学附属病院	18 心脏中心 消化系统中心 呼吸系统中心 脑神经中心 肾脏中心 儿童医疗中心 综合围产期母子医疗中心 成人先天性心脏病中心 脑卒中中心 糖尿病中心 风湿病中心 癫痫中心 血管内治疗中心 生殖医学中心 移植・再生医疗中心 肿瘤中心 临床感染中心 透析中心	

5. 相关中心间关联，相关科室邻近，相关医技集中关联

中国知网 https://www.cnki.net

6. 诊疗中心合并，相关科室邻近，相关医技分散邻近	川崎医科大学附属病院	16 心脏・呼吸系统中心 肾尿路・血液・糖尿病中心 脑神经中心 儿童医疗中心 女性医疗中心 皮肤・运动系统中心 消化系统中心 感官中心 肾中心 新生儿中心 脑卒中中心 癌症中心 姑息治疗中心 造血细胞移植中心 认知症疾病中心 临床心理中心	
7. 诊疗中心相对集中布局	熊本大学医学部附属病院	14 综合周产期母子医疗中心 癌症中心 移植医疗中心 肝疾病中心 淀粉样变性医疗中心 吞咽障碍诊疗中心 神经免疫疾病抗体中心 血栓症中心 先进医疗发展中心 认知症医疗中心 发育障碍医疗中心 儿童居家医疗支援中心 心脏血管中心 脑功能障碍支援中心	

注：图表自制

中国知网 https://www.cnki.net

3.3.3 地域支援医院

1）基本情况

地域支援医院主要承担区域医疗保健服务、担任家庭医生的医疗支援，往往由各县县长单独批准。其作为区域医疗的核心医院，为转诊患者提供医疗服务，开展急救服务，并为当地医务人员提供医疗教育，为家庭医生提供第一线的医疗支援，见图 3-36。以中东远综合医疗中心为例，可以看出日本地域支援医院的一般职能，见图 3-37。

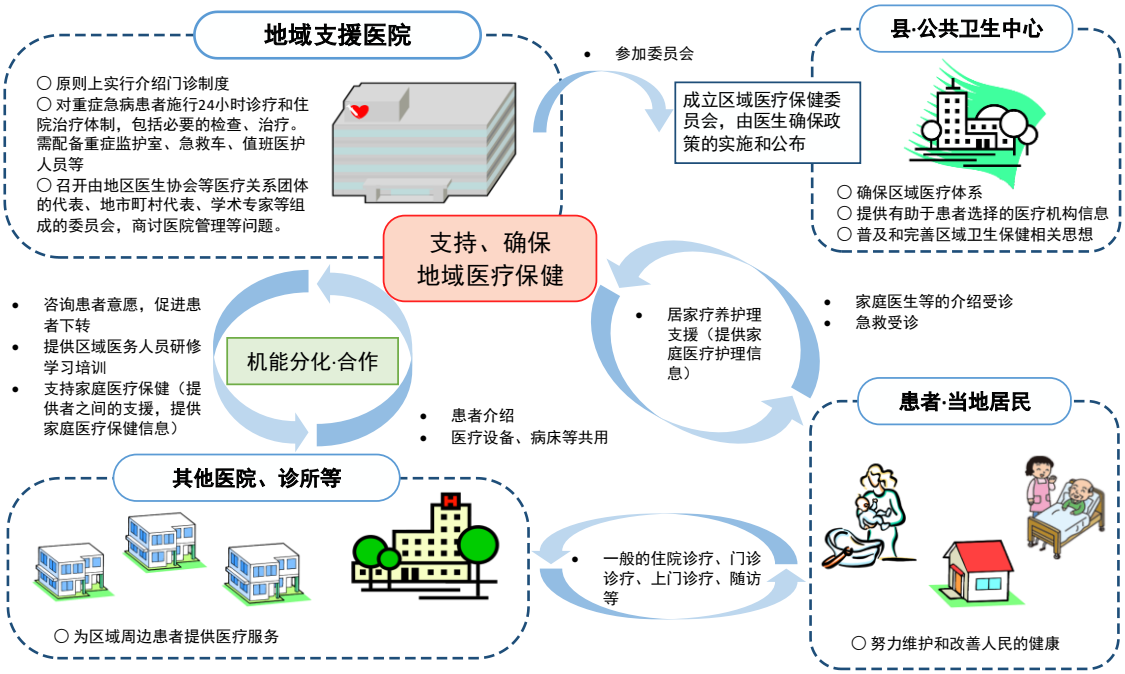


图 3-36 地域支援医院的功能

图片来源：www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r985200000253pd-att/2r985200000253tc.pdf，并由作者翻译

图 3-37 中東遠綜合醫療センター地域支援医院的功能

图片来源：http://www.chutoen-hp.shizuoka.jp/about/certification3.html，并由作者翻译

中国知网 https://www.cnki.net

2）诊疗中心配置数量

根据统计，目前日本官方认可的地域支援医院共 543 所[1]，所选研究案例 130 所，如图 3-38。

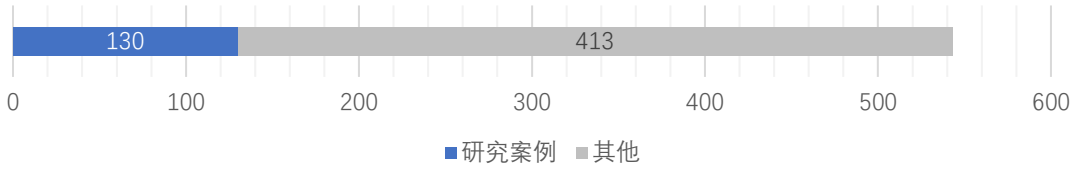


图 3-38 研究案例所占比例
图片来源：作者自绘

通过统计地域支援医院诊疗中心设置数量，如图 3-39。可以看出地域支援医院诊疗中心设置数量多分布在 3-7 个之间，少部分医院诊疗中心数量设置超过 11 个以上，地域支援医院平均设置 6 个左右诊疗中心，有 3 所医院设置 17 个诊疗中心。

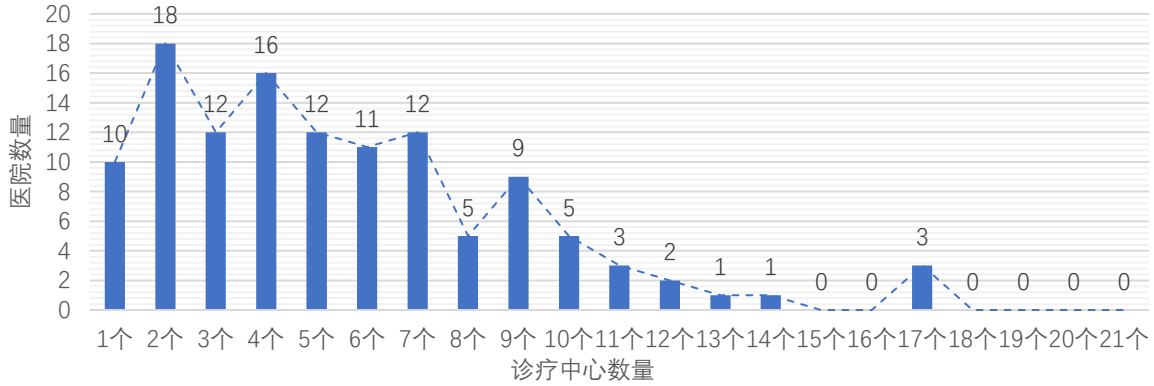


图 3-39 不同数量诊疗中心医院个数统计图
图片来源：作者自绘

3）诊疗中心种类

通过统计地域支援医院不同类型诊疗中心设置数量，如图 3-40。可以得到地域支援医院设置较多的诊疗中心依次为肿瘤中心、心脏（心血管）中心、肾脏中心和消化系统中心。在脏器中心中，设置数量较高的诊疗中心为心脏（心血管）中心、肾脏中心和脑神经中心；在系统中心中，消化系统中心、周产期母子医疗中心和骨科中心设置数量较多；在疾病中心中，肿瘤中心、糖尿病中心和脑卒中中心的设置数量较多。总的来说，脏器中心、系统中心和疾病中心设置量均衡（约各占 30%），见图 3-41。

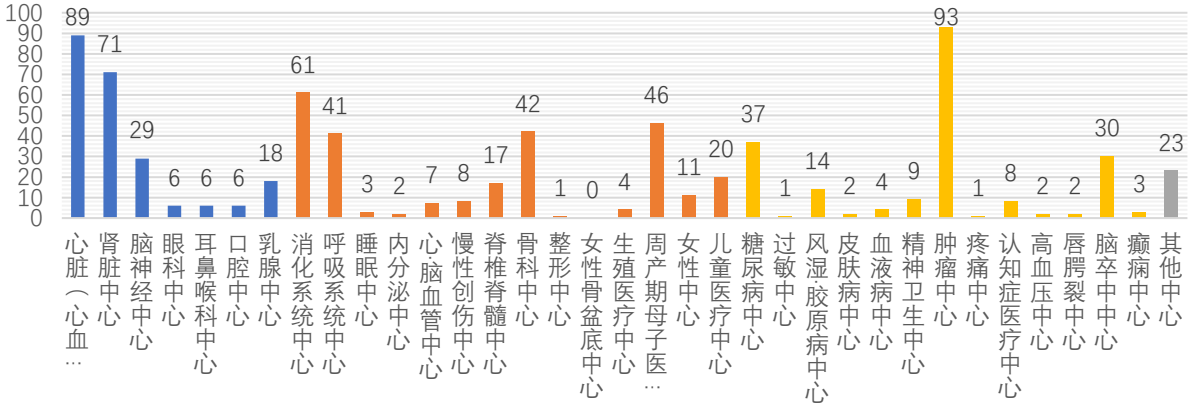


图 3-40 地域支援医院诊疗中心种类配置图
图片来源：作者自绘

[1] 数据来源：www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku.../0000188441.pdf

中国知网 https://www.cnki.net

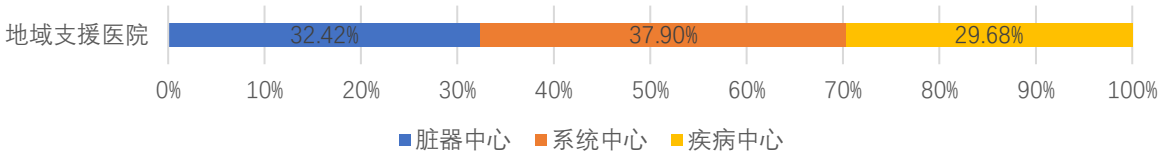
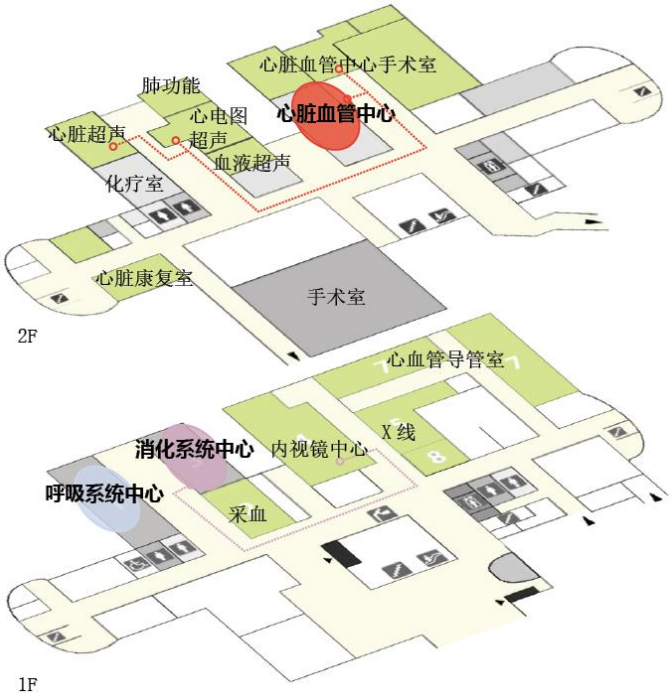


图 3-41 地域支援医院各类中心配置数量相对比率图
图片来源：作者自绘

4）位置关系

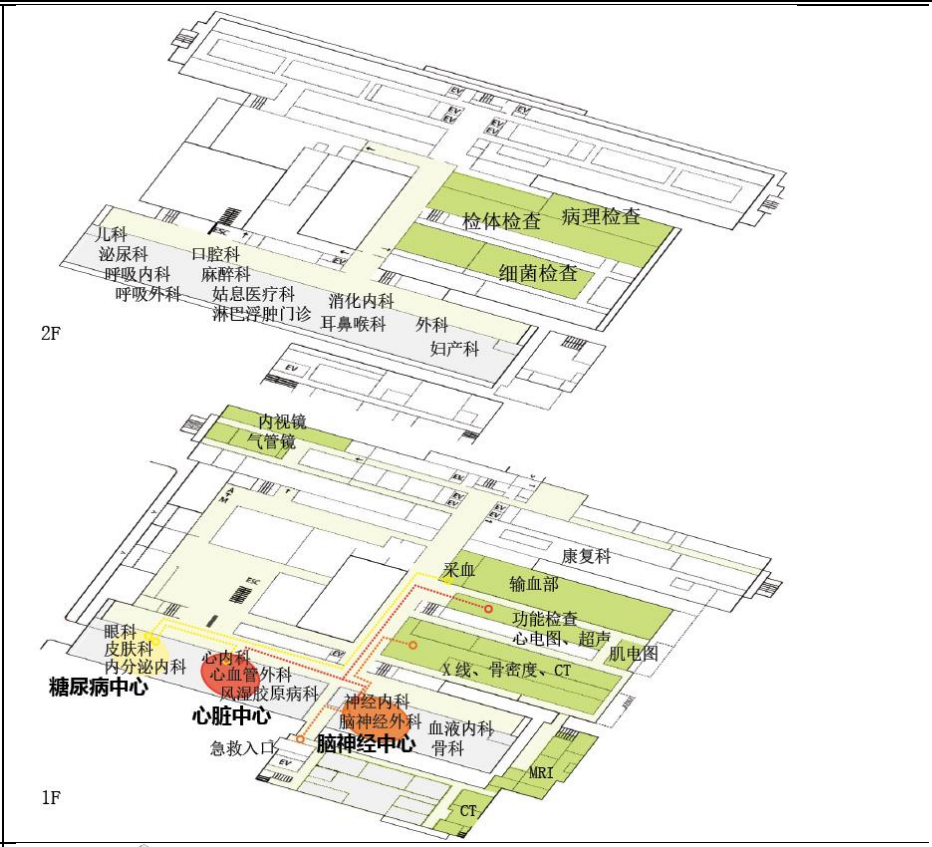
由于地域支援医院诊疗中心数量一般设置在 6 个左右，脏器中心、系统中心和疾病中心设置量均衡（约各占 30%），因此，地域支援医院诊疗中心平面布局多呈相关中心邻近布局的方式，相关科室邻近诊疗中心设置，相关医技集中邻近诊疗中心布局。见表 3.16。

表 3.16 地域支援医院诊疗中心平面布局特征

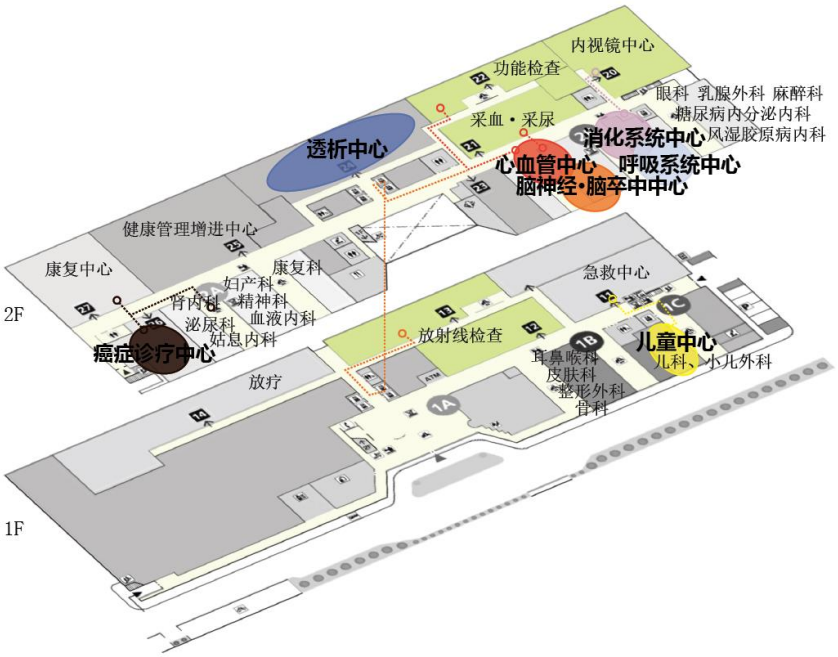
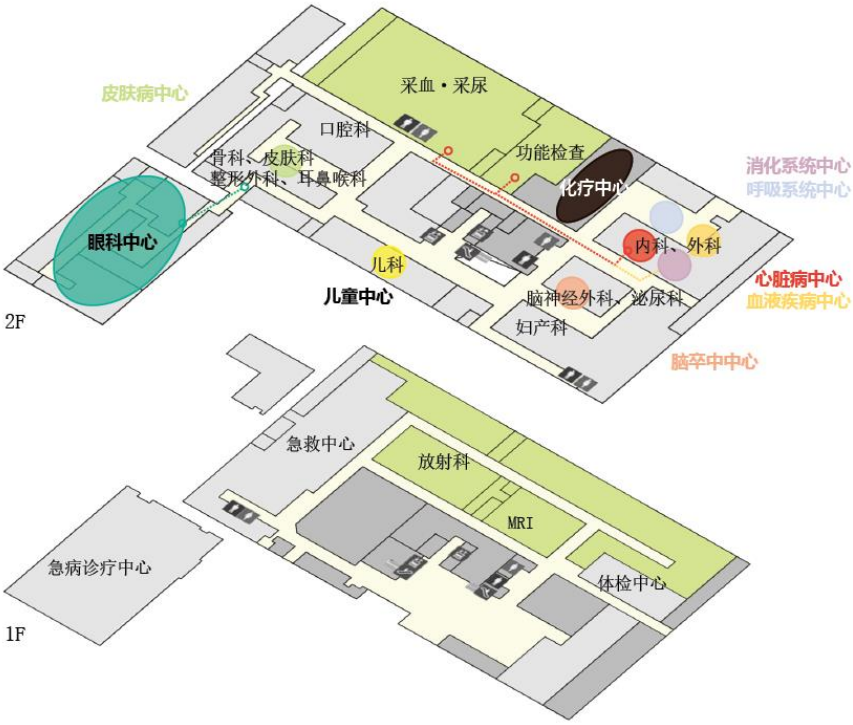
位置关系	医院名称	主要中心数量及种类	布局分析
1.中心独立，医技集中邻近	大阪赤十字病院	2 心脏血管中心 癌症诊疗中心	
2.中心间独立，相关医技分散邻近	仙台厚生病院	3 心脏血管中心 呼吸系统中心 消化系统中心	

中国知网 https://www.cnki.net

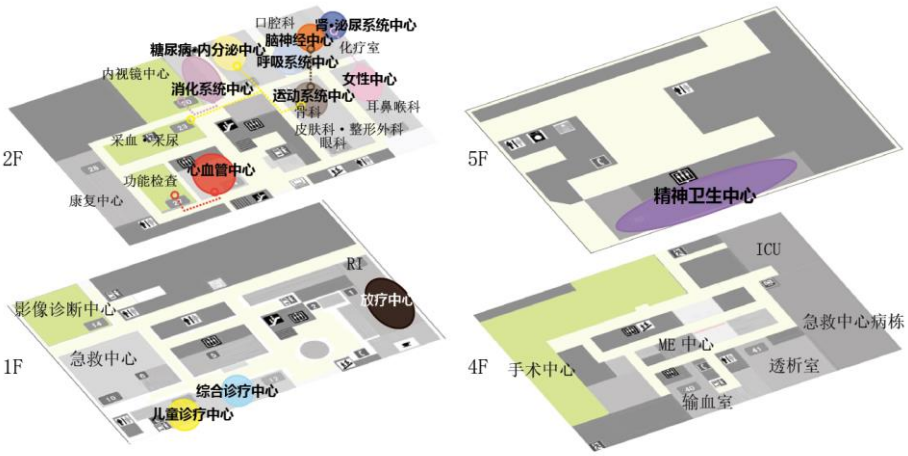
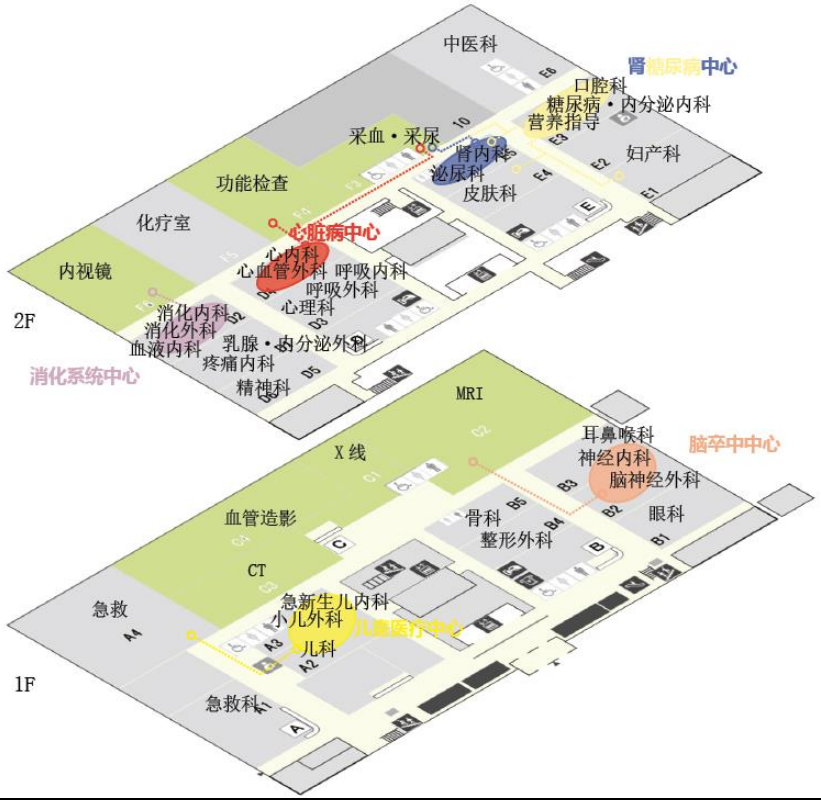
3.相关中心间关联，相关科室邻近，相关医技集中邻近

青森県立中央病院	6 癌症诊疗中心 姑息治疗中心 心脏中心 脑神经中心 糖尿病中心 综合周产期母子医疗中心	
篠ノ井総合病院	9 人工肾中心 风湿胶原病中心 心脏血管中心 关节疾病运动障碍治疗中心 地域周产期母子医疗中心 结石治疗中心 睡眠呼吸中心 糖尿病中心 不孕不育治疗中心	

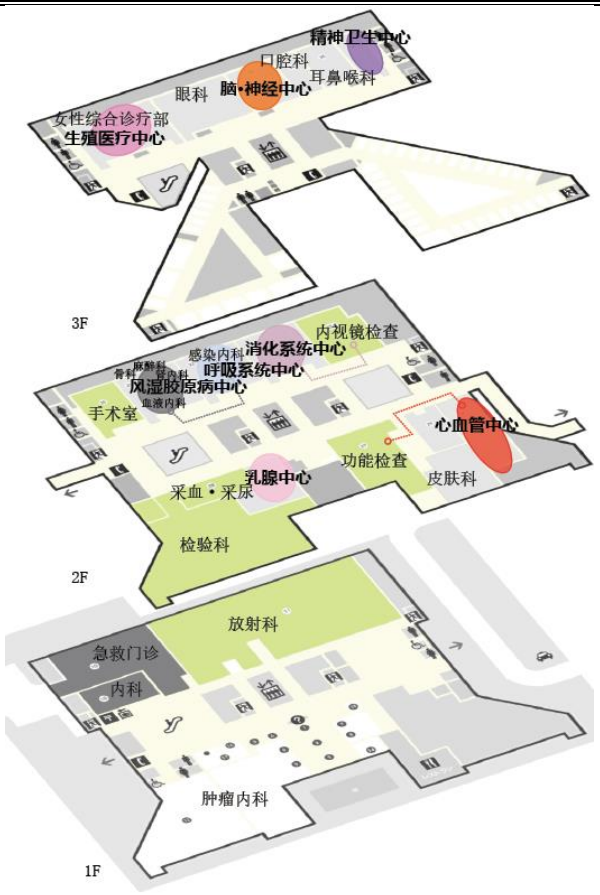
中国知网 https://www.cnki.net

淀川キリスト教病院	10 癌症诊疗中心 母子中心 脑神经・脑卒中中心 消化系统中心 呼吸系统中心 心脏血管中心 助产中心 化疗中心 儿童医疗中心 人工透析中心	
堺市立総合医療センター	14 综合诊疗中心 癌症中心 消化系统中心 呼吸系统中心 心脏病中心 肾・透析中心 脑卒中中心 糖尿病中心 血液疾病中心 风湿胶原病中心 儿童中心 皮肤病中心 乳腺中心 眼科中心	

中国知网 https://www.cnki.net

	济生会横浜市東部病院	17 综合诊疗中心 消化系统中心 呼吸系统中心 心脏血管中心 糖尿病・内分泌中心 肾泌尿系统中心 脑神经中心 女性中心 儿童中心 精神卫生中心 运动系统中心 感觉・口腔中心 放疗中心 主动脉治疗中心 前列腺治疗中心 瓣膜治疗中心 癌症中心	
4. 相关中心间关联，相关科室邻近，相关医技分散邻近	愛媛県立中央病院	9 周产期母子医疗中心 儿童医疗中心 肾糖尿病中心 消化系统中心 癌症治疗中心 脑卒中中心 心脏病中心 综合诊疗中心 灾害中心	

中国知网 https://www.cnki.net

	聖路加国際病院	12 呼吸系统中心 消化系统中心 儿童综合医疗中心 心血管中心 肾中心 运动医疗中心 脑・神经中心 乳房中心 风湿胶原病中心 精神卫生中心 生殖医疗中心 认知症疾病医疗中心	

注：图表自制

3.3.4 一般医院

1）基本情况

一般医院指除特定机能医院和地域支援医院之外的医院，是大多数人就医的地方，旨在为患者提供方便、科学、适当的医疗服务。

2）诊疗中心配置数量

据日本官方 2017 年统计结果显示，目前日本国内医院设施共 8439 所，其中一般医院 7378 所，精神病院 1061 所。[1]，除去其中特定机能医院 85 所，地域支援医院 543 所，一般医院共 6750 所，研究所选一般医院 110 所，见图 3-42。

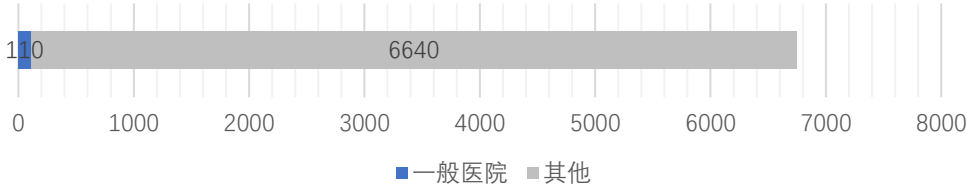


图 3-42 研究案例与总数的对比分析图
图片来源：作者自绘

通过对一般医院诊疗中心数量统计，见图 3-43，可以得出大多数一般医院诊疗中心数量

[1] 数据来源：http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/iryosd/m17/dl/is1703_01.pdf

中国知网 https://www.cnki.net

设置在 4 个左右，仅有 6 家医院诊疗中心设置数量超过 12 个，仅有一家医院诊疗中心的设置数量为 16 个。

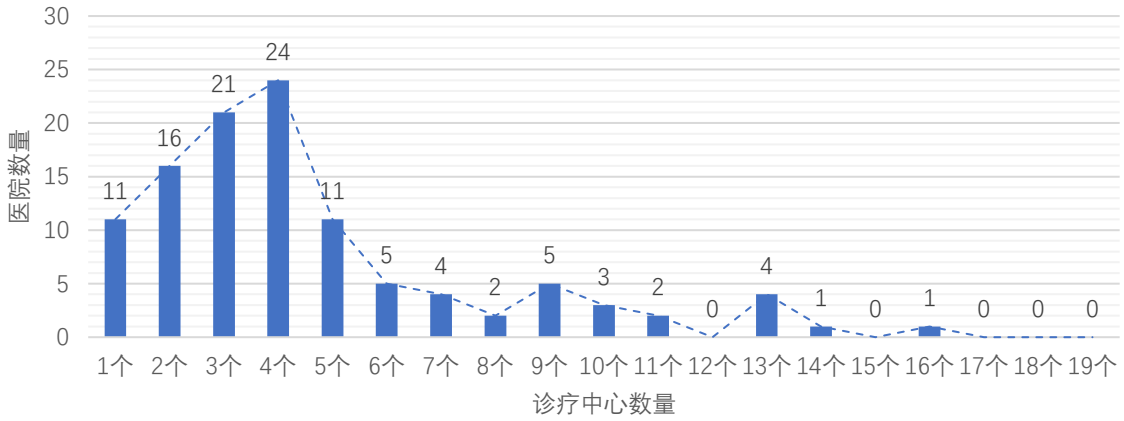


图 3-43 一般医院诊疗中心数量统计图
图片来源：作者自绘

3）诊疗中心种类

将一般医院不同类型诊疗中心进行统计，如图 3-44。可得出一般医院设置诊疗中心种类最多的为消化系统中心，其次为肾脏中心、肿瘤中心和心脏（心血管中心）。在脏器中心中，肾脏中心、心脏（心血管）中心和脑神经中心的设置数量较多；系统中心中，消化系统中心、骨科中心和脊椎脊髓中心设置数量较多；疾病中心中，肿瘤中心、糖尿病中心和脑卒中中心的设置数量较多。总的来看，脏器中心、系统中心和疾病中心设置量均衡（约各占 30%），见图 3-45。

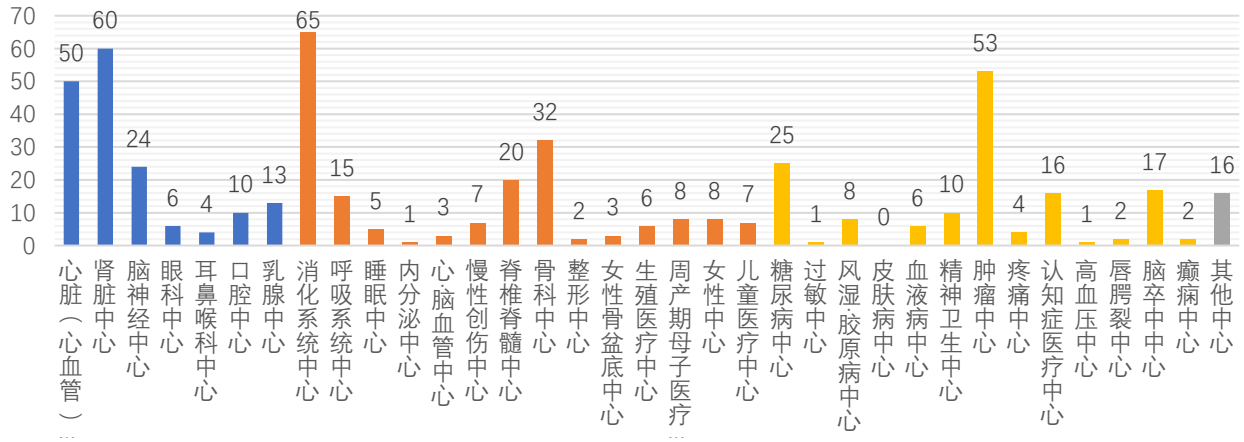


图 3-44 一般医院诊疗中心种类统计图
图片来源：作者自绘

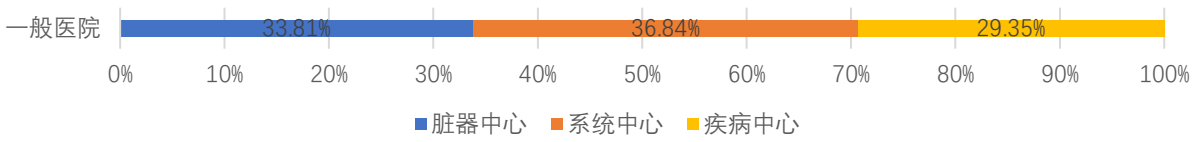


图 3-45 一般医院各类中心配置数量相对比率图
图片来源：作者自绘

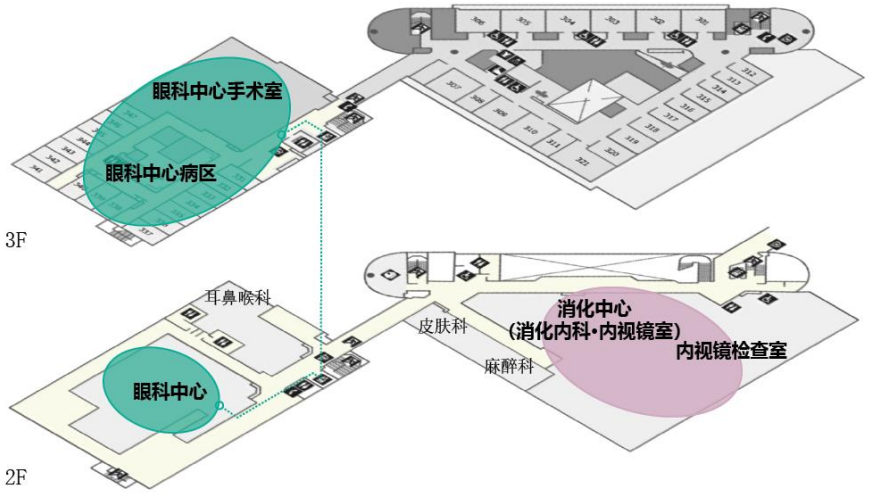
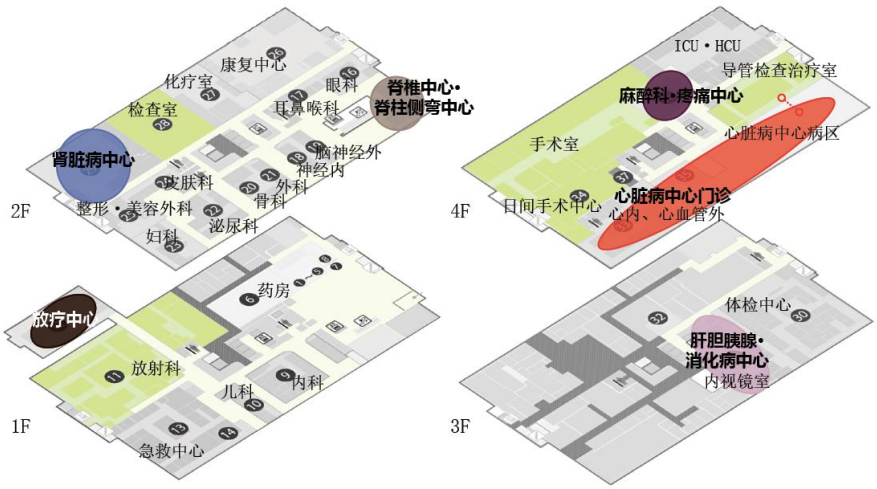
4）位置关系

由于一般医院诊疗中心的数量一般在 4 个左右，脏器中心、系统中心和疾病中心设置量

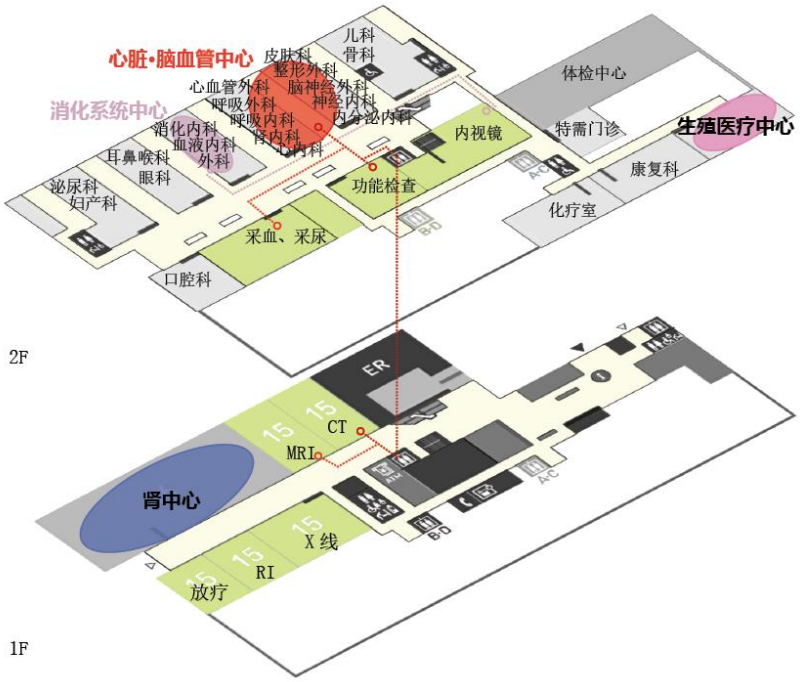
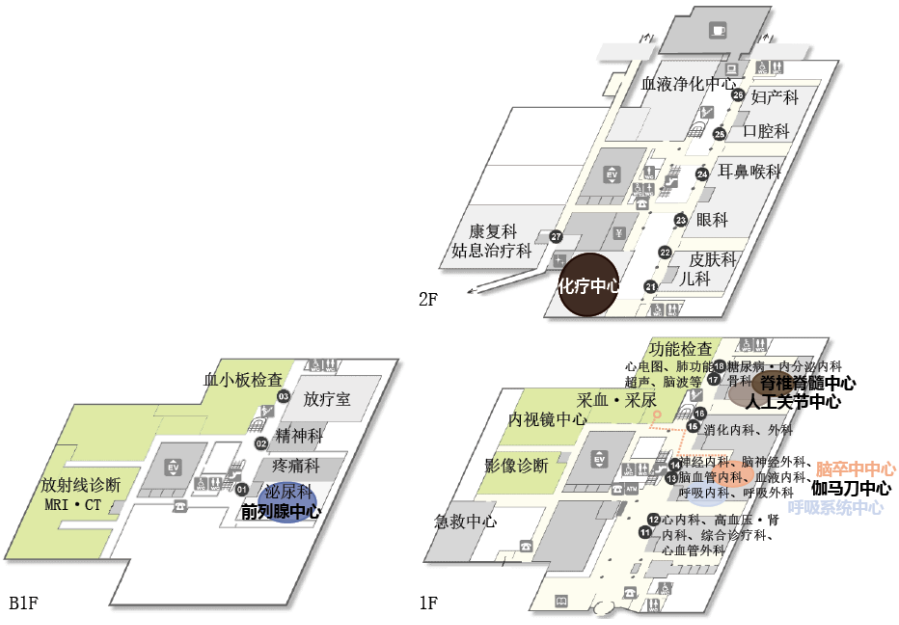
中国知网 https://www.cnki.net

均衡（约各占 30%），所以一般医院诊疗中心多关联分布，相关医技内设或邻近布置的模式，见表 3.17。

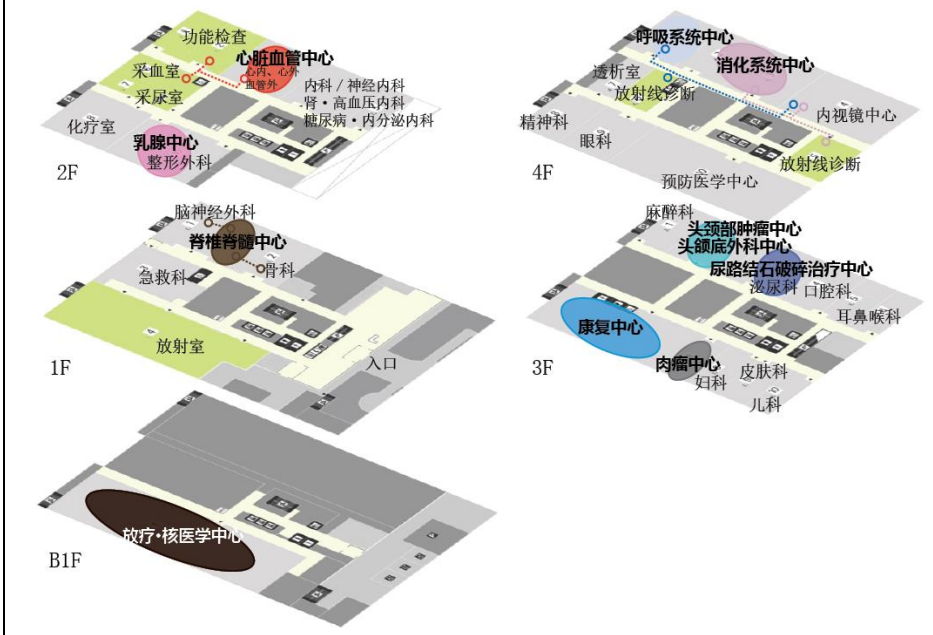
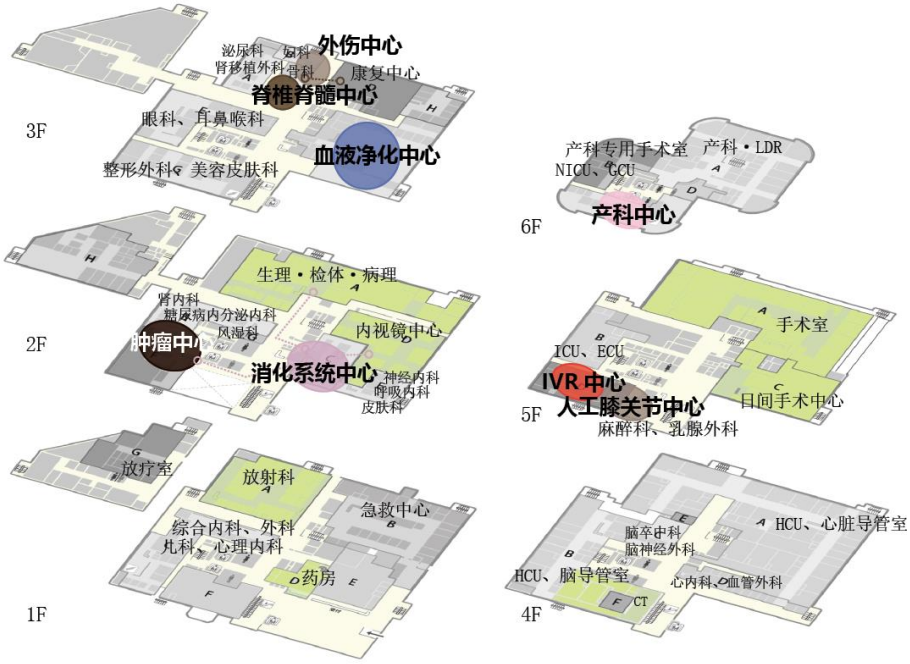
表 3.17 一般医院诊疗中心平面布局特征

位置关系	医院名称	主要中心数量及种类	布局分析
I. 中心独立，相关医技内置	潤和会記念病院	1 脑神经中心	
	真生会富山病院	2 消化系统中心 眼科中心	
	湘南藤沢徳洲会病院	6 心脏病中心 肾病中心 肝胆胰腺·消化病中心 脊椎中心·脊柱侧弯中心 放疗中心 麻醉科·疼痛中心	

中国知网 https://www.cnki.net

2. 中心间独立，相关医技邻近	千葉メディカルセンター	4 运动医学中心 消化系统中心 心脏血管中心 不孕不育治疗中心	
	立川綜合病院	4 心脏·脑血管中心 消化系统中心 生殖医疗中心 肾中心	
3. 相关中心关联，相关科室邻近，相关医技分散邻近	NTT 東日本関東病院	7 呼吸系统中心 人工关节中心 脊椎·脊髓中心 前列腺中心 脑卒中中心 化疗中心 伽马刀中心	

中国知网 https://www.cnki.net

	国際医療福祉大学三田病院	13 心脏血管中心 尿路结石破碎治疗中心 肺高血压中心 女性肿瘤中心·妇科 脊椎脊髓中心 耳鼻喉科（听觉·人工内耳中心） 头颈部肿瘤中心 头颌底外科中心 消化中心 肉瘤中心 乳腺中心 呼吸中心 放疗·核医学中心	
	湘南鎌倉総合病院	13 肾脏病综合医疗中心 血液净化中心 SAS 中心 消化系统中心 主动脉中心 脊椎脊髓中心 外伤中心 产科中心 人工膝关节中心 肿瘤中心 未来医疗研究中心 日间护理中心 IVR 中心	

注：图表自制

3.3.5 高度综合医疗设施

1）基本情况

日本独立行政法人国立医疗机构，主要针对日本国民公共卫生有严重影响的疾病，实行“政策医疗”，以弥补私立医院医疗条件的不足的状况。独立行政法人国立医疗机构在全国共设有 142 所[1]实行政策医疗的医院，并根据政策医疗内容，分为高度专门医疗设施、基干医疗设施、专门医疗设施、其他政策医疗和高度综合医疗设施，见表 3.18。

[1] 日本独立行政法人国立医院机构官方统计数据来源：http://www.hosp.go.jp/about/cnt1-0_000003.html

中国知网 https://www.cnki.net

表 3.18 政策医疗医院功能类型

都道府县	病院名	功能类型（★高度专门医疗、◎基干医疗、○专门医疗、●其他的政策医疗）																			高度综合医疗
		癌症	心脏病	精神疾病	神经・肌肉疾病	成育医疗	呼吸系统疾病	免疫异常	重症心身障碍	肾疾病	内分泌・代谢疾病	感觉器官疾病	骨・运动器官疾病	血液・造血器官疾病	肝疾病	长寿医疗	国际医疗合作	国际传染病	艾滋病	灾害医疗	
富山	富山					○	○		○												
	北陆			○	○				○												
石川	金沢	○	○	○		○	●			○	○	○	●	●	○	○			●	●	☆
	医王				○	○			○				●						○		
	七尾				○		○		○												
	石川		○						○										○		
岐阜	长良		○		○	○	○		○												
静冈	静岡て・神				◎				○								●				
	静冈富士				○				○												
	天竜				○	○	○		○												
	静冈	○	◎					○											●		
爱知	名古屋	◎	○	○	●	○	●	◎		●	○	○	○	★	●				○	●	☆
	东名古屋				○		○		○										●		
	东尾张			○																	
	豊桥	○	○						○		○										
	长寿															★					
三重	三重					○			○								●				
	铃鹿				○				○												
	三重中央	○	○			◎	○												●		
	榊原			○																	
计		5	7	5	10	8	8	2	13	2	3	2	3	2	2	2	2	0	7	2	2

注：★高度专门医疗设施：实施政策医疗（高度先进的医疗设施等、临床研究、教育研修、信息传播），是全国国立医院・疗养院的核心机构。
◎基干医疗设施：为特定疾病提供治疗的中心机构，与高度专门医疗设施合作推行政策医疗。
○专门医疗设施：为特定疾病提供治疗的机构，与高度专门医疗设施和基干医疗设施合作推行政策医疗。
●其他的政策医疗：除上述外，提供国家其他政策医疗的机构。
☆高度综合医疗设施：实施政策医疗、具备高度综合医疗功能，并在灾难发生时提供医疗支援。
表格来源：https://www.hosp.go.jp/~tohkai/common/pdf/clinical01.pdf

本节选取日本独立行政法人国立医疗机构官网公布的、具备高度综合医疗功能的高度综合医疗设施 10 所医院进行相关统计研究[1]，基本情况见表 3.19。

表 3.19 高度综合医疗设施基本信息表

诊疗中心数量	医院名称	病床数	日门诊人次	日住院人数
1	横浜医療センター	510	835	425
	大阪医療センター	692	1138	518
2	仙台医療センター	689	963	540
	名古屋医療センター	740	1377	558
3	金沢医療センター	554	707	427
6	長崎医療センター	643	750	503
	東京医療センター	760	1607	560
7	京都医療センター	600	1362	507
9	呉医療センター	700	1014	486
12	九州医療センター	702	889	561

注：以上数据来源于各医院官网、病院情报局等相关资料

[1] 独立行政法人 国立疗机构 http://www.hosp.go.jp/index.html

中国知网 https://www.cnki.net

2）诊疗中心配置数量

通过对高度综合医疗设施诊疗中心数量统计，见图 3-46，可以见大多数高度综合医疗设施诊疗中心设置数量在 6 个左右，仅有 1 家医院诊疗中心设置数量超过 10 个。

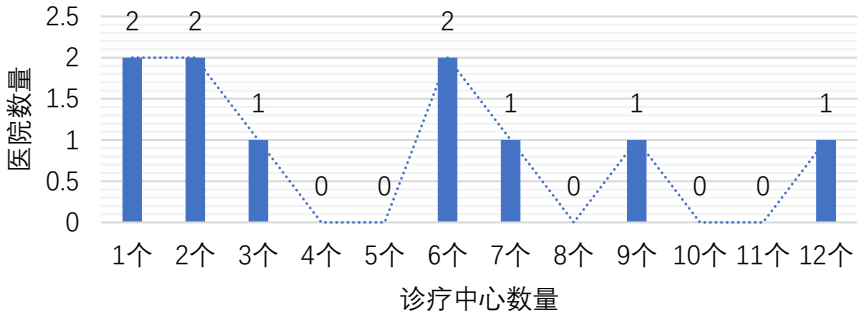


图 3-46 高度综合医疗设施诊疗中心数量统计图
图片来源：作者自绘

3）诊疗中心种类

将高度综合医疗设施不同类型诊疗中心进行统计，如图 3-47。可得出高度综合医疗设施设置诊疗中心种类最多的为肿瘤中心，其次为周产期母子医疗中心、骨科中心。在脏器中心中，心脏（心血管）中心、脑神经中心和肾脏中心的设置数量较多；系统中心中，周产期母子医疗中心、骨科系统中心和消化系统中心设置数量较多；疾病中心中，肿瘤中心和糖尿病中心设置数量较多。 总的来说，高度综合医疗设施脏器中心、系统中心和疾病中心设置量均衡（约各占 30%），见图 3-48。

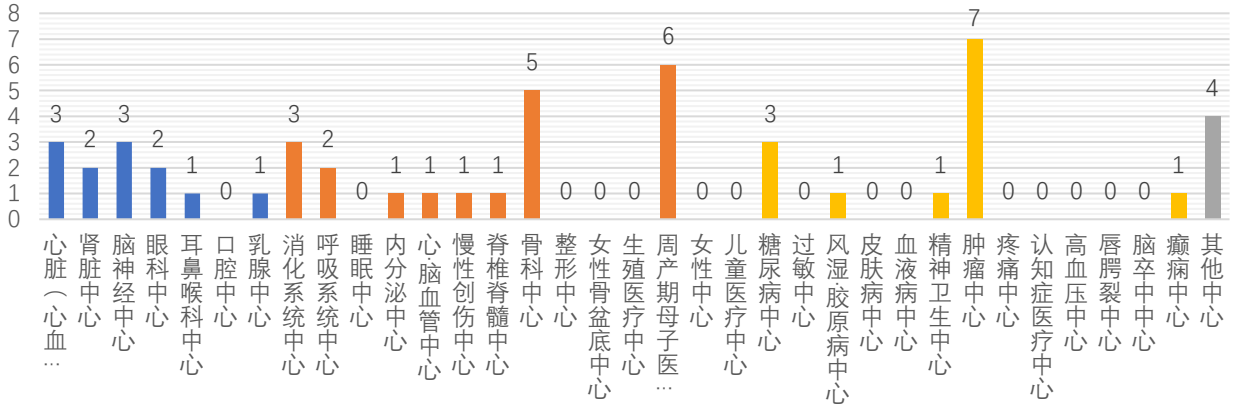


图 3-47 高度综合医疗设施诊疗中心种类统计图
图片来源：作者自绘

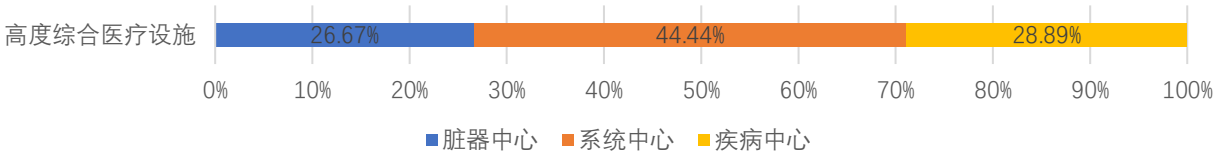


图 3-48 高度综合医疗设施各类中心配置数量相对比率图
图片来源：作者自绘

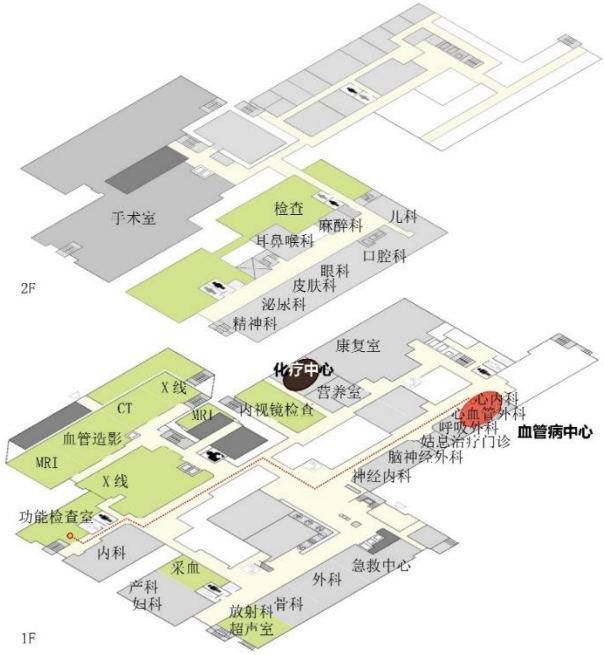
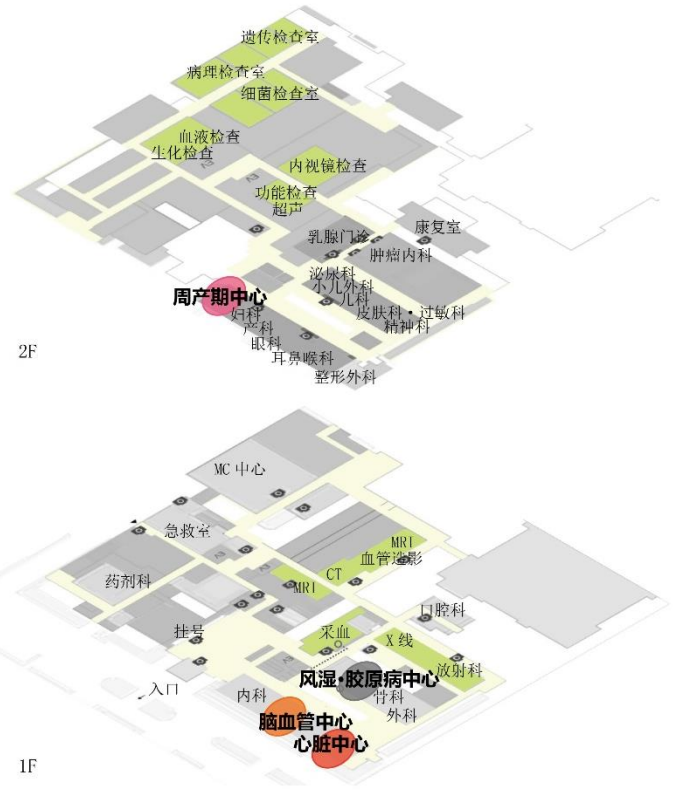
4）位置关系

由于高度综合医疗设施诊疗中心多设置 6 个左右，脏器中心、系统中心和疾病中心设置量均衡（约各占 30%），所以平面布局总体呈现医技相对集中的态势，诊疗中心间关联邻近

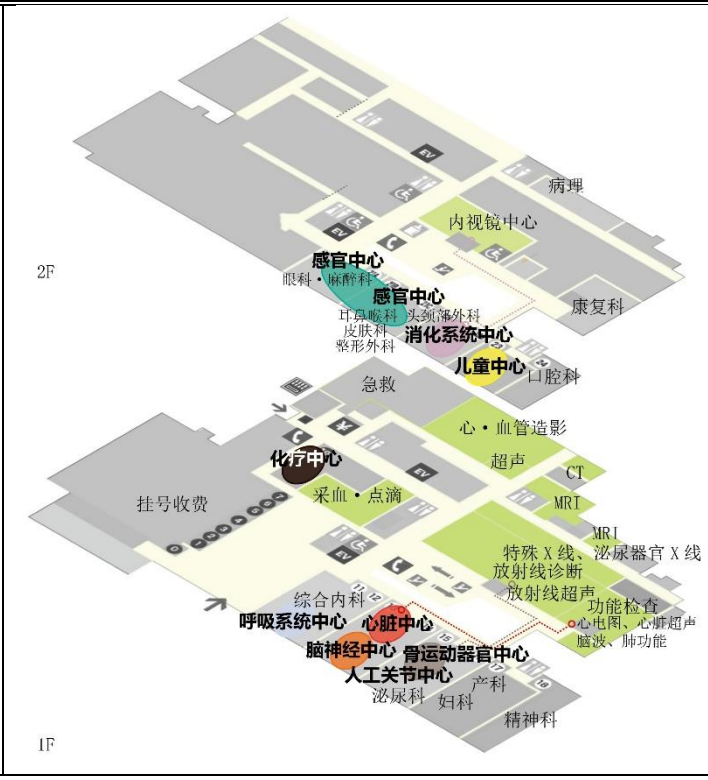
中国知网 https://www.cnki.net

布局，见表 3.20。

表 3.20 高度综合医疗设施诊疗中心平面布局特征

位置关系	医院名称	主要中心数量及种类	布局分析
1. 中心独立，医技集中	金沢医療センター	3 血管病中心 化疗中心 癌症咨询中心	
2. 相关中心间关联，部分相关医技相邻	九州医療センター	12 脑血管中心 心脏中心 呼吸系统中心 风湿・胶原病中心 糖尿病・代谢内分泌中心 前列腺癌综合治疗中心 周产期中心 消化系统中心 肝脏中心 乳腺中心 AIDS/HIV 综合治疗中心 合并精神中心	

中国知网 https://www.cnki.net

3.相关中心间关联，相关医技集中相邻	呉医療センター	9 癌症中心 呼吸系统中心 心脏中心 脑神经中心 骨运动系统中心 感官中心 消化系统中心 人工关节中心 母子医疗中心	

注：图表自制

3.3.6 国立高度专门医疗研究中心

1）基本情况

国立高度专门医疗研究中心作为防治日本死亡数、患者数和医疗费用等占最大比例的疾病（如癌症、脑卒中和心脏病）的核心医疗机构，拥有研究实验室和医院，并与高度专门医疗设施合作，综合全面的提供高度先进的医疗研究、开发和传播服务，解明疾病病因和病理，研发新型诊断和治疗方法，培训医务工作人员和信息传播。[1]日本国立高度专门医疗研究中心共 6 所，包含相关医院 8 所，基本情况见表 3.21。

表 3.21 国立高度专门医疗研究中心概要

法人名	病床数	业务内容
（独）国立癌症研究中心	1. 中央医院：600 床 2. 东医院：425 床	作为日本癌症防治的核心机构，积极开展癌症和其他恶性肿瘤的相关研究开发、医疗保健、医务人员培训、信息传播和政策咨询等服务。
（独）国立心脏病研究中心	618 床	作为日本脑卒中、心脏病等心脏疾病防治的核心机构，积极开展心脏疾病相关的研究开发、医疗保健、医务人员培训、信息传播和政策咨询等服务。
（独）国立精神・神经医疗研究中心	474 床	作为日本精神・神经疾病防治的核心机构，积极开展精神、神经、肌肉疾病、认知障碍和发育障碍的相关研究开发、医疗保健、医务人员培训、信息传播和政策咨询等服务。
（独）国立国际医疗研究中心	1. 医院：801 床 2. 国府台医院：622 床	作为日本国家保健医疗合作的核心机构，积极开展传染病等国际调查研究疾病相关的研究开发、医疗保

[1] http://www.mhlw.go.jp/seisaku/27.html

中国知网 https://www.cnki.net

		健、医务人员培训、信息传播和政策咨询等服务。
（独）国立成育医疗研究中心	490 床	作为日本成育医疗的核心机构，积极开展儿童医疗、母性医疗、父性医疗和相关领域的成育医疗的相关研究开发、医疗保健、医务人员培训、信息传播和政策咨询等服务。
（独）国立长寿医疗研究中心	383 床	作为日本长寿医疗的核心机构，积极开展高龄者患者有的疾病的相关研究开发、医疗保健、医务人员培训、信息传播和政策咨询等服务。

注：表格来源：根据 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002esyb-att/2r9852000002et42.pdf，整理而成。

2）诊疗中心配置数量

通过对高度专门医疗研究中心诊疗中心数量统计，见图 3-49，可以见高度专门医院研究中心诊疗中心设置数量平均在 6 个左右，仅有 1 家医院诊疗中心设置数量超过 10 个。

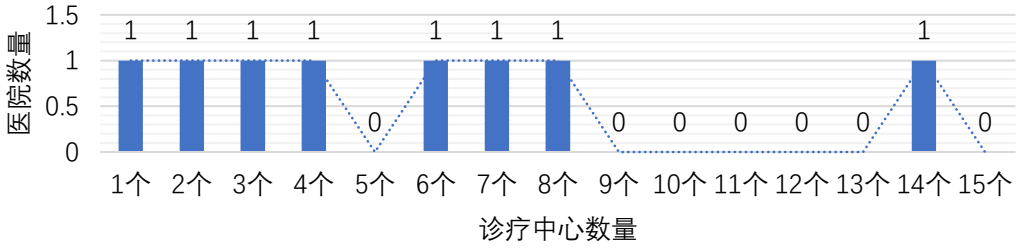


图 3-49 国立高度专门医疗研究中心诊疗中心数量统计图
图片来源：作者自绘

3）诊疗中心种类

将高度专门医疗研究中心不同类型诊疗中心进行统计，如图 3-50。可得出高度专门医疗研究中心设置诊疗中心种类最多的为肿瘤中心，其次为精神卫生中心和认知症医疗中心。在脏器中心中，脑神经中心和口腔中心的设置数量较多；系统中心中，周产期母子医疗中心、儿童医疗中心和消化系统中心设置数量较多；疾病中心中，肿瘤中心、精神卫生中心和认知症医疗中心设置数量较多。

值得注意的是，由于国立高度专门医疗研究中心往往针对某类疾病进行高度专门医疗，所以多设置疾病中心，且诊疗中心的设置种类往往具有一定的特殊性和针对性。如仅国立精神・神经医疗研究中心，就设置了如地域精神模型医疗中心、药物依赖治疗中心和自杀综合治疗推进中心等在内的 6 个精神卫生相关中心。

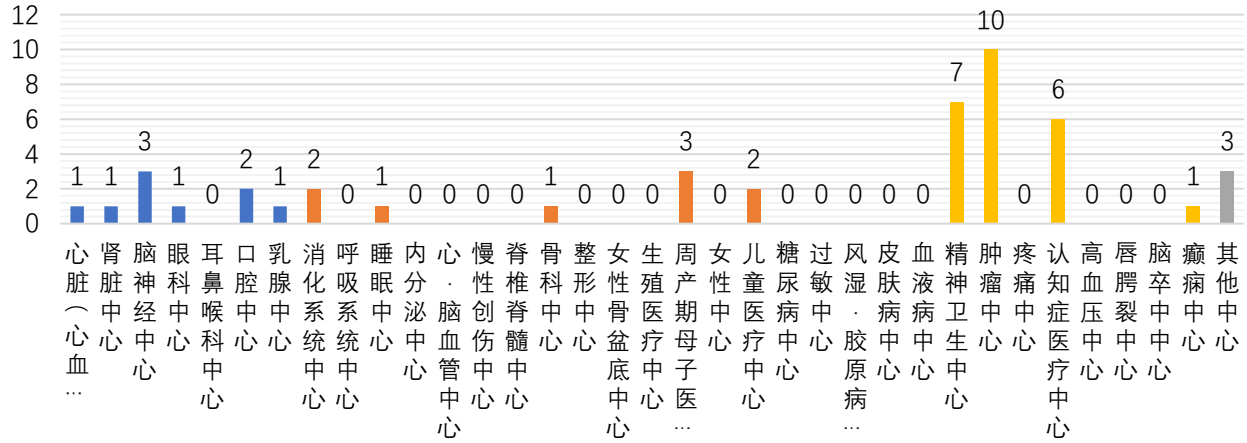


图 3-50 国立高度专门医疗研究中心诊疗中心种类统计图
图片来源：作者自绘

中国知网 https://www.cnki.net

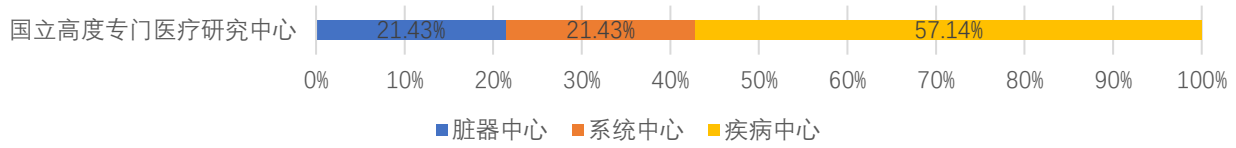
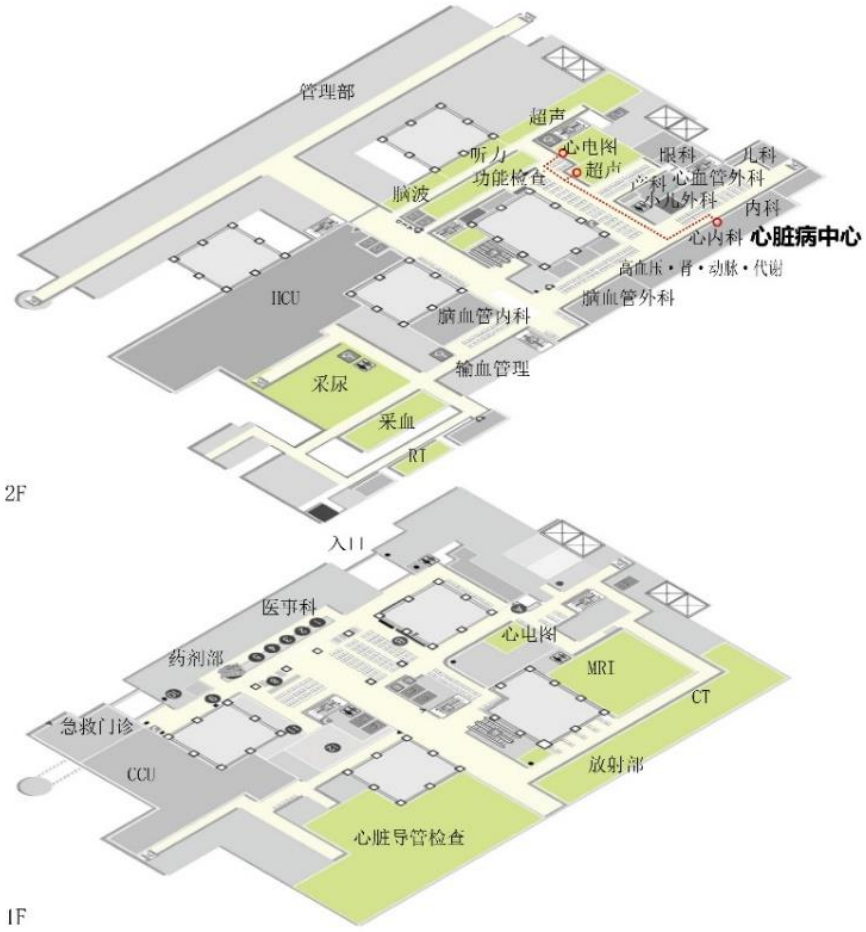


图 3-51 国立高度专门医疗研究中心各类中心配置数量相对比率图
图片来源：作者自绘

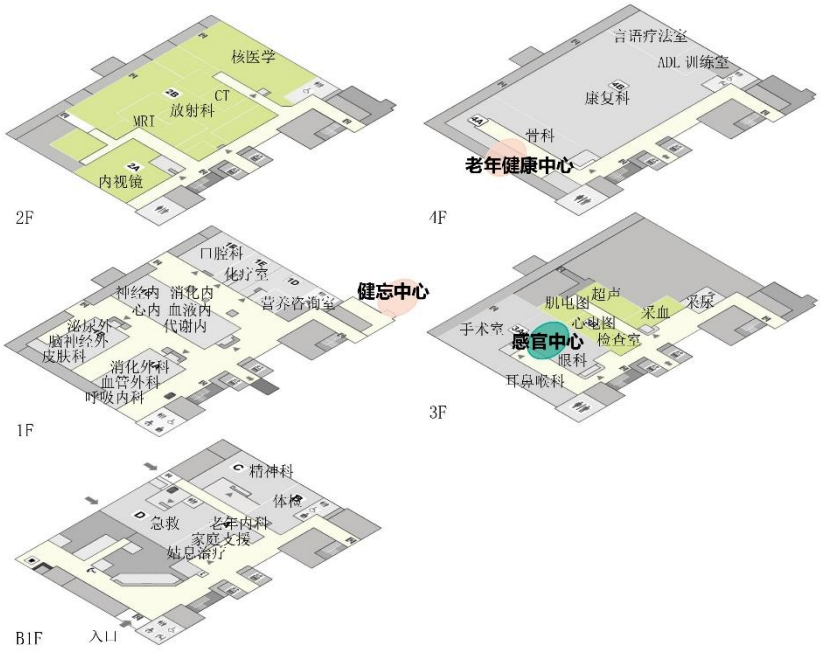
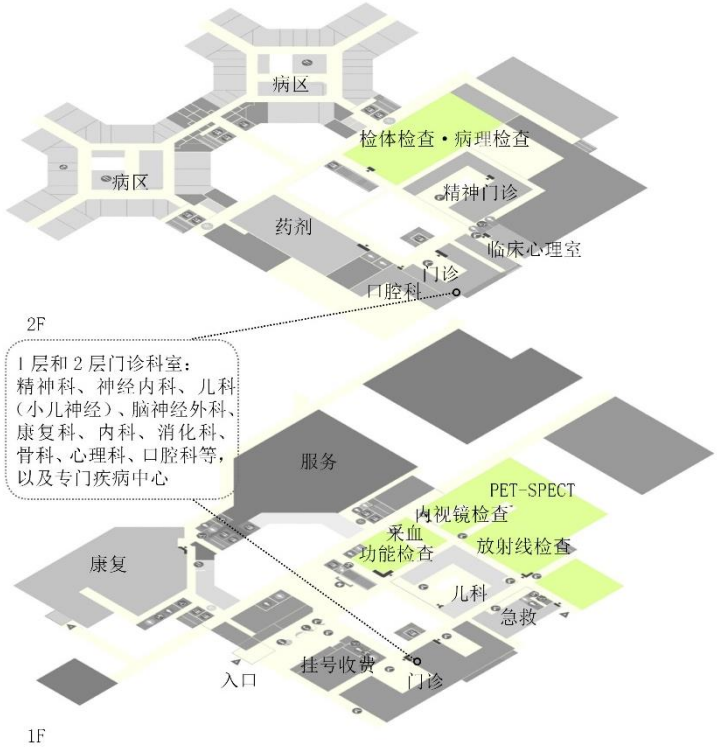
4）位置关系

由于国立高度专门医疗研究中心多设置针对某类疾病的相关诊疗中心，即疾病中心，诊疗中心间往往关联布局，医技则相对集中布局，见表 3.22。

表 3.22 国立高度专门医疗研究中心诊疗中心平面布局特征

位置关系	医院名称	主要中心数量及种类	布局分析
1.中心独立，医技集中邻近	国立循環器病研究センター	1 心脏病综合信息中心	

中国知网 https://www.cnki.net

2. 中心独立分布，医技集中	国立長寿医療研究センター	6 认知症先进医疗开发中心 健忘中心 口腔先进医疗开发中心 健康长寿机器人中心 感官中心 老年健康中心	
3. 相关中心间关联，相关医技集中相邻	国立精神・神経医療研究センター	14[1)] 多发性硬化症中心 肌肉疾病中心 癫痫中心 帕金森・运动障碍疾病中心 地域精神模型医疗中心 睡眠障碍中心 统和失调症早期诊断・治疗中心 气愤障碍先进治疗中心 认知症中心 吞咽障碍研究中心 药物依赖治疗中心 认知行动疗法中心 自杀综合治疗推进中心 综合脑成像中心	

注：1）这些疾病中心多需要神经内科、精神科等合作诊疗，往往需要预约诊疗，首诊医生负责制。

图表自制

3.3.7 对比研究

1）不同类型医院诊疗中心配置数量

通过统计各类型医院诊疗中心设置数量，可得出设置 3-5 个诊疗中心的医院数量最多，见图 3-52。通过对各类型医院诊疗中心配置数量所占比率统计，得出特定机能医院诊疗中心的设置数量多见 12 个及以上，地域支援型医院诊疗中心配置数量多见 7 个左右，一般医院诊疗中心数量多见 4 个左右。如图 3-53。

中国知网 https://www.cnki.net

通过统计各类型医院诊疗中心数量分布趋势（图 3-54）、各类型医院诊疗中心相对数量分布趋势（图 3-55）和各类型医院诊疗中心数量分布箱型图（图 3-56），可以得出，特定机能医院诊疗中心平均设置数量高于国立高度专门医疗设施高于地域支援医院高于高度综合医疗设置高于一般医院，其中特定机能医院诊疗中心设置数量平均在 9 个左右，国立高度专门医疗中心诊疗中心设置数量平均在 6 个左右，地域支援医院诊疗中心设置数量平均在 6 个左右，高度综合医疗设施诊疗中心数量一般设置在 5 个左右，一般医院诊疗中心设置数量平均在 4 个左右。由此可见，诊疗中心的设置数量与医院机能呈一定的相关性。

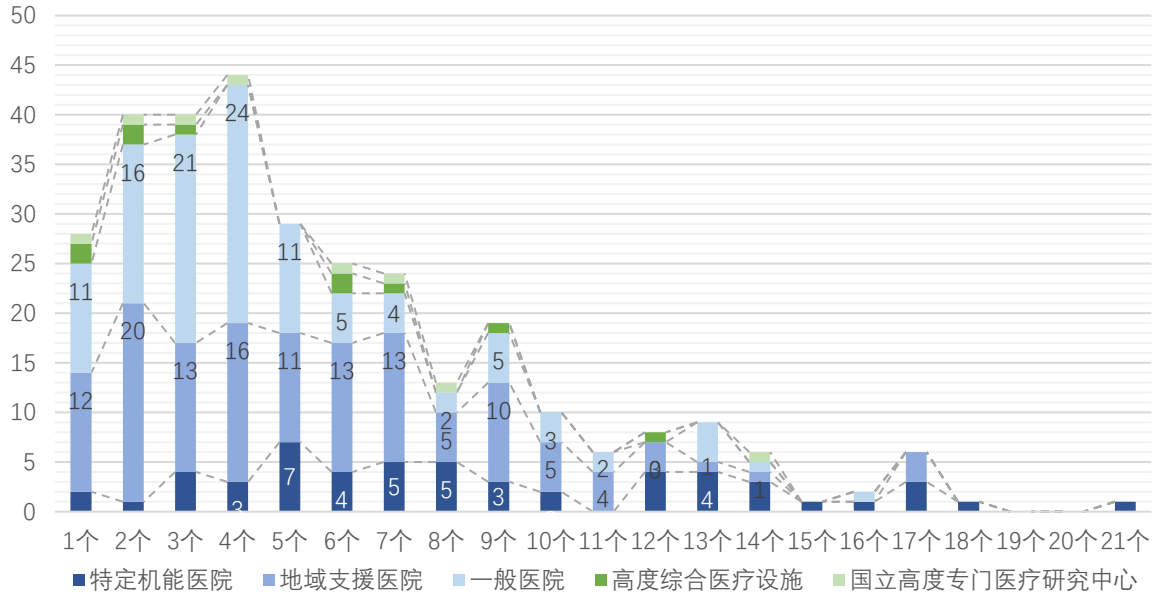


图 3-52 不同类型医院诊疗中心配置数量统计图
图片来源：作者自绘

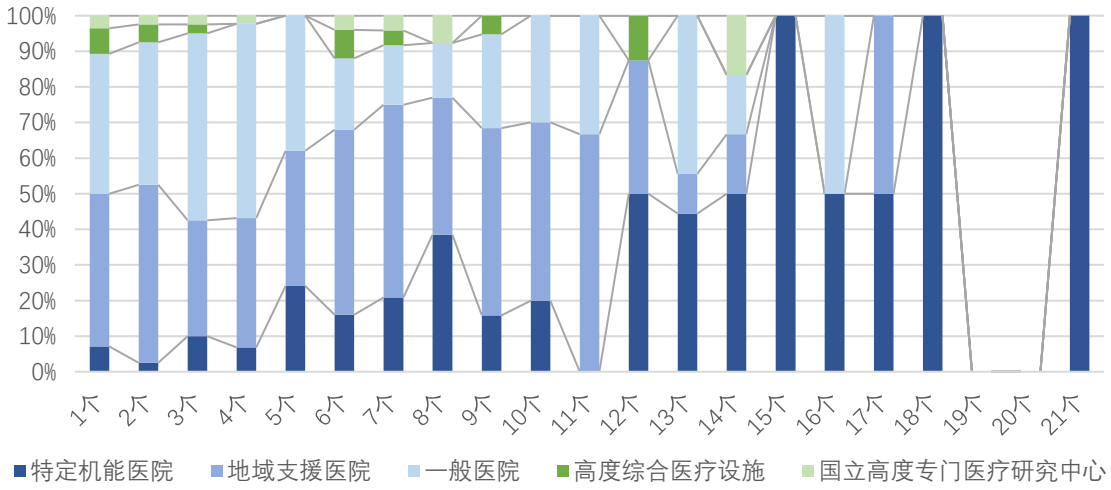


图 3-53 不同类型医院诊疗中心配置数量所占比率图
图片来源：作者自绘

中国知网 https://www.cnki.net

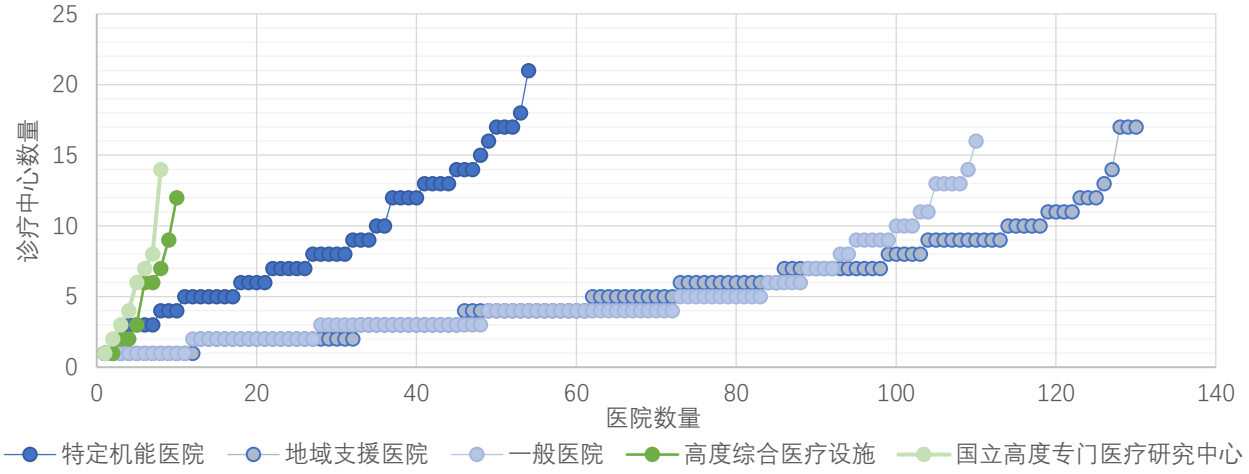


图 3-54 不同类型医院的诊疗中心配置数量趋势图
图片来源：作者自绘

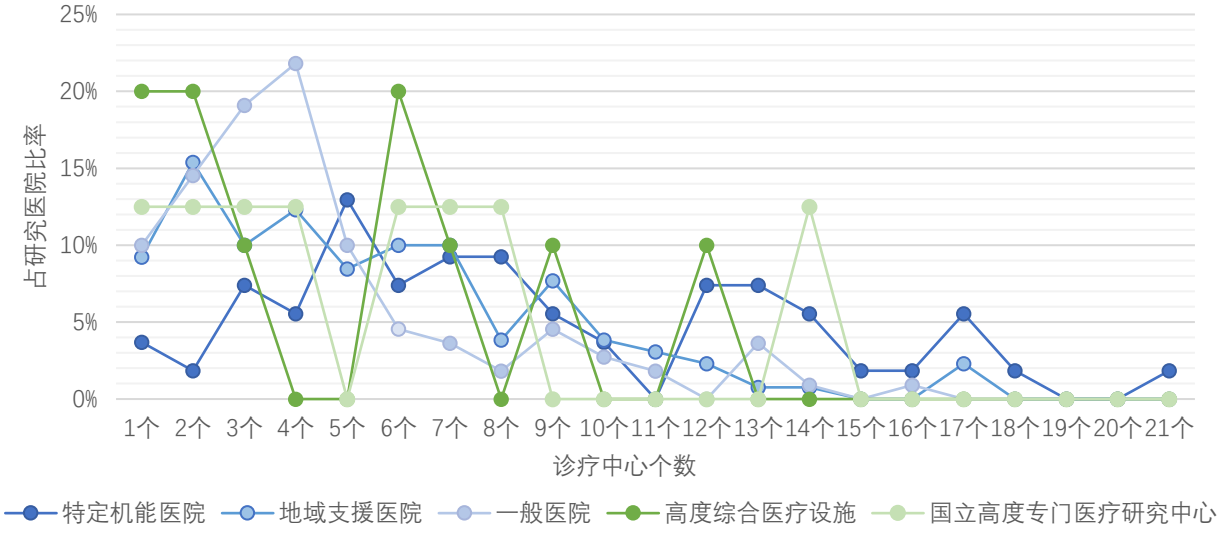


图 3-55 不同类型医院的诊疗中心配置相对数量趋势图
图片来源：作者自绘

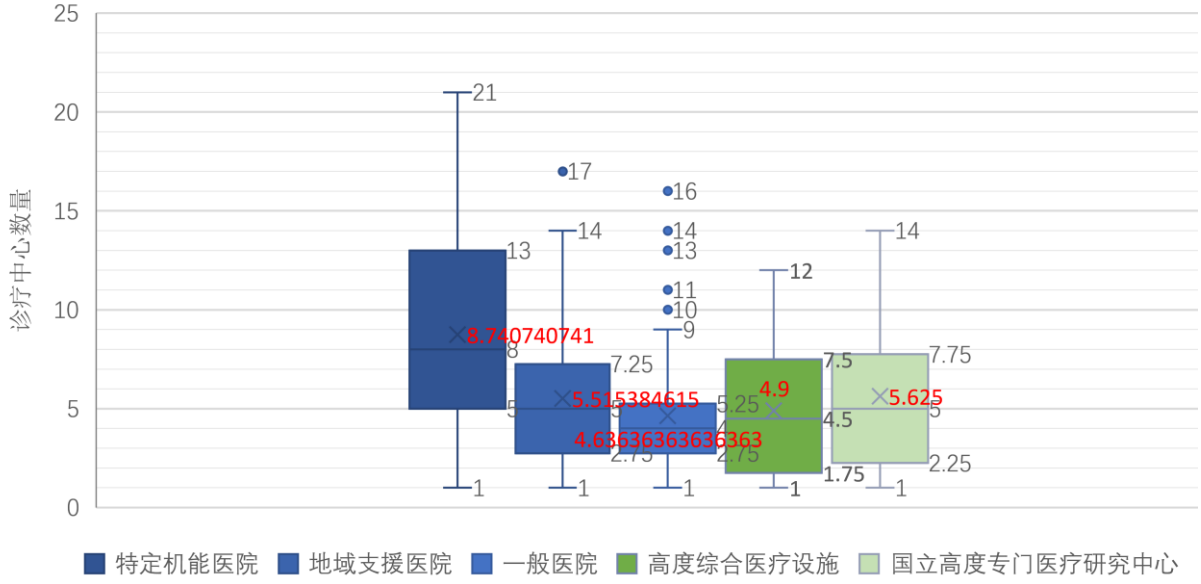


图 3-56 不同类型医院的诊疗中心配置数量分布箱型图
图片来源：作者自绘

中国知网 https://www.cnki.net

2）不同类型医院诊疗中心配置种类

通过统计各类型医院各类诊疗中心的设置数量，如图 3-57，可得到肿瘤中心设置数量最多，其次为心脏（心血管）中心、肾脏中心和消化系统中心。通过统计各类医院各类别诊疗中心的设置情况，如图 3-58，可以发现，一般医院相较其他类型医院更常设置整形中心和女性骨盆底中心；地域支援医院相较其他类型医院较常设置心脏（心血管）中心、呼吸系统中心等和心·脑血管中心；特定机能医院相较其他类型医院较常设置疾病中心，如癫痫中心，过敏中心、唇腭裂中心等；国立高度专门医疗研究中心相较其他类型医院较常设置精神卫生中心；高度综合医疗设施相较其他类型医院较常设置内分泌中心。

通过比较各类型医院各类诊疗中心设置相对数量图，如图 3-59，可以得到特定机能医院设置肿瘤中心、周产期母子中心和心脏（心血管）中心的比率高于其他类型医院；地域支援医院和一般医院诊疗中心的设置类型的相对比率较为接近；高度综合医疗设施设置周产期母子医疗中心和骨科中心的比率较其他类型医院较高；国立高度专门医疗研究中心设置肿瘤中心、精神卫生中心和认知症医疗中心的比率高于其他类型医院。总的来说，特定机能医院和国立高度专门医疗研究中心多设置疾病中心，其他类型医院脏器中心、系统中心和疾病中心设置量均衡（约各占 30%），见图 3-60。

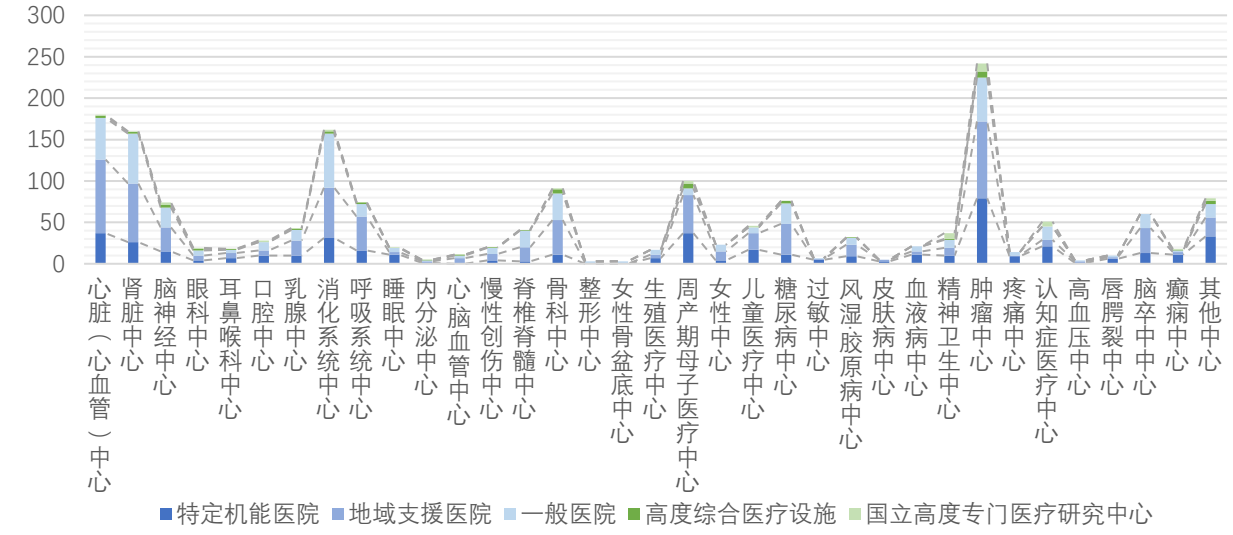


图 3-57 不同类型医院各类诊疗中心设置数量统计图

图片来源：作者自绘

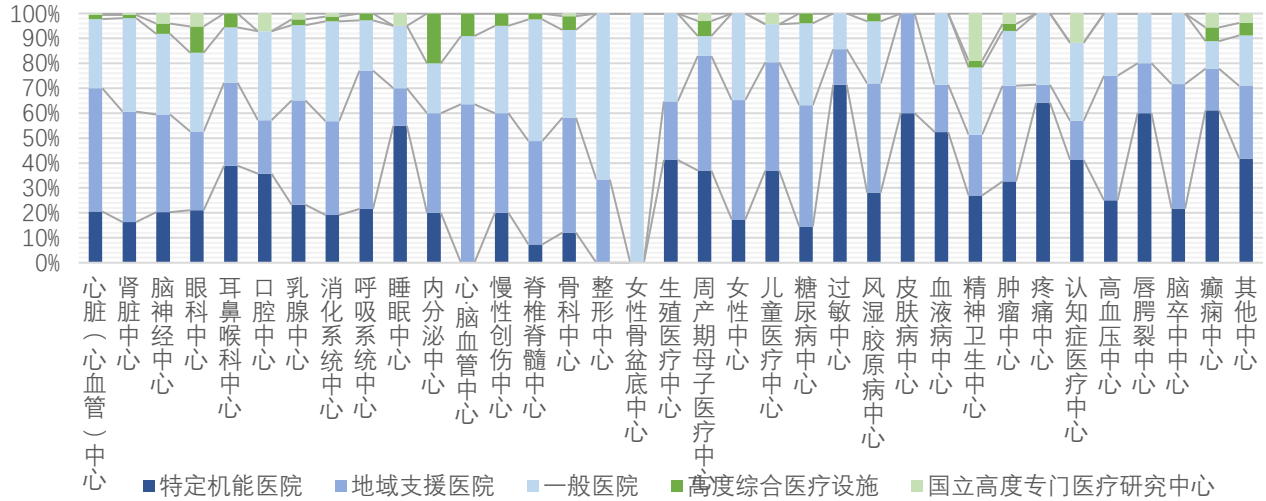


图 3-58 不同类型医院各类诊疗中心比率构成图

图片来源：作者自绘

中国知网 https://www.cnki.net

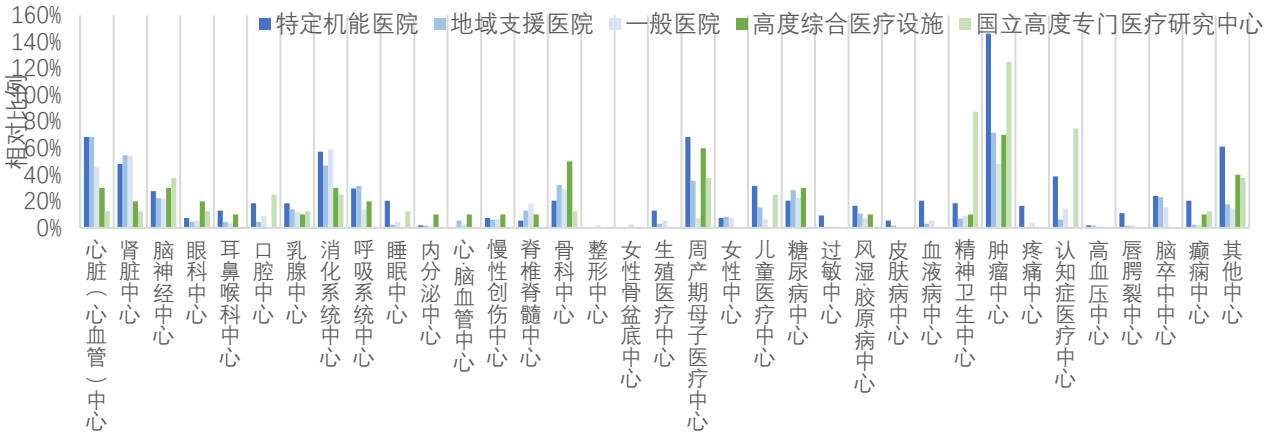


图 3-59 医院类型与诊疗中心种类相对数量关系图
图片来源：作者自绘

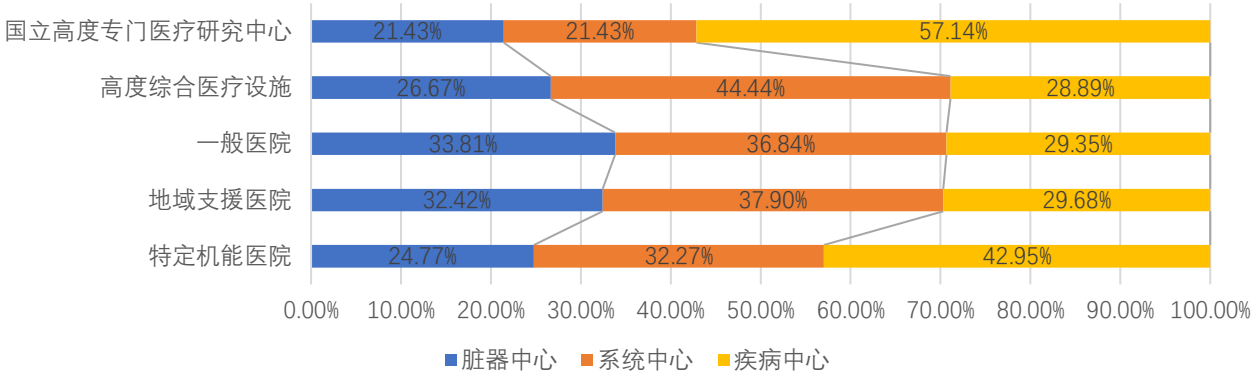


图 3-60 不同类型医院各类诊疗中心设置相对数量比率图
图片来源：作者自绘

3）不同类型医院诊疗中心平面布局特征

由于不同类型医院机能、诊疗中心设置种类和数量不同，诊疗中心布局也呈现不同的特点：

特定机能医院多以先进诊疗为主，多设置疾病中心，诊疗中心设置数量在 9 个左右，所以该类型医院诊疗中心布局呈现相关诊疗中心邻近，相关科室邻近和相关医技分散邻近的布局方式，见表 3.15。

地域支援医院作为地区医疗的核心，保证地域医疗资源的完善，诊疗中心数量多设置在 6 个左右，脏器中心、系统中心和疾病中心设置量均衡（约各占 30%）。因此，该类型医院相关诊疗中心关联邻近布局，相关科室邻近中心，相关医技呈集中邻近布置的态势，见表 3.16。

一般医院作为人们日常诊疗常去的医疗机构，诊疗中心数量一般设置在 4 个左右，脏器中心、系统中心和疾病中心设置量均衡（约各占 30%），所以诊疗中心布局也多呈中心间关联，相关医技检查邻近诊疗中心或于中心内设置的方式，见表 3.17。

高度综合医疗设施作为综合性实施政策医疗的国立医疗机构，多设置 5 个左右的诊疗中心，脏器中心、系统中心和疾病中心设置量均衡（约各占 30%），所以诊疗中心布局呈相关诊疗中心关联邻近布局，相关医技集中邻近的态势，见表 3.20。

国立高度专门医疗研究中心作为专业化研究、诊疗影响日本国民健康重大疾病的医疗机构，诊疗中心的设置则根据医疗研究中心的主要研究疾病进行相关诊疗中心的设置，多为疾病中心，诊疗中心的数量一般设置在 6 个左右，所以其相关诊疗中心关联布局，相关医技邻近布局，见表 3.22。

中国知网 https://www.cnki.net

3.4 小结

医院诊疗中心的配置数量、设置种类和平面布局，关系到一个医院根据自身条件，最优布置诊疗中心的可能，以高效服务患者。笔者通过研究不同规模和不同类型医院诊疗中心设置数量、种类和位置关系的分析，得出不同医院配置诊疗中心的一般趋势和医院层面科室与医技部门布局特征：

1.诊疗中心的设置数量与医院的规模成正相关。

2.诊疗中心的设置数量与医院的等级相关。

3.诊疗中心的设置种类与医院的规模相关。20-199 床规模医院多设置脏器中心和系统中心，且多设置消化系统中心；200-799 床规模医院脏器中心、系统中心和疾病中心设置量均衡（约各占 30%）；800 床以上规模医院多设置疾病中心。

4.诊疗中心的设置种类与医院的等级相关。特定机能医院与国立高度专门医疗研究中心多设置疾病中心；高度综合医疗设施、地域支援医院和一般医院脏器中心、系统中心和疾病中心设置量均衡（约各占 30%）。

5.诊疗中心布局往往跟各医院诊疗中心的配置数量、种类，以及医院的规模和机能有关。医院配置较少数量（3 个左右）诊疗中心，且多设置脏器中心和系统中心时，医院诊疗中心平面布局多呈诊疗中心间独立布局，相关医技检查邻近或内设的布局特征；随着医院诊疗中心设置数量的增加（5 个左右），脏器中心、系统中心和疾病中心设置量均衡（约各占 30%），医院诊疗中心平面布局多呈部分相关中心关联邻近布局，相关医技检查集中邻近诊疗中心布局的态势；医院诊疗中心数量更多（9 个左右），并多设置疾病中心时，相关诊疗中心呈关联邻近布局，诊疗中心相关医技呈分散式邻近诊疗中心布置；对等级较高的医院，如特定机能医院和国立高度专门医疗研究中心，会出现集中设置较多个疾病中心的情况，以便利用先进的医疗资源，治愈患者；对等级较高和规模较大的医院，还出现多诊疗中心合并布局的情况。

中国知网 https://www.cnki.net

第 4 章 考察

4.1 总述

在前文的研究过程中，发现日本不同医院诊疗中心设置数量和种类各有不同，如果说诊疗中心的建设在各医院势在必行的话，为什么还会有医院不设置诊疗中心？为什么有的医院诊疗中心设置的多，有的医院诊疗中心设置的少？那是什么原因导致的呢？诊疗中心设置到底有哪些优势和局限？如果除去“诊疗中心”这个名称，新建设的医院的设计方向又会是什么？针对上述问题，本章分别进行相同医院间科室构成、诊疗方式等考察，以解明医院设置不同诊疗中心的影响因素和中心化诊疗的优势和困境，并窥探新时代医院的建设方向和方法。

4.2 医院诊疗中心设置与否及配置不同比较研究

医院的规模和类型影响医院配置诊疗中心的数量和种类，但对同一规模或同一类型的医院而言，仍有诊疗中心设置数量和种类上的差异，本节着重对比相同规模、类型而诊疗中心配置不同的医院科室设置、诊疗模式等，探讨影响医院诊疗中心配置的原因。

4.2.1 同规模医院诊疗中心设置与否及配置不同比较研究

1） 20-199 床

选取同规模研究案例中诊疗中心数量设置较少和较多的两家医院，以及规模接近但没有研究的案例中近年来新建的未设置诊疗中心的医院，进行科室与诊疗中心的关系、医院诊疗模式和诊疗中心建设时间与新门诊楼建设时间关系，及其对平面布局的影响的比较研究，各医院基本情况见表 4.1。

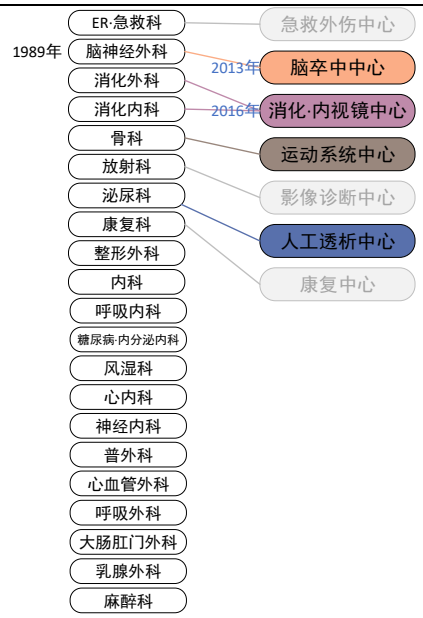
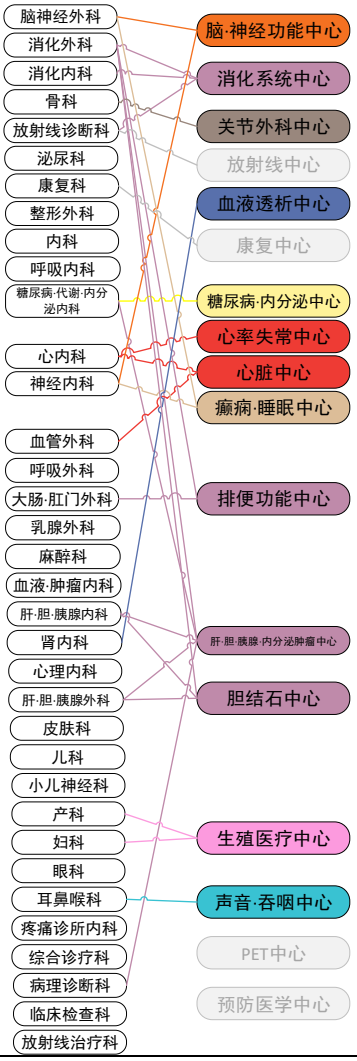
其中，通过比较同规模诊疗中心设置较少和设置较多的两家医院，发现科室设置的数量影响诊疗中心的设置数量，即未设置某些科室的医院不会形成与该科室相关的诊疗中心，如大分三爱医疗中心未设置耳鼻喉科，就不会形成相关的耳鼻喉科相关中心。但对未设置诊疗中心的医院，即使设置了相关科室，仍未形成诊疗中心的原因，则在于其与设置了诊疗中心医院的诊疗模式的不同或针对某一疾病诊疗专业度的不同，如舞鹤赤十字医院和福冈山王医院均设置了耳鼻喉科，但舞鹤赤十字医院耳鼻喉科仅诊疗一般耳鼻喉科疾病，而福冈山王医院耳鼻喉科成立的声音・吞咽中心则专门诊疗发音和吞咽障碍疾病。未设置诊疗中心的医院往往各科单独诊疗，很少涉及不同科室间合作诊疗或针对某一疾病针对性诊疗的诊疗方式，而设置诊疗中心的医院，联合成立诊疗中心的科室强调科室间合作诊疗，单科成立诊疗中心的科室往往对某类疾病有针对性的诊疗对策，而未形成诊疗中心的科室仍各科单独诊疗。

除此之外，通过对各医院科室形成时间和诊疗中心形成时间对比，发现医院科室或诊疗中心的建设往往存在一定的时间性。对于新门诊医技楼建设后成立的诊疗中心往往呈独立区域设置的态势，见图 4-1。

表 4.1 20-199 床规模医院不同数量诊疗中心配置案例基本情况

医院名称	大分三爱医疗中心	福冈山王医院	舞鹤赤十字病院
规模	179 床	199 床	198 床
中心	6 个	15 个	0 个

中国知网 https://www.cnki.net

数量			
诊疗科室与诊疗中心			
诊疗方式	联合成立诊疗中心的科室，中心化诊疗； 单科成立的诊疗中心往往对某类疾病诊疗有较强的针对性； 其他各科单独受诊	联合成立诊疗中心的科室，中心化诊疗； 单科成立的诊疗中心往往对某类疾病诊疗有较强的针对性； 其他各科单独受诊	各科单独受诊
新门诊楼运营时间	2006 年	2009 年	2014 年
诊疗中心建设与门诊楼建设关系	诊疗中心在新门诊医技楼建设后开设		
布局特征	诊疗中心布局相对独立 （详见图 4-1）	诊疗中心相关科室邻近 （详见图 4-2）	（详见图 4-3）

注：图表自制

中国知网 https://www.cnki.net

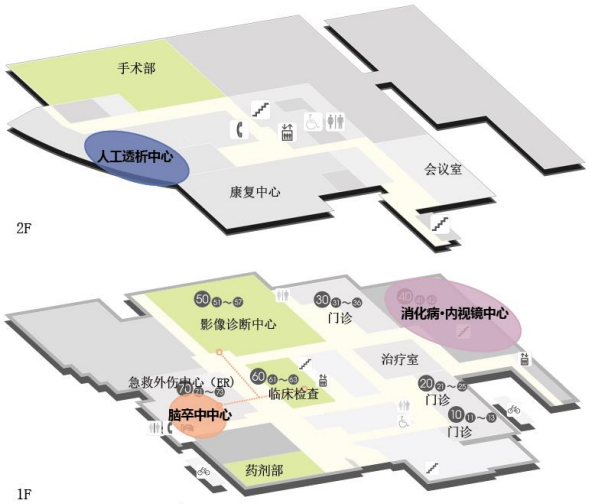


图 4-1 大分三爱医疗中心
图片来源：作者自绘

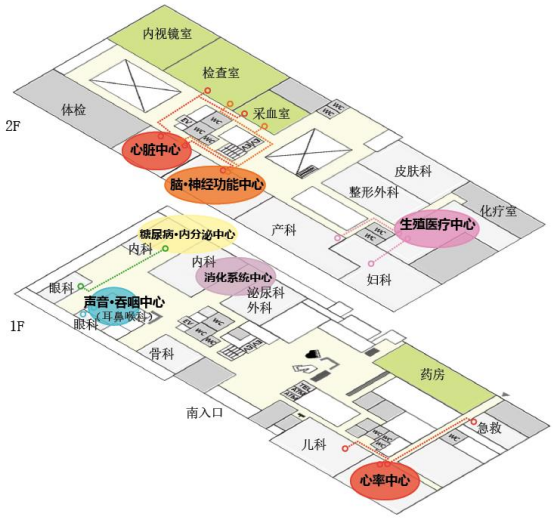


图 4-2 福冈山王医院
图片来源：作者自绘

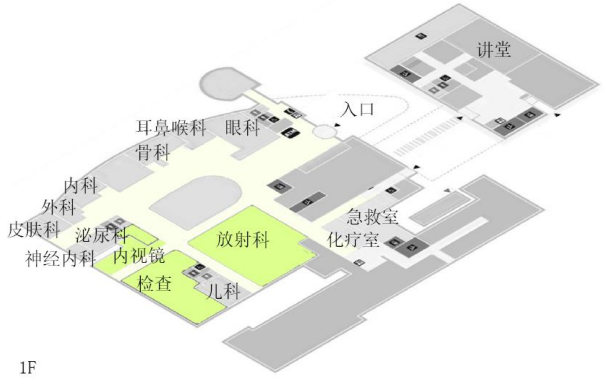


图 4-3 舞鹤赤十字病院
图片来源：作者自绘

2） 200-399 床

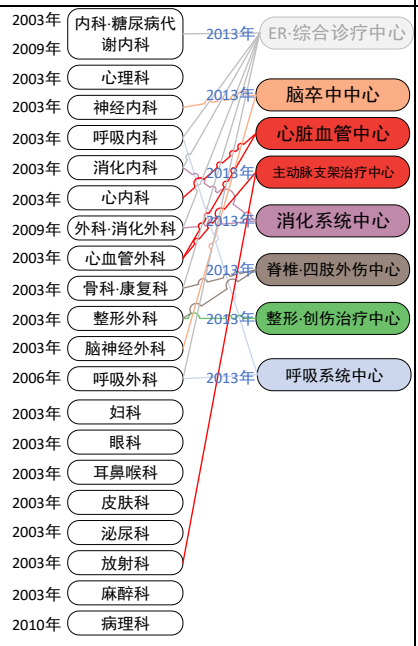
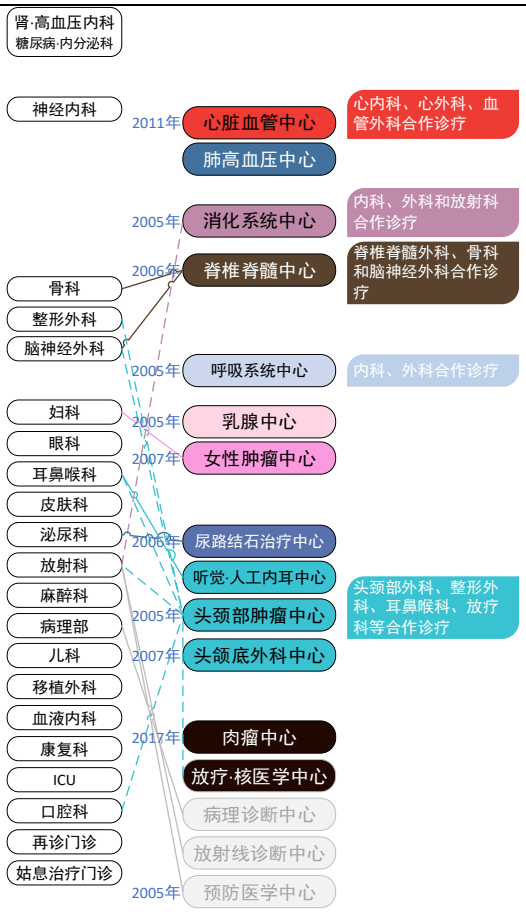
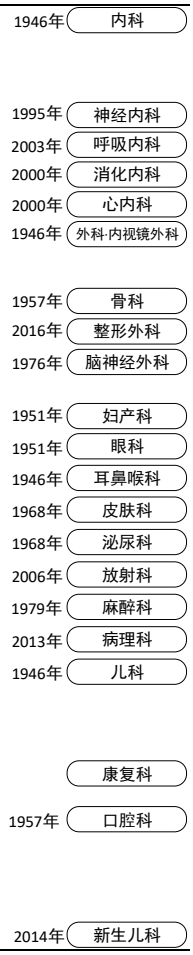
选取研究案例 200-399 床规模医院中诊疗中心设置数量较少和较多的两家医院，以及未研究案例中未设置诊疗中心的一家医院，进行科室与诊疗中心的关系、医院诊疗模式和诊疗中心建设时间与新门诊楼建设时间关系，及其对平面布局的影响的比较研究，各医院基本情况见表 4.2。

通过对比设置有不同数量诊疗中心的医院，发现诊疗方式是影响诊疗中心的形成的重要原因，对于形成诊疗中心的科室往往科室间合作诊疗，而其他科室则相对独立诊疗，并出现设置诊疗中心的医院，取消单科诊疗的情况，如国际医疗福祉大学三田医院，其设置心脏血管中心强调心内科、心外科和血管外科合作诊疗，不再单开设心内科、心外科和血管外科诊疗。

通过比较各医院科室、诊疗中心设置时间和新门诊楼建设时间，发现对在门诊医技楼建设之后一次性出现的多量诊疗中心的医院（此类中心多为脏器类诊疗中心），如果之前医院仍按照传统的内外科分开建设的模式而言，诊疗中心建设仅为诊疗方式的建设，与医院平面间产生分隔，见图 4-4；对在新门诊楼建设之前就设置诊疗中心的医院，在新医院建设时，会按照诊疗中心方式进行医院布局，诊疗中心涉及科室和相关医技呈分散式邻近诊疗中心，有一定的针对性，见图 4-5；但未设置诊疗中心的医院仍出现了部分关联科室邻近布局的倾向，如苫小牧市立医院消化内科与普外科邻近布局，见图 4-6。

中国知网 https://www.cnki.net

表 4.2 200-399 床规模医院不同数量诊疗中心配置案例基本情况

医院名称	神户赤十字医院	国际医疗福祉大学三田医院	苫小牧市立医院
规模	310 床	291 床	382 床
中心数量	8 个	14 个	0 个
诊疗科室与诊疗中心			
诊疗方式	联合成立诊疗中心的科室，中心化诊疗； 其他各科单独受诊	已形成中心化诊疗的科室，不再细分科室； 其他各科单独受诊	各科单独受诊
新门诊楼运营时间	2003 年	2012 年	2006 年
诊疗中心建设与门诊楼建设关系	诊疗中心在新门诊医技楼运营后成立	最早诊疗中心成立在新门诊医技楼运营前，新门诊医技楼运营后继续增加诊疗中心	
布局特征	诊疗中心与门诊楼平面无对应关系（见图 4-4）	新门诊楼以诊疗中心方式布局，相关科室和医技分散邻近诊疗中心设置，诊疗中心布局更有针对性。 （见图 4-5）	出现部分关联科室邻近布局情况（见图 4-6）

注：图表自制

中国知网 https://www.cnki.net

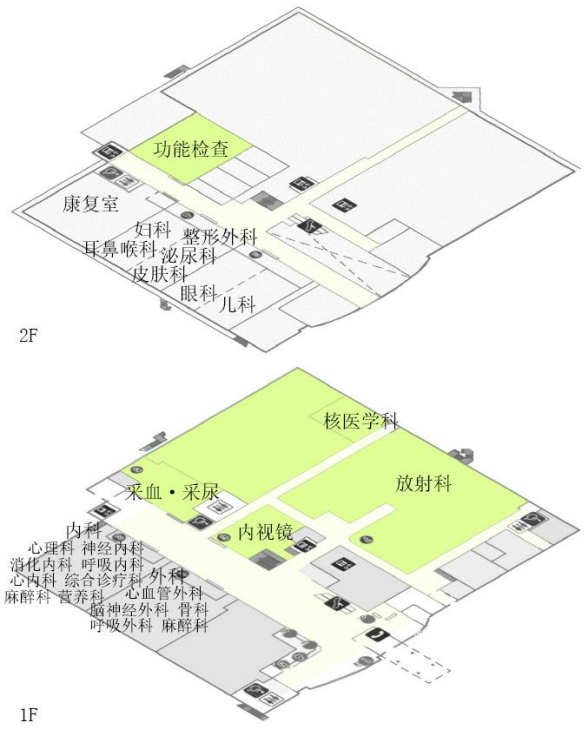


图 4-4 神户赤十字医院
图片来源：作者自绘

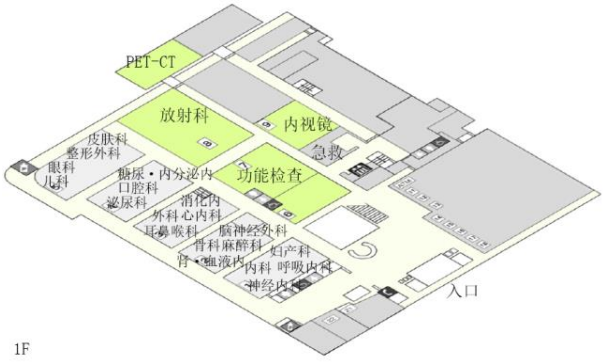


图 4-6 苫小牧市立病院
图片来源：作者自绘

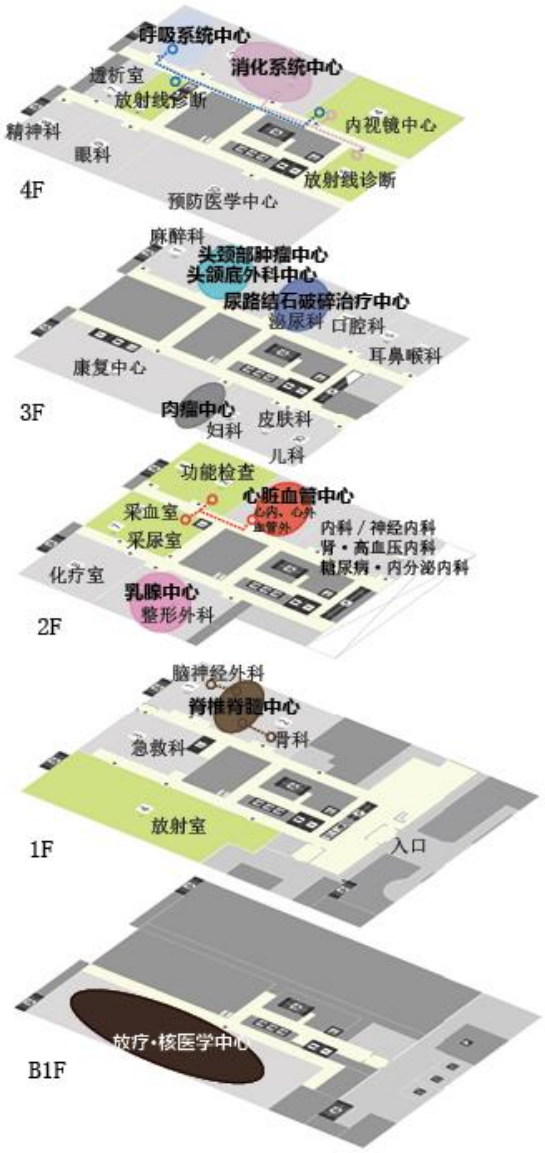


图 4-5 国际医疗福祉大学三田医院
图片来源：作者自绘

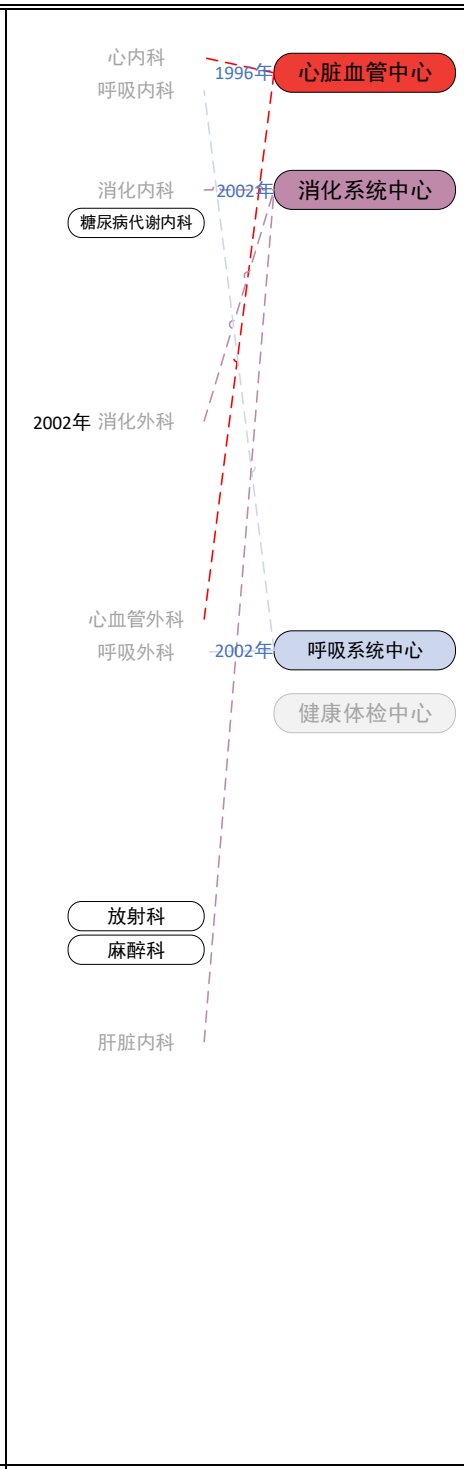
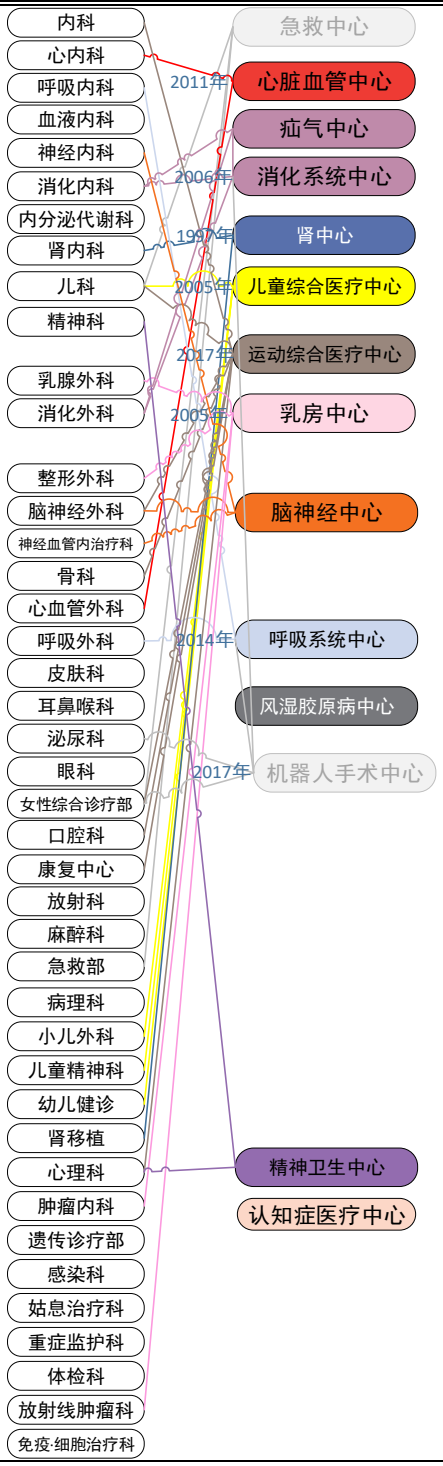
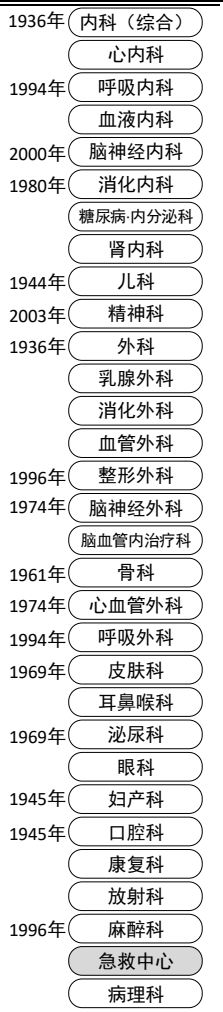
3） 400-599 床

选取研究案例 400-599 床规模医院中诊疗中心设置数量较少和较多的两家医院，以及未研究案例中未设置诊疗中心的一家医院，进行科室与诊疗中心的关系、医院诊疗模式和诊疗中心建设时间与新门诊楼建设时间关系，及其对平面布局的影响的比较研究，各医院基本情况见表 4.3。

表 4.3 400-599 床规模医院不同数量诊疗中心配置案例基本情况

医院名称	仙台厚生医院	圣路加国际医院	市立四日市病院
规模	409 床	520 床	568 床
中心数量	3 个	12 个	（0）

中国知网 https://www.cnki.net

诊疗科室与诊疗中心			
诊疗方式	中心化诊疗； 其他各科单独受诊	联合成立诊疗中心的科室，中心化诊疗； 其他各科单独受诊	各科单独受诊
新门诊楼运营时间	1996 年	1992 年	2005 年
诊疗中心建设与门诊楼建设关系	诊疗中心建设与新门诊医技楼运营时间相同，后建设的科室以诊疗中心形式开设。	诊疗中心在新门诊医技楼建设之后	
布局特征	门诊楼形成诊疗中心布局方式，相关医技与诊疗中心邻近布局	建设时，考虑到相关科室及医技邻近布局，更有利于成立相关诊疗中心	相关科室出现邻近现象，如泌尿科和

中国知网 https://www.cnki.net

	（见图 4-7）	（见图 4-8）	肾内科邻近布局（见图 4-9）

注：图表自制

通过对比诊疗中心设置数量不同的两家医院的科室构成，发现科室数量种类影响诊疗中心的设立，对于较专科的医院，诊疗中心的设置数量自然比其他医院要少；而对于科室构成类似，设置与未设置诊疗中心的医院对比，发现科室诊疗模式是诊疗中心是否形成的关键，对于联合成立诊疗中心的科室，往往中心化诊疗，未形成诊疗中心的科室仍各科独自诊疗。而对于形成诊疗中心的科室，也会出现不再单独设置相关科的情况，而以诊疗中心的模式接诊，如仙台厚生医院设置心脏血管中心诊疗患者。

通过各医院科室形成时间和诊疗中心形成时间比较，发现科室的形成和诊疗中心的形成往往具有一定的时间性，且科室的形成时间会影响诊疗中心的形成，如仙台厚生医院消化内科于 2002 年开始，相应的消化系统中心也于 2002 年开设。

通过对比各医院诊疗中心的形成时间和新门诊楼建设时间，可以发现若医院一开始就建设诊疗中心，医院后续科室成立将以诊疗中心的方式进行，并采用相关中心与相关医技邻近布局的情况，见图 4-7；对于在医院建设后才开展诊疗中心建设的医院，若之前医院的建设采用相关科室邻近，相关医技邻近相关科室布局的模式，将有助于诊疗中心的开展及落实，但其诊疗中心设置会多以脏器中心为主，也会出现考虑不周的情况，如心脏中心与心脏相关检查室相隔设置，见图 4-8；而对于未设置诊疗中心的医院，根据各医院诊疗特色，仍会出现将相关科室邻近的情况，如市立四日市医院肾内科与泌尿科独立区域邻近布局，见图 4-9。

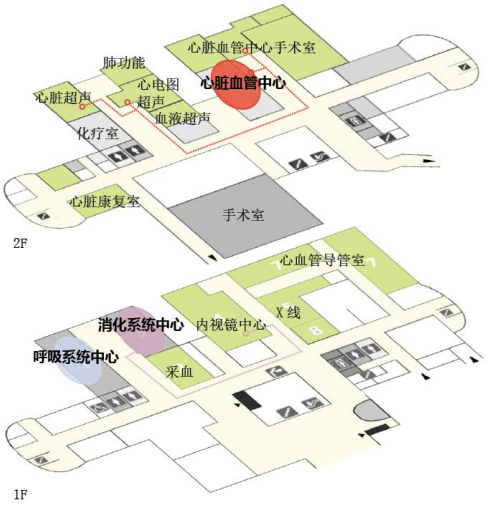


图 4-7 仙台厚生医院
图片来源：作者自绘

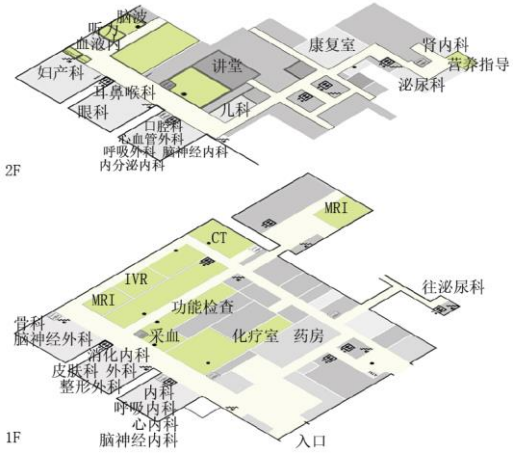


图 4-9 市立四日市病院
图片来源：作者自绘

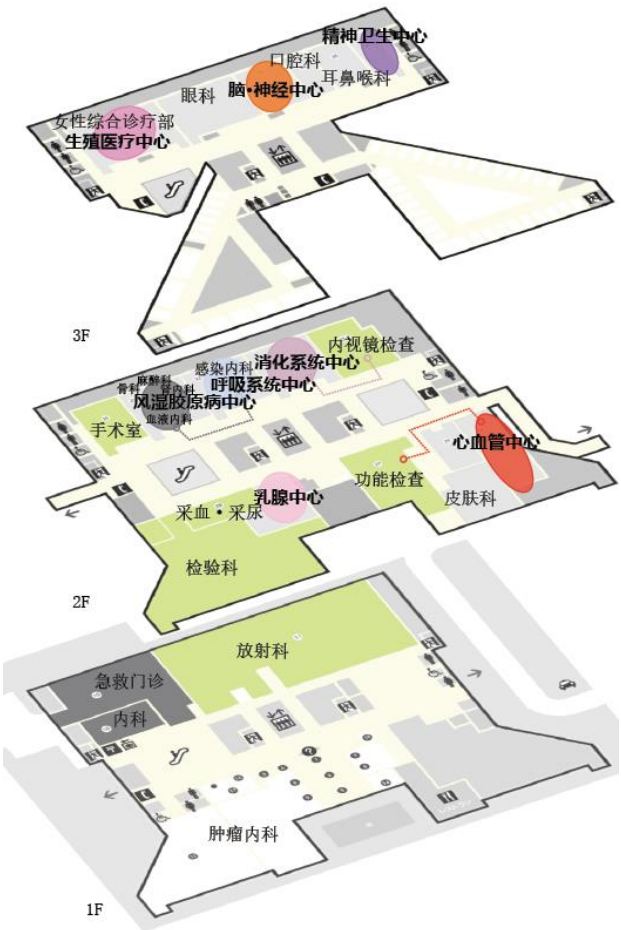


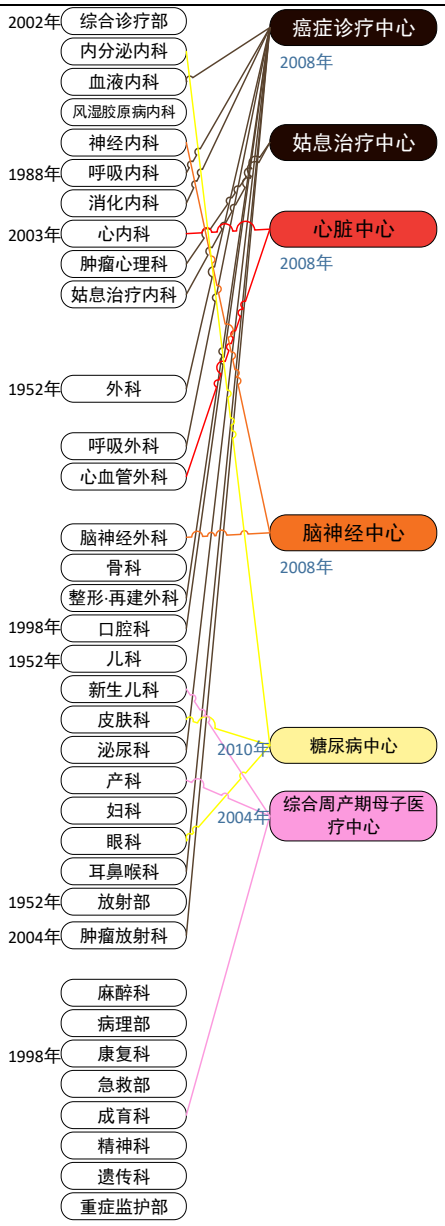
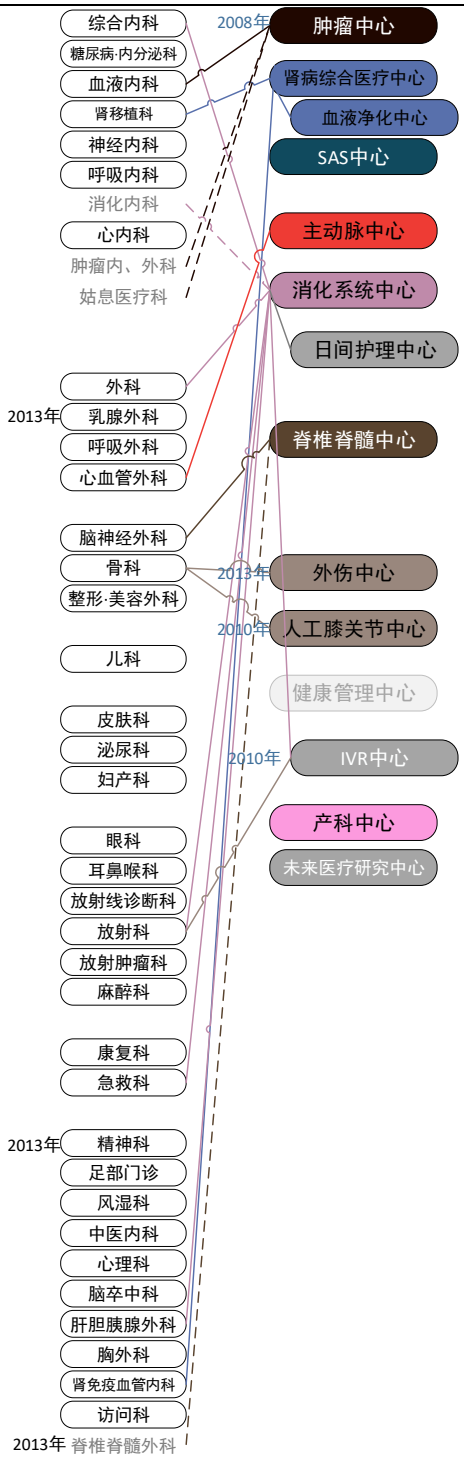
图 4-8 圣路加国际医院
图片来源：作者自绘

中国知网 https://www.cnki.net

4） 600-799 床

选取研究案例 400-599 床规模医院中诊疗中心设置数量较少和较多的两家医院，以及未研究案例中的一家医院，进行科室与诊疗中心的关系、医院诊疗模式和诊疗中心建设时间与新门诊楼建设时间关系，及其对平面布局的影响的比较研究，各医院基本情况见表 4.4。

表 4.4 600-799 床规模医院不同数量诊疗中心配置案例基本情况

医院名称	青森县立中央医院	湘南镰仓综合医院	石川县立中央病院
规模	684 床	648 床	630 床
中心数量	6 个	13 个	
诊疗科室与诊疗中心			
诊疗	联合成立诊疗中心的科室，中心化诊疗；	联合成立诊疗中心的科室，中心化诊疗；	各科单独受诊

中国知网 https://www.cnki.net

方式	其他各科单独受诊	单科成立的诊疗中心往往对某类疾病诊疗有较强的针对性； 其他各科单独受诊	
新门诊楼运营时间	（1981 年）	2006 年	2017 年
诊疗中心建设与门诊楼建设关系	诊疗中心在新门诊医技楼建设之后	诊疗中心在新门诊医技楼建设之后	
布局特征	建设时，考虑到相关科室及医技邻近布局，更有利于成立相关诊疗中心 （见图 4-10）	建设时，考虑到相关科室及医技邻近布局，更有利于成立相关诊疗中心 （见图 4-11）	虽未设置诊疗中心，但相关科室及医技邻近布局 （见图 4-12）

注：图表自制

通过比较诊疗中心设置数量不同的两家医院，可以发现由各科室针对性诊疗疾病形成的诊疗中心会影响诊疗中心的数量，如湘南镰仓综合医院骨科同时设立外伤中心和人工关节中心；对于科室构成类似却未成立诊疗中心的医院和设置诊疗中心未设置其他诊疗中心的医院，诊疗方式是影响诊疗中心构成的主要原因，成立诊疗中心的科室往往以中心的形式合作诊疗，或不单独设立其构成科室以中心的形式诊疗，而未成立诊疗中心的科室仍单独诊疗。

通过比较各医院科室形成时间和诊疗中心形成时间，发现医院科室形成和诊疗中心的形成均有一定的时间性，各医院根据自身特色逐步建设诊疗中心。

通过对比各医院诊疗中心的形成时间和医院建设时间，发现预先将相关科室及医技邻近布局的方式，更利于医院诊疗中心的开展，见图 4-10，图 4-11；但在医院建设后成立的一些诊疗中心，由于之前考虑不足，也会产生一些相关科室邻近较远的缺陷，如湘南镰仓综合医院新门诊楼于 2006 年建设，脊椎脊髓科于 2013 年建设，虽成立了脊椎脊髓中心，但由于脊椎脊髓中心需要脊椎脊髓科与脑神经外科合作诊疗，而脊椎脊髓中心位于门诊楼的 3 楼、脑神经外科位于门诊楼的 4 楼，虽说医院可以安排脑神经外科医生在脊椎脊髓中心坐诊，但在一定程度上会影响该医生看其专业所属病的效率，见图 4-11。对于由于诊疗方式等原因未设置诊疗中心的医院，仍出现了相关科室及医技邻近布局的情况，这为多科就诊患者提供了便利，也为医院后续相关诊疗中心的开展创造有利条件，见图 4-12。

中国知网 https://www.cnki.net

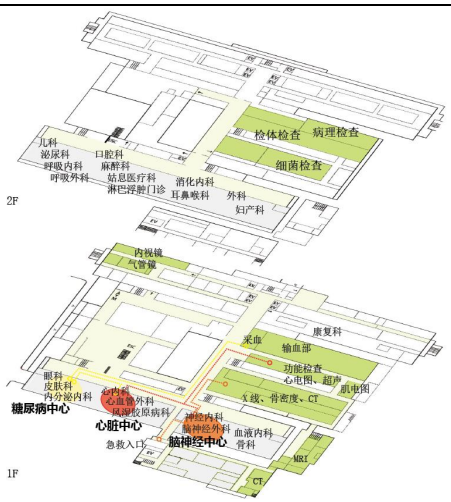


图 4-10 青森县立中央医院
图片来源：作者自绘

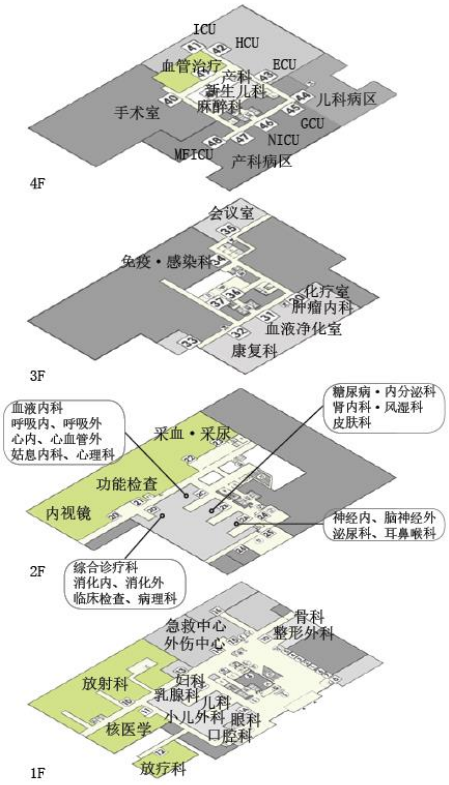


图 4-12 石川县立中央病院
图片来源：作者自绘

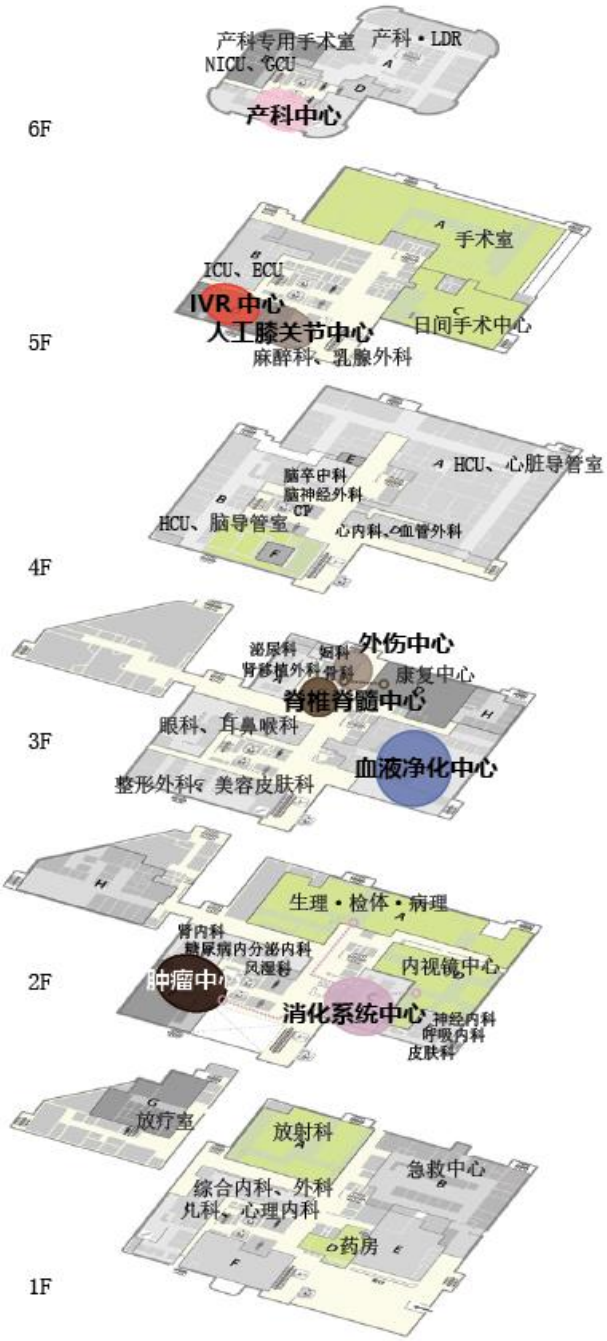


图 4-11 湘南镰仓综合医院
图片来源：作者自绘

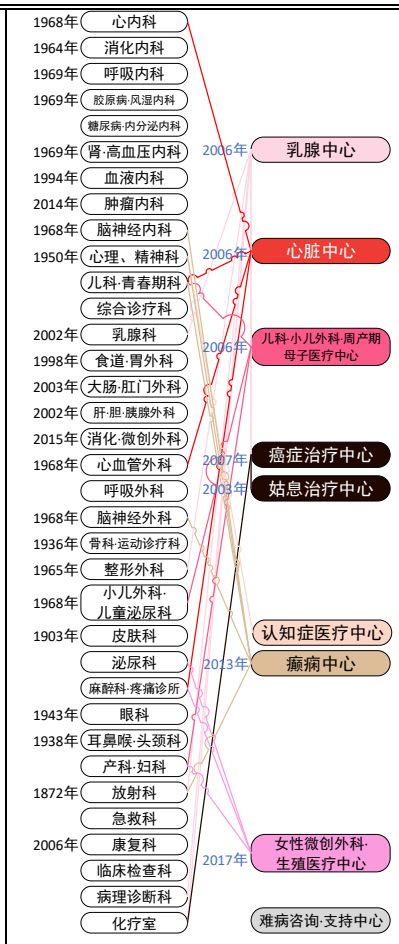
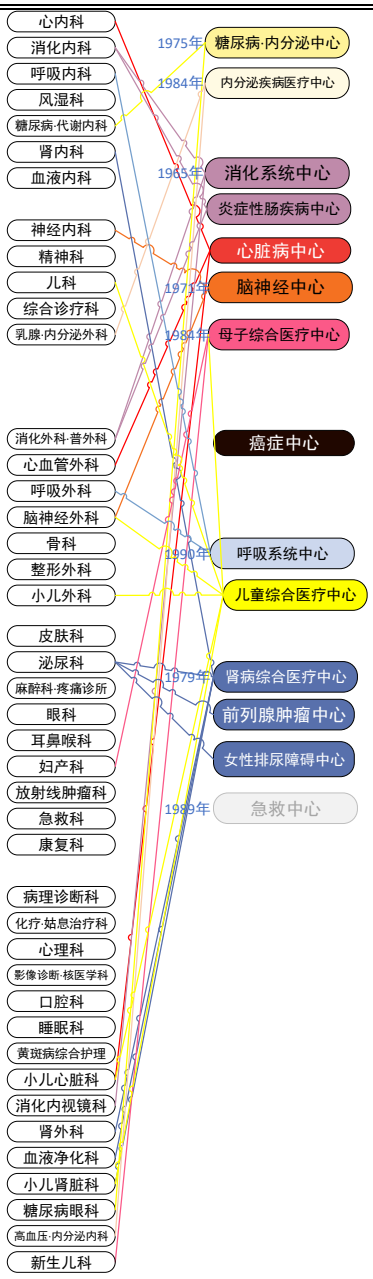
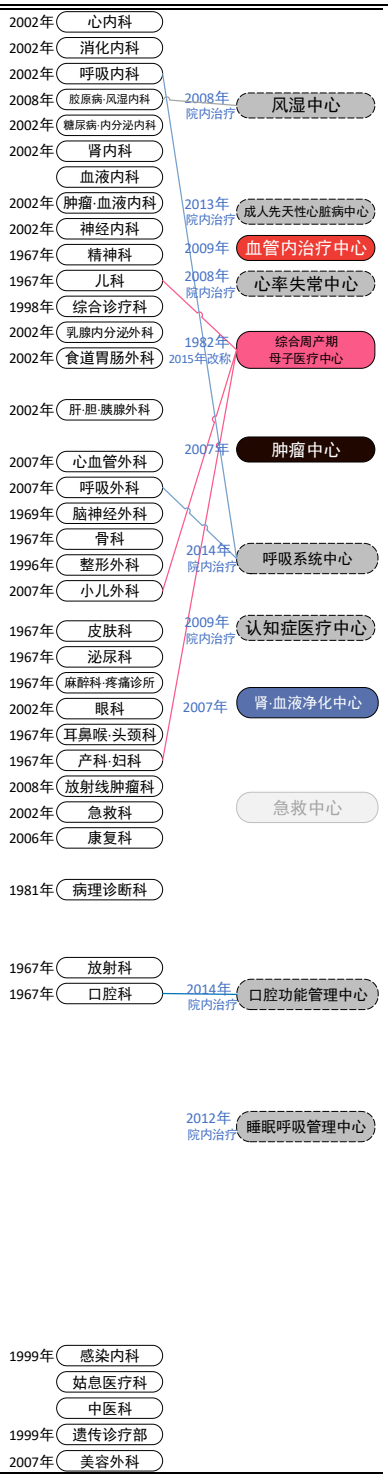
5） 800 床以上

选取同规模研究案例中诊疗中心设置较少和较多的两所医院，及未研究案例中相同规模医院进行科室与诊疗中心的关系、医院诊疗模式和诊疗中心建设时间与新门诊楼建设时间关系，及其对平面布局的影响的比较研究，各医院基本情况见表 4.5。

表 4.5 800 床以上规模医院不同数量诊疗中心配置案例基本情况

医院名称	顺天堂医院	东京女子医科大学附属医院	神戸大学医学部附属病院
规模	1026 床	1379 床	934 床
中心数量	8 个	13 个	（3）[1)]

中国知网 https://www.cnki.net

诊疗科室与诊疗中心			
诊疗方式	联合成立诊疗中心的科室，中心化诊疗； 其他各科单独受诊	联合成立诊疗中心的科室，中心化诊疗； 单科成立的诊疗中心往往对某类疾病诊疗有较强的针对性； 其他各科单独受诊	大部分诊疗中心为住院治疗施行； 其他刻个单独受诊
新门诊楼建设时间	（1993 年）	2003 年	1983 年中央诊疗栋建设 1986 年门诊楼建立 2014 年中央诊疗栋增设
诊疗中心建设与门诊楼	诊疗中心在新门诊医技楼建设之后	诊疗中心成立在新门诊医技楼建设之前	交叉进行

中国知网 https://www.cnki.net

建设关系			
布局特征	建设时，考虑到相关科室及医技邻近布局，更有利于成立相关诊疗中心 （见图 4-13）	新门诊医技楼以诊疗中心方式布局，相关科室和医技分散邻近诊疗中心设置，诊疗中心的布局更有针对性。 （见图 4-14）	诊疗中心关联相关科室医技，独立区域设置在新修改建门诊医技楼内 （见图 4-15）

注：1）该医院形成的部分诊疗中心为住院治疗的措施，门诊未实行，不计入门诊诊疗中心的范畴。
图表自制

通过比较研究三家医院科室和诊疗中心的构成，发现科室数量会影响诊疗中心的数量，划分更细的科室更易与其他科室合作成立诊疗中心，如东京女子医科大学附属医院设置糖尿病眼科与糖尿病・代谢内科合作成立糖尿病中心；同样，科室对某些疾病的专业化诊疗形成的诊疗中心，也会影响医院整体诊疗中心的数量，如东京女子医科大学附属医院泌尿科根据专科特色与其他科室合作分别开始了肾病综合医疗中心、前列腺中心和女性排尿障碍中心。对于有相同科室而未形成相关诊疗中心的原因，则在于医院诊疗体制的不同，成立诊疗中心的相关科室合作诊疗，未形成诊疗中心的科室各科单独诊疗。

由于各医院科室建设和诊疗中心建设往往有一定的时间历程，所以医院平面布局也会受到影响。对于后建设诊疗中心的医院而言，如果在建设医院之初就考虑到相关科室及医技邻近的情况，则有利于后续诊疗中心的建设，见图 4-13；对于之前就以诊疗中心模式运营的医院，在新建门诊医技楼时，会考虑诊疗中心关联科室特征和相关医技进行邻近布局，诊疗中心的建设也更有针对性，见图 4-14；对于原有医院新开设诊疗中心而进行医院修改建时，会将诊疗中心关联科室、医技等考虑在内，在新修、改建建筑中单独区域设置，见图 4-15。

中国知网 https://www.cnki.net

图 4-13 顺天堂医院
图片来源：作者自绘

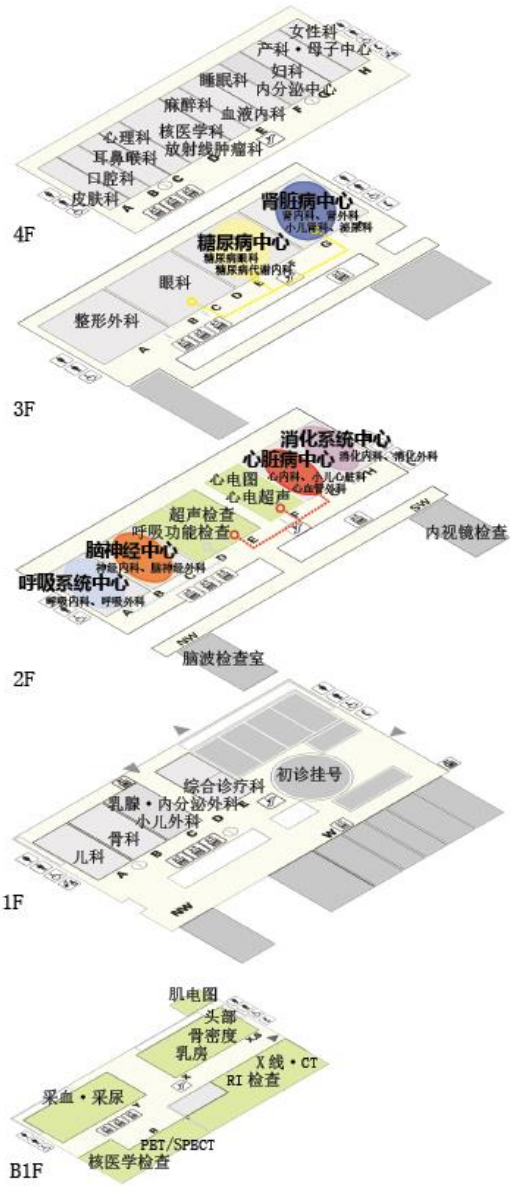


图 4-14 东京女子医科大学
图片来源：作者自绘

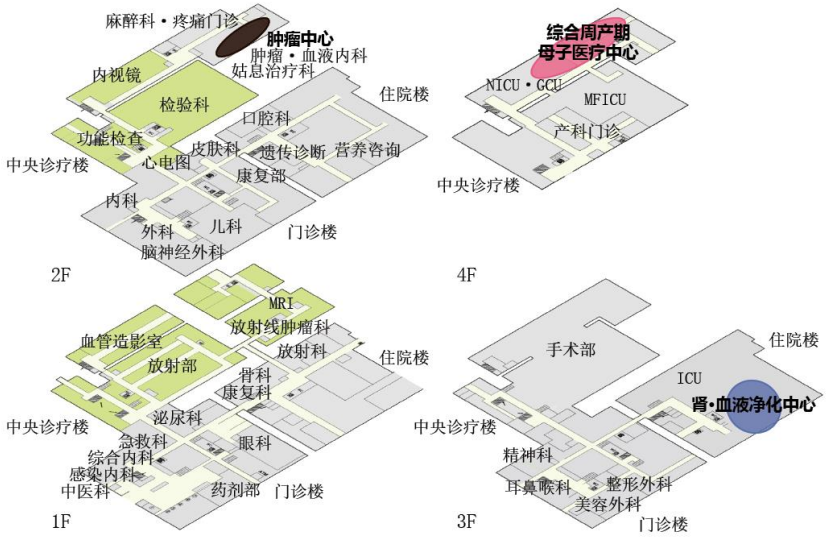


图 4-15 神戸大学医学部附属病院
图片来源：作者自绘

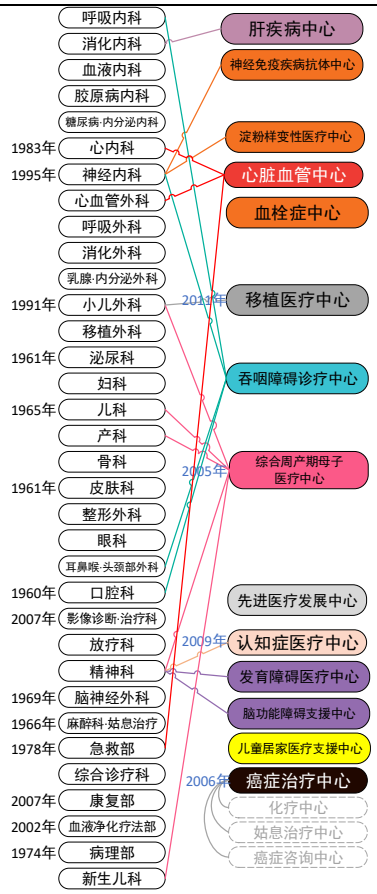
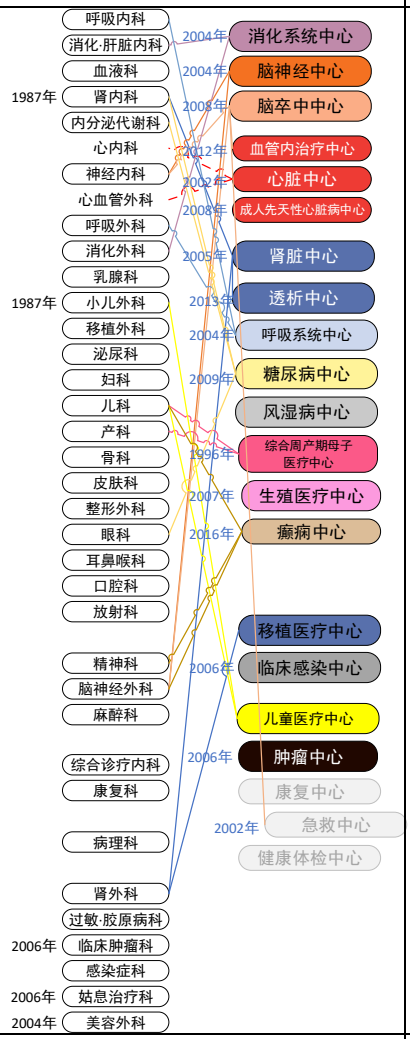
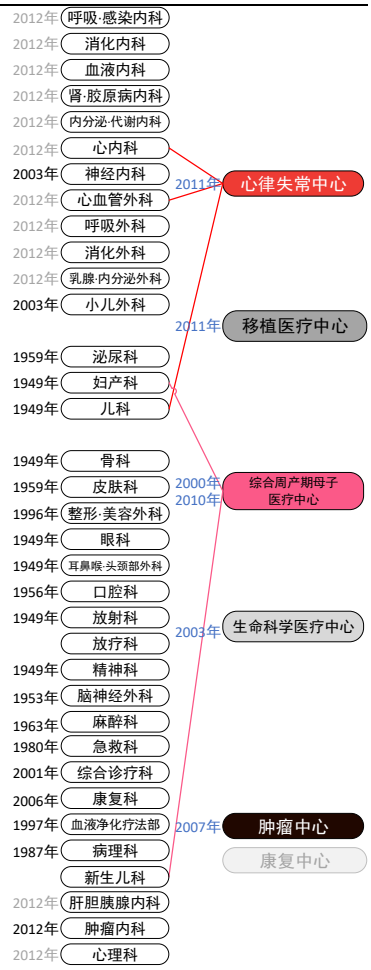
中国知网 https://www.cnki.net

4.2.2 同类型医院诊疗中心设置与否及配置不同比较研究

1） 特定机能医院

选取研究案例中特定机能医院诊疗中心设置较少和较多的两家医院，及未研究医院中一家特定机能医院，进行科室与诊疗中心的关系、医院诊疗模式和诊疗中心建设时间与新门诊楼建设时间关系，及其对平面布局的影响的比较研究，各医院基本情况见表 4.6。

表 4.6 特定机能医院不同数量诊疗中心配置案例基本情况

医院名称	熊本大学医学部附属病院	自治医科大学附属病院	新潟大学医歯学総合病院
规模	848 床	1132 床	827 床
中心数量	14 个	17 个	5 个
诊疗科室与诊疗中心			
诊疗方式	联合成立诊疗中心的科室，中心化诊疗； 单科成立的诊疗中心往往对某类疾病诊疗有较强的针对性； 其他各科单独受诊	联合成立诊疗中心的科室，中心化诊疗； 单科成立的诊疗中心往往对某类疾病诊疗有较强的针对性； 其他各科单独受诊	联合成立诊疗中心的科室，中心化诊疗； 其他各科单独受诊
新门诊楼建设时间	2006 年	2004 年	2012 年
诊疗中心建设	部分诊疗中心成立于新门诊医技楼同时建设之前，后不断成立诊疗中心。	部分诊疗中心成立于新门诊楼建设之前，后不断成立诊疗中心。	诊疗中心建设于新门诊医技楼之前

中国知网 https://www.cnki.net

与门诊楼建设关系			
布局特征	后于门诊医技楼建设的诊疗中心往往集中独立区域布置；未形成诊疗中心的相关科室邻近布局。（见图 4-16）	新门诊医技楼以诊疗中心方式布局，相关科室或医技集中邻近诊疗中心设置，诊疗中心布局更有针对性。（见图 4-17）	虽诊疗中心建设于新门诊医技楼之前，但由于科室分化较晚，新门诊医技楼仍按照同年代内外科分开设置的情况布局。（见图 4-18）

注：1）注新潟大学医歯学総合病院 2012 年原第一内科分为心内科、内分泌・代谢内科和血液内科；第二内科分为肾・胶原病内科、呼吸・感染内科和心理内科；第三内科分为消化内科和肝胆胰腺内科；第一外科分为消化外科和乳腺・内分泌外科；第二外科分为心血管外科和呼吸外科等。
表格自制

通过比较所选特定机能医院科室和诊疗中心构成，发现科室对某些疾病的专业化诊疗形成的诊疗中心，往往影响特定机能医院整体诊疗中心的数量，这也跟特定机能医院以诊疗一般医院难以解决的疾病的定位有一定的关系，如熊本大学医学部附属医院精神科组建认知症医疗中心、发育障碍医疗中心和脑功能障碍支援中心，而自治医科大学附属医院精神科则与其他科联合形成癫痫中心。当然，科室间的合作诊疗是形成诊疗中心的基础，直接影响诊疗中心的构成。形成诊疗中心的科室往往中心化诊疗，未形成诊疗中心科室仍单独诊疗。

与科室成立具有一定的时间性一样，特定机能医院诊疗中心的成立也有一定的时间性，并会影响新门诊医技楼的设计布局。在医院新门诊医技楼设计之前和之时就成立诊疗中心的医院，在新门诊医技楼建设时会将其考虑在内，对后续成立的诊疗中心，可根据诊疗中心的性质，于科室内设置或集中独立布局，而对该医院未成立诊疗中心的科室，同样出现了相关科室邻近布局的倾向，见图 4-16；对于之前有诊疗中心建设经验，以及一次建立多个诊疗中心的新建医院门诊医技楼而言，会充分考虑诊疗中心涉及科室和医技，进行邻近布局，也更有针对性和专业性，见图 4-17；而科室分科时间，也会影响新门诊医技楼的科室和医技布局，即使诊疗中心先于医院建设布局，如果之前医院科室未分开，医院建设仍会按照传统的内外科分开布局方式排布，诊疗中心的建设也仅为诊疗流程的建设，如新潟大学医齿学综合病院心率失常中心虽早于 2012 年新医院建设和 2012 年内外科的细分之前开设，但新医院门诊医技楼的科室布局仍按照内外科方式分开布局，诊疗中心涉及的心内科和心血管外科分开设置，对患者就近合作化诊疗带来了一定的不便，见图 4-18。

中国知网 https://www.cnki.net

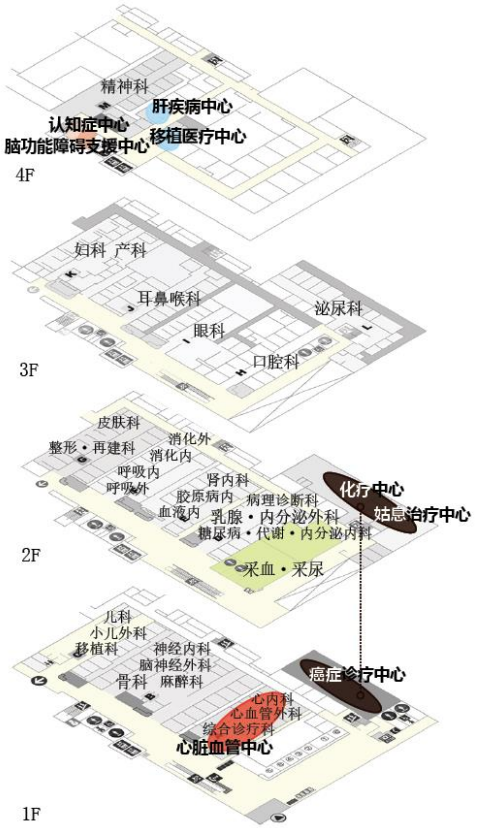


图 4-16 熊本大学医学部附属病院
图片来源：作者自绘

图 4-17 自治医科大学附属病院
图片来源：作者自绘

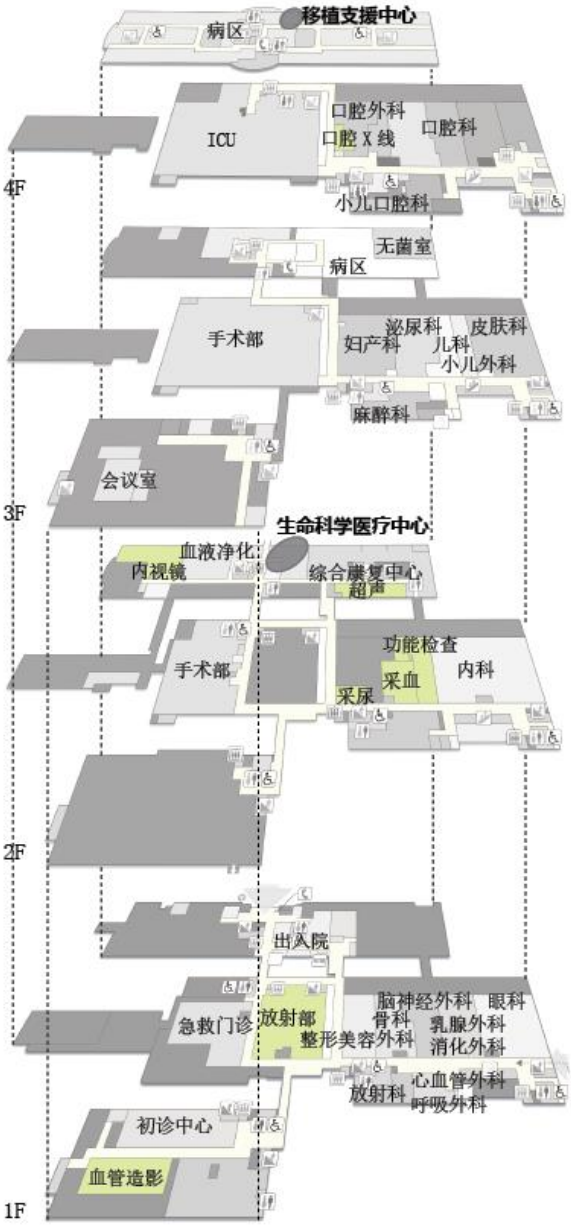


图 4-18 新潟大学医歯学総合病院
图片来源：作者自绘

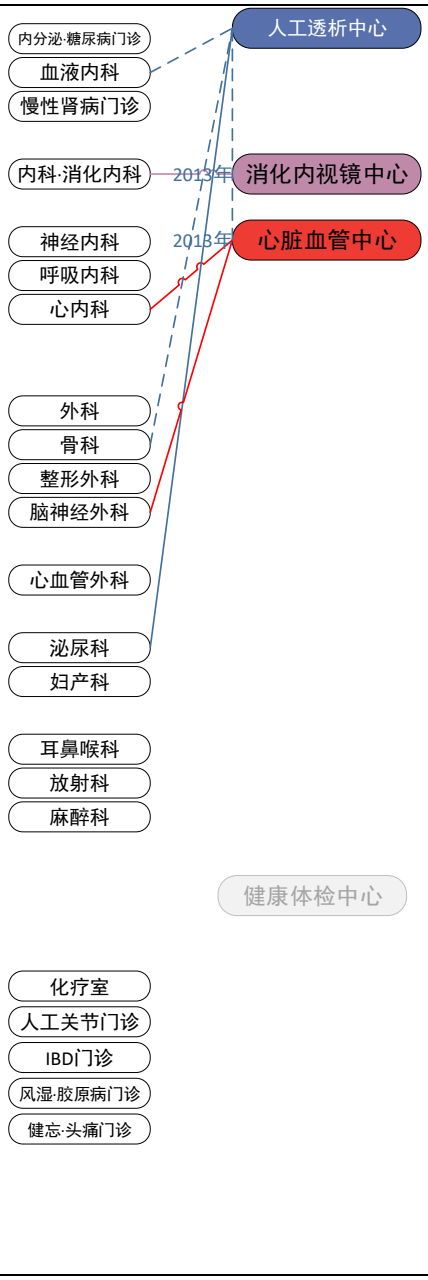
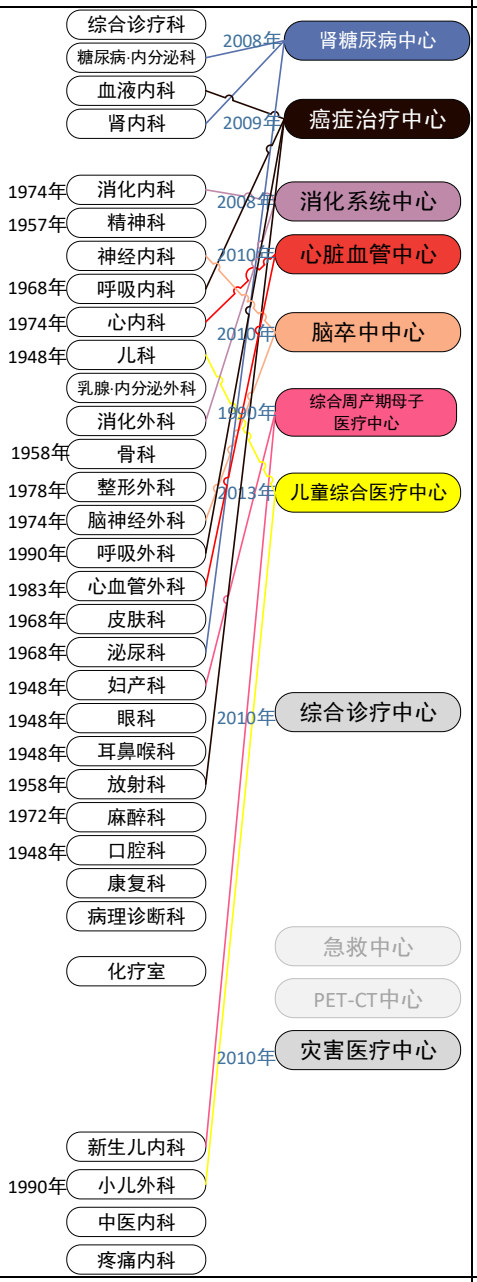
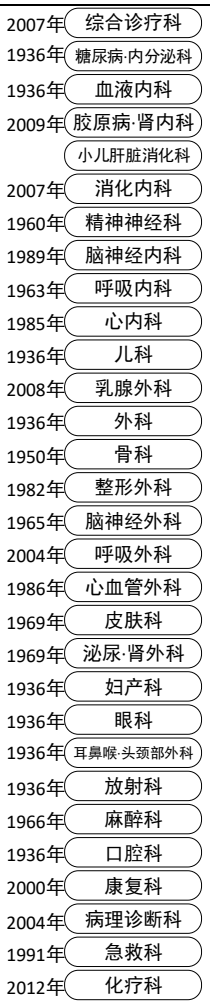
2） 地域支援医院

选取研究案例中地域支援医院诊疗中心设置较少和较多的两家医院，及未研究医院中一家地域支援医院，进行科室与诊疗中心的关系、医院诊疗模式和诊疗中心建设时间与新门诊楼建设时间关系，及其对平面布局的影响的比较研究，各医院基本情况见表 4.7。

表 4.7 地域支援医院不同数量诊疗中心配置案例基本情况

医院名称	高の原中央病院	愛媛県立中央病院	松江赤十字医院
规模	249 床	827 床	599 床

中国知网 https://www.cnki.net

中心数量	3 个	9 个	0 个
诊疗科室与诊疗中心			
诊疗方式	联合成立诊疗中心的科室，中心化诊疗； 其他各科单独受诊	联合成立诊疗中心的科室，中心化诊疗； 其他各科单独受诊	各科单独受诊
新门诊楼建设时间	2007 年	2013 年	2013 年
诊疗中心建设与门诊楼建设关系	诊疗中心于新门诊医技楼之后建设	诊疗中心于新门诊医技楼之前建设	
布局特征	建设时，考虑到相关科室及医技邻近布局，更有利于成立相关诊疗中心 （见图 4-19）	新门诊医技楼建设考虑到诊疗中心的建设，相关科室相邻，医技相邻布局 （见图 4-20）	虽未形成诊疗中心，但仍出现部分相关科室邻近布局的形势 （见图 4-21）

注：表格自制

中国知网 https://www.cnki.net

通过设置诊疗中心而诊疗中心设置数量不同医院间科室和诊疗中心比较，发现科室种类影响诊疗中心的设置数量和种类，如高的原中央医院未设置儿科等相关科室，则不能形成儿童综合医疗中心；对于同一类型医院未设置诊疗中心或同一所医院未设置其他诊疗中心的主要原因则在于诊疗体制的不同，形成诊疗中心的科室，往往科室间合作中心化诊疗，而未形成诊疗中心的科室往往单独诊疗。

通过比较各医院科室和诊疗中心的形成时间，发现诊疗中心的形成与科室形成均有一定的时间脉络，且会影响医院的平面布局。对于考虑到相关科室和医技相邻的建筑设计，有助于医院后续诊疗中心的开设，如高的原中央医院心内科与心血管外科及心电图相关检查邻近布置，有利于形成心脏血管中心，进行中心化诊疗，见图 4-19；对于之前就建设有诊疗中心的医院，在新医院门诊医技楼建设时，会以诊疗中心的方式，邻近布置相关科室和医技布局，以方便患者诊疗，见图 4-20；对于未成立相关诊疗中心的医院，却仍出现了相关科室邻近布局倾向，如松江赤十字医院虽未设置诊疗中心，但已出现心内科与心外科，呼吸内科与呼吸外科邻近布局的倾向，但相较于考虑到设置诊疗中心布局的医院，缺少一定的诊疗中心涉及科室考虑的针对性，仅为内外科科室邻近布局。

图 4-19 高の原中央病院
图片来源：作者自绘

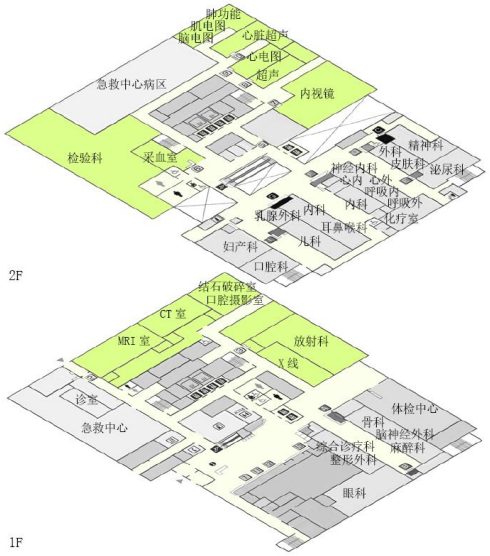


图 4-21 松江赤十字医院
图片来源：作者自绘

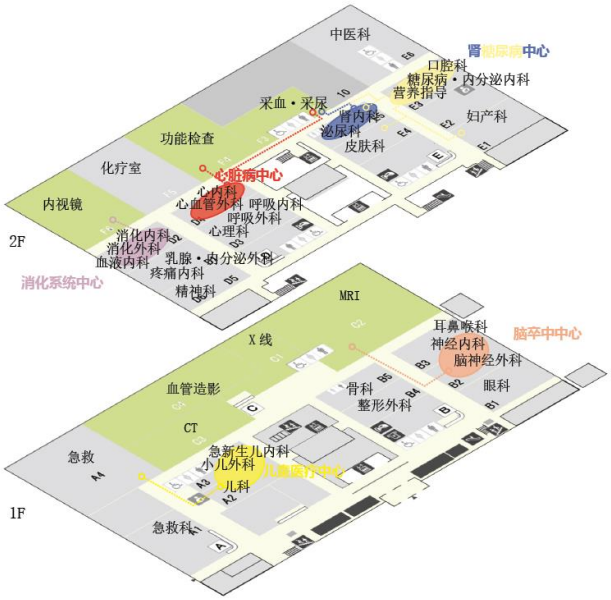


图 4-20 愛媛県立中央病院
图片来源：作者自绘

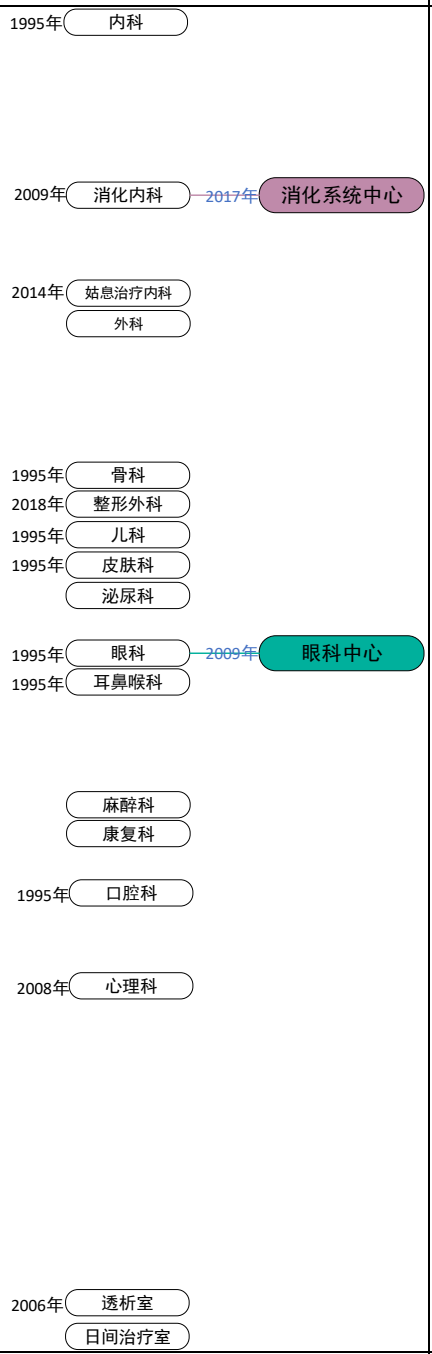
3） 一般医院

选取研究的一般医院的案例中诊疗中心设置数量较少和较多的两所医院和未研究案例中心未设置诊疗中心的一所医院，进行科室与诊疗中心的关系、医院诊疗模式和诊疗中心建设

中国知网 https://www.cnki.net

时间与新门诊楼建设时间关系，及其对平面布局的影响的比较研究，各医院基本情况见表 4.8。

表 4.8 一般医院不同数量诊疗中心配置案例基本情况

医院名称	真生会富山医院	湘南镰仓综合医院	苫小牧市立医院
规模	99 床	648 床	382 床
中心数量	2 个	13 个	0
诊疗科室与诊疗中心			
诊疗方式	包含相关医技或手术或住院区，形成诊疗中心； 其他各科单独受诊	联合成立诊疗中心的科室，中心化诊疗； 单科成立的诊疗中心往往对某类疾病诊疗有较强的针对性； 其他各科单独受诊	各科单独受诊
新门诊楼建设时间	主体 2000 年竣工 2009 年消化内科重新开设 2009 年眼科中心楼建立	2006 年	2006 年
诊疗	诊疗中心建设伴随着医院建设调整。	诊疗中心于新建门诊医技楼之后成立。	

中国知网 https://www.cnki.net

中心建设与门诊楼建设关系			
布局特征	诊疗中心的建设带动医院建设调整，诊疗中心形成诊疗住院一体化的趋势。（见图 4-22）	建设时，考虑到相关科室及医技邻近布局，更有利于成立相关诊疗中心（见图 4-23）	出现部分关联科室邻近布局情况（见图 4-24）

注：表格自制

通过比较设置数量不同的诊疗中心两所医院科室和诊疗中心设置数量和种类，发现科室的数量影响诊疗中心的数量；而对于同一医院未形成诊疗中心的科室和医院未设置诊疗中心的原因，往往取决于诊疗体制和该科室对某类疾病治疗的专业度。联合形成诊疗中心的科室，往往中心化联合诊疗，未形成诊疗中心的科室则单独诊疗；对某类疾病诊疗有一定建树的科室，往往会单独成立某些中心，如湘南镰仓综合医院骨科成立外伤中心和人工膝关节中心，而真生会富山医院和苫小牧市立医院骨科未形成相关中心。

与科室形成有一定的时间性一样，诊疗中心的建设也常常循序渐进的进行。对于新设立的诊疗中心，医院往往也会跟着进行相关建筑配套设计，以保证诊疗中心布局与诊疗体制对应，如真生会富山医院新门诊医技楼建立于 2000 年，随着 2009 年眼科中心的成立，门诊楼也进行一部分的修建，见图 4-22；对于建设时就考虑相关科室及医技相邻的布局方式的医院，在成立新的诊疗中心时，有一定的优势，但仍有一些考虑不足，如湘南镰仓综合医院在 2013 年成立的脊椎脊髓科外科和脊椎脊髓中心，与 2006 年建设的骨科与脑神经外科分层设置的状况有些微出入，使得邻近骨科设置的脊椎脊髓中心很难邻近脑神经外科，进行合作诊疗，但仍可以被动的以医生坐诊的方式进行诊疗中心的联合诊疗；而对于未设置诊疗中心的医院，也根据各医院特色，出现了部分相关科室相邻的倾向，如苫小牧市立医院消化内科和普外科邻近布局。

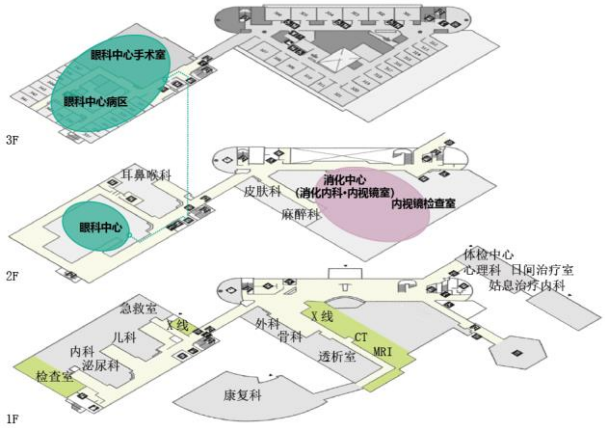


图 4-22 真生会富山医院
图片来源：作者自绘

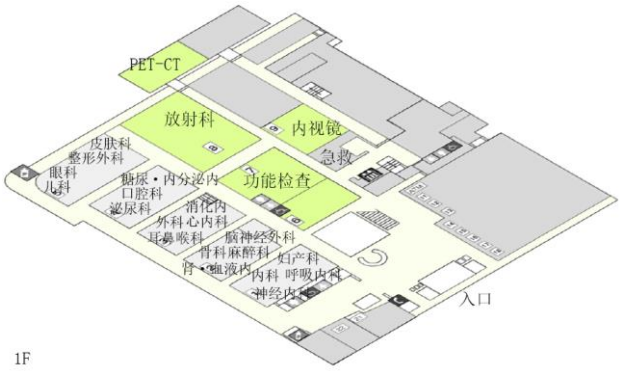


图 4-24 苫小牧市立医院
图片来源：作者自绘

中国知网 https://www.cnki.net

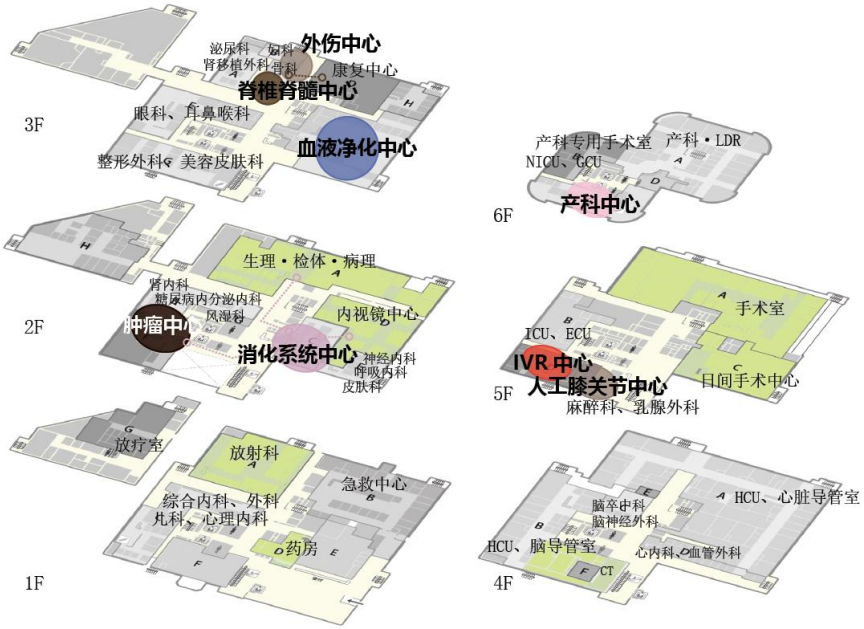


图 4-23 湘南镰仓综合医院
图片来源：作者自绘

4） 高度综合医疗设施

选取高度综合医疗设施中诊疗中心设置数量较少、一般和较多的三所医院，进行科室与诊疗中心的关系、医院诊疗模式和诊疗中心建设时间与新门诊楼建设时间关系，及其对平面布局的影响的比较研究，各医院基本情况见表 4.9。

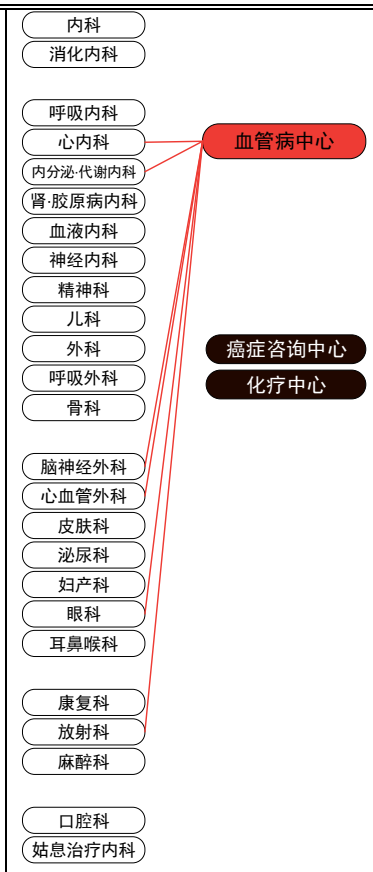
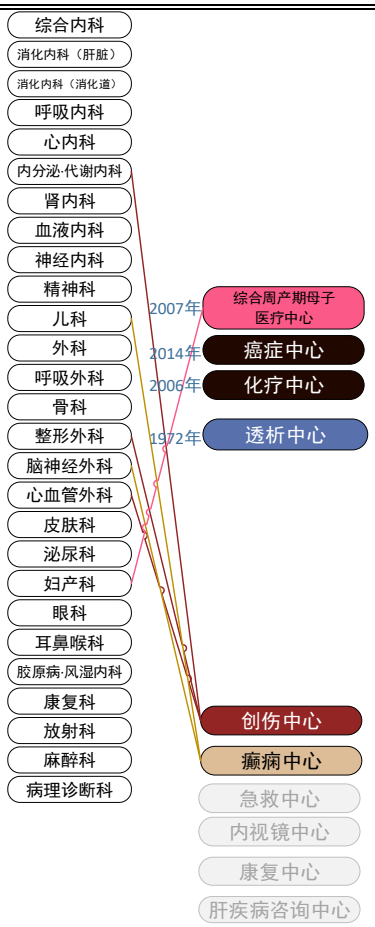
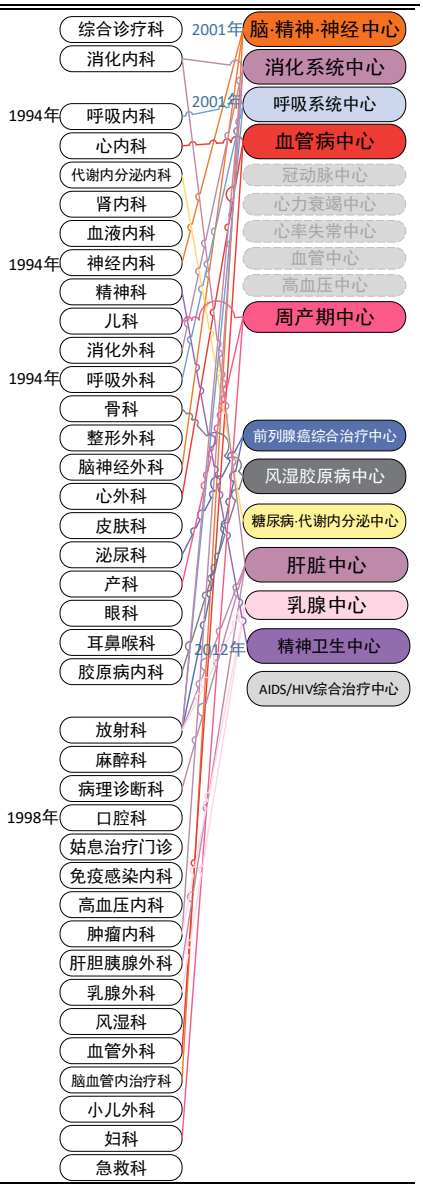
通过比较设置数量不同诊疗中心医院的科室组成和诊疗中心的种类，可以看出与其他医院不同的科室，易形成相关诊疗中心。但具有类似科室却形成不了诊疗中心的原因则在于科室间诊疗体制的不同，联合成立诊疗中心的科室各科合作诊疗，未形成诊疗中心的科室各科单独受诊。

通过对比各医院诊疗中心的形成时间和新建门诊医技楼时间，可以发现，若诊疗中心设置在新门诊医技楼开设之前，新医院的建设会按照诊疗中心相关科室邻近的方式布局，医技集中布局，如图 4-25、图 4-27。若诊疗中心多在新门诊医技楼开设之后设立，新门诊医技楼的建设仍按照传统内外科分开建设的方法，诊疗中心的成立多以先咨询某一科室，后经过会诊的形式构成，如长崎医疗中心创伤中心先咨询整形外科，后多科就诊，图 4-26。

表 4.9 高度综合医疗设施不同数量诊疗中心配置案例基本情况

医院名称	金沢医療センター	長崎医療センター	九州医療センター
规模	554 床	643 床	702 床
中心数量	3 个	6 个	12 个

中国知网 https://www.cnki.net

诊疗科室与诊疗中心			
诊疗方式	联合成立诊疗中心的科室合作诊疗，其他各科单独受诊	联合成立诊疗中心的科室以会诊方式诊疗，其他各科单独受诊	联合成立诊疗中心的科室合作诊疗
新门诊楼建设时间	2012 年	2001 年	2011 年
诊疗中心建设与门诊楼建设关系		大部分诊疗中心在新建门诊医技楼之后建设	大部分诊疗中心在新建门诊医技楼之前建设
布局特征	未形成诊疗中心的科室也呈相关科室邻近，医技相对集中布局的态势 （见图 4-25）	设立诊疗中心多为多病因诊疗中心，科室布局仍内外科分开设置，诊疗中心布局未在平面上标识。 （见图 4-26）	诊疗中心成立于新医院建设前，相关科室邻近布局，部分医技邻近中心布局。 （见图 4-27）

注：表格自制

中国知网 https://www.cnki.net

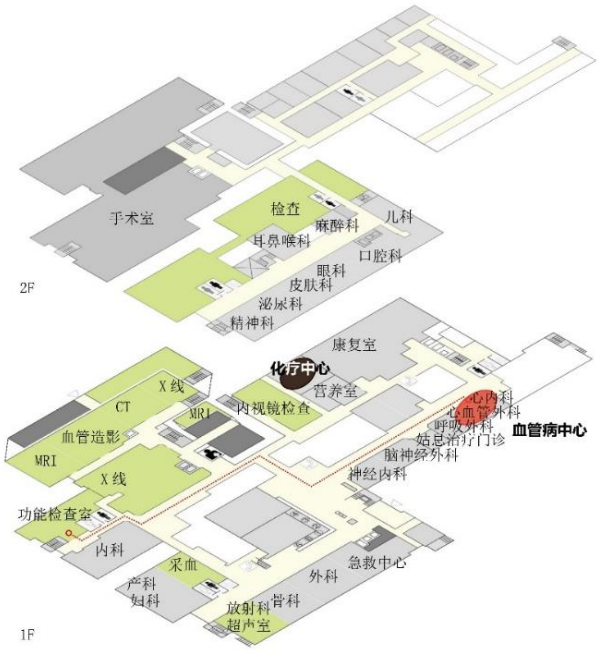


图 4-25 金沢医療センター
图片来源：作者自绘

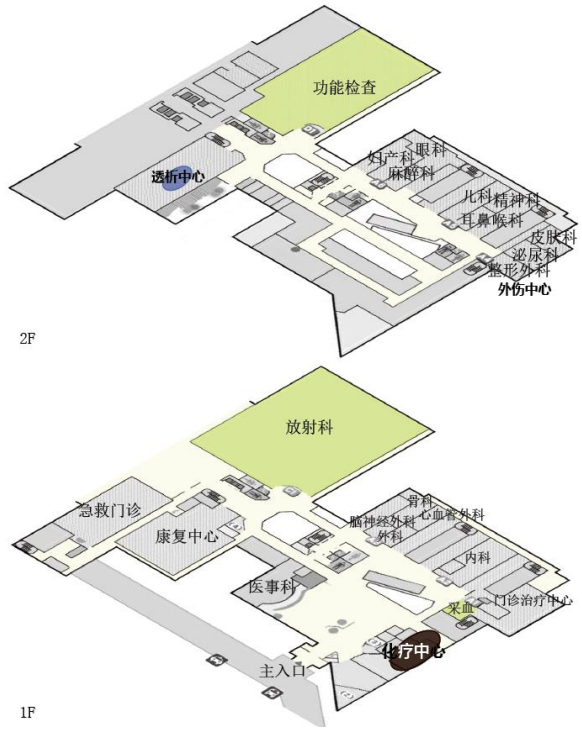
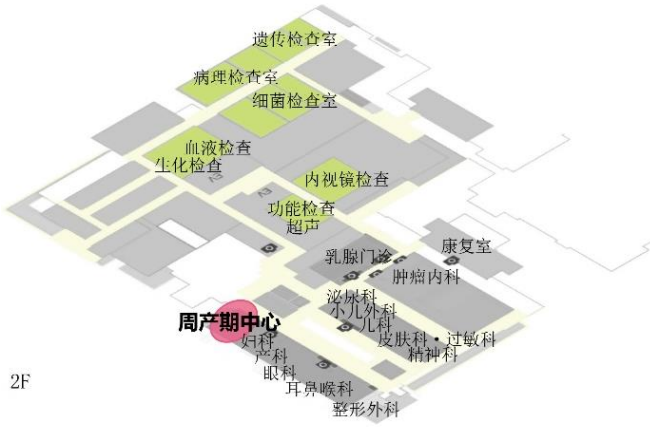


图 4-26 長崎医療センター
图片来源：作者自绘



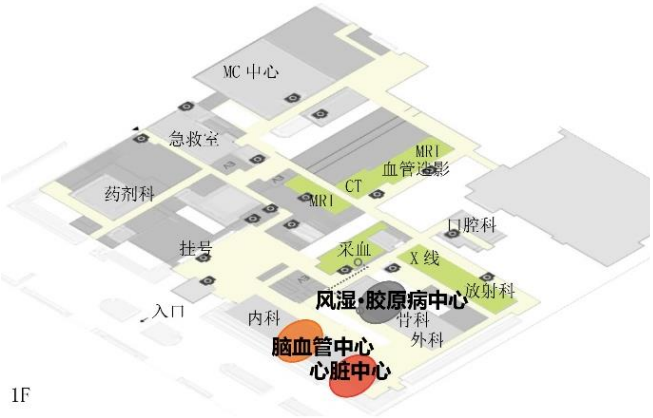


图 4-27 九州医療センター
图片来源：作者自绘

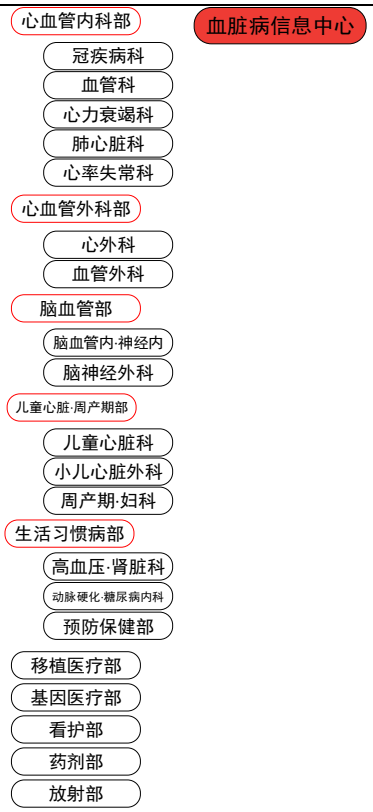
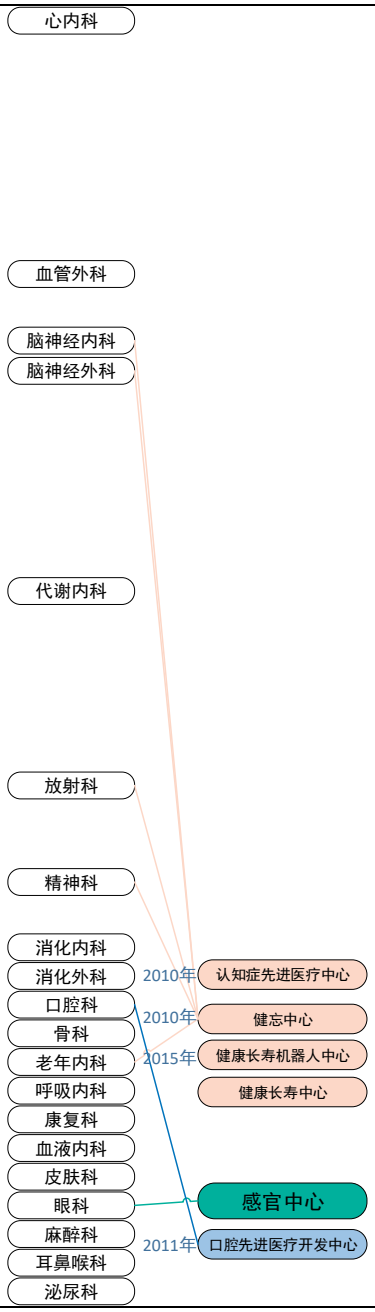
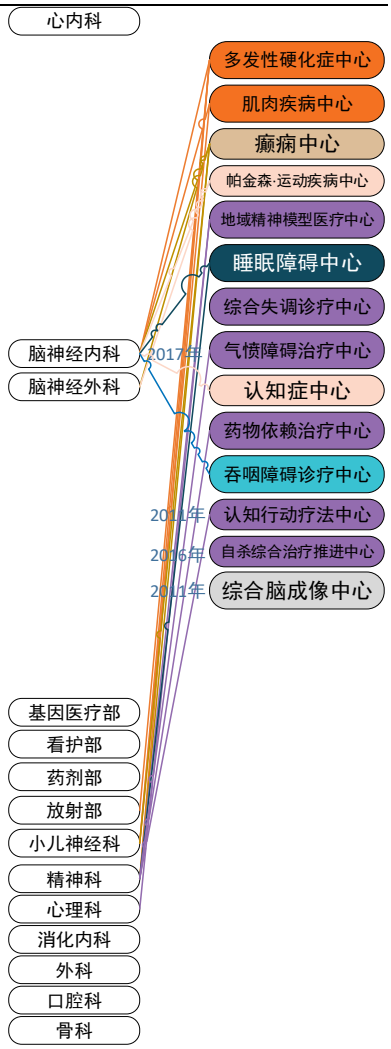
5） 国立高度专门医疗研究中心

选取国立高度专门医疗研究中心中诊疗中心设置数量较少、一般和较多的三所医院，进行科室与诊疗中心的关系、医院诊疗模式和诊疗中心建设时间与新门诊楼建设时间关系，及其对平面布局的影响的比较研究，各医院基本情况见表 4.10。

通过比较设置数量不同诊疗中心医院的科室组成和诊疗中心的种类，可以看出三所医院科室设置差异较大，这与该类型医院对某类疾病有较专业的研究有关，进而直接影响了诊疗中心的设置数量和种类。而对某些特殊疾病的专业化治疗而形成的诊疗中心，是导致该类型诊疗中心数量设置不同的主要原因。

中国知网 https://www.cnki.net

表 4.10 国立高度专门医疗研究中心不同数量诊疗中心配置案例基本情况

医院名称	国立循環器病研究センター	国立長寿医療研究センター	国立精神・神経医療研究センター
规模	612 床	383 床	474 床
中心数量	1 个	6 个	14 个
诊疗科室与诊疗中心			
诊疗方式	一个部门下科室精细划分，部门内合作诊疗	形成诊疗中心的科室往往以会诊方式诊疗，其他各科单独受诊	主要设置精神・神经相关科室，成立多个多病因疾病中心，各相关科室以会诊方式合作诊疗
新门诊楼建设时间	2017 年？	2018 年	2010 年
诊疗中心建设与门诊楼		诊疗中心建设在新门诊医技楼之前	部分诊疗中心设置在新门诊医技楼开设之后

中国知网 https://www.cnki.net

建设关系			
布局特征	科室邻近集中，医技集中 （见图 4-28）	中心间独立，医技集中布局。 （见图 4-29）	部分诊疗中心关联布局，医技集中。 （见图 4-30）

注：表格自制

通过综合对比各医院各类诊疗中心的形成时间和新建门诊医技楼时间，可以发现，诊疗中心的设置种类和诊疗体制影响新医院门诊医技楼的建设。若医院多设置多病因诊疗中心或全身性诊疗中心，而这些类型诊疗中心又多以预约会诊的方式进行，会忽视其他相关科室相邻布局的可能，如图 4-29、图 4-30。

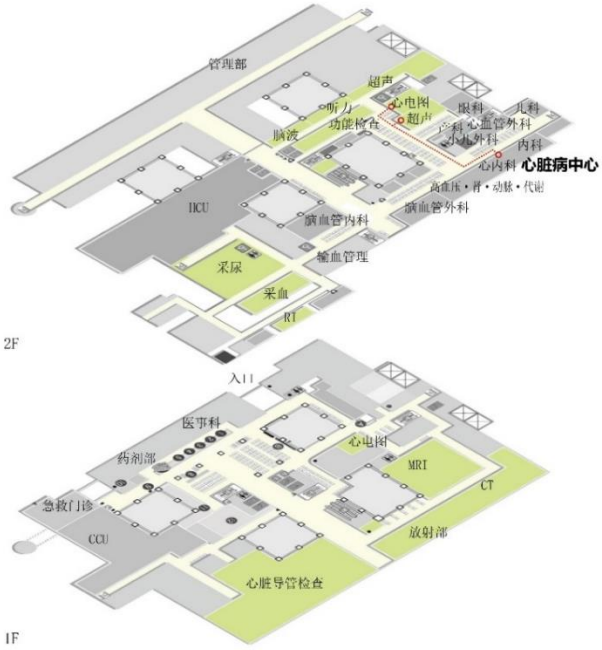


图 4-28 国立循環器病研究センター
图片来源：作者自绘

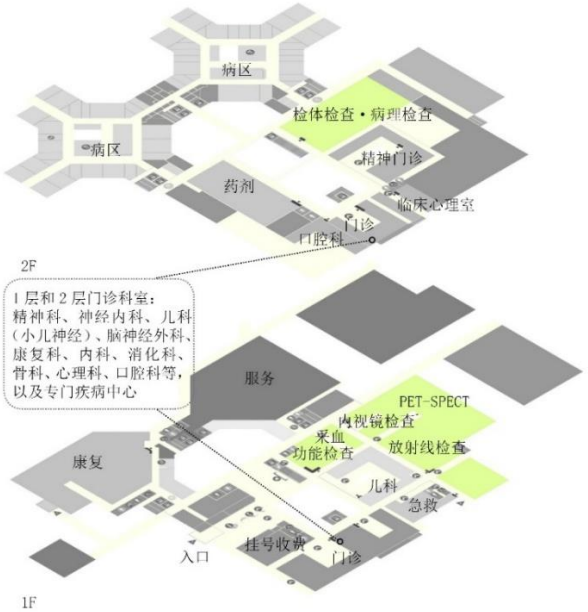


图 4-30 国立精神・神経医療研究センター
图片来源：作者自绘

图 4-29 国立長寿医療研究センター
图片来源：作者自绘

中国知网 https://www.cnki.net

4.2.3 小结

通过比较相同规模及相同类型而诊疗中心不同的医院间，科室与诊疗中心的关系、医院的诊疗模式和诊疗中心建设与医院新门诊医技楼建设时间对诊疗中心的平面布局的影响等方面内容，得出各医院诊疗中心设置与否，以及诊疗中心设置数量不同的影响因素：

1.诊疗中心的建设跟医院诊疗体制有关。科室形成诊疗中心一般由科室间联合诊疗和单个科室针对某类疾病进行专业化诊疗，两种方式形成。而医院未形成诊疗中心或未形成相关诊疗中心的原因，则在于可形成相关中心的科室单独诊疗或科室针对某疾病诊疗的专业度不够。

2.诊疗中心的设置数量和种类跟医院科室配置数量和种类有关。科室是诊疗中心形成的基础，未设置相关科室的医院不会形成该类中心。

3.医院的科室建设和诊疗中心的建设往往具有一定的时间性，医院根据各科室自身情况，酌情考虑诊疗中心的开设。

4.诊疗中心的建设时间往往会影响新建医院门诊医技楼平面布局。对于在新建门诊医技楼之前就设立诊疗中心的医院，在新建门诊医院楼时会考虑诊疗中心涉及的相关科室和医技，采用邻近布局方式，针对性的布局；对于在新建门诊医技楼之后成立诊疗中心的医院，若医院按照原来内外科布局方式，会出现诊疗中心中心化诊疗的体制与医院平面布局不对应的情况，联合诊疗的情况往往呈先在某个科室就诊，然后再会诊的方式进行；若医院在成立诊疗中心的同时进行新门诊医技楼的修整，诊疗中心则会在新修空间内较独立布局；若医院在新门诊医技楼建设时就考虑相关科室和医技相邻情况建设的医院，则有利于医院后来诊疗的开设，但也存在对未来可能成立其他诊疗中心的未知性。

5.诊疗中心的诊疗体制影响新建医院门诊医技楼平面布局。若医院之前设置的诊疗中心多为疾病中心，而诊疗中心体制又多为联合会诊的形式，新建医院门诊楼若未考虑其他合作诊疗和继续以相同会诊方式进行中心化诊疗，则其平面布局仍会呈传统内外科分类布局的形态。

6.在未设置诊疗中心的新建医院中，也出现了相当程度的相关科室和医技邻近布局的做法。

4.3 医院科室实行中心化诊疗模式与否比较研究

医院科室和诊疗体制影响医院诊疗中心的建设与否，并会影响新医院门诊医技楼平面布局，但对诊疗中心中心化诊疗对患者带来的优劣仍未明确，本节通过考察现行医院不同的诊疗制度对患者就诊流程的影响，解明医院诊疗中心实行相关诊疗模式的优势和局限。

4.3.1 分科诊疗制

1） 诊疗制度

通常初诊患者到医院，往往先根据自身身体状况，查询医院科室信息，再针对性的挂相关科室号。一般医院将自身科室分为内科、外科和其他科以供患者检索，如图 4-31，但对多数不清楚自身疾病特征的患者，可能出现挂错号的情况。

中国知网 https://www.cnki.net

图 4-31 石川县立中央医院科室检索图
图片来源：医院官网 http://kenchu.ipch.jp/department/index.html，并由作者翻译

2） 诊疗流程

对于分科诊疗制，初诊患者在挂完相关科室号之后要去相关科室前等候就诊，在医生问诊后，经医生指导去相关检查室做某些检查，以帮助医生确诊，后回到诊室供医生参考，若医生认为病症明显，即可给出诊疗方案，患者即可缴费离开；若医生认为还不能确诊或更适合其他科医生诊疗，会推荐患者到相关科室诊疗，但这时患者则需要重新挂号、等候，再到推荐科室诊疗，医生可能仍会推荐患者做某些检查，再回诊室供医生判断，若病症明显，医生会给患者开出诊疗方案，患者可缴费离开；若被推荐医生仍未能诊断患者疾病，则会再次推荐患者到相关医生处诊疗……如图 4-32。同样对于复诊患者或多疾病患者仍会在某些时候经历上述同样的诊疗流程：重复挂号、可能做某些不必要的检查、可能最终仍未得到诊疗方案，并交了多科诊疗的昂贵医药费。

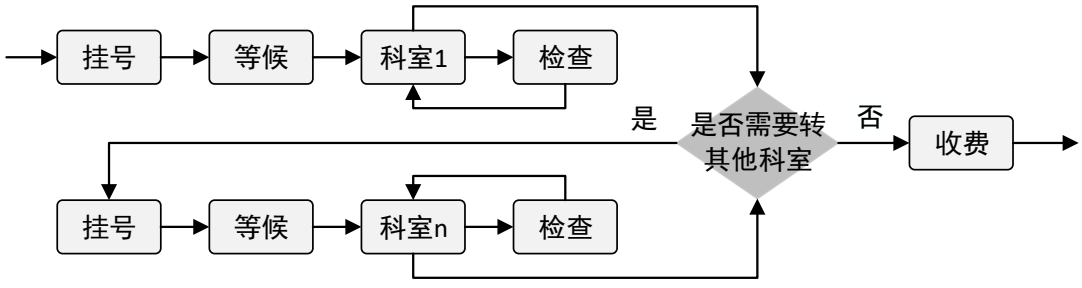


图 4-32 分科诊疗制模式下初诊患者诊疗流程
图片来源：作者自绘

3） 平面流线

以心脏病相关患者为例，模拟分科诊疗制下患者就诊流程，见图 4-33、图 4-34。其中图 4-33 医院按内外科分离设置模式进行平面布局，图 4-34 医院按相关科室相邻方式进行平面布局。就同一就诊流程而言，可以发现在相关科室相邻布局医院，患者往返位置点相较内外科分离布局医院较少，即患者不需要增加寻找“心血管外科”诊疗。

中国知网 https://www.cnki.net

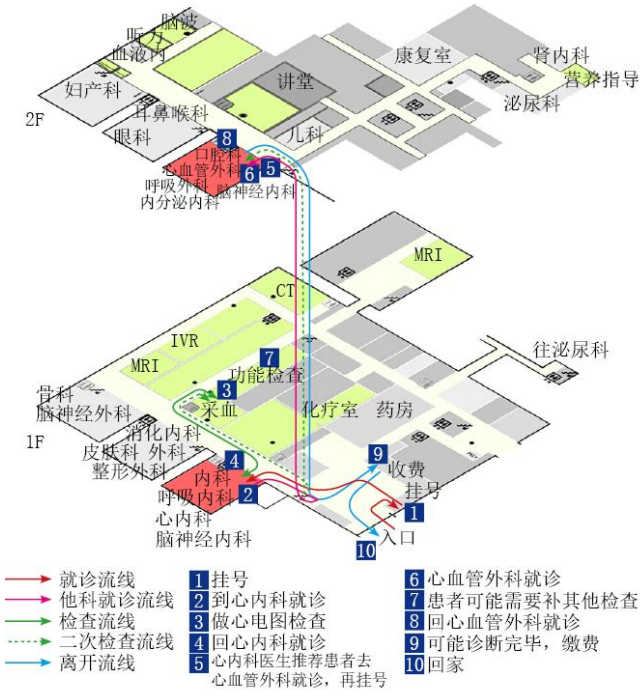


图 4-33 （市立四日市病院）内外科分开布局心脏病相关患者诊疗流线
图片来源：作者自绘

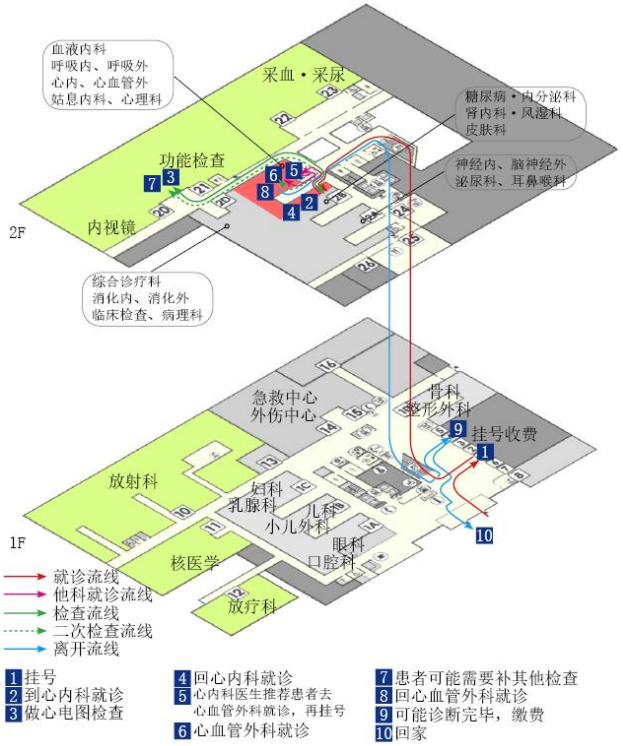


图 4-34 （石川县立中央医院）相关科室邻近布局心脏病相关患者诊疗流线
图片来源：作者自绘

4.3.2 中心制

1） 诊疗制度

医院部分科室通过以诊疗中心模式而非科室分开检索模式供患者检索，可方便患者根据疾病发病部位进行相关中心的挂号，见图 4-35。

图 4-35 国际医疗福祉大学三田医院诊疗科检索图
图片来源：http://mita.iuhw.ac.jp/clinic/index.html，并由作者翻译

中国知网 https://www.cnki.net

2） 诊疗流程

实行中心制科室，患者只需挂诊疗中心的号，就可到相关诊疗中心接受相关医生诊疗，若即使借助相关检查仍未能确诊，首诊医生会联合中心其他医生对患者联合诊疗，免去了患者多次挂号、检查、寻找科室和多重缴费的负担，中心制往往需要患者提前预约，且由于对患者未加区分，医生的工作量增加，可能造成医师资源浪费。

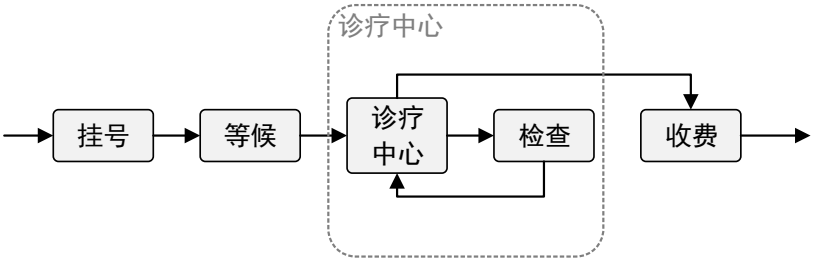


图 4-36 中心制模式下初诊患者诊疗流程
图片来源：作者自绘

3） 平面流线

以心脏病相关患者为例，模拟中心制下患者就诊流程，见图 4-37。可以发现患者仅需到挂号收费处、心脏病中心和功能检查室就可完成全部诊疗行为，更方便患者诊疗。

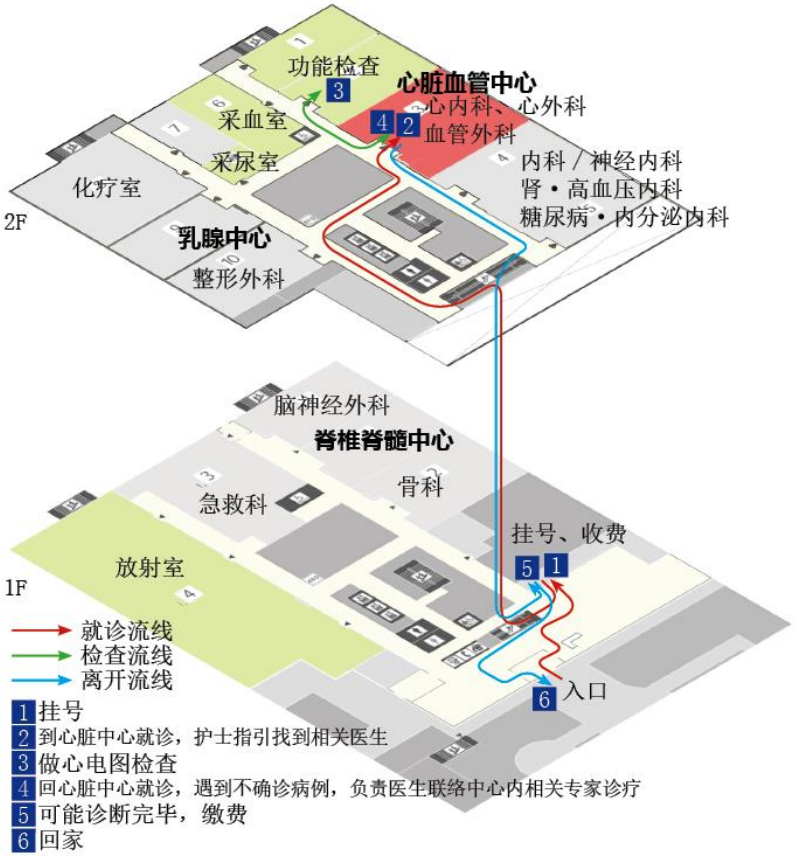


图 4-37 （国际医疗福祉大学三田医院）诊疗中心化布局
心脏病相关患者诊疗流线
图片来源：作者自绘

中国知网 https://www.cnki.net

4.3.3 双轨制

1） 诊疗制度

在综合分科诊疗制和双轨制的基础上，部分医院相关科室使用双轨制诊疗，以方便患者诊疗和提高医护效率。实行双轨制的科室，可供患者根据发病部位找寻相关诊疗中心，并进一步找寻相关科室，挂号，如图 4-38。

图 4-38 东京女子医科大学医院科室检索图

图片来源：http://www.twmu.ac.jp/info-twmu/shinryo-center.html，并由作者翻译

2） 诊疗流程

患者通过挂诊疗中心某一科室号，进行诊疗，此时患者无需为可能挂错科室号而担心，中心制保证了该诊疗中心间科室的互通有无，由首诊医生负责与其他相关科室医生合作，并对进行患者全面诊疗。其他科医生仍正常接诊，如图 4-39。

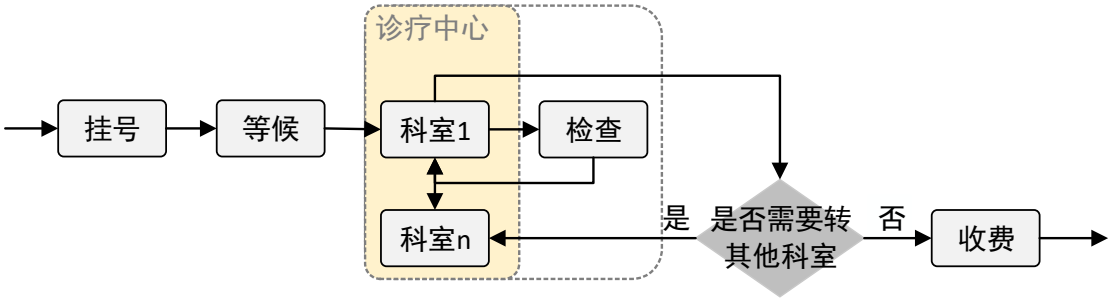


图 4-39 双轨制模式下初诊患者诊疗流程

图片来源：作者自绘

中国知网 https://www.cnki.net

3） 平面流线

以心脏病相关患者为例，模拟双轨制诊疗模式下患者就诊流程，见图 4-40。可以发现患者仅需到挂号收费处、心脏病中心和功能检查室就可完成全部诊疗行为，方便患者诊疗。

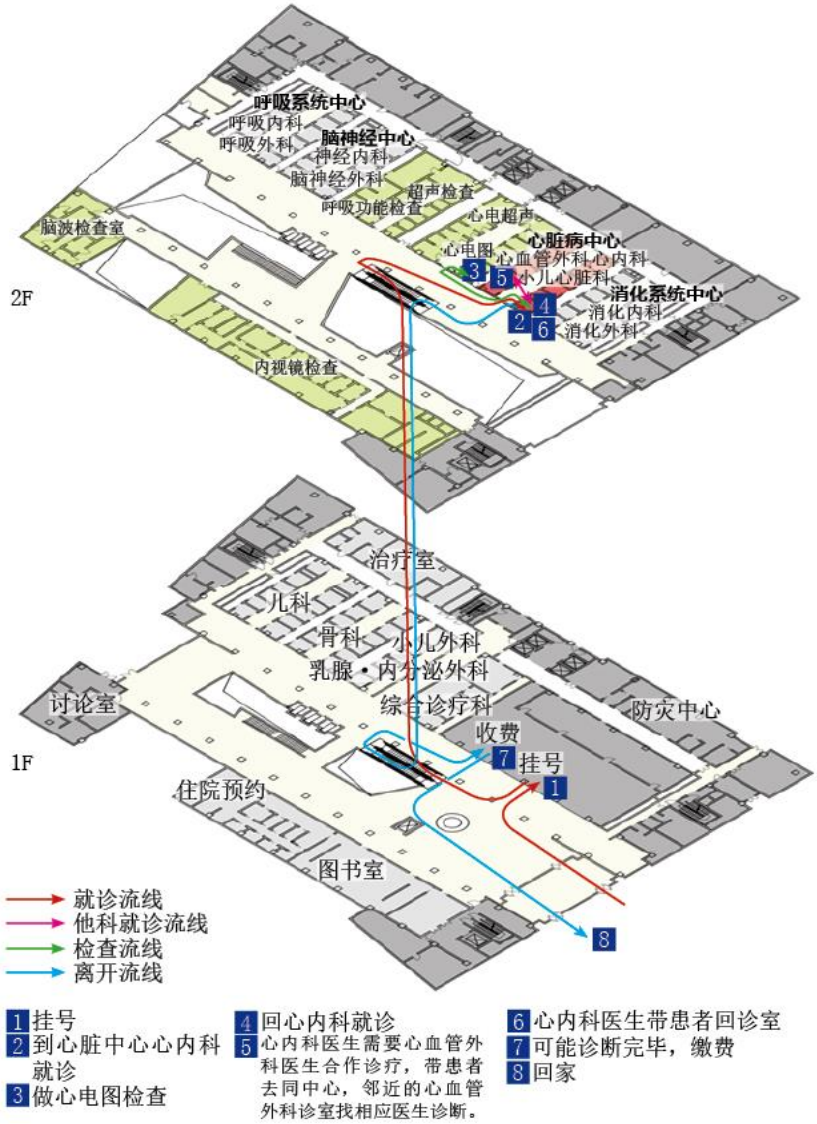


图 4-40 （东京女子医科大学医院）诊疗中心化布局
心脏病相关患者诊疗流线
图片来源：作者自绘

4.3.4 对比研究

不同诊疗体制会对患者就诊产生影响，各医院应考虑自身实际情况，合理综合运用不同诊疗体制。总的来讲，分科诊疗制可方便单疾病患者诊疗，但不利于多疾病患者诊疗，但相关科室邻近能减少多科就诊患者步行距离和利于患者寻找相关科室；中心制方便患者诊疗，但可能造成医师资源浪费；双轨制综合了分科诊疗制和中心制的特点，便于患者检索、便于不同需求患者的诊疗、提高医疗效率，但需克服医院传统内外科分开管理体制的束缚和因某特殊疾病患者临时加塞而导致其他患者不满等问题。但相较而言，双轨制更利于患者诊疗和提高医疗效率。且通过比较实行各种诊疗制医院平面布局模式，可以发现若医院按照诊疗中心模式进行相关科室邻近布局，更能方便患者诊疗。

中国知网 https://www.cnki.net

表 4.11 不同诊疗体制下患者诊疗优劣比较表

		分科诊疗制		中心制	双轨制
检索方式	优势	科室全部罗列，便于患者查找		以发病器官检索，便于患者检索、挂号	先以发病器官检索，然后患者再根据自身情况针对性的科室挂号
	局限	需要患者对医院科室诊疗内容较为明确，以免挂错号		往往需预约	患者乱挂号
就诊流程	优势	便于单科就诊患者诊疗		便于患者一站式诊疗，减少重复挂号、多次检查和缴费	分科室保证单科诊疗患者快速诊疗，中心制保证多科诊疗患者一站式诊疗，医师资源合理利用
	局限	可能造成多次挂号、重复检查和多次缴费的行为，不利于多科就诊患者或难诊断患者诊疗		可能造成医师资源浪费	诊疗制度实施难度大，需改变传统医院管理体制
平面流线		**内外科分离布置的医院**	**相关科室邻近布局医院**		
	优势	便于仅知自己内外伤患者诊疗	较便于多科就诊患者邻近诊疗	便于找寻诊疗中心、就诊	便于患者以中心方式寻找科室，就诊
	局限	不利于多科就诊患者邻近诊疗，医生间缺乏合作，对患者诊疗不系统	科室划分较细，不利于初诊患者寻找，医生间缺乏合作，对患者诊疗不系统	中心患者滞留数较多或接诊量较少	对需多科就诊患者，可能出现首诊医生加塞，对其他患者造成不好影响

注：表格自制

4.4 诊疗中心式医院平面设计方法研究

诊疗中心的建设与否，往往跟医院的诊疗体制和科室配置密不可分，但按照诊疗中心模式进行相关科室和医技邻近布局，无疑更能方便多疾病患者的诊疗，增加医生间交流合作，并有利于医院后续诊疗中心的开设。因此，本节以诊疗中心为出发点，剥离中心化诊疗的体制束缚，研究新时代医院设计的方法。

4.4.1 功能配置及相互关系

全面了解和掌握诊疗中心功能配置及相互关系，是诊疗中心式医院建设的关键。其有助于设计师在进行医院设计时，整体思考，统筹优化门诊部门各功能空间布局，从而达到简化医疗流程、方便患者诊疗和提高医疗效率的作用。本章以“诊疗中心”[1]为契机，进行诊疗中心式医院功能配置的研究。

1） “诊疗中心”科室构成

科室是诊疗中心成立的关键，是诊疗中心式医院建设的根本。“诊疗中心”可以由单一科室组成，也可以由多个科室共同合作构成。除此之外，“诊疗中心”还可能跟其他一些科室合作诊疗某些特殊疾病。一般“诊疗中心”由哪些科室构成往往跟医院设立诊疗中心诊疗某种疾病的目的有关。如设立糖尿病中心时，若它的目的在于解决初期糖尿病患者基本饮食指导、取药等问题，它可以只由糖尿病·代谢内科组成；若它的目的在于联合诊疗糖尿病眼部并发症等糖尿病并发症时，它可以由糖尿病·代谢内科和糖尿病眼科组成，并与眼科保持紧密联系。

[1] 这里的“诊疗中心”指医院未来可能建设的诊疗中心，是抽离具体诊疗中心名称的相关科室和医技邻近布局的相关科室间的通称。

中国知网 https://www.cnki.net

诊疗中心式医院设计需要设计师全方面的了解诊疗中心有哪些科室组成，为帮助医院未来规划定位打下基础，现将日本各医院诊疗中心与科室关系总结如表 4.12 和图 4-41。

表 4.12“诊疗中心”与科室关系表

	心内科	心血管外科	肾内科	泌尿科	神经内科	脑神经外科	眼科	耳鼻喉科	口腔科	乳腺·内分泌外科	消化内科	消化外科	呼吸内科	呼吸外科	骨科	整形外科	美容外科	妇科	产科	新生儿科	儿科	小儿外科	糖尿病·内分泌内科	风湿胶原病科	皮肤科	血液内科	精神科	心理科	麻醉科	肿瘤内科	老年科	普内科	康复科	营养科	急救科
心脏中心	1	1																			3		-2					3				3		3
肾脏中心			1	1																	3		3											3
脑神经中心	3				1	1	3	3							3												3					3		3
眼科中心							1									-2							-2											
耳鼻喉科中心		3			3		3	1	3				3			3					3		3		4		3					3	3	
口腔中心									1							3							-2					5	-2					
乳腺中心										1						3		3	3															
消化系统中心											1	1																			4			3
呼吸系统中心	3												1	1										3				3				3		
睡眠中心	2				2			2	2				2										3				2	2			3			
内分泌中心				3						1		3						3	3		3		1											
心·脑血管中心	1	1	2		1	1																	3					3				3		3
慢性创伤中心	2	2	2			2									2	3	1.5						1.5									3		
脊椎脊髓中心					2	1									1																	3		
骨科中心						3									1						3			3				3				3		3
整形中心																1	1								3									3
女性骨盆底中心				1								1						1														3	3	
生殖医疗中心				1														1	1		3													
周产期母子医疗中心																			1	1	2							3						3
女性医疗中心				2						1						3		1	1													3		
儿童医疗中心																					1	1												3
糖尿病中心	3		3	3	3		3	3	3						3	3		3	3				1		3							3	3	3
过敏中心							2	2					2								3			3	2						4			3
风湿·胶原病中心	3												3		3									1	3							3		3
皮肤病中心															5	1								3	1									
血液病中心																					3					1							3	
精神卫生中心																					3						1	1						3
疼痛中心					2	3									3												2	3	1			3		
肿瘤中心				2		2		2	2	2					2			2			3				2	2	2		3	1		3	1	
认知症中心					1																						1				1	3		
高血压中心	2			2									2								3		3	2										
唇腭裂中心								2	2							1.5			2	2	2								3			3		
脑卒中中心					1	1																										3		3
癫痫中心					1	1															1						1					3		

注：表格中数字表示中心与科室的关系，1 表示中心主要构成科室，数字越大表示科室与中心的关系越弱，负数表示此中心与该科室被动相关（例如眼科中心与糖尿病·内分泌内科的关系，主要是由糖尿病·内分泌内科产生的，记为-2）。

表格自制

中国知网 https://www.cnki.net

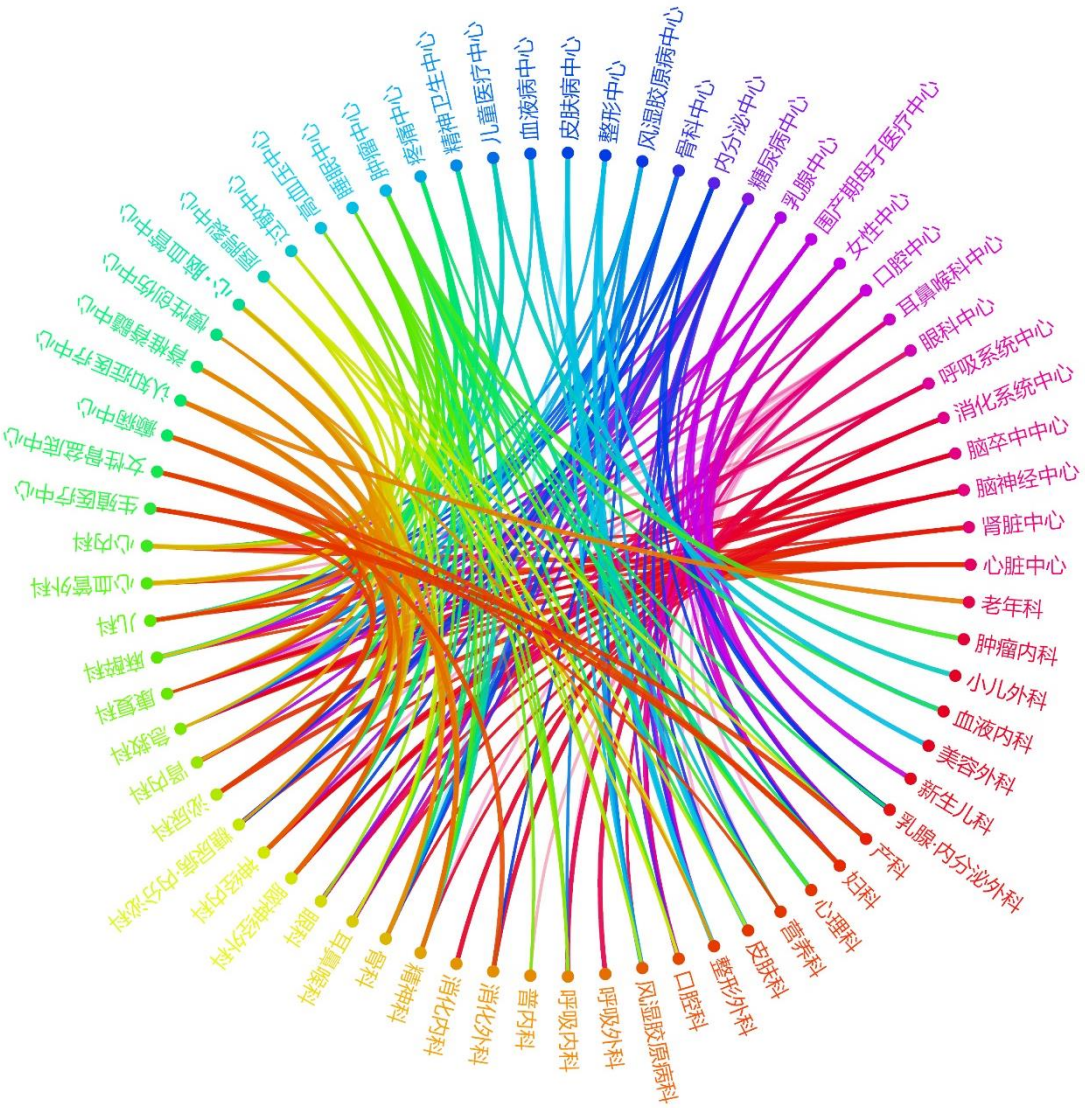
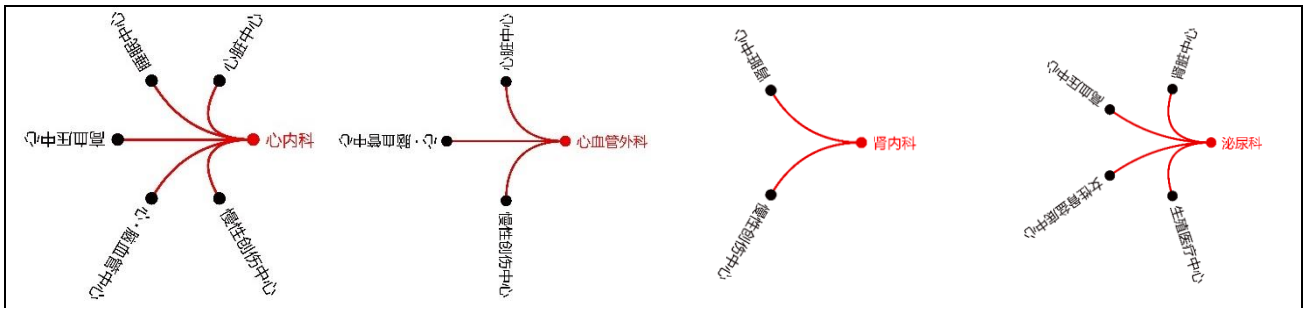


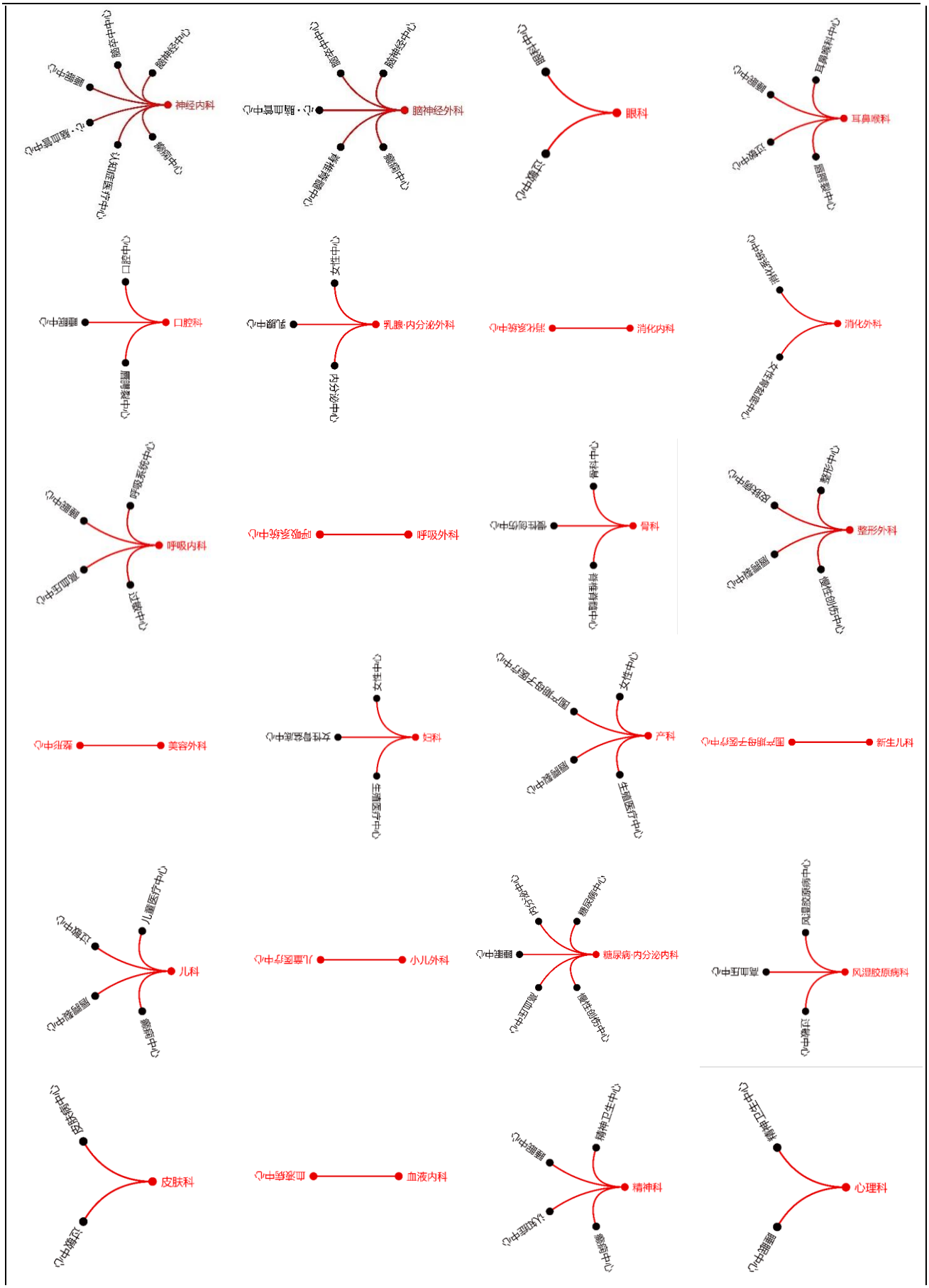
图 4-41 “诊疗中心”与科室关系图
图片来源：作者自绘

a） 科室构成中心

诊疗中心式医院设计，需设计师了解科室能够构成“诊疗中心”的种类，以便该科室更好、更优质地服务潜在患者和为医院未来建设相关诊疗中心提供便利。如心内科，通常情况下，设置为心脏中心 ，但它仍可以构成睡眠中心、高血压中心、心·脑血管中心及慢性创伤中心，以诊疗相关疾病。因此，通过考察日本医院各科室构成诊疗中心情况，绘制出图 4-42，以方便院方和设计师进一步设计和决策。



中国知网 https://www.cnki.net



中国知网 https://www.cnki.net

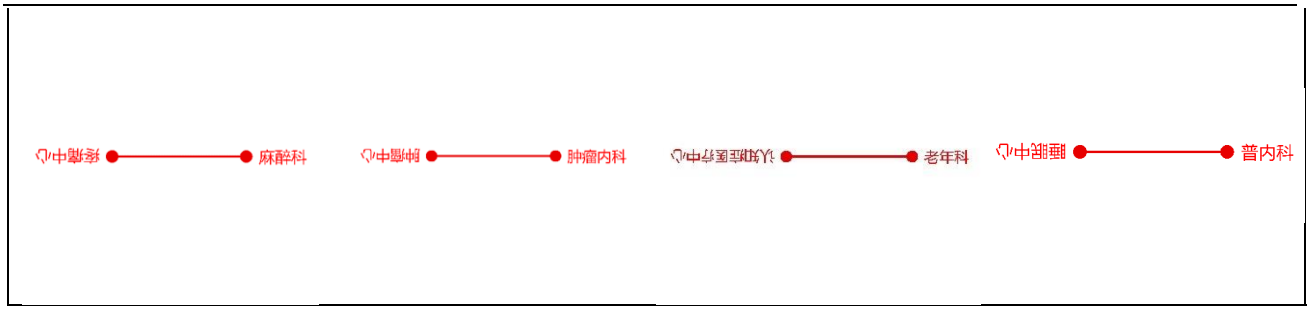
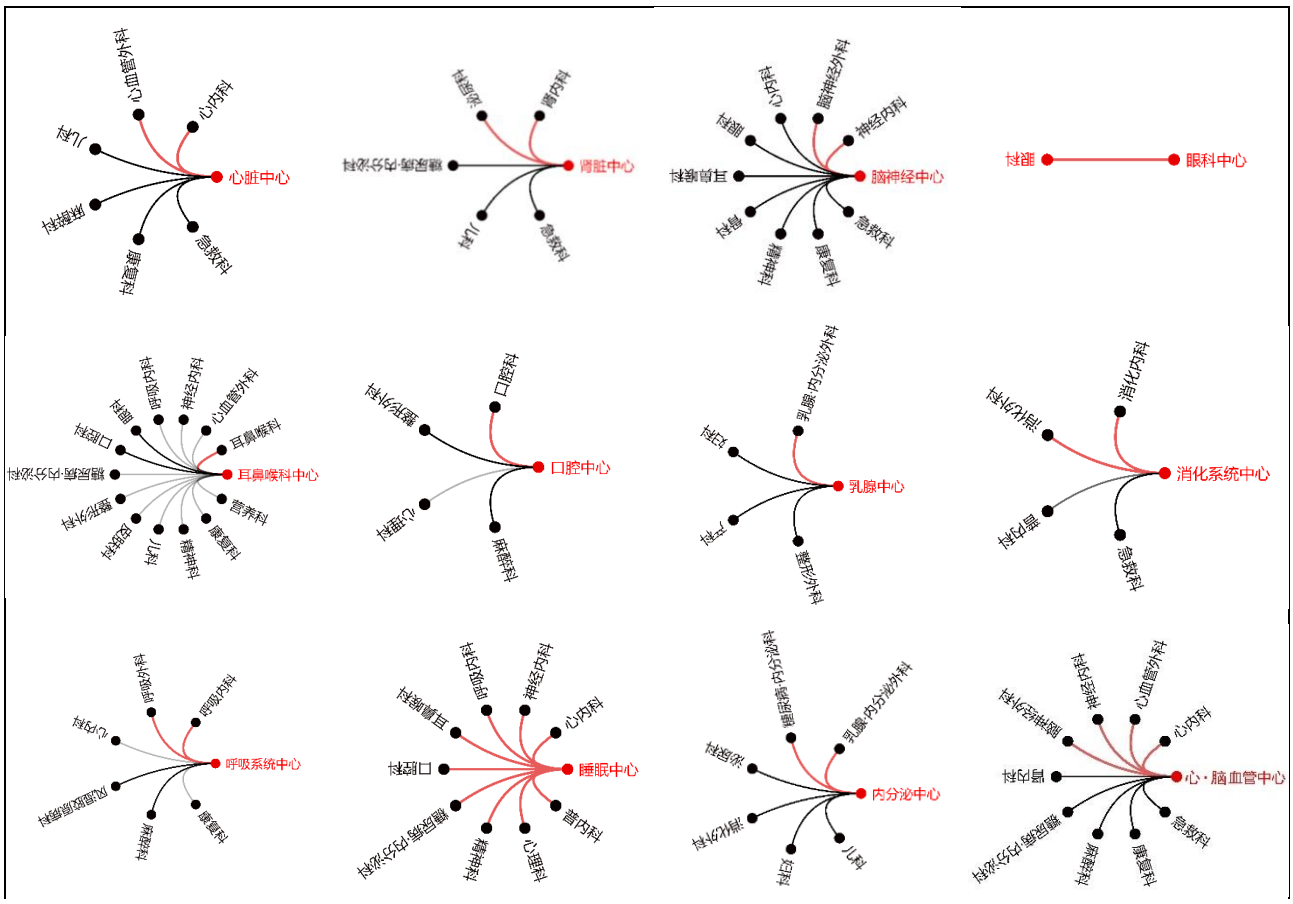


图 4-42 各科室构成 “诊疗中心”关系图
图片来源：作者自绘

b）中心涉及科室

诊疗中心式医院设计，往往需要设计师了解“诊疗中心”科室构成，以便邻近布局相关科室，方便患者诊疗和医院诊疗中心的建立。

诊疗中心往往由一个或数个，因治疗某种或某类疾病的科室组成。根据治疗疾病的轻重缓急不同，可以将“诊疗中心”涉及的科室分为主要构成科室和关联科室。其中主要构成科室是诊疗过程中需要经常合作的科室，往往是组成该“诊疗中心”必不可少的科室，如心脏中心中的心内科和心血管外科；关联科室主要是指与“诊疗中心”治疗某类疾病可能相互合作的科室，如心脏中心中的儿科。但由于各医院医师资源和优势科室不同，主要构成科室和关联科室间并无明确的界限，各医院可以统筹自身医疗资源，建立有各自医疗特点的“诊疗中心”，如某医院心脏中心更注重门诊患者心脏康复，可以考虑与康复科合作成立心脏康复中心。通过考察日本各医院诊疗中心涉及科室，绘制出各“诊疗中心”与科室关系图 4-43，便于院方和设计师充分考虑建设中心的完善性，从而方便患者诊疗，提高就诊质量和医疗效率。



中国知网 https://www.cnki.net

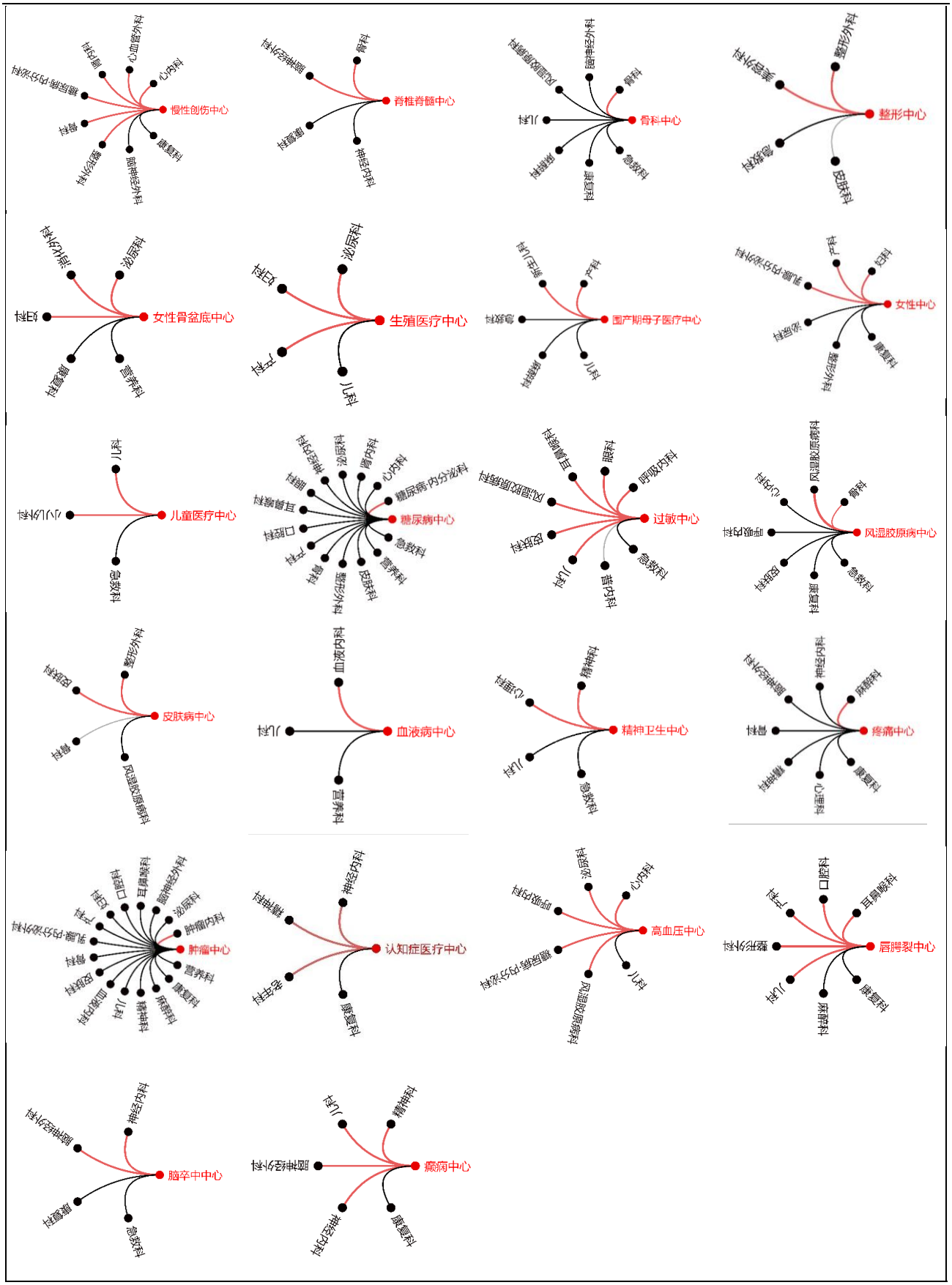


图 4-43 各“诊疗中心”涉及科室关系图

图片来源：作者自绘

注：图中红色连线表示诊疗中心主要构成科室，黑色和灰色表示诊疗中心关联科室，其中灰色表示关联度相比黑色更弱。

中国知网 https://www.cnki.net

2） “诊疗中心”涉及医技

医技部门作为现代医学确诊疾病的主要手段，是诊疗疾病中重要的一环。为了提高医疗效率，方便患者诊疗，院方和设计师需要根据医院医师资源、设备条件及门诊量等合理考虑安排“诊疗中心”与医技关系，并决定“诊疗中心”与医技部门的整合关系，即哪些医技方便直接邻近相关科室或在“诊疗中心”内设置，等等。

但现实情况下，很多设计师往往不清楚某“诊疗中心”涉及哪些医技检查，而将科室和医技部门随意布置，导致医疗流程紊乱，使得患者在医院到处做检查，既造成医疗效率降低，又降低了患者诊疗体验，甚至有可能导致患者间交叉感染。

通过考察日本各医院诊疗中心门诊诊疗主要涉及医技部门，归纳得到表 4.13 和图 4-44，并绘制出各诊疗中心门诊诊疗涉及医技部门关系图，如图 4-45，以方便设计师统筹考虑诊疗中心式医院设计中涉及医技部门，并考虑邻近设计的可能，以方便患者诊疗及提高医疗效率。

表 4.13“诊疗中心”门诊诊疗与医技部门关系表

	心电图	超声	内视镜	关节镜	腹腔镜、宫腔镜	检验科	放射科	乳房×线	骨密度检查	手术部	日间手术中心	输血部	药剂部	病理科	遗传检查	眼底检查	听觉检查	肺功能检查	脑电图检查	脑磁图	肌电图	ABI检查	神经心理学检查
心脏中心	1	1				3	2																
肾脏中心		2				1	2							1									
脑神经中心		1				1	1							1	1				1	1	1		1
眼科中心		2														1							
耳鼻喉科中心		2					3								1		1						
口腔中心										2	2												
乳腺中心		1					1	1						1	1								
消化系统中心		1	1				2							2									
呼吸系统中心		3	1			2	2							2				1					
睡眠中心	1		1			1	1												1	1	1		
内分泌中心		1				1	3																
心·脑血管中心		1					1															1	
慢性创伤中心		1				1	1															1	
脊椎脊髓中心							1																
骨科中心		2		1			1		1												2		
整形中心																							
女性骨盆底中心		1																					
生殖医疗中心		1			1	1									1								
周产期母子医疗中心		1				3				4					1								
女性中心		1			1	3	3	1	2					3									
儿童医疗中心																							
糖尿病中心	2	2				1			2						2	2					2	2	
过敏中心																							
风湿·胶原病中心		1				3																	
皮肤病中心							2																
血液病中心						1	1					1	2	1	1								1
精神卫生中心							2												1				
疼痛中心						2	2																
肿瘤中心		1				1	1						1	1	1								
认知症医疗中心	2					1	1												2				1
高血压中心						2	2																
唇腭裂中心		2																					
脑卒中中心	1	1				1	1			2									1		1		
癫痫中心							2								1				1	1			1

注：表中数字大小代表诊疗中心与医技关联紧密程度，数字越高代表联系越弱。
表格自制

中国知网 https://www.cnki.net

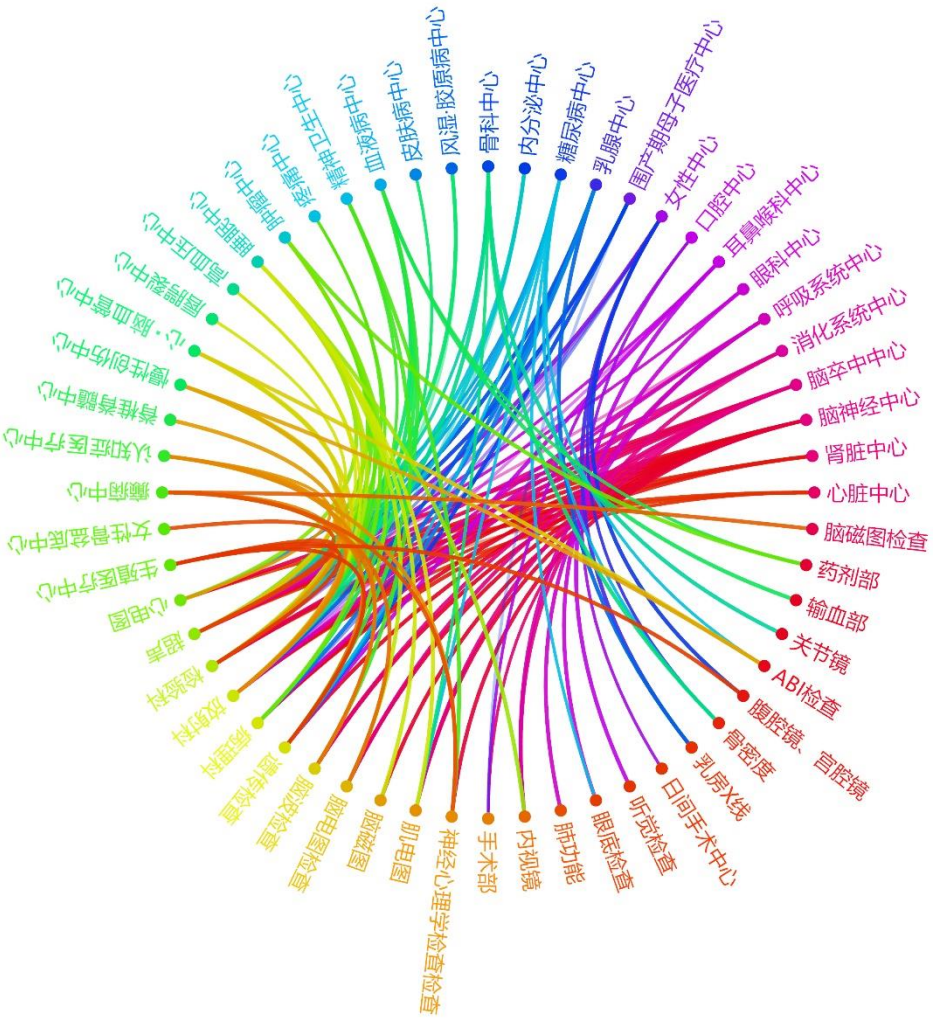
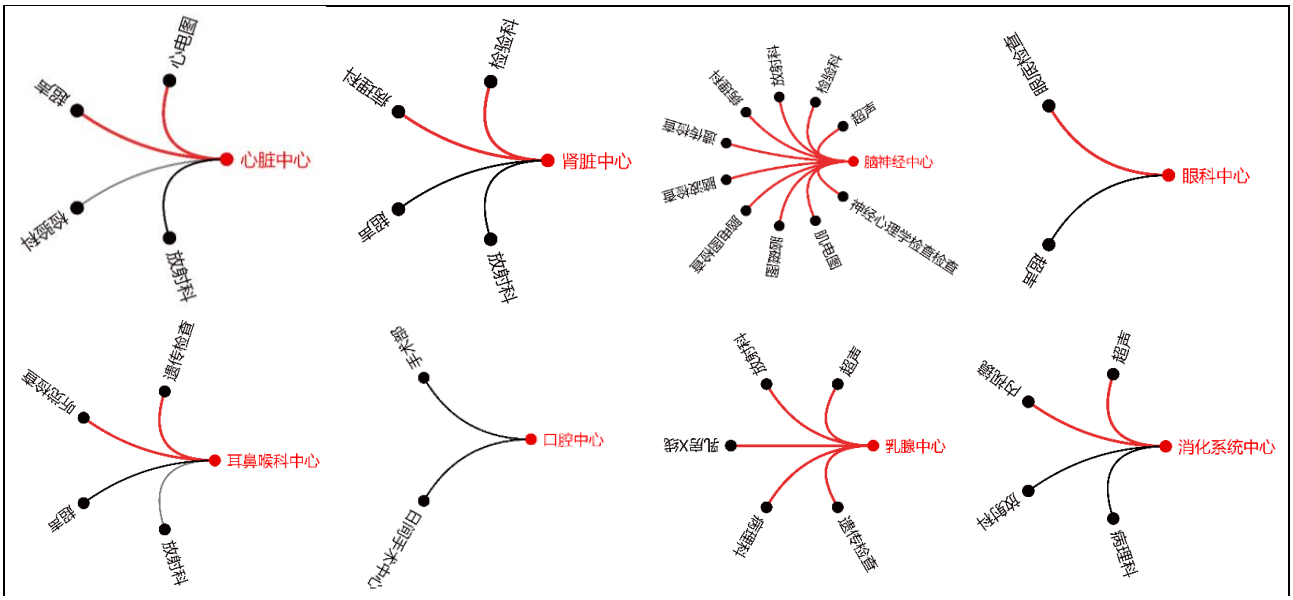


图 4-44 “诊疗中心”门诊诊疗与医技部门关系图
图片来源：作者自绘



中国知网 https://www.cnki.net

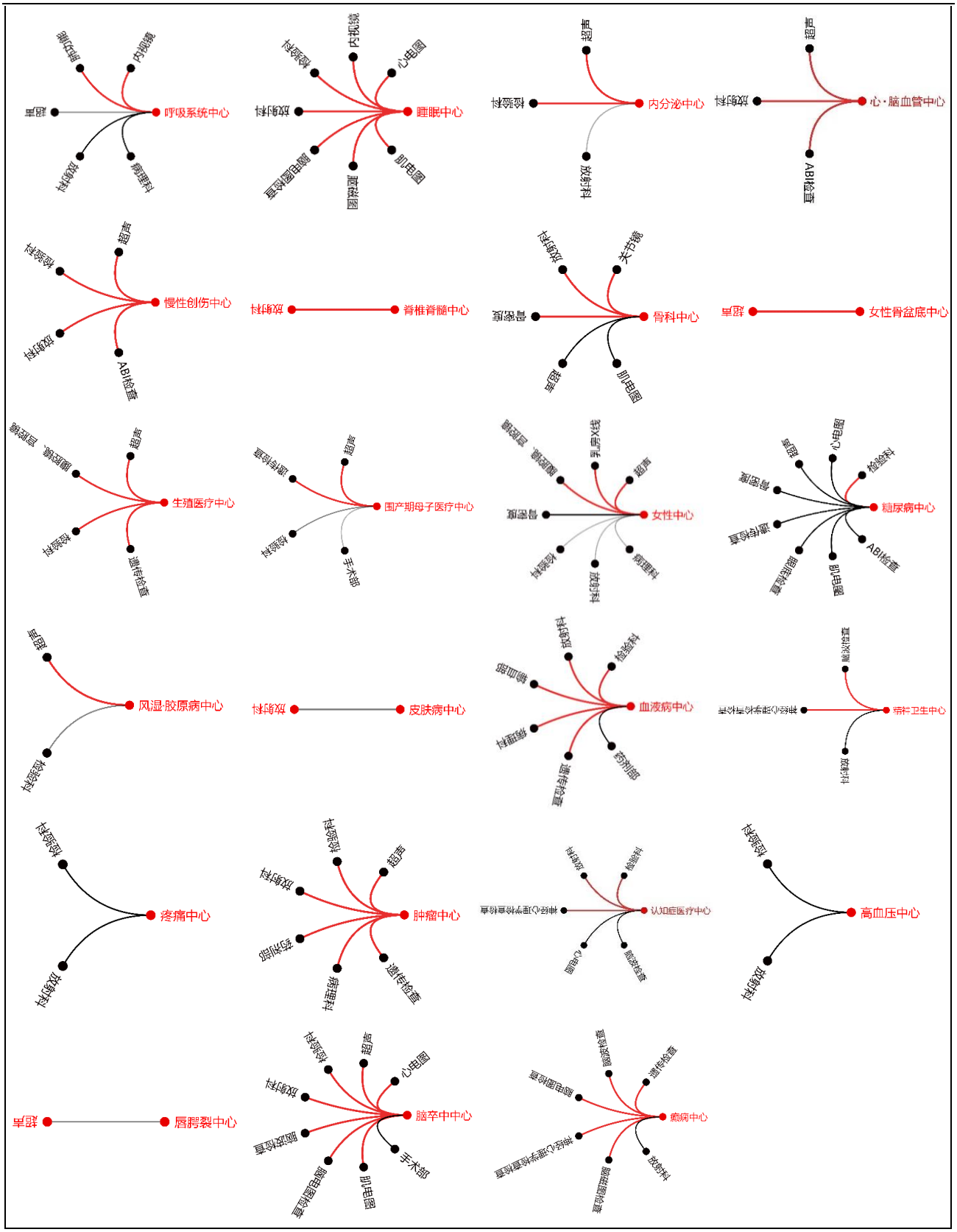


图 4-45 各“诊疗中心”门诊诊疗涉及医技部门关系图

图片来源：作者自绘

注：图中红色连线表示诊疗中心门诊诊疗主要涉及医技部门，黑色和灰色表示诊疗中心门诊诊疗少部分涉及到的医技部门，其中灰色表示涉及程度相比黑色更弱。

中国知网 https://www.cnki.net

3） “诊疗中心”间相互关系

诊疗中心式医院布局，往往不会仅仅考虑单个“诊疗中心”的布局，其必然会与其他“诊疗中心”存在一定的科室关联。与 4.12 单个科室可能构成“诊疗中心”不同的是，“诊疗中心”间的关系，往往是医院有意向成立哪些“诊疗中心”后，或以“诊疗中心”视角全面涵盖其他相关中心出发产生的。构建和把握“诊疗中心”间的关系能够帮助设计师进行合理功能布局，进而达到提高医护工作效率，共用医护资源，方便患者诊疗的目的。“诊疗中心”之间的相互关系详见表 4.14 和图 4-46，各“诊疗中心”间的关系，见图 4-47。

表 4.14 “诊疗中心”间相互关系表

	心脏中心	肾脏中心	脑神经中心	眼科中心	耳鼻喉科中心	口腔中心	乳腺中心	消化系统中心	呼吸系统中心	睡眠中心	内分泌中心	心·脑血管中心	慢性创伤中心	脊椎脊髓中心	骨科中心	整形中心	女性骨盆底中心	生殖医学中心	周产期母子医疗中心	女性诊疗中心	儿童医疗中心	糖尿病中心	过敏中心	风湿·胶原病中心	皮肤病中心	血液病中心	精神卫生中心	疼痛中心	肿瘤中心	认知症中心	高血压中心	唇腭裂中心	脑卒中中心	癫痫中心
心脏中心	—									2		2	2																		2			
肾脏中心		—																													2			
脑神经中心			—							2		2		2														3	2	2			2	2
眼科中心				—																		2	3											
耳鼻喉科中心					—					2													3						3			2		
口腔中心						—				2												5							2			2		
乳腺中心							—				2									2									2					
消化系统中心								—								5												2					
呼吸系统中心									—	2													2					2		2			
睡眠中心	2		2		2	2			2	—	5											5					3						
内分泌中心							2			5	—		5							5		2								5			
心·脑血管中心	2		2									—	3																			2	
慢性创伤中心	2										5	3	—		3	2						2			2								
脊椎脊髓中心			2											—	2													5					
骨科中心													3	2	—													3					
整形中心													2			—									2						2		
女性骨盆底中心								5									—	3		2													
生殖医学中心																	3	—	2	2													
周产期母子医疗中心																		2	—	2	2	5					2				2		
女性诊疗中心							2				5						2	2	2	—									2		5		
儿童医疗中心																			2		—		2								2		2
糖尿病中心				2		5				5	2		2						5			—							5	5			
过敏中心				3	3				2												2		—	3	2								
风湿·胶原病中心																							3	—						3			
皮肤病中心													2			2							2		—				3				
血液病中心																										—			2				
精神卫生中心										3									2								—	3	3	2			2
疼痛中心			3											5	3												3	—	2				
肿瘤中心			2		3	2	2	2	2											2					3	2	3	2	—				
认知症中心			2																			5				2			—				
高血压中心	2	2							2		5											5		3						—			
唇腭裂中心					2	2										2			2	5	2										—		
脑卒中中心			2									2																				—	
癫痫中心			2																		2						2						—

注：诊疗中心与诊疗中心的关系往往是由诊疗中心构成科室而形成的关联，所以诊疗中心与诊疗中心的关系值从 2 开始，数字越大表示关联度越低。

表格自制

中国知网 https://www.cnki.net

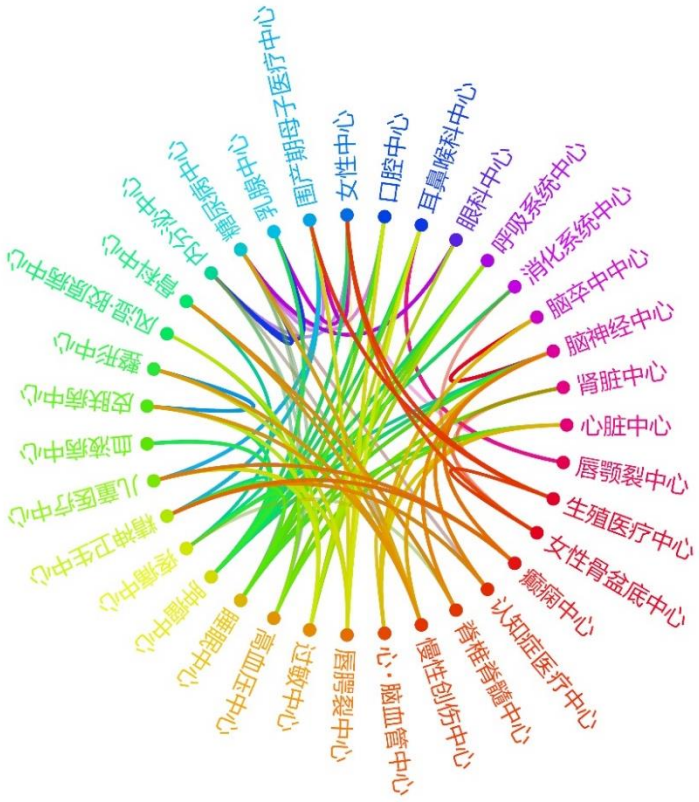
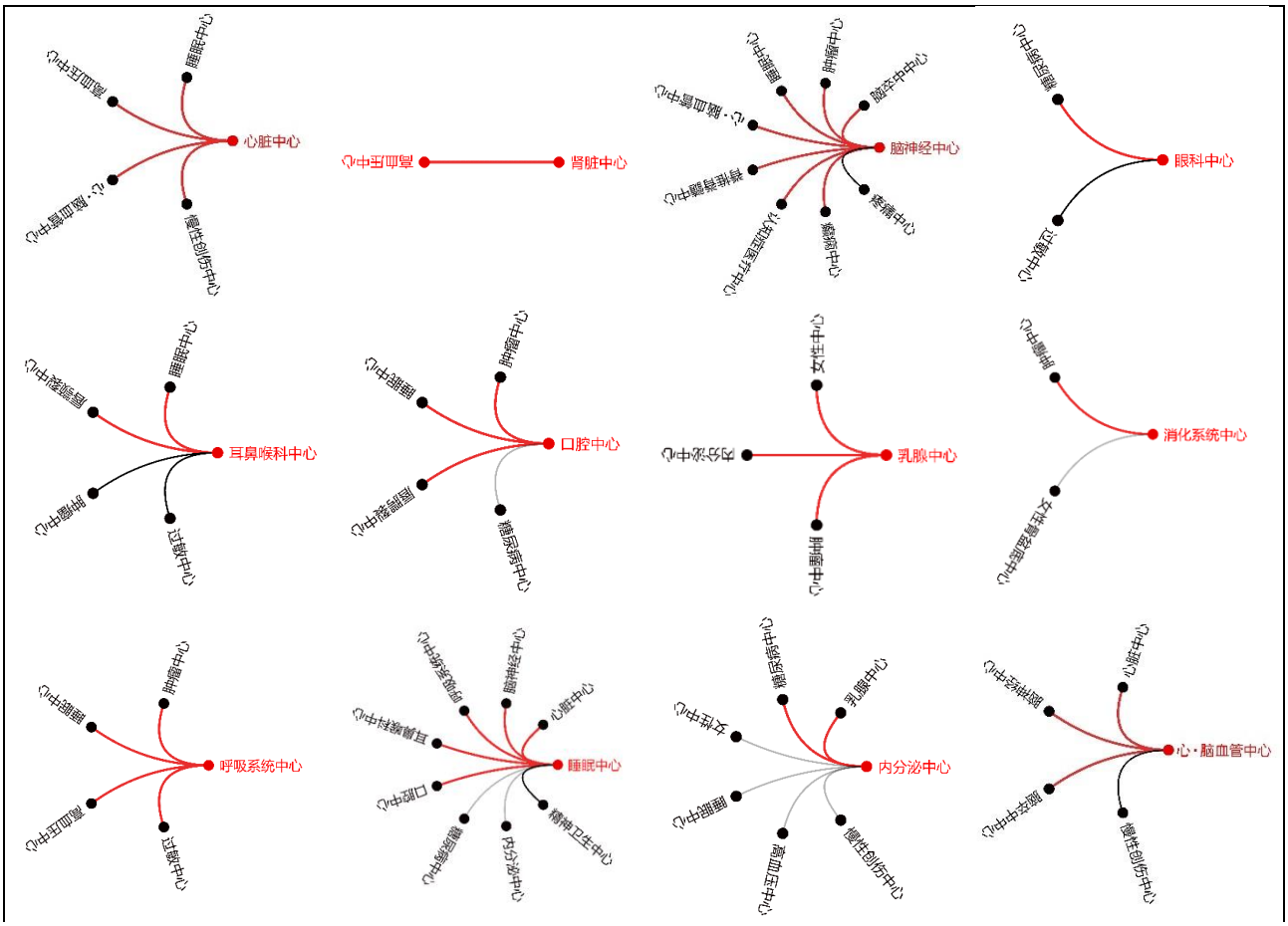


图 4-46 “诊疗中心”间相互关系图
图片来源：作者自绘



中国知网 https://www.cnki.net

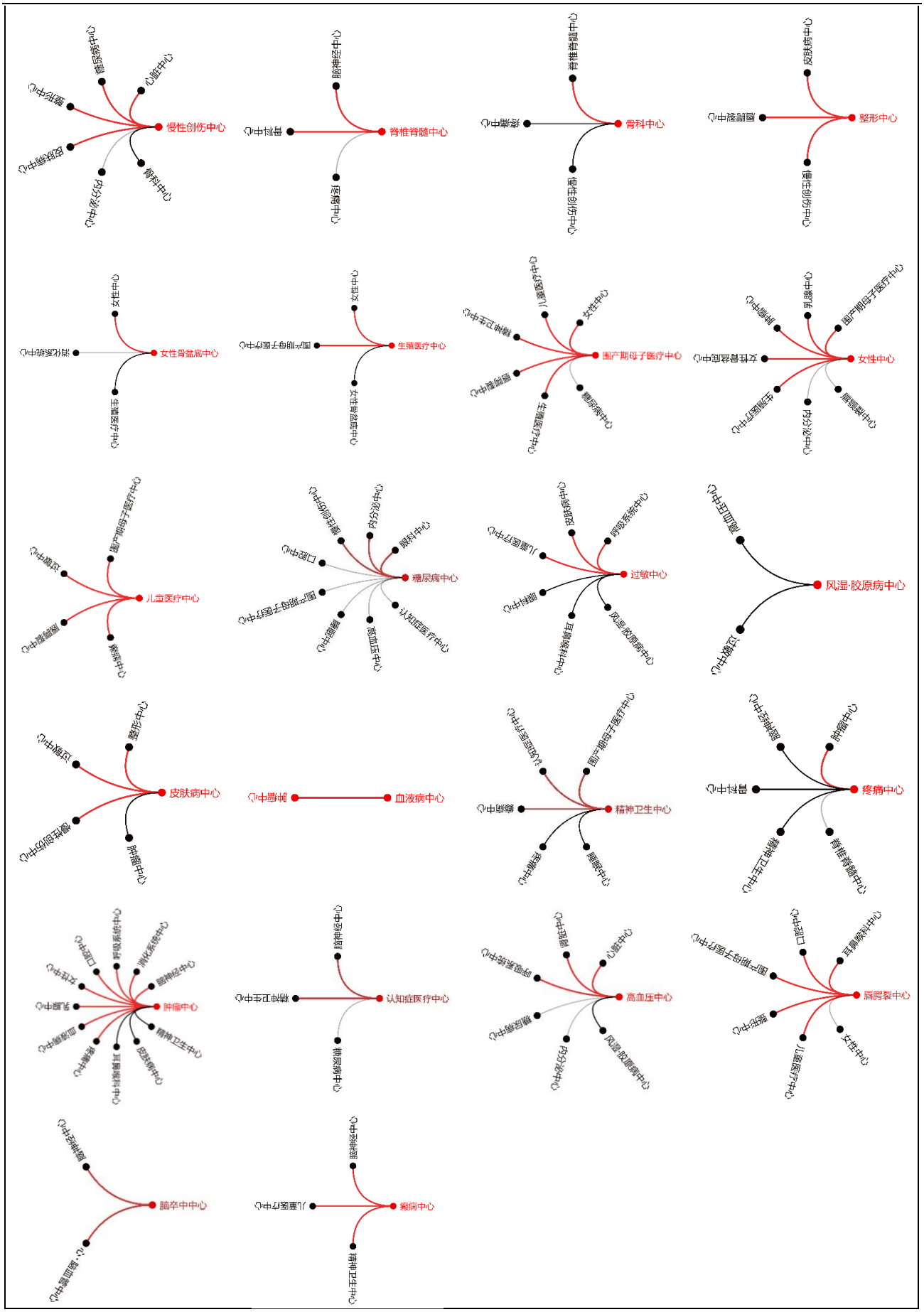


图 4-47 各“诊疗中心”间相互关系图

图片来源：作者自绘

注：图中红色连线表示诊疗中心间联系较紧密，黑色和灰色表示诊疗中心间联系较弱，其中灰色表示关联度相比黑色更弱。

中国知网 https://www.cnki.net

4） 小结

通过构建诊疗中心式医院的科室构成、关联科室、涉及医技和与其他“诊疗中心”间的关系，有助于设计师进行以“诊疗中心”为基础的相关科室和医技邻近布局的诊疗中心式医院的功能配置和平面布局，进而方便多科就诊患者的诊疗和为医院成立诊疗中心打下基础。

4.4.2 平面布局

科室构成是诊疗中心式医院平面布局的基础。设计师需与院方紧密联系，在全面了解医院医师资源、设备资源、空间资源等情况下，进行诊疗中心式医院平面的合理规划。本节通过不针对某个诊疗中心的抽象的“诊疗中心”理念，提出单“诊疗中心”医院平面布局和多“诊疗中心”医院平面布局模式，探讨诊疗中心式医院门诊部平面布局可能，供设计师快速合理的进行平面选型，进行平面布局。

诊疗中心式医院平面布局涉及到“诊疗中心”与相关科室、与相关医技部门、以及与相关病区的位置关系，而由于这三者与“诊疗中心”间平面布局关系基本类同，本章将主要以“诊疗中心”与相关医技间平面布局关系为例，进行阐述，其他两类，不做赘述。

1） 单“诊疗中心”平面布局类型

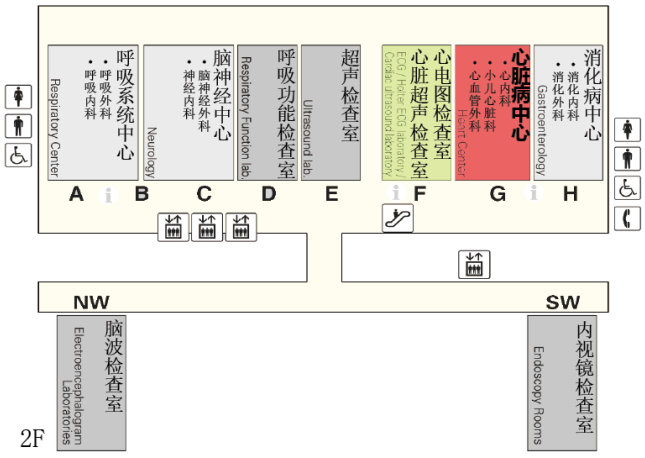
通过考察各医院各诊疗中心平面布局，提出单个“诊疗中心”涉及科室与医技部门平面布局类型三种方式：临近式、内置式和混合式，以帮助设计师进行诊疗中心式医院布局的选型。

a） 邻近式

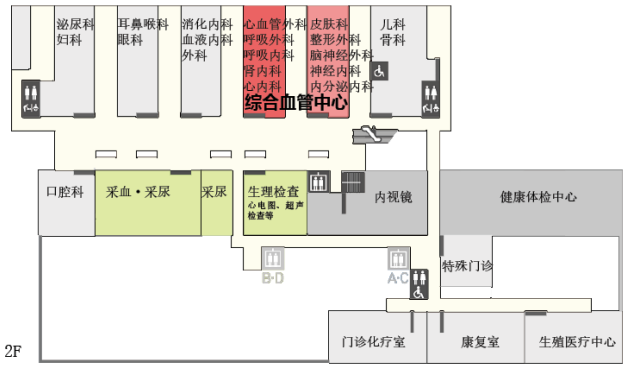
邻近式主要指平面上“诊疗中心”与相关医技部门邻近设置，包括直接邻近、通过走廊隔开形成的间接邻近或对面邻近、以及既包括直接邻近又包括间接邻近的混合邻近布局类型。见表 4.15。

邻近式平面布局的优势在于其能够便于患者就近检查，且通过医技部门的全院共用，节省人力成本和提高设备使用率，但患者需与其他科室或中心前来检查的患者共同等待。这就需要院方解决患者等待时间等问题，设计师解决好患者等待空间等问题。

表 4.15 单“诊疗中心”医院邻近式平面布局

主要类型	布局示意图	案例
直接邻近		 東京女子医科大学病院

中国知网 https://www.cnki.net

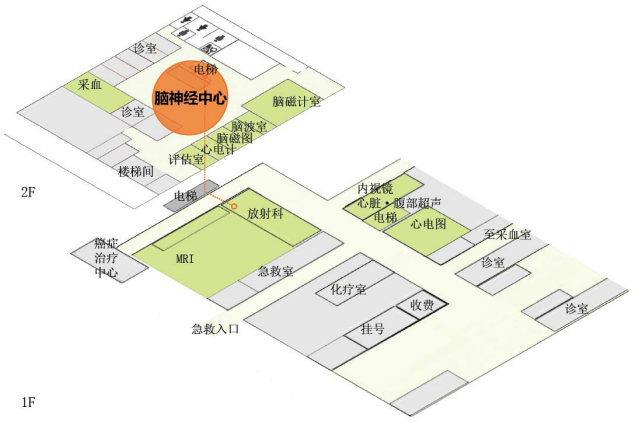
2. 间接邻近（对面邻近）		 立川綜合病院
3. 混合邻近		 国際医療福祉大学三田病院

注：图表自制

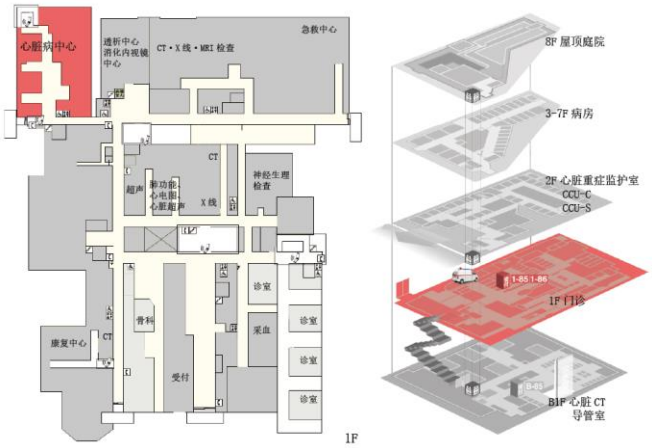
b） 内置式

内置式指“诊疗中心”内设相关医技部门，有条件的医院还会考虑将“诊疗中心”独栋设置。见表 4.16。此种布局的优势在于患者在“诊疗中心”内部即可实现诊疗一体化，不用在医院到处检查，但此种布局往往需要医院有较为雄厚的技师资源、设备资源和空间资源。

表 4.16 单“诊疗中心”内置式平面布局

主要类型	布局示意图	案例
1. 医技内设		 潤和会記念病院

中国知网 https://www.cnki.net

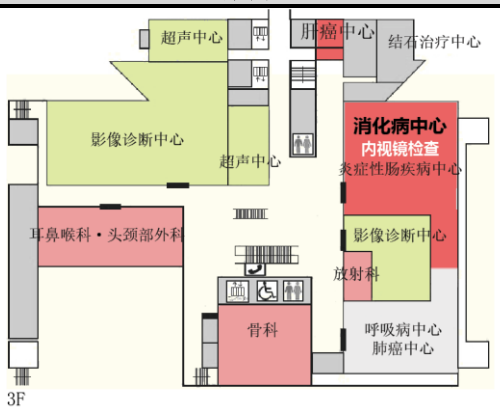
S：独栋布置	诊疗中心栋 门诊楼	 岩手医科大学附属病院
	诊疗中心栋 门诊楼	 倉敷中央病院

注：表格自制

c） 混合式

混合式往往综合临近式和内置式两种布局的特点，“诊疗中心”内设诊断疾病频率较高的医技部门，其他相关医技部门邻近设置。见表 4.17。此种布局有利于医院综合配置医师资源、设备资源和空间资源，方便患者就医和医院高效运营。

表 4.17 单“诊疗中心”混合式平面布局

主要类型	布局示意图	案例
I：主要医技内设，关联医技邻近	相关医技 或科室 或病区 诊疗中心 主要医技	 久留米大学病院

注：表格自制

中国知网 https://www.cnki.net

2） 多“诊疗中心”平面布局类型

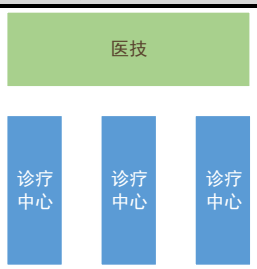
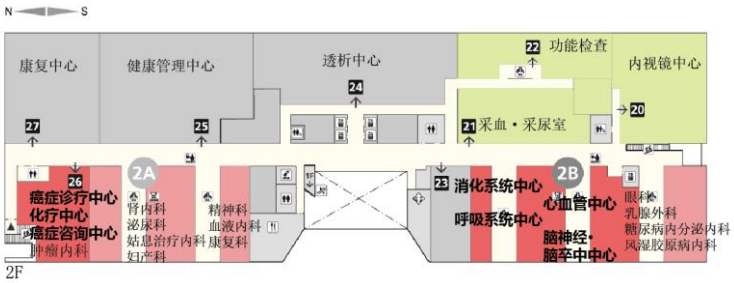
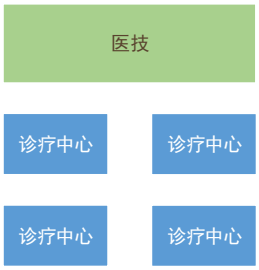
考虑到医院“诊疗中心”的数量往往不止一个，而这些“诊疗中心”间极有可能共用科室或医技部门，现提出多“诊疗中心”平面布局类型。而多“诊疗中心”平面布局模式的确立往往建立在单“诊疗中心”平面布局模式的基础上。通过考察上文日本医院多诊疗中心的平面布局模式，提出多“诊疗中心”医院平面布局四种模式：平行式、分层式、渗入式和组团式。

a） 平行式

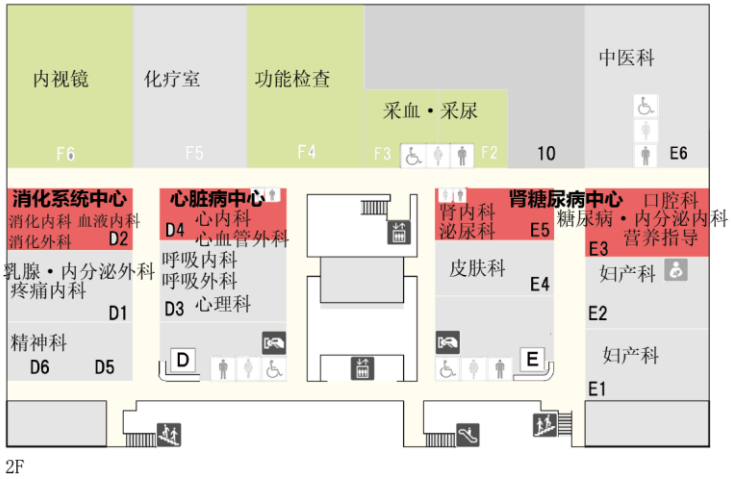
平行式布局模式主要是指“诊疗中心”与医技部门分别相对集中平行式平面分布，又分为短向平行布局、长向平行布局、两侧平均布局和围合式平面布局等，见表 4.18。对于医技相对集中设置的平行式布局模式，即使其与“诊疗中心”间由走廊相隔，但患者仍能轻易识别检查空间位置。

一般情况下，考虑到医院建设空间局促和单层平行布局模式易导致患者步行距离过长而影响患者就医体验，降低医院效率的问题，医院建设往往采用多层平行式设置，具体情况可参见多“诊疗中心”组团式布局模式。

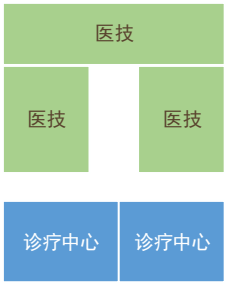
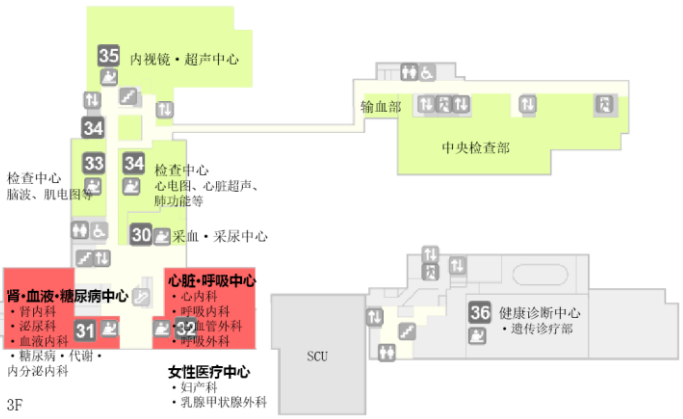
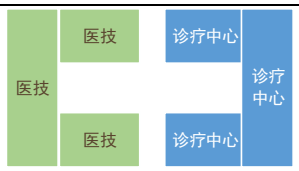
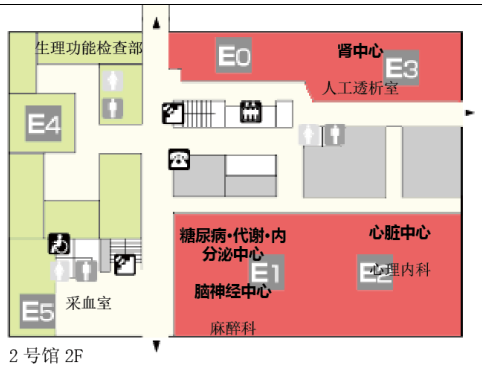
表 4.18 多“诊疗中心”平行式平面布局

主要类型	布局示意图	案例
1. 短向平行		 淀川キリスト教病院
2. 平行式、长向平行		 千葉大学医学部附属病院

中国知网 https://www.cnki.net

3.邻近式、长向平行	医技 诊疗中心 诊疗中心 诊疗中心 诊疗中心 诊疗中心 诊疗中心	 愛媛県立中央病院
4.两侧平行	诊疗中心 诊疗中心 诊疗中心 医技 诊疗中心 诊疗中心 诊疗中心	 千葉メディカルセンター
5.单围合式平行	医技 诊疗中心 诊疗中心 诊疗中心 诊疗中心	 順天堂医院

中国知网 https://www.cnki.net

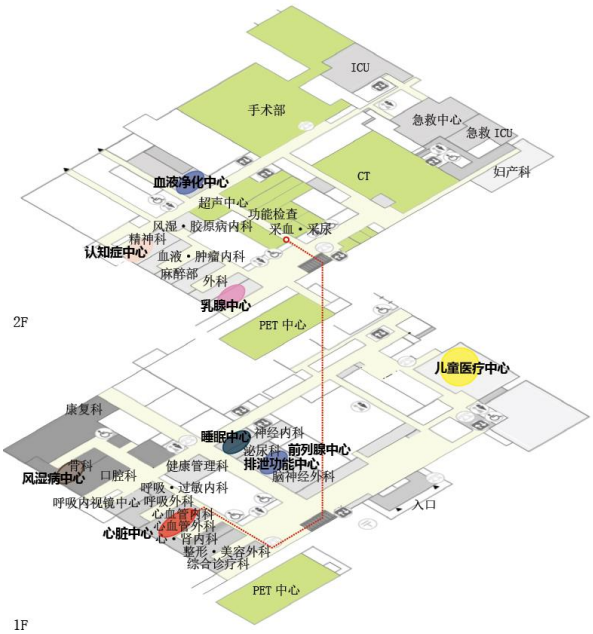
6. 医技单围合式平行		 川崎医科大学附属病院
7. 双围合平行		 東邦大学医療センター 大森病院

注：表格自制

b) 分层式

分层式布局模式指“诊疗中心”和医技部门分层设立，即“诊疗中心”单独一层，医技中心单独一层。见表 4.19。此种布局模式有助于节省平面空间、有助于学科间紧密合作、有助于医技部门的集中利用等，但需要做检查的患者要到不同楼层诊疗，无形中增加了医院患者的走动和医院的交通负荷。

表 4.19 多“诊疗中心”分层式平面布局

主要类型	布局示意图	案例
1.【诊疗中心】单层设置，医技部门单层设置		 獨協医科大学病院

注：表格自制

中国知网 https://www.cnki.net

c) 渗入式

渗入式布局模式指相关医技部门成集中式布局，“诊疗中心”根据自身与相关医技紧密程度，有选择的邻近相关医技布局，见表 4.20。医技部门的集中布置，便于医院设备高效利用和集中管理，“诊疗中心”插入式的布局，方便患者一站式诊疗。这往往需求“诊疗中心”科室配置相对完善，或相关科室邻近“诊疗中心”布置，否则不利于“诊疗中心”间的合作。

表 4.20 多“诊疗中心”渗入式平面布局

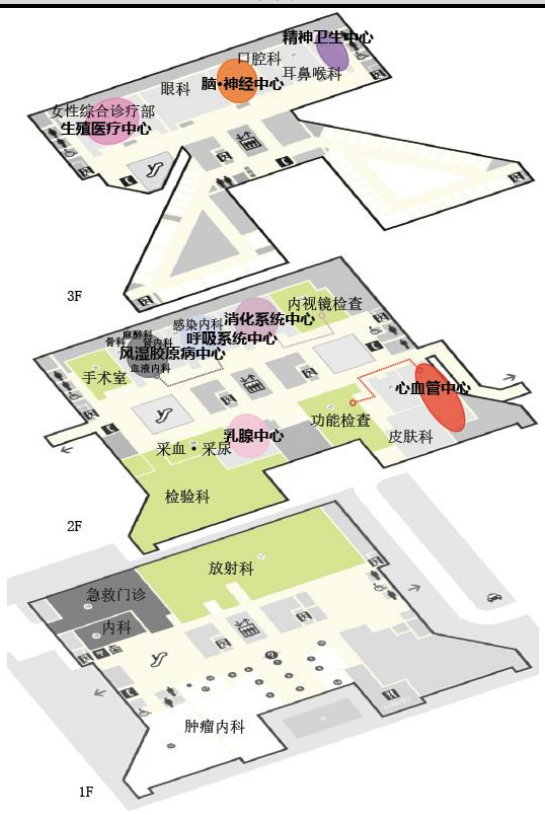
主要类型	布局示意图	案例
1.【诊疗中心】被医技部门包裹		 济生会横浜市東部病院

注：表格自制

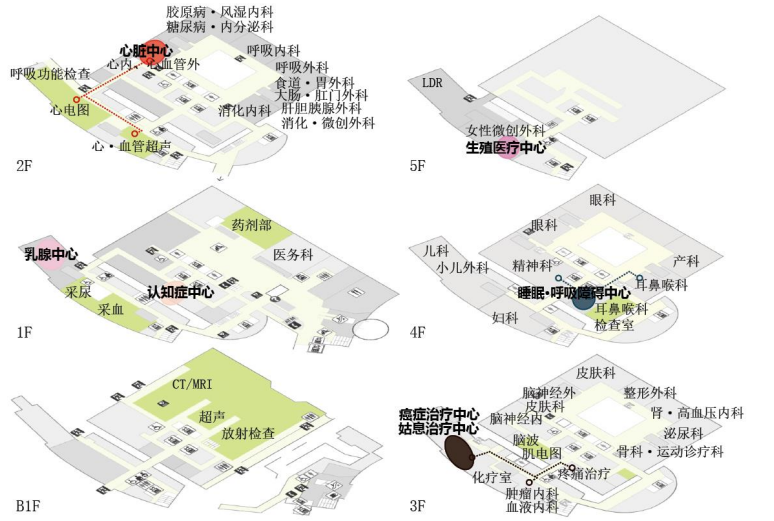
d) 组团式

组团式布局模式是多诊疗中心布局中常用的模式，对于多“诊疗中心”医院的建设也更具参考价值。组团式布局可以由一个个“诊疗中心”邻近其相关医技组团式排布，也可以由多个“诊疗中心”共同邻近相关医技组团式排布，此种布局模式既增加了平面布局的灵活性，又方便患者就近一站式诊疗。见表 4.21。

表 4.21 多“诊疗中心”组团式平面布局

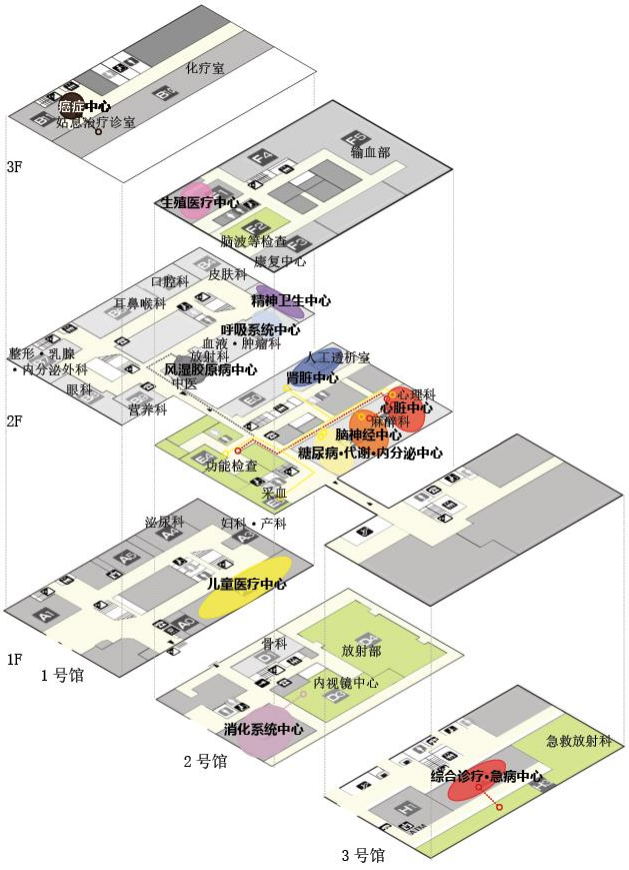
主要类型	布局示意图	案例
1.各【诊疗中心】与相关医技邻近组团化设置		 聖路加国際病院

中国知网 https://www.cnki.net



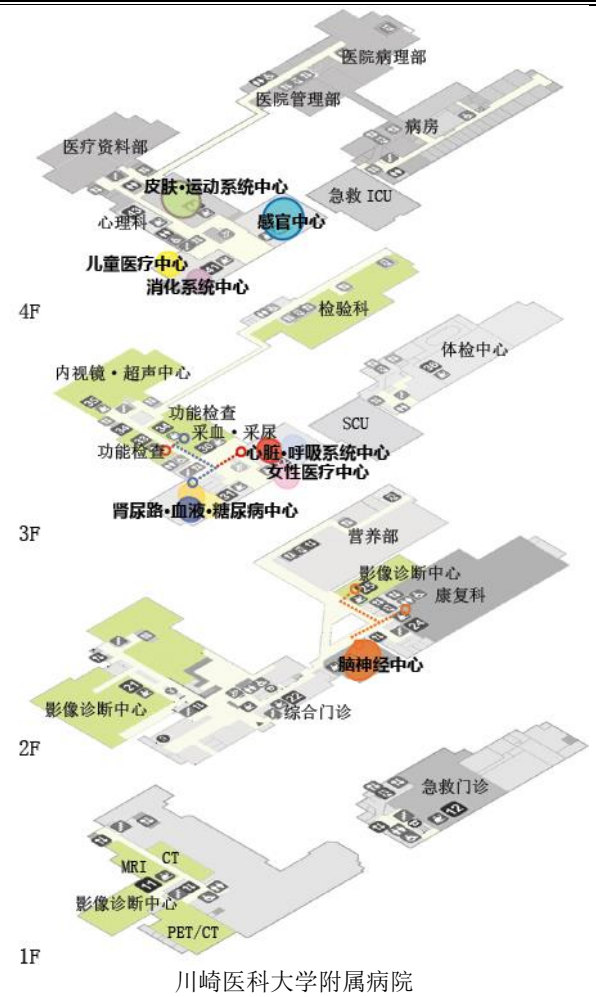
順天堂医院

2. 多【诊疗中心】与医技组团化设计



東邦大学医療センター　大森病院

中国知网 https://www.cnki.net



川崎医科大学附属病院

注：表格自制

3） 小结

无论是单“诊疗中心”平面布局模式还是多“诊疗中心”平面布局模式，都需要设计师在整体考虑建设空间、设备资源、门诊量等前提下，综合运用，以建设出方便患者诊疗，方便医护交流和提高医院整体运行效率的高质量医院。

4.4.3 诊疗中心式医院平面设计思路

诊疗中心的建立能够有效的整合医护、设备等医疗资源，便于患者一站式诊疗，但却需要医院诊疗体制的配套，即便如此，按照诊疗中心相关科室、医技邻近布局模式进行医院设计，则更便于多科就诊患者就近诊疗，便于医院诊疗中心的顺利开设。鉴于目前国内外诊疗中心的建设处于探索阶段，以及国内鲜有按诊疗中心模式建立的医院，通过上文的研究整理，提出诊疗中心式医院前期平面设计流程，供院方和设计师们参考，见图 4-47。

首先院方应根据自身规模、医护资源、优势科室、患者数量等情况，决定是否会建设“诊疗中心”？可能建设哪些“诊疗中心”？建设多少“诊疗中心”？其次，设计师需与院方讨论“诊疗中心”需要哪些科室，关联哪些科室，常用医技设备情况，以便设计师邻近布局；之后设计师应对“诊疗中心”进行相互关系考察，以便于“诊疗中心”间邻近合作；最后，可参考单“诊疗中心”医院平面布局模式和多诊疗中心平面布局模式，根据医院空间、资源、人力等情况，因地制宜的进行设计。

暨此，建立起一套较为完善的诊疗中心式医院功能配置和平面设计思路，希望便于多科就诊患者诊疗，方便到医院各处检查的患者就近检查，便于医院诊疗中心体制的开展，便于

中国知网 https://www.cnki.net

设计师开展医疗建筑平面布局设计，以建设出真正以患者为中心的高效高品质的医院项目。

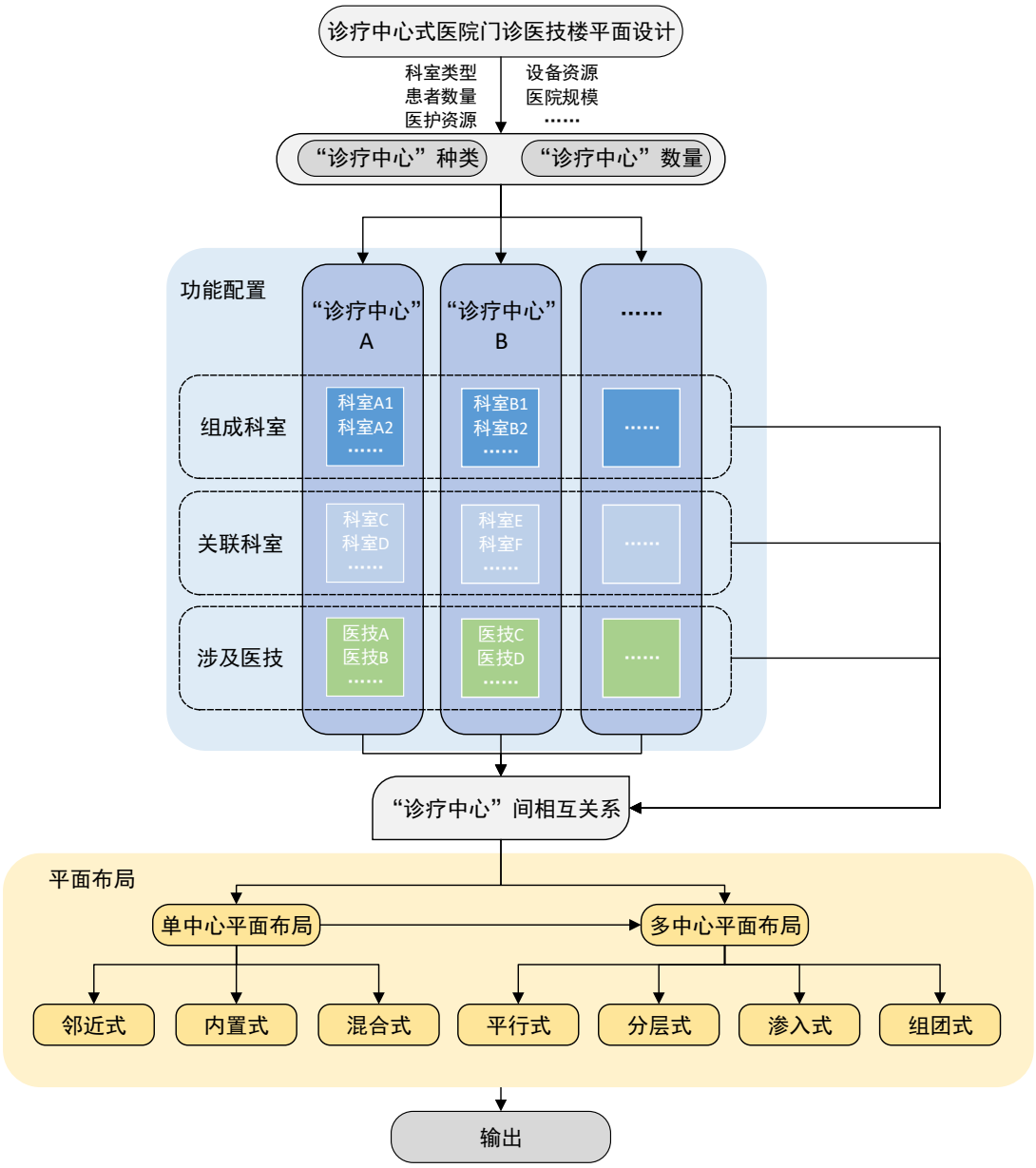


图 4-48 诊疗中心式医院门诊医技楼前期功能配置及平面布局设计流程图
图片来源：作者自绘

4.5 小结

医院的诊疗体制和各科的专业特征，直接决定了医院诊疗中心的建设与否。科室间联合中心化诊疗和单科科室对某类疾病专业化的诊疗是医院成立诊疗中心的内在原因。医院科室构成则决定了医院诊疗中心建设的数量和种类。与医院科室建设有一定时间性一样，各医院诊疗中心的建设也有一定的时间性，各医院会统筹各科患者数量和多科就诊患者数量和各科医师资源等现实状况，针对性的设置诊疗中心。且诊疗中心建设的时间性会影响医院新门诊医技楼的设计：在新建门诊医技楼之前就设立诊疗中心的医院，会沿用诊疗中心的理念，更针对性的布局诊疗中心和相关科室及医技；在新建门诊医技楼之后成立诊疗中心的医院，若建设之前考虑相关科室和医技相邻布置时，在方便患者诊疗的同时，也便于诊疗中心的开展，若未考虑到之后会出现诊疗中心，仍按照内外科布局的医院，则会出现诊疗中心诊疗体制与

中国知网 https://www.cnki.net

平面布局之间的矛盾，此时，有的医院会根据诊疗中心进行时时的修改和建设。

医院诊疗体制直接影响患者就诊流程，分科诊疗制往往利于单疾病患者的诊疗，不利于需多科就诊患者的诊疗，但相关科室邻近能减少多科就诊患者步行距离和利于患者寻找相关科室；中心制则能便于患者一站式诊疗，但往往需要预约诊疗，可能造成医师资源浪费；双轨制综合分科诊疗和中心制的优点，利于患者诊疗和提高医疗效率，但需克服医院传统内外科分开管理体制的束缚和因某特殊疾病患者临时加塞而导致其他患者不满等问题。相较而言，双轨制更利于患者诊疗和提高医疗效率，而医院按照相关科室、医技邻近布局的方式则能更方便患者诊疗。

但无论医院诊疗中心建设与否，按照诊疗中心思路进行相关科室、医技邻近的设计方法进行医院设计，更能方便多科诊疗、提供医疗效率和医院诊疗中心的建设。因此，提出诊疗中心式医院平面设计方法，帮助设计师通过“诊疗中心”的概念，了解医院科室间的关系，科室与医技关系，以及与其他“诊疗中心”间的关系，在统筹考虑医院科室特色、设备资源和空间资源等前提下，设计出更便于患者邻近检查、诊疗，便于医护交流和提高医院整体运行效率的高质量医院。

中国知网 https://www.cnki.net

第 5 章 结论

5.1 结论

医疗领域的学科整合和新时代多疾病患者的增加直接促成了医院诊疗中心的设立和医院科室、医技部门的关系调整，相关科室、医技邻近布局的做法为新时代医院建设的方向。文章紧跟医学多学科合作诊疗模式前沿，率先从诊疗中心层面对不同类型诊疗中心总结，为国内外诊疗中心建设和科室、医技关系的调整提供理论和实践基础；从医院诊疗中心配置层面对不同规模、不同类型医院诊疗中心配置布局总结，为国内外各类医院（包括综合医院、专科医院等）诊疗中心配置和医院科室、医技部门关系调整提供理论和实践基础，为可预见的近期未来医院建设打下基础。

针对疾病类别建设的诊疗中心模式对构建整个国家甚至全球医疗体系、疾病网络具有重要作用、对促进全人类健康协同发展的重要意义。

从诊疗中心层面对医院各科室、医技关系的研究，到医院层面诊疗中心配置研究，再到医疗体系层面以诊疗中心为基础架构国内、国际间联系的方式，为其他朝精细化分科的学科领域，如土木建筑学、信息科学等，提供横构各学科间关系的研究方法。

5.1.1 诊疗中心层面

不同类型诊疗中心由于诊疗疾病类别的不同，主要分为脏器中心、系统中心和疾病中心。由于诊疗疾病的不同，各类诊疗中心科室构成、相关医技各有特色，为国内外各类型医院（综合医院、专科医院等）各类别诊疗中心建设和科室、相关医技设置布局提供实践和理论依据：

1.脏器中心：主要诊疗特定脏器器官疾病，如心脏（心血管）中心、肾脏中心和脑神经中心等。科室构成主要由合作诊疗脏器器官的内外科组成，诊疗中心内往往内设主要检查设施或邻近相关医技部门布置，由于科室完整和诊疗疾病的相对专一性，各脏器中心可选择独栋或独立区域布局或邻近住院部布局，以方便患者门诊——住院一体化诊疗。

2.系统中心：主要诊疗疾病为身体特定系统疾病，如消化系统中心、呼吸系统中心和生殖医疗中心等。科室构成主要由合作诊疗该身体系统的科室组成，该类中心往往内置相关检查设备或邻近相关医技部门布局，科室构成较完善的系统中心可独立区域布局。

3.疾病中心：主要诊疗某类特殊的疾病，如糖尿病中心、肿瘤中心和脑卒中中心等。由于该类疾病极易引发各种并发症，所以该类中心往往需要跨部门多科室合作对患者进行整体性诊疗，除主要诊疗科室外，疾病中心常邻近易发生并发症的科室布局。

此外，还有某些诊疗中心出于对患者隐私和安全性考虑，倾向于单独布置，如生殖医疗中心、精神卫生中心和儿童医疗中心等。

5.1.2 医院层面

随着医院多学科合作诊疗的开展，诊疗中心的逐步建立，使得医院需要根据自身规模、定位合理设置一定数量和种类的诊疗中心，并根据医院的空间、设备等资源，进行合理的科室、医技位置关系调整。通过研究各医院诊疗中心配置数量、种类和平面布局特征，为未来各类型医院（综合医院、专科医院等）建设诊疗中心、科室和医技关系调整提供理论依据和实践基础。

1.诊疗中心设置数量：

1）诊疗中心的设置数量与医院的规模成正相关，即医院的床位数越多，诊疗中心的设置数量越多。日本 20-199 床规模医院诊疗中心数量设置在 3 个左右；200-399 床规模医院诊疗

中国知网 https://www.cnki.net

中心数量设置在 4 个左右；400-599 床规模医院诊疗中心数量设置在 5 个左右；600-799 床规模医院诊疗中心数量设置在 7 个左右；800 床以上规模医院诊疗中心设置数量在 9 个左右。为国内外各规模医院设置多少诊疗中心提供参考。

2）诊疗中心的设置数量与医院的等级相关，一般医院的机能或级别越高，诊疗中心的设置数量越多。日本特定机能医院诊疗中心的设置数量在 9 个左右；地域支援医院诊疗中心数量设置在 6 个左右；一般医院诊疗中心数量设置在 4 个左右；高度综合医疗设施诊疗中心的设置数量在 5 个左右；国立高度专门医疗研究中心诊疗中心的设置数量在 6 个左右。为国内外各类型医院设置多少诊疗中心提供参考。

2.诊疗中心设置种类：

1）诊疗中心的设置种类与医院的规模相关，各种规模的医院个别诊疗中心的设置偏好有一定差异。规模越低的医院（20-199 床）越常设置脏器中心和消化系统中心；规模适中的医院（200-799 床）脏器中心、系统中心和疾病中心设置均衡，约各占 30%；大规模医院（800 床以上）多设置疾病中心。为国内外各规模医院设置哪些诊疗中心提供参考。

2）诊疗中心的设置种类与医院的等级相关，各等级医院诊疗中心的设置种类存在一定差异。等级越高的医院（特定机能医院和国立高度专门医疗研究中心）多设置疾病中心；一般医院（高度综合医疗设施、地域支援医院和一般医院）脏器中心、系统中心和疾病中心设置均衡，约各占 30%。为国内外各类型医院设置哪些诊疗中心提供参考。

3.诊疗中心的布局特征：

诊疗中心的布局跟各医院诊疗中心设置数量、种类、医院机能、医师资源、设备条件和空间资源等有关。

1）诊疗中心配置数量越少（大约在 2-3 个左右），诊疗中心的科室配置越完善，主要医技检查往往中心内设置或邻近中心设置，诊疗中心间联系较弱，越倾向独立布置；

2）诊疗中心配置种类主要为脏器中心或系统中心时，诊疗中心的科室配置越完善，主要医技检查往往中心内设置或邻近中心设置，诊疗中心间的联系较弱，越倾向独立布局；

3）诊疗中心配置数量在 5-6 个左右，脏器中心、系统中心和疾病中心较均衡时（约各占 30%），诊疗中心间往往出现一定的关联，相关诊疗中心间邻近布置，相关医技检查往往呈集中式邻近诊疗中心布局；

4）当诊疗中心配置数量多达到 9 个甚至更多，诊疗中心多设置疾病中心时，医院相关诊疗中心间往往邻近布局，相关主要医技检查则呈现分散式，邻近相关诊疗中心布局；

5）对大规模医院（800 床以上规模）或高等级医院（特定机能医院），部分医院出现多个诊疗中心合并成一个中心布置的情况，这往往跟邻近集中布置某些医技和诊疗特征有关。

6）对大规模医院（800 床以上规模）或高等级医院（特定机能医院或国立高度专门医疗研究中心），部分医院出现多量设置疾病中心的情况，这些中心往往集中、独立独层布置。

4.诊疗中心设置影响因素：

由于各医院医师资源等情况不同，诊疗中心设置存在不同，主要影响因素如下：

1）诊疗体制决定诊疗中心的建设。科室间联合中心化诊疗和单科科室对某类疾病专业化的诊疗是医院建设诊疗中心的主要原因。若可形成相关中心科室单独诊疗或针对某疾病专业治疗程度不够，医院不会设置相关诊疗中心。

2）医院科室数量和种类限制诊疗中心设置数量和种类。科室是诊疗中心的构成基础，医院要设置相关诊疗中心必须具有相关诊疗中心的必要科室。

3）诊疗中心的建设跟医院科室建设类似，具有一定的时间性。各医院根据科室的患者数量、相关科室间多科就诊患者数量和科室间合作频率等特点，逐步建设相关诊疗中心。

4）诊疗中心的设置理念及设置时间影响新医院门诊医技楼的建设：

a.在医院建设新门诊医技楼之前或之时设立或考虑设置诊疗中心，新门诊医技楼建设时以诊疗中心的模式，针对性的邻近布置相关科室和医技。

b.在医院建设新门诊医技楼之后成立诊疗中心的医院，若医院按照原先内外科分开布局

中国知网 https://www.cnki.net

方式，会出现诊疗中心体制与平面布局不对应的情况，中心化诊疗可呈先于单科受诊，后多科会诊的形式存在；若医院在新建诊疗中心的同时进行新门诊医技楼的修改建，诊疗中心可独立建设在新修建建筑内；若医院在新门诊医技楼建设之前就考虑到相关科室和医技邻近对方便患者诊疗，以及未来成立相关诊疗中心的可能，有利于医院未来改变诊疗体制而成立相关诊疗中心。

c.诊疗中心的种类和诊疗体制影响新医院门诊医技楼的建设。若医院建设的诊疗中心多为疾病中心，且诊疗中心的认识停留在会诊上，新医院门诊医技楼的建设仍多会停留在相关科室分离布局态势。

d.部分相关科室和医技相邻布局的做法，出现在其他未设置诊疗中心的新医院门诊医技楼的建设中，虽多以专科内外科即脏器中心式科室邻近布局的方法，但仍能方便患者就近诊疗，促进医护沟通、提高医护工作效率，并为以后医院开始相关诊疗中心打下物质基础。

6.诊疗中心体制特征：

医院门诊诊疗模式基本可分为分科诊疗制、中心制和双轨制三种：

1）分科诊疗制：适应于单疾病患者诊疗，不利于需多科就诊患者的诊疗，但相关科室相邻布局能减少多科就诊患者步行距离、方便患者找寻。

2）中心制：方便患者准确寻找中心，一站式诊疗，但可能造成医师资源浪费。

3）双轨制：综合分科诊疗制和中心制的特点，分科诊疗便于患者快速就诊、中心制便于患者检索、免去需多科就诊患者重复挂号、检查和多次缴费的困扰，由首诊医生负责与其他相关科室医生合作，全面全程诊疗患者，既方便患者又提高医疗效率，但需要克服医院传统内外科分开管理体制的束缚和因某特殊疾病患者临时加塞而导致其他患者不满等问题。

相较而言，双轨制更利于患者诊疗和提高医疗效率，且按照诊疗中心式相关科室、科室和相关医技邻近布局的方式更利于患者诊疗。

7.诊疗中心式医院平面设计方法：

诊疗中心式医院平面设计，不局限于医院是否建设诊疗中心，其基于患者医疗行为和需求，进行相关科室间、科室与相关医技间和“诊疗中心”间邻近布局，为新型医院建设提供方法论。

1）单个科室可构成一个或多个“诊疗中心”：各个医院都有自己的优势学科，在根据各自优势学科诊疗疾病特征设置相关“诊疗中心”时，应全面掌握该学科构成其他“诊疗中心”，邻近布置相关科室的可能，以保证医院医师资源的最优化利用和为未来建设相关诊疗中心留下余地。

2）“诊疗中心”由主要构成科室构成，并与其他科室合作诊疗：“诊疗中心”由主要诊疗科室构成。除了主要诊疗科室外，“诊疗中心”往往会跟其他相关科室合作诊疗某些特殊疾病。设计师和院方在“诊疗中心”科室配置时应统筹考虑主要构成科室和关联科室，邻近排布。

3）各“诊疗中心”均有主要医技检查：诊断疾病往往需要靠医技设备进行，每类诊疗中心由于诊断疾病不同，需要医技设备往往不同。在诊疗中心式医院布局时，设计师应明确各诊疗中心对应主要医技，考虑与诊疗中心邻近布局。

4）“诊疗中心”间由于共享某一科室或由于合作诊疗某一疾病的需要，相互间存在联系：诊疗中心式医院设计，使得“诊疗中心”构成的科室间由于诊疗某些疾病而形成合作关系。通过明确“诊疗中心”间关系，为医院未来多个诊疗中心合并为一个诊疗中心提供便利。

5）医院诊疗中心分单“诊疗中心”平面布局类型和多“诊疗中心”平面布局类型：单“诊疗中心”平面布局模式主要为单个诊疗中心布局提供选型依据，多“诊疗中心”平面布局模式为医院布局多个“诊疗中心”，进行科室、医技部门调整提供参考。

a.单“诊疗中心”平面布局模式：主要分为邻近式、内置式和混合式三种。其中邻近式布局往往医技资源共全院共用，“诊疗中心”邻近该医技布局；在医技设备资源充足和该医技在该“诊疗中心”利用率较高等情况下，医院会考虑该医技在“诊疗中心”内设置；

中国知网 https://www.cnki.net

混合式布局往往综合考虑医院医疗设备资源等情况，选择主要医技内设于“诊疗中心”，一些大型医技资源医院共用。

b.多“诊疗中心”平面布局：分为平行式、分层式、渗入式和组团式四类。其中平行式布局，医技相对集中设置，“诊疗中心”与之平行布局，便于患者寻找和诊疗；分层式布局，医技往往集中一层布置、诊疗在集中在其他层，这种便于设计师设计但不利于患者找寻，容易增加医院竖向交通压力；渗入式布局，医技相对集中设置，“诊疗中心”以插入的形式邻近主要相关医技，有利于患者就近诊断；组团式布局，医技检查室根据各“诊疗中心”需求呈分散式邻近相关“诊疗中心”布局模式，既增加了平面布局的灵活性，又方便患者一站式诊疗。

5.1.3 医疗体系层面

由于不同规模、不同类型医院诊疗中心设置数量和种类不同，且均有设置同一类诊疗中心的状况，因此可从不同规模、不同类型医院诊疗中心种类出发，构建医疗诊疗中心等级体制，分诊患者，减轻等级较高医院的接诊压力；从以疾病特征类别建设出发的诊疗中心角度，构架全国甚至全球分级诊疗中心疾病网，促进全国甚至全人类健康协同发展。

1.不同类型诊疗中心，分级诊疗体制的构建：一般规模越低、等级越低的医院越常设置脏器中心和系统中心，规模越大、等级越高的医院越常设置疾病中心，通过分化不同规模、类型医院诊疗中心类别，减轻等级较高、规模较大医院的接诊压力和增强等级较高、规模较大医院处理疑难杂症的能力，见图 5-1。

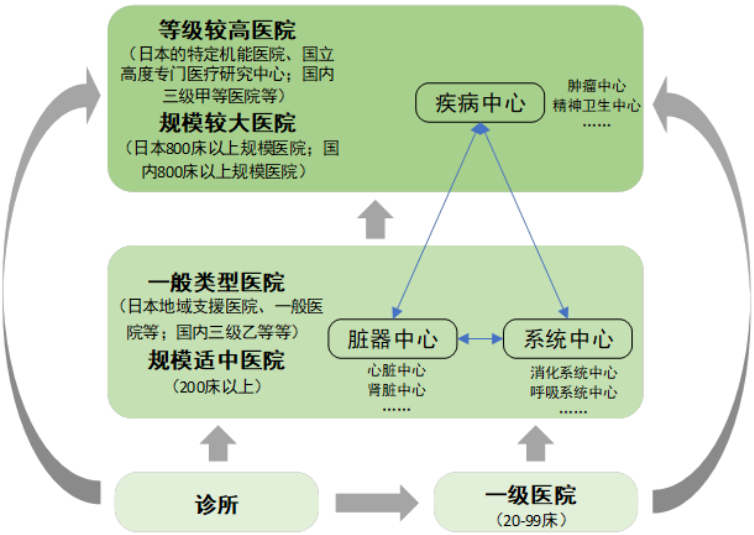


图 5-1 不同类型诊疗中心分级诊疗体制图

图片来源：作者自绘

2.同类型诊疗中心，分级诊疗体制和全球疾病诊疗网的构建：虽然各规模、各等级医院均有设置同类型诊疗中心，但诊疗的疾病能力仍会呈现一定的差距。且诊疗中心的出现，为统一国内外对某种疾病诊疗的科室提供了契机，为某一国家对某类疾病分级诊疗提供现实依据（图 5-2），为国际对某类疾病联合诊疗提供理论依据，有助于构建全人类相关类别疾病系统，促进人类健康协同发展（图 5-3）。

中国知网 https://www.cnki.net

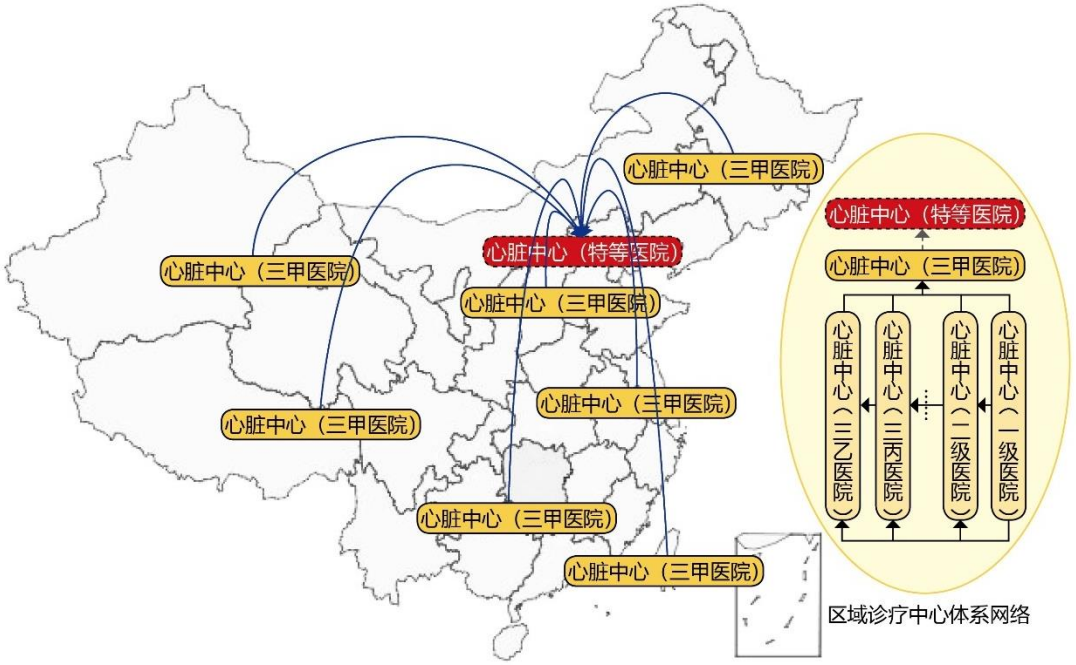


图 5-2 同类诊疗中心分级诊疗体制图（以心脏中心为例）
图片来源：作者自绘

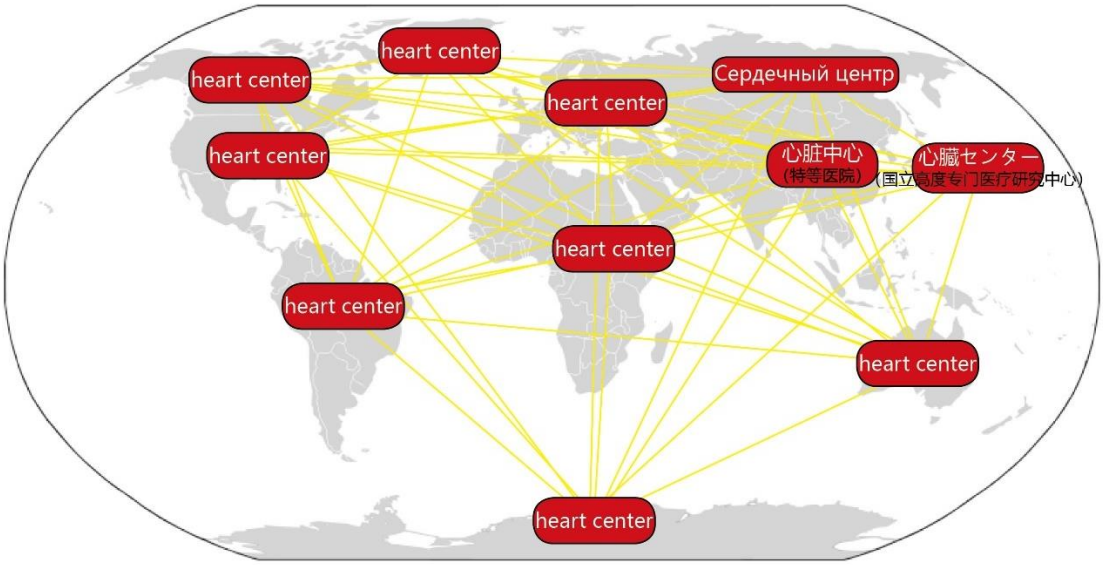


图 5-3 同类诊疗中心全球联络关系图（以心脏中心为例）
图片来源：作者自绘

5.1.4 理论层面

无论是医学领域还是其他学科领域，近年来均朝着专科细化和多学科合作方向发展，本文从医院诊疗中心建设入手，解明各医学精细的专科整合的方向和可能；通过医院层级讨论医院诊疗中心如何配置，学科间如何合作和布局；并从诊疗中心的视角窥探整个国家甚至全球医疗体系构成的可能；为其他学科领域开展学科整合提供研究方法和理论参考。

5.2 提案

1）医院建筑作为功能性很强的建筑设计类型，不仅仅需要设计师掌握一般建筑设计的方法，还应真正从患者行为、诊疗流程和医疗理念上理解医疗建筑的设计方法。以从根本上便

中国知网 https://www.cnki.net

于患者诊疗，提高医院工作效率，进而达到双赢的效果。

2）医疗建筑师在进行诊疗中心式医院建设时，应充分考虑医院科室特色、医护资源、设备资源和空间资源等先决条件，深刻明确院方建设需求，因地制宜的建设符合该医院特色的新型医疗空间。

3）医疗建筑师在规划医院时，应充分考虑医院未来体制改革和布局发生变化的可能，应具有预见性的进行医疗建筑的规划和设计，以使得建设的医院有更长的生命周期和生命活力。

4）诊疗中心作为满足新时代患者诊疗需求和医院学科发展的重要产物，虽面临传统医疗分科就诊的体制的阻碍，但是未来发展医院建设的方向和国家医疗体系规划的方向，各院方应即时的改革传统诊疗体制，以适应新时代的患者的需求和医学领域的发展。

5）以针对各类疾病特征的诊疗中心模式架构国家甚至国际社会分诊模式、构架国家甚至国际社会医疗体系和疾病网络具有相当的可行性，会为人类健康事业发展提供新动力。

6）对构架人类共同体的新时代诉求，不论是医学领域、建筑领域还是其他领域，都需要找到连接各地区、各国家的突破口，“诊疗中心”的架构为其他学科和领域的发展，提供了新思路。

5.3 今后研究课题

本研究主要针对当前时兴的中心化诊疗进行日本各诊疗中心科室配置、相关医技研究和平面布局研究基础研究，并提出相关科室、医技邻近的诊疗中心式医院的设计方法和以诊疗中心构架国家和国家社会医疗、疾病体系的可能。本文研究的局限性在于且不限于以下几点：

1）国际性：本文主要针对日本医院诊疗中心进行研究，对欧美及国内出现的更前沿或更先进的诊疗中心科室配置和相关医技检查未在文中涉及；

2）细致性：本文仅从科室和医技配置等大方向对诊疗中心设置进行研究，未涉及对各类诊疗中心空间及从使用者角度出发对诊疗中心设置进行考察，如眼科中心患者，视力往往不行，需要别人陪同，是否应设置相关陪护人员的空间等；

3）预见性：对诊疗中心设置后平面布局产生的问题没有研究，如诊疗中心化后诊疗中心等候区座位需求是否有变化？医技集中邻近诊疗中心布置后，医技中心座位布置是够有变化？各科室诊疗中心化后如何到达该中心即寻路系统新的发展方向未涉及；

4）深入性：从医疗体系层面架构全国甚至全球医院间关系尚待系统深入的研究。

希望在本研究的基础上，对上述问题进行更加专业和深入的研究。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] 张贵民.学科整合突围[J].中国医院院长,2012(09):36-41.

[2] 诸玲,万付梅,黄培.创新实践路径 加快“中心化诊疗”门诊服务建设[J].江苏卫生事业管理,2013,24(04):36-37.

[3] 龚小军.多学科整合促进综合医院可持续发展[J].中国医院,2013,17(02):59-60.

[4] 王魁英,谭映军,侯凯文,等.综合医院学科整合刍议[J].解放军医院管理杂志,2013,20(12):1181-1182.

[5] 张贵民.学科整合突围[J].中国医院院长,2012(09):36-41.

[6] 张贵民.学科整合突围[J].中国医院院长,2012(09):36-41.

[7] 杰恩·马尔金著.《医疗和口腔诊所空间设计手册》[M]:3 版.吕梅等译.大连：大连理工出版社，2005.5.

[8] Thompson P, Parenti C, Peterson L R. Planning the move of patient activities at a large medical center[J]. Journal of Healthcare Management, 1990, 35(3): 443.

[9] Radley A, Mayberry J, Pearce M. Time, space and opportunity in the outpatient consultation:‘The doctor's story’[J]. Social Science & Medicine, 2008, 66(7): 1484-1496.

[10] Srivastava C. Effect of Clinic Design on Patient Care: Perceptions of Medical Staff and Patients[J]. Intersect: The Stanford Journal of Science, Technology and Society, 2017, 10(2).

[11] Stillman M D, Bertocci G, Smalley C, et al. Healthcare utilization and associated barriers experienced by wheelchair users: A pilot study[J]. Disability and health journal, 2017, 10(4): 502-508.

[12] Gharaveis A, Hamilton D K, Pati D. The impact of environmental design on teamwork and communication in healthcare facilities: A systematic literature review[J]. HERD: Health Environments Research & Design Journal, 2018, 11(1): 119-137.

[13] DUBOSE J, LIM L, WESTLAKE R. DESIGNING TEAM ROOMS FOR COLLABORATION IN THE OUTPATIENT CLINICS[J]. 2015.

[14] Malkin J. Medical and dental space planning: A comprehensive guide to design, equipment, and clinical procedures[M]. John Wiley & Sons, 2002.

[15] Gardiner P, Dresner D, Barnett K G, et al. Medical group visits: a feasibility study to manage patients with chronic pain in an underserved urban clinic[J]. Global advances in health and medicine, 2014, 3(4): 20-26.

[16] Zoll B, Parikh P J, Gallimore J, et al. Impact of diabetes e-consults on outpatient clinic workflow[J]. Medical Decision Making, 2015, 35(6): 745-757.

[17] Manu C A, Mustafa O G, Bates M, et al. Transformation of the multidisciplinary diabetic foot clinic into a multidisciplinary diabetic foot day unit: results from a service evaluation[J]. The international journal of lower extremity wounds, 2014, 13(3): 173-179.

[18] Topp S M, Chipukuma J M, Chiko M M, et al. Integrating HIV treatment with primary care outpatient services: opportunities and challenges from a scaled-up model in Zambia[J]. Health policy and planning, 2012, 28(4): 347-357.

[19] Smith T, Blach O, Baker S, et al. Virtual stone clinic–the future of stone management?[J]. Journal of Clinical Urology, 2018: 2051415818757933.

[20] 吉武泰水. 19. 病院外来部の規模: 特に待合スペースについて[J]. 日本建築學會論文集, 1954, 49: 130-136.

[21] 吉武泰水. 331 待合室の規模: 病院外来各科[J]. 日本建築學會研究報告, 1954 (27): 297-

中国知网 https://www.cnki.net

298.
[22]小栗英男. 23 病院内に於ける物の動きについて: 外来診療に伴なう伝票の動き (第 4 部 設計計画)[J]. 学術研究発表会梗概集, 1967, 38(4): A89-A92.
[23]中野明, 長尾彰, 秋元秀昭, 等. 525 外来患者の動きと中央診療施設の利用実態: 病院の建築計画に関する研究 (建築計画)[J]. 日本建築学会近畿支部研究報告集. 計画系, 1975 (15): 209-212.
[24]江支川, 鈴木成文, 長沢悟, 等. 外来患者の院内滞在に関する考察 (その 1): A 病院でのケーススタディ: 建築計画[J]. 学術講演梗概集. 計画系, 1984, 59: 1675-1676.
[25]伊藤克洋, 小松尚, 加藤彰一, 等. 24 外来患者による病院外来待合い環境の評価構造: ニューラルネットワーク利用による主観的評価の解析手法に関する研究 (建築計画)[J]. 東海支部研究報告集, 1997 (35): 669-672.
[26]長澤泰, 鈴木毅, 山下哲郎. 患者の行動と認知を通してみた病院外来の考察: Hospital Geography に関する研究 1[J]. 日本建築学会計画系論文報告集, 1993, 452: 75-84.
[27]伊藤克洋, 小松尚, 加藤彰一, 等. 24 外来患者による病院外来待合い環境の評価構造: ニューラルネットワーク利用による主観的評価の解析手法に関する研究 (建築計画)[J]. 東海支部研究報告集, 1997 (35): 669-672.
[28]藤井正一. 病院ラジオアイソトープセンター[J]. 建築技術, 1960 (109): 39-50.
[29]松本啓俊. 17. 産科診療施設の地域的計画: 地域における母子健康センターの使われ方(1)(第 4 部 (基本計画・設計々画・設備関係))[J]. 研究発表会梗概集, 1963, 33(2): A65-A68.
[30]伊藤喜三郎建築研究所.作品 大分県立病院総合周産期母子医療センター--設計 伊藤喜三郎建築研究所[J].近代建筑，2005,59（4）：61-66.
[31]岩堀幸司. IWAHORI'S EYE 病院建築最前線 (第 50 回) 周産期および小児医療を 80 年にわたって展開. 培ったノウハウを建物設計に生かして新築移転し, 生命の誕生と成育のさらなる効率的支援を目指す 社会福祉法人恩賜財団 母子愛育会 総合母子保健センター 愛育病院[J]. 月刊新医療, 2015, 42(6): 196-198.
[32]日建設計.弘前脳卒中センター--日建設計 (特集 ニュー・ホスピタル・スタンダード--これからの病院建築に求められるもの)[J].近代建筑:2005，59（11）,94-97.
[33]富田博樹. 急性期中核病院の機能としての脳卒中センター (特集+ 医療建築 トータルケア・ホスピタル)[J]. 近代建築, 2010, 64(11): 48-51.
[34]佐藤圭太, 葛和久, 佐藤忠明. 14021 弘前脳卒中・リハビリテーションセンター 東棟(縮退する社会の中で, あるいは震災後の今考える, 医療・療養空間の未来 (1), 建築デザイン, 2013 年度日本建築学会大会 (北海道) 学術講演会・建築デザイン発表会)[J]. 学術講演梗概集, 2013, 2013: 42-43.
[35]小林健一, 小菅瑠香. 外来点滴センターの運営概要と物的環境: 通院治療部門の建築計画に関する研究 (その 1)(2002 年度大会 (北陸) 学術講演梗概集)[J]. 学術講演梗概集. E-1, 建築計画 I, 各種建物・地域施設, 設計方法, 構法計画, 人間工学, 計画基礎, 2002, 2002: 241-242.
[36]日本設計. 作品 名古屋掖済会病院 緩和・化学療法センター--設計 日本設計[J].近代建筑:2004，58（4）,57-62.
[37]東畑建築事務所. 済生会熊本病院外来がん治療センター--東畑建築事務所 (特集 3e-ホスピタル) [J].近代建筑:2008，62（11）,144-147.
[38]永坂祐貴, 宇田淳, 笹川紀夫, 等. 病院の改装に向けた診療科適正配置に関する研究--外来診療科の適正配置の検討[J]. 広島国際大学医療経営学論叢, 2010, 3: 89-102.

中国知网 https://www.cnki.net

[39]金子眞央, 今井沙耶, 中山茂樹. 5066 診療科特性から読み解くセンター化の有効性と課題: 外来部門の診療科再編・連携に向けた患者空間構築に関する研究 その 1 (病院の全体計画, 建築計画, 学術講演会・建築デザイン発表会)[J]. 学術講演梗概集, 2015, 2015: 131-132.
[40]郭晖.“以病人为中心”的医院设计——湖北省人民医院综合门诊楼简介[J].华中建筑,2002(04):32-33+37.
[41]高枫.超大型综合医院医疗体系设计研究[J].建筑学报,2010(10):96-99.
[42]杨冰洁. 现代综合医院检验中心空间设计研究[D].西安建筑科技大学,2014.
[43]王炜. 现代综合医院内镜中心建筑空间设计研究[D].西安建筑科技大学,2014.
[44]张名良. 现代综合医院血液透析中心的建筑空间设计研究[D].西安建筑科技大学,2014.
[45]张雷. 大型综合医院门诊部诊疗单元及空间环境设计研究[D].沈阳建筑大学,2012.
[46]徐更.精细创造高效 “新医疗体制”下三级综合医院交通组织的探索[J].时代建筑,2016(04):178-181.
[47]曹胜昔,杨丽娜,栗树凯,毛文举.超大型综合医院设计模式浅析——以河北医科大学第二医院正定新区医院设计为例[J].建筑技艺,2016(01):120-122.
[48]张远平,夏志伟,庹量.基于 MDT 模式的肿瘤医院设计——四川省肿瘤诊疗中心新建工程[J].中国医院建筑与装备,2017,18(11):45-48.
[49]陈海波.北京医院帕金森病及锥体外系疾病诊疗中心成立[J].中华老年医学杂志,1995(01):51.
[50].安徽省首家“脑胶质瘤诊疗中心”在安徽省立医院揭牌成立[J].中国神经肿瘤杂志,2013,11(04):285.
[51]郑成中,余红亚,牛杰,等.综合性医院多学科整体诊疗模式的构想[J].解放军医院管理杂志,2002(06):509-510.
[52]胡大一.现代医学发展探寻多学科整合之路[J].医学与哲学(人文社会医学版),2009,30(02):8-9+13.
[53]张贵民.学科整合突围[J].中国医院院长,2012(09):36-41.
[54]王静成.大型公立医院学科整合的初步探索[J].江苏卫生事业管理,2013,24(02):1-4.
[55]王魁英,谭映军,侯凯文,等.综合医院学科整合刍议[J].解放军医院管理杂志,2013,20(12):1181-1182.
[56]诸玲,万付梅,黄培.创新实践路径 加快“中心化诊疗”门诊服务建设[J].江苏卫生事业管理,2013,24(04):36-37.
[57]黄柳.细致演绎 MDT 门诊[J].中国医院院长,2014(22):58-59

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

致谢

三年的研究生涯转瞬即逝，感谢遇到的每一个人，教会了我很多东西：
感谢父母、亲人和朋友，感谢你们的支持和陪伴；
感谢我的导师周颖老师，感谢您悉心的教导和指引；
感谢师兄师姐、同门和学弟学妹们，感谢你们的鼓励和帮助；
感谢其他老师、同学等帮助过我的人，感谢你们的批评和指导；
感谢……
值此，请接受我满怀真诚的谢意：“谢谢！”

刘曦文
2018 年 5 月
于东南大学四牌楼校区图书馆

中国知网 https://www.cnki.net

附录

中国知网 https://www.cnki.net

附录 A 文献研究动向

附录 A-1 欧美国家门诊诊所设计相关研究文献

文献内容分类		年代	1934 1957 1961 1963 1966 1967 1971 1972 1976 1978 1979 1980 1982 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1998 1990	1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000	2001 2002 2003 2004 2005	2006 2007 2008 2009 2010	2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
门诊诊所设计	总体设计		Hospital Design — The Maternity and Out-Patient Departments Design of Outpatient Departments		Why is it so Difficult to Organise an Outpatient Clinic?	Medical and dental space planning: A comprehensive guide to design, equipment, and clinical procedures Healing spaces: elements of environmental design that make an impact on health Healthcare spaces Out-patient care Health Building Note 12-01: Consulting, examination and treatment facilities Beyond the Hospital: Human Factors and Ergonomics Issues in the Ambulatory/Outpatient Care Setting Outpatient clinic	A comparative analysis of outpatient clinics in two hospitals Applying discrete event simulation (DES) in healthcare: The case for outpatient facility capacity planning Translating Quality Care Factors to Quality Space: Design Criteria for Outpatient Facility Retrospective Preevaluation-Postevaluation in Health Design OUTPATIENT CLINIC Capacity planning with demand uncertainty for outpatient clinics
	使用者角度	患者角度		Planning the move of patient activities at a large medical center Understanding the patient in all his human needs	Can we see more Outpatients without More Doctors? Outpatient Clinic: Where is the Delay? Outpatient preanaesthesia evaluation clinics	Ambulatory facility design and patients' perceptions of healthcare quality Experience based design: a practical method of working with patients to redesign services Design and analysis of a health care clinic for homeless people using simulations	Analyzing patient flow: Reviewing literature to understand the contribution of space syntax to improve operational efficiency in healthcar Design that cares: Planning health facilities for patients and visitors Planning and designing the care transitions innovation (C-Train) for uninsured and Medicaid patients Do Patients Really Prefer Individual Outpatient Follow-up Visits, Compared with Group Medical Visits? Humanizing Narratives for Inspired Healthcare Experiences Results of Guided Tours With Health Care Providers and Employees Key ingredients for implementing intensive outpatient programs within patient-centered medical homes: A l Prevention by Design: Construction and Renovation of Health Care Facilities for Patient Safety and Infectic Healthcare utilization and associated barriers experienced by wheelchair users: A pilot study Patient involvement 2.0: Experience-based co-design supported by action research Perspectives on Research Participation and Facilitation Among Dialysis Patients, Clinic Personnel,
		工作人员角度				Time, space and opportunity in the outpatient consultation: 'The doctor's story'	Transforming the doctor's office: Principles from evidence-based design Lessons Learned: Clinicians' Post-Occupancy Perspective of Facility Design Involvement Changes in the Attentional Capacity and Emotional State of Physicians After Working at Busy Outpatient Building Situation Awareness on the Move: Staff Monitoring Behavior in Clinic Corridors Post-Occupancy Evaluation of a Mental Healthcare Facility Based on Staff Perceptions of Design Ir Setting the Stage: A Comparative Analysis of an Onstage/Offstage and a Linear Clinic Modul The Impact of Environmental Design on Teamwork and Communication in Healthcare Facilities: A
		全体					Effect of Clinic Design on Patient Care: Perceptions of Medical Staff and Patients
	转诊			Workshop 3: Bridging the Gap-Inpatient to Outpatient to Home Care			The Elimination of Transfer Distances Is an Important Part of Hospital Design
	通用设计						Designing safety-net clinics for flexibility Collaboration in-between: The care hotel and designing for flexible use Outpatient clinic layout design accounting for flexible policies Modularising outpatient care delivery: A mixed methods case study at a Finnish University H
	功能配置	等候区	Book Review: Waiting in Outpatient Departments	Seating in the outpatient clinic: the elderly patient's perspective Patient Attitude towards Waiting in an Outpatient Clinic and its Applications		Hospital outpatient perceptions of the physical environment of waiting areas: the role of patient characteristics on atmospherics in one academic medical …	Influence of Positive Distractions on Children in Two Clinic Waiting Areas The design and testing of interactive hospital spaces to meet the needs of waiting children Determining Waiting Room Occupancy at an OutpatientClinic Using Simulated Observations and Probabili Informing Healthcare Waiting Area Design Using Transparency Attributes: A Comparative Preference Stuc
		护理模块		Integration of Module Nurses Into the Outpatient Setting			Defining and improving quality management in Dutch diabetes care groups and outpatient clinics: design of the study
		内视镜检查			Outpatient endoscopy possibilities for the office		Guidelines for designing a digestive disease endoscopy unit: Report of the World Endoscopy Organization Outpatient rigid cystoscopy: Is it acceptable to women? Setting up the Pediatric Endoscopy Unit
		检查室				Effects of exam-room computing on clinician-patient communication: A longitudinal qualitative study	Clinic Exam Room Design: Present and Future Human Factors Research and Design Trends for the Modern Exam and Hospital Room
		哺乳区				How to Integrate a Lactation Consultant in an Outpatient Clinic Environment	
		多学科诊疗				Corridor work: How liminal space becomes a resource for handling complexities of multi-disciplinary health care	
		姑息医疗				Outpatient clinics are a new frontier for palliative care	
		诊室				Consultation room design and the clinical encounter: The space and interaction randomized trial.	Exploring space in the consultation room: Environmental influences during patient–physician interaction. Effects of Revised Consultation Room Design on Patient–Physician Communication
		康复				Trends in referral to outpatient cardiac rehabilitation in the Hunter Region of Australia, 2002-2007	Outpatient cardiac rehabilitation: the Austrian model Multidisciplinary outpatient rehabilitation following cardiac revascularization or valve surgery: patient-related factors for uptake Geographic Variation in Outpatient Health Care Service Utilization After Spinal Cord Injury
		远程医					The potential of telehealth for 'business as usual' in outpatient clinics Telemedicine compared with standard care in type 2 diabetes mellitus: A randomized trial in an outpati
		工作人员空间					Redesigning your work space to support team-based care. Restorative Design Features for Hospital Staff Break Areas Transforming the Doctor's Office Designing Team Rooms for Collaboration in the Outpatient Clinics Administrative workplaces in healthcare: Designing an efficient and patient-focused environment Designing the future of healthcare together: prototyping a hospital co-design space
	计算机模型		Use of optimization and simulation models to analyze outpatient health care settings Analysis of congestion in a university outpatient centre Outpatient health care facility planning and sizing via computer simulation COMPUTERIZED PSYCHIATRIC OUTPATIENT FILES: DESIGN AND IMPLEMENTATION ISSUES. Modelling and simulating the management of medical outpatient clinics		Application of discrete-event simulation in health care clinics: A survey Modeling and analyzing a physician clinic environment using discrete-event (visual) simulation	Process Improvement in an Outpatient Clinic: Application of Sociotechnical System Analysis Computer simulation and discrete-event models in the analysis of a mammography clinic patient flow Optimization of facility design and workflow process at the phlebotomy clinic of Toronto general hospital A simulation study of registration queue disciplines in an outpatient clinic: A two-stage patient flow model Outpatient queue business simulation based on acceptable waiting time	Using simulation to design and improve an outpatient procedure center Simulation-based analysis of scheduling decisions in an outpatient clinic Simulation modeling to optimize healthcare delivery in an outpatient clinic A Robust Predictive Resource Planning under Demand Uncertainty to Improve Waiting Times i

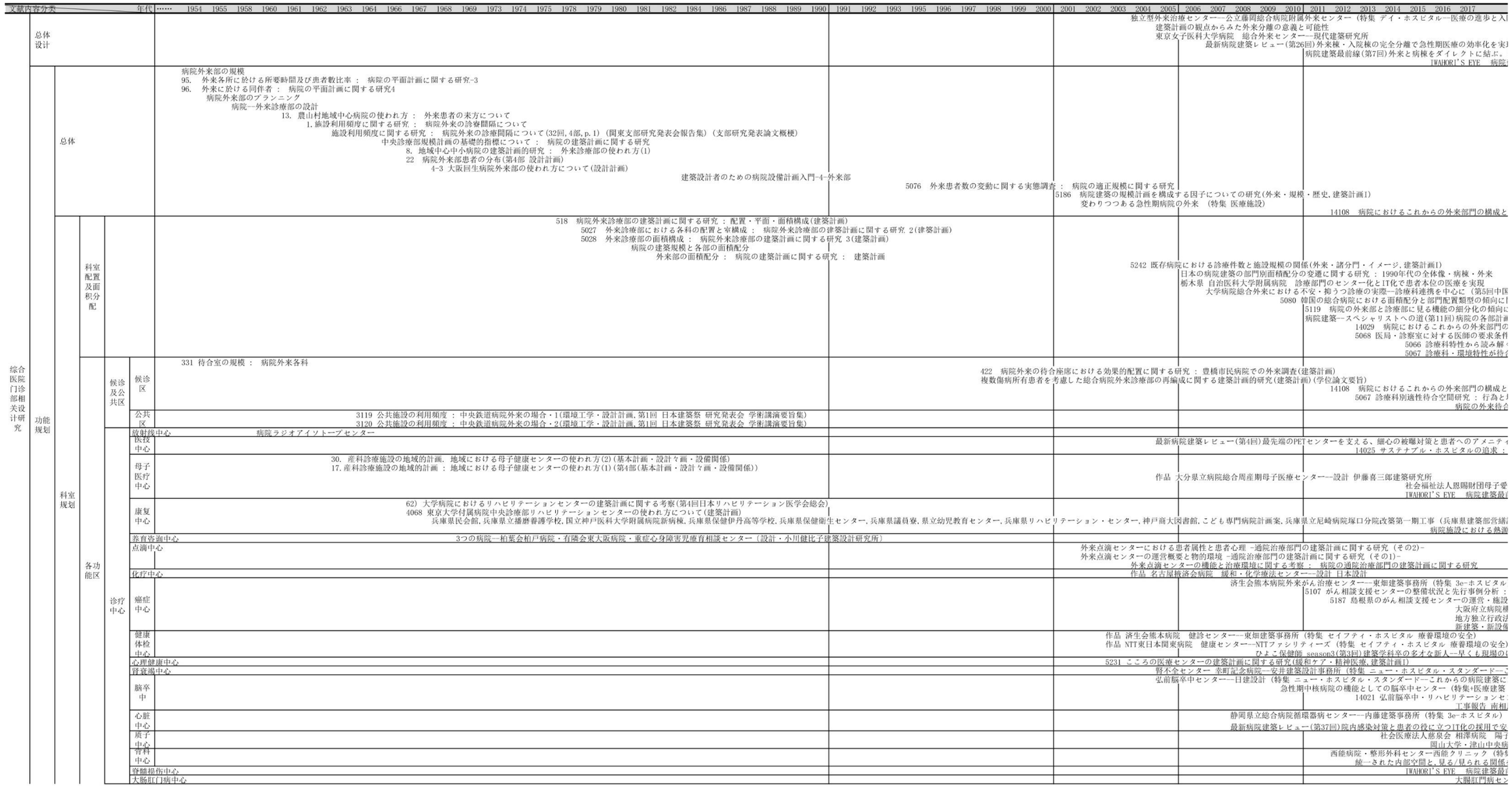
中国知网 https://www.cnki.net

附录 A-2 欧美国家专科诊所设计相关研究文献

文献内容分类	年代	…… 1934	1957	1961	1963	1966	1967	1971	1972	1976	1978	1979	1980	1982	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1998	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
专科诊所	性病诊所																																																		
	城乡结合区诊所																																																		
	学前儿童发展诊所																																																		
	泌尿科诊所																																																		
	大学诊所																																																		
	精神病诊所 患者																																																		
	精神病诊所 跨文化转诊																																																		
	精神健康中心 互动设计																																																		
	青少年诊所																																																		
	医院依附型诊所																																																		
	烟瘾诊所																																																		
	运动诊所																																																		
	疼痛诊所																																																		
	疼痛诊所 团队合作																																																		
	糖尿病中心																																																		
	糖尿病中心 转诊																																																		
	糖尿病中心 戒烟服务																																																		
	糖尿病中心 电子诊疗																																																		
	糖尿病中心 多学科日间护理																																																		
	糖尿病中心 患者为中心																																																		
	外科手术中心																																																		
	其他																																																		
	影像中心																																																		
	更年期诊所																																																		
	门诊透析中心																																																		
	外科诊所																																																		
	老年诊所 患者行为																																																		
	老年诊所 患者行为																																																		
	初级保健诊所 转诊																																																		
	初级保健诊所 防止自杀																																																		
	初级保健诊所 特定人群																																																		
	初级保健诊所 特定人群																																																		
	初级保健诊所 整合特定疾病治疗																																																		
	初级保健诊所 种族																																																		
	社区咨询诊所																																																		
	骨髓移植诊所																																																		
	骨髓移植诊所 环境																																																		
	骨髓移植诊所 环境																																																		
	骨髓移植诊所 视觉艺术																																																		
	术前评估诊所																																																		
	耳鼻喉科诊所																																																		
	创伤诊所																																																		
	健康中心																																																		
	风湿病门诊																																																		
	风湿病门诊 转诊																																																		
	门诊教学中心																																																		
	计划生育诊所																																																		
	血液科、肿瘤科、骨																																																		
	血液科、肿瘤科、骨 整合药剂师																																																		
	家庭诊所																																																		
	皮肤科门诊																																																		
	认知症诊所																																																		
	手部诊所																																																		
	美容诊所																																																		
	介入放射诊所																																																		
	大型护理中心																																																		
	运动障碍诊所																																																		
	多学科诊所																																																		
	儿童精神诊所																																																		
	肿瘤诊所 团队合作																																																		
	肿瘤诊所 患者																																																		
	脊髓骨神经诊所																																																		
	癌症诊所																																																		
	癌症诊所 改善等待时间																																																		
	骨科诊所																																																		
	骨科诊所 骨科、康复科																																																		
	骨科诊所 绿色设计																																																		
	骨科诊所 虚拟骨科诊所																																																		
	骨科诊所 虚拟骨科诊所																																																		
	儿科诊所																																																		
	儿科诊所 姑息治疗																																																		
	儿科诊所 互联网																																																		
	儿科诊所 转诊																																																		
	儿科诊所 家庭护理																																																		
	儿科诊所 家庭护理																																																		
	儿科诊所 员工参与																																																		
	姑息医疗诊所																																																		
	心脏诊所																																																		
	骨质疏松诊所																																																		
	哺育诊所																																																		
	心衰诊所																																																		
	心衰诊所 工作人员角度																																																		
	心衰诊所 姑息服务																																																		
	儿童神经内科诊所																																																		
	儿童癌症患者成年幸存者诊所																																																		
	听力诊所																																																		
	儿童健康患者参与																																																		
	多学科消化诊所																																																		
	乡村诊所 患者参与																																																		

中国知网 https://www.cnki.net

附录 A-3 日本综合医院门诊部相关研究文献



中国知网 https://www.cnki.net

附录 A-3 日本综合医院门诊部相关研究文献（接上页）

文献内容分类				年代 …… 1954 1955 1958 1960 1961 1962 1963 1964 1966 1967 1968 1969 1973 1974 1975 1978 1979 1980 1981 1982 1984 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
综合医院门诊部相关设计研究	功能规划	科室规划	各功能区	急救中心
				医技部门
				其他 精神室
				咨询室
	交通流线	交通	电梯配置	
			停留时间	
			动线	
			寻路	
	空间营造			

5147 救急医療体制整備に関する基礎研究 ： その1 熊本赤十字病院救命救急センターにおける来院患者の特性分析
417 熊本県における高次救急医療施設の利用実態に関する調査研究 ： その2 入院区分に着目した熊本赤十字病院救命救急センター来院患者の特徴分析(建築計画)
416 熊本県における高次救急医療施設の利用実態に関する調査研究 ： その1 熊本赤十字病院救命救急センターにおける調査の概要と基本集計結果(建築計画)
404 熊本県における高次救急医療施設の利用実態に関する調査研究 ： その3 熊本地域医療センター医師会病院における調査結果の概要(建築計画)
5257 救命救急センターの建築計画に関する研究(その1)
5317 救命救急センターの建築計画に関する研究(その2)
作品 青梅市立総合病院 救命救急センター―伊藤喜三郎建築研究所（特集 ファミリーホスピタル 患者と家族に優しい医
杏林大学医学部付属病院救命救急センターの建築計画
最新病院建築レビュー(第29回)救命救急センターを中心に「常に一歩先の医療」の提供
最新病院建築レビュー(第25回)IT化と開放的な空間づくりで、"患者を見守る"救急医療
5085 救急医療における初療室の空間要件 ： 救命救急センターの
5086 救急医療従事者からみた治療関連諸室の利用実態と評価 ：
5087 救急搬送患者の疾患構造と施設利用に関する考察 ： 救命救
5120 救命救急センターの診療関連諸室の整備状況 ： 救命
医療法人社団 永生会 南多摩病院 救急医療センタ
5165 救命救急センターの平面構成分析 ： 救命救急
5164 救命救急センターの運営体制と治療環境の実
5163 救急医療提供体制と救命救急センターの運営
5074 救急部門における専有医
5075 救急部門の専有機能別に
18. 地域中心中小病院の建築計画的研究 ： 放射線、検査部の外来利用
放射線部門の建築設計 分散配置型の得失 ： 自治医科大学大宮医療センター
5178 外来手術施設に関する海外事例による考察 ： 通院治療施設の建築計画に関する研究(1)(通院治療・供給・検査部他,建築計
5189 病院の運用設定の評価に関する考察 ： 外来を中心として(外来・検査部門,建築計画I)
"5194 病院検査部の機能評価に関する研究(その1) ： 動線量の予測と必要動作領域による平面構成の考察(外来・
5084 外来診療部における処置室の設置形態と物品管理システム
5114 病院霊安室の設置要求とそのありかたについて(外来
5022 病院外に設置された相談支援施
外来部におけるエレベーター所要台数算定に関する一考察 ： 病院の建築計画的研究 ： 建築計画
外来患者の院内滞在に関する考察(その1) ： A病院でのケーススタディ ： 建築計画
外来患者の院内滞在に関する考察(その2) ： B病院でのケーススタディ ： 建築計画
5223 病院外来部の運営方式が滞留患者数に与える影響について ： シミュレーション・モデルの開発
7.外来待合における患者の意識・行動に関する研究 ： 病院外来待合のアメニティに関する1考察(建築計画)
5245 迷いからみた患者の病院像に関する研究 ： Hospital Geographyに関する研究 外来(1)
外来待合における患者の意識・行動に関する研究 ： 病院外来待合のアメニティに関する1考察(建築計画)(東海支部)(1990年度支部研究発表梗概)
運営からみる外来部門の特性把握 ： 急性期病院における外来患者の滞在構造に関する研究 その1(2002年度大会（北陸）
外来患者の院内滞在に影響を及ぼす建築・運営因子の分析 ： 急性期病院における外来患者の滞在構造に関する研究 その2
4-35 日本バプテスト病院における外来診療所要時間(第4室 設計計画)
23 病院内に於ける物の動きについて ： 外来診療に伴なう伝票の動き(第4部 設計計画)
525 外来患者の動きと中央診療施設の利用実態 ： 病院の建築計画に関する研究(建築計画)
Y市立病院における外来患者の動き ： 病院の建築計画に関する研究
外来診療部における患者の数とその動き ： 病院の建築計画に関する研究
5139 外来部における患者の動き 1 ： 病院の建築計画に関する研究
5140 外来部における患者の動き 2 ： 病院の建築計画に関する研究
外来部における患者の動き ： 病院の建築計画に関する研究
5216 外来部における患者の動き ： 大阪赤十字病院の場合
5161 外来患者の動きのシミュレーション ： 病院の建築計画に関する研究
5194 病院検査部の機能評価に関する研究(その1) ： 動線量の予測と必要動作領域による平面構成の考察(外来・検
5195 病院検査部の機能評価に関する研究(その2) ： 動線量の予測と必要動作領域による平面構成の考察(外来・検
最新病院建築レビュー(第20回)外来動線[ワンウェイ方式]で、コンパクト設計でも混雑知らず
外来患者動線のシミュレーション
外来患者動線のシミュレーション:―外来診療部における患
5112 病院内の医師の移動に関する研究 ： 病院建築の計
外来患者の病院内行動記録撮り実験の報告 ： 実験概
5069 病院内の医師の移動に関する調査研究
患者の行動と認知を通してみた病院外来の考察 ： Hospital Geographyに関する研究I
28 サイン・マップの定量化による病院外来診療部門のウェイファインディングに関する研究(建築計画)
22 POEによる待合環境認識の比較 ： 病院新築前後の外来待合における環境認識・行動に関する研究 その1(建築計画)
23 人の居場所とその環境認識・行動の関係 ： 病院新築前後の外来待合における環境認識・行動に関する研究 その2(建築計画)
移転改築前後の環境認識比較による居場所としての病院外来待合に関する研究
5035 病院外来部門における案内支援システムの開発 ： ヘルスケア施設のウェイファインディングに関する研究
401 病院外来部門における案内支援システムの試用に関する研究 ： ヘルスケア施設のウェイファインディングに関する研究(建
5184 視認順序と発話によるA総合病院の分かり易さの分析 ： 総合病院におけるアイマークによる探索行動の研究 その1(外来・
5185 視認順序と発話によるB総合病院の分析と2施設比較による分かり易さの分析 ： 総合病院におけるアイマークによる探索行動
外来患者の院内行動からみた病院情報システムの効果に関する研究(2002年度大会（北陸）学術講演梗概集)
5190 病院の絵本が果たす案内支援システムとしての役割に関する研究 ： ヘルスケア施設のウェイファインディン
5191 初診受付を目的室とした探索行動の分析 ： 総合病院の探索行動における空間情報視認時間分析 その1(外来・
5192 耳鼻咽喉科を目的室とした探索行動の分析 ： 総合病院の探索行動における空間情報視認時間分析 その2(外来
5193 検査部を目的室とした探索行動の分析 ： 総合病院の探索行動における空間情報視認時間分析 その3(外来・検
5243 現地実験と3次元立体映像装置を用いたサイン実験による比較分析 ： 3次元立体映像装置を用いた総合
5244 アイマークレコーダー利用の影響と視認サイン実験の分析 ： 3次元立体映像装置を用いた総合病院の空
5240 電子カルテ導入による外来診療の変化 ： 外来患者の院内行動からみた病院情報システムの効果に関す
5034 T・0総合病院の分かり易さ改善手法の構築 ： 総合病院の3次元立体視映像探索行動実験
5035 T総合病院の探索行動実験による分かり易さの分析 ： 総合病院の3次元立体視映像探索行
5036 0総合病院の探索行動実験による分かり易さの分析 ： 総合病院の3次元立体視映像探索行
5161 ウェイファインディングからみた外来部の空間構成 ： 病院外来部のウェイファ
5162 外来部における患者向け情報の内容分析 ： 病院外来部のウェイファインディン
5163 外来部の空間構成と患者向け情報の関係 ： 病院外来部のウェイファインディン
5165 外来患者のシミュレーション ： 外来患者の院内行動からみた病院情報システム
5218 病院外来部における患者向け情報のサイン計画指針 ： 病院外来部のウェ
5083 3次元立体映像装置による第II―IV期画像を用いた高齢者の
5110 3次元立体映像装置探索行動実験によるII期―IV期高
5111 3次元立体映像装置によるT総合病院探索行動実験の
24 外来患者による病院外来待合い環境の評価構造 ： ニューラルネットワーク利用による主観的評価の解析手法に関する研究(建築計画)
414 外来患者を中心としたウェイファインディングに関する研究 ： 蒲郡市民病院と豊橋市民病院におけるサイン・マップの定量化(建築計画)
5021 外来部の待合や廊下を中心としたサイン計画に関する研究 ： 蒲郡市民病院におけるサイン・マップの定量化
病院外来部コモンスペースにおける居場所形成に関する研究(建築計画)(学位論文要旨)
5182 クラスター分析により調査対象病院の選出 ： 病院のアプローチ空間の研究(その1)(外来・規模・歴史,建築計画I)
5183 病院のエントランスから外来待合までの心理量分析 ： 病院のアプローチ空間の研究(その2)(外来・規模・歴史,建築計画I
病院のアプローチ空間の研究（その4）
CLOSE UP 建築 公立苅田綜合病院(宮城県白石市) 患者の視点に立った明快な施設構成
外来空間における心理量分析 ： 病院のアプローチ空間の研究（その3)(2002年度大会（北陸） 学術講演梗概集)
5039 病院外来部の共用空間における空間構成とその利用実態に関する研究(建築計画)
5188 病院外来部の空間構成と患者の利用実態に関する研究(外来・検査部門,建築計画I)
評価される病院の外来待合を建築面から考える（患者が集まる待合室を
5082 子どものヘルスケア施設における支援的デザインの導入方法
治療環境の整備に向けて ： 総合病院におけるセン
5070 回復期リハビリテーション病院におけ
5021 がん診療連携拠点病院における

中国知网 https://www.cnki.net

附录 A-4 中国建筑领域综合医院门诊部相关研究文献

文献内容分类			…… 1995 1999 2000	2001 2002 2003 2004 2005	2006 2007 2008 2009 2010	2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
综合医院门诊部设计	门诊楼设计	前期策划		医院建筑设计的前期策划	前期策划，为医院支5招 前期策划，医院如何考虑，怎样入手? 格伦 破解医院前期策划缺失的乱象 医院建筑前期策划亟待关注 医院建筑设计的前期策划 对现代医院建筑项目前期策划设计的思考	医院建筑设计的前期策划 析美国医疗建筑前期策划 广州南方医院新建外科楼前期策划 德国医疗建筑
		医疗工艺			论医疗工艺流程与建筑布局的统一	医疗工艺流程设计的研究和优化 新建医院医疗工艺设计要点 启程·医疗工艺设计 综合医院门急诊部医疗工艺设计 医疗工艺设计“三段论” 医疗工艺设计与医院建设项目前期策划 日本医疗工艺设计的解读 从工艺设计三段论到工艺咨询八步法 医疗工艺设计·灼见 医院建设前期工作中的医疗工艺设计 医疗工艺设计的实施方法与技巧 医疗工艺设计与医疗策划——以四川大学华西医院转化医学综合楼为例 血液透析中心的医疗工艺设计 医疗工艺设计与运营管理 台湾医疗建筑与医疗工艺发展现状 以医疗工艺及流程整合为主线的功能更新——中建西南院旧办公楼改造为眼科医院楼实例分析 以医疗工艺为主导的医院室内设计——以成都市新生堂妇产医院为例 中国医院设计之路将走向何方?
		门诊设计总括		我国综合性医院门诊部建筑设计研究 当代医院门诊楼设计的新观念初探	城市中心区大型综合医院门诊楼建筑设计研究	综合医院门诊部建筑用后评价体系研究 大型综合医院门诊楼空间设计研究 基于空间句法理论的综合医院门诊部研究 协和医院门诊建筑模式的发展变化研究 大型综合医院门诊楼建筑设计探讨
		综合效率			医院建筑综合效率研究	综合效率观下的大型医院建筑评价与设计策略初探 基于综合效率评价的大型医院建筑改扩建的设计策略研究 基于综合效率评价的大型医院门诊楼的设计策略研究 关于提高大型三级综合医院门诊效率的思考
	设计理念	患者为中心		“以病人为中心”的医院设计——湖北省人民医院综合门诊楼简介 以病人为中心优化门诊流程	基于行为心理的综合医院门诊部建筑空间环境设计研究 基于医患分离理念的综合医院门诊空间体系架构 以人为本的医院建筑设计和布局流程	基于就诊者心理需求的大型综合医院门诊公共空间人性化设计策略研究 基于患者体验的综合医院门诊楼公共空间设计研究
		医学模式		复合型医疗理念对综合医院建筑设计的影响研究 现代医学模式下的综合医院门诊楼公共空间设计研究 医疗体制变革与医院建筑创作 医院建筑医疗区设计模式研究 现代大型综合医院门诊部医学模式与建筑设计研究	论医学模式的演变与医疗建筑的发展 从医疗需求出发，寻求符合实际的设计 医院建筑的研究与创意 日本医院建筑设计的新动向 医疗联盟模式下医院建筑设计研究 试论我国综合性医院的专科专病建设 “一站式”门诊就诊服务模式下综合医院门诊空间设计研究 新型就医模式下医院建筑计划研究 大专科转型小综合“生长”记——东方肝胆外科医院新院区建设
		诊疗中心			超大型综合医院医疗体系设计研究	精细创造高效 “新医疗体制”下三级综合医院交通组织的探索 超大型综合医院设计模式浅析——以河北医科大学第二医院正定新区医院设计为例 基于MDT模式的肿瘤医院设计——四川省肿瘤诊疗中心新建工程
		诊疗单元				大型综合医院门诊部诊疗单元及空间环境设计研究 综合医院医疗功能单元模块化设计研究

中国知网 https://www.cnki.net

附录 A-4 中国建筑领域综合医院门诊部相关研究文献（接上页）

文献内容分类			…… 1995 1999 2000	2001 2002 2003 2004 2005	2006 2007 2008 2009 2010	2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
综合医院门诊部设计	功能布局	总体布局			功能与形式的完美结合——浅谈张家港市第一人民医院建筑创作体会	现代三甲综合医院功能分区规模量比研究 现代三甲综合医院功能分区规模量比研究 综合医院建筑三级功能布局用后评价标准研究 大型综合医院中心手术部与其相关医技科室综合布局关系初探 鞍山医院改扩建的功能布局研究 浅谈综合医院功能布局流线关系 广州中心城区大型综合医院门诊部优化设计研究 大型综合医院医疗功能空间面积指标研究 综合医院改扩建功能布局分析——以中国医科大学附属第一医院鞍山医院改扩建为例
		医技中心			医学影像中心工程的规划设计建议 如何打造现代医院影像中心——访解放军总医院院务部部长杨洛渝 浙江大学医学院附属妇产科医院放射中心的建设案例 整合“影像” 兴建中心——现代医院建设影像中心渐成潮流	大型公立医院医学影像科DSA诊疗中心的规划与筹建——以深圳市滨海医院为例 大型公立医院医学影像中心的规划与筹建[大型公立医院超声影像诊疗中心的规划与筹建 现代综合医院分娩中心人性化设计研究 综合医院影像中心建筑用后评价标准研究 现代综合医院中的介入治疗中心建筑设计研究 现代综合医院血液透析中心的建筑空间设计研究 现代综合医院检验中心空间设计研究 现代综合医院内镜中心建筑空间设计研究 心血管介入诊疗中心的设计及实践 现代医院影像中心建筑设计研究 现代综合医院新生儿重症监护中心（NICU）建筑设计研究
	交通流线	交通组织		医院建筑中的交通组织和空间营造——资阳市第一人民医院新医院设计	综合医院建筑内部交通体系组织模式浅析 大型综合医院交通系统研究	谈开放式综合性医院的交通组织 大型医院交通问题的解决策略 大型综合医院门急诊楼竖向交通系统设计研究 基于系统化的大型综合医院交通组织研究 综合医院门诊部公共交通空间设计策略研究 综合医院立体交通设计研究——以浙江省台州恩泽医院为例 综合医院立体交通设计研究——以厦门马銮湾医院为例[
		流线		综合医院建筑的流线系统研究 大型综合医院门诊部流线与空间系统化研究		医院的流线设计 综合医院医疗技术部门动线设计与空间组织研究 浅析综合医院建筑内部空间及流线设计 门诊就医流程再造的应用进展 为提高医疗效率的山地医院建筑流线设计——以南宁明安医院一期工程为例 医院门诊流程的分析与优化

中国知网 https://www.cnki.net

附录 A-5 中国医疗领域诊疗中心相关研究文献

文献内容分类—年代		…… 1995 1999 2000	2001 2002 2003 2004 2005	2006 2007 2008 2009 2010	2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
诊疗中心（医疗领域）	诊疗中心设立	北京医院帕金森病及锥体外系疾病诊疗中心成立 浅谈重点专病医疗中心建设	浙江省第一家睡眠呼吸障碍诊疗中心成立 首都医科大学成立肺癌诊疗中心 首都医科大学肺癌诊疗中心在北京宣武医院成立	广西壮族自治区人民医院已建立12个自治区级临床研究和诊疗中心 坚持与时俱进 争创名优科室——济南军区肿瘤诊疗中心建设发展剪影 走在现代医学技术前沿的同仁医院心血管疾病诊疗中心 坚持与时俱进 争创名优科室——济南军区肿瘤诊疗中心建设发展剪影 睡眠呼吸疾病诊疗中心配置与运转 美国哈佛大学医学院睡眠疾病诊疗中心见闻 加州大学戴维斯分校嗓音和吞咽障碍诊疗中心简介 小儿骨科/脊柱脊髓病诊疗中心简介 北京市中医管理局在东方医院举行“北京中医儿科诊疗中心”揭牌仪式——西苑医院、东方医院获准成立北京市儿科诊疗中心 白求恩国际和平医院心血管内科 全军心律失常诊治专病中心、北京军区心血管疾病诊治研究中心 南京市中西医结合医院打造儿童诊疗中心 解放军第一〇七医院全军肿瘤无创诊疗中心 攻克肿瘤顽疾 创建诊疗新路 心血管疾病临床诊疗中心简介 依靠领先技术 突出中医特色 河南中医学院第一附属医院心脏病诊疗中心简介 专科有专家 专家治专病 专病有专药 河南中医学院第一附属医院肛肠病诊疗中心简介 加强男科学学科建设,创建国际先进、国内领先的男科疾病诊疗中心 南京市中西医结合医院打造儿童诊疗中心 解放军302医院肝纤维化诊疗中心简介 解放军455医院全军胸部肿瘤诊疗中心简介 首届全国中医院冠心病介入论坛暨广东省中医院胸痛诊疗中心成立大会纪要 湖南省中医药研究院附属医院中医肿瘤诊疗中心 复旦大学附属中山医院肺部肿瘤综合诊疗中心成立十周年 安徽省首家“脑胶质瘤诊疗中心”在安徽省立医院揭牌成立 安徽省中医院脑病中心成为区域诊疗中心 创面诊疗中心伤口护理模式的探讨 利益相关者理论在骨质疏松诊疗中心创建的应用 同舟共济,营造西南地区呼吸病学诊疗中心一一记重医大附二院呼吸内科 流程重组在消化内镜诊疗中心的应用研究 北京市中医睡眠诊疗中心介绍 《世界睡眠医学杂志》创刊号首发式暨北京市中医睡眠诊疗中心揭牌仪式在京举行 中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会儿童结石病诊疗中心 北京老年医院 北京安贞医院 心血管疾病联合诊疗中心 新疆边远地区基于智能骨科装备的骨科远程诊疗中心的搭建和思考 血友病诊疗中心信息化管理系统与资源平台构建 我院皮肤病诊疗中心门诊用药分析 首都医科大学肺癌诊疗中心 打造国内领先的“精确放疗”中心——访海军总医院肿瘤诊疗中心主任康静波 卫生院设立“慢病联合诊疗中心”对提高社区“慢病”规范化管理质量的研究 儿童癫痫中心——多学科协作的综合诊疗模式 第二军医大学难治性反流性食管炎诊疗中心简介 长征医院睡眠障碍诊疗中心简介 大医精诚 妙手回春——温州医科大学附属第二医院肛肠病诊疗中心主任 金定国 第二军医大学难治性反流性食管炎诊疗中心简介 国家卫生部临床重点专科、国家中医药管理局重点专科——长春中医药大学附属医院儿童诊疗中心 安全管理在介入诊疗中心护理工作中的应用 国际肿瘤联合诊疗中心落户武安市第一人民医院 解放军一八〇医院南京军区肝病中心简介 南京医科大学第二附属医院心血管病中心 新医改形式下建设区域中医诊疗中心的实践与思考 诊疗中心模式下中医药进社区的理论与实践研究

中国知网 https://www.cnki.net

附录 A-5 中国医疗领域诊疗中心相关研究文献（接上页）

文献内容分类	年代	…… 1995 1999 2000	2001 2002 2003 2004 2005	2006 2007 2008 2009 2010	2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
诊疗中心（医疗领域）	科室建设及多学科诊疗		浅谈对“以器官系统为中心”教学模式的认识 综合性医院多学科整体诊疗模式的构想	医院学科技术整合实践与思考 加强医疗资源整合 发展医院优势学科 围绕核心技术整合医院优势学科 一站式服务在门诊流程改造中的作用 综合性医院专科化门诊服务流程再造 多学科协作模式——MDT的探讨 论中心化医疗模式中病人上报流程的建立 围绕核心技术整合医院优势学科 以整体医疗理论指导临床学科整合的做法与成效 关于医学整合的几点认识 综合性中医院建设专病联合诊疗中心的体会 “以器官系统为中心”的医学基础课程整合“三步走”的改革探索及设想 现代医学发展探寻多学科整合之路 医学整合:推进医疗公正的新探索 大型综合性军队医院学科建设循证研究 多学科整合促进军队医学专科中心发展	综合医院学科整合的研究进展 基于疾病诊疗需要的心脏中心建设模式 某综合医院学科整合后住院病人满意度调查研究 整体医疗中学科整合后病人满意度调查研究 试析多学科专家组诊疗模式与区域医疗中心的建立 多学科联合诊疗，带动医疗水平整体提高 上海市级医院开设整合门诊的实践 规范化乃整合基石 学科整合突围 整合模式探路 整合之辨 关于以患者为中心的医学学科整合的思考 大型公立医院学科整合的初步探索 多学科整合促进综合医院可持续发展 学科整合 顺势而为 综合医院学科整合刍议 创新实践路径 加快“中心化诊疗”门诊服务建设 基于T型管理法的医院学科群“中心化”诊疗模式探讨 医院临床学科整合及其展望 细致演绎MDT门诊 以联合门诊为突破点 探索医院学科整合之路 以器官-系统为中心的临床医学课程整合在八年制教学中的应用 以器官系统为中心的课程整合改革现状及思考 上海市级公立医院学科资源配置与学科发展意向研究 我院实施中心制门诊服务的探索 某大型医院医疗中心专科经营助理管理模式研究 基于JCI的医疗中心建设 某院医疗中心整合TOPSIS法的效果评价 公立医院实施多学科协作诊疗整合门诊服务模式探讨 依托学科群建设构建多学科协作诊疗模式的实践与思考 多学科协作诊疗模式对促进医院学科建设的探讨 基于组织变革理论的医院多学科综合诊疗体系构建 TOPSIS法在医疗中心运行评价的实例应用 诊疗中心模式下中医药进社区的理论与实践研究 “一体化”诊疗打破专科局限——江苏省无锡市第三人民医院管理模式创新 珠三角地区基层医院消化专科多学科协作综合医疗模式的建立和探讨 公立医院多学科整合门诊服务模式的实践探索
	医技中心	邢矿总院影像诊疗中心成立		超声介入微创诊疗中心 远程影像诊疗中心建设及远程会诊流程的设计	全军腔内介入诊疗中心 区域化放射诊疗中心建立

中国知网 https://www.cnki.net

附录 B 日本研究案例基本情况

序号	医院名称	基本情况			诊疗中心个量	职能										网址
		病床数（床）	日门诊人次	日住院人数		国立高度专门医疗研究中心	高度综合医疗设施	特定机能医院	地域支援医院	急救中心	癌症诊疗医院	地域癌症诊疗合作医院	综合围产期母子医疗中心	地域围产期母子医疗中心	灾害医院	
1	井上病院	46			2											http://www.inoue-hp.com/
2	山王病院	79	795	61	11											http://www.sannoclc.or.jp/hospital/index.html
3	真生会富山病院	99	914	95	2											https://www.shinseikai.jp/
4	佐野病院	131			3											http://www.sano-hospital.or.jp/
5	泰玄会病院	133	242	93	1											https://www.taigenkai.or.jp/hospital/taigenkai/index.php
6	洛和会丸太町病院	150	343	122	2											http://www.rakuwa.or.jp/maruta/shinryoka/shokaki/
7	大分三愛メディカルセンター	179	258	162	4											http://san-ai-group.org/section
8	札幌共立五輪橋病院	188	180	130	3						○					http://www.gorinbashi.or.jp/department/
9	小松病院	190	600		1											http://www.komatsu.or.jp/department/
10	長津田厚生総合病院	190			3											http://www.nagatsuta-ks-hp.or.jp/departments/
11	西宮渡辺病院	192	181	110	4											http://www.n-watanabe-hosp.jp/dep/prosthetic_j.html
12	福西会病院	198	316	172	2											http://fukuseikai-hp.com/service/
13	土庫病院	199	313	179	1											http://kenseikai-nara.or.jp/dongo/index.html
14	鹿島労災病院	199	269	37	3											http://www.kashimah.johas.go.jp/index.html
15	神戸百年記念病院	199	506	112	3						○					http://www.kobe-century-mh.or.jp/
16	福岡山王病院	199	663	148	13											http://f-sanno.kouhoukai.or.jp/medical/
17	柏市立柏病院	200	529	143	2											http://kashiwacity-hp.or.jp/index.html
18	宇城総合病院	204	252	190	2				○						○	http://www.reimeikai.jp/department/
19	大濱第一病院	214	567	212	3											http://www.omotokai.or.jp/ohama1/
20	高萩協同病院病院	220	393	91	1											http://takahagi-kyodo-hp.jp/
21	出水郡医師会広域医療センター	222	183		1				○			○				http://www.akunehp.com/sinryobumon/
22	練馬総合病院	224	500	180	4											http://nerima-hosp.or.jp/index.html
23	福島県立医科大学 会津医療センター	226	503	157	4											https://www.fmu.ac.jp/amc/
24	土浦協同病院なめがた地域医療センター	230	484	115	1								○		○	https://www.ndgh.jp/shinryo
25	南奈良総合医療センター	232	442	138	7				○			○			○	http://nanwairyou.jp/category_list.php?frmCd=17-0-0-0-0
26	横浜新緑総合病院	236			3											http://www.shinmidori.com/department/
27	福岡市立こども病院	239	289	184	7				○					○		http://www.fcho.jp/childhp/shinryou.php
28	葛城病院	243	396	213	3											http://www.katsuragi-hosp.or.jp/shinryoka.htm
29	西の京病院	248	445	143	2											http://www.nishinokyo.or.jp/index.html
30	高の原中央病院	249	419	158	3											http://www.takanohara-ch.or.jp/medicalsubjects/
31	市立貝塚病院	249	613	168	4						○					http://www.hosp.kaizuka.osaka.jp/index.html
32	久留米大学医療センター	250	518		5											http://iryo.kurume-u.ac.jp/bumon/
33	時計台記念病院	250	49	197	10											http://www.tokeidaihosp.or.jp/outpatient.html
34	荻窪病院	252	617	234	4				○						○	http://www.ogikubo-hospital.or.jp/index.html
35	HITO 病院	257	282	150	4											http://hito-medical.jp/department/
36	金沢赤十字病院	262	522	172	3										○	http://kanazawa-rc-hosp.jp/outline/facility/
37	吉田病院	263	187	228	5											http://www.keiyukai-group.com/yoshi-hp/
38	北斗病院	267	203	194	12				○							https://www.hokuto7.or.jp/patient/center/
39	常滑市民病院	267	579	209	2											http://www.tokonamecityhospital.jp/about/floor
40	倉敷成人病センター	269	120	243	5											http://www.fkmc.or.jp/medical
41	千葉中央メディカルセンター	272	661	231	4											http://www.ccmc.seikei-kai.or.jp/
42	イムス三芳総合病院	273	555	209	6											http://www.ims.gr.jp/miyoshisougou/index.html
43	東大和病院	284	447	247	11				○		○				○	http://www.yamatokai.or.jp/higasiyamato/
44	牧田総合病院	284	700		4											http://www.makita-hosp.or.jp/MedicalSubjects.php

中国知网 https://www.cnki.net

45	大船中央病院	285	735	192	4											http://www.ofunachuohp.net/shinryo/index.php
46	函館協会病院	286	298		1											http://www.hakodatekyokaihp.com/index.shtml
47	日高病院	287	274	231	6				○						○	http://www.hidaka-kai.com/hidaka/center/
48	国際親善総合病院	287	720	240	2											http://shinzen.jp/department/
49	国際医療福祉大学三田病院	291	827	213	13						○					http://mita.iuhw.ac.jp/clinic/index.html
50	城山病院	299	511	272	3											http://www.shiroyama-hsp.or.jp/index.html
51	新小山市民病院	300	624	210	2				○							http://hospital-shinoyama.jp/
52	朝倉医師会病院	300		230	3				○			○			○	http://www.asakura-med.or.jp/hospital/diagnosis.html
53	小林病院	300			4											http://www.k-24.jp/section/
54	大阪回生病院	300	930	192	3											http://www.kaisei-hp.co.jp/department/
55	緑成会横浜総合病院	300	780	247	5											https://yokoso.or.jp/
56	昭和大学江東豊洲病院	303	478	284	5				○						○	http://www.showa-u.ac.jp/SHKT/index.html
57	鎌ケ谷総合病院	306	800	290	4											http://www.kamagaya-hp.jp/index.html
58	行徳総合病院	307	421	152	4											https://gyo-toku.jp/med-dept/
59	神户赤十字病院	310	511	285	8				○						○	http://www.kobe.jrc.or.jp/
60	つくばセントラル病院	313	719	237	1											http://www.central.or.jp/index005.html
61	下関医療センター	315	586	183	1				○							https://shimonoseki.jcho.go.jp/
62	千葉メディカルセンター	315	937	224	4											http://www.seikeikai-cmc.jp/department/index.html
63	北アルプス医療センター　あづみ病院	320	691	206	3											http://www.azumi-ghp.jp/center/
64	日本大学病院	320	1032	276	4					○					○	https://www.nihon-u.ac.jp/hospital/division/
65	藤沢湘南台病院	322	545	187	2											http://www.fj-shonandai.jp/kamoku/
66	興生総合病院	323	545	195	1										○	http://kohsei-hp.jp/department/index.html
67	札幌東徳洲会病院	325	532	284	3										○	http://www.higashi-tokushukai.or.jp/
68	名城病院	326	530	260	2				○							https://www.meijohosp.jp/
69	川崎幸病院	326	308	136	7				○							http://saiwaihp.jp/
70	医誠会病院	327	334	283	10											http://www.iseikaihp.or.jp/dept/index.html
71	松阪市民病院	328	628	278	2				○						○	https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/hosannai/
72	北里大学北里研究所病院	329	907	157	10						○				○	https://www.kitasato-u.ac.jp/hokken-hp/
73	河北総合病院	331	1190	354	5				○							http://kawakita.or.jp/shinryou/index.html
74	筑波学園病院	331	945	238	1											https://www.gakuen-hospital.or.jp/
75	石切生喜病院	331	931		2						○					http://ishikiriseiki.or.jp/diagnosis/
76	神鋼記念病院	333	1098	309	3				○		○					http://www.shinkohp.or.jp/
77	新松户中央総合病院	333	869	278	2											http://www.ims.gr.jp/shinmatsudo/
78	彩の国東大宮メディカルセンター	337	644	287	2						○					http://www.shmc.jp/#
79	複十字病院	339	530		9											https://www.fukujuji.org/
80	大分赤十字病院	340	507	292	2				○			○			○	http://www.oitasekijyuji.jp/
81	NTT 西日本大阪病院	341	774	219	2						○					http://www.ntt-west.co.jp/osaka-hosp/index.html
82	岸和田徳洲会病院	341	877	328	3					○	○				○	https://kishiwada.tokushukai.or.jp/
83	藤元総合病院	343	627	233	4									○		http://fgh.fujimoto.com/services/
84	湘南東部総合病院	348			5											http://www.fureai-g.or.jp/toubu/
85	兵庫県立 姫路循環器病センター	350	362	222	3				○						○	http://www.hbhc.jp/
86	河内総合病院・森本記念クリニック	350	475	258	4											http://kawati.or.jp/center/
87	日生病院	350	883	281	5						○					http://www.nissay-hp.or.jp/nissay/kannai.php
88	市立奈良病院	350	765	283	8							○			○	http://www.nara-jadecom.jp/index.html
89	上都賀総合病院	352	803	293	2							○			○	http://www.kamituga-hp.or.jp/index.html
90	坂総合病院	357	830	330	1				○						○	https://www.m-kousei.com/saka/
91	岡山ろうさい病院	358	835	289	10				○							http://okayamah.johas.go.jp/index.html
92	市立池田病院	364	891	327	8				○		○					http://www.hosp.ikeda.osaka.jp/index.html
93	長野松代総合病院	365	900	320	9											http://www.nagano-matsushiro.or.jp/dept/
94	福岡和白病院	369	495		6				○						○	http://www.f-wajirohp.jp/shinryouka/

中国知网　https://www.cnki.net

95	坂文種報德會病院	370	665	296	6				○							http://www.fujita-hu.ac.jp/HOSPITAL2/
96	PL 病院	370	930	274	3						○					http://www.plhospital.or.jp/index.html
97	名鉄病院	373	619	290	3											http://www.meitetsu-hospital.jp/index.html
98	福山医療センター	374	703	303	8				○		○			○		http://www.fukuyama-hosp.go.jp/
99	福岡県済生会福岡総合病院	380	547	320	2				○	○		○			○	https://www.saiseikai-hp.chuo.fukuoka.jp/
100	府中病院	380	880	364	5				○		○					http://www.seichokai.or.jp/fuchu/dept/
101	川崎市立 井田病院	383	702	279	5							○				http://www.city.kawasaki.jp/33/cmsfiles/contents/0000037/37855/ida/
102	国立長寿医療研究センター	383	601	255	6	○										http://www.ncgg.go.jp/
103	池上総合病院	384	850	305	3										○	http://www.ikegamihosp.jp/index.html
104	耳原総合病院	386	403	326	6				○		○				○	http://www.mimihara.or.jp/sogo/medical/
105	りんくう総合医療センター	388	824	345	10				○		○			○	○	http://www.rgmc.izumisano.osaka.jp/index.html
106	JA 尾道総合病院	393	746	335	4				○	○		○		○	○	http://onomichi-gh.jp/subject/
107	伊那中央病院	394	860	325	1				○	○		○		○	○	https://www.inahp.jp/0300021.html
108	武田病院	394	715	253	3				○							http://www.takedahp.or.jp/koseikai/
109	新東京病院	396	28	321	5											http://www.shin-tokyohospital.or.jp/index.html
110	市立岸和田市民病院	400	1019	322	1				○			○				http://www.kishiwada-hospital.com/specialty/
111	東京労災病院	400	913	318	5				○			○			○	http://www.tokyoh.johas.go.jp/
112	長野市民病院	400	997	320	4				○			○				http://www.hospital.nagano.nagano.jp/
113	済生会熊本病院	400	503	381	7				○	○		○				http://www.sk-kumamoto.jp/
114	関西電力病院	400	908	320	5						○					http://kanden-hsp.jp/feature/index.html
115	日本医科大学多摩永山病院	401	841	305	1						○			○	○	https://www.nms.ac.jp/tama-h.html
116	総合病院 回生病院	402	594	283	7				○							https://www.kaisei.or.jp/
117	春日部中央総合病院	404	680	340	3											http://www.ims.gr.jp/ims_kasukabe/
118	近江八幡市立総合医療センター	407	896	362	2				○	○		○		○	○	http://kenkoul.com/medical_list/index.html
119	仙台厚生病院	409	401	412	3				○							http://www.sendai-kousei-hospital.jp/index.html
120	けいゆう病院	410	1270	334	3				○		○				○	http://www.keiyu-hospital.com/
121	公立甲賀病院	413	987	320	3				○			○			○	http://www.kohka-hp.or.jp/
122	北里大学東病院	413	864	151	7											https://www.kitasato-u.ac.jp/ehp/index.html
123	東京警察病院	415	1172	327	5										○	http://www.keisatsubyoin.or.jp/shinryoka/
124	江戸川病院	418	277	346	11				○		○				○	http://www.edogawa.or.jp/kamoku_annnai.html
125	京都岡本記念病院	419	599	312	4				○						○	https://www.okamoto-hp.or.jp/oka2/
126	湘南藤沢徳洲会病院	419	987	362	6										○	http://fujisawatokushukai.jp/department/
127	飯田市立病院	423	926	307	1				○	○		○		○	○	http://www.imh.jp/
128	国立がん研究センター（東病院）	425			3	○		○								https://www.ncc.go.jp/jp/ncce/
129	篠ノ井総合病院	433	821	404	9				○					○		https://shinonoi-ghp.jp/group
130	相模原協同病院	437	1243	370	5				○		○				○	http://www.sagamiharahp.com/
131	松阪中央総合病院	440	747	338	2				○			○			○	http://www.miekosei.or.jp/1_mch/index.html
132	平塚共済病院	441	913	364	4				○		○					https://www.kkr.hiratsuka.kanagawa.jp/
133	潤和会記念病院	446	263	386	1											http://www.junwakai.com/center_info
134	JR 東京総合病院	448	1464	292	5							○				http://www.jreast.co.jp/hospital/index.html/
135	船橋市立医療センター	449	908	384	2				○	○		○			○	http://www.mmc.funabashi.chiba.jp/section/
136	佐久医療センター	450	751	428	4				○	○		○		○	○	http://www.sakuhp.or.jp/ja/center/
137	北播磨総合医療センター	450	927	391	6				○		○					http://www.kitahari-mc.jp/1059/1182/
138	釧路ろうさい病院	450	969	379	7				○			○				http://www.kushiroh.johas.go.jp/
139	立川病院	450	950	400	8				○	○					○	http://www.tachikawa-hosp.gr.jp/index.html
140	勤医協中央病院	450	500	430	9						○					http://www.kin-ikyo-chuo.jp/index.html
141	高崎総合医療センター	451	793	380	4				○	○		○			○	http://www.tnho.jp/center
142	総合東京病院	451	501	264	9										○	https://www.tokyo-hospital.com/department
143	木沢記念病院	452	860	446	7				○			○			○	http://kizawa-memorial-hospital.jp/
144	製鉄記念八幡病院	453	502	359	6				○							http://www.ns.yawata-mhp.or.jp/

中国知网 https://www.cnki.net

145	大雄会について	454	424	370	5				○	○					○	https://www.daiyukai.or.jp/corporation/
146	福井県済生会病院	460	1295	428	9				○		○			○	○	https://www.fukui-saiseikai.com/
147	京都中部総合医療センター	464	578	296	4							○		○	○	http://www.kyoto-chubumedc.or.jp/
148	宇治徳洲会病院	473	1375	339	8					○	○			○	○	http://www.ujitoku.or.jp/
149	国立精神・神経医療研究センター	474	478	231	14	○										https://www.ncnp.go.jp/hospital/disease/index.html
150	静岡市立清水病院	475	706	326	3				○						○	https://www.shimizuhospital.com/
151	ベルランド総合病院	477	866	456	6				○		○			○		http://www.seichokai.or.jp/bell/dept/
152	高槻病院	477	1143	421	10				○		○		○			http://takatsuki.aijinkai.or.jp/index.html
153	関西医科大学総合医療センター	477	1296	469	16					○	○				○	http://www.kmu.ac.jp/takii/visit/treatment/
154	三豊総合病院	478	1037	412	2				○	○		○			○	http://mitoyo-hosp.jp/department01.html
155	市立旭川病院	478	982	334	4							○				http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/hospital/index.html
156	仙台西多賀病院	480	123	403	7											http://www.nishitaga-hosp.jp/index.html
157	立川綜合病院	481	1100	420	4						○					https://www.tatikawa.or.jp/tatikawa/
158	三井記念病院	482	1110	410	2				○		○				○	https://www.mitsuihosp.or.jp/
159	東京西徳洲会病院	486	700	400	9						○					http://www.tokyonishi-hp.or.jp/department/
160	筑波記念病院	487	197	394	2				○							http://www.tsukuba-kinen.or.jp/
161	堺市立総合医療センター	487	767	392	14				○	○		○			○	http://www.sakai-city-hospital.jp/
162	熊本赤十字病院	490	1221	447	3				○	○	○			○	○	http://www.kumamoto-med.jrc.or.jp/
163	国立成育医療研究センター	490	977	385	7	○							○		○	https://www.ncchd.go.jp/index.html
164	戸田中央総合病院	492	1222	401	4							○				https://www.chuobyoin.or.jp/
165	住友病院	499	1281	408	4						○					http://www.sumitomo-hp.or.jp/index.php
166	大崎市民病院	500	1030	327	5				○			○		○	○	https://www.h-osaki.jp/
167	茨城県立中央病院	500	1031	401	7				○			○			○	http://www.hospital.pref.ibaraki.jp/
168	中東遠綜合醫療センター	500	1262	384	9				○	○					○	http://www.chutoen-hp.shizuoka.jp/
169	名古屋市立西部医療センター	500	1015	420	4										○	http://www.west-medical-center.city.nagoya.jp/
170	医仁会武田総合病院	500	1456	411	3											http://www.takedahp.or.jp/ijinkai/
171	松波総合病院	501	395	413	4				○						○	http://www.matsunami-hsp.or.jp/
172	徳山中央病院	507	1384	454	1				○	○		○		○	○	https://tokuyama.jcho.go.jp/
173	横浜医療センター	510	835	425	1		○		○	○				○	○	www.yokohama-mc.jp/
174	近森病院	512	524	395	2				○	○					○	http://www.chikamori.com/page978/
175	市立砺波総合病院	514	951	359	6					○		○		○	○	http://www.city.tonami.toyama.jp/tgh/index.html
176	公立昭和病院	518	1030	387	4				○	○		○		○	○	http://www.kouritu-showa.jp/medical.html
177	聖路加国際病院	520	2700	490	12				○							http://hospital.luke.ac.jp/index.html
178	東京新宿メディカルセンター	520	1141	406	2						○				○	https://shinjuku.jcho.go.jp/
179	北海道がんセンター	520	613	372	6							○				http://www.sap-cc.org/index.html
180	岩国医療センター	530	699	434	3				○	○	○	○			○	https://www.iwakuni-nh.go.jp/
181	香川県立中央病院	533	949	421	3				○	○		○			○	http://www.chp-kagawa.jp/department/
182	津山中央病院	535	911	433	4				○	○		○		○	○	http://www.tch.or.jp/
183	京都市立病院	548	1303	460	4				○			○		○	○	http://www.kch-org.jp/outline/section
184	洛和会音羽病院	548	1403	361	9				○	○						http://www.rakuwa.or.jp/otowa/
185	熊本医療センター	550	640	454	11				○	○		○			○	http://www.kuh.kumamoto-u.ac.jp/
186	東京都健康長寿医療センター	550	802	475	3										○	http://www.tmghig.jp/hospital/
187	岡山済生会総合病院	553	967	513	8				○			○			○	http://www.okayamasaiseikai.or.jp/
188	金沢医療センター	554	707	427	3		○		○		○	○		○	○	http://www.kanazawa-hosp.jp/pv/index.html
189	済生会横浜市東部病院	560	1075	490	17				○	○		○		○		https://www.tobu.saiseikai.or.jp/
190	青梅市立総合病院	562	1302	393	2					○		○			○	https://www.mghp.ome.tokyo.jp/
191	広島赤十字・原爆病院	565	1467	482	1				○		○					http://www.hiroshima-med.jrc.or.jp/
192	市川総合病院	570	1373	443	5				○			○			○	http://www.tdc.ac.jp/hospital/igh/index.html
193	板橋中央総合病院	579	1001	430	4										○	http://ims-itabashi.jp/service/
194	昭和大学藤が丘病院	584	1105	505	9				○		○			○	○	http://www.showa-u.ac.jp/SUHF/index.html

中国知网 https://www.cnki.net

195	福岡東医療センター	591	423		2				○	○		○			○	http://www.fe-med.jp/
196	加古川中央市民病院	600	1300	500	5				○		○			○	○	http://www.kakohp.jp/section/
197	松戸市立病院	600	929	416	7				○	○		○		○	○	https://www.city.matsudo.chiba.jp/hospital/index.html
198	京都医療センター	600	1362	507	7		○		○	○		○			○	http://www.hosp.go.jp/~kyotolan/index.html
199	国立がん研究センター（中央病院）	600	1301	524	4	○		○								https://www.ncc.go.jp/jp/index.html
200	旭川医科大学病院	602	1553	503	7			○		○		○		○	○	http://www.asahikawa-med.ac.jp/index_h.php?f=index
201	佐賀大学医学部附属病院	604	933	503	7			○		○	○				○	https://www.hospital.med.saga-u.ac.jp/hp/
202	岐阜県総合医療センター	604	1349	532	4				○			○	○		○	http://www.gifu-hp.jp/centerfunctions/
203	浜松医療センター	606	940	522	7				○	○		○		○	○	http://www.hmedc.or.jp/index.php
204	千葉西総合病院	608	1419	541	11											http://www.chibanishi-hp.or.jp/
205	東京医科大学八王子医療センター	610	1162	485	1				○			○			○	http://hachioji.tokyo-med.ac.jp/
206	滋賀医科大学医学部附属病院	612	1315	542	5			○			○	○	○		○	http://www.shiga-med.ac.jp/hospital/index.html
207	富山大学附属病院	612	1245	470	5			○				○		○	○	http://www.hosp.u-toyama.ac.jp/guide/index.html
208	国立循環器病研究センター	612	623	480	1	○		○								http://www.ncvc.go.jp/hospital/pub/
209	香川大学医学部附属病院	613	932	427	5			○			○		○		○	http://www.med.kagawa-u.ac.jp/hosp/
210	市立豊中病院	613	1199	520	4				○							http://chp.toyonaka.osaka.jp/index.html
211	岐阜大学医学部附属病院	614	1325	491	5			○		○	○				○	https://www.hosp.gifu-u.ac.jp/
212	国立国際医療研究センター（国府台病院）	622			2	○		○								http://www.ncgmkohnodai.go.jp/
213	NTT東日本関東病院	627	1914	428	7							○			○	https://www.ntt-east.co.jp/kmc/
214	淀川キリスト教病院	630	1156	564	10				○		○			○		http://www.ych.or.jp/
215	宮崎大学医学部附属病院	632	1058	547	3			○		○	○		○		○	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/hospital/
216	山形大学医学部附属病院	637	1245	545	4			○				○		○		http://www1.id.yamagata-u.ac.jp/MIDINFO/
217	長崎医療センター	643	750	503	6		○		○	○	○	○	○		○	http://www.nagasaki-mc.jp/
218	愛媛大学医学部附属病院	644	1237	519	18			○				○		○	○	https://www.hsp.ehime-u.ac.jp/
219	山梨県立中央病院	647	1117	483	2				○	○	○		○		○	http://www.ych.pref.yamanashi.jp/
220	湘南鎌倉総合病院	648	1427	570	13					○	○					https://www.shonankamakura.or.jp/
221	横浜市立市民病院	650	1373	550	7				○	○		○		○		http://yokohama-shiminhosp.jp/
222	横浜労災病院	650	1898	572	11				○	○		○				https://www.yokohamah.johas.go.jp/
223	日立総合病院	651	1001	419	4				○		○	○		○	○	http://www.hitachi.co.jp/hospital/hitachi/
224	高知医療センター	660	873	494	4				○	○		○	○		○	http://www.khsc.or.jp/
225	京都第一赤十字病院	666	1404	537	9				○	○		○	○		○	http://www.kyotol-jrc.org/
226	横浜市立大学附属病院	674	1874	561	6			○				○		○	○	https://www.yokohama-cu.ac.jp/fukuhp/
227	新潟市民病院	676	839	612	1				○	○		○	○		○	http://www.hosp.niigata.niigata.jp/
228	青森県立中央病院	684	1306	583	6				○	○	○	○	○		○	http://aomori-kenbyo.jp/
229	三重大学医学部附属病院	685	1288	600	1			○		○	○				○	https://www.hosp.mie-u.ac.jp/
230	昭和大学横浜市北部病院	689	1138	603	5				○			○			○	http://www.showa-u.ac.jp/SUHY/
231	仙台医療センター	689	963	540	2		○		○	○		○			○	https://www.snh.go.jp/
232	大阪医療センター	692	1138	518	1		○		○	○		○			○	www.onh.go.jp/
233	北野病院	699	1779	609	9				○		○			○		https://www.kitano-hp.or.jp/
234	がん研有明病院	700	1569	606	6			○								http://www.jfcr.or.jp/hospital/index.html
235	呉医療センター	700	1014	486	9		○		○	○	○	○		○	○	www.kure-nh.go.jp/
236	九州医療センター	702	889	561	12		○		○	○	○	○		○	○	www.kyumed.jp/
237	信州大学医学部附属病院	707	1509	599	12			○		○		○		○	○	http://wwwhp.md.shinshu-u.ac.jp/
238	刈谷豊田総合病院	710	1898	658	4				○	○	○			○	○	https://www.toyota-kai.or.jp/
239	県立広島病院	712	1253	601	6				○	○		○	○		○	http://www.hph.pref.hiroshima.jp/
240	鹿児島大学病院	716	1279	565	7			○		○	○				○	http://com4.kufm.kagoshima-u.ac.jp/index.html?jtpl=8
241	草津総合病院	719	705	304	3				○			○			○	http://kusatsu-gh.or.jp/ghk/
242	市民総合医療センター	726	2053	651	10				○	○		○	○		○	https://www.yokohama-cu.ac.jp/urahp/
243	山口大学医学部附属病院	736	1271	619	10			○		○	○		○			http://www.hosp.yamaguchi-u.ac.jp/
244	名古屋医療センター	740	1377	558	2		○		○	○		○			○	https://www.nnh.go.jp/guide/

中国知网 https://www.cnki.net

245	安城更生病院	749	1873	710	17				○	○		○	○		○	http://anjokosei.jp/
246	総合病院聖隷浜松病院	750	1615	695	9				○	○		○	○			http://www.seirei.or.jp/hamamatsu/
247	関西医科大学附属病院	751	1920	701	8			○		○	○	○	○		○	http://www.kmu.ac.jp/hirakata/
248	東京医療センター	760	1607	560	6		○		○	○	○	○			○	http://www.ntmc.go.jp/
249	いわき市立総合磐城共立病院	761	902	547	6				○	○		○		○	○	http://www.iwaki-kyoritsu.iwaki.fukushima.jp/
250	大阪急性期・総合医療センター	768	1249	686	17				○	○		○		○	○	http://www.gh.opho.jp/
251	和歌山県立医科大学附属病院	800	1509	658	5			○		○	○		○		○	http://www.wakayama-med.ac.jp/hospital/
252	国立国際医療研究センター（病院）	801	1912	670	8	○		○		○		○				www.ncgm.go.jp/
253	東海大学医学部付属病院	804	2528	773	7			○		○	○		○		○	http://www.fuzoku-hosp.tokai.ac.jp/
254	名古屋市立大学病院	808	1750	683	6			○		○		○	○		○	https://w3hosp.med.nagoya-cu.ac.jp/
255	昭和大学病院	815	1442	666	13			○		○	○		○		○	http://www.showa-u.ac.jp/SUH/
256	天理よろづ相談所病院	815	2038	571	4							○				http://www.tenriyorozu.jp/
257	愛媛県立中央病院	827	1664	643	9				○	○		○	○		○	http://www.eph.pref.ehime.jp/epch/
258	竹田綜合病院	837	1176	641	2				○			○		○		http://www.takeda.or.jp/
259	熊本大学医学部附属病院	848	1487	753	14			○			○		○			http://www.kuh.kumamoto-u.ac.jp/
260	千葉大学医学部附属病院	850	2139	706	12			○			○		○		○	https://www.ho.chiba-u.ac.jp/
261	岡山大学病院	855	2561	667	8			○		○					○	http://www.hsc.okayama-u.ac.jp/hos/
262	虎の門病院	868	2794	752	6				○			○				https://www.toranomon.gr.jp/
263	福井県立病院	880	1115	655	5				○	○			○		○	http://fph.pref.fukui.lg.jp/
264	大阪医科大学附属病院	882	1979	709	4			○		○		○		○	○	http://hospital.osaka-med.ac.jp/
265	愛知医科大学病院	900	2541	741	17			○		○					○	http://www.aichi-med-u.ac.jp/hospital/
266	近畿大学医学部附属病院	929	2044	766	9			○		○	○	○		○	○	http://www.med.kindai.ac.jp/
267	北海道大学病院	944	3073	828	6			○			○				○	http://www.huhp.hokudai.ac.jp/
268	東邦大学医療センター　大森病院	948	2353	822	21			○		○		○	○		○	https://www.omori.med.toho-u.ac.jp/
269	埼玉医科大学病院	972	1836	643	9			○				○		○	○	http://www.saitama-med.ac.jp/hospital/
270	奈良県立医科大学附属病院	992	1995	685	13			○		○	○		○		○	http://www.naramed-u.ac.jp/hospital/
271	大阪赤十字病院	999	2076	728	2				○	○	○	○		○	○	http://www.osaka-med.jrc.or.jp/
272	東京医科大学病院	1015	2621	813	13			○		○		○		○	○	http://hospinfo.tokyo-med.ac.jp/
273	日本大学医学部附属板橋病院	1025	2211	783	3			○		○		○	○		○	http://www.med.nihon-u.ac.jp/hospital/itabashi/
274	久留米大学病院	1025	1761	775	13			○		○		○	○			https://www.hosp.kurume-u.ac.jp/
275	順天堂医院	1026	3900	945	8			○		○	○			○	○	https://www.juntendo.ac.jp/hospital/
276	慶應義塾大学病院	1044	3064	785	10			○		○		○		○	○	http://www.hosp.keio.ac.jp/
277	飯塚病院	1048	1896	894	2				○	○		○	○			http://aih-net.com/
278	大阪市立総合医療センター	1063	1818	833	13				○			○	○		○	http://www.osakacity-hp.or.jp/ocgh/
279	京都府立医科大学附属病院	1065	2113	624	12			○			○			○		http://www.h.kpu-m.ac.jp/
280	東京慈恵医科大学附属病院	1075	2769	867	5			○				○		○	○	http://www.jikei.ac.jp/hospital/honin/
281	帝京大学医学部附属病院	1078	1643	800	7			○		○		○	○		○	http://www.teikyo-hospital.jp/
282	大阪大学医学部附属病院	1086	2393	907	17			○		○		○	○		○	http://www.hosp.med.osaka-u.ac.jp/
283	自治医科大学附属病院	1132	2631	873	17			○		○		○	○		○	http://www.jichi.ac.jp/hospital/top/
284	杏林大学医学部付属病院	1153	2205	809	8			○		○	○		○			http://www.kyorin-u.ac.jp/hospital/
285	岩手医科大学附属病院	1166	1470	766	5			○		○	○		○		○	http://www.iwate-med.ac.jp/hospital/
286	倉敷中央病院	1166	2708	1073	7				○	○		○	○		○	https://www.kchnet.or.jp/
287	獨協医科大学病院	1167	2118	1007	14			○		○		○	○		○	http://www.dokkyomed.ac.jp/hosp-m.html
288	川崎医科大学附属病院	1182	1750	646	16			○		○		○		○	○	https://h.kawasaki-m.ac.jp/
289	聖マリアンナ医科大学病院	1208	2316	843	14			○		○	○		○		○	http://www.marianna-u.ac.jp/hospital/
290	東京大学医学部附属病院	1217	2926	1043	9			○				○	○		○	http://www.h.u-tokyo.ac.jp/
291	東北大学病院	1225	2244	1021	15			○		○	○		○			http://www.hosp.tohoku.ac.jp/
292	九州大学病院	1275	2943	1124	12			○		○	○		○			http://www.hosp.kyushu-u.ac.jp/
293	東京女子医科大学病院	1379	3552	990	13								○		○	http://www.twmu.ac.jp/info-twmu/
294	藤田保健衛生大学病院	1435	2236	1261	3			○		○		○		○	○	http://www.fujita-hu.ac.jp/HOSPITAL1/

注：以上数据信息统计截止于 2017.12.31

中国知网　https://www.cnki.net

附录 C 日本研究案例各类诊疗中心配置情况

附录 C-1 脏器中心种类数量统计表

| 序号 | 医院名称 | 心脏（心血管）相关中心 | | |

附录 C-1 脏器中心种类数量统计表（接上页）

| 序号 | 医院名称 | 诊疗中心种类 | 心脏（心血管）相关中心 | | |

附录 C-2 系统中心种类数量统计表（接上页）

| 序号 | 医院名称 \ 诊疗中心种类 | 消化系统疾病相关中心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 呼吸系统疾病相关中心 | | | | | | | | | | | | 心・脈血管中心 | | | | | | | | | | | | 糖性创伤治疗相关中心 | | | | | | | | | | | | 脊椎脊髓相关中心 | | | | | | | | | | | | 骨科相关中心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

附录 C-2 系统中心种类数量统计表

| 序号 | 医院名称 | 消化系统疾病相关中心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 呼吸系统疾病相关中心 | | | | | 心・脈血管中心 | | | | 慢性创伤治疗相关中心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

附录 C-3 疾病中心及其他类诊疗中心种类数量统计表（接上页）

| 序号 | 医院名称 | 诊疗中心种类 | 糖尿病·代谢疾病相关中心 | | |

附录 C-3 疾病中心及其他类诊疗中心种类数量统计表（接上页）

序号	医院名称 \ 诊疗中心种类	糖尿病与代谢类病相关中心	肾脏病相关中心	风湿病相关中心	皮肤病相关中心	血液病相关中心	精神卫生相关中心	静脉（输尿）相关中心	认知症相关中心	疼痛相关中心	营养计中心	感染相关中心	其他类中心
151	ベルランド総合病院												
152	南鳴病院												
153	三井記念病院												
154	市立豊中病院												
155	市立堺病院												
156	仙台厚生病院												
157	立川総合病院												
158	三井記念病院												
159	東京西徳洲会病院												
160	関西医科大学総合医療センター												
161	堺市立総合医療センター												
162	順天堂大学練馬病院												
163	戸田中央総合病院												
164	佐久総合病院												
165	大崎市民病院												
166	大崎市民病院・岩出分院												
167	武蔵野赤十字病院												
168	中東遠総合医療センター												
169	名古屋市立西部医療センター												
170	医仁会武田総合病院												
171	松波総合病院												
172	横浜市立大学病院												
173	近畿大学医学部堺病院												
174	公立昭和病院												
175	市立豊能病院												
176	公立昭和病院												
177	東京慈恵会医科大学附属病院												
178	東京都健康長寿医療センター												
179	北海道がんセンター												
180	公益財団法人日本対がん協会												
181	香川県立中央病院												
182	愛知県がんセンター												
183	静岡がんセンター												
184	独立行政法人国立病院機構												
185	静岡がんセンター												
186	東京都健康長寿医療センター												
187	関西医科大学総合医療センター												
188	金沢医療センター												
189	済生会横浜市東部病院												
190	万樹会中央総合病院												
191	仁寿会病院												
192	松山赤十字病院												
193	愛媛県立中央病院												
194	順天堂大学医学部附属病院												
195	神奈川県立がんセンター												
196	独立行政法人国立病院機構												
197	松戸市立病院												
198	兵庫医療センター												
199	国立がん研究センター（中央病院）												
200	東京医科大学病院												
201	公益財団法人がん研究会有明病院												
202	兵庫県立がんセンター												
203	千葉県がんセンター												
204	千葉県循環器病センター												
205	東京医科大学八王子医療センター												
206	慈恵医大病院												
207	富山大学附属病院												
208	国立循環器病研究センター												
209	香川大学医学部附属病院												
210	市立春日病院												
211	岐阜大学医学部附属病院												
212	国立研究開発法人国立がん研究センター（国際臨床病院）												
213	国立研究開発法人国立がん研究センター												
214	医仁会武田総合病院												
215	大阪大学医学部附属病院												
216	山形大学医学部附属病院												
217	長崎医療センター												
218	愛媛大学医学部附属病院												
219	山梨県立中央病院												
220	浦河赤十字病院												
221	横浜市立市民病院												
222	君津中央病院												
223	岐阜県立多治見病院												
224	公立豊岡病院												
225	東京都立駒込病院												
226	埼玉県立小児医療センター												
227	静岡県立総合病院												
228	青森県立中央病院												
229	一宮市立市民病院												
230	昭和大学横浜市北部病院												
231	仙台医療センター												
232	北野病院												
233	大阪急性期・総合医療センター												
234	がん研究会有明病院												
235	名医療センター												
236	九州医療センター												
237	広島大学医学部附属病院												
238	埼玉県立循環器・呼吸器病センター												
239	独立行政法人国立病院機構												
240	東京慈恵会医科大学病院												
241	埼玉医科大学総合医療センター												
242	山口大学医学部附属病院												
243	山口県立総合医療センター												
244	名古屋医療センター												
245	愛媛県立中央病院												
246	総合病院聖隷浜松病院												
247	関西医科大学附属病院												
248	東京医療センター												
249	いわき市立総合磐城共立病院												
250	大阪急性期・総合医療センター												
251	和歌山県立医科大学附属病院												
252	名古屋医療センター												
253	東海大学医学部付属病院												
254	名古屋市立大学病院												
255	昭和大学病院												
256	大垣ヘラス健康所病院												
257	愛媛県立中央病院												
258	竹田綜合病院												
259	順天堂大学医学部附属病院												
260	千葉大学医学部附属病院												
261	関山丸善病院												
262	福井県立病院												
263	福井県立病院												
264	大阪医科大学附属病院												
265	愛知医科大学病院												
266	近畿大学医学部附属病院												
267	北海道大学病院												
268	東京大学医学部附属病院												
269	埼玉医科大学病院												
270	奈良県立医科大学附属病院												
271	大阪医科薬科大学病院												
272	日本大学医学部附属板橋病院												
273	日本大学医学部附属板橋病院												
274	久留米大学病院												
275	順天堂医院												
276	慶應義塾大学病院												
277	順天堂医院												
278	大阪市立総合医療センター												
279	奈良県立医科大学附属病院												
280	東京慈恵会医科大学附属病院												
281	順天堂大学医学部附属病院												
282	日本大学医学部附属板橋病院												
283	日本医科大学武蔵小杉病院												
284	杏林大学医学部付属病院												
285	奈良県立医科大学附属病院												
286	倉敷中央病院												
287	獨協医科大学病院												
288	川崎医科大学附属病院												
289	東京女子医科大学病院												
290	東京女子医科大学病院												
291	東京女子医科大学病院												
292	藤田医科大学病院												
小计	合计	73	11	31	5	22	29	225	414	4	60	16	72

中国知网 https://www.cnki.net